

TUGAS AKHIR

PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK

**MODEL *ENTERPRISE RISK MANAGEMET* PADA PELAYANAN PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor Administrasi Publik**



Arjaty Wahidah Daud

NIM: 501201741

**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS TERBUKA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAIN DAN TEKNOLOGI**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing complexity of risks in hospital public services, especially due to the paradox between the demands of access, quality of service, and sustainability of resources in the VUCA era (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). The implementation of risk management at Tarakan hospital, DKI Jakarta Province, is still partial, administrative, and has not been strategically integrated in organizational governance. In addition, there are empirical, theoretical, and normative gaps, as well as regulatory disharmonization that hinder the optimal implementation of Enterprise Risk Management (ERM). The purpose of this study is to analyze the actual conditions of risk management implementation, identify supporting and inhibiting factors, and develop an Enterprise Risk Management (ERM) Model at Tarakan Hospital, DKI Jakarta Province. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using interactive analysis techniques that included data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results of the study show that the implementation of risk management at Tarakan Hospital is not optimal and is still silo-based, with a dominance of clinical risk and has not been integrated into strategic planning and budgeting. Supporting factors include regulations and leadership commitment, while inhibiting factors include low risk awareness culture, limited human resource competencies, information systems that have not been integrated, and policy disharmony between central and regional governments.

This research resulted in an integrated ERM Model by combining the COSO ERM 2017 framework and hybridization of public administration paradigms (Old Public Administration, New Public Management, and New Public Service). This model integrates risk management at the strategic, tactical, and operational levels and includes clinical and non-clinical risks holistically. In addition, the paradox of healthcare services is positioned as a strategic risk in order to create public value, increase accountability, and strengthen organizational resilience. This research provides theoretical contributions in the development of public administration-based ERM models as well as practical contributions as policy recommendations and guidelines for the implementation of risk management in public hospitals.

Keywords: *Enterprise Risk Management (ERM), public services, hospitals, risk management, COSO ERM 2017, public administration, governance, VUCA*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas risiko dalam pelayanan publik rumah sakit, khususnya akibat paradoks antara tuntutan akses, mutu layanan, dan keberlanjutan sumber daya di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Penerapan manajemen risiko di rumah sakit Tarakan Provinsi DKI Jakarta, masih bersifat parsial, administratif, dan belum terintegrasi secara strategis dalam tata kelola organisasi. Selain itu, terdapat kesenjangan empiris, teoritis, dan normatif, serta disharmonisasi regulasi yang menghambat implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi aktual penerapan manajemen risiko, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengembangkan Model *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan belum optimal dan masih bersifat *silo-based*, dengan dominasi pada risiko klinis serta belum terintegrasi ke dalam perencanaan strategis dan penganggaran. Faktor pendukung meliputi regulasi dan komitmen pimpinan, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya budaya sadar risiko, keterbatasan kompetensi SDM, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta disharmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini menghasilkan Model ERM yang terintegrasi dengan menggabungkan kerangka COSO ERM 2017 dan hibridisasi paradigma administrasi publik (*Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service*). Model ini mengintegrasikan pengelolaan risiko pada level strategis, taktis, dan operasional serta mencakup risiko klinis dan non-klinis secara holistik. Selain itu, paradoks pelayanan kesehatan diposisikan sebagai risiko strategis dalam rangka menciptakan *public value*, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat ketahanan organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model ERM berbasis administrasi publik serta kontribusi praktis sebagai rekomendasi kebijakan dan pedoman implementasi manajemen risiko di rumah sakit publik.

Kata kunci: Enterprise Risk Management (ERM), pelayanan publik, rumah sakit, manajemen risiko, COSO ERM 2017, administrasi publik, tata kelola, VUCA

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGTAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH PASCA SARJANA

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Doktor yang berjudul

**MODEL *ENTERPRISE RISK MANAGEMET (ERM)* PADA PELAYANAN PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TARAKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 10 April 2026

Yang Menyatakan



(Arjaty Wahidah Daud)

NIM: 501201741

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjaty Wahidah Daud
NIM : 501201741
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Disertasi : *MODEL ENTERPRISE RISK MANAGEMET (ERM)*
PADA PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) TARAKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi yang saya tulis adalah murni hasil Karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan hasil penjiplakan (Plagiasi) dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Saya juga menyatakan bahwa Tingkat kemiripan (Similarity) karya ilmiah ini tidak melebihi 20% sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan akademik.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 April 2026

Yang membuat Pernyataan



(Arjaty Wahidah Daud)
NIM 501201741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Doktor Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Proses penyusunan disertasi ini tidaklah mudah, namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Sofjan Aripin MSi., selaku Ketua Tim Promotor, atas segala bentuk motivasi, arahan, serta pencerahan ilmiah yang sangat berarti bagi penyempurnaan disertasi ini. Penghargaan yang sama juga penulis tujukan kepada Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Ir.H. Dahyar Daraba MSi, selaku Ko-Promotor, atas bimbingan, masukan, serta dukungan moral yang berharga selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Ungkapan terima kasih mendalam juga penulis sampaikan kepada Yang Terhormat Ibu Prof Dr.Ginta Ginting MBA., atas dukungan, wawasan akademik, serta dorongan moral yang senantiasa diberikan hingga terselesaikannya disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan budi para pembimbing tersebut.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., dan Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. (masa bakti 2017–2025), Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Prof Dr. Maman Rumanta MSi, serta Ketua Program Studi Doktoral Administrasi Publik, Dr. Florentina Ratih Wulandari, atas motivasi, keteladanan, serta arahannya dalam menjaga agar penelitian ini tetap berada dalam koridor keilmuan Administrasi Publik.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Yang Terhormat para Penguji Disertasi, yaitu Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., dan Prof. Dr. Bambang Supriyono MS, atas saran dan masukan konstruktif yang sangat berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para Informan penelitian, yaitu: Ibu dr.Irna Lidiawati, MARS sebagai Ketua Tim Kerja Mutu Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Bapak Wisnu Saputro, SE MAP, sebagai

Kasubdit BLUD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, drg. Nuniek Ria Sundari, MARS, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, drg. Yuditha Endah, MKes sebagai Dewan Pengawas RSUD Tarakan, dr. Weningtyas Purnomorini, MARS sebagai Direktur RSUD Tarakan DKI Jakarta, dr. Nikensari Koesrindartia, MARS sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Tarakan, dr. Siti Hannah, MKM, sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum & Keuangan RSUD Tarakan, dr. Yuli Doris Memy, Sp.THT-KL (K) sebagai Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, dr. Ferry C Nugroho sebagai dr. Ferry C Nugroho, Ns. Nilandari, MARS sebagai Sekretaris Komite Mutu, apt. F. Kurniasari, S.Farm, sebagai Kepala Bagian SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUD Tarakan, Napsiah, S.Kep.Ners. sebagai Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Tarakan, Apt. Nanang Erlana, S.Farm sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal RSUD Tarakan, dr. Djon Deddy sebagai Komite PPI RSUD Tarakan, dr. Bertha Ria Lestari, Sp. PK sebagai Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Tarakan, Apt. Isnani, S.Farm sebagai Kepala Instalasi Farmasi RSUD Tarakan, dr. Riennie Maisara sebagai Koordinator Instalasi Rawat Inap, Imam Bukhari, SH sebagai Kesekretariatan dan Legal, dr. Friska Sinaga sebagai Koordinator Instalasi K3KL, dr. Tetty Harefa, SP.GK sebagai Ka. Instalasi Gizi RSUD Tarakan, dr. Lie Helen Lesmana sebagai Sekretaris Komite Medik, KSP Mobilisasi Dana, dr. Gracia sebagai Humas RSUD Tarakan, Ferdy Wijaya, S.Kom sebagai KSP PSIT, Santi, S.Sos sebagai Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan, Ritha Okta Mutiara, SE sebagai Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi dan dr. Elvita Dwi Amelia sebagai Koordinator Instalasi Gawat Darurat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kontribusi dan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.

Disertasi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta yang dengan ketulusan hati senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tiada henti bagi terselesaikannya penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada orang tua Alm. Ayahanda H. M Arsjad Daud dan Alm. H. Arina Dhianto, Almh Ibunda Hj. Resia Sugerha, dan Ibunda Hj. Wiwiek Sarwiasih atas doa dan semangat yang tiada henti, juga kepada Suami tercinta Dr. dr Rudi Putranto SpPD, Subs.P.P.M.(K), FINASIM, M.P.H., kedua anak saya Diah Karina Sabaniah S.H., M.Kn., Andriena Kartika Nabilla, S.Ked., M Ilham Hasibuan, S.E., Ak. dan cucunda tercinta M. Arkafi Hasibuan atas dukungan dan disertai permohonan maaf yang tulus karena waktu kebersamaan dengan keluarga berkurang selama penyusunan disertasi ini.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual. dan Ibu Rina Nurlaela serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta semangat kolegal yang turut menguatkan penulis hingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik serta saran yang

membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

Jakarta, 10 April 2026

Arjaty Wahidah Daud

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. <i>Research Gap</i>	18
2. <i>Fenomena</i>	19
3. <i>Kebaruan Penelitian (Novelty)</i>	19
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kajian Pustaka	22
1. Administrasi Publik.....	22
2. Administrasi Publik dalam konteks Governance	34
3. Akuntabilitas dalam Pelayanan publik	36
4. Pelayanan Publik.....	38
5. Pelayanan publik di bidang kesehatan	46
6. Paradoks Pelayanan kesehatan publik dalam perspektif Administrasi Publik	50
7. <i>Standardization by Provider</i> dalam Pelayanan publik.....	51
8. <i>Perfomance Index by Citizen</i> dalam Pelayanan Publik dengan Pendekatan SERVQUAL	54
9. <i>Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam intervensi Kebijakan</i> 	56

10. <i>System Thinking dalam Enterprise risk management</i>	57
11. <i>Manajemen Risiko</i>	59
12. <i>Manajemen risiko pada Administrasi publik</i>	60
13. <i>Manajemen risiko organisasi (Enterprise risk management / ERM)</i>	67
14. <i>Kerangka kerja COSO ERM 2017</i>	70
15. <i>ISO 31000:2018</i>	78
16. <i>Integrated Risk Management Framework (Canada)</i>	86
17. <i>Deliberative Policy dan Collaborative Governance sebagai Mekanisme Integrasi ERM dengan Paradigma Administrasi Publik</i>	89
18. <i>ERM dalam Perspektif Public Enterprise, Integrasi Nilai Ekonomi dan Nilai Pelayanan</i>	90
19. <i>Risk Appetite dalam Perspektif Public Value dan Resilience Organisasi</i> ..	96
20. <i>Balanced Scorecard sebagai Instrumen Penguatan Value for Money melalui Enterprise Risk Management di Rumah Sakit Publik</i>	103
21. <i>Pemodelan Sitem</i>	107
B. <i>Penelitian Terdahulu</i>	108
C. <i>Kerangka pikir Penelitian</i>	134
D. <i>Proposisi Penelitian</i>	135
BAB III METODE PENELITIAN	137
A. <i>Desain Penelitian</i>	137
B. <i>Lokasi Penelitian</i>	137
C. <i>Waktu Penelitian</i>	139
D. <i>Sumber Data</i>	140
E. <i>Instrumen Penelitian</i>	141
F. <i>Definisi Konseptual</i>	141
G. <i>Prosedur Pengumpulan data</i>	142
1. <i>Wawancara</i>	143
2. <i>Observasi</i>	144
3. <i>Dokumen</i>	145
H. <i>Teknik Analisis Data</i>	148
1. <i>Pengumpulan Data (Data Collection)</i>	148
2. <i>Kondensasi Data (Data Condensation)</i>	149
3. <i>Penyajian Data (Data Display)</i>	149

4. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (<i>Conclusions: Drawing/Verifying</i>)	149
I. Uji Validitas Data	150
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	152
A. Deskripsi Penelitian	152
1. Gambaran Umum RSUD Tarakan	152
2. Daftar Informan	164
B. Hasil Penelitian	165
1. Gambaran umum Penerapan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> di RSUD Tarakan	165
2. Tata Kelola dan Budaya (<i>Governance and Culture</i>)	179
3. Strategi dan Sasaran	231
4. Kerangka kerja ERM	240
5. Informasi dan Komunikasi ERM	247
6. <i>Performance</i>	251
7. Review dan revisi	265
8. Audit Internal ERM	271
C. Pembahasan	274
1. Gambaran Umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan	275
2. Faktor Pendukung	293
3. Faktor Penghambat	298
4. Tata Kelola dan Budaya	305
5. Strategi dan Sasaran	360
6. Kerangka Kerja	372
7. Informasi dan Komunikasi	382
8. <i>Performance</i>	387
9. Review dan Revisi	397
10. Audit Internal	403
11. Keterbatasan Penelitian	407
12. Implikasi Penelitian	408
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	410
A. Kesimpulan	410
1. Kondisi aktual Penerapan Manajemen Risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.	410

2. Faktor Pendukung dan Penghambat	410
3. Model <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> pada Pelayanan Publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta	411
B. Saran.....	411
1. Saran bagi RSUD Tarakan.....	411
2. Saran bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	412
3. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	412
4. Saran bagi Kementerian Kesehatan	413
5. Saran bagi Kementerian Dalam Negeri.....	413
6. Saran bagi Akademisi dan Peneliti	413
DAFTAR PUSTAKA.....	414
LAMPIRAN	433

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hubungan Dimensi Akuntabilitas dengan Komponen COSO ERM 2017	3
Tabel 1.2 Perbandingan penelitian terdahulu dengan Rencana penelitian.....	7
Tabel 2.1 Pengembangan teori dalam tiga paradigma administrasi publik	29
Tabel 2.2 <i>Value for Money</i> (VfM) di Rumah Sakit	43
Tabel 2.3 <i>Value for Money</i> dan Dimensi Mutu (WHO)	45
Tabel 2.4 Standar Manajemen Risiko: 12 Karakteristik Utama	64
Tabel 2.5 Perbedaan antara Manajemen Risiko Tradisional dan <i>Enterprise risk management</i> (ERM).....	70
Tabel 2.6 Perbandingan Kerangka Kerja ERM	88
Tabel 2.7 Definisi dan Skala Risiko yang dapat diterima (<i>Risk Appetite</i>).....	100
Tabel 2.8 <i>Risk Appetite mapped over the Risk Taxonomy</i>	101
Tabel 2.9 Penelitian terdahulu	109
Tabel 2.10 Perbedaan dan Persamaan Tujuan dan Hasil Penelitian	132
Tabel 3.1 Jumlah Rumah Sakit di DKI Jakarta	138
Tabel 3.2 Waktu dan Kegiatan Penelitian	139
Tabel 3.3 Operasionalisasi Konsep Manajemen risiko	141
Tabel 3.4 Sumber Data, Jenis Data dan Teknik Pengambilan dan Pengendalian data ..	145
Tabel 4.1 Indikator Kinerja utama RSUD Tarakan.....	158
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia RSUD Tarakan	161
Tabel 4.3 Indikator Sasaran Manajemen risiko	164
Tabel 4.4 Daftar Informan wawancara	164
Tabel 4.5 Daftar <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	165
Tabel 4.6 Triangulasi Data Gambaran Penerapan ERM di RSUD Tarakan.....	165
Tabel 4.7 Triangulasi data Faktor Pendukung	172
Tabel 4.8 Triangulasi data Faktor Penghambat	175
Tabel 4.9 Triangulasi data Kesesuaian visi, misi, nilai dan sasaran rumah sakit	179
Tabel 4.10 Triangulasi data Kepemimpinan dan Pengawasan berupa Komitmen terhadap <i>Core Value</i> dan ERM	183
Tabel 4.11 Triangulasi Hasil Penelitian <i>Value for Money</i>	190
Tabel 4.12 Triangulasi data Pengorganisasian ERM dengan <i>Three Line Model</i>	193
Tabel 4.13 Triangulasi data Penetapan Regulasi manajemen risiko	195

Tabel 4.14	Triangulasi data Regulasi manajemen Risiko Eksternal.....	197
Tabel 4.15	Triangulasi data Kesesuaian Regulasi internal dan eksternal.....	202
Tabel 4.16	Triangulasi data Ketersediaan Anggaran.....	206
Tabel 4.17	Triangulasi data Akuntabilitas	208
Tabel 4.18	Triangulasi data Keterlibatan Pemangku kepentingan	211
Tabel 4.19	Triangulasi data Budaya sadar risiko	215
Tabel 4.20	Triangulasi data Kompetensi SDM terhadap risiko.....	219
Tabel 4.21	Triangulasi data Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi	221
Tabel 4.22	Triangulasi data Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko...	224
Tabel 4.23	Triangulasi data <i>Standard decision by Government</i> dengan SPM.....	226
Tabel 4.24	Triangulasi data <i>Performance Index</i> by citizen	228
Tabel 4.25	Triangulasi data Analisa Konteks internal dan eksternal	231
Tabel 4.26	Triangulasi data Penetapan selera risiko (<i>risk appetite</i>).....	232
Tabel 4.27	Triangulasi data Evaluasi Alternatif Kinerja	236
Tabel 4.28	Triangulasi data Perumusan Tujuan dan Sasaran strategis mempertimbangkan risiko	237
Tabel 4.29	Triangulasi data Rancang Program Kerja ERM	240
Tabel 4.30	Triangulasi data <i>Roadmap</i> dan Penerapan ERM	241
Tabel 4.31	Triangulasi data Evaluasi Kegiatan ERM	242
Tabel 4.32	Triangulasi data Perbaikan berkelanjutan.....	243
Tabel 4.33	Triangulasi Data Pelaporan Pelaporan Program ERM dan budaya sadar risiko	245
Tabel 4.34	Triangulasi data Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas dan tepat waktu	247
Tabel 4.35	Triangulasi Data Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko	248
Tabel 4.36	Triangulasi data Identifikasi risiko	251
Tabel 4.37	Triangulasi data Analisa risiko	256
Tabel 4.38	Triangulasi data Penentuan Prioritas risiko	258
Tabel 4.39	Triangulasi data Perlakuan risiko	261
Tabel 4.40	Triangulasi data Pembiayaan risiko.....	262
Tabel 4.41	Triangulasi data Portofolio risiko	264
Tabel 4.42	Triangulasi data Penilaian perubahan substansial pada perubahan internal / eksternal signifikan direspons dengan penyesuaian risiko	265

Tabel 4.43	Triangulasi Data <i>Review</i> kinerja dan Revisi	267
Tabel 4.44	Triangulasi Data Perbaikan ERM dengan Tindakan peningkatan sistem ERM secara berkelanjutan.....	270
Tabel 4.45	Triangulasi Data Audit internal berbasis risiko.....	271
Tabel 4.46	Triangulasi Data Tindak lanjut audit internal	273
Tabel 4.47	Pembahasan Gambaran penerapan ERM di RSUD Tarakan	292
Tabel 4.48	Pembahasan Faktor Pendukung	296
Tabel 4.49	Pembahasan Faktor Penghambat	302
Tabel 4.50	<i>Capacity Building</i>	351
Tabel 4.51	Tata Kelola dan Budaya	354
Tabel 4.52	Pembahasan Strategi dan Sasaran.....	369
Tabel 4.53	Pembahasan Kerangka kerja	380
Tabel 4.54	Pembahasan Informasi dan Komunikasi	385
Tabel 4.55	Pembahasan Performance	395
Tabel 4.56	Pembahasan <i>Review</i> dan revisi	400
Tabel 4.57	Pembahasan Audit Internal	405

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses manajemen risiko di institusi publik	63
Gambar 2.2 COSO ERM 2017 Components and principles.....	72
Gambar 2.3 Manajemen risiko ISO 31000:2018.....	85
Gambar 2.4 Proses manajemen risiko dalam Kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi.....	86
Gambar 2.5 Diagram matrix 4 kuadran.....	94
Gambar 2.6 Langkah Langkah Pengembangan Model.....	108
Gambar 2.7 Kerangka pikir Penelitian.....	134
Gambar 2.8 Proposisi ERM di Rumah Sakit	136
Gambar 3.1 Komponen dan analisis data model interaktif	148
Gambar 3.2 Analisis Kualitatif dengan perangkat lunak (software) NVIVO	150
Gambar 4.1 Gedung RSUD Tarakan.....	154
Gambar 4.2 Lokasi RSUD Tarakan.....	154
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi RSUD Tarakan.....	155
Gambar 4.4 Project Map Gambaran umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan.....	304
Gambar 4.5 Word Query Gambaran umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan.....	305
Gambar 4.6 Project Map Tata Kelola dan Budaya.....	360
Gambar 4.7 Word Query Tata Kelola dan Budaya	360
Gambar 4.8 Project Map Strategi dan Sasaran Sumber: Hasil Penelitian 2025	371
Gambar 4.9 Word Query Strategi dan Sasaran	372
Gambar 4.10 Project Map Kerangka kerja	382
Gambar 4.11 Word Query Kerangka kerja.....	382
Gambar 4.12 Project Map Informasi dan Komunikasi	386
Gambar 4.13 Word Query Informasi dan Komunikasi.....	387
Gambar 4.14 Project Map Performance	397
Gambar 4.15 Word Query Performance	397
Gambar 4.16 Project Map Review dan Revisi	402
Gambar 4.17 Word Query Review dan Revisi	402
Gambar 4.18 Project Map Audit internal.....	406
Gambar 4.19 Word Query Audit internal	406
Gambar 4.20 Model Enterprise Risk Management di Rumah Sakit	407

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	433
Lampiran 2. Daftar Rumah Sakit di DKI Jakarta	441
Lampiran 3. Pelayanan di RSUD Tarakan	449
Lampiran 4. Definisi Operasional.....	452
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di RSUD Tarakan	449
Lampiran 6. Surat Keterangan selesai Penelitian di RSUD Tarakan	451

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme birokrasi, tetapi juga sebagai manifestasi konkret dari fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan (Denhardt & Denhardt, 2015). Administrasi publik secara tradisional dipahami sebagai aktivitas birokratis yang dijalankan oleh negara untuk menyediakan pelayanan dan melaksanakan kebijakan (Rosenbloom et al., 2015). Pendekatan ini bersifat hierarkis dan legalistik, di mana struktur formal dan prosedur dominan dalam pengambilan keputusan. Namun, dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas pelayanan mendorong pergeseran paradigma menuju *public governance*.

Governance mengacu pada proses interaksi antara berbagai aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik secara kolaboratif, akuntabel, dan responsif (Pierre & Peters, 2000). Di sektor pelayanan kesehatan terutama rumah sakit, pergeseran ini menuntut tata kelola yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pencapaian hasil dan penciptaan nilai publik.

Organisasi sektor publik dihadapkan pada tekanan yang semakin besar untuk menghasilkan layanan yang lebih berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *value squeeze*, dimana para pengelola publik dituntut untuk “*do more with less*” sekaligus memastikan bahwa pengeluaran publik benar-benar menghasilkan *outcome* yang diharapkan masyarakat. (Cole, M., & Parston, G. (2006).

Dalam konteks pelayanan kesehatan publik, tekanan tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan sumber daya, tetapi juga memunculkan suatu paradoks kebijakan yang inheren. Sistem pelayanan kesehatan dihadapkan pada tuntutan untuk menyediakan layanan yang adil, merata, dan terjangkau melalui skema *Universal Health Coverage* (UHC), namun di sisi lain rumah sakit dituntut untuk menjaga keberlanjutan finansial dan operasionalnya.

Paradoks ini menempatkan rumah sakit pada posisi dualisme peran, yaitu sebagai institusi sosial yang menjalankan mandat pelayanan publik sekaligus sebagai organisasi yang harus mempertahankan efisiensi, kinerja, dan keberlanjutan finansial. Ketegangan antara misi sosial dan tuntutan ekonomi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

berdampak pada meningkatnya risiko sistemik, baik risiko finansial, operasional, mutu pelayanan, maupun keselamatan pasien. Oleh karena itu, paradoks pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai kontradiksi semata, melainkan sebagai *strategic trade-off* yang harus dikelola secara sistematis melalui pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, paradigma administrasi publik modern menekankan pentingnya penciptaan *public value*, yaitu kemampuan organisasi publik menghasilkan *outcome* sosial dan ekonomi yang selaras dengan prioritas warga secara *cost-effective*. Keberhasilan organisasi publik tidak lagi semata diukur dari kepatuhan prosedural atau besarnya output layanan, tetapi dari sejauh mana organisasi mampu mengonversi sumber daya publik menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. (Cole, M., & Parston, G. (2006).

Pendekatan *Public Service Value* menunjukkan bahwa sektor publik perlu mengadaptasi prinsip-prinsip manajerial tanpa kehilangan karakter publiknya. Model ini mengadopsi konsep *shareholder value* dari sektor privat dengan menempatkan *citizens*, *taxpayers*, dan *service recipients* sebagai *stakeholder* utama. Oleh karena itu, *enterprise* dalam sektor publik tidak dimaknai sebagai orientasi profit, melainkan sebagai upaya memastikan terciptanya *value for money*, sementara dimensi *service* diwujudkan melalui pencapaian *outcome* yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Cole, M., & Parston, G. (2006).

Oleh karena itu, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga bertransformasi menuju tata kelola yang berbasis prinsip-prinsip *governance*. Transformasi ini menuntut penguatan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan dan pengambilan keputusan.

Dalam kerangka *governance*, akuntabilitas menjadi elemen kunci yang tidak hanya mencerminkan transparansi, tetapi juga menjadi dasar legitimasi dalam setiap proses pelayanan publik. Jabbra dan Dwivedi (1989) mengemukakan bahwa akuntabilitas mencakup lima dimensi penting yang saling berkaitan meliputi 1) Akuntabilitas administratif yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan; 2) Akuntabilitas hukum yaitu tanggung jawab sesuai ketentuan hukum; 3) Akuntabilitas politik yaitu hubungan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan politik dan 4) Akuntabilitas profesional yaitu kompetensi dan standar etika profesi serta 5) Akuntabilitas moral yaitu komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan pelayanan publik. Kelima dimensi ini berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan institusi publik, termasuk rumah sakit, dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan.

Kelima dimensi ini membingkai penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis kerangka COSO 2017, yang terdiri dari lima komponen utama yaitu : *governance and culture, strategy and objective-setting, performance, review and revision*, serta *information, communication, and reporting*. (Moeller, R. R, 2011). Dalam kerangka ini, rumah sakit sebagai organisasi publik dituntut untuk membangun Manajemen risiko yang tidak hanya berbasis pada regulasi teknis, tetapi juga mampu menunjukkan akuntabilitas multidimensi. Dalam konteks rumah sakit, hubungan kelima dimensi akuntabilitas dan lima komponen COSO ERM 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hubungan Dimensi Akuntabilitas dengan Komponen COSO ERM 2017

Dimensi Akuntabilitas	Komponen COSO ERM 2017	Konteks Rumah Sakit
Administratif	<i>Governance and Culture</i>	Budaya kepatuhan terhadap regulasi Standar Akreditasi, (KMK No. 1596/2024), Standar pelayanan dan Budaya sadar risiko
Hukum	<i>Information, Communication, and Reporting</i>	- Sistem pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan pasien (SP2KP) - Daftar risiko dan Profil risiko berbasis regulasi (KMK No. 1596/2024) dan KMK No. 1354/2024).
Politik	<i>Strategy and Objective- Setting</i>	Penetapan tujuan pelayanan kesehatan yang akuntabel kepada pemangku kepentingan publik
Profesional	<i>Performance</i>	Kompetensi tenaga kesehatan dalam menerapkan Identifikasi, Analisa dan evaluasi prioritas risiko
Moral	<i>Review and Revision</i>	Evaluasi berkelanjutan terhadap praktik yang mencerminkan nilai integritas dan keselamatan pasien.

Sumber: (Jabbara dan Dwivedi, (1989) dan Moeller R,R (2017), diolah Peneliti)

Dengan demikian, penguatan tata kelola risiko di rumah sakit memerlukan pendekatan integratif yang memadukan prinsip *governance*, akuntabilitas publik, dan manajemen risiko. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan negara.

Disisi lain Pelayanan publik (*public service*) juga mencerminkan inti dari eksistensi administrasi publik, yang terdiri dari dua fungsi utama, yaitu fungsi layanan (*service functions*) dan fungsi regulasi (*regulatory functions*). Fungsi layanan (*service functions*)

mengacu pada penyediaan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan sosial yang bersifat non-komersial namun vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam konteks ini negara hadir sebagai *provider* untuk memastikan keadilan distributif serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama bagi kelompok rentan dan marjinal (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). Di sisi lain, fungsi regulasi (*regulatory functions*) mencerminkan peran negara sebagai pengatur dan penjaga kepatuhan terhadap norma, hukum, serta etika publik. Fungsi ini meliputi pembuatan regulasi, pengawasan, perizinan, serta penegakan hukum yang diperlukan untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah penyalahgunaan kewenangan baik oleh sektor publik maupun swasta (Frederickson, Smith, Larimer, & Licari, 2016). Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya berperan dalam memberikan layanan, tetapi juga dalam mengendalikan proses-proses sosial agar tetap berada dalam kerangka yang mendukung kepentingan umum.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menetapkan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu *Standard Decision by Government* (keputusan standar pelayanan oleh pemerintah) dan *Performance Index by Citizen* (penilaian kinerja oleh masyarakat). Keduanya membentuk kerangka normatif dan evaluatif yang saling melengkapi dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas layanan.

Standard Decision by Government mengacu pada penetapan standar pelayanan secara tertulis oleh penyelenggara layanan, yang mencakup elemen-elemen seperti prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, serta jaminan kepastian hukum dan keselamatan bagi penerima layanan (UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 21–23). Di rumah sakit, standar ini tercermin dalam standar pelayanan minimal (SPM), standar prosedur operasional (SPO), standar akreditasi, keselamatan pasien dan indikator mutu layanan yang menjadi dasar pengukuran kinerja internal serta pemenuhan hak-hak pasien. Sementara itu, *Performance Index by Citizen* merepresentasikan dimensi evaluatif berdasarkan persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Mekanisme ini diwujudkan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang menjadi alat untuk menangkap harapan, pengalaman, dan persepsi warga sebagai penerima layanan (KemenPAN-RB, 2021). Dalam konteks rumah sakit, dimensi ini sangat penting karena mencerminkan aspek subjektif kualitas layanan dari sudut pandang pengguna, yang tidak selalu dapat diukur hanya dengan indikator teknis atau administratif.

Untuk menjembatani antara standar pemerintah dan persepsi masyarakat, pendekatan SERVQUAL (*Service Quality*) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) memberikan kerangka teoritis yang relevan. SERVQUAL mengidentifikasi lima dimensi utama dalam menilai kualitas layanan, yaitu: *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Kelima dimensi ini berfokus pada kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kenyataan layanan yang diterima.

Dalam praktik rumah sakit, dimensi *reliability* berkaitan dengan kemampuan institusi dalam memberikan layanan medis sesuai janji dan standar yang ditetapkan pemerintah. *Responsiveness* mencerminkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam merespons kebutuhan pasien. *Assurance* menyangkut profesionalisme, kompetensi, dan keamanan layanan atau keselamatan pasien, sementara *empathy* menggambarkan sejauh mana rumah sakit mampu memberikan perhatian individual dan empati kepada pasien. *Tangibles* mencerminkan kelayakan sarana dan fasilitas rumah sakit.

Oleh karena itu, *Standard Decision by Government* mencerminkan aspek formal (*supply side*), sedangkan *Performance Index by Citizen* mencerminkan aspek perseptual (*demand side*). Ketika kedua pendekatan ini dikaji dalam perspektif SERVQUAL, maka akan ditemukan kesenjangan (*gap*) kualitas layanan yang menjadi basis untuk intervensi peningkatan mutu berbasis manajemen risiko dan kepuasan pengguna.

Namun, saat ini dalam era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan *service functions*. Ketidakpastian kebijakan, dinamika politik, kemajuan teknologi, hingga ekspektasi publik yang terus berkembang menyebabkan pelayanan publik harus lebih adaptif, proaktif, dan mampu mengelola risiko secara sistematis (OECD, 2020). Ketidakmampuan untuk mengelola risiko dalam lingkungan yang berubah-ubah akan berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di rumah sakit tidak hanya terletak pada aspek teknis prosedural, tetapi juga pada lemahnya fondasi konseptual dan strategis dalam menghadapi dinamika risiko di era VUCA. Lingkungan VUCA yang ditandai oleh *volatilitas*, ketidakpastian, kompleksitas sistem layanan, serta *ambiguitas* dalam regulasi dan pengambilan keputusan, menuntut rumah sakit untuk mampu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola yang adaptif, berbasis data, serta tanggap terhadap perubahan yang tidak terduga dan saling

terkait antar sektor pelayanan. Meskipun berbagai regulasi normatif telah diterbitkan, penerapan ERM di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan seringkali tidak seragam dan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Studi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah, termasuk rumah sakit daerah, belum memiliki mekanisme pemetaan risiko yang komprehensif dan terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya data informasi risiko, serta belum adanya sistem pelaporan risiko yang *real-time* menjadi kendala utama dalam pelaksanaan ERM.

Dalam konteks ini, fenomena empirik yang terjadi tidak hanya mencerminkan kelemahan pada sisi operasional, namun juga menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai organisasi publik belum memiliki sistem ERM yang dapat menjawab dinamika risiko multidimensi secara proaktif dan strategis. Ketiadaan model ERM yang menyatukan pendekatan administratif dan pelayanan publik dalam kerangka yang integratif menjadi salah satu akar masalah. Hal ini diperparah dengan belum adanya sinergi antara prinsip-prinsip tata kelola publik seperti *accountability*, *performance*, dan *citizen orientation* dengan praktik manajemen risiko yang proaktif dan strategis. Meskipun model ERM COSO 2017 telah menawarkan integrasi antara risiko, strategi, dan kinerja, implementasinya dalam konteks rumah sakit masih belum terwujud secara optimal.

Sejumlah studi empiris penerapan ERM di rumah sakit umumnya masih bersifat sektoral atau *silo-based*, di mana fokus penanganan risiko terbatas pada unit atau fungsi tertentu, seperti pengelolaan salah berkas pasien (Nugraheni, 2019; Fanny & Soviani, 2020), rekam medis (Ningsih et al., 2020; Saud et al., 2021), sistem informasi manajemen rumah sakit (Setiawan et al., 2021; Hutagalung, 2022), keselamatan dan kesehatan kerja (Firmansyah, 2022; Purnatimu & Rifai, 2023), serta layanan klinis (Olii et al., 2019; Afifa & Adisasmito, 2021; Izza et al., 2022). Pendekatan *silo* ini menyebabkan manajemen risiko tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam struktur dan proses organisasi rumah sakit, sehingga melemahkan efektivitas mitigasi risiko yang bersifat strategis.

Sebaliknya, berbagai studi internasional telah menunjukkan pentingnya integrasi risiko dalam sistem tata kelola, strategi organisasi, dan teknologi melalui pendekatan ERM yang holistik (Ferdosi et al., 2020; Sajwani, 2022; Darwiesh et al., 2022; Pascarella et al., 2021). Di Indonesia, beberapa penelitian mulai mengarah pada pendekatan ERM strategis (Dewi & Darma, 2019; Pratama, 2024; Dihartawan et al., 2024; Hanggraeni & Maris, 2016), namun belum secara komprehensif mengintegrasikan kerangka teori administrasi

publik seperti *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS).

Lebih lanjut, penerapan ERM di rumah sakit pemerintah umumnya masih bersifat administratif, belum berbasis analisis risiko menyeluruh, dan tidak terintegrasi ke dalam strategi institusi (Widjaja et al., 2021; Mulyono, 2022). Kristanto dan Lisdiono (2025) menyatakan bahwa pelaksanaan ERM di RSUD berstatus BLUD masih terbatas pada penyusunan *risk register* dan *profil risiko*, tanpa integrasi lintas unit maupun tingkatan organisasi, khususnya di fungsi non-klinis dan keuangan. Hardino et al. (2025) juga menemukan bahwa sistem manajemen risiko dalam proses penganggaran dan perencanaan belum berjalan secara konsisten di seluruh bagian organisasi. Bahkan, meskipun aspek teknis seperti identifikasi bahaya dan prosedur operasional standar terbukti mempengaruhi kualitas manajemen risiko (Dihartawan et al., 2023), dimensi kepatuhan (*compliance*) dan strategi (*strategy*) dalam *maturity model* ERM di rumah sakit pemerintah masih berada pada tingkat rendah (Permadi & Hartanti, 2025).

Kondisi tersebut juga tercermin pada studi oleh Hanggraeni & Maris (2016), yang menekankan bahwa rumah sakit menghadapi tingkat risiko yang tidak kalah kompleks dibandingkan sektor perbankan dan jasa keuangan. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai jenis risiko dengan penyebab serta tingkat keparahan yang beragam, sementara alat pengendalian yang digunakan masih belum optimal. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan ISO 31000, risiko operasional merupakan jenis risiko yang paling dominan, diikuti oleh risiko strategis.

Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perbandingan penelitian terdahulu dengan Rencana penelitian

No.	Komponen	Hanggraeni & Maris (2016)	Sajwani (2022)	Rencana penelitian (2025)
1	Judul Penelitian	Penerapan ERM berdasarkan ISO 31000 pada rumah sakit. Studi kasus di RSUD Tarakan Kaltara	<i>Enterprise Risk Management in Healthcare Organization</i> (Master's thesis, <i>The British University in Dubai</i>).	Model <i>Enterprise risk Management</i> (ERM) pada Pelayanan publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta
2	Lokasi Penelitian	Indonesia (Kalimantan Utara)	Dubai	Indonesia (DKI Jakarta)

No.	Komponen	Hanggraeni & Maris (2016)	Sajwani (2022)	Rencana penelitian (2025)
3.	Lokasi Penelitian	RSUD Tipe B Tarakan Kalimantan utara	RS di Dubai	RSUD Tarakan Tipe A di DKI Jakarta
4.	Teori manajemen risiko : ISO 31000	ISO 31000 : 2012		ERM COSO 2017 (Moeller, R. R. (2011))
5.	Metode Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
6.	Temuan Penelitian	Penelitian ini mengidentifikasi berbagai risiko dengan penyebab dan tingkat keparahan beragam, namun pengendaliannya belum optimal. Berdasarkan ISO 31000, risiko dipetakan ke tujuh kategori, dengan risiko operasional paling dominan, diikuti risiko strategis pada 15 unit RS yang diteliti.	Ditemukan bahwa 6 faktor organisasi seperti tata kelola, budaya, pengembangan strategi, penilaian risiko, pemantauan, dan komunikasi memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan ERM. Risiko operasional dan strategis menjadi fokus utama.	Belum ada

Sumber: Diolah Peneliti

Disisi lain, tantangan penerapan ERM di rumah sakit tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga mencerminkan permasalahan pada tataran teoritis. Secara konseptual, belum terdapat integrasi yang kuat antara kerangka manajemen risiko strategis, seperti COSO ERM 2017 dengan teori-teori tata kelola dalam administrasi publik. COSO ERM 2017 menekankan pentingnya integrasi risiko dengan strategi dan kinerja organisasi, namun dalam praktik di sektor publik, pendekatan ini sering kali tidak terakomodasi secara utuh karena model tata kelola publik yang masih bersifat birokratis dan fragmentatif (Moeller, R. R. (2011; OECD, 2020).

Permasalahan teoritis ini terlihat dari belum sinkronnya pendekatan ERM dengan tiga paradigma utama dalam administrasi publik, yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Dalam pendekatan OPA yang bersifat hierarkis dan legalistik, manajemen risiko sering kali dipahami sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari strategi institusional. NPM

menawarkan efisiensi dan orientasi hasil, namun berpotensi mengabaikan aspek legitimasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan risiko. Sementara itu, NPS mengedepankan kolaborasi dan orientasi pada nilai publik, namun belum memiliki instrumen teknokratis yang kuat untuk mengelola risiko strategis dalam organisasi pelayanan (Denhardt & Denhardt, 2015; Frederickson et al., 2016).

Selain itu, literatur tentang manajemen risiko di sektor publik cenderung lebih banyak mengadopsi perspektif privat dan teknokratis, sehingga kurang memperhatikan dimensi-dimensi khas pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan warga negara. Akibatnya, tidak banyak model konseptual yang mampu menjembatani antara kerangka manajemen risiko strategis seperti COSO ERM 2017 dengan nilai-nilai normatif dalam tata kelola sektor publik (Sajwani, 2022; Pascarella et al., 2021).

Persoalan normatif muncul ketika rumah sakit sebagai institusi pelayanan yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah namun juga tunduk pada regulasi teknis dari pemerintah pusat dihadapkan pada diskrepansi norma dan kebijakan. Penerapan ERM berbasis COSO 2017 sebagai pendekatan strategis membutuhkan landasan regulasi yang selaras, konsisten, dan terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Namun, hingga kini, norma-norma hukum yang mengatur kewajiban manajemen risiko di rumah sakit masih menunjukkan fragmentasi substansial.

Di satu sisi, pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Keputusan Gubernur No. 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan integrasi pengelolaan risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran organisasi. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan sebagai regulator sektoral mengeluarkan kebijakan teknis seperti KMK No. 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi dan KMK No. 1354 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang juga mewajibkan penerapan manajemen risiko namun dengan terminologi, pendekatan, dan indikator yang berbeda. Selain itu, secara nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pemerintah mengamankan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor publik secara menyeluruh.

Disharmonisasi ini menimbulkan kebingungan normatif di tingkat implementasi, khususnya dalam hal standar, indikator keberhasilan, dan ruang lingkup manajemen risiko.

Rumah sakit pemerintah sering kali berada di persimpangan antara memenuhi regulasi teknis Kementerian Kesehatan dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaan manajemen risiko menjadi tidak konsisten, sekedar administratif, dan cenderung simbolik tidak berorientasi pada kinerja strategis sebagaimana ditekankan dalam kerangka COSO ERM 2017.

Lebih lanjut, ketiadaan integrasi vertikal dan horizontal antara kebijakan pusat dan daerah menciptakan hambatan dalam menyusun sistem manajemen risiko yang komprehensif dan seragam, padahal keberhasilan penerapan ERM sangat bergantung pada keselarasan kebijakan lintas level pemerintahan (OECD, 2020). Situasi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi yang tidak hanya menyatukan terminologi dan prosedur, tetapi juga mengadopsi kerangka kerja internasional seperti COSO ERM 2017 secara substansial dalam regulasi nasional dan lokal. Kondisi ini juga belum dibarengi dengan kesiapan SDM, infrastruktur, dan sistem manajemen yang matang, menimbulkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan karena kebijakan yang bersifat makro tidak disertai dengan desain mikro yang proaktif dan kontekstual karena belum tersedianya pedoman teknis operasional berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan implementasi manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai organisasi pelayanan publik di sektor kesehatan, rumah sakit memiliki mandat sosial dan hukum untuk menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat (Frederickson, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit memegang peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk dapat menjalankan peran strategis tersebut secara optimal, rumah sakit perlu memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif.

Sejarah penerapan manajemen risiko di rumah sakit, mulai berkembang sejak dekade 1970-an, terutama di negara maju, ketika krisis malpraktik dan tekanan finansial mendorong rumah sakit di Amerika Serikat untuk mengadopsi pendekatan manajemen risiko. Langkah ini merupakan adaptasi dari praktik manajemen risiko di sektor industri dan keuangan sebagai upaya perlindungan terhadap operasional rumah sakit. Dalam konteks historis tersebut, manajemen risiko bukanlah konsep baru, melainkan merupakan respons terhadap kompleksitas dan tingginya eksposur risiko dalam pelayanan kesehatan seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Perhatian global terhadap urgensi penerapan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan meningkat sejak laporan *Institute of Medicine* (IOM) pada tahun 1999, yang mengungkapkan

bahwa kesalahan medis di rumah sakit menyebabkan kematian antara 44.000 hingga 98.000 pasien setiap tahun di Amerika Serikat. Temuan ini menjadi alarm global akan pentingnya reformasi sistem keselamatan pasien dan pengelolaan risiko secara menyeluruh di rumah sakit. (Donaldson, M. S., et al, 2000).

Sejalan dengan hal tersebut, laporan *World Health Organization* (WHO) (2021), juga menyoroti masih tingginya insiden dalam praktik pelayanan kesehatan yaitu sekitar 1 dari 10 pasien mengalami *adverse event* / Kejadian tidak diharapkan (KTD) selama proses pelayanan kesehatan di negara berkembang. Temuan ini mencerminkan adanya celah serius dalam sistem manajemen mutu dan risiko yang belum optimal, serta memperlihatkan bahwa upaya peningkatan keselamatan pasien masih menjadi tantangan global.

Di Indonesia, data dari Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP), jumlah insiden keselamatan pasien meningkat dari 2.506 kasus pada tahun 2022 menjadi 5.710 kasus pada 2023, dan menurun menjadi 4.471 pada 2024. Di Provinsi DKI Jakarta, insiden yang dilaporkan juga meningkat dari 255 kasus (2022) menjadi 536 (2023), lalu menurun menjadi 432 (2024). Di RSUD Tarakan jumlah insiden keselamatan pasien terjadi penurunan 20 kasus pada tahun 2023 menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Fakta ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko, budaya pelaporan, serta keberlanjutan implementasi keselamatan pasien.

Selain tingginya insiden keselamatan pasien, kasus malpraktik medis di Indonesia juga menunjukkan urgensi pengelolaan risiko di rumah sakit sebagai upaya melindungi pasien dan meningkatkan kualitas layanan. Data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menunjukkan bahwa selama periode 2006–2012 terdapat 306 pengaduan dugaan malpraktik yang ditangani Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sementara itu, menurut Wibisono dalam (Agustina & Hariri, 2022), terdapat 182 gugatan malpraktik pada periode yang sama. Jumlah gugatan terus meningkat, dengan 10 kasus pada 2015, 30 kasus pada 2016, 38 kasus pada 2017, dan 33 kasus hanya dalam enam bulan pertama 2018 (Lubis, 2020). Tren tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko sebagai mekanisme proteksi terhadap insiden keselamatan pasien dan litigasi hukum belum berjalan optimal. Kondisi ini juga mencerminkan adanya keterkaitan berbagai kategori risiko, baik klinis maupun non-klinis, seperti risiko operasional, reputasi, kepatuhan, hukum, dan keuangan, yang seluruhnya perlu dikelola secara terpadu.

Meskipun data resmi kasus malpraktek lima tahun terakhir belum tersedia secara publik, malpraktek tetap menjadi masalah krusial karena berdampak pada keselamatan

pasien, kepercayaan masyarakat, dan kualitas layanan. Linu *et al.* (2025) menunjukkan bahwa berbagai kasus yang dilaporkan media mencerminkan lemahnya pengendalian risiko di fasilitas kesehatan. Contohnya, pada 2019 terdapat kasus kelumpuhan serta hilang ingatan setelah pencabutan gigi, pada 2022 terjadi kematian bayi dalam rahim akibat kegagalan penanganan persalinan di fasilitas primer dan pada 2023 seorang bayi mengalami amputasi jari akibat kelalaian tenaga Kesehatan. Dalam konteks kasus malpraktek di RSUD Tarakan, laporan dari media oleh Fransisca L (2025), terdapat kasus pasien yang meninggal setelah operasi usus buntu akibat dugaan kelalaian dalam penanganan pasca-operasi dan komunikasi yang buruk kepada keluarga.

Selain risiko keselamatan pasien dan malpraktik, rumah sakit juga menghadapi risiko keuangan, terlihat dari keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 5 triliun (3%) dari total klaim 175,1 triliun pada tahun 2024 (Deonisia, A. 2025), yang menimbulkan masalah likuiditas, keterlambatan pembayaran vendor, dan penundaan insentif bagi tenaga kesehatan (BPJS Kesehatan, 2020; Kemenkeu RI, 2019). Risiko SDM tercermin dari temuan bahwa 41,5% tenaga kesehatan mengalami *burnout* sedang hingga berat selama pandemi COVID-19, yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2021b). Risiko teknologi muncul ketika terjadi gangguan terhadap SIMRS rumah sakit pada 2023 yang menyebabkan lumpuhnya layanan selama tiga hari dan kebocoran data 230.000 pasien, menimbulkan kerugian reputasi serta potensi litigasi (Kemkominfo RI, 2023).

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa rumah sakit membutuhkan penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghadapi berbagai risiko secara efektif. Dalam konteks ini, ERM menurut COSO ERM (2004) sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen dan seluruh personel dalam organisasi, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh tingkatan organisasi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat memengaruhi organisasi dan untuk mengelola risiko sesuai dengan tingkat selera risiko (*risk appetite*) organisasi, guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi (Moeller, 2011).

Pendekatan komprehensif berarti penerapan manajemen risiko mulai dari Dewan Direksi, Manajemen dan seluruh personel dalam organisasi pada seluruh tingkatan organisasi yaitu Strategis, Taktis, dan Operasional (STO). Menurut Alijoyo (2022) dan Wibowo, A (2022)), ERM adalah pendekatan yang luas, proaktif, dan terukur yang menggabungkan informasi tentang risiko pada semua tingkatan organisasi yaitu: 1).

Strategis, karena risiko yang terkait dengan opsi strategis yang berbeda akan dianalisis sepenuhnya dan keputusan strategis yang lebih baik akan dicapai. ERM diintegrasikan ke dalam visi, misi, kebijakan, dan perencanaan strategis organisasi, serta menjadi dasar penetapan tujuan strategis, *risk appetite*, dan alokasi sumber daya 2). Taktis, karena pertimbangan akan diberikan pada pemilihan taktis dan risiko yang terlibat dalam alternatif yang tersedia. ERM diwujudkan melalui penyusunan *risk register*, serta penerapan sistem monitoring dan pelaporan risiko untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial 3). Operasional, karena kejadian yang dapat menyebabkan gangguan akan diidentifikasi terlebih dahulu dan tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian tersebut, membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kejadian tersebut dan menanggung biaya kejadian tersebut. ERM diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari staf di seluruh unit kerja, melalui identifikasi risiko klinis dan non-klinis, *incident reporting*, mitigasi risiko dan pelatihan keselamatan pasien. ERM sangat penting untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, mendorong kinerja, dan memberikan perlindungan kepada organisasinya.

Pendekatan terintegrasi dalam manajemen risiko bermakna bahwa pengelolaan risiko bukanlah program terpisah, melainkan bagian yang melekat dalam seluruh aktivitas rumah sakit. *Enterprise Risk Management* (ERM) diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi, sehingga risiko menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis. (Moeller, R. R, 2011). Pendekatan ini mencakup semua jenis risiko, baik risiko klinis maupun non-klinis, serta seluruh kategori risiko meliputi risiko operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi dan risiko strategis. (Frigo & Anderson, 2011); WHO, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, ASHRM (*American Society for Health Care Risk Management*), (2020), menyatakan bahwa domain risiko dalam pelayanan kesehatan meliputi risiko klinis terkait keselamatan pasien, risiko finansial, operasional, strategis, sumber daya manusia, legal / regulasi, teknologi, dan *hazard*.

Praktik penerapan ERM di rumah sakit telah banyak dikembangkan di berbagai negara sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola organisasi, kualitas pelayanan, dan keselamatan pasien. Salah satu negara yang telah menerapkan ERM secara komprehensif adalah Inggris, ERM diterapkan di sektor publik termasuk rumah sakit NHS (*National Health Service*) melalui *HM Treasury Orange Book* (2020) sebagai pedoman manajemen risiko terstruktur. Setiap *NHS Trust* wajib memiliki *Board Assurance Framework* (BAF) yang mengintegrasikan ERM dalam tata kelola dan pengambilan keputusan strategis, mencakup risiko strategis, klinis, operasional, finansial, hukum, dan reputasi (HM

Treasury, 2020; NHS England, 2016). Selain Inggris, Australia juga telah menerapkan ERM di sektor kesehatan, yang mengacu pada ISO 31000:2018, dengan *NSW (New South Wales) Health* menerapkan *Enterprise Risk Management Framework* pada seluruh rumah sakit publik. Framework ini mengintegrasikan risiko strategis, klinis, operasional, dan finansial untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan (NSW Government, 2020; Standards Australia, 2018). Sedangkan di Amerika Serikat, ASHRM mengembangkan *ERM Integrated Framework* yang diterapkan di seluruh rumah sakit mencakup risiko klinis/pasien, strategis, operasional, teknologi, finansial, hukum, dan *hazard*. *Mayo Clinic* dan *Cleveland Clinic* mengadopsi ERM untuk mendukung tata kelola dan keselamatan pasien (ASHRM, 2014; Baker, 2017). Sementara itu, Kanada juga menunjukkan komitmen dalam penerapan ERM di rumah sakit, *Canadian Patient Safety Institute* (CPSI) mendorong penerapan ERM untuk keselamatan pasien dan kualitas layanan, serta *Ontario Hospital Association* (OHA) menerbitkan *ERM Toolkit* bagi rumah sakit di Ontario sebagai pedoman pengelolaan risiko terpadu (*Ontario Hospital Association*, 2010), (*Canadian Patient Safety Institute*, 2015). Secara keseluruhan, *best practice* ERM rumah sakit menekankan integrasi risiko strategis hingga *hazard*, adanya *framework* nasional atau regional, keterlibatan manajemen puncak untuk keberhasilan implementasi.

Sementara itu di Indonesia, penerapan manajemen risiko, pada awalnya lebih dominan di sektor keuangan dan perbankan. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut dianggap memiliki eksposur risiko yang tinggi dan memerlukan pengaturan yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah memainkan peran penting dalam memastikan manajemen risiko di sektor ini terlaksana dengan baik, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (Priyarsono, 2023).

Namun demikian, meskipun secara normatif kerangka regulasi telah tersedia, realisasi implementatif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Alijoyo (2022), penerapan manajemen risiko secara optimal masih terbatas di sebagian organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi antara lain: (1) anggapan bahwa manajemen risiko hanya relevan bagi lembaga keuangan; (2) ketergantungan pada regulasi umum seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tanpa adanya penjabaran teknis yang spesifik; dan (3) rendahnya literasi risiko di kalangan birokrat yang menyebabkan miskonsepsi terhadap konsep dan fungsi manajemen risiko. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Padahal, literatur dan studi empiris telah banyak menunjukkan bahwa integrasi

manajemen risiko dalam tata kelola instansi publik mampu meningkatkan efektivitas layanan dan menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam konteks ini, rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik yang kompleks juga harus dikelola secara efektif melalui sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh elemen organisasi guna memastikan pencapaian hasil pelayanan yang optimal (Rainey, 2009). Kompleksitas rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik tercermin dari karakteristiknya yang padat modal, padat karya, dan padat risiko. Padat modal mengindikasikan bahwa rumah sakit memerlukan investasi besar, baik dalam bentuk infrastruktur, peralatan medis, maupun pengembangan sumber daya manusia. Padat karya berarti rumah sakit melibatkan sejumlah besar tenaga kerja dari berbagai bidang, mulai dari tenaga medis hingga tenaga penunjang non medis. Sementara itu, padat risiko merujuk pada beragam risiko yang dihadapi rumah sakit, baik risiko klinis maupun risiko non-klinis. Dengan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem keselamatan pasien, dan memastikan tercapainya tujuan institusi secara lebih efektif dan efisien. Sebagaimana dikemukakan oleh Daud (2007), proses manajemen risiko yang terintegrasi memainkan peran penting dalam mempercepat pencapaian sasaran organisasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik di sektor kesehatan.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen risiko yang lebih terstruktur dalam sektor kesehatan juga tercermin dari tren akademik di tingkat global. Berdasarkan kajian literatur yang terindeks di Scopus selama periode 2015–2024, tercatat sebanyak 252 publikasi yang membahas topik manajemen risiko di rumah sakit dan layanan Kesehatan. (Daud, A, et al, 2025). Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan manajemen risiko yang lebih integratif, sistematis, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, sejumlah pakar menyatakan bahwa manajemen risiko bukan lagi sekadar alat kontrol, melainkan instrumen proaktif dan preventif dalam mengelola tantangan operasional rumah sakit secara komprehensif. Donaldson, L, al. (2022) dan Yostin *et al.* (2023) mengidentifikasi delapan faktor utama yang mendasari pentingnya manajemen risiko, yakni: (1) tingginya insiden keselamatan pasien akibat kesalahan medis; (2) kompleksitas operasional; (3) tekanan hukum dan regulasi; (4) kerugian finansial akibat klaim; (5) kesiapsiagaan terhadap krisis dan bencana; (6) dampak terhadap kepuasan pasien; (7) risiko teknologi dan keamanan data; serta (8) ancaman terhadap keberlanjutan dan reputasi institusi.

Perhatian terhadap pentingnya manajemen risiko dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dimulai sejak tahun 2005, saat standar keselamatan pasien resmi menjadi komponen wajib dalam proses akreditasi rumah sakit. Langkah ini menjadi tonggak awal manajemen risiko dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di rumah sakit Indonesia masih berfokus pada aspek keselamatan pasien (risiko klinis), khususnya di level operasional dan taktis, dengan integrasi risiko ke dalam perencanaan strategis, penganggaran, dan tata kelola organisasi masih terbatas. Di tingkat taktis, sebagian besar rumah sakit telah membentuk sub-komite manajemen risiko atau tim mutu yang menyusun kebijakan, risk register, dan melakukan monitoring, meskipun fokusnya masih dominan pada risiko klinis dan belum mencakup risiko non klinis seperti reputasi, fraud, dan risiko strategis secara menyeluruh. Pada tingkat operasional, penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui identifikasi risiko, sistem pelaporan insiden (*incident reporting*), dan analisis insiden keselamatan pasien, sebagaimana diatur dalam Akreditasi STARKES (Standar Akreditasi Rumah Sakit), Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). (Kusnadi J. 2023).

Berbagai tantangan penerapan ERM di rumah sakit meliputi rendahnya komitmen pimpinan, lemahnya tata kelola ERM, sistem informasi manajemen risiko yang belum terintegrasi, serta rendahnya budaya sadar risiko (Raczkowski, 2017; Ari Y, 2020; Soleh, 2020). Komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh elemen organisasi menjadi fondasi utama untuk membangun manajemen risiko yang tangguh dan adaptif. Dengan fondasi tersebut, ERM tidak hanya memastikan pencapaian kinerja organisasi (de Souza et al., 2020), tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya pembelajaran berkelanjutan (Cichoń, 2018)

Tata kelola ERM yang efektif membutuhkan peran aktif pimpinan dan Dewan pengawas untuk memastikan integrasi manajemen risiko ke dalam strategi organisasi. Namun, banyak rumah sakit belum memiliki struktur Tata kelola ERM yang jelas dan kuat (Moeller, R. R. (2011; Frigo & Anderson, 2011). Sistem informasi manajemen risiko juga masih lemah, di mana sebagian besar rumah sakit belum menggunakan sistem terintegrasi sehingga proses identifikasi dan pelaporan risiko masih manual, lambat, dan tidak *real-time*, yang menghambat pengambilan keputusan (WHO, 2021). Selain itu, budaya sadar risiko masih rendah sehingga tenaga kesehatan enggan melaporkan insiden karena takut disalahkan (*blaming culture*), kurangnya *feedback*, dan tingginya beban kerja serta minimnya dukungan manajemen. (Putra & Hendrawan, 2024, Nurdin & Wibowo A, 2022).

Selain itu pemahaman konsep ERM secara utuh masih rendah, dengan implementasi yang umumnya terbatas pada penyusunan *risk register* dan pelaporan insiden, keterbatasan SDM yang kompeten di bidang ERM karena pelatihan lebih banyak difokuskan pada aspek *patient safety*. (Budiani, et al. 2025). Berbeda dengan lembaga keuangan yang diwajibkan menerapkan ERM oleh OJK, hingga kini belum ada regulasi yang mewajibkan penerapan ERM secara *enterprise-wide* di rumah sakit publik. Frączkiewicz-Wronka *et al.* (2021) menegaskan bahwa manajemen risiko perlu dipahami bukan hanya sebagai alat kontrol, melainkan juga sebagai pendorong kinerja organisasi yang berkelanjutan.

Menariknya, di tengah berbagai tantangan tersebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 31 Mei 2025, dari total 3.236 rumah sakit yang teregistrasi, sebanyak 3.130 rumah sakit (96,72%) telah terakreditasi, dan 84% di antaranya (2.630 rumah sakit) berstatus Paripurna, yaitu status tertinggi dalam standar akreditasi nasional. Namun demikian, capaian tinggi akreditasi termasuk status Paripurna belum sepenuhnya mencerminkan penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem survei cenderung fokus pada pemenuhan bukti dokumentasi seperti program manajemen risiko, *risk register*, dan profil risiko untuk kepatuhan standar, sementara aspek implementasi nyata kurang terdokumentasi. Akibatnya, banyak rumah sakit hanya memenuhi formalitas standar akreditasi, tanpa memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah diimplementasikan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi ke dalam seluruh proses organisasi. Temuan ini selaras dengan tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa efektivitas akreditasi dalam meningkatkan *outcome* manajemen risiko masih belum terbukti secara konsisten, dan penerapannya lebih banyak bersifat kepatuhan dokumen dibandingkan perubahan nyata dalam praktik internal (Hussein et al., 2021).

Oleh karena itu untuk menjawab tantangan, *empirical problem*, *theoretical problem* dan *normative problem*, dibutuhkan Model *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terintegrasi dan berorientasi strategis untuk mengelola risiko secara proaktif, dan holistik, guna mendukung peningkatan mutu dan akuntabilitas pelayanan untuk memastikan pelayanan publik rumah sakit yang efektif, aman, berkelanjutan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip *good governance*. *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis kerangka COSO 2017 menjadi relevan untuk menjawab tantangan tersebut. COSO ERM 2017 tidak hanya fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko, tetapi juga mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan, pencapaian kinerja, dan penciptaan nilai publik (Moeller, 2011). Dengan penerapan ERM, institusi publik dapat lebih proaktif

dalam mengenali potensi risiko yang menghambat pelayanan dan mengembangkan kapasitas adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Hal inilah yang menjadi dasar penting dalam pengembangan Model *Enterprise Risk Management* (ERM) pada organisasi rumah sakit yang kontekstual dan berbasis administrasi public, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kompleksitas pelayanan kesehatan di era VUCA, sekaligus memperkuat kapabilitas institusi dalam menciptakan nilai publik secara berkelanjutan. Disisi lain diperlukan harmonisasi regulasi manajemen risiko antara pusat, provinsi, dan rumah sakit yang tidak hanya menetapkan norma hukum, tetapi juga panduan teknis, struktur kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat rumah sakit agar dapat menerapkan ERM secara adaptif, sistematis, dan berkelanjutan.

1. Research Gap

a. Empirical Gap

Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di rumah sakit publik di Indonesia masih bersifat parsial, administratif, dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses tata kelola rumah sakit. Pendekatan yang digunakan masih *silo based*, terbatas pada unit atau aspek tertentu seperti rekam medis, keselamatan kerja, atau sistem informasi, tanpa integrasi lintas unit dan fungsi strategis. Selain itu, belum ada sistem pelaporan risiko yang *real time*, peta risiko institusional yang menyeluruh, ataupun pengelolaan risiko yang terhubung langsung dengan perencanaan dan penganggaran (BPKP, 2023; Nugraheni, 2019; Widjaja et al., 2021; Kristanto & Lisdiono, 2025). *Empirical gapnya* adalah belum tersedia model ERM yang *evidence based*, terintegrasi, dan kontekstual bagi rumah sakit publik untuk menjawab tantangan manajemen risiko dalam lingkungan VUCA secara efektif. *Gap* ini juga menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara eksplisit memposisikan paradoks pelayanan kesehatan sebagai sumber risiko strategis dalam kerangka ERM.

b. Theoretical Gap

Secara teoritis, belum terdapat integrasi yang memadai antara kerangka ERM strategis seperti COSO ERM 2017 dengan teori administrasi publik kontemporer. Pendekatan COSO masih dominan digunakan di sektor privat, sementara teori-teori seperti OPA, NPM, dan NPS belum banyak diadaptasi ke dalam model manajemen risiko di rumah sakit pemerintah. Literatur cenderung tidak menjembatani kebutuhan pengelolaan risiko strategis dengan nilai-nilai

tata kelola publik seperti akuntabilitas, partisipasi, dan penciptaan nilai publik. *Theoretical gapnya* adalah belum ada model konseptual yang mengintegrasikan COSO ERM 2017 dengan paradigma administrasi publik (OPA, NPM, NPS) untuk pengelolaan risiko strategis di rumah sakit pemerintah dalam menghadapi lingkungan VUCA.

c. Normative Gap

Terdapat disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerapan manajemen risiko. Regulasi seperti PP No. 60/2008, Perpres No. 39/2023, KMK No. 1128/2022, KMK No. 1354/2024, dan berbagai peraturan daerah seperti Pergub No. 122/2020 dan Kepgub No. 153/2021, belum sepenuhnya terintegrasi baik dalam substansi, terminologi, maupun pendekatan. Akibatnya, rumah sakit sebagai objek pengaturan mengalami kebingungan dalam implementasi, yang berdampak pada ketidakkonsistenan dan lemahnya keberlanjutan sistem manajemen risiko. *Normative gapnya* Adalah belum terdapat harmonisasi regulasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yang mendukung penerapan ERM strategis secara konsisten di rumah sakit publik.

2. Fenomena

Pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di RSUD DKI Jakarta, menghadapi kompleksitas risiko yang tinggi. Fenomena yang menonjol adalah masih tingginya angka insiden keselamatan pasien, kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19, tingginya kasus malpraktek, budaya sadar risiko yang belum terbentuk, keterbatasan anggaran, rendahnya komitmen pimpinan terhadap manajemen risiko serta keterbatasan SDM. Penerapan manajemen risiko yang ada saat ini di banyak rumah sakit masih bersifat *silo* dan bersifat responsif terhadap kejadian (reaktif), bukan preventif. Di sisi lain, disharmonisasi regulasi dan belum tersedianya pedoman teknis penerapan manajemen risiko di rumah sakit, meskipun telah ada dorongan dari berbagai kebijakan pemerintah.

Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari paradoks sistem pelayanan kesehatan, di mana peningkatan akses layanan tidak selalu diikuti oleh kesiapan kapasitas dan keberlanjutan sumber daya.

3. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terintegrasi dalam konteks rumah sakit sebagai *public*

enterprise, dengan menggabungkan kerangka COSO ERM 2017 dan hibridisasi paradigma administrasi publik (OPA, NPM, dan NPS). Model ini mencakup seluruh tingkatan organisasi (Strategis, Taktis, Operasional) serta mengintegrasikan risiko klinis dan non-klinis secara holistik dalam menghadapi dinamika lingkungan VUCA.

Penelitian ini juga memposisikan paradoks pelayanan Kesehatan antara tuntutan akses, mutu layanan, dan keberlanjutan sumber daya sebagai risiko strategis yang dikelola dalam kerangka ERM. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara penciptaan nilai publik (*public value*), keberlanjutan organisasi (*sustainability*), dan ketahanan organisasi (*organizational resilience*) dalam satu Model manajemen risiko yang adaptif dan berorientasi kinerja.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, rumusan masalah berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana Model *Enterprise risk management* (ERM) pada pelayanan publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Model *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dapat diterapkan secara komprehensif, terstruktur, dan kontekstual di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi aktual penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta
3. Merumuskan Model ERM di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan risiko organisasi sektor publik melalui pendekatan ERM, yang selama ini masih terbatas penerapannya dalam konteks rumah sakit di Indonesia. Sebagai referensi bahan kajian, informasi untuk melengkapi kepustakaan dalam mempelajari ERM di rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan rekomendasi berbasis data kepada manajemen rumah sakit dan pemerintah Pusat dan Daerah dalam merancang kebijakan manajemen risiko yang lebih efektif, integratif, dan aplikatif.
- b. Diharapkan menjadi panduan penerapan ERM di rumah sakit sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Diharapkan penelitian ini akan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengelola rumah sakit tentang bagaimana menerapkan ERM di rumah sakit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988), administrasi publik merupakan suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam ranah kebijakan publik. Rosenbloom et al. (2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, struktur, dan mekanisme guna mencapai tujuan bersama. Ruang lingkup administrasi publik sendiri mencakup berbagai aspek fundamental, yaitu: (1) kebijakan publik, (2) birokrasi publik, (3) manajemen publik, (4) kepemimpinan, (5) pelayanan publik, (6) administrasi kepegawaian, (7) kinerja organisasi, dan (8) etika dalam administrasi publik. Seluruh elemen tersebut saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Sellang, 2016).

a Perkembangan Paradigma Administrasi publik

Pelayanan publik pada abad ke-21 mengalami kemajuan dramatis ditandai dengan globalisasi dan pluralisasi penyediaan layanan yang memberikan kekuatan pendorong terhadap perubahan dalam kebijakan yang sering bersifat kompleks dan global (Slomski, 2022). Perubahan ini tentunya berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut juga mendorong tuntutan reformasi birokrasi yang tidak lagi berorientasi pada prosedur semata, tetapi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Daraba, 2009). Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, telah terjadi evolusi paradigma dalam administrasi publik yang memengaruhi cara pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai, tujuan, serta pendekatan dalam tata kelola sektor publik dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi tiga paradigma utama yang menandai perkembangan pemikiran dan praktik administrasi publik, yaitu: 1).

Old Public Administration (OPA), yang menekankan pada hierarki birokrasi, kepatuhan terhadap aturan, dan efisiensi melalui struktur yang terpusat; 2) *New Public Management* (NPM), yang mengadopsi prinsip-prinsip manajerial sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas berbasis hasil, dan orientasi pasar dalam pelayanan publik; dan 3) *New Public Service* (NPS), yang menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dalam proses pemerintahan, dengan fokus pada partisipasi, nilai-nilai demokratis, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar kepuasan pelanggan. Ketiga paradigma ini mencerminkan dinamika perubahan dalam administrasi publik yang terus berkembang seiring dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.

1) *Old Public Administration* (OPA)

Old Public Administration (OPA) merupakan paradigma klasik dalam administrasi publik yang telah meletakkan fondasi bagi perkembangan pelayanan publik modern. Paradigma ini berkembang pada awal abad ke-20 dengan berlandaskan pada pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional (Weber, 1947a). Wilson (1887) melalui esainya "*The Study of Administration*" memberikan kontribusi signifikan dengan mengusulkan pemisahan tegas antara politik dan administrasi, dimana politisi bertugas membuat kebijakan sementara administrator menjalankan kebijakan tersebut secara profesional dan netral. Fayol (1949) dan Taylor (1911) turut berkontribusi dengan mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan administrasi yang menjadi basis bagi praktik pelayanan publik dalam paradigma OPA, menekankan hierarki, spesialisasi, dan standarisasi prosedur untuk mencapai efisiensi organisasi.

OPA memiliki karakteristik *distingtif* yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Hughes, O,E (2012), OPA berfokus pada struktur organisasi hierarkis dengan rantai komando yang jelas, formalisasi aturan dan prosedur, serta profesionalisme birokrasi. Gulick dan Urwick (1937) mengembangkan prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang menjadi panduan dalam praktik administrasi publik tradisional. Dalam paradigma ini, pelayanan publik diselenggarakan dengan mengutamakan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur standar dengan asumsi bahwa

standardisasi akan menghasilkan pelayanan yang adil dan efisien (Shafritz *et al.*, 2017). Frederickson *et al.* (2012) menambahkan bahwa OPA menekankan nilai-nilai netralitas, integritas, dan kompetensi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pelayanan publik, OPA tidak terlepas dari kritik. Merton (1962) mengidentifikasi disfungsi birokrasi yang seringkali muncul dalam paradigma OPA, seperti perilaku ritualistik, resistensi terhadap perubahan, dan pengabaian terhadap kebutuhan spesifik masyarakat. Crozier (1964) menjelaskan bahwa birokrasi yang kaku cenderung lambat dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kritik terhadap OPA semakin menguat pada tahun 1970-an dan 1980-an, sebagaimana dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang mengidentifikasi ketidakmampuan birokrasi tradisional dalam menghadapi kompleksitas permasalahan publik kontemporer, memunculkan kebutuhan akan paradigma baru dalam administrasi publik.

2) *New Public Management (NPM)*

New Public Management (NPM) merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang muncul pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an sebagai respons terhadap keterbatasan model birokrasi tradisional. Hood (1991) dalam karya klasiknya mendeskripsikan NPM sebagai seperangkat doktrin administratif yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam administrasi publik. Osborne dan Gaebler (D. Osborne & Gaebler, 1992) mempopulerkan konsep "*reinventing government*" yang berfokus pada peran pemerintah sebagai katalisator yang "mengarahkan, bukan mendayung" dalam penyediaan pelayanan publik. Karakteristik utama NPM menurut Pollitt & Bouckaert (2017) meliputi fokus pada efisiensi, pengukuran kinerja berbasis output, desentralisasi, mekanisme pasar, dan orientasi pada pengguna layanan sebagai "pelanggan".

Implementasi NPM dalam pelayanan publik telah menghasilkan berbagai inovasi dalam penyediaan dan pengelolaan layanan. Boston (2000) menjelaskan bahwa reformasi berbasis NPM mendorong restrukturisasi organisasi publik menjadi unit-unit yang lebih kecil dan fokus pada fungsi inti. Selain itu, Ferlie (1996) mengidentifikasi empat model NPM yang

berbeda: model efisiensi, model *downsizing* dan desentralisasi, model keunggulan, dan model orientasi pelayanan publik. Dunleavy (2006) menambahkan bahwa NPM telah mendorong disagregasi struktur birokrasi, kompetisi dalam penyediaan layanan publik, dan insentivisasi manajemen publik yang menekankan kinerja dan hasil terukur.

Pengaruh NPM terhadap kualitas pelayanan publik telah menjadi subjek berbagai penelitian. Kettl (2005) berargumen bahwa penekanan NPM pada penilaian kinerja dan akuntabilitas telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan responsivitas pelayanan publik. Christensen & Lægreid (2007) mengobservasi bahwa fragmentasi akibat reformasi NPM dapat menghasilkan tantangan koordinasi dan koherensi kebijakan, sementara itu Denhardt dan Denhardt (2015) mengkritik orientasi "pelanggan" dalam NPM yang dianggap mengabaikan peran warga negara sebagai pemilik kolektif layanan publik.

Evolusi NPM dalam dekade terakhir menunjukkan adaptasi dan transformasi lebih lanjut. Lapsley (2009) mengidentifikasi bahwa meskipun menghadapi kritik, prinsip-prinsip NPM tetap memengaruhi reformasi administrasi publik di berbagai negara. Osborne (2010) mengemukakan bahwa NPM telah bergeser menuju paradigma *New Public Governance* (NPG) yang menekankan kerja sama jaringan dan ko-produksi layanan publik. (O'Flynn, 2007) menambahkan bahwa perkembangan post NPM mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan efisiensi dengan nilai-nilai sosial dan politik dalam pelayanan publik. Lodge & Gill (2011) mengamati bahwa di banyak negara, reformasi pelayanan publik kontemporer menunjukkan hibridisasi antara elemen NPM dan pendekatan lain, termasuk *Digital Era Governance* yang diidentifikasi oleh Dunleavy (2006) sebagai paradigma yang mengatasi fragmentasi melalui reintegrasi berbasis teknologi digital.

Dalam konteks negara berkembang, penerapan NPM menunjukkan variasi dan adaptasi unik. Manning (2001) menjelaskan bahwa reformasi NPM di negara berkembang sering dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks lokal, kapasitas administratif, dan kerangka institusional yang berbeda. Sarker (2006) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti kapasitas administratif, sistem politik, dan tingkat pembangunan ekonomi

memengaruhi keberhasilan implementasi NPM. Adapun Polidano (1999) menegaskan bahwa negara berkembang cenderung mengadopsi elemen-elemen NPM secara selektif daripada mengimplementasikan reformasi secara menyeluruh. Studi oleh McCourt (2008) menunjukkan bahwa konteks sosial, budaya, dan institusional memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana prinsip-prinsip NPM diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan publik di berbagai negara.

3) *New Public Service (NPS)*

New Public Service (NPS) muncul sebagai paradigma alternatif dalam administrasi publik yang merespons kritik terhadap pendekatan *New Public Management (NPM)* yang dianggap terlalu berorientasi pada nilai-nilai pasar. Denhardt dan Denhardt (2000) memperkenalkan konsep NPS melalui artikel mereka "*The New Public Service: Serving Rather than Steering*". Mereka mengadvokasi pergeseran dari "mengarahkan" ke "melayani" dengan prinsip dasar bahwa peran utama pegawai publik adalah membantu warga negara dalam mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama, bukan mengendalikan atau mengarahkan masyarakat ke arah baru. Denhardt dan Denhardt (2015) menegaskan bahwa NPS berlandaskan pada nilai-nilai demokratis, kewarganegaraan, dan kepentingan publik yang menekankan bahwa pemerintah seharusnya melayani warga negara, bukan pelanggan.

Sejalan dengan paradigma *New Public Service*, Supriyono (2001) menegaskan bahwa responsivitas dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sektor publik yang demokratis. Organisasi publik dituntut tidak hanya mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya, tetapi juga mampu secara aktif merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Dalam perkembangan administrasi publik kontemporer, penerjemahan nilai-nilai NPS ke dalam praktik organisasi menuntut desain birokrasi yang lebih adaptif. Penelitian oleh *Agile bureaucracy for public policy accountability* menunjukkan bahwa pembangunan model *agile* dalam implementasi kebijakan publik membantu tim tata kelola menghasilkan output berkualitas tinggi secara cepat melalui perubahan pola pikir yang memprioritaskan visi strategis yang jelas dibandingkan detail yang preskriptif. Pendekatan ini memfasilitasi kepemimpinan dan struktur

organisasi yang fleksibel, kerja tim lintas fungsi, penguatan ekosistem talenta, serta budaya dan perilaku kolaboratif. Ketika diterapkan secara luas, birokrasi *agile* terbukti memecah *silo* fungsional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberdayakan aparatur, sehingga selaras dengan tuntutan tata kelola adaptif dalam paradigma *New Public Service*. (Aripin, S., & Samboteng, L., 2021).

NPS mendasarkan fondasi teoretisnya pada teori demokrasi, pendekatan-pendekatan positif dan alternatif terhadap teori organisasi, serta humanisme organisasi. Perry (2007) menjelaskan bahwa NPS menekankan motivasi pelayanan publik sebagai dorongan altruistik untuk melayani kepentingan publik, yang berbeda dengan asumsi NPM tentang *self-interest*. Sejalan dengan itu, Box (2015) menyoroti pentingnya dialog dan deliberasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan legitimasi demokratis dalam pelayanan publik. King dan Stivers (1998) berkontribusi pada pengembangan NPS dengan menekankan konsep "administrasi sebagai kewarganegaraan" yang memandang administrator sebagai fasilitator dalam proses pemerintahan yang melibatkan warga negara secara aktif.

Dalam konteks ini, Ginting, G (2016) memandang organisasi publik sebagai agen perubahan yang berperan strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan lintas sektor, yang secara konseptual selaras dengan prinsip-prinsip partisipasi dan kolaborasi yang diusung oleh paradigma NPS.

Prinsip-prinsip utama NPS secara komprehensif diuraikan oleh Denhardt dan Denhardt (2015) yang meliputi: melayani warga negara bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, menghargai kewarganegaraan di atas kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, mengakui kompleksitas akuntabilitas, melayani daripada mengendalikan, dan menghargai orang, bukan hanya produktivitas. Osborne (2010a) menambahkan bahwa NPS mendorong pendekatan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi non-profit, dan warga masyarakat. Bryson *et al.* (2014) menyoroti bahwa pendekatan NPS sangat relevan untuk menghadapi "masalah jahat" (*wicked problems*) yang memerlukan kerja

sama lintas sektoral dan keterlibatan warga dalam proses pemecahan masalah.

Model penciptaan *public value* yang dikemukakan oleh Ginting (2016) memberikan penguatan empiris terhadap paradigma NPS, dengan menegaskan bahwa nilai publik dapat diciptakan secara sistematis melalui inovasi kelembagaan, kolaborasi multi-aktor, dan pemanfaatan teknologi digital dalam organisasi publik.

Implementasi NPS dalam praktik pelayanan publik telah menunjukkan beragam bentuk dan pendekatan. Nabatchi (2010) mendokumentasikan berbagai praktik deliberasi publik yang mencerminkan nilai-nilai NPS dalam pengambilan keputusan administratif. Thomas (2013) menganalisis bagaimana keterlibatan warga negara dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi pelayanan publik. Studi oleh Moynihan *et al.* (2011) menunjukkan bahwa organisasi yang mengadopsi nilai-nilai NPS cenderung memfasilitasi pembelajaran dan adaptasi yang lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sementara itu, Williams dan Shearer (2011) mengidentifikasi bahwa konsep nilai publik yang dikembangkan Moore (1997) memberikan kerangka evaluatif yang kompatibel dengan paradigma NPS untuk menilai kinerja organisasi publik berdasarkan nilai yang mereka ciptakan bagi masyarakat.

Perkembangan NPS menunjukkan konvergensi dengan perspektif pelayanan publik lainnya dan adaptasi terhadap konteks kontemporer. Osborne (2010) mengemukakan konsep *New Public Governance* (NPG) yang memiliki banyak kesamaan dengan NPS dalam penekanannya pada jaringan, kemitraan, dan pluralisme dalam penyediaan layanan publik. Dalam era digital, Dunleavy (2006) mengemukakan bahwa *Digital Era Governance* dapat melengkapi NPS dengan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi warga dan transparansi. Adapun Ansell & Gash (2018) mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip NPS dengan kerangka institusional untuk mengatasi tantangan koordinasi dalam penyediaan layanan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Tantangan dan kritik terhadap NPS juga menjadi bagian dari diskusi akademik. Jordan (2014) mempertanyakan implementasi praktis dari ideal

demokratis NPS dalam struktur administratif yang ada. Dahl & Soss (2014) mengidentifikasi ketegangan antara nilai-nilai NPS dan realitas politik yang sering membatasi ruang partisipasi warga. Sementara itu, DeLeon & Denhardt (2000) mengakui bahwa meskipun NPS menawarkan visi normatif yang menarik, implementasinya memerlukan perubahan signifikan dalam budaya organisasi dan pengembangan kapasitas baru di kalangan administrator publik maupun warga negara. Rhodes (2016) menambahkan dimensi kritis dengan mengingatkan bahwa meskipun NPS mendorong demokratisasi pelayanan publik, tantangan akuntabilitas tetap menjadi isu penting dalam jaringan pemerintahan yang kompleks dan beragam.

Berdasarkan perkembangan pelayanan publik dari ketiga dekade dapat dilihat pula perbedaan dan persamaan dari ketiga perkembangan administrasi publik tersebut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengembangan teori dalam tiga paradigma administrasi publik

Aspek	<i>Old Public Administration (OPA)</i>	<i>New Public Management (NPM)</i>	<i>New Public Service (NPS)</i>
Dasar Teoretis	Birokrasi Weber (1947), Pemisahan politik-administrasi (Wilson, 1887), Manajemen ilmiah (Taylor, 1911; Fayol, 1949)	Teori pilihan publik, Manajemen sektor swasta, Ekonomi pasar (Hood, 1991)	Teori demokrasi, Kewarganegaraan, Humanisme organisasi (Denhardt & Denhardt, 2000, 2015)
Nilai Utama	Efisiensi, Hierarki, Kepatuhan pada aturan, Netralitas, Integritas (Hughes, 2012)	Efisiensi ekonomi, Produktivitas, Orientasi pasar, Kompetisi (Pollitt & Bouckaert, 2017)	Kepentingan publik, Demokrasi, Kewarganegaraan, Keadilan sosial (Perry, 2007)
Pandangan terhadap Warga	Penerima layanan pasif, Subjek administrasi	Pelanggan (customer), Konsumen layanan	Warga negara aktif, Ko-produser layanan publik (Box, 1999)
Struktur Organisasi	Hierarkis, Terpusat, Terstandarisasi (Gulick & Urwick,	Desentralisasi, Fleksibel, Berbasis unit	Kolaboratif, Jaringan, Struktur partisipatif (Light, 2006)

Aspek	<i>Old Public Administration (OPA)</i>	<i>New Public Management (NPM)</i>	<i>New Public Service (NPS)</i>
	1937)	kerja (Boston, 1996)	
Mekanisme Akuntabilitas	Prosedural, Hierarkis (Patuh pada aturan dan otoritas)	Berbasis hasil, Penilaian kinerja, Kontrak (Kettl, 2005)	Kompleks, Multi-dimensi, Berorientasi pada nilai publik (Moore, 1995)
Pengambilan Keputusan	<i>Hybrid</i> , Berbasis otoritas dan <i>expertise</i>	Berbasis analisis rasional-ekonomis, <i>Cost-benefit Analysis</i>	Deliberatif, Partisipatif, Dialog publik (Nabatchi, 2010)
Motivasi Pegawai Publik	Kepatuhan pada aturan, Etika birokrasi	Insentif ekonomi, Penghargaan kinerja	Pelayanan publik, Komitmen pada nilai publik (Perry, 2007)
Peran Administrator	Implementator netral kebijakan	Manajer yang berorientasi hasil	Fasilitator dialog publik, Mediator kepentingan (King & Stivers, 1998)
Pengukuran Keberhasilan	Kepatuhan prosedural, Stabilitas	Efisiensi, Produktivitas, Hasil terukur	Keadilan, Responsivitas, Nilai publik, Keterlibatan Warga
Kritik Utama	Kaku, Lambat beradaptasi, Disfungsi birokrasi (Merton, 1940; Crozier, 1964)	Mengabaikan keadilan dan ekuitas, Fragmentasi (Peters, 2001; Christensen & Lægreid, 2007)	Idealistis, Tantangan implementasi praktis (Jordan, 2014; Rhodes, 2016)

Sumber : Diolah Peneliti

Tabel 2.1 menyajikan perbandingan komprehensif antara tiga paradigma utama dalam administrasi publik: *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Pada aspek dasar teoretis, ketiga paradigma memiliki landasan pemikiran yang berbeda. OPA berpijak pada birokrasi Weberian, pemisahan politik-administrasi oleh Wilson, dan manajemen ilmiah dari Taylor dan Fayol, sementara NPM berakar pada teori pilihan publik dan manajemen sektor swasta, dan NPS berlandaskan pada teori demokrasi dan humanisme organisasi yang menekankan partisipasi warga.

Dari segi nilai utama, OPA menjunjung tinggi efisiensi birokrasi, hierarki, dan kepatuhan pada aturan sebagaimana diidentifikasi oleh Hughes, sedangkan NPM mengutamakan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan kompetisi sesuai pandangan Pollitt dan Bouckaert. NPS, sebagaimana dijelaskan Perry, lebih berorientasi pada kepentingan publik, demokrasi, dan keadilan sosial. Perbedaan mendasar juga terlihat dalam cara ketiga paradigma memandang warga: OPA melihat warga sebagai penerima layanan pasif, NPM memperlakukan mereka sebagai pelanggan, sementara NPS, seperti dikemukakan Box, menghargai peran aktif warga sebagai ko-produser layanan publik.

Struktur organisasi dalam OPA bersifat hierarkis dan terpusat sebagaimana digagas Gulick dan Urwick, berbeda dengan NPM yang menurut Boston lebih mengedepankan desentralisasi dan fleksibilitas. NPS, sesuai pandangan Light, menerapkan struktur kolaboratif dan partisipatif. Mekanisme akuntabilitas juga berbeda: OPA berfokus pada kepatuhan prosedural, NPM menekankan hasil dan penilaian kinerja sebagaimana dijelaskan Kettl, sedangkan NPS mengadopsi akuntabilitas multi-dimensi berorientasi nilai publik sesuai kerangka Moore.

Dalam hal pengambilan keputusan, OPA menerapkan pendekatan *top-down* berdasarkan otoritas, NPM mengandalkan analisis rasional-ekonomis, sementara NPS, seperti dikemukakan Nabatchi, mengutamakan proses deliberatif dan dialog publik. Motivasi pegawai publik dalam OPA berdasarkan kepatuhan pada aturan dan etika birokrasi, NPM memanfaatkan insentif ekonomi, sedangkan NPS, menurut Perry, bertumpu pada komitmen terhadap nilai publik. Peran administrator juga mengalami evolusi dari implementator netral kebijakan dalam OPA, menjadi manajer berorientasi hasil dalam NPM, hingga fasilitator dialog publik dalam NPS sesuai pandangan King dan Stivers.

Pengukuran keberhasilan dalam OPA dilihat dari kepatuhan prosedural dan stabilitas, NPM mengukurnya melalui efisiensi dan hasil terukur, sementara NPS lebih menekankan keadilan, responsivitas, dan keterlibatan warga. Masing-masing paradigma juga menghadapi kritik: OPA dikritik oleh Merton dan Crozier karena kekakuan dan lambatnya adaptasi, NPM mendapat sorotan dari Peters serta Christensen dan Lægreid karena mengabaikan aspek keadilan dan cenderung fragmentatif, sedangkan NPS, sebagaimana diidentifikasi Jordan dan Rhodes, dianggap terlalu idealistis dengan tantangan implementasi praktis.

Pengembangan teori dalam ketiga paradigma menunjukkan evolusi pemikiran administrasi publik sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan konteks masyarakat. OPA dengan birokrasi Weberian dan prinsip POSDCORB memberikan fondasi bagi administrasi publik modern yang kemudian dikembangkan oleh Simon dengan konsep bounded rationality dan diperluas oleh Frederickson dengan dimensi keadilan sosial. NPM muncul sebagai kritik terhadap OPA dengan adopsi prinsip-prinsip manajemen bisnis yang dikembangkan Hood, Osborne dan Gaebler, serta Ferlie dengan berbagai model NPM-nya, dan dimodifikasi dalam konteks negara berkembang oleh Sarker dan Polidano. NPS kemudian hadir sebagai paradigma alternatif yang dikembangkan Denhardt berlandaskan demokrasi dan kewarganegaraan, didukung teori motivasi pelayanan publik dari Perry, dan diperkaya oleh kontribusi Box serta King & Stivers tentang partisipasi warga, hingga model tata kelola kolaboratif dari Koppenjan, Klijn, Ansell, dan Gash yang mengintegrasikan aspek digital dalam implementasi pelayanan publik.

Munculnya teori-teori manajemen dalam sektor publik pada akhirnya telah mengubah paradigma pengelolaan sektor publik dari yang semula berorientasi pada konsep administrasi menjadi berorientasi pada manajemen. Dalam pandangan tradisional *public administration*, pengelolaan sektor publik diposisikan hanya sebagai pelaksana keputusan dan kebijakan politik tanpa memiliki otonomi yang signifikan. Namun demikian, konsep *public management* bergerak lebih maju dengan merekomendasikan agar institusi publik tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, melainkan juga memiliki inisiatif, kemampuan *bargaining*, serta tingkat independensi tertentu untuk menetapkan tujuan, program, anggaran, dan mekanisme kontrol terhadap organisasinya sendiri (Setiyono, 2020). Perubahan paradigma ini menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Administrasi publik yang baik menciptakan struktur dan proses yang efisien dalam memberikan pelayanan publik. Teori administrasi publik, seperti yang dijelaskan dalam pendekatan birokrasi oleh Weber (1947b) memberikan panduan tentang bagaimana pelayanan publik bisa diberikan secara adil dan efisien melalui struktur yang terorganisir dengan baik. Pelayanan publik, pada dasarnya, adalah aplikasi langsung dari teori administrasi publik dalam bentuk pelayanan yang

diterima masyarakat. Administrasi publik juga harus mampu mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan atau pelayanan publik.

Perkembangan administrasi publik yang mengalami transformasi signifikan sejak paradigma OPA, kemudian menjadi NPM dan berlanjut pada NPS. Hughes (2003) menjelaskan bahwa OPA menekankan birokrasi hierarkis, prosedural, dan legalistik sebagai ciri utama penyelenggaraan pemerintahan, mengacu pada konsep *Weberian bureaucracy* untuk memastikan stabilitas dan kepastian hukum. Namun demikian, pada era 1980-an, NPM muncul sebagai respon atas kelemahan OPA yang dianggap kaku dan tidak efisien. NPM mengadopsi praktik manajemen sektor swasta, dengan orientasi pada kinerja, kompetisi, desentralisasi, dan efisiensi pelayanan publik (Hood, 1991; Osborne, 2006). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelanggan (*citizen as customer*) dan fokus pada hasil (*outcome-based management*).

Selanjutnya, paradigma NPM juga mendapat kritik karena terlalu menekankan pasar dan melupakan nilai-nilai demokrasi. Sebagai antitesisnya, NPS yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2000) mengedepankan pelayanan publik sebagai proses demokratis dan kolaboratif, menekankan *serving citizens rather than steering*. Pendekatan NPS mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Transformasi tersebut menghasilkan pergeseran dari konsep *government* menuju *governance*, sebagaimana dikemukakan Osborne dan Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government*. *Governance* dipahami sebagai pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam jejaring bersama untuk mencapai tujuan publik (Kooiman, 2003).

b *Reinventing Government: From Government to Governance*

Konsep *reinventing government* pertama kali dipopulerkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam karya mereka *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Mereka menekankan perlunya transformasi pemerintahan dari entitas birokratis tradisional yang kaku (*government*) menjadi pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi hasil (*governance*).

Menurut Osborne dan Gaebler (1992), terdapat empat prinsip utama dalam proses *reinventing government*. Pertama, pengurangan peran langsung

pemerintah dalam pelayanan publik, dimana pemerintah didorong untuk tidak lagi menjadi pelaksana tunggal, tetapi mendelegasikan peran tertentu kepada sektor swasta, masyarakat sipil, atau organisasi nirlaba melalui kontrak, kemitraan, atau privatisasi layanan publik. *Kedua*, pemberdayaan sektor swasta dan masyarakat sipil, dengan menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor untuk menciptakan nilai publik secara lebih efektif dan efisien. *Ketiga*, desentralisasi kewenangan, yakni pengambilan keputusan didorong berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit kerja yang lebih kecil agar pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. *Keempat*, fokus pada hasil (*results-oriented government*), dimana reformasi birokrasi menuntut pemerintah berorientasi pada hasil dan kinerja, bukan sekadar kepatuhan prosedur atau input (Osborne & Gaebler, 1992).

Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*. Osborne (2006) menjelaskan bahwa *government* dicirikan oleh struktur hierarkis, kontrol, dan regulasi langsung dalam pelaksanaan kebijakan publik, sedangkan *governance* lebih menekankan pada jaringan (*network*), kolaborasi, dan ko-produksi antara berbagai aktor termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, transisi dari *government* ke *governance* mengubah peran pemerintah dari sekadar regulator dan pelaksana kebijakan menjadi fasilitator, koordinator, dan *enabler* yang memberdayakan aktor lain dalam sistem pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan kesehatan, transisi ini tercermin pada desentralisasi pengelolaan rumah sakit daerah, kemitraan pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan penunjang medis, serta pelibatan masyarakat dalam forum komunikasi publik untuk peningkatan mutu pelayanan.

2. Administrasi Publik dalam konteks Governance

Dalam era administrasi publik modern, konsep *governance* menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Osborne dan Gaebler (1992) menekankan bahwa *governance* merupakan transformasi peran pemerintah dari birokrasi tradisional yang terpusat (*government*) menjadi fasilitator yang memberdayakan aktor lain, melalui jaringan kolaborasi, kemitraan, dan desentralisasi kewenangan.

Administrasi publik dan *governance* merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik modern. Secara klasik, administrasi publik didefinisikan sebagai proses yang melibatkan perumusan kebijakan publik, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat (Rosenbloom et al., 2014). Administrasi publik berfokus pada fungsi manajerial dan birokrasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan (Chandler & Plano, 1988).

Namun, sejak berkembangnya paradigma *New Public Management* (NPM) dan *New Public Governance* (NPG), konsep *governance* muncul sebagai perluasan perspektif administrasi publik tradisional. Osborne (2006) menyatakan bahwa *governance* bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja sama dengan aktor-aktor non-pemerintah, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam penyediaan layanan publik. Dengan kata lain, *governance* menekankan pada proses koordinasi, kolaborasi, dan jaringan (*network*) antar aktor, melampaui pendekatan administrasi publik yang berfokus pada struktur dan prosedur birokrasi semata (Kooiman, 2003).

Menurut Hughes (2003), *governance* adalah inti dari administrasi publik modern karena *governance* mendefinisikan cara pemerintah mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan, serta memastikan akuntabilitas dan legitimasi publik melalui partisipasi dan transparansi. *Governance* menggeser fokus administrasi publik dari *hierarchical control* menuju *shared governance* yang berbasis pada kemitraan, ko-produksi layanan, dan dialog dengan stakeholders (Denhardt & Denhardt, 2000).

Dengan demikian, administrasi publik menyediakan struktur, fungsi, dan mekanisme operasional penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan *governance* memberikan kerangka normatif dan proses interaksi antar aktor untuk mencapai tujuan publik secara demokratis dan kolaboratif. Osborne dan Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government* juga menekankan bahwa pergeseran dari *government to governance* adalah bagian dari reformasi administrasi publik, agar birokrasi pemerintah tidak hanya mengandalkan peran kontrol dan regulasi, tetapi juga menjadi fasilitator, *enabler*, dan partner dalam pelayanan publik.

Governance merupakan perluasan, penguatan, sekaligus paradigma pelengkap dari administrasi publik, yang menekankan nilai kolaborasi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi hasil untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan

berkeadilan di era kompleksitas dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks pelayanan kesehatan publik, seperti rumah sakit daerah, administrasi publik menyediakan struktur organisasi, standar operasional, regulasi, dan pembiayaan, sedangkan *governance* memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat, transparansi informasi, akuntabilitas manajemen risiko, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

3. Akuntabilitas dalam Pelayanan publik

Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik kontemporer. Bovens (2010) mendefinisikan akuntabilitas dalam pelayanan publik sebagai kewajiban organisasi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemangku kepentingan. Hood (2010) mengidentifikasi bahwa mekanisme transparansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif. Namun, Christensen & Lægreid (2015) memperingatkan bahwa tuntutan berlebihan terhadap akuntabilitas formal dapat mengarah pada "*accountability paradox*" dimana fokus bergeser dari peningkatan pelayanan ke pemenuhan persyaratan administratif.

Konsep *accountability* merupakan salah satu pilar utama *good governance* dan praktik pelayanan publik yang efektif. Jabbra dan Dwivedi (1989) mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki cakupan yang luas, mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, serta kebijakan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Mereka mengidentifikasi lima bentuk *accountability* yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan administrasi publik, yaitu *moral accountability*, *political accountability*, *managerial accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*. (Jabbra & Dwivedi, 1989).

Pertama, *moral accountability* merupakan bentuk akuntabilitas yang berlandaskan nilai moral dan etika universal. *Moral accountability* muncul sebagai kewajiban batin (*inner obligation*) bagi setiap aparatur negara atau pelayan publik untuk menjalankan tugas dengan kejujuran, integritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Jabbra & Dwivedi, 1989). Bentuk akuntabilitas ini tidak selalu tertulis dalam peraturan formal, namun menjadi dasar utama integritas pribadi seorang pejabat publik. Dalam konteks pelayanan publik di rumah sakit, *moral accountability* terwujud dalam perilaku tenaga medis yang melayani pasien dengan empati, tanpa

diskriminasi, dan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, meskipun tidak ada aturan tertulis yang memaksa (Denhardt & Denhardt, 2000).

Kedua, *political accountability* merujuk pada kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, dan tindakan mereka kepada aktor-aktor politik yang memiliki legitimasi, seperti parlemen, kepala daerah, atau masyarakat melalui mekanisme demokrasi (Jabbra & Dwivedi, 1989; Osborne, 2006). *Political accountability* terwujud melalui pemilu, mekanisme *checks and balances*, serta forum akuntabilitas publik. (Osborne & Gaebler, 1992). Misalnya, dalam organisasi rumah sakit pemerintah, Direktur RSUD bertanggung jawab kepada Gubernur dan DPRD terkait pemenuhan standar pelayanan minimal, penggunaan anggaran, dan kebijakan strategis rumah sakit dalam mendukung tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Ketiga, *managerial accountability* menekankan pertanggungjawaban atas pencapaian hasil kerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi. Akuntabilitas ini berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan (Hood, 1991; Jabbra & Dwivedi, 1989). *Managerial accountability* diukur melalui *Key Performance Indicators* (KPI), sistem pelaporan kinerja, audit internal, serta *reward and punishment system*. Contohnya, kepala instalasi di rumah sakit memiliki *managerial accountability* untuk memastikan tercapainya target *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Average Length of Stay* (ALOS), dan kepuasan pasien sesuai standar mutu pelayanan (Hughes, 2003).

Keempat, *professional accountability* merupakan bentuk akuntabilitas terhadap standar profesi dan organisasi profesi yang mengatur perilaku, kompetensi, dan etika anggotanya. *Professional accountability* mengharuskan pejabat publik yang memiliki keahlian profesional tertentu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan kode etik profesi (Jabbra & Dwivedi, 1989). Dalam konteks rumah sakit, seorang dokter spesialis memiliki *professional accountability* kepada organisasi profesinya, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), ketika terdapat pelanggaran etik praktik medis (Denhardt & Denhardt, 2000).

Kelima, *legal accountability* berkaitan dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran dalam bentuk konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana (Jabbra & Dwivedi, 1989). *Legal accountability* bersifat formal,

tertulis, mengikat secara hukum, dan pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi yang tegas. Pemerintah (Osborne, 2006). Contoh dalam konteks rumah sakit adalah kasus malpraktik medis yang dapat menimbulkan tuntutan hukum, atau pelanggaran prosedur pengadaan barang / jasa rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan.

Dengan demikian, kelima bentuk *accountability* menurut Jabbra dan Dwivedi ini bersifat komplementer, memastikan bahwa administrasi publik dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memenuhi tujuan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Jabbra & Dwivedi, 1989; Osborne, 2006; Denhardt & Denhardt, 2000).

Dalam perspektif ERM, dimensi *accountability* ini menjadi dasar bagi penerapan *risk governance* yang efektif, karena memastikan bahwa setiap risiko ditangani dengan mengedepankan nilai moral, legitimasi politik, efektivitas manajerial, kepatuhan profesi, dan kepatuhan hukum (COSO, 2017).

4. Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik (*public service*) pada hakikatnya berkaitan dengan kegiatan penyediaan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Merriam Webster dalam (Setiyono, 2020) mendefinisikan pelayanan publik sebagai layanan yang diberikan untuk kepentingan umum. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi pelayan publik (*public servant*), apa pun profesi dan peran kehidupannya. Dengan demikian, kriteria utama dalam konsep pelayanan publik terletak pada siapa yang menjadi penerima manfaat (*beneficiary*), bukan pada siapa aktor yang memberikan layanan.

Mengingat beragamnya kebutuhan warga negara, jenis pelayanan publik sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum cakupan pelayanan publik dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, penyediaan barang publik (*public goods*), yaitu produk atau jasa yang kemanfaatannya dapat dinikmati bersama oleh semua orang, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan. Kedua, penyediaan barang atau jasa untuk keperluan individual yang difasilitasi secara publik (*publicly provided private goods*), yakni produk atau jasa yang kemanfaatannya dinikmati secara individual namun penyediaannya difasilitasi oleh negara, seperti listrik, air bersih, dan telepon (Setiyono, 2020).

Salah satu teori klasik yang berpengaruh dikemukakan oleh Fayol (1916), yang menyebutkan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi,

pengarahan, dan pengendalian. Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh Luther Gulick pada 1930-an melalui konsep POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Selain itu, terdapat teori *entrepreneurship* yang menekankan peran manajer sebagai *entrepreneur*, yaitu pengambil risiko yang berani membuat keputusan di luar metode baku berdasarkan intuisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajer dituntut menjadi inovator yang berpikir kreatif dan melihat peluang untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tokoh teori ini adalah Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa setiap orang adalah *entrepreneur* ketika melakukan kombinasi baru, namun kehilangan karakter tersebut ketika hanya mempertahankan bisnis yang sudah ada (Collins & Moore, 1970, dalam Setiyono, 2020).

Menurut Meyer & Waldorff (2022), ciri utama manajemen organisasi publik adalah operasionalisasinya di bawah pengawasan dan pengendalian pejabat pemerintah serta legislator yang memiliki otoritas formal. Pengawasan ini muncul sebagai konsekuensi dari peran strategis organisasi publik dalam menyediakan layanan vital bagi masyarakat. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik bidang kesehatan tidak terkecuali, dengan fungsinya yang krusial dalam penyediaan layanan kesehatan, organisasi ini berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan operasionalnya berlangsung secara tepat, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan bagi pasien.

Pelayanan publik merupakan elemen fundamental dalam fungsi organisasi publik yang telah menjadi fokus utama dalam studi administrasi publik. Denhardt & Denhardt (2015) mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Osborne (2010) memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan upaya sistematis untuk menyediakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya publik yang tersedia. Perkembangan konsep pelayanan publik telah mengalami evolusi signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Hood (1991) yang mengidentifikasi pergeseran paradigma dari model administrasi publik tradisional ke *New Public Management* (NPM) yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen bisnis ke dalam sektor publik dengan penekanan pada efisiensi, pengukuran kinerja, dan orientasi hasil.

Dalam masa modern, pelayanan publik dianggap begitu penting untuk kehidupan manusia, sehingga ada ketentuan universal bahwa hak pelayanan itu harus dijamin oleh negara. Hal itu dikaitkan dengan konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM), dimana kegagalan dalam penyediaan pelayanan publik yang baik dapat dipandang sebagai sebuah pelanggaran atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan HAM, salah satu hak yang harus dipenuhi adalah Kesehatan. Di negara-negara berkembang, pelayanan publik cenderung masih terbatas dan tidak dikelola dengan baik, salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang tidak profesional (Setiyono, 2020).

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di organisasi publik diidentifikasi oleh Lipsky (2010) melalui konsep "*street-level bureaucracy*" yang menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan pelayanan pada tingkat *front-line*, dimana petugas sering dihadapkan pada dilema antara tuntutan prosedural dan kebutuhan riil masyarakat. Osborne (2018) mengembangkan perspektif "*Public Service-Dominant Logic*" yang menekankan pentingnya ko-produksi dalam pelayanan publik, dimana nilai layanan diciptakan bersama antara penyedia dan pengguna layanan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Alford (2016) berargumen bahwa keterlibatan warga negara dalam proses pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna layanan tetapi juga efektivitas dan efisiensi pelayanan secara keseluruhan.

a. Value for Money (VfM) dalam Pelayanan publik

Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tersebut, konsep *Value for Money* (VfM) merupakan konsep inti dalam manajemen keuangan publik yang perlu diterapkan agar penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat (Jackson, 2012). OECD (2015) mendefinisikan VfM sebagai pencapaian keseimbangan terbaik antara biaya, kualitas, dan keberlanjutan suatu layanan publik. Konsep ini menjadi tolok ukur penting dalam penilaian efektivitas belanja negara, terutama di sektor kesehatan yang memiliki tuntutan efisiensi dan kualitas tinggi secara bersamaan. *Value for money* (VfM) memastikan penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat (OECD, 2015). VfM menekankan tiga elemen utama: ekonomi (input yang efisien), efisiensi (proses yang tepat), dan efektivitas (hasil yang sesuai tujuan) (Jackson, 2012). Dalam layanan kesehatan, VfM tercapai ketika rumah sakit

mampu menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar dan berkontribusi pada outcome kesehatan masyarakat (WHO, 2007).

Dalam konteks pengelolaan keuangan layanan kesehatan berbasis BLUD, pencapaian *Value for Money* sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem akuntabilitas keuangan yang memadai. Studi pendampingan dan revidi penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas di Kota Tangerang Selatan oleh Muktiyanto et al. (2025) menunjukkan bahwa bimbingan teknis dan pendampingan yang terstruktur mampu meningkatkan pemahaman aparatur, memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat transparansi dan tata kelola layanan kesehatan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan BLUD merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penciptaan manfaat maksimal bagi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Value for Money*.

Implementasi kebijakan yang efektif, didukung *governance* yang kuat, menjadi prasyarat tercapainya VfM dalam organisasi publik. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koherensi sistem dan kapasitas organisasi. Ketika kebijakan diimplementasikan tanpa sistem tata kelola yang efektif, maka risiko kegagalan meningkat, sehingga tujuan kebijakan sulit dicapai.

Menurut *The National Audit Office* (NAO) Inggris (2001), VfM memiliki tiga komponen utama yang sering dikenal sebagai *the 3Es*:

- 1) Ekonomi (*Economy*). Mengacu pada kemampuan memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai pada harga terendah (NAO, 2001). Contohnya, pengadaan obat generik yang berkualitas setara dengan branded medicine namun dengan harga lebih rendah.
- 2) Efisiensi (*Efficiency*). Mengukur rasio antara input dan output, yaitu seberapa optimal penggunaan sumber daya untuk menghasilkan layanan (Jackson, 2012). Di rumah sakit, contohnya adalah penggunaan ruang operasi yang terjadwal dengan baik sehingga mengurangi waktu menganggur (*idle time*) dan meningkatkan utilisasi.
- 3) Efektivitas (*Effectiveness*). Menggambarkan sejauh mana output layanan mencapai tujuan dan menghasilkan outcome yang diinginkan (OECD, 2015). Dalam pelayanan rumah sakit, efektivitas tercermin pada keberhasilan pengobatan, tingkat kepuasan pasien, dan perbaikan outcome kesehatan.

masyarakat.

Selanjutnya, *World Health Organization* (WHO, 2007) menekankan bahwa *Value for Money* (VfM) di sektor kesehatan bukan sekadar upaya pengurangan biaya, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pendekatan ini menuntut manajemen rumah sakit untuk memprioritaskan intervensi dengan *cost-effectiveness* tinggi, seperti penerapan terapi berbasis *evidence-based guideline* dibandingkan prosedur dengan manfaat klinis yang rendah. Selain itu, rumah sakit juga perlu mengelola risiko keuangan dan operasional yang dapat memengaruhi keberlanjutan layanan, misalnya risiko pembengkakan biaya operasional akibat ketidakefisienan proses. Terakhir, VfM menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan keselamatan pasien untuk mengurangi biaya yang muncul akibat *adverse events* atau kesalahan medis, yang justru menjadi beban tambahan bagi sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2007).

Dalam konteks rumah sakit di Indonesia, pencapaian VfM menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran, tingginya beban layanan pasien JKN, serta inefisiensi operasional pada berbagai lini (Kemenkes RI, 2020). Laporan BPKP (2020) menunjukkan bahwa banyak rumah sakit daerah belum menerapkan analisis VfM secara sistematis dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga program yang dijalankan belum optimal dalam menciptakan outcome kesehatan masyarakat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Untuk itu, implementasi manajemen risiko terintegrasi ERM menjadi instrumen strategis dalam mencapai VfM di sektor kesehatan. ERM memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang berdampak pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas layanan secara menyeluruh. Selain itu, ERM COSO (2017) dalam Moeller, R. R. (2011), menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga pengelolaan risiko tidak berjalan terpisah dari strategi organisasi.

Lebih jauh, ERM memastikan bahwa sumber daya rumah sakit dialokasikan untuk program-program yang memiliki *value for money* tertinggi dan risiko yang terkelola dengan baik, sehingga mampu memaksimalkan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam keterbatasan anggaran yang ada. Pandangan ini sejalan dengan

Frigo dan Anderson (2011) yang menyatakan bahwa ERM bukan sekadar alat mitigasi risiko, tetapi juga berfungsi mendukung penciptaan nilai dan pencapaian tujuan strategis organisasi, termasuk pencapaian VfM dalam pelayanan publik kesehatan.

Tabel 2.2
Value for Money (VfM) di Rumah Sakit

Dimensi VfM	Definisi	Contoh Aplikasi di Rumah Sakit
Ekonomi	Memperoleh input dengan biaya terendah tanpa mengurangi kualitas	• Pengadaan obat generik esensial sesuai formularium nasional (Fornas) untuk menekan biaya farmasi. • Kontrak payung pembelian alat kesehatan secara kolektif (<i>e-catalogue</i>) untuk harga lebih rendah.
Efisiensi	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output layanan	• Penjadwalan ruang operasi yang efektif untuk mengurangi waktu menganggur (<i>idle time</i>). • Mengurangi <i>wastage</i> logistik medis melalui <i>inventory control</i> (FIFO/FEFO).
Efektivitas	Mencapai hasil dan <i>outcome</i> layanan sesuai tujuan	• Peningkatan angka kesembuhan (<i>clinical outcome</i>) pasien rawat inap penyakit katastropik. • Kepuasan pasien terhadap pelayanan instalasi rawat jalan mencapai target >85%.

(Sumber: Diadaptasi dari NAO, 2001; OECD, 2015; WHO, 2007, diolah Peneliti)

Menurut WHO (2007), penerapan indikator VfM di rumah sakit mendukung akuntabilitas keuangan publik, transparansi manajemen, dan peningkatan mutu layanan yang berorientasi pada pasien. Integrasi dengan *ERM* memastikan risiko pada ketiga dimensi VfM teridentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik rumah sakit. (Moeller, R. R. (2011))

b. *Reconceptualizing Value for Money in Public Healthcare*

Meskipun kerangka klasik *Value for Money* (VfM) menekankan tiga dimensi utama yaitu *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*, perkembangan administrasi publik modern menunjukkan bahwa pengukuran nilai dalam sektor kesehatan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (*equity*). Dalam konteks pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara, efisiensi tanpa distribusi

yang adil berpotensi menghasilkan kesenjangan akses layanan, terutama bagi kelompok rentan (Braveman & Gruskin, 2003; (WHO 2010).

WHO menegaskan bahwa sistem kesehatan yang berkinerja tinggi tidak hanya ditandai oleh efektivitas klinis dan efisiensi biaya, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan layanan yang berkualitas, aman, berpusat pada pasien, serta berkeadilan. Oleh karena itu, *equity* tidak hanya merupakan prinsip etis, tetapi juga indikator fundamental dalam penciptaan nilai publik (*public value*) pada sektor kesehatan (WHO, 2007; Smith et al., 2009).

Sejalan dengan itu, OECD menekankan bahwa *Value for Money* harus dipahami sebagai keseimbangan antara biaya, kualitas, dan keberlanjutan layanan publik, sehingga organisasi sektor publik dituntut tidak hanya ekonomis tetapi juga mampu menghasilkan manfaat sosial yang merata (OECD, 2015). Dengan demikian, dalam perspektif administrasi publik kontemporer, VfM perlu direkonseptualisasi sebagai keseimbangan antara optimalisasi sumber daya, mutu pelayanan, *outcome* kesehatan, serta pemerataan akses layanan. Pendekatan ini menggeser orientasi VfM dari sekadar efisiensi fiskal menuju penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan (Denhardt & Denhardt, 2015).

Perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa kerangka *Value for Money* tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada dimensi *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Dalam sektor kesehatan yang berorientasi pada pelayanan publik, nilai tidak hanya ditentukan oleh optimalisasi biaya, tetapi juga oleh mutu layanan dan keadilan akses. WHO menegaskan bahwa sistem kesehatan yang berkinerja tinggi harus memastikan pelayanan yang aman (*safe*), efektif (*effective*), berpusat pada pasien (*people-centred*), tepat waktu (*timely*), efisien (*efficient*), dan berkeadilan (*equitable*). Oleh karena itu, penelitian ini merekonseptualisasi *Value for Money* ke dalam kerangka yang lebih luas dengan mengintegrasikan dimensi *equity* dan mutu pelayanan sebagai fondasi penciptaan nilai publik.

Tabel 2.3
Value for Money dan Dimensi Mutu (WHO)

Evolusi Konsep	Dimensi	Fokus Evaluasi	Pertanyaan Kunci	Dimensi Mutu (WHO)	Implikasi bagi Nilai Publik
VfM Klasik	Economy	Pengadaan input dengan biaya terendah tanpa mengurangi standar minimum	Apakah sumber daya diperoleh secara hemat?	<i>Efficient</i>	Menjamin keberlanjutan fiskal organisasi
	Efficiency	Optimalisasi hubungan input–output	Apakah layanan diberikan dengan pemborosan minimal?	<i>Efficient, Timely</i>	Meningkatkan produktivitas layanan
	Effectiveness	Pencapaian outcome sesuai tujuan	Apakah intervensi menghasilkan dampak kesehatan?	<i>Effective, Safe</i>	Menghasilkan manfaat klinis bagi masyarakat
VfM Kontemporer	Equity	Pemerataan akses dan keadilan distribusi layanan	Apakah seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang adil?	<i>Equitable, People-centred</i>	Mengurangi kesenjangan kesehatan dan memperkuat legitimasi publik
VfM Berbasis Public Value (Extended VfM)	Quality	Tingkat keamanan, responsivitas, dan orientasi pada pasien	Apakah layanan aman, responsif, dan berpusat pada kebutuhan pasien?	<i>Safe, People-centred, Timely, Effective</i>	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nilai sosial layanan kesehatan

(Sumber: Diadaptasi dari NAO, 2001; OECD, 2015; WHO 2007, diolah Peneliti)

Hal ini menunjukkan pergeseran fundamental dari pendekatan *Value for Money* yang berorientasi pada efisiensi fiskal menuju kerangka evaluasi kinerja yang menempatkan penciptaan nilai publik sebagai tujuan utama organisasi sektor kesehatan. Dengan memasukkan dimensi *equity* dan mutu pelayanan, *Value for Money* tidak lagi sekadar menjadi instrumen akuntabilitas keuangan, tetapi berkembang sebagai kerangka strategis untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

5. Pelayanan publik di bidang kesehatan

Pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya dalam konteks rumah sakit, telah menjadi fokus penting dalam studi administrasi publik dan manajemen kesehatan. Perkembangan pelayanan kesehatan rumah sakit mencerminkan evolusi paradigma dalam administrasi publik, tantangan pengelolaan institusi kesehatan, serta dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Arrow (1964) dalam artikelnya mengidentifikasi sifat khusus pasar kesehatan, termasuk ketidakpastian hasil, asimetri informasi antara penyedia dan penerima layanan, serta *barriers to entry*. Sifat-sifat ini menjadikan pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat mengikuti mekanisme pasar konvensional. McKee & Healy (2002) menjelaskan bahwa rumah sakit, sebagai penyedia utama layanan kesehatan, memiliki kompleksitas organisasi yang tinggi karena menggabungkan aspek teknis-medis, sosial, dan ekonomis dalam operasionalnya. Johns *et al.* (2010) menekankan bahwa rumah sakit sebagai institusi publik memiliki *multiple stakeholders* dengan kepentingan yang sering bertentangan, meliputi pasien, tenaga kesehatan, pemerintah, asuransi, dan masyarakat luas. Hal ini menciptakan tantangan dalam mendefinisikan dan mengukur kualitas serta kinerja pelayanan. Lee *et al.* (2013) menambahkan dimensi etis dalam pelayanan rumah sakit, dimana prinsip-prinsip bioetika seperti *non-maleficence*, *beneficence*, otonomi, dan keadilan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pasien.

Dalam konteks sektor kesehatan, konsep pelayanan publik yang diuraikan oleh Denhardt & Denhardt (2015) serta Osborne (2010) menemukan aplikasi konkretnya di rumah sakit sebagai institusi publik yang bertugas memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit mengalami transformasi manajemen pelayanan sejalan dengan pergeseran paradigma ke *New Public Management* (NPM), sebagaimana dijelaskan Hood (1991), yang tercermin dalam adopsi praktik manajemen berbasis kinerja, efisiensi operasional, dan akreditasi rumah sakit. Dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan Parasuraman *et al.* (1988) melalui model SERVQUAL sangat relevan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan, dimana aspek keandalan (*reliability*) berhubungan dengan ketepatan diagnosis dan pengobatan, daya tanggap (*responsiveness*) terkait kecepatan penanganan pasien, jaminan (*assurance*) mencakup kompetensi tenaga medis, empati terwujud dalam komunikasi dokter-pasien, dan bukti fisik meliputi fasilitas dan peralatan medis. Performa multidimensional pelayanan publik yang dikemukakan Boyne & Chen (2006) juga

menjadi kerangka penting dalam evaluasi rumah sakit, dimana efisiensi tercermin dalam pengelolaan sumber daya, efektivitas dalam *outcomes* kesehatan pasien, keadilan dalam aksesibilitas layanan, dan responsivitas dalam pemenuhan kebutuhan spesifik pasien.

Tantangan "*street-level bureaucracy*" yang diidentifikasi Lipsky (2010) terwujud dalam dilema yang dihadapi tenaga kesehatan di garis depan rumah sakit, yang harus menyeimbangkan protokol medis standar dengan kebutuhan individual pasien. Konsep ko-produksi dalam pelayanan publik yang dikemukakan oleh Osborne (2013) dan Alford (2016) sangat relevan dalam konteks kesehatan, dimana keberhasilan pengobatan tidak hanya ditentukan oleh intervensi medis tetapi juga partisipasi aktif pasien dalam proses penyembuhan.

Sementara itu, tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dibahas oleh Bovens (2010) dan Hood (2010) menemukan implementasinya dalam sistem pelaporan kinerja rumah sakit, pengukuran indikator mutu, dan publikasi informasi layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, peringatan Christensen & Lægreid (2015) tentang "*accountability paradox*" juga relevan dalam konteks rumah sakit, dimana fokus berlebihan pada dokumentasi akreditasi dan persyaratan administratif dapat mengalihkan perhatian dari kualitas perawatan pasien yang sesungguhnya.

Berdasarkan perkembangan pelayanan publik di rumah sakit sebagai institusi kesehatan mencerminkan evolusi paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), hingga *New Public Service* (NPS). Pada era OPA, pengelolaan rumah sakit pemerintah dicirikan oleh struktur birokrasi yang hierarkis dan kaku, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prosedur standar, perencanaan terpusat, dan pendekatan yang seragam dalam pelayanan kesehatan (Figueras, *et al.*, 2005). Rumah sakit pada masa ini umumnya dikelola langsung oleh kementerian kesehatan atau pemerintah daerah dengan alokasi anggaran berbasis input dan minimnya otonomi manajerial, menyebabkan lambatnya respons terhadap kebutuhan spesifik pasien dan komunitas. Memasuki era NPM pada 1980-an dan 1990-an, pelayanan kesehatan mengalami transformasi signifikan dengan penerapan prinsip-prinsip pasar dan manajemen bisnis dalam pengelolaan rumah sakit. Menurut Preker & Harding (2003), reformasi NPM dalam sektor kesehatan tercermin dalam korporatisasi rumah sakit, pembentukan badan layanan umum, sistem pembayaran berbasis kinerja dan diagnosis (seperti DRGs), serta penggunaan indikator kinerja untuk mengukur efisiensi dan produktivitas. Pendekatan NPM

mendorong rumah sakit untuk beroperasi dengan orientasi pelanggan, efisiensi biaya, dan akuntabilitas berbasis hasil, meskipun kritik muncul bahwa hal ini terkadang mengesampingkan aspek keadilan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

Paradigma NPS yang berkembang di awal abad ke-21 membawa dimensi baru dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan menekankan keterlibatan pasien dan masyarakat dalam pengambilan keputusan kesehatan. McDermott *et al.* (2015) menyoroti bagaimana NPS menggeser fokus rumah sakit dari sekadar penyedia layanan kepada fasilitator kesehatan masyarakat yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Implementasi prinsip NPS terlihat dalam pengembangan dewan pengawas, mekanisme umpan balik pasien, program *co-production* dalam perawatan kesehatan, dan integrasi layanan kesehatan dengan inisiatif kesehatan masyarakat yang lebih luas. Osborne (2013) mengidentifikasi bahwa dalam konteks NPS, pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak lagi semata-mata berfokus pada efisiensi dan kepuasan pelanggan, tetapi juga pada nilai-nilai publik seperti keadilan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sistem kesehatan. Newman & Clarke (2009) menambahkan bahwa pendekatan NPS memfasilitasi pergeseran dari model biomedis tradisional menuju model biopsikososial yang lebih komprehensif dalam pelayanan kesehatan rumah sakit.

Dalam praktiknya, hibridisasi dari berbagai paradigma, yaitu pada era OPA, fokus pada birokrasi, hierarki, dan efisiensi prosedural Weber (1947b), pada era NPM, fokus pada efisiensi, akuntabilitas kinerja, dan orientasi pelanggan (Hood, 1991) pada era NPS, menekankan nilai publik, partisipasi, dan etika pelayanan (Denhardt, 2000). Hibridisasi ketiganya menciptakan fondasi nilai bagi manajemen risiko yang berbasis pada profesionalisme birokrasi, efisiensi kinerja, dan partisipasi publik.

Untuk menghadapi kompleksitas tantangan kesehatan kontemporer seperti penuaan populasi, penyakit kronis, dan ketimpangan akses layanan kesehatan, rumah sakit telah mengalami transformasi paradigma sejalan dengan evolusi administrasi publik. Figueras *et al.* (2005) menjelaskan bahwa model tradisional pengelolaan rumah sakit publik yang bercirikan birokrasi hierarkis dan sentralisasi (*Old Public Administration*) berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan standarisasi praktik medis dan penyediaan layanan universal. Pendekatan ini menekankan kepatuhan prosedural dan standarisasi sebagai mekanisme jaminan kualitas. Sejalan dengan kemunculan *New Public Management* (NPM), Preker & Harding (2003) mengidentifikasi pergeseran dalam tata kelola dan manajemen rumah sakit publik,

termasuk desentralisasi kewenangan, otonomi manajerial, dan penekanan pada efisiensi serta kinerja terukur. Berbagai model reformasi rumah sakit di Eropa yang mencerminkan prinsip-prinsip NPM, termasuk *corporatization*, *contracting out*, dan *case-based payment systems* seperti *Diagnosis-Related Groups* (DRGs). Di negara berkembang, reformasi serupa juga diterapkan sebagaimana ditunjukkan oleh McPake (1996), meskipun dengan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks lokal. Perkembangan lebih lanjut menuju paradigma *New Public Service* (NPS) dan *New Public Governance* (NPG) tercermin dalam penekanan pada orientasi pasien, keterlibatan masyarakat, dan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit modern berupaya mengintegrasikan nilai-nilai efisiensi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. McDermott *et al.* (2015) mengidentifikasi gerakan *patient-centered care* (PCC) sebagai manifestasi dari prinsip NPS yang menempatkan pasien tidak hanya sebagai penerima pasif tetapi sebagai pusat proses perawatan.

Pelayanan rumah sakit di negara berkembang menghadapi tantangan spesifik terkait dengan keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan beban penyakit ganda (*communicable dan non-communicable diseases*). Mills (1994) mengidentifikasi masalah umum dalam pengelolaan rumah sakit di negara berkembang, termasuk rendahnya efisiensi, kekurangan tenaga terampil, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Studi oleh Hsia *et al.* (2012) di beberapa negara Afrika menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketersediaan layanan dasar di rumah sakit, yang berimplikasi pada aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Reformasi sektor kesehatan di negara berkembang sering dipengaruhi oleh lembaga donor dan tren global. Lindelow (2006) menganalisis bagaimana inisiatif *good governance* mempengaruhi manajemen rumah sakit di negara berkembang, sementara Gilson (2006) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan *bottom-up* dalam reformasi pelayanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, Trisnantoro (2018) mengkaji transformasi rumah sakit publik menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan fleksibilitas manajerial lebih besar namun tetap mempertahankan misi sosial.

Sektor kesehatan dan rumah sakit menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang menuntut adaptasi dalam model pelayanan. Penuaan populasi dan peningkatan penyakit kronis, sebagaimana dijelaskan oleh Rechel *et al.* (2013), membutuhkan pergeseran dari pelayanan akut ke manajemen kondisi kronis dan preventif. Pandemi

COVID-19 menyoroti kerentanan sistem kesehatan dan pentingnya ketahanan (*resilience*) dalam pelayanan rumah sakit, sebagaimana dianalisis oleh Legido-Quigley *et al.* (2020). Diskusi akademik juga mengarah pada konsep *value-based healthcare* yang dikembangkan Porter & Teisberg (2006), yang menekankan penciptaan nilai bagi pasien sebagai tujuan utama sistem kesehatan. Pendekatan ini mendorong integrasi layanan, pengukuran outcome yang bermakna, dan *alignment* insentif di seluruh rantai pelayanan kesehatan. De Savigny & Adam (2009) memperkuat argumen tentang pentingnya pendekatan sistem dalam reformasi kesehatan, mengakui interkoneksi antara berbagai elemen sistem termasuk rumah sakit. Literatur tentang pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit, menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang dipengaruhi oleh evolusi paradigma administrasi publik, perkembangan teknologi, dan perubahan ekspektasi masyarakat. Sebagai institusi publik, rumah sakit berada dalam tegangan antara berbagai tuntutan yang terkadang bertentangan: efisiensi ekonomi versus keadilan sosial, standarisasi versus personalisasi layanan, dan otonomi profesional versus akuntabilitas publik.

Denhardt *et al.* (2013) menekankan bahwa organisasi publik dihadapkan pada berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi elemen fundamental yang berkaitan dengan upaya organisasi dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko secara sistematis dan komprehensif untuk mencapai dimensi *reliability*. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan efektif merupakan faktor determinan bagi organisasi publik, khususnya rumah sakit, dalam menghadapi ketidakpastian dan menjamin keberlanjutan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

6. Paradoks Pelayanan kesehatan publik dalam perspektif Administrasi Publik

Pelayanan kesehatan publik dalam perspektif administrasi publik saat ini dihadapkan pada paradoks struktural yang mencerminkan ketegangan antara mandat normatif pelayanan publik dan keterbatasan sumber daya organisasi. Paradoks ini bersifat strategis karena memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pelayanan.

Paradoks pertama muncul dalam implementasi *Universal Health Coverage* (UHC), yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan tanpa hambatan finansial bagi seluruh masyarakat (WHO 2010). Namun, perluasan akses tersebut seringkali meningkatkan beban pembiayaan dan tekanan terhadap kapasitas

layanan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan finansial rumah sakit, terutama akibat ketidaksesuaian tarif dengan biaya riil dan mekanisme pembayaran yang belum optimal (World Bank, 2019). Kondisi ini mencerminkan *trade-off* antara perluasan akses dan stabilitas sistem pelayanan.

Paradoks kedua berkaitan dengan ketegangan antara penciptaan *public value* dan keterbatasan sumber daya (*cost constraint*). Dalam administrasi publik, kinerja organisasi tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi dari kemampuannya menghasilkan nilai publik berupa kualitas layanan, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat (Moore, 1995; Cole & Parston, 2006). Namun, keterbatasan anggaran dan tuntutan akuntabilitas memaksa organisasi publik untuk melakukan prioritisasi, sehingga seringkali terjadi dilema antara peningkatan mutu layanan dan efisiensi biaya.

Paradoks ketiga berkaitan dengan dualisme peran rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik (*service organization*) sekaligus organisasi yang harus menjaga keberlanjutan operasional (*survival organization*). Sebagai penyedia layanan publik, rumah sakit memiliki kewajiban sosial untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (Frederickson, 2005). Di sisi lain, rumah sakit membutuhkan stabilitas finansial untuk mendukung operasional, investasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (Preker & Harding, 2003). Ketegangan ini menciptakan dilema strategis dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam perspektif *governance*, ketiga paradoks tersebut tidak dapat dieliminasi, melainkan harus dikelola sebagai *strategic tension* yang inheren dalam sistem pelayanan publik. Organisasi publik dituntut untuk mampu mengelola kompleksitas dan ketidakpastian melalui pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis risiko (OECD, 2020).

Dalam konteks ini, *Enterprise Risk Management* (ERM) menjadi pendekatan yang relevan untuk mengelola paradoks tersebut secara sistematis. ERM memungkinkan organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang muncul dari ketegangan antara akses layanan, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya dalam satu kerangka terintegrasi (COSO, 2017). Dengan demikian, ERM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi sebagai mekanisme strategis untuk menjembatani tuntutan pelayanan publik dan keberlanjutan organisasi.

7. *Standardization by Provider* dalam Pelayanan publik

Dalam konteks *governance* dan manajemen risiko pelayanan publik,

standardization by provider menjadi salah satu elemen fundamental untuk memastikan tercapainya kualitas layanan yang konsisten, aman, dan akuntabel. Standardisasi oleh *provider* mengacu pada penetapan standar pelayanan, prosedur operasional baku, pedoman teknis, dan protokol kerja yang disusun oleh penyedia layanan (provider) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan organisasi (Osborne & Gaebler, 1992; Hughes, 2003).

Menurut Osborne dan Gaebler (1992), birokrasi tradisional OPA menekankan pentingnya standardisasi sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, keseragaman tindakan administratif, dan pengendalian internal yang efektif. Standardisasi menjadi mekanisme untuk mengatur perilaku birokrasi agar sejalan dengan tujuan organisasi dan kebijakan publik yang berlaku. Hughes (2003) juga menekankan bahwa dalam administrasi publik, standardisasi membantu mengurangi diskresi yang berlebihan dari petugas lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau bias dalam pelayanan.

Dalam kerangka manajemen risiko, *standardization by provider* berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal (*internal control*) untuk meminimalkan risiko kesalahan prosedur, risiko keselamatan pasien, risiko hukum, hingga risiko reputasi organisasi. Sebagai contoh, di sektor pelayanan kesehatan, standardisasi diwujudkan melalui Standard Pelayanan minimal (SPM), *Clinical Pathway*, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan Pedoman Praktik Klinis (PPK) untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan regulasi keselamatan pasien (WHO, 2009).

Selain itu, COSO dalam kerangka ERM menempatkan standardisasi sebagai bagian dari komponen *Governance and Culture* serta *Performance*. COSO (2017) menjelaskan bahwa standar operasional dan kebijakan organisasi merupakan landasan penting untuk menciptakan budaya risiko yang sehat, mengatur ekspektasi perilaku personel, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara konsisten. (Moeller, R. R. (2011)

Dalam kerangka *governance*, *standardization by provider* mendukung terciptanya *good governance* dengan memastikan akuntabilitas prosedural (*procedural accountability*), kepatuhan terhadap regulasi (*legal compliance*), dan legitimasi profesional (*professional legitimacy*). Sementara dalam konteks pelayanan publik, standardisasi juga berfungsi sebagai dasar bagi proses akreditasi, audit mutu, dan penilaian kinerja organisasi (Hughes, 2003; WHO, 2009).

Sebagai contoh implementasi pada rumah sakit publik, standardisasi protokol triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) memastikan setiap pasien gawat darurat ditangani berdasarkan prioritas medis yang objektif, bukan berdasarkan persepsi atau preferensi individu petugas. Hal ini tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan dan organisasi dari risiko tuntutan hukum akibat malpraktik. Dengan demikian, *standardization by provider* merupakan komponen esensial dalam *governance* dan manajemen risiko pelayanan publik, karena menyediakan kerangka kerja formal yang mengatur proses kerja organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi pelayanan public.

Namun demikian, *standardization by provider* memiliki keterbatasan. Denhardt dan Denhardt (2000) mengingatkan bahwa pendekatan standardisasi yang terlalu birokratis dan dominan dapat menimbulkan rigiditas organisasi, mengurangi inovasi, dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara standardisasi internal dengan mekanisme evaluasi eksternal seperti *performance index by citizen* untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan provider menghasilkan outcome dan *public value* sesuai harapan masyarakat (Osborne, 2006).

Dalam konteks ERM, standardisasi oleh provider merupakan komponen kontrol internal yang krusial. COSO (2017) menekankan bahwa ERM terintegrasi dengan strategi dan kinerja organisasi melalui struktur tata kelola, budaya risiko, dan proses manajemen risiko menyeluruh, termasuk penetapan standar risiko di tingkat operasional dan strategis. Standardisasi ini berfungsi untuk mengurangi variasi proses yang memicu risiko klinis dan administratif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dengan meminimalkan risiko yang dapat dicegah melalui prosedur baku (Kaplan & Mikes, 2012).

Lebih lanjut, *standardization by provider* dan *performance index by citizen* saling melengkapi dalam *governance* dan ERM. Standardisasi oleh *provider* memastikan prosedur yang aman dan berkualitas, sedangkan *performance index by citizen* mengevaluasi *outcome* dan manfaat nyata bagi Masyarakat. Moeller, R. R. (2011). Misalnya, dalam pelayanan instalasi gawat darurat, standardisasi triase memberikan algoritma penanganan kegawatdaruratan untuk keselamatan pasien, sementara *performance index by citizen* mengukur kepuasan pasien atas kecepatan layanan sebagai indikator efektivitas standar tersebut.

Dengan demikian, keseimbangan antara *standardization by provider* dan *performance index by citizen* menjadi prinsip fundamental dalam *governance* dan manajemen risiko pelayanan publik modern, memastikan organisasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada outcome dan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik sah pelayanan publik (Kaplan & Mikes, 2012; Moeller, R. R. 2011).

8. *Performance Index by Citizen* dalam Pelayanan Publik dengan Pendekatan SERVQUAL

Dalam paradigma *governance* dan pelayanan publik, *performance index by citizen* merupakan salah satu elemen penting untuk mengukur kinerja organisasi berdasarkan pengalaman, persepsi, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Osborne dan Gaebler (1992) menyatakan bahwa dalam kerangka *reinventing government*, pemerintah dituntut untuk berorientasi pada hasil dan outcome yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan prosedural internal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan publik, dengan mengukur kinerja dari sisi penerima manfaat (*citizen as customer*) dan bukan hanya dari sisi provider.

Performance index by citizen menekankan evaluasi kinerja organisasi publik berdasarkan persepsi, pengalaman, dan kepuasan warga negara sebagai pengguna layanan (Osborne, Radnor, & Strokosch, 2016). Indeks ini bisa berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), *PROMs (Patient Reported Outcome Measures)* atau *Patient Reported Experience Measures (PREMs)* yang menilai kualitas layanan dari sudut pandang penerima manfaat.

Performance index by citizen digunakan untuk menilai sejauh mana layanan publik memenuhi ekspektasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas eksternal, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta memperkuat legitimasi organisasi publik di mata masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2000; Osborne, 2006). Hal ini penting karena tanpa evaluasi berbasis masyarakat, organisasi publik berpotensi terjebak dalam paradigma *inward-looking* yang hanya mengukur keberhasilan dari aspek input dan proses internal, bukan dari nilai yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam kerangka ERM, perspektif pengguna layanan menjadi salah satu sumber utama dalam identifikasi risiko strategis dan reputasi. COSO (2017) menekankan bahwa input *stakeholder* merupakan faktor penting dalam penilaian risiko, karena

persepsi publik terhadap kualitas layanan dapat memunculkan beberapa konsekuensi risiko. Pertama, munculnya risiko reputasi (*reputational risk*) ketika terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan pengalaman layanan yang dirasakan masyarakat. Kedua, risiko strategis, apabila layanan rumah sakit tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan legitimasi organisasi. Ketiga, risiko kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) dan standar akreditasi, yang menekankan prinsip *patient-centered care* (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur *performance index by citizen* dalam pelayanan publik adalah model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Model ini mengukur kesenjangan (*gap*) antara persepsi (*perceived service*) dan harapan (*expected service*) pengguna layanan, sehingga memberikan gambaran seberapa besar kualitas pelayanan organisasi publik dalam memenuhi ekspektasi masyarakat.

Pentingnya *performance index by citizen* antara lain meningkatkan akuntabilitas eksternal dan legitimasi organisasi karena indikator kinerja diukur dari perspektif pengguna layanan, bukan hanya prosedur internal (Osborne, 2006). Selain itu, pendekatan ini mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) berbasis umpan balik masyarakat, serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kualitas dan efektivitas pelayanan publik (Kooiman, 2003; Hughes, 2003).

Menurut Parasuraman *et al.* (1988), dalam (Setiyono, 2020) terdapat lima dimensi pokok yang menentukan kualitas jasa pelayanan yaitu SERVQUAL untuk mengukur *performance index by citizen*: *Reliability* (keandalan), *assurance*, *tangibles*, *responsiveness*, dan *empathy*. *Reliability* merupakan prioritas pertama merupakan kemampuan organisasi untuk membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai yang apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dalam hal ini, pelayanan harus tepat waktu, dilakukan tanpa kesalahan, ramah, simpatik dan dengan tingkat akurasi tinggi.:

a. *Reliability* (Keandalan).

Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat, konsisten, dan terpercaya. Contohnya keakuratan hasil laboratorium, ketepatan jadwal visit dokter, serta ketersediaan obat sesuai resep.

b. *Assurance* (Jaminan / Kepercayaan).

Pengetahuan dan sikap pegawai yang menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat. Contohnya profesionalisme dokter dalam menjelaskan diagnosis dan prosedur kepada pasien dengan empati dan bahasa yang mudah dipahami.

c. *Tangibles* (Bukti Fisik).

Meliputi fasilitas fisik, sarana prasarana, peralatan, dan penampilan personel. Dalam konteks rumah sakit, hal ini mencakup kebersihan ruangan, kerapian perawat dan dokter, serta kenyamanan ruang tunggu pasien.

d. *Responsiveness* (Daya Tanggap).

Kesediaan dan kecepatan petugas membantu pasien serta memberikan pelayanan dengan sigap. Misalnya respon cepat petugas IGD saat pasien datang dalam kondisi gawat darurat.

e. *Empathy* (Empati).

Perhatian dan kepedulian individual yang diberikan kepada pasien. Contohnya perawat yang mengingat nama pasien, menanyakan kondisi pasien secara personal, serta menunjukkan sikap peduli selama perawatan.

Model SERVQUAL telah banyak digunakan dalam penelitian kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan pelayanan publik lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengukur kepuasan masyarakat, kesenjangan pelayanan, dan memetakan prioritas perbaikan layanan (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et al., 1990).

Sebagai contoh implementasi di rumah sakit, pengukuran SERVQUAL digunakan dalam survei kepuasan pasien rawat jalan untuk menilai waktu tunggu pendaftaran, kejelasan informasi yang diberikan dokter, keramahan petugas, dan kebersihan fasilitas. Hasil pengukuran ini kemudian dijadikan dasar dalam perbaikan proses layanan, pelatihan staf, serta penentuan prioritas kebijakan manajemen risiko pelayanan.

9. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) dalam intervensi Kebijakan

Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh aktor negara untuk menyelesaikan masalah publik tertentu (Dye, 2013). Menurut Dunn (2018), kebijakan publik meliputi proses perumusan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Merilee S. Grindle dalam bukunya *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of*

Developing Countries (1997) menguraikan pentingnya intervensi kebijakan (*policy intervention*) dalam memperkuat kapasitas organisasi sektor publik. Intervensi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mempengaruhi kondisi tertentu melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Grindle (1980) menyatakan bahwa intervensi kebijakan mencakup penetapan tujuan kebijakan, pemilihan instrumen kebijakan yang tepat ((regulasi, insentif, program), proses implementasi yang efektif, dan evaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan. Tujuan utamanya adalah mengubah situasi, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kinerja sektor publik sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam konteks penguatan implementasi kebijakan, Grindle (1997) mengemukakan bahwa keberhasilan intervensi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas institusi dan aktor pelaksana. Teori pengembangan kapasitas Grindle (1997) menekankan tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), meliputi struktur organisasi, regulasi, prosedur, serta mekanisme koordinasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien.
- b. Kapasitas sumber daya manusia (*human resource capacity*), yaitu kemampuan teknis, kompetensi manajerial, dan pengetahuan yang dimiliki para aktor kebijakan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.
- c. Kapasitas sistemik (*systemic capacity*), mencakup hubungan antar lembaga, sistem insentif, lingkungan politik, serta faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Grindle (1997) menyatakan bahwa intervensi kebijakan yang efektif memerlukan penguatan kapasitas pada ketiga dimensi tersebut secara simultan, tanpa pengembangan kapasitas akan berisiko mengalami kegagalan implementasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik memerlukan strategi penguatan kapasitas pada ketiga dimensi tersebut secara simultan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

10. System Thinking dalam Enterprise risk management

Menurut Peter Senge (1990), organisasi modern harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan dinamis, sehingga penyelesaian masalah organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, melainkan melalui pendekatan

holistik yang mempertimbangkan keterkaitan antar-komponen organisasi. Konsep ini dikenal sebagai *systems thinking*, yaitu suatu pendekatan yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling memengaruhi melalui pola hubungan, umpan balik (*feedback loop*), keterlambatan dampak (*delay*), dan mekanisme adaptasi yang berlangsung secara terus-menerus (Senge, 1990). Dalam perspektif ini, organisasi tidak hanya dipahami berdasarkan kejadian individual (*event-oriented thinking*), tetapi lebih pada pola hubungan dan struktur sistem yang membentuk perilaku organisasi dalam jangka panjang.

Senge, 1990), menempatkan *systems thinking* sebagai disiplin kelima (*the fifth discipline*) yang mengintegrasikan empat disiplin organisasi pembelajar lainnya, yaitu *personal mastery*, *mental models*, *shared vision*, dan *team learning* (Senge, 1990). *Personal mastery* menekankan pentingnya pengembangan kapasitas individu secara berkelanjutan, sedangkan *mental models* berkaitan dengan asumsi dan pola pikir yang memengaruhi proses pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, *shared vision* menekankan pentingnya visi kolektif yang menjadi arah bersama organisasi, sementara *team learning* menekankan pembelajaran kolaboratif melalui dialog dan refleksi bersama. Integrasi kelima disiplin tersebut membentuk organisasi pembelajar (*learning organization*) yang mampu beradaptasi terhadap kompleksitas lingkungan strategis.

Dalam konteks rumah sakit, pendekatan *systems thinking* merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi multidisiplin, teknologi, regulasi, tata kelola, budaya organisasi, dan keselamatan pasien. Pendekatan ini memandang bahwa insiden keselamatan pasien tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu (*human error*), tetapi merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor sistemik, seperti komunikasi, kepemimpinan, budaya keselamatan, beban kerja, desain proses pelayanan, serta mekanisme pengawasan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko rumah sakit memerlukan pendekatan sistemik yang mampu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara komprehensif dan berorientasi pada pembelajaran organisasi.

Dalam perspektif ERM, *systems thinking* memberikan landasan konseptual bagi integrasi manajemen risiko ke dalam keseluruhan proses tata kelola organisasi rumah sakit. ERM tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme pengendalian risiko administratif, tetapi sebagai pendekatan strategis yang menghubungkan tata kelola,

pengambilan keputusan, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien secara terpadu. Oleh karena itu, implementasi ERM membutuhkan kepemimpinan transformasional yang mampu membangun budaya risiko, mengintegrasikan visi strategis, serta mendorong pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Pemimpin transformasional berfungsi sebagai integrator sistem dan agen perubahan yang memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari tata kelola rumah sakit publik secara menyeluruh.

Dengan demikian, pendekatan *systems thinking* mendukung terciptanya rumah sakit yang adaptif, *resilien*, serta mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi organisasi, akuntabilitas publik, dan perlindungan keselamatan Masyarakat.

11. Manajemen Risiko

Menurut McPhee (2005) yang mengutip Atkinson & Webb, risiko dipahami sebagai ketidakpastian dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Senada dengan itu, Comcover (2008) dalam Wibowo (2022) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa atau aktivitas menimbulkan dampak buruk pada organisasi sehingga menghalangi pencapaian hasil yang ditetapkan. *Internal Auditor Internasional* (IIA) juga menyatakan bahwa risiko merupakan ketidakpastian dari suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Wibowo, 2022). Definisi tersebut sejalan dengan COSO dalam Reding (2013) dan ISO 31000:2009 yang memaknai risiko sebagai dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Demikian pula, AS-NZS (*Australian New Zealand Standard*) 4360:2004 mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada pencapaian tujuan, sedangkan ISO 31000:2018 menegaskan bahwa risiko adalah efek ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran atau tujuan.

Menurut Atkinson dan Webb dalam (McPhee, 2005), baik organisasi publik maupun privat dapat menghadapi risiko berdasarkan sifat dasar dan akibatnya. Organisasi privat biasanya dikaitkan dengan nilai finansial, sedangkan organisasi publik atau nonprofit biasanya dikaitkan dengan kualitas pencapaian tujuan. Tiga faktor mempengaruhi risiko organisasi. Pertama adalah risiko strategis, yang berfokus pada keakuratan alternatif strategi dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Kedua adalah risiko lingkungan, yang mencakup aspek kondisi makro, persaingan, dan pasar. Ketiga adalah risiko operasi, yang mencakup risiko kepatuhan

dan risiko proses (McPhee, 2005).

Risiko dalam konteks organisasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat berdampak pada pemenuhan Visi, Misi, Nilai, tujuan dan sasaran organisasi. Namun, biasanya tidak sepenuhnya dinyatakan oleh sebagian besar organisasi (Wibowo, 2022). Selaras dengan pernyataan Reding, sebuah artikel yang disusun oleh *The Association of Risk Management (Airmic)*, *The Public Risk Management Association (Alarm)*, & *IRM* atau *Institute of Risk Management* (2010) menyatakan bahwa definisi risiko dapat diaplikasikan dengan mudah ketika tujuan dan sasaran organisasi telah ditetapkan dengan jelas dan komprehensif. Lebih lanjut lagi, risiko dapat mempengaruhi organisasi baik dalam operasional, taktik dan strategi. Sehingga risiko dapat mempengaruhi organisasi baik dalam jangka waktu pendek, menengah maupun dalam jangka waktu panjang.

Dalam administrasi publik, risiko bukan hanya terkait dengan hilangnya aset atau sumber daya, tetapi juga dampak pada stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik. Teori ini mengakui bahwa institusi publik beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti, di mana setiap keputusan dapat memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat (Raczkowski, 2017).

Menurut ISO 31000:2018, manajemen risiko merupakan aktivitas terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya. Manajemen risiko adalah suatu prosedur pengelolaan risiko secara terarah melalui suatu sistem tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan risiko, atau setidaknya tindakan yang sistematis dan terencana untuk mengurangi risiko ke tingkat serendah mungkin. Ini adalah prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan keselamatan. (Daneshjo *et al.*, 2021).

Adapun menurut (Kumar, 2021), Manajemen risiko adalah suatu proses dimana risiko diidentifikasi, kemungkinan dan dampaknya diukur, tindakan mitigasinya direncanakan dan risiko dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada manajemen puncak. Secara tradisional, manajemen risiko lebih banyak diterapkan di sektor keuangan seperti asuransi dan perbankan. Namun, penerapannya selama bertahun-tahun telah meningkat di banyak bidang seperti sektor energi, sektor konstruksi, lingkungan hidup termasuk sektor Kesehatan.

12. Manajemen risiko pada Administrasi publik

Manajemen risiko dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor swasta, meskipun keduanya menghadapi tantangan yang

semakin kompleks dan dinamis (Postula, 2016; Raczkowski & Tworek, 2017). Dalam konteks administrasi publik, risiko mencakup stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan sistemik dalam manajemen risiko menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap risiko yang muncul dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif (McPhee, 2005).

Manajemen risiko pada administrasi publik memiliki peran yang strategis, karena penerapan pendekatan manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pengembangan konsep manajemen risiko di sektor publik bertujuan untuk membantu institusi pemerintah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Pendekatan ini menekankan pentingnya adopsi sistem manajemen risiko yang komprehensif, mengingat risiko dapat memengaruhi berbagai aspek strategis, taktis, maupun operasional organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Airmic & IRM, 2010).

Selain itu, terdapat berbagai alasan mengapa risiko di sektor publik perlu dikelola dengan baik yaitu reputasi organisasi yang jelek di mata masyarakat, gangguan akibat penerapan teknologi dan sistem informasi baru, permasalahan komunikasi dan arus informasi dalam organisasi publik, kesulitan logistik dan transportasi, buruknya kualitas pelayanan publik (Osborne & Brown, 2013), gangguan komunikasi internal, korupsi dan penipuan, serta dampak bencana alam (Raczkowski, 2017).

Dalam konteks pelayanan publik di rumah sakit, karakteristik organisasi publik memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Rumah sakit pemerintah memiliki tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat luas, berbeda dengan rumah sakit swasta yang berorientasi pada profit (Bovaird et al., 2002). Selain itu, rumah sakit publik menghadapi tantangan dalam manajemen risiko operasional, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan, sehingga penerapan *risk-based performance management* menjadi relevan untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan (Peters & Pierre, 2000).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem mitigasi

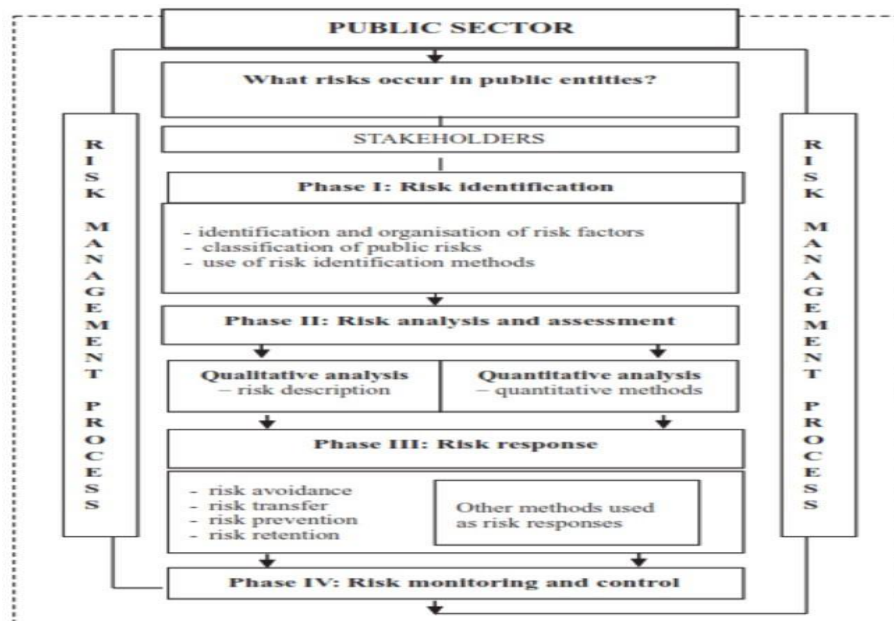
risiko berbasis data yang memungkinkan rumah sakit untuk mengidentifikasi potensi risiko serta mengambil langkah preventif sebelum risiko tersebut memengaruhi kinerja layanan. Selain aspek regulasi dan operasional, rumah sakit sebagai organisasi publik juga memiliki kompleksitas dalam tata kelola pemangku kepentingan. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit berinteraksi tidak hanya dengan pasien dan tenaga medis, tetapi juga dengan lembaga asuransi kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, konsep *collaborative governance* menjadi krusial untuk mengelola risiko dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan (Bovaird et al., 2002).

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko di rumah sakit publik harus mempertimbangkan karakteristik organisasi publik yang unik. Efektivitas sistem manajemen risiko tidak hanya bergantung pada strategi internal rumah sakit, tetapi juga pada keberhasilan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan risiko tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Raczkowski, 2017).

Pengelolaan risiko dan identifikasi risiko merupakan komponen penting dari tata kelola (*governance*) dan manajemen yang efektif, baik di sektor publik maupun swasta. Menurut McPhee (2005), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi risiko organisasi untuk kepentingan para pemangku kepentingan utama mereka. Risiko ini mencakup risiko strategis, program, dan operasional, serta risiko terkait kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan pelaporan keuangan. Para pemangku kepentingan juga mengharapkan para pengelola organisasi untuk mampu mengelola risiko strategis dan lingkungan serta menerapkan kontrol yang efektif. Manajer di semua tingkatan diharapkan dapat mengelola risiko strategis, lingkungan, dan operasional, sehingga pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab kolektif di semua level organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterhubungan antar bagian organisasi dan pemangku kepentingan, sehingga setiap risiko dipahami dalam konteks sistem yang lebih luas. Hal ini menegaskan perlunya koordinasi yang efektif antara departemen dan lembaga dalam mengelola risiko secara menyeluruh.

Menurut Raczkowski (2017), proses manajemen risiko dalam administrasi publik mencakup tahapan identifikasi risiko, analisis dan asesmen risiko, respon risiko, serta

pemantauan dan pengendalian risiko secara berkelanjutan, untuk memastikan risiko tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh organisasi. (1) identifikasi risiko, meliputi pengenalan sumber risiko dan penetapan subkategori risiko dasar; (2) analisis dan penilaian risiko, mencakup estimasi risiko dan penentuan dampaknya terhadap organisasi publik; dan (3) respon risiko, pemilihan metode yang tepat untuk mengurangi atau mencegah risiko yang telah diidentifikasi dan diukur sebelumnya (Tworek, 2012; McPhee, 2005).



Gambar 2.1

Proses manajemen risiko di institusi publik

Sumber: (Tworek, 2012) dalam (Rackowski, K, 2017).

Dalam konteks internasional, berbagai standar telah dikembangkan untuk membantu organisasi publik dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, di antaranya adalah AS/NZS 4360:2004, COSO ERM, serta standar FERMA (*Federation of European Risk Management Associations*) yang mengacu pada pendekatan berbasis tata kelola risiko yang sistematis dan berbasis proses. Dari ketiga penerapan manajemen resiko terlihat dari 12 karakteristik utama yang disajikan pada tabel 2.4 Penerapan standar ini menekankan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu dalam organisasi, tetapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi yang diterapkan di semua tingkatan (Tworek, 2012) dalam (Rackowski, K, 2017).

Tabel 2.4
Standar Manajemen Risiko: 12 Karakteristik Utama

No	Karakteristik Utama	AS/NZS 4360:2004	ERM – COSO II	Standar FERMA
1	Definisi Risiko	Kemungkinan terjadinya sesuatu yang berdampak pada tujuan perusahaan, mencakup aspek risiko negatif dan positif.	Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan, mencakup aspek negatif dan positif (peluang).	Kombinasi kemungkinan suatu peristiwa dan konsekuensinya, berfokus terutama pada aspek risiko negatif.
2	Fokus Manajemen Risiko	Budaya, proses, dan struktur untuk memperoleh keuntungan serta mengendalikan ancaman.	Dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain, diterapkan dalam strategi perusahaan.	Proses sistematis organisasi dalam mengatasi risiko.
3	Ruang Lingkup	Dapat diterapkan di organisasi mana pun.	Dirancang untuk perusahaan-perusahaan terdaftar di Amerika.	Dapat diterapkan di semua jenis organisasi, termasuk sektor publik.
4	Penjelasan Standar	Penjelasan umum dengan perluasan dalam buku pegangan.	Penjelasan rinci mengenai tahapan dalam proses manajemen risiko.	Gambaran umum tentang proses dan tahapan manajemen risiko.
5	Identifikasi Entitas dalam Manajemen Risiko	Mengidentifikasi entitas yang terlibat serta dokumen pendukung sistem manajemen risiko.	Menekankan bahwa manajemen risiko harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis.	Mengidentifikasi entitas yang berpartisipasi dan merekomendasikan regulasi internal umum.
6	Penetapan Tujuan	Tertanam dalam proses manajemen risiko.	Bagian dari proses manajemen risiko, membedakan empat jenis tujuan: strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	Tidak ada bagian khusus tentang penetapan tujuan, tetapi dampaknya pada pencapaian tujuan strategis ditekankan.
7	Identifikasi Risiko	Tidak terlalu menekankan identifikasi risiko, tetapi memberikan panduan metode identifikasi dan dokumentasi.	Berbasis analisis lingkungan internal dan eksternal, serta teknik identifikasi risiko yang rinci.	Bagian dari analisis risiko yang mencakup deskripsi dan estimasi risiko, disarankan dilakukan secara metodis.

No	Karakteristik Utama	AS/NZS 4360:2004	ERM – COSO II	Standar FERMA
8	Estimasi Risiko	Dijelaskan dalam bagian pedoman, tetapi tanpa referensi peristiwa historis.	Tidak ada bagian tersendiri mengenai estimasi, hanya beberapa referensi dalam penilaian dan respons risiko.	Setelah evaluasi risiko, keputusan harus diambil sesuai kriteria yang telah disepakati.
9	Pelaporan dan Komunikasi	Dibahas di bagian pertama standar.	Harus dilakukan setelah respons dan pengendalian risiko.	Dibahas sebelum bagian respons risiko, mencakup komunikasi internal dan eksternal.
10	Respons Risiko	Menjelaskan aktivitas risiko yang memiliki dampak positif dan negatif, dengan analisis biaya dan manfaat.	Membedakan empat respons risiko: menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko, dengan analisis singkat biaya dan manfaat.	Tidak banyak membahas pengendalian risiko, hanya menekankan mitigasi, transfer, dan pembiayaan risiko.
11	Pemantauan dan Pengukuran	Pemantauan berkelanjutan sangat penting, bagian pedoman mencakup pengukuran efektivitas.	Membedakan pemantauan yang sedang berlangsung dan ad hoc, dengan ruang lingkup pelaporan subjektif dan objektif.	Pemantauan harus memberikan informasi tentang identifikasi risiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan.
12	Peran dan Tanggung Jawab	Mengacu pada evaluasi praktik sebelumnya, peran manajemen tingkat atas, dan penyediaan sumber daya.	Menguraikan peran dewan direksi, manajer, CRO, pejabat keuangan, auditor internal, serta pihak eksternal.	Menetapkan peran direksi, unit bisnis, fungsi manajemen risiko, dan audit internal, termasuk kebijakan manajemen risiko dan sumber daya yang diperlukan.

Sumber: ASHRM (2020)

Berdasarkan Tabel 2.4, terdapat tiga standar utama dalam manajemen risiko, yaitu AS/NZS 4360:2004, ERM COSO II, dan Standar FERMA. Ketiga standar ini memiliki perbedaan dalam mendefinisikan risiko. AS/NZS 4360:2004 dan COSO II mengakui bahwa risiko mencakup aspek positif dan negatif, sementara Standar FERMA lebih berfokus pada aspek negatif. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam ruang lingkup penerapannya, di mana AS/NZS 4360:2004 dan Standar FERMA dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk sektor publik, sementara COSO

II lebih ditujukan bagi perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat.

Dalam aspek metodologi, ketiga standar memiliki cara berbeda dalam menangani identifikasi risiko, estimasi risiko, serta respons terhadap risiko. AS/NZS 4360:2004 menyediakan pedoman umum untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko tanpa terlalu menekankan teknik spesifik. COSO II, sebaliknya, menekankan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam mengidentifikasi risiko, sedangkan Standar FERMA lebih menekankan pendekatan metodis dalam mendeskripsikan dan mengestimasi risiko. Dalam hal respons risiko, COSO II mengklasifikasikan respons menjadi empat kategori utama (menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko), sementara Standar FERMA lebih fokus pada mitigasi, transfer, dan pembiayaan risiko. Terakhir, dalam aspek tata kelola, pemantauan, dan komunikasi, terdapat beberapa perbedaan penting. AS/NZS 4360:2004 menekankan pemantauan berkelanjutan dalam pengukuran efektivitas manajemen risiko, sedangkan COSO II membedakan antara pemantauan berkelanjutan dan pemantauan ad hoc. Standar FERMA menekankan bahwa pemantauan harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk tindakan pengendalian risiko. Dalam hal komunikasi, COSO II mengatur bahwa pelaporan dan komunikasi harus dilakukan setelah respons dan pengendalian risiko, sementara Standar FERMA menempatkan komunikasi sebelum respons risiko, mencakup komunikasi internal dan eksternal. Dalam hal peran dan tanggung jawab, COSO II dan Standar FERMA lebih rinci dalam menguraikan peran direksi, manajer, auditor, serta sumber daya yang diperlukan dibandingkan dengan AS/NZS 4360:2004, yang lebih berfokus pada praktik manajemen sebelumnya.

Dalam penerapan manajemen risiko sektor publik, kepemimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun budaya risiko yang sehat di dalam organisasi. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada risiko akan mendorong organisasi untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Jika *tone of the top* dalam organisasi tidak mendukung budaya risiko yang baik, maka upaya manajemen risiko yang diterapkan sering kali mengalami hambatan, terutama dalam implementasi di lapangan (Ari, 2020)

Pendekatan berbasis risiko dalam administrasi publik juga sangat relevan dalam konteks pengelolaan layanan publik yang berkelanjutan dan efisien (Bovaird & Löffler, 2003). Pengelolaan risiko dalam layanan publik harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, dinamika sosial, serta keterbatasan

anggaran yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu mengembangkan strategi mitigasi yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari risiko yang ada.

Dari aspek *governance*, manajemen risiko menjadi salah satu komponen yang harus diterapkan di sektor publik. Untuk menuntun dan mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Semua anggota diharapkan mengikuti pimpinan sebagai panutan. Fakta bahwa pemimpin terus menunjukkan contoh yang buruk adalah fenomena yang menunjukkan bahwa budaya risiko belum terbentuk, baik dari pelaku maupun lingkungan, di mana orang saling menegur atau melarang anggota organisasi untuk tidak melakukan kesalahan, termasuk menegur pimpinan (Ari, 2020).

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif dalam administrasi publik merupakan elemen kunci dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan fungsi pemerintahan. Selain itu, manajemen risiko yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan (Rothstein *et al.*, 2013). Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam pengelolaan risiko sektor publik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

13. Manajemen risiko organisasi (*Enterprise risk management* / ERM)

Enterprise Risk Management (ERM), mulai berkembang di awal 1990an dengan mengelola risiko agar organisasi dapat bertahan hidup, memiliki stabilitas, tanggung jawab fidusia dan mematuhi perilaku hukum dan etika. ERM adalah proses mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi suatu organisasi, memperkirakan signifikansinya dalam proses bisnis, menanganinya dalam suatu rencana yang sistematis dan terkoordinasi, menerapkan rencana tersebut dan meminta pertanggungjawaban individu-individu kunci untuk mengelola risiko-risiko kritis dalam lingkup tanggung jawab mereka (ASHRM, 2020)

ERM merupakan pendekatan terstruktur dan menyeluruh dalam mengelola risiko yang dihadapi organisasi sebagai upaya mencapai tujuan strategisnya. Kerangka kerja ERM yang diakui secara luas adalah dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). (COSO ERM 2017).

Framework ini mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategis dan pengambilan Keputusan organisasi. COSO ERM 2017 menekankan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab unit tertentu, tetapi merupakan bagian integral dari budaya, struktur, dan sistem informasi organisasi. Terdapat lima komponen utama dalam COSO ERM 2017, yaitu: *Governance and Culture, Strategy and Objective-Setting, Performance, Review and Revision, serta Information, Communication, and Reporting*. Masing-masing komponen ini terdiri dari prinsip-prinsip yang dapat dioperasionalkan untuk menilai dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko (Moeller, 2011).

Menurut ASHRM (2020), ERM didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mencakup seluruh jenis risiko dalam suatu organisasi, termasuk tantangan dan peluang, serta mengintegrasikannya ke dalam suatu kerangka kerja strategis yang selaras dengan tujuan organisasi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi. Setiap bidang dalam manajemen risiko memiliki terminologi, pendekatan, dan fokusnya sendiri. Namun, pada dasarnya, semuanya berkaitan dengan ancaman terhadap organisasi. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Raczkowski & Tworek, 2017), menjadi jelas bahwa strategi manajemen risiko yang bersifat terpadu lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang terpisah-pisah (*silo approach*). Keberhasilan manajemen risiko bahaya (*hazard risk management*) dan manajemen risiko keuangan mendorong para manajer untuk mengintegrasikan berbagai kategori risiko lainnya ke dalam strategi manajemen risiko yang lebih komprehensif, mencakup risiko strategis dan operasional. Dengan konsep ini, ERM dikembangkan sebagai pendekatan holistik dalam mengelola risiko secara menyeluruh (Raczkowski & Tworek, 2017).

Pada era 1970-an, dengan meningkatnya volatilitas suku bunga dan harga komoditas global, perusahaan mulai mengembangkan metode baru untuk mengelola risiko finansial yang sebelumnya tidak banyak diperhatikan. (ASHRM, 2020) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko kolaboratif dan proaktif sangat penting untuk memastikan organisasi mampu mengelola risiko dengan lebih efektif, bukan hanya untuk mengurangi ancaman, tetapi juga untuk menciptakan peluang strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Pemahaman terhadap jenis risiko juga menjadi aspek fundamental dalam strategi manajemen risiko organisasi.

Selain itu, keseluruhan proses manajemen risiko merupakan strategi manajemen yang bersifat kolaboratif dan proaktif, yang memerlukan pendekatan terkoordinasi dan tersegmentasi dalam suatu organisasi untuk memungkinkan perumusan keputusan yang optimal serta pembentukan kerangka kerja dalam mengelola risiko dan menciptakan peluang. Dengan demikian, ERM mencakup seluruh aspek organisasi dan memandang risiko tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang.

Berbagai jenis informasi mengenai risiko keuangan dan risiko murni kemungkinan besar akan diterima oleh dewan direksi serta manajer lainnya dalam menetapkan rencana manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Baik jenis risiko, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikannya, maupun ukuran risiko yang digunakan, semuanya memiliki perbedaan. Hal ini memperumit tugas dalam mengkoordinasikan eksposur risiko organisasi secara menyeluruh. Ketika pengelolaan risiko memerlukan lebih dari sekadar manajer risiko tradisional untuk menangani risiko yang dapat mempengaruhi strategi organisasi, alasan mendasar untuk pengembangan ERM pun muncul (Tworek, 2012).

Sejalan dengan hal tersebut, Abah & ESQ (2019) menyatakan bahwa ERM telah menjadi suatu kebutuhan bagi banyak organisasi saat ini. ERM memperluas cakupan manajemen risiko, tidak hanya terbatas pada risiko terkait dan insidental, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam keseluruhan operasi organisasi. Dengan demikian, ERM tidak hanya berfokus pada perlindungan terhadap ancaman, tetapi juga pada pengelolaan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara strategis.

Karena ERM mencakup berbagai aspek dalam operasi organisasi serta beragam jenis risiko, tidak ada satu individu pun yang dapat mengelola seluruh proses ini secara menyeluruh (Raczkowski & Tworek, 2017). Berbeda dengan manajemen risiko tradisional, ERM merupakan usaha kolaboratif yang melibatkan berbagai bidang keahlian, termasuk manajemen risiko tradisional, manajemen risiko keuangan, sistem informasi manajemen, audit, perencanaan, dan operasional. Pendekatan berbasis tim ini mencegah para manajer risiko untuk hanya berfokus pada aspek risiko tertentu, melainkan melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Agar tim ini efektif, pemimpin tim harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang seluruh proses serta metodologi yang digunakan oleh setiap departemen. Selain itu, anggota tim ERM perlu mengembangkan keterampilan tambahan seperti memahami terminologi strategi dan risiko keuangan, menguasai instrumen manajemen risiko keuangan yang baru,

serta menggunakan teknik simulasi dan pemodelan (Bromiley *et al.*, 2015).

Lebih jauh, pelaporan risiko yang transparan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan manajemen risiko serta keterbukaan informasi. Untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif, tim manajemen risiko harus mampu menyelaraskan tugas antar berbagai unit guna memastikan kelangsungan organisasi. Dengan demikian, ERM bukanlah pendekatan baru dalam manajemen risiko, tetapi lebih merupakan pengakuan bahwa manajemen risiko harus mencakup semua risiko, bukan hanya sebagian darinya. Hal ini menjadikan ERM sebagai pendekatan holistik yang tidak hanya melindungi organisasi dari ancaman, tetapi juga mengoptimalkan peluang pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Perbedaan antara Manajemen Risiko Tradisional dan
Enterprise risk management (ERM)

No	Manajemen Risiko Tradisional	<i>Enterprise risk management (ERM)</i>
1	Risiko dianggap sebagai risiko murni atau bahaya.	Risiko mencakup bahaya, keuangan, dan strategi.
2	Identifikasi dan penilaian risiko.	Identifikasi risiko secara menyeluruh.
3	Pendekatan silo dalam manajemen risiko.	Pendekatan yang terintegrasi dalam manajemen risiko.
4	Mitigasi risiko sebagai fokus utama.	Optimasi risiko untuk keseimbangan peluang dan ancaman.
5	Dimiliki oleh petugas risiko (<i>risk officer</i>).	Dimiliki oleh dewan direksi dan seluruh tim dalam organisasi.
6	Batasan risiko sebagai pedoman.	Strategi risiko yang menyeluruh dan selaras dengan tujuan organisasi.

Sumber: ASHRM (2020)

14. Kerangka kerja COSO ERM 2017

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan ERM sebagai proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi organisasi, serta mengelola risiko sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. (Moeller, R. R. (2011)

ERM mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis dan proses bisnis untuk memaksimalkan nilai organisasi melalui:

- a. Identifikasi risiko strategis dan operasional yang dapat menghambat pencapaian

tujuan kebijakan.

- b. Penilaian dan prioritasasi risiko untuk pengambilan keputusan berbasis risiko.
- c. Perlakuan risiko (risk treatment) untuk mengurangi, mengalihkan, menerima, atau menghindari risiko yang tidak dapat diterima.
- d. Pemantauan risiko secara berkelanjutan untuk memastikan adaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal.

Kerangka kerja COSO ERM pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) di Amerika Serikat. Kerangka ini menetapkan bagaimana implementasi ERM dilakukan serta peran dan tanggung jawab utama dalam organisasi, termasuk Dewan direksi, Manajemen, dan staf lainnya. Untuk mencapai tujuan organisasi, kerangka COSO ERM menyediakan prosedur untuk identifikasi risiko, pengelolaan risiko dalam batasan pengendalian internal, serta jaminan kualitas. Kerangka COSO ERM banyak digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk *Global Fund* (Beasley *et al.*, 2010).

Namun, kompleksitas implementasi, kurangnya integrasi strategis dalam ERM, serta perubahan lingkungan eksternal menyebabkan COSO memperbarui kerangka kerja ERM pada tahun 2017 (COSO, 2017). Pembaruan ini menekankan filosofi dasar baru, di mana manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari organisasi, tidak hanya dengan mengidentifikasi risiko negatif, tetapi juga mengevaluasi peluang atau risiko positif. Dengan demikian, risiko harus dinilai bersamaan dengan pengambilan keputusan strategis dan penilaian dampak terhadap kinerja organisasi (Rubino, 2018).

ERM COSO diproduksi pada tahun 2004 dengan pengendalian internal dalam ruang lingkupnya dengan visual dalam bentuk kubus. Kerangka COSO ini kemudian berevolusi menjadi *helix* yang lebih terintegrasi dalam menjalin komponen dan proses di seluruh kegiatan strategis organisasi, seperti yang tercantum dalam Gambar 2.2 (ASHRM, 2020)



Gambar 2.2
COSO ERM 2017 Components and principles
 Sumber: ASHRM, (2020)

Kerangka kerja COSO dibagi menjadi lima komponen utama COSO ERM *Integrating with Strategy and Performance* yaitu 1) Tata kelola dan budaya; 2) Strategi dan penetapan tujuan; 3) Kinerja (*performance*); 4) Evaluasi dan Tinjauan; dan 5) Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan. Semua komponen ini berhubungan dengan tugas utama organisasi, mulai dari komunikasi tentang tujuan, visi, dan nilai utamanya. Visualisasi kerangka kerja menegaskan bahwa ERM tidak statis dan peningkatan nilai dapat dicapai dengan mengintegrasikan elemen dan prinsip ke dalam tugas utama. (ASHRM, 2020)

a. Tata kelola dan budaya (*Governance and Culture*)

Komponen ini menekankan pentingnya struktur tata kelola (*governance structure*) yang jelas dan budaya organisasi yang mendukung perilaku sadar risiko, etika, dan integritas. Governance yang baik menjadi fondasi ERM, memastikan peran dan tanggung jawab aktor kunci dalam pengelolaan risiko terdefinisi dengan jelas.

Tata kelola dan budaya sangat penting untuk mengembangkan dan mempertahankan ERM. Tata kelola akan mempengaruhi budaya, yang pada

akhirnya mendukung pencapaian misi dan visi organisasi. Dalam kerangka COSO, tata kelola diartikulasikan merupakan konsep yang paling luas yang mengacu pada peran, wewenang dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, Dewan direksi, dan Manajemen. Kerangka kerja ERM COSO 2017 memberikan peta jalan yang praktis untuk menerapkan ERM dan memungkinkan fleksibilitas jika diperlukan untuk melindungi dan menciptakan nilai. Budaya Risiko adalah sikap, perilaku, dan pemahaman tentang risiko, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi keputusan manajemen dan personel dan mencerminkan misi, Visi, dan nilai-nilai inti organisasi.

b. Strategi dan penetapan tujuan (*Strategy and Objective Setting*)

Governance yang kuat mendukung proses penetapan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi, serta memastikan bahwa strategi yang dipilih mempertimbangkan profil risiko organisasi. Di sini, manajemen risiko tidak berdiri sendiri, melainkan melekat dalam proses perencanaan strategis.

Keberhasilan setiap bisnis memerlukan strategi untuk mencapai misi dan visinya serta untuk mendorong nilai bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini mencakup pemahaman strategi yang diusulkan selaras dengan misi dan visi, risiko apa yang bersedia diterima oleh organisasi (*risk appetite*) dan apa yang mungkin terjadi, seperti pengurangan nilai, jika beberapa risiko tidak dilakukan. Prinsip-prinsip ERM memformalitkan penetapan strategi yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan bisnis dan strategi alternatif dapat dipertimbangkan jika diperlukan.

c. Kinerja (*performance*)

Pelaksanaan strategi diukur berdasarkan kinerja organisasi, sambil memonitor risiko yang muncul selama implementasi. *Governance* memastikan adanya mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi kinerja secara objektif (Hughes, 2003; COSO, 2017).

Prinsip-prinsip ERM yang berkaitan dengan kinerja sangat mirip dengan proses manajemen risiko lima langkah. Identifikasi risiko adalah aktivitas penting dalam ERM, baik yang terjadi pada tingkat transaksional, departemen, atau entitas. Kegiatan ini juga harus berupaya mengidentifikasi risiko yang tidak diantisipasi. Menilai dan memprioritaskan risiko dan mengidentifikasi respons risiko yang tepat dapat dilakukan dengan berbagai metode dan sumber daya.

d. Evaluasi dan Tinjauan (*Review and Revision*)

Governance yang efektif mendukung adanya proses evaluasi berkala (*review*) dan perbaikan (*revision*) kebijakan serta strategi organisasi berdasarkan hasil monitoring risiko dan kinerja. Hal ini menunjukkan *governance* bukanlah struktur statis, tetapi sistem adaptif yang responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal (Kooiman, 2003; COSO, 2017).

Strategi, tujuan dan kemampuan bisnis dapat berubah seiring waktu, perubahan tersebut disebabkan oleh lingkungan internal, lingkungan eksternal, atau keduanya. Menyadari hal ini, fungsi ERM harus diintegrasikan ke dalam praktik bisnis untuk mencakup tinjauan kinerja formal. Perbaikan ERM yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kegunaan harus diawasi oleh badan pengelola.

e. Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan (*Information, Communication, and Reporting*)

Governance dan ERM terintegrasi melalui sistem informasi yang menyediakan data risiko yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Pelaporan risiko yang transparan mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat strategis maupun operasional.

Sejumlah besar data yang tersedia di lingkungan kerja saat ini, tidak semuanya memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Transformasi data yang tepat pada waktu yang tepat dalam bentuk yang tepat kepada orang yang tepat harus dilakukan. Komunikasi dua arah yang terstruktur, tepat sasaran, dan konsisten sangat penting untuk memastikan keputusan strategis dapat diambil tepat waktu dengan informasi terbaik yang tersedia. Memahami komponen dan prinsip kerangka COSO, dan bagaimana integrasinya melalui alur pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi, akan memandu merancang dan menerapkan program ERM yang berkelanjutan.

Standar ISO dan COSO merupakan dua rute alternatif untuk menuju tujuan yang sama. Kedua model fokus pada penciptaan dan perlindungan nilai. Model ISO menekankan pada inovasi, sedangkan model COSO menekankan pada hubungan pemangku kepentingan dengan entitasnya. Petunjuk ISO sebagian besar muncul sebagai daftar, sedangkan petunjuk COSO muncul sebagai narasi. ISO mengakui fungsi manajemen risiko dalam manajemen proyek, manajemen risiko keuangan, risiko operasional, dan manajemen risiko organisasi (ASHRM

2020).

Kerangka ini dirancang untuk melindungi nilai organisasi mengarah pada peluang untuk menciptakan nilai baru. Peningkatan kualitas hasil dapat mendorong peningkatan pangsa pasar, memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan kekuatan keuangan organisasi, meningkatkan reputasi dan meningkatkan kepuasan pasien dan staf. Prinsip-prinsip ERM, dalam kepemimpinan untuk mengurangi risiko, menghilangkan kerugian, meminimalkan hilangnya peluang untuk menciptakan nilai, dan menangkap peluang yang menciptakan sisi positif dari pengelolaan risiko (ASHRM 2020).

Dengan demikian, COSO ERM menjadi instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan, governance, dan pencapaian *value for money* dalam organisasi pelayanan publik dengan memposisikan *governance* sebagai komponen fundamental dalam manajemen risiko organisasi. *Governance* menentukan struktur pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, dan akuntabilitas, sementara ERM memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. (Frigo & Anderson, 2011; ISO 31000, 2018).

Dalam konteks rumah sakit publik, integrasi *governance* dan ERM berarti bahwa tata kelola organisasi rumah sakit harus mendukung penerapan manajemen risiko yang sistematis, mulai dari perumusan strategi pelayanan, implementasi program mutu dan keselamatan pasien, hingga pelaporan risiko kepada pemerintah daerah dan publik sebagai bentuk akuntabilitas. *Governance* yang kuat memastikan ERM tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan melekat dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis rumah sakit.

Seiring waktu, berbagai standar telah diterbitkan untuk membantu organisasi publik dan swasta dalam mengadopsi strategi manajemen risiko yang tepat dan sukses. Sehingga penting untuk memahami jenis risiko yang dihadapi organisasi, yaitu risiko sistematis dan risiko unsistematis.

1) Risiko Sistematis

Risiko sistematis (*systematic risk*) adalah risiko yang bersifat makro dan berdampak luas pada organisasi, sektor, maupun sistem secara keseluruhan. Dalam literatur keuangan, risiko sistematis dikaitkan dengan faktor-faktor eksternal seperti inflasi, resesi, krisis politik, dan perubahan

kebijakan nasional, yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi portofolio (Bodie, Kane, & Marcus, 2014; Brigham & Ehrhardt, 2014).

Dalam kerangka COSO ERM (2017), risiko sistematis termasuk dalam kategori risiko strategis karena terkait dengan *external environment* dan *strategic objectives*. Oleh karena itu, pengelolaan risiko sistematis memerlukan pendekatan *environment scanning*, formulasi strategi yang adaptif, penetapan *risk appetite* yang realistis, serta penguatan *governance* untuk memastikan organisasi mampu merespons dinamika eksternal secara efektif (Moeller, R. R. (2011; Frigo & Anderson, 2011).

Dalam konteks rumah sakit pemerintah, risiko sistematis mencakup berbagai faktor eksternal yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pelayanan publik kesehatan. Contoh risiko sistematis di sektor kesehatan antara lain:

- a) Perubahan kebijakan nasional, seperti implementasi JKN-BPJS atau regulasi akreditasi rumah sakit yang mewajibkan standarisasi layanan tertentu.
- b) Krisis epidemiologis, misalnya pandemi COVID-19 yang mengganggu seluruh sistem pelayanan kesehatan.
- c) Fluktuasi alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah, yang memengaruhi pembiayaan operasional dan program prioritas rumah sakit.
- d) Restrukturisasi organisasi kesehatan oleh pemerintah pusat, yang dapat mengubah struktur, fungsi, dan kewenangan rumah sakit daerah.

Risiko-risiko sistematis tersebut bersifat tidak terkontrol oleh organisasi, sehingga strategi ERM yang adaptif, termasuk perencanaan kontinjensi (*contingency planning*) dan *scenario planning*, diperlukan agar rumah sakit tetap dapat memenuhi mandat pelayanan publiknya dalam berbagai kondisi ketidakpastian. (Moeller, R. R, 2011)

2) Risiko *Unsystematis*

Risiko unsistematis (*unsystematic risk*) adalah risiko yang bersifat mikro, spesifik pada organisasi, unit kerja, atau aktivitas tertentu, dan umumnya dapat dikurangi melalui pengendalian internal yang efektif (Bodie, Kane, & Marcus, 2014; Benninga, 2010; Sattar, 2015). Dalam konteks rumah sakit pemerintah, risiko ini meliputi:

- a) *Human error* oleh perawat atau dokter pada prosedur klinis tertentu.
- b) Kegagalan fungsi alat kesehatan di unit layanan spesifik.
- c) Fraud atau penyimpangan prosedur oleh pegawai internal.
- d) Keterlambatan distribusi logistik farmasi yang menghambat pelayanan.

Berbeda dengan risiko sistematis yang bersifat makro dan berada di luar kendali organisasi, risiko unsistematis dapat diminimalkan melalui penerapan SOP yang kuat, pelatihan berkelanjutan, pengendalian internal, dan pengawasan manajerial yang efektif.

Dalam kerangka COSO ERM (2017), risiko unsistematis terkait dengan komponen *performance*, *risk response*, dan *control activities*, dimana organisasi memiliki kendali langsung untuk melakukan identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan pelaporan risiko. Contoh lainnya termasuk risiko teknologi informasi (*IT risk*), risiko ketidakpatuhan regulasi (*compliance risk*), risiko keuangan unit tertentu, dan risiko keselamatan pasien (*patient safety risk*).

Integrasi risiko sistematis dan unsistematis secara menyeluruh penting untuk memastikan strategi organisasi tahan terhadap dinamika eksternal, serta proses operasional berjalan efektif, efisien, dan aman (Moeller, R. R. (2011; Frigo & Anderson, 2011). Dalam model ERM penelitian ini, teori Grindle (1980) terkait intervensi kebijakan dan pengembangan kapasitas diintegrasikan dengan konsep kedua risiko tersebut untuk:

- a) Menyusun kebijakan risiko berdasarkan analisis kondisi makro (risiko sistematis) dan mikro (risiko unsistematis) rumah sakit pemerintah.
- b) Mengaitkan strategi ERM dengan struktur organisasi, kompetensi SDM, dan prosedur kerja di setiap unit pelayanan.
- c) Meningkatkan efektivitas mitigasi risiko baik pada level strategis maupun operasional untuk mendukung tujuan pelayanan publik kesehatan secara optimal.

Dengan demikian, koherensi manajemen risiko sistematis dan unsistematis merupakan inti dari implementasi ERM yang efektif, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong pencapaian kinerja strategis dan operasional rumah sakit secara berkelanjutan.

15. ISO 31000:2018

Standar manajemen risiko ISO 31000:2009 yang diterbitkan oleh *International Standard Organization* (ISO) menetapkan serangkaian metode untuk membantu organisasi dalam mengurangi risiko. Menurut standar ini, organisasi harus mengembangkan, mengimplementasikan, dan secara berkelanjutan meningkatkan suatu kerangka kerja guna mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola, strategi dan perencanaan, manajemen, proses pelaporan, kebijakan, nilai-nilai, serta budaya organisasi secara keseluruhan (ISO 31000, 2009).

Pada tahun 2018, rekomendasi ISO 31000:2009 dimodifikasi menjadi ISO 31000: 2018 yang menekankan pentingnya kepemimpinan manajemen tingkat atas dalam manajemen risiko, serta kebutuhan akan keterlibatan eksternal yang berkelanjutan dan nilai dari manajemen risiko yang interaktif dalam suatu organisasi.

Standar ISO dikembangkan oleh komite internasional yang terdiri dari para ahli di bidangnya. Salah satu standar penting yang diterbitkan oleh ISO adalah ISO 31000, yang memberikan panduan umum dalam manajemen risiko untuk berbagai organisasi. ISO 31000 memiliki tiga komponen utama, yaitu prinsip (*principles*), kerangka kerja (*framework*), dan proses (*process*) (ASHRM, 2020).

a. Prinsip manajemen risiko

Prinsip utama manajemen risiko adalah memberikan nilai bagi organisasi. Dengan kata lain, aktivitas manajemen risiko dirancang untuk mencapai hasil terbaik dan mengurangi volatilitas atau ketidakpastian hasil (Fletcher & Stanton, 2019).

Tujuan manajemen risiko pada Standar internasional ISO 31000: 2018 adalah penciptaan nilai (*value creation*) dan perlindungan nilai (*value protection*) organisasi. Delapan prinsip manajemen risiko meliputi Terintegrasi, Terstruktur dan Komprehensif, Disesuaikan, Inklusif, Dinamis, Informasi Terbaik yang tersedia, Faktor Manusia dan Budaya, dan Perbaikan sinambung. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mengembangkan Kerangka kerja dan Proses manajemen risiko.

1) Terintegrasi (*Integrated*)

Manajemen risiko terintegrasi pada setiap kegiatan organisasi, termasuk perencanaan strategis, operasional, maupun fungsi manajemen meliputi, penganggaran, pengelolaan evaluasi dan audit. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan mempertimbangkan risiko.

2) Terstruktur dan menyeluruh (*Structured and comprehensive*)

Manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan mencakup seluruh aktivitas organisasi sehingga berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan dengan data sebelumnya.

3) Disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya (*Customized*)

Mekanisme dan prosedur manajemen risiko disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

4) Inklusif (*Inclusive*)

Dengan keterlibatan yang sesuai dan tepat dari para pemangku kepentingan maka pengetahuan, perspektif, dan persepsi mereka dapat dipertimbangkan. Proses ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan manajemen risiko agar terinformasi dengan baik.

5) Dinamis (*Dynamic*)

Seiring perubahan konteks di dalam dan di luar organisasi, risiko dapat muncul, berubah, atau hilang. Oleh karena itu proses manajemen risiko bersifat proaktif untuk mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa dengan sesuai dan tepat waktu.

6) Informasi terbaik yang tersedia (*best available information*)

Informasi yang didasarkan pada informasi terkini dan data historis, serta prediksi ke depan, diperlukan agar manajemen risiko dapat memahami hambatan dan ketidakpastian yang ada dalam organisasi.

7) Faktor budaya dan manusia (*human and cultural factors*)

Budaya dan perilaku manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan organisasi sehingga dapat terwujud Manajemen risiko yang efektif.

8) Perbaikan sinambung (*continual improvement*)

Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman setiap periode waktu dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko. Selain itu, proses manajemen risiko dilakukan berdasarkan proses yang telah berjalan dan *lesson learned* setiap periode waktu.

b. Kerangka manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko ISO 31000:2018 merupakan seperangkat komponen yang menjadi landasan dan pengaturan organisasi untuk perancangan,

pelaksanaan, pemantauan, peninjauan dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di seluruh organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko dirancang untuk membantu mengintegrasikan manajemen risiko kedalam operasional organisasi.

Elemen dalam kerangka kerja meliputi integrasi, desain, penerapan, evaluasi dan perbaikan. Elemen-elemen ini merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas yang dikenal sebagai *Plan-Do-Check-Act* atau *Plan-Do-Study-Act*.

1) Integrasi

Manajemen risiko harus terintegrasi dalam filosofi dan budaya organisasi, kebijakan tata kelola, perencanaan, pelaporan dan pengambilan keputusan baik pada level strategis maupun level operasional. Organisasi pelayanan publik yang mengintegrasikan manajemen risiko memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam mencapai tujuan strategis dan memberikan layanan secara efisien dan efektif. Integrasi manajemen risiko perlu dilakukan melalui kebijakan, prioritas, tujuan organisasi (integrasi vertikal) dan kebijakan operasional (integrasi horizontal) (Anindya, 2023)

2) Desain

Dalam merancang kebijakan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, pemahaman organisasi dan konteksnya sangat krusial karena lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal mencakup faktor sosial, politik, budaya, regulasi, keuangan, teknologi, serta dinamika global yang dapat berdampak pada organisasi. Sementara itu, lingkungan internal meliputi tata kelola, struktur organisasi, kebijakan, sumber daya, serta budaya organisasi yang membentuk cara risiko dikelola.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manajemen risiko yang mencakup tenaga kerja kompeten, manajer risiko yang memiliki keahlian khusus, serta sistem dan teknologi pendukung. Sumber daya yang memadai akan memastikan bahwa manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam seluruh proses organisasi.

Terakhir, komunikasi risiko dan mekanisme pelaporan harus diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa informasi terkait risiko dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan. Komunikasi yang

baik akan meningkatkan budaya kesadaran akan risiko dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat.

3) Penerapan

Desain pada tahap sebelumnya dalam bentuk dokumen strategi manajemen risiko dibuat Peta jalan (*roadmap*) agar penerapan manajemen risiko lebih terarah dan terstruktur

4) Evaluasi manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko perlu direviu secara berkala. Sesuai perubahan tujuan atau sasaran, sangat penting untuk menjaga kerangka manajemen risiko tetap relevan dan bekerja efektif sesuai ekspektasi pimpinan. Evaluasi akan membantu untuk menemukan kekurangan, sehingga dapat segera diperbaiki dan/ atau diupayakan terjadi peningkatan.

5) Perbaikan

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Ada dua cara untuk melakukan perbaikan berkelanjutan meliputi (a) Perbaikan berkesinambungan yaitu Organisasi secara bertahap meningkatkan struktur, kapasitas, dan efisiensi manajemen risiko, dan (b) Perbaikan adaptasi yaitu Kerangka kerja manajemen risiko harus dipantau dan disesuaikan secara teratur agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi (perubahan konteks).

c. Proses manajemen risiko

Proses manajemen risiko ISO:31000: 2018 merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis melalui kegiatan seperti komunikasi dan konsultasi; penetapan lingkup, konteks dan kriteria; penilaian risiko yang mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi; perlakuan, risiko; pemantauan dan tinjauan; dan dokumentasi dan pelaporan.

1) Komunikasi dan Konsultasi

Di setiap tahapan proses manajemen risiko, organisasi berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui rapat berkala, rapat insidental, diskusi risiko, penggunaan sistem informasi, dan / atau pelaporan berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui apa yang harus dilakukan selama proses manajemen risiko dan apa tujuan proses tersebut. Komunikasi didefinisikan

sebagai penyebaran informasi untuk membantu para pemangku kepentingan menyadari dan memahami risiko. Konsultasi, di sisi lain, adalah penyediaan informasi untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang tepat waktu. Sebelum dilakukan komunikasi dan konsultasi, perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan baik untuk kepentingan komunikasi maupun konsultasi.

2) Penetapan Lingkup, Konteks dan Kriteria

a) Menetapkan Lingkup proses manajemen risiko

Lingkup manajemen risiko di fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi a) Risiko klinis adalah kemungkinan yang dapat terjadi dan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan terutama keselamatan pasien, b) Risiko non klinis adalah kemungkinan yang dapat terjadi dan berdampak negatif terkait dengan selain pelayanan Kesehatan. (UU no. 17 tahun 2023).

b) Menetapkan Konteks

Menetapkan konteks manajemen risiko berarti menetapkan batasan yang akan digunakan untuk menerapkan proses manajemen risiko. Dalam menetapkan konteks ini, organisasi harus mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. 1) Konteks eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian sasarannya. Konteks eksternal termasuk faktor budaya, sosial, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, dan ekonomi yang beroperasi. Lingkungan eksternal dapat terjadi di tingkat internasional, nasional, atau regional. Lingkungan ini akan mencakup pertimbangan sektor bisnis di mana organisasi beroperasi, pemangku kepentingan eksternal dan harapan mereka dan lingkungan keuangan eksternal. 2) Konteks internal adalah lingkungan di dalam organisasi untuk mencapai sasarannya. Ini mencakup struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, kebijakan, sasaran, strategi, dan kebijakan; kemampuan, nilai-nilai, budaya, dan standar organisasi; pemahaman tentang sumber daya dan pengetahuan informasi; dan proses membuat keputusan dan arus informasi. (Wibowo, A, 2022)

c) Kriteria risiko merupakan acuan yang menjadi dasar pada tahap penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko dan risiko prioritas.

Meskipun kriteria risiko harus ditetapkan pada awal proses penilaian risiko, mereka harus disesuaikan dengan kerangka kerja manajemen risiko dan disesuaikan dengan tujuan dan lingkup risiko. Namun, kriteria tetap dinamis dan harus terus ditinjau dan diubah jika diperlukan.

d. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara berulang, sistematis, dan berkolaborasi dengan menggunakan data terbaik yang tersedia.

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko, (SNI ISO 31000) adalah proses menemukan, mengenali, dan memberikan gambaran risiko. Ini dilakukan untuk menemukan sumber risiko, termasuk area dampak yang terkendali dan tidak terkendali. Identifikasi risiko mempertimbangkan data historis (kejadian yang mungkin terjadi di masa lalu), analisis teoretis, informasi, dan pendapat ahli, serta potensi peristiwa risiko di masa depan. Peristiwa atau keadaan yang dapat mengganggu, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi dikenal sebagai risiko. Semakin besar tingkat risiko negatif, semakin besar dampaknya pada pencapaian tujuan organisasi.

2) Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses menentukan besaran risiko dan tingkat atau level risiko dengan menggunakan kriteria risiko setelah mempertimbangkan keandalan penanganan yang sudah dilakukan di unit. Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, membantu dalam menentukan apakah risiko perlu ditangani dan bagaimana, serta memilih strategi dan metode penanganan risiko yang paling sesuai.

Cara lain untuk melihat aktivitas pengendalian kerugian adalah bahwa pencegahan kerugian adalah bagaimana mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan, meskipun hal itu juga akan berkaitan dengan pengurangan besarnya peristiwa yang memang terjadi.

Teknik untuk pencegahan kerugian akan bervariasi sesuai dengan jenis risiko bahaya yang sedang dipertimbangkan. Untuk risiko kesehatan dan

keselamatan, pencegahan kerugian terkait dengan menghilangkan aktivitas sepenuhnya. (Wibowo, A, 2022)

3) Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko perlu ditangani yang menjadi prioritas risiko. Prioritas risiko dilakukan untuk menentukan urutan tingkat kepentingan penanganan seluruh risiko yang telah diidentifikasi oleh unit. Urutan prioritas risiko menjadi acuan dalam fokus penanganan dan alokasi sumber daya untuk mengelola risiko. Risiko prioritas yang perlu penanganan kemudian dimasukkan dalam profil risiko. Proses evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan perlakuan risiko.

4) Perlakuan Risiko

Langkah selanjutnya adalah perlakuan risiko untuk menentukan pengendalian yang tepat untuk menekan dampak dan keterjadian risiko pada tingkat yang dapat diterima. Perlakuan risiko menurut SNI ISO 31000, merupakan proses mengubah risiko untuk mengurangi eksposur risiko.

5) Pemantauan dan Peninjauan

Pemantauan dan peninjauan dilakukan di setiap tahap proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa penerapan berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan untuk memberikan umpan balik untuk penyempurnaan proses.

a) Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa semua proses manajemen risiko berjalan dengan baik. Unit Pemilik Risiko melakukan pemantauan berkelanjutan (*ongoing monitoring*) atas perubahan lingkungan organisasi, variabel yang mempengaruhi risiko, dan strategi untuk mitigasi seluruh risiko. dan pemantauan berkala minimal setiap triwulan.

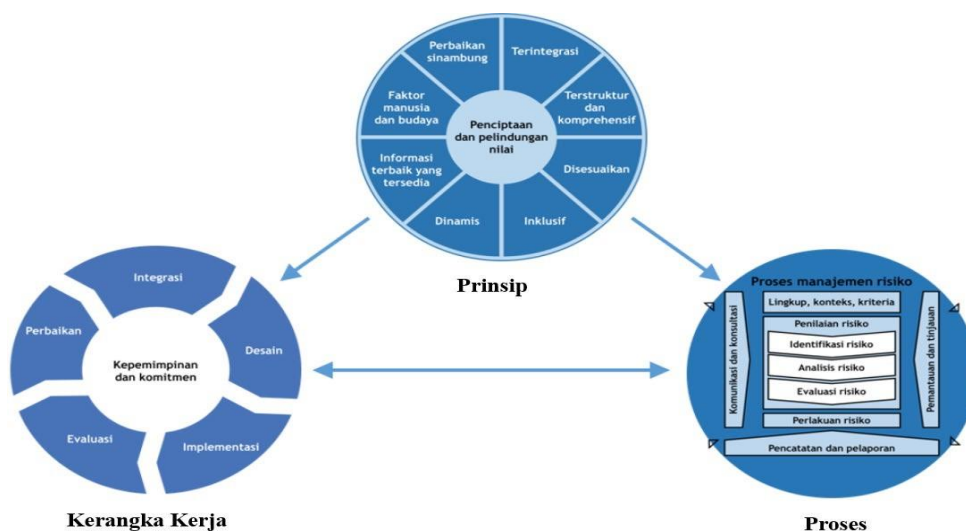
b) Peninjauan

Peninjauan terdiri atas: 1) Peninjauan terhadap penerapan dan efektivitas Kebijakan manajemen risiko dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan berhasil mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko yang dihadapi oleh organisasi serta memastikan bahwa

kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan atau masalah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2) Peninjauan terhadap kepatuhan Penerapan manajemen risiko yang akan membantu organisasi untuk terus meningkatkan strategi manajemen risiko.

6) Pencatatan dan Pelaporan

Pelaksanaan manajemen resiko harus tercatat dalam sistem pencatatan dan dilaporkan secara berkala. Pencatatan dan pelaporan sangat penting sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko. 1)Pencatatan Manajemen Risiko melalui *Risk Register* / Daftar risiko dan Profil risiko menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola risiko. 2)Pelaporan Manajemen Risiko, meliputi a) Laporan profil risiko, yang merupakan kumpulan risiko prioritas; b). Laporan penerapan proses manajemen risiko, yang mencakup informasi tentang realisasi program manajemen risiko. c) Laporan pemantauan dan peninjauan proses manajemen risiko adalah hasil dari pemantauan manajemen risiko. Untuk lebih jelas, disajikan pada gambar 2.3.



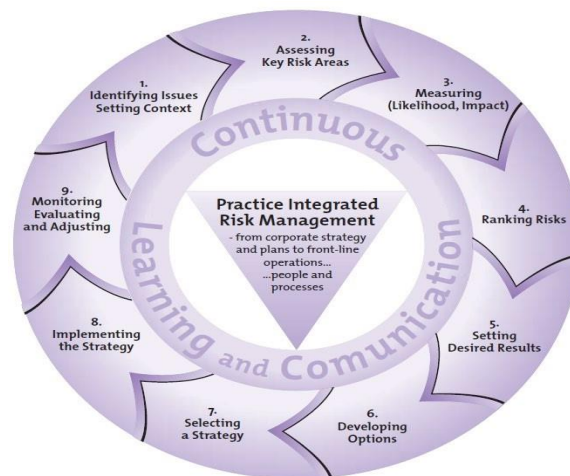
Gambar 2.3

Manajemen risiko ISO 31000:2018

Sumber: Hutchins, G. (2018).

16. Integrated Risk Management Framework (Canada)

Framework for Risk Management – Canada, yang menggantikan *Integrated Risk Management Framework* (2001) dan *Integrated Implementation Management Guide*, juga diterbitkan pada tahun 2010. Kerangka ini merupakan alat yang dirancang khusus untuk entitas publik, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengenali, menganalisis, merespons, dan mengoptimalkan tantangan serta peluang baru dalam sektor yang dikenal dengan sifatnya yang proaktif dan kompleks. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memberikan panduan dalam menerapkan prosedur manajemen risiko yang efektif di semua tingkatan organisasi. Hal ini akan membantu dalam penetapan prioritas strategis, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan terkait toleransi risiko, serta peningkatan hasil organisasi. Kerangka ini juga memberikan pedoman dan saran tentang bagaimana pemimpin dapat memahami peran mereka dalam manajemen risiko serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam organisasi mereka (Hill & Dinsdale, 2001).



Gambar 2.4

Proses manajemen risiko dalam Kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi
Sumber: Hill & Dinsdale, (2001).

a. Mengidentifikasi Masalah dan Menentukan Konteks

Langkah pertama ini mengenali dan mengakui risiko yang relevan, termasuk memahami konteks eksternal dan internal organisasi. Hal ini mencakup: Pemindaian lingkungan untuk risiko yang sedang atau akan muncul, menentukan siapa yang terkena dampak dan apa yang dipertaruhkan dan mengklasifikasi risiko: kesehatan, lingkungan, keuangan, reputasi dan teknologi.

b. Menilai Bidang Risiko Utama

Dengan dua pendekatan untuk menilai risiko yaitu Karakterisasi Risiko Empiris yaitu menggunakan data historis dan pemodelan untuk menentukan probabilitas dan dampak risiko dan Karakterisasi Risiko Intuitif yaitu memahami persepsi publik dan sosial tentang risiko, yang mungkin berbeda dengan pandangan teknis.

c. Menetapkan Tujuan

Penetapan tujuan manajemen risiko harus berasal dari hasil penilaian risiko. Tujuan ini menjadi dasar strategi, tolok ukur evaluasi, dan panduan pengambilan keputusan. Tujuan harus realistis, fleksibel, dan selaras dengan mandat hukum dan nilai organisasi.

d. Mengembangkan Opsi

Menyusun berbagai pendekatan atau instrumen untuk menangani risiko, dari yang paling koersif (regulasi) hingga yang paling sukarela (edukasi dan informasi). Pilihan ini harus mempertimbangkan tingkat kehati-hatian yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian tinggi.

e. Menentukan Tingkat Kehati-hatian yang Memadai

Dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah atau risiko dengan dampak besar, pendekatan kehati-hatian harus diambil. Ini melibatkan dialog dengan publik dan pemangku kepentingan untuk menentukan standar perlindungan yang dapat diterima.

f. Menerapkan Strategi Manajemen Risiko

Implementasi strategi memerlukan struktur organisasi yang mendukung, kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas, serta kompetensi SDM. Perlu ada dokumentasi proses, pelatihan, dan komunikasi internal yang efektif.

g. Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan

Membangun sistem indikator untuk mengevaluasi baik hasil (apakah tujuan tercapai) maupun proses (apakah prosedur berjalan dengan benar). Evaluasi ini bisa berbentuk audit mandiri, evaluasi eksternal, atau sistem pelaporan berkala.

h. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Pembelajaran

Umpan balik dari evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Penting membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap kritik, kesalahan, dan perubahan. Pembelajaran tidak hanya bertahap, tapi juga mendalam bertanya "mengapa", bukan hanya "bagaimana".

i. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko harus bersifat dua arah dan transparan, melibatkan pemangku kepentingan sejak awal. Ini termasuk menjelaskan alasan di balik keputusan, menyampaikan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami publik, serta membangun kepercayaan melalui keterbukaan, integritas, dan empati. Untuk memperjelas kerangka kerja ERM disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perbandingan Kerangka Kerja ERM

ISO 31000 (2009/2018)	ERM COSO 2017	Kerangka Manajemen Risiko – Kanada (Hill & Dinsdale, 2001).
Prinsip dan pedoman	Informasi, komunikasi, dan pelaporan peran	Prinsip dan pedoman
Kinerja risiko berkelanjutan, identifikasi, penilaian, dan perlakuan	Pengendalian risiko dan integrasi dalam strategi organisasi	Manajemen risiko yang efektif
Manajemen risiko interaktif	Peran utama manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategi	Praktik manajemen risiko yang efektif
Tidak ada standarisasi dalam manajemen risiko	Tata kelola dan budaya organisasi	Untuk organisasi publik

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 2.6, perbandingan setiap kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapannya. ISO 31000 (2009/2018) menekankan prinsip dan pedoman untuk meningkatkan kinerja risiko secara berkelanjutan, termasuk identifikasi, penilaian, dan perlakuan risiko, serta menggunakan pendekatan manajemen risiko yang interaktif. Namun, standar ini tidak mengatur standarisasi dalam manajemen risiko, sehingga organisasi memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan spesifik. Pedoman ISO 31000 menyatakan bahwa standar tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan manajemen risiko di berbagai organisasi. Sebaliknya, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, konteks, struktur, operasi, proses, fungsi, proyek, produk, layanan, aset, serta praktik spesifik yang mereka gunakan. Sementara itu, kerangka kerja COSO sering dianggap sebagai kerangka konseptual yang sangat abstrak. COSO 2004 lebih berfokus pada informasi dan komunikasi, dengan cakupan utama pada strategi risiko, identifikasi, pemantauan, dan kontrol

dalam lingkungan internal organisasi. Sementara itu, COSO 2017 merupakan pembaruan dari versi sebelumnya yang menambahkan unsur pengendalian risiko dan integrasi dengan strategi organisasi, serta menekankan peran manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, *Canadian Framework for Risk Management* dirancang secara khusus untuk organisasi publik, dengan pendekatan praktik manajemen risiko yang efektif.

17. *Deliberative Policy dan Collaborative Governance* sebagai Mekanisme Integrasi ERM dengan Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan tata kelola sektor publik menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi publik modern tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan birokratis yang bersifat hierarkis dan sektoral, melainkan memerlukan mekanisme kolaboratif, partisipatif, dan deliberatif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks rumah sakit publik, kompleksitas pelayanan kesehatan, tingginya risiko organisasi, serta keberagaman kepentingan pemangku kepentingan menyebabkan implementasi Enterprise Risk Management (ERM) tidak dapat dilakukan semata sebagai instrumen teknokratis pengendalian risiko, tetapi harus dipahami sebagai proses tata kelola publik yang melibatkan negosiasi nilai, kepentingan, dan tujuan organisasi.

Pendekatan *deliberative policy* berakar pada teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas dan John Dryzek. Habermas (1996) menjelaskan bahwa legitimasi kebijakan publik dibangun melalui proses komunikasi rasional (*communicative rationality*) dan diskursus publik yang memungkinkan berbagai aktor menyampaikan argumentasi secara setara. Dalam perspektif ini, kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai hasil proses deliberasi kolektif yang mempertimbangkan kepentingan publik secara lebih luas. Dryzek (2000) menambahkan bahwa pendekatan deliberatif memungkinkan terjadinya negosiasi nilai dalam situasi kebijakan yang kompleks dan multidimensional, terutama ketika terdapat konflik antara efisiensi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan kepentingan publik.

Dalam konteks ERM rumah sakit publik, pendekatan deliberatif menjadi relevan karena implementasi manajemen risiko melibatkan berbagai kepentingan yang sering kali bersifat kontradiktif. Paradigma Old Public Administration (OPA) menekankan kepatuhan birokratis, kontrol administratif, dan akuntabilitas prosedural;

New Public Management (NPM) berorientasi pada efisiensi, pengukuran kinerja, dan produktivitas; sedangkan New Public Service (NPS) menekankan nilai publik, partisipasi masyarakat, dan keselamatan pasien. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam penentuan *risk appetite*, prioritas risiko, maupun pengambilan keputusan strategis rumah sakit. Oleh karena itu, pendekatan deliberatif diperlukan sebagai mekanisme untuk menyelaraskan perbedaan nilai melalui proses dialog, negosiasi, dan pencapaian konsensus antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, konsep *collaborative governance* berkembang sebagai pendekatan tata kelola publik yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor privat, tenaga profesional, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola dimana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang formal, deliberatif, dan berbasis konsensus. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan birokrasi tradisional dan kegagalan pendekatan manajerial yang terlalu berorientasi pasar dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks.

Dalam perspektif administrasi publik, *collaborative governance* berfungsi sebagai wadah integrasi berbagai paradigma administrasi publik. Nilai-nilai OPA tetap dipertahankan melalui mekanisme akuntabilitas dan regulasi birokratis; prinsip-prinsip NPM masuk melalui tuntutan efisiensi, pengukuran kinerja, dan efektivitas organisasi; sedangkan NPS diakomodasi melalui partisipasi publik, orientasi pelayanan, dan penciptaan *public value*. Dengan demikian, ketiga paradigma tidak diposisikan sebagai pendekatan yang saling meniadakan, tetapi dinegosiasikan melalui forum kolaboratif untuk menghasilkan tata kelola risiko yang lebih adaptif dan legitimate.

18. ERM dalam Perspektif *Public Enterprise*, Integrasi Nilai Ekonomi dan Nilai Pelayanan

Dalam konteks administrasi publik, penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen pengendalian risiko operasional, tetapi harus diposisikan sebagai mekanisme strategis untuk menciptakan *public value* melalui integrasi nilai ekonomi dan nilai pelayanan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *Public Service Value Model* yang mengadaptasi prinsip *shareholder value* sektor privat ke sektor publik dengan menempatkan warga sebagai

pemangku kepentingan utama. Model tersebut menegaskan bahwa organisasi publik menciptakan nilai ketika mampu menghasilkan *outcomes* sosial dan ekonomi yang selaras dengan prioritas masyarakat secara *cost-effective*.

Lebih lanjut, pendekatan ini menekankan dua pengungkit utama nilai publik, yaitu *outcomes* dan *cost-effectiveness*, di mana peningkatan salah satu tanpa mempertimbangkan yang lain akan menghasilkan *trade-off* yang berpotensi menurunkan nilai publik secara keseluruhan. Peningkatan salah satu tanpa diimbangi yang lain akan menghasilkan *trade-off* dalam penciptaan nilai, sedangkan peningkatan keduanya secara simultan mencerminkan kinerja organisasi publik yang tinggi.

Model ini memiliki dua sumbu utama:

- a. *Outcomes* yaitu hasil sosial yang dicapai, misalnya keselamatan pasien dan mutu layanan.
- b. *Cost-effectiveness* yaitu efisiensi penggunaan anggaran

Situasi *trade-off* terjadi misalnya ketika:

- a. *Outcome* naik tetapi biaya menjadi kurang efisien → pelayanan meningkat tetapi biaya lebih besar.
- b. Efisiensi biaya meningkat tetapi *outcomes* menurun → penghematan anggaran tetapi kualitas layanan turun.

Kedua kondisi tersebut menunjukkan organisasi sedang menukar satu nilai dengan nilai lain untuk mempertahankan atau mengoptimalkan nilai publik. Perspektif ini menegaskan bahwa organisasi publik pada hakikatnya merupakan *public enterprise* tetap berorientasi pada kepentingan publik namun dikelola dengan disiplin strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan. (Cole, M., & Parston, G. 2006)

Public Service Value Matrix merupakan kerangka analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi sektor publik menciptakan nilai bagi masyarakat melalui keseimbangan antara pencapaian hasil pelayanan (*outcomes*) dan efisiensi penggunaan sumber daya (*cost-effectiveness*). Matriks ini menempatkan kinerja organisasi publik dalam dua dimensi utama yang saling berinteraksi, yaitu tingkat pencapaian hasil sosial yang dihasilkan oleh organisasi dan tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut.

Dimensi pertama adalah sumbu vertikal (*outcomes*) yang menggambarkan tingkat pencapaian manfaat atau dampak sosial yang dihasilkan oleh organisasi. Dalam sektor pelayanan kesehatan, *outcomes* dapat tercermin melalui berbagai

indikator seperti peningkatan keselamatan pasien, penurunan angka mortalitas, peningkatan kualitas pelayanan klinis, serta meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Semakin tinggi posisi organisasi pada sumbu vertikal ini, semakin baik pula outcomes yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dimensi kedua adalah sumbu horizontal (*cost-effectiveness*) yang menunjukkan tingkat efisiensi organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan outcomes tersebut. Dalam konteks rumah sakit, efisiensi ini dapat diukur melalui berbagai indikator seperti biaya pelayanan per pasien, efisiensi operasional rumah sakit, serta produktivitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Semakin ke arah kanan posisi organisasi pada sumbu ini, semakin efisien organisasi tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan kombinasi kedua dimensi tersebut, *Public Service Value Matrix* membagi kinerja organisasi publik ke dalam empat kuadran utama yang menggambarkan tingkat penciptaan nilai publik.

Kuadran pertama adalah kuadran kanan atas, yang menggambarkan kondisi *high performance* atau *value creation*. Pada kuadran ini organisasi mampu meningkatkan outcomes sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Kondisi ini merupakan situasi ideal bagi organisasi publik karena mampu menghasilkan manfaat yang tinggi bagi masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam konteks rumah sakit, kondisi ini dapat tercermin melalui penurunan angka infeksi rumah sakit, peningkatan kualitas pelayanan klinis, serta efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional.

Kuadran kedua adalah kuadran kiri atas, yang menggambarkan kondisi peningkatan outcomes namun dengan efisiensi biaya yang rendah. Pada kondisi ini organisasi berhasil meningkatkan kualitas pelayanan atau hasil layanan, tetapi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mencapainya. Contohnya adalah ketika rumah sakit melakukan investasi besar dalam teknologi medis atau meningkatkan standar keselamatan pasien yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan, namun juga meningkatkan biaya pelayanan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya *trade-off* antara peningkatan outcomes dan efisiensi biaya.

Kuadran ketiga adalah kuadran kanan bawah, yang menggambarkan kondisi peningkatan efisiensi namun disertai dengan penurunan outcomes. Pada kondisi ini organisasi berhasil menekan biaya operasional atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi kualitas pelayanan atau hasil layanan justru menurun.

Dalam konteks rumah sakit, kondisi ini dapat terjadi ketika organisasi melakukan pengurangan tenaga kesehatan atau pembatasan layanan demi efisiensi anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada pasien.

Kuadran keempat adalah kuadran kiri bawah, yang menggambarkan kondisi *value destruction* atau kinerja organisasi yang rendah. Pada kondisi ini organisasi mengalami penurunan outcomes sekaligus penurunan efisiensi biaya. Hal ini berarti organisasi tidak hanya gagal menghasilkan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga tidak mampu mengelola sumber daya secara efektif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kondisi ini dapat terlihat ketika kualitas pelayanan rumah sakit menurun, biaya pelayanan tetap tinggi, dan kinerja organisasi secara keseluruhan mengalami penurunan.

Salah satu konsep penting dalam *Public Service Value Matrix* adalah *trade-off*, yaitu kondisi ketika organisasi harus meningkatkan salah satu dimensi dengan mengorbankan dimensi lainnya. Dalam praktik organisasi publik, keterbatasan sumber daya seringkali memaksa manajemen untuk memilih antara peningkatan kualitas layanan atau peningkatan efisiensi biaya. *Trade-off* pertama terjadi ketika organisasi meningkatkan outcomes namun efisiensi biaya menurun. Hal ini sering terjadi ketika organisasi melakukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti pengadaan teknologi medis baru atau peningkatan standar keselamatan pasien.

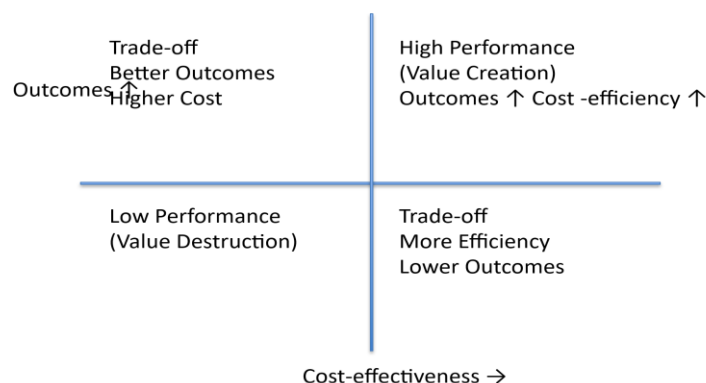
Sebaliknya, *trade-off* kedua terjadi ketika organisasi meningkatkan efisiensi biaya tetapi *outcomes* justru menurun. Kondisi ini biasanya terjadi ketika organisasi berfokus pada penghematan biaya melalui pengurangan staf, pembatasan layanan, atau efisiensi operasional yang berlebihan sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan.

Dalam konteks ERM di rumah sakit, konsep *trade-off* ini menjadi sangat penting karena manajemen rumah sakit harus mampu menyeimbangkan berbagai tujuan organisasi yang seringkali saling berkonflik, seperti keselamatan pasien, kualitas pelayanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan organisasi. Berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan rumah sakit seringkali mengandung risiko *trade-off*, misalnya keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kesehatan demi efisiensi anggaran yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien, atau keputusan untuk berinvestasi pada teknologi medis canggih yang dapat meningkatkan *outcomes* tetapi memerlukan biaya yang tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pendekatan *Enterprise Risk Management* berperan penting dalam membantu organisasi mengidentifikasi risiko dari setiap keputusan strategis, mengevaluasi potensi *trade-off* yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengarah pada penciptaan nilai publik. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko organisasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menyeimbangkan kualitas pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan organisasi.

Secara keseluruhan, *Public Service Value Matrix* menunjukkan bahwa organisasi publik seringkali menghadapi pilihan antara peningkatan *outcomes* atau peningkatan efisiensi biaya akibat keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, manajemen organisasi yang efektif adalah manajemen yang mampu mengelola berbagai *trade-off* tersebut secara strategis sehingga organisasi dapat bergerak menuju kuadran *high performance*, yaitu kondisi di mana organisasi mampu menciptakan nilai publik yang optimal bagi masyarakat.

Trade-off in Public Service Value Matrix



Gambar 2.5
Diagram matrix 4 kuadran
Sumbu Outcomes (↑) dan Cost-effectiveness (→)

Trade-off dalam Diagram *Public Service Value katalisatorMatrix* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- High Performance (Value Creation)*
- Trade-off: Better Outcomes – Higher Cost*
- Trade-off: More Efficiency – Lower Outcomes*

d. *Low Performance (Value Destruction)*

Secara konseptual, pendekatan tersebut merefleksikan transformasi paradigma administrasi publik dari model birokratik menuju *public enterprise*, yaitu organisasi publik yang tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat namun mengadopsi logika kinerja sektor privat. Bahkan, penerapan konsep *shareholder value* pada sektor publik dengan warga sebagai substitusi pemegang saham memberikan kerangka baru bagi organisasi publik untuk menyeimbangkan hasil sosial dan efisiensi biaya, sekaligus menjaga *citizen concerns* sebagai pusat pengambilan keputusan. (Cole, M., & Parston, G. 2006)

Kompleksitas tuntutan tersebut menempatkan risiko sebagai faktor strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Risiko tidak lagi dipahami sekadar sebagai potensi kerugian operasional, tetapi sebagai ancaman terhadap kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai publik. Oleh karena itu, ERM menjadi krusial sebagai pendekatan terintegrasi yang memungkinkan organisasi menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pencapaian outcome pelayanan secara berkelanjutan.

Tekanan untuk “melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit” menciptakan fenomena *value squeeze*, yaitu kondisi ketika organisasi publik dituntut meningkatkan *outcomes* sambil memastikan penggunaan anggaran tetap efisien. Cole, M., & Parston, G. 2006)

Kondisi ini menuntut organisasi kesehatan publik untuk tidak hanya berfokus pada keselamatan pasien dan mutu layanan, tetapi juga pada keberlanjutan fiskal sebagai prasyarat stabilitas layanan jangka panjang. Dari perspektif *public choice*, aktor sektor publik memiliki motivasi yang tidak sepenuhnya berbeda dari aktor sektor privat, di mana *self-interest* menjadi stimulus perilaku yang signifikan. (Shughart, W. F., II, & Razzolini, L, 2001)

Selain itu, organisasi privat memiliki insentif kuat untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan melayani pelanggan dengan baik karena adanya sinyal harga dan keuntungan. (Shughart, W. F., II, & Razzolini, L, 2001)

Implikasinya bagi organisasi publik adalah pentingnya membangun mekanisme tata kelola yang mampu menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan publik, karena tanpa desain institusional yang tepat, intervensi sektor publik justru berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak *cost-effective* dan bahkan menurunkan kesejahteraan sosial. (Shughart, W. F., II, & Razzolini, L, 2001)

Meskipun berbagai organisasi publik telah mengadopsi praktik manajemen risiko, implementasinya masih cenderung berorientasi pada kepatuhan dan pengendalian internal, belum sepenuhnya dikaitkan dengan strategi penciptaan nilai publik. Di sisi lain, banyak organisasi publik masih menitikberatkan pengukuran pada output dibandingkan *outcome*, sehingga hubungan antara pengelolaan risiko dan peningkatan kinerja publik belum menjelaskan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model ERM yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mendukung penciptaan *public value*.

Dengan demikian, masa depan organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik mereka melayani, tetapi juga oleh seberapa cerdas mereka mengelola risiko untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut tetap bernilai dan berkelanjutan. Integrasi nilai *enterprise* dalam sektor publik bukan berarti mengkomersialisasi pelayanan, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan strategis mempertimbangkan konsekuensi ekonomi sekaligus manfaat sosial. Tanpa disiplin *enterprise*, pelayanan publik berisiko tidak berkelanjutan; namun tanpa orientasi pelayanan, organisasi kehilangan legitimasi publik. Oleh karena itu, integrasi ERM dalam kerangka *public value* menjadi kebutuhan strategis dalam administrasi publik kontemporer.

19. Risk Appetite dalam Perspektif Public Value dan Resilience Organisasi

Kerangka COSO ERM 2017 mendefinisikan *risk appetite* sebagai tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi dalam upaya mencapai nilai dan tujuan strategisnya. Oleh karena itu *risk appetite* merupakan elemen kunci dalam integrasi antara strategi dan kinerja organisasi, yang mencerminkan keseimbangan antara pencapaian tujuan dan pengelolaan risiko (COSO, 2017). Dengan demikian, *risk appetite* berfungsi sebagai panduan strategis dalam pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh level organisasi.

Organisasi sektor publik termasuk rumah sakit tidak dapat menetapkan satu ambang risiko yang tetap, tetapi memerlukan rentang toleransi yang adaptif terhadap periode perencanaan, karakteristik unit layanan, serta variasi kategori risiko seperti strategis, finansial, operasional, klinis, dan kepatuhan (Frigo & Anderson, 2011; Moeller, 2011).

Pendekatan dinamis tersebut sejalan dengan prinsip ISO 31000:2018 yang menegaskan bahwa proses manajemen risiko harus mempertimbangkan perubahan konteks internal dan eksternal secara berkelanjutan. Dalam konteks rumah sakit, hal ini berarti *risk appetite* dapat bergeser menjadi lebih konservatif pada saat terjadi krisis likuiditas atau peningkatan insiden keselamatan pasien, namun dapat menjadi lebih moderat ketika kapasitas organisasi, cadangan keuangan, serta kinerja mutu berada dalam kondisi stabil. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai dan penciptaan peluang strategis.

Dalam praktiknya, *risk appetite* umumnya diklasifikasikan ke dalam spektrum kualitatif yang mencerminkan sikap organisasi terhadap risiko, yaitu rendah (*risk averse/conservative*), sedang (*moderate/balanced*), dan tinggi (*risk seeking/aggressive*). Klasifikasi ini menggambarkan variasi preferensi organisasi terhadap ketidakpastian dan tingkat toleransi terhadap deviasi. Organisasi dengan *risk appetite* rendah cenderung berorientasi pada stabilitas, kepatuhan, dan keselamatan, dengan toleransi yang sangat terbatas terhadap risiko. Sebaliknya, *risk appetite* sedang mencerminkan pendekatan yang lebih seimbang antara pengendalian risiko dan pencapaian kinerja, sedangkan *risk appetite* tinggi menunjukkan kesiapan organisasi untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam rangka inovasi dan penciptaan nilai (Hillson & Murray-Webster, 2017).

Namun demikian, dalam sektor kesehatan, pendekatan terhadap *risk appetite* memiliki karakteristik yang lebih konservatif. WHO melalui *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* menegaskan bahwa keselamatan pasien harus diarahkan pada eliminasi *avoidable harm* dan pengurangan risiko hingga tingkat minimum yang dapat diterima (*acceptable minimum risk*) (WHO, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, toleransi terhadap risiko yang berdampak pada keselamatan pasien sangat terbatas, sehingga *risk appetite* cenderung berada pada spektrum rendah untuk domain klinis.

Lebih lanjut, WHO juga menegaskan bahwa *risk appetite* harus diterjemahkan ke dalam batasan operasional dan indikator yang terukur sebagai bagian dari sistem manajemen risiko organisasi (WHO, 2025). Oleh karena itu, dalam praktik organisasi pelayanan kesehatan, *risk appetite* perlu dioperasionalisasikan melalui indikator kinerja seperti angka kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian sentinel, kepatuhan terhadap *clinical pathway*, serta waktu respons kegawatdaruratan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa *risk appetite* harus dikaitkan dengan *risk criteria* dan

key risk indicators untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan risiko.

Kerangka *risk appetite* yang dikembangkan oleh WHO dalam dokumen *WHO Risk Appetite Statemen (2025)*, memberikan landasan konseptual yang sistematis dalam memahami tingkat penerimaan risiko (*risk acceptability*) dalam organisasi publik global. Dalam dokumen tersebut, WHO mengklasifikasikan tingkat penerimaan risiko ke dalam beberapa kategori utama, yaitu *averse*, *minimal*, *cautious*, dan *open*, yang merepresentasikan spektrum sikap organisasi terhadap risiko, mulai dari sangat konservatif hingga relatif terbuka terhadap risiko dalam rangka mencapai dampak strategis (WHO, 2025).

Pada tingkat *averse* dan *minimal*, risiko pada dasarnya tidak dapat diterima tanpa adanya upaya mitigasi yang segera dan komprehensif. WHO menekankan bahwa pada level ini, risiko harus dikurangi hingga mencapai prinsip *as low as reasonably practicable* (ALARP), dengan prioritas utama pada pengendalian faktor internal serta penguatan mekanisme pencegahan, deteksi, dan perencanaan kontinjensi terhadap faktor eksternal. Bahkan, apabila tingkat risiko residual tidak dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima, organisasi disarankan untuk mempertimbangkan penghentian atau pembatasan aktivitas yang berisiko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada spektrum ini, orientasi organisasi sangat kuat pada perlindungan nilai dan penghindaran risiko (*risk avoidance*), yang sejalan dengan karakteristik *low risk appetite* dalam kerangka ERM (WHO, 2025).

Sebaliknya, pada tingkat *cautious*, WHO mulai membuka ruang bagi penerimaan risiko secara terbatas dalam rangka mencapai dampak atau manfaat tertentu. Risiko dapat diterima sepanjang telah dikendalikan hingga mencapai tingkat moderat dalam jangka waktu yang wajar, serta dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara risiko dan manfaat (*risk–benefit balance*). Pendekatan ini mencerminkan karakteristik *moderate risk appetite*, di mana organisasi tidak sepenuhnya menghindari risiko, tetapi mengelolanya secara adaptif dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan strategis (WHO, 2025).

Sementara itu, pada tingkat *open*, WHO mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, organisasi dapat menerima risiko dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi, termasuk risiko yang bersifat signifikan hingga berat (*severe risk*), terutama dalam konteks pencapaian dampak strategis yang besar. Dalam situasi ini, risiko bahkan dapat dibiarkan tidak sepenuhnya dimitigasi dalam jangka pendek untuk

memungkinkan organisasi memanfaatkan peluang yang ada, dengan tetap mensyaratkan adanya mekanisme pemantauan berkala dan respons adaptif terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik *high risk appetite*, yang lebih berorientasi pada inovasi dan penciptaan nilai, meskipun dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi (WHO, 2025).

Lebih lanjut, WHO mengaitkan kerangka *risk acceptance scale* ini dengan domain risiko strategis organisasi yang mencakup aspek strategis, operasional, programatik, integritas, serta sumber daya manusia. Setiap domain memiliki karakteristik risiko yang berbeda dan memerlukan pendekatan *risk appetite* yang kontekstual. Misalnya, dalam domain keselamatan pasien (*patient safety*) dan integritas, organisasi cenderung menerapkan *risk appetite* yang rendah (*averse/minimal*), sedangkan dalam domain inovasi program atau transformasi sistem kesehatan, pendekatan yang lebih *cautious* atau bahkan *open* dapat diterapkan secara selektif (WHO, 2025).

Dengan demikian, kerangka WHO ini menegaskan bahwa *risk appetite* bukanlah konsep yang bersifat statis atau seragam, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual, tergantung pada jenis risiko, dampak yang diharapkan, serta kapasitas organisasi dalam mengelola risiko tersebut. Dalam konteks rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik, pendekatan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam mengelola paradoks antara keselamatan pasien, mutu layanan, efisiensi, dan inovasi. Oleh karena itu, adaptasi kerangka *risk acceptance scale* WHO ke dalam indikator operasional seperti kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian sentinel, kepatuhan klinis, dan respons kegawatdaruratan merupakan langkah strategis untuk menerjemahkan konsep abstrak *risk appetite* ke dalam praktik manajemen risiko yang terukur dan aplikatif.

Meskipun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa tidak terdapat batas numerik universal yang ditetapkan secara global untuk mengklasifikasikan *risk appetite* ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi tersebut merupakan bentuk operasionalisasi konseptual yang dikembangkan berdasarkan konteks organisasi, kapasitas risiko (*risk capacity*), serta karakteristik risiko yang dihadapi. Dengan demikian, penggunaan indikator kuantitatif untuk menentukan tingkat *risk appetite* dalam penelitian ini diposisikan sebagai konstruksi analitik yang bertujuan untuk menjembatani konsep ERM dengan praktik keselamatan pasien di rumah sakit.

Tabel 2.7
Definisi dan Skala Risiko yang dapat diterima (*Risk Appetite*)

Level	Definisi Risiko yang dapat di terima	Tingkat Risiko yang dapat diterima
Averse (Sangat Menghindari Risiko)	1) Tingkat risiko yang signifikan tidak dapat diterima dan mitigasi harus segera dikembangkan serta diimplementasikan untuk menurunkan risiko residual hingga serendah mungkin (<i>As Low As Reasonably Practicable / ALARP</i>), dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. 2) Paparan terhadap faktor internal harus segera dikurangi. Jika faktor eksternal tidak dapat dikendalikan, maka harus diterapkan langkah pencegahan, deteksi, dan perencanaan kontinjensi yang kuat. 3) Jika risiko residual tidak dapat diturunkan secara realistis, maka perlu dipertimbangkan penghentian atau pengurangan aktivitas terkait.	Sedang, Rendah
Minimal (Sangat Rendah)	• Tingkat risiko yang signifikan tidak dapat diterima, namun mitigasi dapat dilakukan secepat mungkin untuk menurunkan risiko hingga tingkat ALARP, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. • Paparan terhadap faktor internal harus dikurangi sesegera mungkin, dan sumber daya harus dialokasikan untuk mencapai hal tersebut. 4) Jika faktor eksternal tidak dapat dikendalikan, maka diperlukan langkah pencegahan, deteksi, dan kontinjensi yang kuat.	Sedang, Rendah
Cautious (Hati-hati / Moderat)	• Tingkat risiko yang signifikan dapat diterima secara terbatas untuk mencapai dampak tertentu, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Paparan risiko harus diturunkan setidaknya ke tingkat moderat dalam jangka waktu yang wajar. • Risiko harus dipantau secara berkala untuk memastikan perubahan kondisi terdeteksi dan peluang mitigasi dapat dilakukan guna menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat.	Tinggi, Sedang, Rendah
Open (Terbuka terhadap Risiko)	• Tingkat risiko yang berat dapat diterima dalam rangka mencapai dampak strategis, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Paparan terhadap faktor internal dapat tetap tidak dimitigasi sementara waktu	Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah

Level	Definisi Risiko yang dapat di terima	Tingkat Risiko yang dapat diterima
	jika diperlukan untuk memanfaatkan peluang. Risiko harus dipantau secara berkala untuk memastikan perubahan kondisi terdeteksi dan dampak yang tidak diinginkan dapat ditangani dengan tepat.	

Sumber: WHO 2025

Tabel 2.8
Risk Appetite mapped over the Risk Taxonomy

1. Strategic	2. Operational	3. Programmatic	4. Integrity	5. Workforce/Human C.
1.1 Strategy setting and execution 1.1.1 GPW design and preparation 1.1.2 WHO governance structures and accountability 1.1.3 Change Management Programmes and Culture 1.1.4 Mission and vision 1.2 Stakeholder engagement and partnerships 1.2.1 Communication with stakeholders and partners 1.2.2 Alignment with stakeholders and partners 1.2.3 Leadership in health 1.3 Communication and visibility 1.3.1 Media relations and infodemics 1.3.2 Communication strategy 1.3.3 Crisis and Risk communication 1.4 Resource mobilization 1.4.1 Sustainable Financing 1.4.2 Donor relationship management 1.4.3 Predictability of funding 1.4.4 Flexibility of funding 1.5 Programme context 1.5.1 Political landscape 1.5.2 Health sector capacity, incl. workforce and systems 1.5.3 National health financing and governance 1.5.4 Community engagement and acceptance	2.1 Financial management 2.1.1 Payroll, compensation and benefits 2.1.2 Assets and investments 2.1.3 Treasury, liquidity and currencies 2.1.4 Accounting and financial reporting 2.1.5 Taxation and customs 2.2 IT and communications 2.2.1 Systems and IT infrastructure 2.2.2 Operations and user support 2.2.3 Cyber security 2.2.4 Data Management 2.3 Procurement and supply chain 2.3.1 Strategic sourcing and Specifications 2.3.2 Supply planning, availability and forecasting 2.3.3 Supplier selection and contracting 2.3.4 Storage and logistics 2.4 Continuity of operations 2.4.1 Crisis management and coordination 2.4.2 Security 2.4.3 Crisis Communications 2.4.4 IT Disaster Recovery 2.4.5 Business Continuity 2.4.6 Support to Staff /Survivors/ Families	3.1 Technical expertise 3.1.1 Quality assurance 3.1.2 Prioritization of programmatic activities 3.1.3 Health ethics and equity (incl. GER) 3.1.4 Patient safety 3.1.5 Health information and data 3.2 Partners and vendors 3.2.1 Partner capacity, capability due diligence 3.2.2 Vendor capacity, capability and due diligence 3.2.3 Performance monitoring of partners 3.3 Programme management 3.3.1 Programme design 3.3.2 Programme planning and governance 3.3.3 Programme budgeting 3.3.4 Programme delivery 3.4 Programme monitoring, evaluation and assurance 3.4.1 Programmatic data 3.4.2 Data collection 3.4.3 Risk and assumptions 3.4.4 Third party monitoring 3.4.5 Reporting and escalation 3.4.6 Sustainability and scale-up 3.5 Environmental and social impact 3.5.1 Environment and Biodiversity 3.5.2 Health and Safety Hazards 3.5.3 Communities and Cultural Heritage	4.1 Breach of obligations 4.1.1 Policies and standards (FENSA, code of Ethics, etc.) 4.1.2 Regulations or laws 4.1.3 Third party contracts 4.1.4 Donor agreement 4.2 Fraud and corruption 4.2.1 Fraudulent practices 4.2.2 Corrupt /collusive practices 4.2.3 Money Laundering 4.2.4 Financing terrorism 4.2.5 Theft or misappropriation 4.2.6 Coercive/obstructive practice 4.3 Safeguarding and conduct 4.3.1 Abusive conduct 4.3.2 Sexual misconduct	5.1 Occupational health and safety 5.1.1 Staff well-being 5.1.2 Safety of Staff 5.2 Staff development 5.2.1 Skills development, including training and coaching 5.2.2 Staff performance management 5.2.3 Succession planning 5.3 Human resources management 5.3.1 Recruitment 5.3.2 Availability of appropriate skillsets 5.3.3 Supervision and mentoring 5.3.4 Diversity, equity and inclusion 5.3.5 Staff retention

Risk acceptability : Minimal (Target risk levels: moderate or low)
Risk acceptability : Cautious (Target risk levels: significant, moderate or low)
Risk acceptability : Open (Target risk levels: severe, significant, moderate or low)

Sumber: WHO 2025

Risk appetite dalam kerangka ERM berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam menciptakan nilai publik (*public value*) dan memperkuat ketahanan organisasi (*organizational resilience*) di tengah kompleksitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks sektor publik, khususnya rumah sakit, pengelolaan risiko tidak dapat

dilepaskan dari tuntutan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan, sebagaimana dikemukakan dalam teori *public value* yang menekankan bahwa organisasi publik harus mampu menciptakan nilai yang diakui oleh masyarakat melalui kinerja yang efektif dan legitimasi sosial (Moore, 1995).

Dalam perspektif ini, *risk appetite* menjadi instrumen penting untuk menentukan sejauh mana organisasi bersedia mengambil atau menghindari risiko dalam rangka menciptakan nilai publik tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka WHO yang menekankan bahwa sistem kesehatan harus mampu menyeimbangkan antara pengurangan risiko dan pencapaian dampak kesehatan yang optimal (*health impact*), tanpa mengorbankan keselamatan pasien (WHO, 2021; WHO, 2025). Dengan demikian, *risk appetite* tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai *value governance mechanism* dalam pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, hubungan antara *risk appetite* dan *organizational resilience* menjadi semakin relevan dalam konteks sistem kesehatan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Resiliensi organisasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menyerap, beradaptasi, dan pulih dari gangguan, sekaligus mempertahankan fungsi esensialnya (Hollnagel et al., 2015). Dalam hal ini, tingkat *risk appetite* yang terlalu rendah dapat menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi, sedangkan *risk appetite* yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kerentanan terhadap kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang adaptif antara pengendalian risiko dan fleksibilitas organisasi, yang tercermin dalam spektrum *averse-cautious-open* sebagaimana diadopsi dalam kerangka WHO.

Dalam konteks rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik, dinamika ini semakin kompleks karena adanya paradoks pelayanan kesehatan, yaitu ketegangan antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan, seperti antara keselamatan pasien dan efisiensi biaya, antara akses layanan dan mutu pelayanan, serta antara standarisasi dan kebutuhan individual pasien. Paradoks ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan linear, melainkan harus dikelola melalui pendekatan ambidextrous yang mampu menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi secara simultan (Smith & Lewis, 2011).

Dalam kerangka ini, *risk appetite* berperan sebagai mekanisme strategis untuk mengelola paradoks tersebut. Pada domain keselamatan pasien (*clinical domain*), organisasi cenderung menerapkan *risk appetite* yang rendah (*averse*) untuk memastikan tercapainya *zero avoidable harm*. Namun, pada domain inovasi dan

transformasi sistem kesehatan, organisasi perlu mengadopsi *risk appetite* yang lebih moderat atau bahkan tinggi (*cautious–open*) untuk memungkinkan pengembangan layanan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem. Dengan demikian, *risk appetite* tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat diferensial dan kontekstual sesuai dengan domain risiko yang dihadapi.

Integrasi antara *risk appetite*, *public value*, *resilience*, dan paradoks pelayanan kesehatan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko di rumah sakit tidak lagi dapat dipahami sebagai fungsi teknis semata, melainkan sebagai bagian dari tata kelola strategis organisasi publik. Pendekatan ini memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam pengembangan model ERM di rumah sakit, khususnya dalam menjembatani antara tuntutan keselamatan pasien, kinerja organisasi, dan keberlanjutan sistem pelayanan Kesehatan.

20. *Balanced Scorecard* sebagai Instrumen Penguatan *Value for Money* melalui *Enterprise Risk Management* di Rumah Sakit Publik

Kinerja organisasi sektor publik pada hakikatnya tidak dapat dipahami hanya melalui pencapaian outcome maupun efisiensi penggunaan sumber daya secara terpisah. Perspektif *Public Service Value Model* menegaskan bahwa organisasi publik menghasilkan nilai ketika mampu menyelaraskan *social and economic outcomes* dengan prioritas warga secara *cost-effective* (Cole & Parston, 2006). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi publik tidak lagi diukur semata dari besaran anggaran yang dibelanjakan atau kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi dari sejauh mana organisasi mampu mengonversi sumber daya publik menjadi manfaat sosial yang nyata.

Dalam kerangka tersebut, *outcome* dipahami sebagai hasil akhir (*end result*) yang mencerminkan dampak substantif pelayanan publik, bukan sekadar output administratif. Sementara itu, *cost-effectiveness* didefinisikan sebagai rasio antara outcome yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan, yang pada dasarnya merepresentasikan *social return on public investment* (Cole & Parston, 2006). Dengan demikian, kinerja organisasi publik harus dimaknai sebagai manifestasi keseimbangan strategis antara penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan fiskal.

Secara konseptual, *outcome* berperan sebagai dimensi *value creation*, sedangkan *cost-effectiveness* berfungsi sebagai mekanisme *value protection*. Kinerja

organisasi publik terjadi ketika kedua dimensi tersebut bergerak secara simultan. Peningkatan *outcome* tanpa efisiensi berisiko menimbulkan tekanan fiskal, sementara efisiensi tanpa *outcome* berpotensi melemahkan legitimasi publik. Perspektif ini sekaligus menggeser paradigma pengukuran kinerja sektor publik dari *spending orientation* menuju *value orientation*, di mana hubungan antara *outcome* dan pengeluaran menjadi pusat analisis kinerja organisasi.

Relasi antara *outcome* dan *cost-effectiveness* bersifat komplementer, bukan substitutif. Peningkatan salah satu dimensi dengan mengorbankan dimensi lainnya mencerminkan adanya *trade-off* dalam penciptaan nilai publik, sedangkan peningkatan keduanya secara simultan menunjukkan kapasitas organisasi dalam menghasilkan kinerja unggul. Namun demikian, hubungan tersebut juga bersifat dinamis dan sering melibatkan pilihan strategis. Investasi awal pada teknologi, program pelayanan, maupun penguatan kapabilitas organisasi dapat menurunkan efisiensi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis kinerja organisasi publik perlu mempertimbangkan dimensi temporal dan tidak terjebak pada efisiensi jangka pendek semata.

Integrasi antara *outcome* dan *cost-effectiveness* menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan kerangka manajemen kinerja organisasi. *Balanced Scorecard* (BSC) merupakan kerangka kerja manajemen strategis yang mengintegrasikan ukuran kinerja finansial dan non-finansial untuk memastikan keseimbangan antara pencapaian tujuan jangka pendek dan keberlanjutan strategis jangka panjang organisasi. Konsep yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton ini telah berkembang menjadi alat komprehensif dalam pengukuran kinerja organisasi secara holistik karena tidak hanya menilai hasil finansial tetapi juga faktor pendorong kinerja masa depan seperti proses internal, pelanggan, serta pembelajaran organisasi (Madsen, 2025).

Dalam perspektif strategis *Balanced Scorecard*, *outcome* merujuk pada pencapaian indikator strategis yang mencerminkan manfaat nyata dari implementasi kebijakan dan strategi organisasi. Sebaliknya, *cost-effectiveness* menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, sehingga organisasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target tetapi juga pada efisiensi penggunaan biaya dalam menghasilkan nilai strategis. Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi sektor publik dan layanan kesehatan yang menghadapi keterbatasan sumber daya sekaligus tuntutan peningkatan kualitas pelayanan (Sundari, 2024).

Dengan demikian, *Balanced Scorecard* tidak hanya mengukur seberapa besar hasil telah dicapai, tetapi juga sejauh mana biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan outcome yang optimal. Integrasi ini memungkinkan organisasi memastikan bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya efektif secara kinerja tetapi juga efisien secara ekonomi, sehingga mendukung terciptanya *value for money*.

Dalam konteks *Balanced Scorecard*, Perspektif Keuangan berfungsi sebagai fondasi utama dalam penilaian *cost-effectiveness*. Perspektif ini mencakup indikator seperti *return on investment*, biaya operasional, margin, dan efisiensi anggaran, yang menggabungkan ukuran hasil finansial dengan biaya yang digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut (Madsen, 2025). Organisasi tidak lagi hanya mengevaluasi surplus atau profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk mencapai outcome finansial tersebut. Indikator seperti *cost per outcome* dan rasio efisiensi operasional menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan finansial tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Perspektif Pelanggan atau *stakeholder* menempatkan outcome sebagai representasi nilai publik melalui kepuasan pengguna, loyalitas, dan persepsi kualitas layanan. Walaupun tidak secara langsung bersifat finansial, outcome pada dimensi ini berkontribusi terhadap kinerja jangka panjang melalui peningkatan kepercayaan dan legitimasi publik. Selain itu, perspektif ini menunjukkan sejauh mana biaya yang dikeluarkan organisasi mampu menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder (Sundari, 2024). Oleh karena itu, indikator kepuasan perlu dianalisis bersama biaya pelayanan (*cost-to-serve*) agar organisasi dapat menilai apakah peningkatan kepuasan dicapai secara *cost-effective*.

Perspektif Proses bisnis internal berperan sebagai penghubung langsung antara biaya dan outcome. Efisiensi operasional menghasilkan proses yang lebih cepat, akurat, dan minim pemborosan, sehingga mampu menurunkan biaya sekaligus meningkatkan kinerja organisasi. Indikator seperti *cycle time*, *lead time*, dan tingkat kesalahan proses menjadi relevan ketika dikaitkan dengan biaya proses karena mencerminkan hubungan langsung antara efisiensi operasional dan outcome strategis (Madsen, 2025).

Sementara itu, Perspektif *Learning and growth* berfokus pada investasi terhadap sumber daya manusia, teknologi, dan kapabilitas organisasi. Outcome pada dimensi ini berupa peningkatan kapasitas organisasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa depan. Meskipun sering dipandang sebagai non-finansial, peningkatan

kompetensi staf dan inovasi terbukti berkorelasi dengan *cost-effectiveness* jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan pemborosan (Sundari, 2024). Dengan demikian, pembelajaran organisasi tidak lagi dapat dipandang sebagai variabel pendukung semata, melainkan sebagai penggerak utama kinerja masa depan.

Rantai kausal *Balanced Scorecard* menunjukkan bahwa *learning and growth* memperkuat kapabilitas organisasi, kapabilitas meningkatkan efektivitas proses internal, proses yang unggul menghasilkan outcome yang lebih baik, dan outcome yang meningkat pada akhirnya mendorong keberlanjutan fiskal. Pengaitan *outcome* dengan hasil finansial ini menciptakan disiplin investasi yang memastikan pengembangan kapabilitas dilakukan secara *cost-effective*.

Selain perspektif organisasi, pemahaman tentang kinerja juga perlu ditempatkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Literatur ekonomi menekankan bahwa indikator paling fundamental dari keberhasilan suatu sistem adalah pertumbuhan produktivitas karena hal tersebut menentukan kesejahteraan jangka panjang. Dalam organisasi publik, produktivitas dapat dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan outcome yang lebih besar tanpa peningkatan sumber daya yang proporsional. Oleh sebab itu, keterkaitan antara *outcome* dan *cost-effectiveness* pada dasarnya merupakan manifestasi dari produktivitas organisasi.

Peran inovasi menjadi krusial dalam konteks ini, karena peningkatan kinerja tidak hanya bergantung pada efisiensi operasional tetapi juga pada kemampuan organisasi membangun kapabilitas inovatif. Namun demikian, pencapaian *cost-effectiveness* tidak hanya ditentukan oleh faktor manajerial, tetapi juga oleh struktur institusional yang membentuk insentif bagi para pengambil keputusan. Tanpa desain insentif yang tepat, organisasi publik berisiko tidak menyediakan layanan secara optimal maupun efisien, sehingga kinerja harus diukur, dikelola, dan dianalisis secara sistematis.

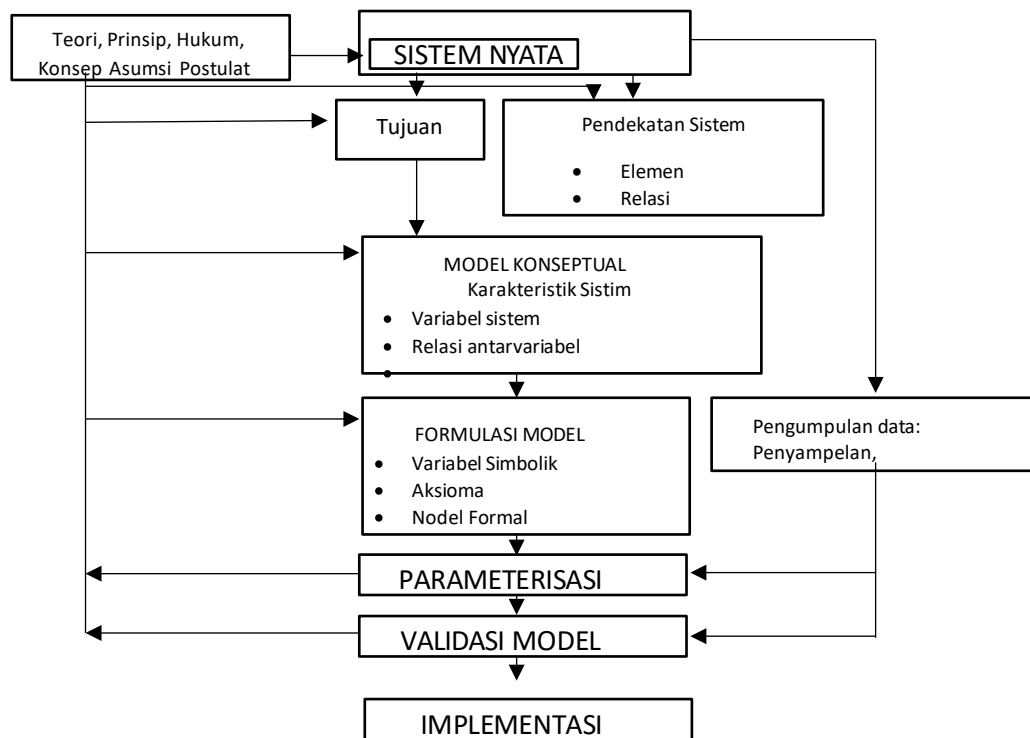
Dengan mempertimbangkan perspektif *public value*, produktivitas, dan institusi, kinerja organisasi publik dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas organisasi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta mekanisme insentif yang mengarahkan perilaku aktor organisasi. Oleh karena itu, *performance index* tidak seharusnya hanya merefleksikan capaian outcome atau efisiensi biaya secara parsial, tetapi harus menangkap keseimbangan strategis antara keduanya. Dalam kerangka *Balanced Scorecard*, *performance index* dapat dikembangkan sebagai indikator komposit yang menggabungkan *outcome achievement score*, *cost ratio*, serta *value*

efficiency index untuk menilai efektivitas dan efisiensi secara simultan (Sundari, 2024).

21. Pemodelan Sitem

Menurut Simatupang (1995), Pemodelan adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antar elemen yang membangun sebuah kesatuan, biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem di terapkan di lapangan. Pemodelan sebagai proses menampilkan objek nyata atau realitas dalam bentuk seperangkat persamaan matematika, grafik, atau bagan agar orang yang terlibat dapat memahaminya dengan mudah. Pemodelan sistem merupakan dasar pemahaman sistem nyata yang ada disekitarnya baik itu sistem produksi maupun sistem jasa. Dari pemahaman tersebut, kemudian dapat menentukan entitas, variabel status, untuk membuat keterkaitan antara sub-sistem yang ada.

Dalam pembentukan model, harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sistem. Untuk dapat memodelkan suatu sistem terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain: (a) model harus mewakili merepresentasikan sistem yang nyata, (b) model merupakan penyederhanaan dari sistem yang kompleks, sehingga pada model diperbolehkan adanya penyimpangan pada batas- batas tertentu. Pertanyaan yang sering muncul saat membangun model adalah bagaimana menggunakannya tanpa mengurangi pemecahan masalah, yang berarti berarti diperlukan modifikasi dan pengembangan model. Pengembangan model adalah suatu usaha memperoleh model baru yang memiliki kemampuan lebih di dalam beberapa aspek Simatupang (1995) seperti dalam langkah langkah pengembangan model pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6
Langkah Langkah Pengembangan Model
Sumber: Simatupang, T (1995)

B. Penelitian Terdahulu

Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami perkembangan konsep, teori, serta metode yang telah diterapkan, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian terdahulu berperan sebagai dasar teoritis dalam mengembangkan penelitian ini. Analisis terhadap berbagai studi sebelumnya memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana temuan yang ada telah berkontribusi dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Selain itu, penelitian terdahulu juga memberikan wawasan tentang pendekatan metodologis yang telah digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode yang lebih relevan.

Dengan menyajikan penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya membangun landasan konseptual yang kuat serta memastikan adanya kontribusi akademik yang baru. Kajian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi keterbatasan dan kekurangan yang dapat diperbaiki, sehingga penelitian ini tidak hanya mengulang studi yang telah ada, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memperluas atau menyempurnakan konsep yang dikaji.

Peneliti menggunakan *Google Scholar*, *Research gate*, *Publish & Perish (Harring.com)*, *Sciencedirect.com*, *Researchgate.Net*, *Semanticscholar.com*, untuk mencari literatur dengan kata kunci “manajemen risiko, “rumah sakit”, “hospital”, *healthcare*, *enterprise risk management* dalam waktu 2019 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Penelitian terdahulu

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
1.	Olii <i>et al.</i> (2019) Judul: Implementasi Manajemen Risiko Klinis Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pada Rumah Sakit Di Kota Makassar	Nama Jurnal: Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim ISSN: 2599-1167 Halaman:106-120 Tahun: 2019 DOI: https://doi.org/10.30597/jkmm.v2i1.10063 URL: https://doi.org/10.30597/jkmm.v2i1.10063	Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi CRM pada rumah sakit di Kota Makassar dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya.	Metode penelitian gabungan dengan desain eksplanatori sekuensial (urutan pembuktian). Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam.	Dari 9 rumah sakit yang diteliti, 7 rumah sakit (77,78%) memiliki tingkat implementasi MRK yang tinggi. Kelas dan status kepemilikan rumah sakit menunjukkan kecenderungan positif terhadap implementasi CRM, sedangkan tipe rumah sakit tidak berpengaruh. Lima faktor yang berkontribusi positif terhadap implementasi CRM adalah kepemimpinan, pengetahuan staf, koordinator, kebijakan rumah sakit, dan akreditasi.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa 77,78% rumah sakit di Kota Makassar memiliki tingkat implementasi Manajemen Risiko Klinis yang tinggi.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
2.	(Nugraheni, 2019) Judul: <i>Risk Management in Hospital Filing Unit</i>	Nama jurnal: International <i>Conference Of Health Science, & Technology</i> ISSN:978-623-92207-0-9 Halaman:59-62 Tahun: 2019 DOI: https://doi.org/10.47701/icohetech.v1i1.764 URL: https://doi.org/10.47701/icohetech.v1i1.764 Scopus/Sinta: - (Indeks Copernikus dan Garuda)	Penelitian ini bertujuan - Mengidentifikasi risiko di unit pengarsipan. - Mengendalikan, melaporkan, dan memantau risiko secara efektif.	- Pendekatan <i>cross-sectional</i> digunakan untuk pengumpulan data. - Pedoman observasi dan wawancara untuk pengumpulan data. - Analisis deskriptif dari data yang dikumpulkan.	Diidentifikasi adanya risiko pada - Risiko fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan proses produksi teridentifikasi. - Pelaporan dan pemantauan manajemen risiko belum dilakukan.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Risiko di unit filing meliputi debu, pencahayaan kurang, bau apek, kecoa dan tikus, full roll o pack, serta LBP. 2. Pengendalian risiko telah dilakukan untuk debu, kecoa dan tikus, <i>full roll o pack</i> , dan LBP. 3. Pelaporan risiko masih dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. 4. Monitoring risiko belum dilakukan karena dianggap minor. 5. Sikap petugas cenderung menghentikan, menghindari, atau mengurangi risiko saat bekerja.
3.	Dewi & Darma (2019) Judul: Strategi Investasi & Manajemen Resiko	Nama jurnal: Jurnal Manajemen Bisnis ISSN: 1829-8486 (print) Halaman:110-127	Untuk memahami kebijakan investasi dari aspek keuangan berdasarkan manajemen risiko	Penelitian Kualitatif	Perhitungan NPV menunjukkan nilai Rp463.592.397, IRR sebesar 10,62%, dan Payback Period selama 8 tahun. Meski investasi	Analisis NPV, IRR, dan PP menunjukkan investasi rumah sakit layak dilanjutkan. Namun, penerapan manajemen risiko tetap

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	Rumah Sakit Swasta di Bali	Tahun:2019 URL: https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2044 Scopus/Sinta: - (Google scholar, Garuda)			rumah sakit dinilai layak untuk dikembangkan, belum optimalnya manajemen risiko dapat menimbulkan potensi kerugian, sehingga integrasi strategi mitigasi risiko tetap diperlukan.	penting untuk strategi mitigasi. Penelitian ini fokus pada aspek keuangan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan aspek lain dalam menilai kelayakan investasi.
4.	(Izza <i>et al.</i> , 2022) Judul: Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Tahun 2020	Nama jurnal: JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudu ISSN: P-ISSN 2338-6347 E-ISSN 2580-992X Halaman:278-292 Tahun: 2022 DOI: https://doi.org/10.31596/jkm.v9i2.835 URL: Scopus/Sinta: - (Google scholar, Garuda, one search, PKP)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai implementasi manajemen risiko pada Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari variabel-variabel yang ditemukan dalam studi pendahuluan. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang pada periode Maret sampai dengan April 2021	Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis narasi dan triangulasi data. Subjek penelitian terdiri dari 3 informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu Kepala Sub Bagian Komite Mutu sebagai key informan, serta Penanggung Jawab Program Manajemen Risiko dan perwakilan instansi/unit sebagai informan.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko di IBS selama pandemi cukup optimal, meski terhambat kurangnya pemahaman pegawai dan belum ada evaluasi khusus COVID-19. Pemangku kebijakan memahami konsepnya, namun pelaksanaan dan pemantauan terhambat karena risk register belum terintegrasi dengan sistem rumah sakit. Evaluasi masih manual atau via Google Sheet, meskipun seluruh jajaran RS berpartisipasi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pada masa pandemic di IBS dapat diambil kesimpulan bahwasanya penilaian dari implementasi program manajemen resiko dinilai cukup optimal

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
					aktif dalam peningkatan manajemen risiko.	
5.	(Fanny & Soviani, 2020) Judul: Analisis Manajemen Risiko Di Ruang Filing RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2020	<i>Risk Management Analysis in the Filing Room</i> of Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Regional Hospital in 2020 Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Informatika Kesehatan ISSN: p-ISSN : 2086 - 2628 e-ISSN : 2745 - 5629 Halaman:12-19 Tahun:2020 DOI: https://doi.org/10.47701/infokes.v10i2.1027 Sinta: Sinta 3	Untuk mengetahui potensi faktor risiko dan bahaya di ruang arsip, dan mengetahui proses manajemen risiko di ruang arsip RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso, Wonogiri tahun 2020. Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi rumah sakit dalam membuat kebijakan manajemen risiko, khususnya di ruang arsip.	descriptive with cross sectional approach	Temuan menunjukkan bahwa penerapan protokol manajemen risiko di RS Dr. Soediran Mangun Soemarso Wonogiri telah efektif diinisiasi. Manajemen Fasilitas Keselamatan merumuskan strategi risiko di setiap unit, dan departemen rekam medis melaksanakan proses manajemen risiko secara sistematis. Namun, di departemen pengarsipan, tahapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria masih diabaikan.	
6.	Ningsih <i>et al.</i> (2020) Manajemen Resiko Redesign Sistem Penjajaran Rekam Medis dengan	Nama jurnal: <i>Indonesian of Health Information Management Journal</i> ISSN: ISSN (Print) :	RS Condong Catur Yogyakarta menggunakan sistem Straight Numerical Filing (SNF) yang sering menyebabkan misfile, sehingga perlu	Desain penelitian menggunakan penelitian tindakan. Instrumen untuk mengukur manajemen risiko redesign sistem penjajaran rekam medis dari SNF menjadi TDF	Setelah dilakukan redesign terjadi penurunan RPN. Penurunan RPN tertinggi pada proses penyimpanan rekam medis mode kegagalan	Dengan demikian dapat disimpulkan setelah dilakukan evaluasi dan monitoring implementasi redesign sistem penjajaran rekam medis dari SNF menjadi TDF

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	Metode <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> (FMEA)	2354-8932 ISSN (Online) : 2655-9129 Halaman:8-20 Tahun:2020 DOI: https://doi.org/10.47007/inohim.v8i1.204 URL: Scopus/Sinta: Sinta 4	redesign menjadi Terminal Digit Filing (TDF). Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko redesign sistem penjabaran rekam medis dengan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk mencegah kegagalan dan meminimalkan risiko	dengan menerapkan ke-8 langkah FMEA	“petugas menjajarkan rekam medis tidak sesuai urutan TDF” dengan nilai RPN turun dari 336 menjadi 72.	dengan metode FMEA mampu secara signifikan menurunkan resiko pada proses menerima permintaan rekam medis, pengambilan dan penyimpanan rekam medis.
7.	Setiawan <i>et al.</i> (2021) Judul: Manajemen Risiko SIMRS Menggunakan Metode OCTAVE-S dan Standar Pengendalian ISO/EIC 27001	<i>SIMRS Risk Management Using the OCTAVE-S Method and ISO/EIC 27001 Control Standard</i> Nama jurnal: JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) ISSN: 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 Halaman:593-600 Tahun: 2021	<i>Performing risk assessments employing the OCTAVE-S framework alongside</i> RS Wishnu Husada Banyumas telah menerapkan teknologi informasi dalam pelayanannya, namun masih menghadapi masalah seperti human error, gangguan server, dan risiko lainnya. Kurangnya dokumentasi penanganan risiko menyebabkan masalah	<i>Qualitative case study approach</i> Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan.	Penelitian ini mengidentifikasi aset kritis sistem informasi RS berupa database server dan SIMRS, serta ancaman akibat belum adanya standar prosedur pada enam praktik keamanan. Berdasarkan metode OCTAVE-S, terdapat enam praktik dengan stoplight merah, sembilan kuning, dan satu hijau. Strategi mitigasi risiko disusun mengacu pada ISO 27001 untuk	(1) Pengukuran risiko dengan metode OCTAVE-S membantu RS Wishnu Husada Banyumas mengelompokkan risiko dan mengidentifikasi kelemahan sistem informasinya. (2) Ancaman utama teridentifikasi pada SIM RS, database server, dan sistem BPJS yang saling terintegrasi. (3) Dari 15 praktik

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
		DOI: https://doi.org/10.35957/jatisi.v7i3.336 URL: Sinta: Sinta 5	berulang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi risiko dengan metode OCTAVE-S dan mengacu pada kontrol ISO 27001.		memetakan hasil evaluasi praktik keamanan rumah sakit.	keamanan, enam di antaranya bernilai merah, yaitu kebijakan keamanan, manajemen keamanan kolaboratif, perencanaan contingency, pengendalian akses fisik, pemantauan dan audit keamanan fisik, serta manajemen insiden. Rencana mitigasi telah disusun mengacu pada ISO 27001.
8.	(Firmansyah, 2022) Judul: Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Islam Surabaya A. Yani	<i>Implementation of Occupational Safety and Health Risk Management at the A. Yani Islamic Hospital in Surabaya</i> Nama jurnal: Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip) ISSN: 2715-5617 / e-ISSN: 2356-	Manajemen risiko adalah upaya preventif penting bagi rumah sakit untuk meminimalkan kesalahan dan pengaduan. Data insiden keselamatan pasien RS Islam A. Yani Surabaya tahun 2019 menunjukkan 93% <i>near miss</i> , 4% tidak cedera, 3% KTD, dan 0%	Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap penerapan manajemen risiko K3 di Rumah Sakit A. Yani Surabaya berdasarkan data observasi, survey dan dokumentasi pada 37 unit dan tempat kerja rumah sakit dengan cara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko K3 di Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya berdasarkan hasil identifikasi risiko diperoleh sebanyak 25 risiko pada gedung graha dan gedung lama yang selanjutnya dianalisa dengan menemukan 15 risiko sedang dan 10	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko K3 di Rumah Sakit Islam Surabaya A. Yani berdasarkan proses identifikasi risiko dan analisis risiko terdapat 25 risiko potensial, yang mana terdapat 15 risiko sedang dan 10 risiko tinggi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
		3346 Halaman: 12-22 Tahun: 2022 DOI: 10.14710/jkm.v10i 1.31550 URL: <a href="http://ejournal3.un
dip.ac.id/index.php/
jkm">http://ejournal3.un dip.ac.id/index.php/ jkm	sentinel. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penerapan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit tersebut.	mengidentifikasi risiko, menganalisis dan menemukan tindakan pengendalian risiko.	risiko tinggi. yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki sarana prasarana yang rusak dan meningkatkan sistem keamanan yang ada di Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya.	pada karyawan, pengunjung dan pasien. Dalam hal ini dilakukan (4) upaya pengendalian untuk meminimalisir jumlah insiden dan kecelakaan.
9.	(Saud <i>et al.</i> , 2021) Judul: Tingkat Kemapanan Implementasi Manajemen Risiko Rekam Medis di Rumah Sakit Kota Gorontalo	Nama jurnal: <i>Journal of Health, Education and Literacy</i> (J-Healt) ISSN: 9772-930004 Halaman:90-96 Tahun: 2021 DOI: https://doi.org/10.31605/j-healt.v3i2.921 URL: https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-healt/ Scopus/Sinta:	Pelayanan rumah sakit selalu memiliki risiko yang dapat memengaruhi keselamatan pasien. Di Kota Gorontalo, masalah umum meliputi ketidaklengkapan rekam medis akibat ketidakdisiplinan dokter, kesalahan identifikasi pasien, dan kesalahan coding diagnosis yang mempersulit klaim. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemapanan implementasi manajemen risiko	Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Populasinya yaitu seluruh rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Pemilihan sampel secara <i>non probability sampling</i> yaitu mewakili keseluruhan faktor struktural organisasi rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan rumah sakit, dan jenis rumah sakit.	Implementasi manajemen risiko di rumah sakit Kota Gorontalo menunjukkan dokumentasi masih rendah (60–66,67%), sedangkan pelatihan berkelanjutan cukup tinggi. Empat dari lima rumah sakit berada pada tahap 4 (aksi) dan satu pada tahap 2 (kontemplasi). Peningkatan kemapanan memerlukan komitmen seluruh organisasi rumah sakit.	Rata-rata rumah sakit di Kota Gorontalo berada pada tahap ke-4 (<i>aksi</i>), menunjukkan implementasi manajemen risiko belum sistematis. Semua rumah sakit masih menggunakan rekam medis manual, sehingga sering terjadi kerusakan dokumen dan rendahnya keakuratan data. Hal ini disebabkan belum adanya sistem manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan. Peningkatan kemapanan memerlukan komitmen seluruh bagian organisasi rumah sakit.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
			rekam medis di rumah sakit Kota Gorontalo.			
10.	(Afifa & Adisasmito, 2021) Judul: Analisis Manajemen Risiko Penularan Virus COVID-19 Pada Dokter dan Perawat Di Rumah Sakit X	<i>Analysis of COVID-19 Virus Transmission Risk Management in Doctors & Nurses at Hospital X</i> Jurnal Manajemen Dan Administrasi RS Indonesia ISSN: E-ISSN: 2865-6583 P-ISSN: 2865-6298 Halaman: 1640172 Tahun: 2021 URL: http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI 172 Scopus/Sinta: Sinta 4	Selama pandemi COVID-19, rumah sakit perlu melindungi dokter dan perawat melalui manajemen risiko yang baik. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pencegahan infeksi COVID-19 di RS X, termasuk elemen penting dan hubungannya dengan penilaian penerapan manajemen risiko.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif paralel konvergen yang diolah secara univariat dan bivariat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner daring.	Hasil: Rumah sakit telah melakukan upaya demi tercapainya lingkungan kerja yang aman, seperti pembuatan area khusus COVID, penyediaan APD yang cukup, serta pengaturan durasi shift. Didapatkan korelasi signifikan (p-value <0.05) elemen yang diteliti dengan penilaian penerapan manajemen risiko, dengan nilai uji Spearman tertinggi 0.607 pada elemen komunikasi dan information.	Elemen yang diteliti berhubungan dengan penilaian penerapan manajemen risiko di RS X. Upaya perlindungan dokter dan perawat sudah cukup baik, ditunjukkan oleh menurunnya angka infeksi. Namun, masih ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurang disiplin, dan komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka..
11.	Zahra <i>et al.</i> (2021) Judul: Manajemen Risiko Sistem Informasi Rumah Sakit (Studi Kasus : Rumah Sakit EMC Tangerang) Anisah	Nama jurnal: Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA) Jakarta-Indonesia, 20 April 2021	Rumah Sakit EMC Tangerang, bagian dari EMC Group, menyediakan layanan kesehatan yang unggul dan terpercaya. Di era teknologi, sistem informasi rumah sakit	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan lebih cenderung menggunakan kemampuan analisis penulis dengan pendekatan studi kasus.	Pada sistem informasi Rumah Sakit EMC Tangerang terdapat beberapa risiko yang harus diutamakan atau memiliki nilai risiko yang tinggi, antara lain kebocoran data yang	Penelitian ini menyimpulkan bahwa RS EMC Tangerang memprioritaskan tiga aset utama: perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Risiko utama yang diidentifikasi meliputi

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
		Manajemen ISSN: e-ISBN 978-623-93343-3-82962-6129 Halaman: 456-469 Tahun: 2021 DOI:- URL: https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/1429 Scopus/Sinta: -	menjadi krusial namun rentan terhadap risiko dari sumber daya manusia, sistem, infrastruktur, maupun faktor lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko untuk menjaga keberlangsungan sistem informasi RS EMC Tangerang.	Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi literatur, observasi dan melakukan pendeskripsian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian terhadap risiko – risiko yang dapat terjadi pada sistem informasi rumah sakit EMC Tangerang melalui 9 tahapan.	disebabkan pemberian hak akses kepada orang yang tidak berwenang oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab, kehilangan data yang disebabkan tidak adanya backup database oleh Rumah Sakit EMC Tangerang.	kebocoran data oleh pegawai, hilangnya data karena tidak ada backup, serangan virus akibat firewall lemah, pembobolan data karena keamanan sistem rendah, serta kerusakan akibat bencana. Mitigasi diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko ini.
12.	(Hutagalung, 2022) Judul: Analisa Manajemen Risiko Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Simrs) Pada Rumah Sakit Xyz Menggunakan Iso 31000	Nama jurnal: TeIKa ISSN: 1979-6439 Halaman:23-33 Tahun:2022 DOI: 10.36342/teika.v12i01.2820 URL: https://doi.org/10.36342/teika.v12i01.2820	Rumah Sakit merupakan sebuah instansi kesehatan yang merupakan pusat pelayanan kesehatan di mana orang sakit dapat ditampung dan diobati dengan baik. Rumah Sakit XYZ merupakan bagian dari jaringan pelayanan kesehatan AHSA, dimana pada tahun 1986 telah	Identifikasi masalah dilakukan dengan metode kuantitatif melalui studi literatur, observasi, dan kuesioner yang dibagikan kepada bagian Mirsa selaku pengelola IT rumah sakit. Manajemen risiko menggunakan ISO 31000 sebagai pedoman generik yang dapat diterapkan pada semua jenis organisasi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 risk level tingkatan high, merupakan risiko berbahaya yang harus diatasi secepatnya, dan 13 risk level tingkatan medium yang merupakan risiko yang harus diperhatikan terus-menerus, sehingga setiap risiko harus dilakukan perlakuan risiko yang	□ Manajemen risiko di RS XYZ dilakukan sesuai pedoman ISO 31000, mulai dari komunikasi dan konsultasi, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, asesmen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi), perlakuan risiko, hingga pencatatan dan pelaporan kepada organisasi.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
		Scopus/Sinta: Sinta 4	menggunakan aplikasi CLIPPER untuk penyimpanan data. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan manajemen risiko Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit XYZ		diharapkan dapat menjadi acuan dalam penanganan dan pemeliharaan terhadap Sistem Informasi di waktu yang akan datang	□ Hasil asesmen risiko menunjukkan dua risiko dengan level tinggi (virus, mati listrik) dan 13 risiko level sedang, seperti kegagalan input data, koneksi putus-putus, UPS tidak berfungsi, human error, hingga kerusakan hardware. Perlakuan risiko diharapkan dapat mencegah risiko di masa depan.
13.	Vanesa <i>et al.</i> (2022) Judul: Analisis Manajemen Risiko Pada Petugas Khusus Laboratorium Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah MANDAU DURI TAHUN 2021	Nama jurnal: Media Kesmas (<i>Public Health Media</i>) ISSN: e-ISSN 2776-1339 Halaman:347-362 Tahun:2021 DOI: 10.25311/kesmas.vol2.iss1.552 URL: https://jom.hip.ac.id/index.php/kesmas Scopus/Sinta: -	Manajemen risiko K3 bertujuan mencegah kecelakaan secara komprehensif dan terstruktur. Di RSUD Mandau Duri, program K3 laboratorium belum terlaksana dan kesadaran penggunaan APD masih rendah. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis identifikasi bahaya,	Studi kualitatif, dengan metode wawancara dan observasi lapangan dimana penelitian ini dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Duri pada bulan September 2021. Informan penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Laboratorium, Kepala K3 Rumah Sakit, dan 3 Petugas Laboratorium. Variabel	Penelitian menunjukkan identifikasi bahaya dan program K3 di laboratorium belum optimal, serta kepatuhan APD masih rendah. Analisis risiko cukup baik karena kecelakaan jarang terjadi, meski <i>risk matrix</i> menunjukkan risiko <i>extreme</i> dan <i>high</i> . Evaluasi risiko baik, namun pengendalian masih kurang efektif	Identifikasi bahaya di laboratorium RSUD Mandau Duri belum optimal, program K3 belum terlaksana, dan kepatuhan penggunaan APD perlu ditingkatkan untuk mencegah COVID-19. Analisis risiko cukup baik karena kecelakaan jarang terjadi, namun <i>risk matrix</i> menunjukkan kategori risiko <i>extreme</i> dan <i>high</i> .

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
			evaluasi, dan pengendalian risiko di laboratorium.	penelitian ini yaitu, identifikasi bahaya, analisa risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko.	karena petugas belum sepenuhnya taat menggunakan APD.	
14.	(Purnatimu & Rifai, 2023) Judul: <i>Analysis of Occupational Safety and Health Risk in Emergency Installations with Hospital X Yogyakarta Using the Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) Method</i>	Nama jurnal: MASHIJO: <i>Medical Science and Hospital Journal Dental and Oral Hospital of Universitas Muhammadiyah Semarang</i> ISSN: 1234-5678 Halaman: 6-27 Tahun: 2023 Scopus/Sinta: - (Garuda, Google scholar)	Menganalisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja di unit gawat darurat. Membatasi, meminimalkan, dan menghilangkan bahaya di rumah sakit	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Failure Mode Effect and Analysis (FMEA). Pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan merupakan dua metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di dan meliputi seluruh aktivitas kerja di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit X.	Terdapat 21 aktivitas kerja yang diketahui memiliki risiko K3, dengan 4 aktivitas kerja memiliki risiko tinggi, 8 aktivitas kerja memiliki risiko potensial, dan 9 aktivitas kerja memiliki Anamnesis, pengambilan sampel darah, pemeriksaan pasien, penerimaan pasien, dan tindakan medis dengan menggunakan alat tajam merupakan sumber bahaya yang paling umum; terdapat insiden di unit gawat darurat yang menyebabkan tindakan medis dengan alat tajam mengakibatkan kasus seperti luka tusuk jarum pada petugas kesehatan yang terkena pecahan ampul kaca dan sebagainya.	Penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, dapat mempengaruhi perilaku pekerja sehingga dapat mengurangi angka kesalahan dan pelanggaran, serta kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja lagi.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
15.	(Dihartawan et al., 2024) Judul: <i>Analysis of Factors Affecting Hospital Risk Management in Indonesia: The SEM-PLS Approach</i>	Nama jurnal: Kesmas ISSN: 1 9 0 7 - 7 5 0 5 Halaman: 135-143 Tahun: 2024 DOI: https://doi.org/10.21109/kesmas.v19i2.1106 URL: Scopus/Sinta: Scopus Q4 / Sinta 1	Penelitian ini meneliti dampak faktor manajemen risiko rumah sakit terhadap efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko. Meskipun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam lembaga perawatan kesehatan secara historis menekankan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang diberikan, keselamatan petugas kesehatan sering kali diabaikan.	Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan metode survei pada 90 rumah sakit di 10 provinsi, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sampel dipilih secara purposive berdasarkan permintaan Ditjen Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes RI.	risiko yang dapat ditoleransi. Sebanyak 44 fasilitas kesehatan (48,9%) berstatus lengkap, mayoritas rumah sakit tipe C (43,3%). Analisis SEM-PLS menunjukkan identifikasi bahaya (koefisien 0,282) dan faktor SOP (koefisien 0,469) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan manajemen risiko. Peningkatan penggunaan SOP dan analisis bahaya yang komprehensif penting untuk memajukan manajemen risiko rumah sakit di Indonesia.	Penelitian ini menemukan bahwa SOP berperan utama dalam meningkatkan manajemen risiko di rumah sakit Indonesia dan berkorelasi dengan kualitas identifikasi bahaya dan risiko. Penelitian selanjutnya disarankan menambah sampel agar lebih representatif. Integrasi K3-MS dengan keselamatan pasien juga dapat meningkatkan program manajemen risiko.
16.	(Pratama, 2024) <i>Analysis of The Influence of Risk Management And Hospital Management Information System on The Performance of</i>	Nama jurnal: <i>International Journal of Economics, Business and Accounting</i> ISSN: 3032-3754 Halaman: 379-384 Tahun: 2024 DOI:	Untuk menyelidiki dan mengevaluasi sejauh mana manajemen risiko memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja operasional rumah sakit umum daerah di Provinsi Lampung.	Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan pendekatan berbasis survei.	Data menunjukkan manajemen risiko berkontribusi 35,9% terhadap kinerja RSUD (koefisien 0,359; t-hitung 3,115 > t-tabel 2,026; P = 0,002). SIMRS juga berpengaruh signifikan dengan kontribusi 63,7%	Manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal ini menegaskan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja rumah

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Regional Public Hospitals (Empirical Study at Regional General Hospitals in Lampung Province)</i>	10.5281/zenodo.13789915 URL: https://basecampcopubmed.com/index.php/injeba/article/view/98 Scopus/Sinta: - (Garuda, Index Copernicus International)	Untuk memastikan dan menguji apakah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara signifikan mempengaruhi metrik kinerja rumah sakit umum daerah di Provinsi Lampung.		(koefisien 0,637; t-hitung 5,567; P = 0,000). Kedua faktor ini terbukti meningkatkan kinerja RSUD.	sakit umum daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh dapat ditolak.
17.	Putra & Hendrawan (2024) Judul: Analisis Manajemen Risiko SIMRS pada Rumah Sakit Ganesha Menggunakan ISO 31000	Nama jurnal: Jurnal Teknologi dan Informasi ISSN: 2655-6839 Halaman: 88-98 Tahun: 2024 DOI: https://doi.org/10.34010/jati.v14i1.12329 URL: Scopus/Sinta:	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelola risiko di SIMRS Rumah Sakit Ganesha dengan menggunakan kerangka kerja ISO 31000.	Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Tahapan penyelidikan meliputi identifikasi aset, identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, manajemen risiko, serta dokumentasi dan pelaporan.	Analisis menunjukkan risiko tinggi dan sedang, seperti pemadaman listrik dan kehilangan data pasien. Rekomendasi penanganan meliputi pemasangan genset. Hasil penanganan dicatat dan dikirim ke organisasi untuk ditinjau.	Manajemen risiko penting untuk mengatasi risiko terkait penggunaan SIMRS di Rumah Sakit Ganesha. Dengan mematuhi ISO 31000, diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap operasional rumah sakit
18	Ferdosi <i>et al.</i> (2020) <i>Risk Management in Executive Levels of Healthcare Organizations : Insights from a</i>	- Nama Jurnal: <i>Risk Management and Healthcare Policy</i> - ISSN: Tidak disediakan dalam konteks	Studi ini menyajikan kerangka kerja dan teknik manajemen risiko di tingkat eksekutif organisasi kesehatan, dengan fokus pada identifikasi dan kategorisasi risiko.	- Metodologi penelitian menggunakan tinjauan pelingkupan pada studi berbahasa Inggris dari Januari 2000–Oktober 2018. Data dikumpulkan melalui pencarian kata kunci di database utama,	- Temuan menunjukkan pengembangan kerangka kerja RM berbasis ISO 31000 untuk eksekutif organisasi kesehatan, terdiri dari lima fase: menetapkan konteks,	- studi ini menyajikan kerangka manajemen risiko untuk eksekutif organisasi kesehatan, berguna sebagai alat pelatihan penilaian dan evaluasi risiko non-klinis. Ditekankan

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Scoping Review</i> (2018), vol 13, hal 215, tahun 2020, 10.2147/RMHP.S231712, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=56885	- Halaman:215-243 - Tahun: 2018 - DOI: https://doi.org/10.2147/RMHP.S231712 - URL: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=56885 Scopus/Sinta: Scopus Q2	Tujuannya mengembangkan kerangka berbasis ISO 31000 yang sederhana dan komprehensif, mencakup lima fase: konteks, penilaian, penanganan, pemantauan, dan komunikasi	dengan dua pengulas independen menilai kesesuaian studi. Sebanyak 37 studi dianalisis untuk menyusun kerangka kerja manajemen risiko di organisasi kesehatan.	penilaian risiko, perawatan risiko, pemantauan dan tinjauan, serta komunikasi dan konsultasi. Set alat dan teknik disarankan di tiap fase. Penilaian menunjukkan perlunya metode RM yang sesuai kebutuhan organisasi, serta pentingnya identifikasi dan kategorisasi risiko untuk manajemen berkualitas tinggi, termasuk risiko non-klinis.	pentingnya penggunaan berbagai metode yang sesuai kebutuhan organisasi, bukan hanya satu alat tunggal. Temuan juga menunjukkan adanya kesenjangan penelitian praktik manajemen risiko di negara berkembang, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.
19	Khassouani <i>et al.</i> (2021) <i>Risk management and surveillance systems: A Model proposed for the provincial public hospital (CHP)</i>, vol 319, hal 01061, tahun 2021, 10.1051/E3S	- Nama Jurnal: <i>International Congress on Health Vigilance</i> (VIGISAN 2021) - Halaman: 1-5 - Tahun: 2021 - DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131901061 - URL:	- Pendahuluan membahas penerapan sistem pengawasan kesehatan di RS umum Maroko untuk memantau risiko dan memberi peringatan kesehatan. Sistem seperti keselamatan pasien, hemovigilans, dan farmakovigilans diatur dalam struktur	- Metodologi penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif menggunakan debat kelompok fokus untuk mengumpulkan persepsi lokal mengenai manajemen risiko. - Kotak enam pertanyaan terbuka digunakan sebagai referensi untuk lima kelompok homogen, yang meliputi	- Temuan menunjukkan rumah sakit provinsi di Maroko mampu beradaptasi selama pandemi COVID-19. Namun, analisis kualitatif di RS Ifrane mengungkapkan proses manajemen risiko yang tidak jelas dan tanggung jawab	- Model yang diusulkan untuk manajemen risiko rumah sakit menekankan manajemen lintas sektoral yang mengintegrasikan berbagai proses dan misi di dalam rumah sakit. - Sangat penting bagi model untuk berasal dari

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	CONF/20213 1901061,	- https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/95/e3sconf_vigisan_01061.pdf Scopus/Sinta: -	kesehatan masyarakat. Peraturan internal RS menekankan kewaspadaan dan keamanan, sementara orientasi akreditasi nasional mendorong pengembangan manajemen mutu dan risiko.	staf perawat, staf administrasi, dokter dan magang, staf laboratorium, dan staf pendukung CHP. Setiap kelompok fokus terdiri dari maksimal delapan peserta, dan beberapa pertemuan diselenggarakan untuk mengumpulkan berbagai tanggapan	tumpang tindih, menghambat informasi dan keputusan. Studi ini menekankan perlunya sistem kewaspadaan kesehatan yang terstruktur untuk meningkatkan ketahanan terhadap infeksi dan bencana.	kebijakan manajerial yang dengan jelas menggambarkan peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi
20	Zaitseva <i>et al.</i> (2022) <i>Developing the methodology for health risk assessment within public management of sanitary-epidemiologic al welfare of the population</i> hal 4, tahun 2022, 10.21668/health.risk/2022.3.01.eng, https://journal	- Nama Jurnal: <i>Health Risk Analysis</i> - ISSN: ISSN (Print) 2308-1155 ISSN (Online) 2308-1163 ISSN (Eng-online) 2542-2308 - Halaman: 4-20 - Tahun: 2022 - DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.01.eng	- Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan metodologi penilaian risiko kesehatan di Rusia dengan menggabungkan analisis statistik multidimensi, pemodelan matematika, dan logika fuzzy. Fokus utamanya pada pemodelan evolusi risiko akibat perubahan eksposur, penilaian paparan gabungan faktor lingkungan, serta	- Metodologi penelitian ini memperbarui penilaian risiko kesehatan untuk manajemen kesejahteraan sanitasi-epidemiologis, menggunakan analisis statistik multidimensi, pemodelan matematika, dan logika fuzzy. Data dikumpulkan melalui pemodelan evolusi risiko akibat perubahan eksposur, dianalisis secara kuantitatif untuk risiko non-karsinogenik dan tingkat keparahan gangguan kesehatan. Validasi dilakukan	- Temuan menunjukkan metodologi penilaian risiko kesehatan di Rusia telah diperbarui, menekankan kesejahteraan sanitasi-epidemiologis dengan pendekatan unik yang menggabungkan analisis statistik multidimensi, pemodelan matematika, dan logika fuzzy. Inovasi mencakup penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif, khususnya	- Penelitian ini menekankan perlunya metodologi penilaian risiko kesehatan komprehensif di Rusia, yang menggabungkan analisis statistik multidimensi, pemodelan matematika, dan logika fuzzy. Inovasinya mencakup penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif, khususnya pemodelan evolusi risiko. Metodologi ini mendukung standar

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	.fcisk.ru/eng/sites/journal.fcisk.ru/eng/files/upload/article/624/health-risk-analysis-2022-3-1.pdf	- URL: https://journal.fcisk.ru/eng/sites/journal.fcisk.ru/eng/files/upload/article/624/health-risk-analysis-2022-3-1.pdf	pengembangan metode penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif berdasarkan tingkat keparahan gangguan kesehatan.	dengan menilai risiko integral paparan faktor lingkungan heterogen, menggunakan kalkulus diferensial untuk analisis numerik berbagai skenario paparan dan kondisi kerja berbahaya.	risiko non-karsinogenik, serta pemodelan evolusi risiko akibat perubahan eksposur. Penelitian menekankan pentingnya menilai paparan gabungan faktor lingkungan dan kerja, perlunya standarisasi higienis, serta penggunaan pemodelan situasional untuk memprediksi kesejahteraan kesehatan masyarakat di Rusia	higienis dan strategi manajemen kesehatan masyarakat, dengan rekomendasi penelitian lanjutan untuk penyempurnaan.
21	Jule (2020) <i>Workplace Safety: A Strategy for Enterprise Risk Management</i> , vol 68, 8, hal 360, tahun 2020, 10.1177/2165079920916654, https://journals.sagepub.co	Nama jurnal: <i>Workplace Health & Safety</i> ISSN: - Halaman: 360-365 Tahun: 2020 DOI: https://doi.org/10.1177/216507992091665	- Penelitian ini membahas tingginya cedera dan penyakit di fasilitas kesehatan akibat paparan cairan tubuh dan penyakit menular. Tujuannya mengurangi insiden melalui keterlibatan kepemimpinan dan penerapan kontrol preventif, direktif, serta korektif. Studi	- Penelitian ini mengembangkan sistem manajemen keselamatan di pusat medis tersier California dengan melibatkan kepemimpinan dan staf untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi cedera. Data dikumpulkan dari 114 klaim cedera dalam	- Penelitian menunjukkan pusat medis tersier di California berhasil menurunkan klaim cedera kerja sebesar 59% (dari 114 menjadi 67 klaim dalam dua tahun). Keterlibatan kepemimpinan meningkatkan budaya keselamatan dengan	- Budaya keselamatan dibangun melalui kepemimpinan yang kuat dan proses keselamatan yang jelas. Mitigasi bahaya penting untuk menurunkan cedera kerja. Keselamatan menjadi tanggung jawab bersama staf, manajer, dan pimpinan, dengan

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	m/doi/pdf/10.1177/2165079920916654	URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920916654	menekankan pentingnya sistem manajemen keselamatan yang melibatkan kepemimpinan dan staf dengan fokus pada budaya keselamatan, perilaku kepemimpinan, proses yang jelas, dan tanggung jawab bersama.	setahun, dengan analisis menunjukkan penurunan menjadi 67 klaim dalam dua tahun, serta peningkatan dua poin pada skor keterlibatan staf dan pemimpin. Validasi dilakukan dengan membandingkan klaim sebelum dan sesudah implementasi sistem, berfokus pada pembentukan budaya keselamatan dan efektivitas kepemimpinan.	proses yang jelas dan mitigasi bahaya. Skor keterlibatan staf dan pemimpin naik dua poin, mencerminkan akuntabilitas dan komunikasi yang lebih baik. Temuan menegaskan bahwa keselamatan kerja memerlukan tanggung jawab bersama antara staf dan pimpinan.	pemimpin senior berperan sebagai teladan untuk menciptakan budaya komunikasi terbuka. Keterlibatan efektif pimpinan dan staf terbukti mengurangi klaim cedera dan meningkatkan budaya keselamatan.
22	Botet (2021) <i>Dealing with Unforeseen Circumstances. Implication of Risk Management in the COVID-19 Public Health Emergency</i> , tahun 2021, 10.5772/INT ECHOPEN.9 7408, https://www.intechopen.com/citation-pdf-url/76302	- Nama <i>Jurnal/Intechopen: Risk Management</i> - ISSN (online): 978-1-83968-905-5 - Halaman: 145-160 - Tahun: 2021 DOI: Tidak ditentukan dalam	- Makalah ini membahas dampak darurat kesehatan COVID-19 pada pabrik dan pentingnya rencana manajemen darurat berbasis manajemen risiko (RM) untuk pemulihan bencana. Penelitian bertujuan mengembangkan model rencana kontinjensi dengan	- Metodologi penelitian menggunakan manajemen risiko (RM) untuk menilai, mengendalikan, berkomunikasi, dan meninjau risiko pabrik manufaktur selama darurat seperti COVID-19. Pendekatan dimulai dengan mendefinisikan bidang tindakan dan mengumpulkan	- Penelitian ini menekankan pentingnya setiap unit manufaktur menyiapkan rencana manajemen darurat yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Manajemen risiko efektif setelah penilaian mendalam menggunakan alat seperti PHA dan	- Semua unit manufaktur perlu menyiapkan rencana darurat untuk pemulihan saat krisis. Manajemen risiko (RM) membantu mengendalikan situasi tak terduga melalui penilaian risiko yang memerlukan pemahaman objek dan pengalaman. Alat seperti PHA efektif untuk identifikasi

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
		konteks yang disediakan. - URL: - https://www.intechopen.com/citation-pdf-url/76302	metode RM dari pedoman farmasi internasional, menggunakan alat penilaian risiko seperti PHA dan FMEA untuk mengidentifikasi bahaya, menilai signifikansi, dan menentukan tindakan mitigasi dalam proses manufaktur.	informasi, lalu mengidentifikasi bahaya atau mode kegagalan dan menilai Signifikansinya menggunakan PHA untuk unit dan FMEA untuk proses. Validasi dilakukan dengan memfokuskan sumber daya pada risiko kritis, sedangkan bahaya non-kritis disisihkan.	FMEA, atau alternatif sederhana untuk pengalaman terbatas. Analisis akurat sangat penting mengingat dampak pandemi yang berbeda dari bencana biasa, terutama dalam memahami pengaruhnya pada operasional pabrik.	bahaya unit, sedangkan FMEA untuk proses. Risiko dikategorikan menjadi kritis (perlu tindakan) atau non-kritis. Rencana darurat harus disesuaikan dengan kondisi khusus darurat kesehatan seperti COVID-19 yang menimbulkan dampak unik pada operasional pabrik.
23	Darwiesh <i>et al.</i> (2022) <i>Artificial Intelligence Model for Risk Management in Healthcare Institutions: Towards Sustainable Development</i> , vol 15, 1, hal 420, tahun 2023, 10.3390/su15010420, https://www.	- Nama Jurnal: <i>Sustainability</i> - ISSN: Tidak disediakan dalam konteks. - Halaman: 1-13 - Tahun: 2023 - DOI: https://doi.org/10.3390/su15010420 - URL: https://www.mdpi.com/2071-	membahas pembangunan berkelanjutan dan pentingnya manajemen risiko dalam perawatan kesehatan digital. Risiko operasional, keuangan, dan teknologi perlu dikelola dengan kecerdasan buatan. NLP digunakan untuk analisis teks kesehatan, sementara media sosial mendukung interaksi pasien. Penelitian ini mengembangkan model	Penelitian ini mengembangkan model AI untuk manajemen risiko di layanan kesehatan dengan menganalisis data media sosial, khususnya tweet. NLP digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, sementara teknik big data seperti klasifikasi membantu mengelola data. Validasi dilakukan melalui analisis	Temuan menunjukkan sebagian besar tweet pasien terkait risiko layanan CVS, terutama operasional, keuangan, dan teknologi, dengan 19% risiko tinggi, 80,4% sedang, dan 0,6% rendah. NLP digunakan untuk analisis data, didukung model matematika dengan rumus eksplisit untuk identifikasi dan penilaian risiko. Validasi dilakukan melalui ukuran kinerja dan analisis kompleksitas, menunjukkan efektivitas model AI yang diusulkan.	Studi ini mengusulkan model NLP untuk identifikasi dan penilaian risiko di institusi kesehatan dengan memanfaatkan data media sosial dan teknik klasifikasi. Dihasilkan ekspresi matematika tertutup untuk analisis risiko. Studi kasus di CVS AS menunjukkan penerapannya, dengan ukuran kinerja mengevaluasi efektivitas model. Penelitian selanjutnya akan

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
	mdpi.com/2071-1050/15/1/420/pdf?version=1672126354	1050/15/1/420/pdf?version=1672126354	NLP berbasis media sosial untuk manajemen risiko dengan analisis data besar dan model matematika, menggunakan studi kasus di CVS AS.	kinerja dan kompleksitas, dengan fokus pada pengelompokan topik dan pembobotan kata berdasarkan risiko. Ask ChatGPT		mengoptimalkan akurasi dan kompleksitas hasil.
24	Pascarella <i>et al.</i> (2021) <i>Risk Analysis in Healthcare Organizations :Methodologi cal Framework and Critical Variables</i> , vol 14, hal 2897, tahun 2021, 10.2147/RMHP.S309098, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=71450	- Nama Jurnal: <i>Risk Management and Healthcare Policy</i> - Halaman:2897-2911 - Tahun: 2021 - DOI: https://doi.org/10.2147/RMHP.S309098 - URL: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=71450	Membahas risiko sebagai aspek tak terhindarkan yang dapat memengaruhi tujuan organisasi. Manajemen risiko meliputi identifikasi, penilaian, respons, dan pemantauan, dengan skema ISO 31000 mencakup tujuh tahap. Penilaian risiko penting untuk menentukan prioritas penanganan, terutama di organisasi kesehatan yang kompleks dan berpotensi berdampak besar pada pasien, staf, biaya, dan reputasi.	Metodologi menggunakan matriks risiko (DMRA) untuk menentukan, memberi peringkat, dan memprioritaskan risiko berdasarkan keparahan dan kemungkinan. Metode ini mudah diterapkan, visual, dan tidak memerlukan keahlian khusus. Prosesnya meliputi identifikasi, analisis, evaluasi risiko, serta diskusi pemangku kepentingan. Validasi menilai kontrol yang ada, dengan analisis semi- kuantitatif skala lima poin, meski tetap subjektif dan	Kelebihan, kekurangan, dan kelemahan analisis risiko di organisasi kesehatan, khususnya matriks risiko. Ditekankan pentingnya identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, namun penilaian bersifat subjektif dan rentan bias. Kurangnya standardisasi skala risiko dapat menimbulkan kesalahan prioritas. Disarankan perbaikan penggunaan matriks risiko dan penekanan terminologi yang tepat.	Makalah ini menekankan penilaian risiko sebagai tahap kunci manajemen risiko di organisasi kesehatan, dengan fokus pada variabel penting dan penggunaan matriks risiko. Penulis merekomendasikan mitigasi bias subjektif dan keterbatasan kognitif dalam penilaian. Disarankan agar organisasi menyediakan panduan lebih jelas terkait matriks risiko. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan metode penilaian yang lebih objektif dan standar untuk meningkatkan akurasi dan keandalan.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
				bergantung pada pengalaman pengguna.		
25	Park & Sharp (2019) <i>Improving health and health care efficiency through risk management</i> , 3, 9, 2019, 10.21037/JH MHP.2019.04 .02, https://jhmhp.amegroupp.com/article/download/5054/pdf	- Nama Jurnal: <i>Journal of Hospital Management and Health Policy</i> ISSN: Tidak disediakan dalam konteks - Halaman: 1-3 - Tahun: 2019 - DOI: 10.21037/jhmhp.2019.04. - URL: http://dx.doi.org/10.21037/jhmhp.2019.04.02	Makalah ini membahas tingginya efek samping akibat kesalahan medis dengan sedikit peningkatan keselamatan pasien, meski banyak upaya dilakukan. Diperkenalkan pendekatan standar manajemen risiko dengan kerangka terintegrasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko klinis secara proaktif. Konsep utamanya mencakup manajemen risiko operasional dan klinis, dengan kerangka komprehensif untuk memprioritaskan risiko dan menetapkan rencana perbaikan layanan kesehatan.	Metodologi penelitian tidak dijelaskan secara rinci, namun fokus pada pentingnya pendekatan standar manajemen risiko untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan efisiensi perawatan. Disebutkan komponen kunci seperti dukungan keputusan terintegrasi, pengukuran, umpan balik, pendidikan, dan proses sistematis. Pendekatan proaktif melalui pemodelan prediktif dan stratifikasi risiko juga ditekankan, dengan model penilaian risiko terintegrasi yang melibatkan dukungan kepemimpinan. Teknik pengumpulan dan analisis data serta proses validasi tidak	Penelitian ini menyoroti tingginya efek samping yang dapat dicegah di layanan kesehatan, meski upaya keamanan telah dilakukan. Ditekankan perlunya manajemen risiko standar dengan komponen edukasi, dukungan keputusan, pengukuran, dan umpan balik. Pendekatan bergeser dari reaktif ke proaktif melalui pemodelan prediktif dan stratifikasi risiko. Model penilaian risiko terintegrasi membantu memprioritaskan risiko dan memantau perbaikan, sehingga meningkatkan hasil pasien dan mengurangi risiko operasional.	Penelitian ini menekankan perlunya standarisasi sistem kesehatan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan efisiensi perawatan. Pendekatan sistematis manajemen risiko diperlukan, meliputi edukasi, stratifikasi risiko, dukungan keputusan, dan pelaporan kinerja. Integrasi dukungan keputusan dalam rekam medis elektronik terbukti meningkatkan hasil klinis. Kerangka manajemen risiko proaktif membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko klinis. Penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan pendekatan ini untuk mengurangi efek samping

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
				dijabarkan		dan meningkatkan hasil pasien.
26	Dimitrov (2019) <i>Risks to the sustainability of the healthcare system stemming from the increase in private healthcare costs</i> , 3, 75, 2019, http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/download/90/88	- Nama Jurnal: Sotsialna meditsina - ISSN: Tidak disediakan dalam konteks - Halaman: 5459 - Tahun: Tidak disediakan dalam konteks - DOI: Tidak disediakan dalam Konteks - URL: Tidak disediakan dalam konteks	Makalah ini membahas risiko keberlanjutan sistem kesehatan akibat meningkatnya biaya perawatan swasta yang melebihi pendanaan publik, menimbulkan ketidakseimbangan keuangan dan membebani rumah tangga berpenghasilan rendah-menengah. Penelitian menganalisis tren ini serta dampaknya terhadap stabilitas sistem kesehatan, akses, dan kualitas layanan.	- Metodologi penelitian tidak secara eksplisit dirinci dalam konteks yang disediakan. - Tidak ada penyebutan khusus tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. - Teknik pengumpulan data tidak diuraikan dalam informasi yang diberikan. - Konteks tidak menggambarkan metode apa pun untuk menganalisis data. - Tidak ada informasi tentang cara memvalidasi data. Teknik pemrosesan dan analisis data tidak dibahas dalam konteks yang disediakan	Penelitian ini menyoroti kenaikan biaya perawatan kesehatan swasta yang signifikan, membebani rumah tangga lebih besar dibanding pendanaan publik dan mengancam stabilitas sistem kesehatan. Terdapat tiga pasar layanan kesehatan: pendanaan publik, asuransi sukarela, dan pembayaran langsung. Kurangnya dana publik memicu ketergantungan pada biaya swasta. Studi ini menekankan perlunya transparansi, dialog, dan upaya bersama untuk mengatasi masalah ini, karena model pembiayaan saat ini dianggap tidak berkelanjutan.	Penelitian ini menyoroti tren kenaikan biaya kesehatan swasta yang mengancam keberlanjutan sistem kesehatan dan meningkatkan beban finansial rumah tangga. Ketergantungan pada pengeluaran swasta dapat memicu ketidakstabilan dan ketidakadilan akses layanan. Studi ini menyerukan evaluasi ulang model pembiayaan untuk memastikan alokasi dana publik yang memadai, serta merekomendasikan penelitian lanjutan terkait dampak tren ini dan potensi reformasi sistem kesehatan.

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
27	Buckè et al. (2022) <i>The link between the application of quality management principles and risk management in healthcare</i> , 2022, 10.3846/bm.2022.746,	- Nama Jurnal/Proceding: <i>12th International Scientific Conference “Business and Management 2022”</i> - ISSN: ISSN 2029-4441 / eISSN 2029-929X - Halaman: 1-12 - Tahun: 2022 - DOI: https://doi.org/10.3846/bm.2022.746 - URL: http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2022/paper/download/746/427	Manajemen mutu total sebagai filosofi holistik yang mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi untuk keunggulan kompetitif. Kualitas dipandang sebagai metode operasional dengan peningkatan berkelanjutan. Sertifikasi ISO 9001 dianggap bermanfaat. Fokus makalah adalah hubungan antara manajemen kualitas dan risiko di perawatan kesehatan.	Metodologi penelitian ini mencakup tinjauan literatur dan analisis kritis artikel ilmiah terbaru tentang hubungan manajemen mutu dan risiko dalam perawatan kesehatan. Data dikumpulkan dari artikel di Web of Science dan Scopus selama 15 tahun. Analisis fokus pada manfaat dan relevansi prinsip mutu terhadap manajemen risiko. Validasi dilakukan melalui literatur peer-review, meski tidak sistematis sehingga berpotensi bias. Analisis didasarkan pada wawasan teoritis terkait praktik mutu dan kematangan manajemen risiko.	Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penerapan prinsip manajemen mutu dan manajemen risiko di perawatan kesehatan. Penerapan prinsip mutu meningkatkan pengambilan keputusan dan keselamatan pasien, serta mengurangi kesalahan dan meningkatkan keberhasilan organisasi bersertifikat. Temuan ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan analisis kritis artikel ilmiah terbaru terkait manajemen kualitas dan risiko.	Penelitian ini menekankan integrasi manajemen kualitas dan risiko di perawatan kesehatan, dengan kualitas sebagai metode organisasi. Total Quality Management meningkatkan kinerja, dan ISO 9000 efektif mengurangi kesalahan. Manajemen risiko harus mencakup seluruh proses organisasi. Integrasi ini meningkatkan pengambilan keputusan, keselamatan pasien, pelaporan kesalahan, serta pencegahan risiko, dengan hubungan teoritis yang kuat antara keduanya.
28	Prasanti et al. (2019) <i>Implementati on of Enterprise Risk Management in a</i>	- Nama Jurnal: <i>Journal of Hospital Management</i> - Halaman:16-22 - Tahun:	Perkembangan bisnis menimbulkan risiko dan ketidakpastian yang mengancam organisasi, sehingga diperlukan manajemen risiko	Desain penelitian adalah kualitatif deskriptif	Berdasarkan evaluasi didapat bahwa belum semua unit mengimplementasikan manajemen risiko	Kesimpulannya, dari lima komponen ERM, struktur dan akuntabilitas memiliki penerapan tertinggi, sementara empat komponen lainnya

No	ID Artikel	Kategori	Pendahuluan	Metodologi Penelitian		Temuan Penelitian	Kesimpulan
	<i>State Owned Managed Hospital: lesson learnt</i>	2019 - DOI: - URL: https://johm.ub.ac.id/index.php/johm/article/view/5 -Scopus /Sinta: -	komprehensif. Enterprise Risk Management (ERM) adalah konsep baru manajemen risiko skala luas di industri, termasuk rumah sakit. Makalah ini membahas implementasi ERM di RS milik negara dengan 234 tempat tidur berdasarkan kerangka kerja ERM.				masih rendah. RS perlu memperbaiki aspek sistem dan perencanaan, pengembangan SDM, sistem informasi, dan pemantauan.

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan pada 28 artikel tentang manajemen risiko di rumah sakit, yang dilakukan peneliti lain antara tahun 2019 hingga 2024, Perbedaan dan Persamaan Tujuan dan Hasil Penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perbedaan dan Persamaan Tujuan dan Hasil Penelitian

Aspek	Persamaan	Perbedaan
Tujuan Penelitian	Semua penelitian bertujuan meningkatkan manajemen risiko di fasilitas kesehatan	• Beberapa fokus pada implementasi manajemen risiko klinis dan non-klinis (misal di rumah sakit). • Ada yang menyoroti aspek pembiayaan dan dampaknya terhadap risiko keuangan. • Ada yang mengembangkan metodologi penilaian risiko dengan teknik statistik dan matematika.
Hasil Penelitian	• Manajemen risiko yang sistematis dan berbasis standar (ISO 31000) efektif meningkatkan keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan. • Keterlibatan kepemimpinan dan budaya keselamatan penting. • Penggunaan metode seperti FMEA dan OCTAVE-S • membantu identifikasi dan pengendalian risiko. • Manajemen risiko berkontribusi pada peningkatan kinerja rumah sakit	• Tingkat implementasi dan efektivitas manajemen risiko bervariasi antar studi, dengan beberapa kendala seperti kurangnya dokumentasi dan pemahaman pegawai. • Studi pembiayaan menyoroti risiko keuangan dan ketidakadilan akibat tingginya biaya swasta, yang tidak dibahas dalam studi lain. • Studi di Rusia mengembangkan teknik analisis risiko jangka panjang yang lebih kompleks

Sumber: Diolah Peneliti

Penelitian oleh Ebi *et al.* (2021) mengenai dampak perubahan iklim terhadap sistem kesehatan menunjukkan bahwa risiko eksternal, seperti bencana alam dan perubahan lingkungan, dapat mempengaruhi kinerja layanan kesehatan. Dalam konteks rumah sakit di DKI Jakarta, risiko eksternal seperti pandemi dan polusi udara perlu menjadi perhatian dalam manajemen risiko untuk menjaga ketahanan layanan kesehatan. Selain itu, Tukamuhabwa *et al.* (2023) membahas bagaimana kapabilitas logistik dan manajemen risiko dalam rantai pasok berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemasok di sektor kesehatan. Hal ini relevan dalam pengelolaan logistik rumah sakit, di mana pasokan obat,

alat kesehatan, dan fasilitas medis harus dikelola dengan baik untuk menghindari gangguan operasional.

Penelitian oleh Rikhotso *et al.* (2022), menyoroti biaya kepatuhan dalam manajemen risiko kesehatan di Afrika Selatan, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja dapat membawa implikasi finansial yang signifikan bagi institusi kesehatan. Dalam konteks rumah sakit di Jakarta, penerapan manajemen risiko juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi biaya, terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk pencegahan risiko yang lebih besar di masa mendatang. Sementara itu, penelitian Bazaluk *et al.* (2023) mengenai manajemen risiko ergonomis menunjukkan bahwa faktor ergonomi dalam lingkungan kerja memiliki dampak terhadap keselamatan tenaga medis dan efisiensi layanan. Rumah sakit perlu menerapkan standar ergonomis untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan produktivitas tenaga medis.

Selain penelitian di sektor kesehatan, beberapa studi dalam bidang administrasi publik juga memberikan wawasan mengenai pengelolaan risiko dalam institusi publik. Misalnya, penelitian oleh Monteduro *et al.* (2021) mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam manajemen risiko korupsi menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan publik. Dalam konteks rumah sakit di Jakarta, pengelolaan risiko juga harus mencakup aspek tata kelola dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar meningkatkan kinerja layanan publik.

Penelitian oleh Dobrowolski *et al.* (2022) membahas dampak generasi Z terhadap manajemen risiko di administrasi publik, yang mengungkap bahwa generasi ini lebih cenderung mengadopsi pendekatan digital dan transparan dalam manajemen risiko. Dalam pengelolaan rumah sakit, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi, termasuk dalam mendeteksi dan mencegah risiko medis maupun administratif.

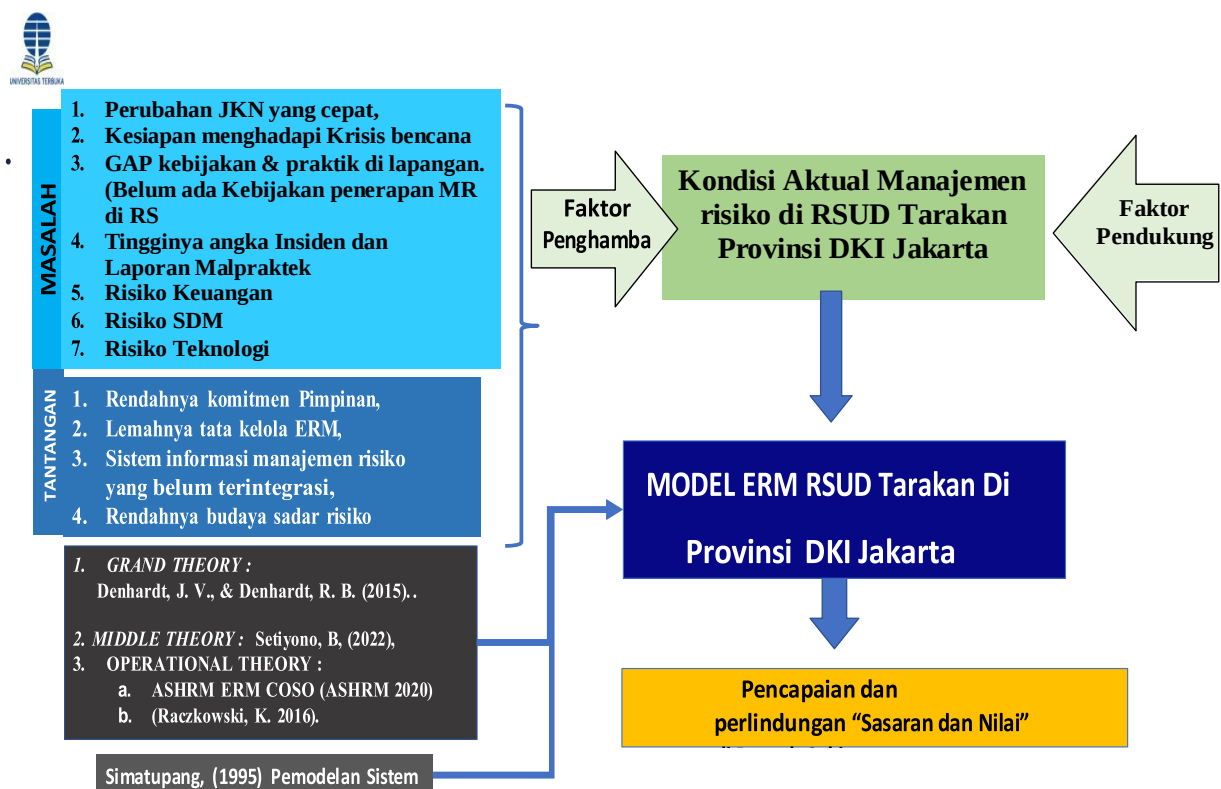
Selain itu, penelitian oleh Bracci *et al.* (2024) mengenai integrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di sektor publik menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar departemen menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan risiko yang efektif. Hal ini relevan dengan kondisi rumah sakit di Jakarta, di mana koordinasi antara berbagai unit layanan, manajemen, dan regulator sangat penting untuk memastikan sistem manajemen risiko berjalan secara optimal.

Beberapa penelitian lainnya membahas risiko yang terkait dengan keselamatan publik dan krisis global, yang juga dapat diaplikasikan dalam konteks rumah sakit.

Misalnya, penelitian oleh Abbas *et al.* (2021) tentang peran media sosial dalam manajemen krisis COVID-19 menyoroti bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kesehatan, tetapi juga memiliki risiko dalam menyebarkan disinformasi. Dalam konteks rumah sakit, strategi komunikasi publik yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan terpercaya.

Dengan memahami temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memperdalam kajian mengenai Model ERM di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjamin keselamatan pasien dan tenaga medis, serta memastikan keberlanjutan layanan kesehatan yang optimal.

C. Kerangka pikir Penelitian



Gambar 2.7
Kerangka pikir Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti

Penelitian ini berfokus pada kondisi aktual penerapan manajemen risiko di RSUD Provinsi DKI Jakarta sebagai objek utama studi. Rumah sakit di DKI Jakarta menghadapi

berbagai risiko kompleks yang memerlukan pendekatan manajemen risiko yang efektif untuk menjaga mutu dan keselamatan dalam pelayanan publik.

Kerangka pikir ini dimulai dari kondisi riil (aktual) penerapan manajemen risiko yang ada di rumah sakit, yang dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu:

1. Faktor Pendukung, yang memperkuat dan memudahkan pelaksanaan manajemen risiko di rumah sakit, misalnya kebijakan pemerintah, sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, dan budaya organisasi.
2. Faktor Penghambat, yang menjadi tantangan atau kendala dalam implementasi manajemen risiko, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko.

Dari pemahaman tentang kondisi aktual tersebut, Model ERM ini diharapkan mampu mengakomodasi kompleksitas risiko yang ada dan mengoptimalkan pengelolaan risiko secara menyeluruh di rumah sakit. Penerapan model ERM yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan rumah sakit dalam menghadapi multirisiko, khususnya pada pelayanan publik. Ketangguhan ini mencakup kemampuan rumah sakit untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi berbagai risiko sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan yang beragam. Dengan dembahaikian, kerangka pikir penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman kondisi nyata penerapan manajemen risiko, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta pengembangan model ERM yang dapat meningkatkan ketangguhan rumah sakit dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta.

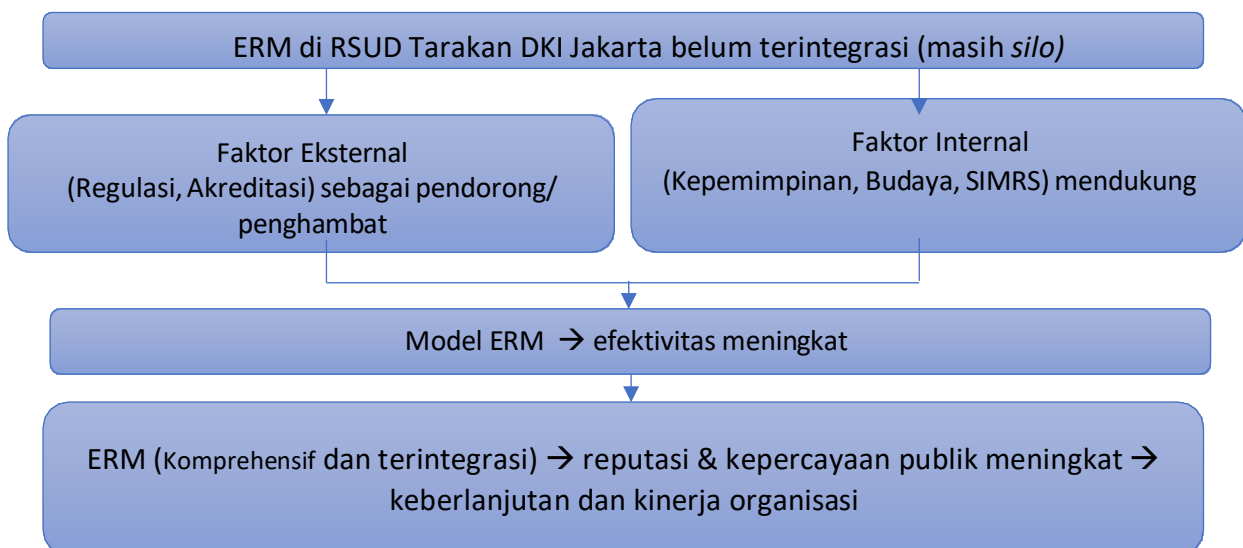
D. Proposisi Penelitian

Dalam penelitian ini, proposisi dikembangkan berdasarkan integrasi antara teori dan fakta empiris terkait praktik ERM di rumah sakit, yang merupakan bagian dari pelayanan publik di sektor kesehatan. Proposisi-proposisi tersebut berfungsi untuk memperkuat kerangka berpikir penelitian dan mengarahkan pada pengembangan model ERM yang terintegrasi pada tiga level manajemen, yaitu Strategis, Taktis, dan Operasional. Adapun proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan ERM di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta pada saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh, melainkan masih bersifat parsial atau sektoral (*silo approach*), baik dalam aspek klinis maupun non-klinis, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pencapaian tujuan pelayanan publik di bidang kesehatan.
2. Model ERM yang bersifat holistik dan kontekstual diperlukan untuk menggambarkan praktik pengelolaan risiko yang efektif di rumah sakit publik Provinsi DKI Jakarta.

3. Faktor internal, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola rumah sakit, berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi ERM secara komprehensif di rumah sakit.
4. Faktor eksternal, seperti regulasi, kebijakan pemerintah daerah, dan tekanan akreditasi, dapat menjadi pendorong maupun penghambat penerapan ERM, tergantung pada tingkat keselarasan antara kebijakan makro dan mikro dalam manajemen risiko di lingkungan rumah sakit.
5. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan unik dalam pengelolaan risiko yang harus diakomodasi dalam pengembangan model ERM agar sesuai dengan karakteristik rumah sakit publik di Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengembangan model ERM yang adaptif dan terintegrasi di level strategis, taktis, dan operasional, selaras dengan strategi pelayanan publik, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, efektivitas pengelolaan risiko, efisiensi operasional, serta akuntabilitas layanan kesehatan di rumah sakit Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, proposisi-proposisi ini menjadi dasar konseptual dalam merumuskan model ERM yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks rumah sakit publik perkotaan, khususnya di DKI Jakarta, untuk mendukung tata kelola risiko yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2.8
Proposisi ERM di Rumah Sakit
Sumber: Diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell & Creswell (2017), penelitian kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi, yang berfokus pada upaya mempelajari pengalaman langsung individu guna memahami makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali dan memahami esensi pengalaman hidup seseorang dari sudut pandang partisipan itu sendiri. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan fenomena penerapan ERM di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

Konsep tentang ERM di rumah sakit hingga saat ini belum banyak diketahui secara mendalam, mengingat penelitian yang mengkaji fenomena tersebut masih terbatas. Menurut Creswell & Creswell (2017), apabila suatu konsep atau fenomena belum banyak diteliti dan perlu dipahami lebih lanjut, maka pendekatan kualitatif merupakan pilihan yang tepat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah yang berlokasi di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rumah sakit di kawasan perkotaan, khususnya Jakarta, menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks.

Secara khusus, terdapat beberapa alasan utama yang mendasari pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian. *Pertama*, rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta umumnya telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki kemandirian dalam pengelolaan manajemen rumah sakitnya. Kemandirian ini memungkinkan penerapan model manajemen risiko yang lebih fleksibel dan sesuai konteks kebutuhan rumah sakit. *Kedua*, DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kepadatan penduduk tersebut berimplikasi pada tingginya permintaan layanan kesehatan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam penguatan pengelolaan risiko rumah sakit yang melayani masyarakat di wilayah berpenduduk padat. *Ketiga*, rumah sakit di Jakarta memiliki variasi dalam hal kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) menjadi penting untuk mengoptimalkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. *Keempat*, DKI Jakarta sering dijadikan sebagai lokasi uji coba berbagai kebijakan baru, termasuk di bidang kesehatan. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai lokasi yang strategis untuk meneliti inovasi manajemen risiko pada rumah sakit publik.

Selain itu, penelitian ini dilakukan pada rumah sakit milik pemerintah daerah dengan klasifikasi Tipe A yaitu RSUD Tarakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit Tipe A merupakan institusi pelayanan kesehatan rujukan tertinggi yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit Tipe A umumnya memiliki kapasitas tempat tidur yang besar, fasilitas medis yang lengkap, serta sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang spesialisistik. Selain itu, rumah sakit Tipe A juga berfungsi sebagai pusat rujukan nasional maupun regional.

RSUD di DKI Jakarta hanya satu yaitu RSUD Tarakan, sehingga pemilihan sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat merepresentasikan kompleksitas tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit publik perkotaan, sekaligus menyediakan konteks yang relevan dan strategis dalam mengkaji penerapan *Enterprise Risk Management* di sektor Kesehatan.

Tabel 3.1
Jumlah Rumah Sakit di DKI Jakarta

No	Pemilik RS	Jumlah
1.	Kementrian Kesehatan (RS Vertikal) (RSUP) : Tipe A : 10 RS	10
2.	Pemerintah Daerah DKI Jakarta (RSUD) teridiri dari : Tipe A : 1 RS Tipe B : 5 RS Tipe C : - Tipe D : 24 RS	30
3.	Swasta	156
	Total	196

Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Agustus hingga Oktober 2025. Pada bulan Agustus, kegiatan akan difokuskan pada pengurusan izin penelitian, persiapan instrumen, dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Bulan September akan digunakan untuk pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Selanjutnya, pada bulan Oktober akan dilakukan analisis data, validasi hasil dengan informan kunci, penyusunan laporan, dan finalisasi hasil penelitian untuk diseminasi.

Tabel 3.2
Waktu dan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC)	Output
1.	Persiapan	Pengajuan surat izin penelitian ke pihak terkait; Persiapan instrumen penelitian	Agustus 2025 (Minggu 1-2)	Peneliti	Surat izin; Instrumen siap digunakan
2.	Koordinasi dan sosialisasi	Koordinasi dengan RS dan unit terkait; Sosialisasi tujuan penelitian kepada Manajemen dan Informan	Agustus 2025 (Minggu 3-4)	Peneliti	Jadwal dan lokasi pengumpulan data jelas
3.	Pengumpulan data primer dan sekunder	Wawancara mendalam, observasi lapangan, pengumpulan dokumen dan data sekunder.	September 2025 (Minggu 1-4)	Peneliti	Data primer dan sekunder terkumpul lengkap
4.	Pengolahan dan analisis data	Transkripsi wawancara, koding data, analisis tematik atau statistik sesuai desain penelitian.	Oktober 2025 (Minggu 1-2)	Peneliti	Data teranalisis dan terinterpretasi
5.	Validasi temuan	Memberi checking dengan informan kunci; diskusi hasil sementara dengan pembimbing/promotor	Oktober 2025 (Minggu 3)	Peneliti	Validasi dan masukan hasil penelitian
6.	Penyusunan laporan penelitian	Penyusunan draft laporan hasil penelitian; finalisasi untuk diseminasi dan publikasi.	Oktober 2025 (Minggu 4)	Peneliti	Draft laporan final siap didiseminasikan

Sumber : Diolah Peneliti

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer mencakup informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui informan, peristiwa atau fenomena, serta dokumen terkait. Sebagaimana disampaikan oleh Creswell & Creswell (2017), dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen menjadi data tambahan. Peneliti menggunakan berbagai informan yang memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, dengan teknik *purposive sampling* untuk Dewan Pengawas, Pimpinan Rumah Sakit. Dan UnIt Manajemen Risiko (UMR). Tujuannya adalah menggali informasi dari individu-individu yang dapat memberikan wawasan mendalam, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun teori penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan membagi ke dalam empat kelompok berdasarkan model tiga lini (*three line model*): 1) Dewan Pengawas 2) Pimpinan Rumah Sakit sebagai pembuat Kebijakan di Tingkat rumah sakit, 3) Unit Pemilik Risiko (UPR), 4) Unit Manajemen Risiko (UMR) sebagai pelaksana kebijakan, dan 5) Unit Pengawas Internal (SPI) sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, peneliti menggunakan metode bola salju (*snowball sampling*) untuk UPR agar mendapatkan informan tambahan dengan mengandalkan rekomendasi dari informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Proses ini dilanjutkan hingga diperoleh kejenuhan data, yaitu kondisi di mana tidak ada informasi baru yang signifikan dari informan tambahan.

Selain itu, peristiwa yang diamati mencakup fenomena atau kondisi yang berhubungan dengan manajemen risiko rumah sakit. Peneliti mengobservasi seluruh tingkatan mulai dari Strategis, Taktis dan operasional.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian meliputi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terdahulu, seperti buku, laporan, jurnal, dan dokumen resmi seperti peraturan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pelayanan kesehatan. Data sekunder ini memberikan konteks tambahan yang mendukung data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh alat bantu (*tools*) seperti alat tulis, tape recorder, foto dan peta serta aplikasi pengolah data. Materi wawancara, dokumentasi dan observasi dikembangkan dari operasional konsep manajemen risiko.

F. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual penelitian memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis operasional teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian dalam merumuskan indikator instrumen penelitian yang digunakan dalam proses wawancara dan pengumpulan data di lapangan.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Konsep Manajemen risiko

No	Sumber / Teori	Dimensi	Parameter (Indikator)
1.	-	1. Gambaran umum ERM di RS	1. Kondisi eksisting penerapan ERM a. Faktor Pendukung b. Faktor Penghambat
2.	COSO ERM (2017), (Hill & Dinsdale, 2001), NAO. (2001), OECD. (2015).	2. Tata Kelola dan Budaya	a. Kesesuaian visi, misi, nilai dan sasaran rumah sakit b. Kepemimpinan dan Pengawasan Berupa Komitmen terhadap <i>Core Value</i> dan ERM c. <i>Value for Money (VfM)</i> d. Pengorganisasian ERM dengan <i>three line Model</i> e. Penetapan Regulasi manajemen Risiko Rumah Sakit f. Regulasi manajemen Risiko Eksternal g. Kesesuaian Regulasi internal dan eksternal h. Ketersediaan anggaran i. Akuntabilitas j. Keterlibatan Pemangku kepentingan k. Budaya sadar risiko l. Kompetensi SDM terhadap risiko m. Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi n. Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko o. <i>Standard decision by Government</i> dengan SPM

No	Sumber / Teori	Dimensi	Parameter (Indikator)
			p. <i>Performance Index by citizen</i>
3.	COSO ERM (2017)	3. Strategi dan Sasaran	a. Analisa Konteks internal dan eksternal b. Penetapan selera risiko (<i>risk appetite</i>) c. Evaluasi strategi alternatif d. Perumusan Tujuan dan Sasaran strategis mempertimbangkan risiko
4.	COSO ERM (2017)	4. Kerangka kerja ERM	a. Rancang Program kerja ERM
5.	COSO ERM (2017)		b. <i>Roadmap</i> dan penerapan c. ERM
6.	COSO ERM (2017)		d. Evaluasi hasil kegiatan ERM
7.	COSO ERM (2017)		e. Perbaikan berkelanjutan
8.	COSO ERM (2017)	5. Informasi dan Komunikasi	a. Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas dan tepat waktu b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko
9.	COSO ERM (2017) <i>Raczkowski and Tworek, 2017</i>), (Hill & Dinsdale, 2001),	6. Performance	a. Identifikasi risiko b. Analisis risiko dengan tingkat keparahan c. Penentuan prioritas risiko d. Perlakuan risiko e. Pembiayaan risiko f. Portofolio risiko
10.	COSO ERM (2017)	7. Review dan revisi	a. Penilaian perubahan substansial pada perubahan internal / eksternal signifikan direspons dengan penyesuaian risiko b. Review Kinerja dan Risiko c. Perbaikan ERM dengan Tindakan secara berkelanjutan
11.	COSO ERM (2017)	3. Audit Internal ERM	a. Audit internal berbasis risiko b. Tindak lanjut hasil audit risiko

Sumber: Diolah Peneliti

G. Prosedur Pengumpulan data

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Yin, (2016) bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari: dokumentasi, wawancara, dan observasi

langsung. Peneliti sendiri sebagai subjek penelitian, dan alat bantu penelitian adalah kamera dan alat perekam, Panduan wawancara dan observasi, serta alat tulis secukupnya. Secara detail langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth-information*) menggunakan pertanyaan terbuka yang fokus pada penerapan ERM. Metode wawancara digunakan untuk klarifikasi dan justifikasi kepada informan agar menghindari pengambilan data dari wawancara yang bias (Creswell & Creswell, 2017).

Dalam pengumpulan data, peneliti akan memulai proses wawancara dengan Dewan Pengawas dan para pimpinan rumah sakit sebagai informan pertama. Tujuan tahap awal ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai visi, misi, nilai, serta tujuan rumah sakit terkait manajemen risiko, termasuk mekanisme pengawasan yang diterapkan di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah memperoleh perspektif strategis dari tingkat pengawasan dan pimpinan, peneliti akan melanjutkan wawancara kepada informan penting berikutnya, yaitu kepala unit pemilik risiko yang berperan sebagai Lini Pertama (*First Line*). Wawancara pada tahap ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan manajemen risiko dilakukan di unit masing-masing serta tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Selanjutnya, peneliti akan mewawancarai unit manajemen risiko yang berperan sebagai Lini Kedua (*Second Line*). Pada tahap ini, peneliti akan menggali lebih dalam peran unit manajemen risiko dalam mengoordinasikan penerapan manajemen risiko di seluruh area dan tingkatan rumah sakit, termasuk integrasi risiko yang telah diidentifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penanganan risiko. Tahap berikutnya adalah wawancara dengan unit pengawas internal atau Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berperan sebagai Lini Ketiga (*Third Line*). Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SPI melaksanakan fungsi audit internal terhadap Lini Pertama dan Lini Kedua dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko di rumah sakit. Seluruh faktor yang diteliti akan dideskripsikan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, serta kajian dokumen, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran komprehensif terkait penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

Dari aspek jumlah yang terlibat dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara individu (*individual interview*) dan wawancara kelompok (*group interview*). Brinkmann membagi wawancara dari aspek jumlah yang terlibat dalam wawancara atas wawancara individu (*individual interview*) dan wawancara kelompok (*group interview*). Pada saat wawancara dengan Dewan Pengawas dan Pimpinan RS, Peneliti menggunakan wawancara individu. Dan saat melakukan wawancara dengan Unit Pemilik risiko, peneliti menggunakan wawancara kelompok. Seperti yang disampaikan Miles *et al.* (2014), bahwa wawancara kelompok, pewawancara dipandang sebagai "moderator" akan memfokuskan pada tema kepentingan dan sangat sesuai untuk penelitian eksploratoris dalam bidang yang sedikit diketahui, atau mengenai fenomena sosial yang baru muncul.

2. Observasi

Dengan kunjungan lapangan ke rumah sakit sebagai lokus penelitian, peneliti ingin melihat secara langsung bagaimana penerapan manajemen risiko di rumah sakit DKI Jakarta dengan mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam / mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti dan aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengeksplorasi penyelenggaraan manajemen risiko di beberapa area rumah sakit. Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengenai alur penyelenggaraan serta pengintegrasian seluruh kategori risiko secara menyeluruh di rumah sakit.

Dalam pelaksanaan observasi, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat (*observer*) pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam kondisi tertentu ketika peristiwa yang diteliti berlangsung. Metode observasi ini memungkinkan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan pendapat Bottorff (2015) yang menyatakan bahwa observasi merupakan strategi pengumpulan data yang melibatkan proses pengumpulan dan pemeriksaan sistematis terhadap perilaku verbal maupun nonverbal sebagaimana terjadi di berbagai konteks. Dalam praktiknya, observasi dapat dilakukan dengan

menggunakan pendekatan terstruktur maupun tidak terstruktur, sesuai kebutuhan penelitian dan karakteristik data yang ingin diperoleh.

3. Dokumen

Dalam penelitian ini dokumen yang akan di lakukan pengkajian adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan Regulasi berupa Kebijakan, Surat Keputusan Direktur, SPO, Rencana kerja, Program kerja, *Road map*, Penganggaran, surat-surat penting/edaran, struktur organisasi, paparan data, program-program kerja, agenda, jadwal kegiatan, buku-buku atau catatan-catatan (notulansi) yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, daftar risiko, profil risiko, pemantauan dan pelaporan manajemen risiko di RSUD Tarakan DKI Jakarta.

Metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan data pendukung dalam memahami dan menganalisis sejauh mana fenomena manajemen risiko dipenerapkan di rumah sakit. Semua data sekunder berasal dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan manajemen risiko. Hal ini sesuai yang disampaikan Moleong (Moleong, 2014) bahwa dokumen digunakan dalam penelitian karena dalam banyak hal dapat digunakan sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan.

Tabel 3.4
Sumber Data, Jenis Data dan Teknik Pengambilan dan Pengendalian data

No	Data yang Dibutuhkan (Parameter/Indikator)	Sumber Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan dan Pengendalian Data	Teori/Referensi
1	Kondisi eksisting penerapan ERM di RS	Profil RS, Dokumen kebijakan, Laporan ERM, wawancara manajemen	Primer & Sekunder	Triangulasi dokumen– wawancara– observasi	Moeller, R. R. (2011)
2	Kesesuaian visi, misi, nilai, dan sasaran RS	Dokumen visi-misi, Renstra, wawancara pimpinan	Sekunder & Primer	Validasi silang dokumen dengan wawancara	Moeller, R. R. (2011); OECD (2015)
3	Komitmen kepemimpinan terhadap <i>Core Value</i> dan ERM	Wawancara pimpinan, observasi Notulen rapat manajemen	Primer & Sekunder	Wawancara, verifikasi dokumen, observasi	Moeller, R. R. (2011); Hill & Dinsdale (2001)
4	Pengorganisasian	SK struktur	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R.

No	Data yang Dibutuhkan (Parameter/Indikator)	Sumber Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan dan Pengendalian Data	Teori/Referensi
	ERM dengan <i>Three Lines Model</i>	ERM, bagan organisasi		& observasi ke unit terkait	(2011)
5	Penetapan regulasi manajemen risiko	Dokumen regulasi internal & eksternal	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
6	Kesesuaian regulasi internal dan eksternal	Dokumen regulasi RS, peraturan pemerintah	Sekunder	Verifikasi dokumen, Analisis perbandingan regulasi	Moeller, R. R. (2011)
7	Ketersediaan anggaran ERM	RKA, laporan keuangan RS	Sekunder	Verifikasi dokumen Cross-check laporan anggaran	Moeller, R. R. (2011)
8	Lima dimensi akuntabilitas	Wawancara, dokumen laporan kinerja	Primer & Sekunder	Wawancara, Verifikasi dokumen, Triangulasi metode	Jabbra & Dwivedi (1989)
9	Keterlibatan pemangku kepentingan	Notulen rapat, wawancara stakeholder	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen, Observasi	Hill & Dinsdale (2001)
10	Value for Money (VfM)	Laporan keuangan & kinerja	Sekunder	Verifikasi dokumen, Analisis rasio	Grindle, M. S. (1997)
11	Budaya sadar risiko di organisasi	Wawancara, hasil survei	Primer	Wawancara, Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
12	Kompetensi SDM terhadap risiko	Hasil pelatihan, wawancara SDM	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen Cross-check sertifikat & wawancara	Moeller, R. R. (2011)
13	Komitmen SDM terhadap nilai & etika	Wawancara terkait nilai yang dianut dan etika RS, etika profesi	Primer & Sekunder	Wawancara, Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
14	Sistem penghargaan budaya sadar risiko	Dokumen HRD, wawancara HR	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen & wawancara	Moeller, R. R. (2011)
15	<i>Standard Decision by Government</i> dengan SPM	Dokumen SPM RS, regulasi	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen & wawancara	UU No. 25/2009; OECD (2015)
16	Performance Index by Citizen (SERVQUAL)	Survei kepuasan pasien	Primer	Verifikasi dokumen & wawancara	Parasuraman et al. (1988)
17	Analisis konteks internal & eksternal	Laporan analisis SWOT, wawancara	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen & wawancara	Moeller, R. R. (2011)

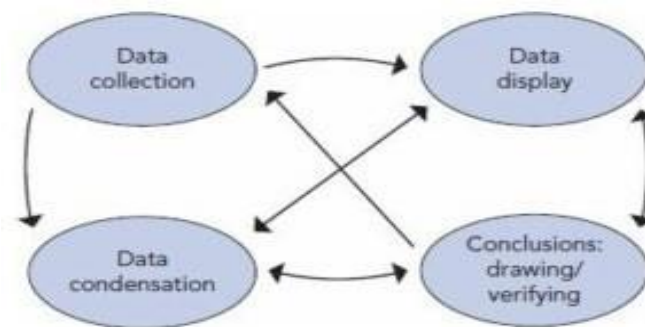
No	Data yang Dibutuhkan (Parameter/Indikator)	Sumber Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan dan Pengendalian Data	Teori/Referensi
18	Penetapan <i>risk appetite</i> sesuai nilai & sasaran	Dokumen kebijakan risiko	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen & wawancara	Moeller, R. R. (2011)
19	Evaluasi strategi alternatif	Notulen rapat perencanaan strategis	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
20	Perumusan tujuan & sasaran strategis mempertimbangkan risiko	Renstra, dokumen risiko	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
21	Program kerja ERM	Dokumen rencana kerja tahunan	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
22	<i>Roadmap</i> & penerapan ERM	Dokumen roadmap	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
23	Evaluasi hasil kegiatan ERM	Laporan evaluasi, risk register	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
24	Tindak lanjut hasil evaluasi ERM	Notulen rapat, laporan perbaikan	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
25	Pemanfaatan TI untuk ERM	Laporan IT, wawancara staf IT	Primer & Sekunder	Observasi system TI	Moeller, R. R. (2011)
26	Mekanisme pelaporan ERM	SOP pelaporan, wawancara pengguna	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
27	Komunikasi informasi risiko	SOP komunikasi, wawancara	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
28	Pelaporan risiko & integrasi sistem	Laporan ERM & IT	Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
29	Identifikasi risiko klinis & non-klinis	<i>Risk register</i> , laporan insiden	Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
30	Analisis risiko berdasarkan dampak & kemungkinan	Matriks risiko	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
31	Penentuan prioritas risiko	Risk register prioritas	Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
32	Mitigasi risiko	Laporan mitigasi	Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
33	Pembiayaan risiko	Laporan anggaran & realisasi	Primer & Sekunder	Verifikasi dokumen, wawancara	Moeller, R. R. (2011)
34	Integrasi portofolio risiko	Laporan risiko gabungan	Sekunder	Verifikasi dokumen,	Moeller, R. R. (2011)

No	Data yang Dibutuhkan (Parameter/Indikator)	Sumber Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan dan Pengendalian Data	Teori/Referensi
				wawancara	
35	Respons terhadap perubahan signifikan	Notulen rapat, laporan penyesuaian	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
36	Review kinerja & risiko rutin	Laporan monitoring	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
37	Perbaikan berkelanjutan ERM	Dokumen perbaikan	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
38	Audit internal berbasis risiko	Laporan audit internal	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)
39	Tindak lanjut hasil audit risiko	Laporan tindak lanjut	Sekunder	Verifikasi dokumen	Moeller, R. R. (2011)

Sumber: Diolah Peneliti

H. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam, penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif (*interactive model*) sebagaimana dikemukakan oleh Miles, (2014).



Gambar 3.1

Komponen dan analisis data model interaktif

Sumber: Miles, (2014)

Berdasarkan Gambar 3.1, analisis data dilakukan melalui empat langkah utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pertama dalam model analisis interaktif adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara mendalam, penelaahan dokumen-dokumen terkait, serta *focus group discussion* (FGD). Data yang dihasilkan dari berbagai teknik ini sangat bergantung pada kompetensi peneliti dalam menerapkan keterampilan integratif dan interpretatif. Data yang terkumpul pada umumnya bersifat kaya rincian, kompleks, dan menggunakan deskripsi naratif,

sehingga memerlukan interpretasi yang mendalam untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap selanjutnya adalah kondensasi data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen menghasilkan informasi yang banyak, beragam, dan kompleks. Data tersebut dapat bersifat serupa, sejenis, berbeda, atau bahkan bertentangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses kategorisasi dan pengelompokan untuk memilih data yang relevan, penting, bermakna, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui proses kondensasi data, gambaran hasil penelitian diharapkan menjadi lebih fokus dan jelas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses kondensasi data dilakukan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel atau gambar sehingga mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Penyajian data ini membantu peneliti dalam menata informasi yang kompleks menjadi struktur yang terorganisir dengan baik.

4. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

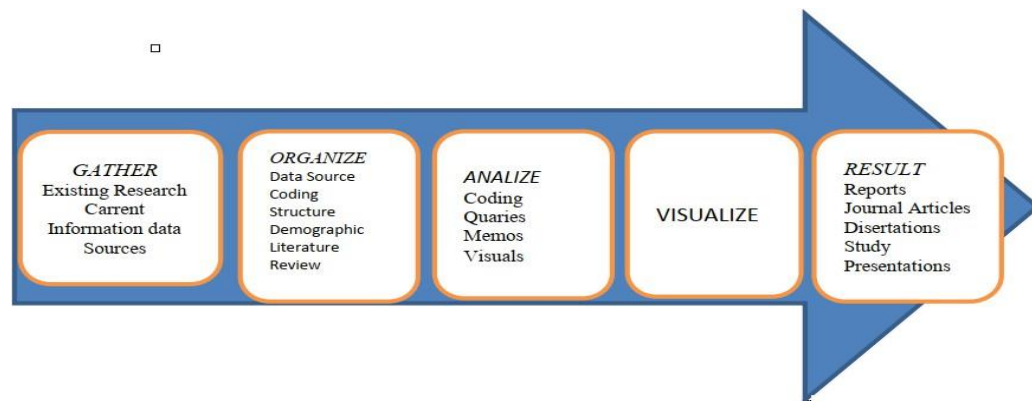
Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data dan informasi yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini diverifikasi dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang belum lengkap, bertentangan, atau meragukan melalui proses triangulasi *data collection*, *data condensation*, dan *data display* yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Verifikasi ini penting untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan menggunakan software NVivo 15. NVivo merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sistem otomasi.

Sumber data internal (*internals*) dalam konteks penelitian ini mencakup seluruh data kualitatif yang dapat dimasukkan ke dalam NVivo, seperti rekaman wawancara, transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, tabel data survei, isi website tertentu, database, dan video. Sementara itu, sumber data eksternal (*externals*) merupakan materi penelitian yang tidak dapat dimasukkan secara langsung ke dalam NVivo, contohnya buku referensi cetak atau jurnal versi cetak.

NVivo 15 memiliki keunggulan dalam mengelola data kualitatif dalam jumlah besar dengan tetap menjaga struktur dan keteraturannya. Variasi data yang dapat diolah melalui NVivo meliputi data wawancara (baik terstruktur maupun tidak terstruktur), hasil observasi, dokumen laporan, media sosial, berita media elektronik, laporan penelitian online, video online atau rekaman video peneliti, serta foto.

Selain itu, NVivo memudahkan peneliti dalam melakukan proses *coding* dan *re-coding* terhadap data yang diperoleh. Hasil pengolahan data menggunakan NVivo dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk visual seperti model diagram dan grafik, yang mendukung analisis hubungan asosiatif baik satu arah maupun simetris. Visualisasi dan analisis data yang dihasilkan melalui NVivo ini sangat membantu peneliti dalam memformulasikan model baru berdasarkan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.



Gambar 3.2

Analisis Kualitatif dengan perangkat lunak (*software*) NVIVO

Sumber: International Seminar *Qualitative Data Analysis with NVivo 12* – QSR

I. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menunjukkan bukti dari empat kriteria utama untuk memastikan kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap temuan penelitian, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Guba & Lincoln, 1989). Pertama, kredibilitas dapat dicapai melalui penggunaan teknik triangulasi data, triangulasi investigator, atau triangulasi teori, guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan benar-benar mewakili fenomena yang diteliti. Selain itu, validasi partisipan atau *member checks* juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan pengalaman dan perspektif para partisipan.

Kedua, transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi yang mendalam dan komprehensif mengenai konteks penelitian, termasuk karakteristik di RSUD Tarakan

Provinsi DKI Jakarta serta proses manajemen risiko yang diterapkan di dalamnya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang serupa.

Ketiga, dependabilitas dijaga melalui dokumentasi yang jelas dan rinci mengenai prosedur pengumpulan dan analisis data. Dengan mendetailkan setiap langkah yang dilakukan selama penelitian, maka penelitian ini dapat direplikasi atau diuji ulang oleh peneliti lain untuk memastikan konsistensi dan stabilitas temuan.

Keempat, konfirmabilitas dapat dipastikan dengan menyediakan audit trail yang mendetail, yang mencakup catatan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Selain itu, refleksi diri oleh peneliti juga penting untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi bias pribadi, sehingga temuan penelitian dapat dipastikan bebas dari pengaruh subjektivitas peneliti.

Dengan menerapkan keempat kriteria *trustworthiness* tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan dapat dipercaya, sehingga memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami penerapan manajemen risiko pada pelayanan publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum RSUD Tarakan

RSUD Tarakan Jakarta merupakan salah satu rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perjalanan kelembagaan RSUD Tarakan menunjukkan transformasi signifikan bermula dari balai pengobatan (1953), berkembang menjadi Puskesmas Kecamatan Gambir (1956) dengan luas bangunan 2.570 m², kemudian meningkat statusnya menjadi RS Kelas C (1987) berlantai 4 dengan 30 tempat tidur berdasarkan SK Menkes 15/1989, dan selanjutnya menjadi RS Kelas B Non-Pendidikan (1997) dengan 153 tempat tidur. Seiring peningkatan kapasitas layanan dan tata kelola, RSUD Tarakan kemudian ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A oleh Kementerian Kesehatan RI pada 30 Juni 2014, sekaligus menjadi rumah sakit rujukan tersier regional di Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai rumah sakit Tipe A, RSUD Tarakan saat ini memiliki kapasitas 450 tempat tidur untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Jakarta dan jejaring rujukan regional. Rumah sakit Tarakan memiliki kapasitas layanan komprehensif yang mencakup 27 layanan spesialis dan 31 layanan sub-spesialis, serta didukung oleh berbagai fasilitas medis berteknologi tinggi, yang mencerminkan keluasan cakupan klinis dan kemampuan penanganan kasus dengan tingkat keparahan (*severity*) lanjut yang tidak dapat ditangani di fasilitas layanan primer maupun sekunder. Dari sisi sumber daya manusia, RSUD Tarakan memiliki 1.240 pegawai yang ditugaskan menangani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS), pasien umum, maupun pasien pengguna asuransi kesehatan non-BPJS, dengan dukungan kompetensi profesi yang tersertifikasi pada unit-unit kritis seperti ICU, NICU, dan lainnya.

Keberadaan rumah sakit Tarakan memiliki nilai strategis dalam sistem pelayanan kesehatan kota besar seperti Jakarta, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis tingkat lanjut dan meningkatnya kompleksitas penyakit akibat perubahan gaya hidup maupun dinamika demografis.

Pelayanan yang diselenggarakan RSUD Tarakan mencakup layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, layanan intensif, serta berbagai bentuk pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, dan rehabilitasi

medik. Instalasi Gawat Darurat (IGD) berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi kasus-kasus emergensi, dengan sistem triase yang memastikan penanganan sesuai tingkat kegawatdaruratan. Sementara itu, pelayanan rawat jalan menghimpun berbagai klinik spesialis dan subspecialis, termasuk jantung, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, bedah digestif, bedah onkologi, ortopedi, urologi, neurologi, THT, mata, kulit dan kelamin, hingga psikiatri. Ketersediaan layanan tersebut menunjukkan peran RSUD Tarakan sebagai pusat rujukan bagi kasus-kasus kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin.

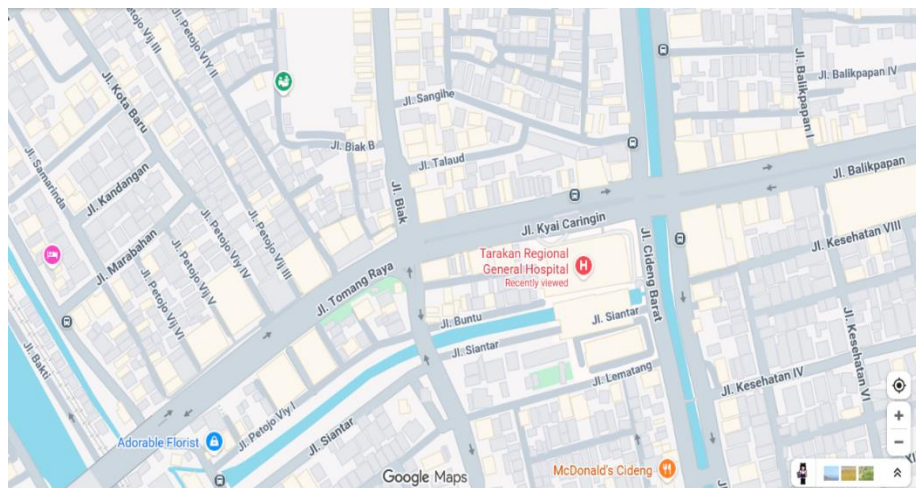
Selain layanan dasar, RSUD Tarakan juga mengembangkan sejumlah layanan unggulan seperti Jantung Terpadu, Stroke Center, Onkologi Terpadu, Burn Center, layanan Urologi–Nefrologi, serta layanan tumbuh kembang anak dan geriatri. Pengembangan layanan unggulan ini menjadi bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan sekaligus respons terhadap kebutuhan spesifik masyarakat urban. Layanan intensif seperti ICU, ICCU, NICU, dan PICU juga memperkuat kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien kritis dan berisiko tinggi, yang merupakan salah satu indikator penting kualitas layanan tersier.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, RSUD Tarakan bukan hanya berfungsi sebagai pusat layanan kuratif, tetapi juga sebagai institusi pendidikan, penelitian, dan inovasi pelayanan publik. Keberhasilan memperoleh akreditasi tingkat paripurna dan berbagai penghargaan pelayanan publik menunjukkan komitmen rumah sakit terhadap mutu, keselamatan pasien, dan tata kelola pelayanan yang baik. Hal ini penting mengingat tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang semakin tinggi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan transformasi sistem kesehatan nasional.

Dengan kompleksitas layanan, luasnya cakupan pelayanan, serta peran strategis RSUD Tarakan sebagai rumah sakit rujukan provinsi, berbagai aspek penyelenggaraan pelayanannya menjadi relevan untuk dikaji dalam penelitian. Baik dalam konteks mutu layanan, keselamatan pasien, manajemen pelayanan, efektivitas sistem rujukan, maupun pencapaian outcome klinis, RSUD Tarakan menyediakan kerangka empiris yang kaya untuk dianalisis. Oleh karena itu, memahami karakteristik dan struktur pelayanan rumah sakit ini menjadi dasar penting dalam menyusun kajian ilmiah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan sistem pelayanan rumah sakit.



Gambar 4.1
Gedung RSUD Tarakan
Sumber: Buku Profil RSUD Tarakan



Gambar 4.2
Lokasi RSUD Tarakan
Sumber: Google maps

a. Visi & Misi RSUD Tarakan

Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan dengan Pelayanan Terbaik Berstandar Internasional.

Misi:

- 1) Menjadi Rumah Sakit rujukan nasional yang modern dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan prima untuk seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemandirian rumah sakit di segala bidang.
- 4) Memiliki SDM yang berkualitas melalui penerapan budaya kerja sesuai dengan

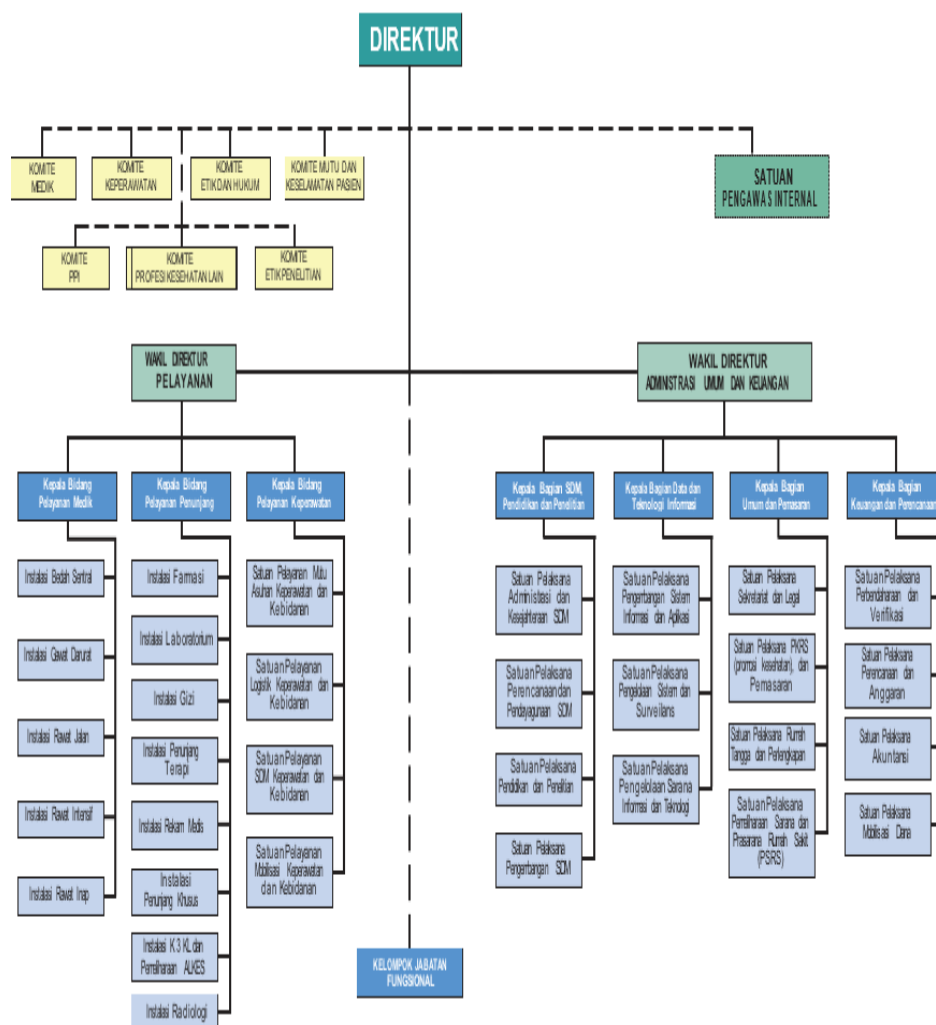
perkembangan IPTEK dan IMTAQ serta memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat

- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang optimal.
- 6) Mewujudkan Rumah Sakit Pendidikan yang berkualitas menuju *Academic Health System* (AHS)

Motto:

Rumah Sakit Tarakan sebagai rumah sakit rujukan kelas A di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi dan tujuan organisasi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh segenap manajemen maupun karyawan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Motto RSUD Tarakan adalah “Merawat dengan Empati”

b. Struktur Organisasi RSUD Tarakan



Gambar 4.3

Bagan Struktur Organisasi RSUD Tarakan
Sumber: Buku Profil RSUD Tarakan 2024

Struktur organisasi RSUD Tarakan disusun untuk mendukung tata kelola rumah sakit kelas A yang kompleks dan berorientasi pada mutu pelayanan. Rumah sakit berada di bawah kepemimpinan seorang Direktur yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan layanan, manajemen sumber daya, serta pengendalian mutu dan keselamatan pasien. Di bawah direktur, terdapat unit-unit manajerial seperti Administrasi Umum & Keuangan, Perencanaan, data dan teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi administratif dan strategis dalam pengelolaan rumah sakit.

Pada ranah operasional, struktur organisasi mencakup tiga pilar utama, yaitu Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan, dan Bidang Penunjang Medik. Ketiga bidang ini mengoordinasikan seluruh layanan klinis, tenaga keperawatan, serta unit-unit penunjang diagnostik dan terapeutik seperti laboratorium, radiologi, farmasi, dan rehabilitasi medik. Selain itu, rumah sakit dilengkapi dengan perangkat tata kelola profesional, seperti Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, serta Satuan Pemeriksaan Internal, yang memastikan standar profesi, mutu layanan, dan akuntabilitas organisasi terpenuhi.

Secara keseluruhan, struktur organisasi RSUD Tarakan bersifat hierarkis dan fungsional, dengan pembagian peran yang jelas antara unsur manajemen, pelayanan, dan penunjang, sehingga mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi.

c. Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Tarakan 2022 - 2026

RSUD Tarakan sebagai salah satu BLUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Gubernur serta harus mengedepankan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan bagi seluruh masyarakat.

Sesuai Permendagri nomor 61 tahun 2007, pasal 69, menyatakan bahwa BLUD harus menyusun Renstra Bisnis BLUD yang berisi pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

1) Tujuan dan Sasaran RSB 2022 - 2026

Tujuan strategis RSUD Tarakan sebagai Rumah Sakit kelas A di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menjadi fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan perorangan secara paripurna serta memberikan perawatan kasus- kasus *severity 3* yang sudah tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat primer dan tingkat sekunder.

Persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B yang menyertai status Rumah Sakit Kelas A pada RSUD Tarakan juga menjadi acuan dalam menetapkan tujuan strategis di bidang pendidikan tenaga kesehatan yaitu menjadikan RSUD Tarakan sebagai *benchmark* bagi pelayanan Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran Strategis RSUD Tarakan yang telah dirumuskan melalui peta strategis meliputi:

- a) Inovasi Pendidikan dan Penelitian
- b) Operasional *Excellent*
- c) Pengembangan SIMRS
- d) Peningkatan kompetensi SDM
- e) Peningkatan mutu layanan
- f) Peningkatan *output* layanan
- g) Peningkatan profitabilitas
- h) Peningkatan promosi layanan
- i) Peningkatan inovasi layanan dan pendidikan

2) Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah dirumuskan melalui Peta Strategi, maka disusun Indikator Kinerja Utama atau KPI (*Key Performance Indicator*) sebagai alat ukur dalam pencapaian kinerja beserta PIC (*Person In Charge*) pada tiap-tiap KPI yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja utama RSUD Tarakan

PERSPEK-TIF	KPI	TARGET						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANCIAL (F)	1. <i>Cost Recovery Rate</i> (F1)	45	55	70	85	85	90	100
	2. <i>Cost Reduction</i> (F2)	5	5	5	5	5	5	5
PELANGGAN (P)	1. <i>Market share</i> (P1)	5%	10%	15%	20%	8%	10%	12%
	2. Loyalitas pelanggan (P2)	35%	35%	50%	50%	60%	60%	70%
	3. Kepuasan pelanggan (P3)	> 80	> 80	85	> 85	> 85	> 85	> 85
	4. Profitabilitas pelanggan (P4)	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
BISNIS INTERNAL (B)	Peningkatan inovasi layanan dan Pendidikan (B1)							
	1. Penambahan Jumlah layanan terpadu (B1.1)	9	14	18	21	23	25	27
	2. Penambahan jumlah penelitian mandiri (B1.2)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	1. Cakupan pemasaran (B2.1)	26	30	30	30	30	30	30
		9	14	18	21	23	25	30
	2. Peningkatan kewirausahaan bidang kediklatan (B2.2)	75	150	150	150	150	200	200
		26	30	30	30	30	30	30
		75	100	150	150	150	200	200
	3. Hospital without wall (B2.3)	2%	5%	10%	10%	10%	15%	a. 15%
	4. Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (B2.4)	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
		60%	70%	80%	85%	90%	90%	90%
	5. Penambahan tenaga sesuai kelas A (B2.5)	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
BISNIS INTERNAL (B)	Peningkatan Standar Mutu Pelayanan (B3)							
	1. Akreditasi Nasional dan Internasinal (B3.1)	Verifikasi KARS 2012	Sertifikasi SNARS	Servis Exelent International	Sertifikasi JCI	Sertifikasi JCI	Sertifikasi JCI	Sertifikasi Malcom Baldrige
LEARNING AND GROWTH	Peningkatan dan Kompetensi SDM (L1)							

PERSPEK-TIF	KPI	TARGET						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(L)	1. Peningkatan kompetensi SDM profesional layanan kesehatan(L1.1)	80%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
	2. Peningkatan kompetensi SDM pendidik (L1.2)	75%	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	3. Peningkatan kompetensi SDM peneliti (L1.3)	75%	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %
LEARNING AND GROWTH (L)	Pengembangan SIM RS dan Sarana (L2)							
	1. Pengembangan terintegrasi SIM RS (L2.1)	188	216	244	273	300	350	400
	III. Reward and Recognition							
	Retensi staff (L3.1)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Indeks culture (L3.2)	75%	80%	85%	> 85%	90%	90%	90%

Sumber: Buku Profil RSUD Tarakan 2024

d. Sumber Daya Manusia RSUD Tarakan

Sumber daya manusia merupakan komponen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, terutama pada rumah sakit rujukan kelas A yang memiliki kompleksitas layanan tinggi. RSUD Tarakan Jakarta sebagai salah satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur SDM yang besar dan beragam untuk mendukung fungsi pelayanan kesehatan komprehensif. Berdasarkan Profil RSUD Tarakan tahun 2024, jumlah keseluruhan SDM mencapai 1.133 orang, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan non-medis, dan tenaga non-kesehatan. Komposisi ini menggambarkan kapasitas organisasi yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsi klinis, penunjang, dan manajerial.

Kelompok tenaga medis terdiri dari dokter spesialis, subspesialis, dokter umum, dan dokter gigi yang tersebar di berbagai bidang. Ketersediaan tenaga medis dengan kompetensi beragam merupakan aspek krusial dalam mendukung layanan unggulan RSUD Tarakan, seperti Jantung Terpadu, Stroke Center, Onkologi Terpadu, *Burn Center*, serta layanan urologi–nefrologi. Keberadaan dokter subspesialis juga menunjukkan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan tersier yang berorientasi pada penanganan kasus kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin.

Selain tenaga medis, kelompok tenaga kesehatan lainnya merupakan komponen dengan jumlah terbesar dalam struktur SDM rumah sakit. Kelompok ini mencakup perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, analis laboratorium, radiografer, fisioterapis, nutrisisionis, perekam medis, dan profesi kesehatan lainnya. Peran tenaga kesehatan ini sangat penting dalam memastikan kontinuitas pelayanan, mulai dari perawatan intensif, pelayanan rawat jalan, hingga pelayanan rawat inap. Pada konteks rumah sakit kelas A, dominasi jumlah perawat dan tenaga kesehatan profesional menjadi indikator penting tersedianya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, mutu perawatan, dan efektivitas layanan.

Sementara itu, tenaga non-kesehatan juga memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan operasional rumah sakit. Kelompok ini terdiri dari staf administrasi, keuangan, IT dan pengelola SIMRS, unit logistik, sarana-prasarana, keamanan, kebersihan, serta tenaga kontrak lainnya. Tanpa dukungan kelompok ini, efektivitas pelayanan klinis tidak dapat tercapai secara optimal.

karena fungsi manajemen, operasional, dan infrastruktur merupakan prasyarat utama dalam memperkuat kualitas pelayanan rumah sakit.

Secara keseluruhan, struktur SDM RSUD Tarakan mencerminkan organisasi kesehatan dengan tingkat kompleksitas tinggi, yang ditopang oleh kombinasi tenaga profesional medis dan non-medis yang proporsional. Jumlah SDM yang besar dan keragaman kompetensi menunjukkan komitmen rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan rumah sakit kelas A sesuai regulasi nasional. Dalam konteks penelitian, karakteristik SDM yang demikian dapat menjadi faktor penting dalam analisis terkait mutu layanan, beban kerja, keselamatan pasien, implementasi kebijakan manajemen SDM, maupun efektivitas sistem pelayanan rumah sakit.

Tabel 4.2
Sumber Daya Manusia RSUD Tarakan

No.	Sumber Daya Manusia	L	P	Jumlah
1.	Apoteker	5	11	16
2.	Asisten Apoteker	10	26	36
3.	Asisten Penata Anestesi	5	6	11
4.	Audiolog	1		1
5.	Bidan		26	26
6.	Dokter Gigi Spesialis		5	5
7.	Dokter Gigi Umum		4	4
8.	Dokter Spesialis	29	28	57
9.	Dokter Subspesialis	21	13	34
10.	Dokter Umum	21	35	56
11.	Epidemiolog Kesehatan		1	1
12.	Fisikawan Medis	1	1	2
13.	Fisioterapi	6	4	10
14.	Kesehatan Lingkungan	2	2	4
15.	Medis	1	2	3
16.	Non Kesehatan	107	84	191
17.	Nutrisi	2	11	13
18.	Okupasi Terapi	1		1
19.	Penata Anestesi	7	2	9
20.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1		1
21.	Penata Laksana Barang		1	1
22.	Perawat	173	445	618
23.	Perawat & Bidan	9	22	31
24.	Petugas Kesehatan Lainnya	3		3
25.	Pranata Komputer Ahli Pertama		1	1
26.	Pranata Labkes	18	17	35
27.	Psikologi Klinis	1	1	2
28.	Radiografer	13	8	21

No.	Sumber Daya Manusia	L	P	Jumlah
29.	Refraksionis Optisi	2		2
30.	Rekam Medik	2	12	14
31.	Sanitasi		1	1
32.	Struktural	6	4	10
33.	Teknik Elektromedik	2		2
34.	Teknik Kardiovaskuler	1	1	2
35.	Tekniker Gigi	1		1
36.	Teknisi Transfusi Darah	7	3	10
37.	Terapi Wicara	1	1	2
38.	Terapis Gigi dan Mulut		3	3
39.	Grand Total	459	781	1.240

Sumber: Data SDM RSUD Tarakan

e. Manajemen Risiko

Kegiatan manajemen risiko di rumah sakit Tarakan tahun 2024 meliputi:

- 1) Manajemen Risiko Sasaran Keselamatan Pasien
- 2) Manajemen Risiko Fasilitas Lingkungan
 - a) Keselamatan dan Keamanan
 - b) Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbahnya
 - c) Penanggulangan Bencana (Emergensi)
 - d) Proteksi Kebakaran
 - e) Pemeliharaan Peralatan Medis (Pemilihan, Pemeliharaan dan Penggunaan Teknologi)
 - f) Sistem Penunjang atau Utilisasi (pemeliharaan system listrik, air dan system penunjang lainnya)
- 3) Manajemen Risiko Pengendalian Infeksi Nosokomial:
 - a) HAIs
 - b) Tindakan Invasif
 - c) Laboratorium
 - d) Perawatan
 - e) Kamar Operasi
 - f) *Cleaning*
 - g) Sterilisasi alat
 - h) Manajemen linen
 - i) Manajemen sampah
 - j) Penyediaan Makanan
 - k) Kamar Jenazah

- l) Pelayanan Farmasi
- m) Radiologi
- n) Pelayanan *Critical care*
- 4) Manajemen Risiko Pola Manajemen Keuangan BLUD Rumah Sakit
 - a) Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Manajemen Rekam Medis
 - c) Manajemen Logistik
 - d) Manajemen Keuangan
- 5) Manajemen Risiko Pelaksanaan Etik dan Hukum
 - a) Area Manajemen
 - (1) Pantauan Kerahasiaan Data dan Rekam Medis
 - (2) Pantauan Konflik Finansial Pasien ke Rumah Sakit
 - (3) Pantauan Pelayanan dengan Media Massa
 - b) Area Pelayanan
 - (1) Pantauan Tentang Penelitian
 - (2) Pantauan Kecelakaan Kerja
 - (3) Pantauan Pelayanan Terlantar
 - (4) Pantauan Pelayanan Sesuai dengan Kompetensi
 - (5) Pantauan Pemberian Resume Medis pada Pasien Pulang
 - (6) Pantauan Informed Consent
 - (7) Pantauan Audit Klinis Keperawatan
 - (8) Pantauan Audit Medis
 - (9) Pantauan Etika Pelayanan Anak
 - (10) Pantauan Komunikasi Efektif antar PPA di Unit Pelayanan
 - (11) Pantauan Perawatan Medis Kasus Sulit
 - (12) Pantauan Tentang Hak dan Kewajiban Pasien
 - (13) Pantauan Discharge Planning
 - (14) Pantauan Second Opinion
 - (15) Pantauan Code Blue
 - (16) Pantuan Pelayanan Pasien Terminal
 - (17) Pantauan Pemberian Surat Sehat
- 6) Manajemen Risiko Penyakit infeksi Emerging
 - a) Melakukan identifikasi risiko di masing-masing instalasi
 - b) Perhitungan skoring/ pembobotan risiko

- c) Pengendalian risiko yang sudah dilakukan dan yang masih di butuhkan
- d) Daftar urutan risiko/ register risiko
- e) Membuat *Plan of Action* pengendalian risiko
- f) Pelaksanaan *Plan of Action* pengendalian risiko
- g) Melakukan audit pelaksanaan pengendalian risiko
- h) Mempresentasikan temuan hasil audit pengendalian risiko
- i) Memberikan umpan balik untuk melakukan PDCA, RCA, FMEA

Tabel 4.3

Indikator Sasaran Manajemen risiko

Indikator	Target
1. Efektivitas pengendalian risiko untuk <i>High Risk</i> K3, ICRA, Infeksi Nosokomial dan Risiko Manajemen	100%
2. <i>Investigasi dan follow up action</i> Insiden/accident	100 %
3. Compliance rate terhadap peraturan perundang- undangan	100%
4. Simulasi keadaan gawat darurat terlaksana sesuai SOP	100%
5. Insiden/ <i>accident fatal</i>	0%

Sumber: Program Kerja Manajemen risiko 2024

2. Daftar Informan

Dalam pengumpulan data penelitian di lapangan, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* dalam menentukan informan untuk metode wawancara mendalam. Dengan demikian diharapkan mendapatkan data yang komprehensif dan valid. Para informan dari awal ditentukan dari berbagai kalangan, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pengawas, Direksi dan Manajemen RSUD Tarakan. Tabel di bawah ini menggambarkan para informan yang sudah diwawancarai.

Tabel 4.4

Daftar Informan wawancara

No	Jabatan	Inisial
1.	Kasubdit BLUD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	WS
2.	Ketua Tim Kerja Mutu Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan	IL
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta	NR
4.	Dewan Pengawas RSUD Tarakan	YE
5.	Direktur RSUD Tarakan	WP
6.	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Tarakan	NK
7.	Wakil Direktur Administrasi Umum & Keuangan RSUD Tarakan	SH
8.	Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	YD
9.	Sub Komite Manajemen Risiko	FN

No	Jabatan	Inisial
10.	Sekretaris Komite Mutu	NL
11.	Kepala Bagian SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUD Tarakan	FK
12.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Tarakan	NS
13.	Satuan Pengawas Internal RSUD Tarakan	NE
14.	Komite PPI RSUD Tarakan	DD
15.	Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Tarakan	BR
16.	Kepala Instalasi Farmasi RSUD Tarakan	IS
17.	Koordinator Instalasi Rawat Inap	RM
18.	Kesekretariatan dan Legal	IB
19.	Koordinator Instalasi K3KL	FS

Tabel 4.5
Daftar Focus Group Discussion (FGD)

No	Jabatan	Inisial
1.	Ka.Instalasi Gizi RSUD Tarakan	TH
2.	Sekretaris Komite Medik KSP Mobilisasi Dana	LH
3.	Humas RSUD Tarakan	GR
4.	KSP PSIT	FW
5.	Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan	SS
6.	Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi	RO
7.	Koordinator Instalasi Gawat Darurat	ED

B. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang telah ditranskrip, kemudian dilakukan analisa data menggunakan NVivo 15. Sebelumnya di buat kodenya terlebih dahulu meliputi dimensi dan indikator-indikator. Kemudian transkrip wawancara di impor ke dalam Nvivo 15 dan dilakukan pengkodean sesuai tema dalam Dimensi / indikator.

Adapun Dimensi yang dianalisa meliputi : Gambaran umum penerapan ERM di RSUD Tarakan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Tata Kelola dan Budaya, Strategi dan Sasaran, Kerangka kerja, Informasi dan Komunikasi, *Performance*, *Review* dan Revisi dan Audit internal.

1. Gambaran umum Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan

Tabel 4.6
Triangulasi Data
Gambaran Penerapan ERM di RSUD Tarakan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Pemahaman ERM</i>	Pemahaman ERM di RSUD

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kalau enterprise risk management itu yang bisa saya pahami, kerangka manajemen risiko. Sebenarnya, kalau saya lihat dari Pergub 122 yang pertama 2020, itu pendekatannya pergub, itu sudah pakai enterprise, bagaimana definisi, bagaimana memproses identifikasi, analisa itu, rasanya kerangkanya itu sudah dipakai.</i> <i>Kemarin sempat dibahas di Inspektorat ini, tuh luar biasa. Inspektorat itu memang mulai mendampingi secara lebih intensif. Kalau kita bilang, setelah mungkin pada saat BPK audit turun, kemudian mereka mendampingi bagaimana permasalahan di rumah sakit. Ada satu titik yang mungkin mereka menganggap, oh kayaknya rumah sakit perlu didampingi nih. Ketika audit BPK yang diharuskan kita menutup temuan BPK, itu ternyata masalah klinis. Dan kita, dengan alasan klinis, kita menyampaikan kenapa itu terjadi. Ya, secara pendekatan klinis, mereka nyerah. (NK)</i> <i>Jenis risiko nya di kelola dan diorganisasi, terkoordinir, terintegrasi, mempertimbangkan semua agar tujuan organisasi tercapai. Risk management menjadi darah sehari-hari. (WP)</i> <i>Resiko residual atau resiko sisa dan Resiko inherent pernah pernah dengar: belum pernah (TH, LH,GR,FW, SS,IF,RO,EK)</i> <i>Kalau yang ERM ini yang saya baru tahu kalau yang manris ini memang saya sudah sedikit paham, tapi kalau yang ERM belum. (YE)</i> <i>Perbedaan antara manajemen resiko dan enterprise risk management: belum tahu (YD, FN)</i> <i>Pernah dengar, Enterprise itu maksudnya risiko organisasi, jadi maksudnya biar tercapainya tujuan organisasi tersebut. (RM)</i>	Tarakan masih bersifat operasional dan parsial, dengan gap antara kerangka normatif regulasi dan pemahaman pelaksana, sehingga ERM lebih dipandang sebagai kewajiban administratif daripada instrumen tata kelola strategis. Penerapan ERM cenderung compliance-driven dan prosedural; meskipun telah terintegrasi dalam dokumen dan forum formal, implementasinya masih terbatas pada level teknis dan belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen puncak. Tantangan utama bersifat struktural, kultural, dan sistemik, terutama pada

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Risiko itu sebetulnya potensi, kalau insiden itu yang sudah terjadi, dua hal yang berbeda ya. (IB)</i> <i>Pernah dengar ERM (Enterprise Risk Management)</i> <i>Belum (IB)</i> <i>Ada juga insiden; ada juga risiko. (DD, BR, FS)</i> <i>Biasanya bukan. Kalau masalah kesalahan sampel, itu kan sudah kita tahu, itu risiko yang dibuat. di lab itu sudah pasti masuk ke risk, itu risiko. Cuma kalau insiden yang non-klinis, kalau di lab, itu sering masuk. Ada banyak petugas-petugas, vendor-vendor untuk perbaikan alat lab, yang tetap risiko untuk ada barang-barang di lab. Itu, ini masalah keamanan risiko yang insiden; misalnya, pernah ada kehilangan, misalnya barang barang itu yang kami masukkan langsung ke risk register (DD, BR, FS)</i> Pendekatan Penerapan MR <i>Kalau kami dari komite medik kan untuk manajemen komite medik itu adalah SPK dan RKK. Karena itu menjadi kunci ya, untuk dokter A dapat melakukan kewenangan komunis apa saja yang memang dia. dapat melakukan secara mandiri. Ataukah dia yang memang tidak ada kebiasaan itu, hanya di supervisi seperti itu: Nanti setelah RKK, kemudian diterbitkan SPK Komite Medik dalam menerapkan manajemen risiko. (LH)</i> <i>Sedangkan untuk faktor risiko, ada apabila jadi, kan kita dapat data, misalnya, risikonya ada, kalau misalnya.</i> <i>dari hasil morning report atau ada keluhan dari pasien, kan kita channel ini keluhannya sama, kan jadi kami apabila ada keluhan-keluhan baik dapat dari manapun, itu akan dilakukan audit medis. (LH)</i> <i>RSUD kelas A, milik Pemprov DKI, kami menggunakan Pergub 122 tahun 2020</i>	kapasitas implementasi, integrasi sistem informasi, dan budaya risiko, yang menunjukkan ERM belum berfungsi optimal sebagai instrumen tata kelola publik yang adaptif dan berkelanjutan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>penerapan manris di Pemprop DKI Jakarta dan menggunakan juga Permenkes PMK 25 tahun 2019. (WP)</i> <i>Pendekatan yang saya lihat dari teman-teman itu adalah mulai memilah dari masing-masing bidang terkait dengan risiko yang paling tinggi nilainya. Sehingga dari situlah mereka akan membuat nilai, membuat level-level terkait dengan nilai yang tertinggi. Nanti akan diajukan sebagai manajemen risiko di bidangnya masing-masing seperti itu. (YE)</i> <i>Awalnya Tahun 2023, rumah sakit dengan Standar akreditasi Tahun 2022. Tetapi, terakhir ini yang saya terima dari rumah sakit memakai Pergub 122 Tahun 2020. (YE)</i> <i>Di Tarakan itu menurut versi ISO atau COSO : Yang ISO31000 (YE)</i> <i>Jadi kalau yang saya lihat, masih reaktif. Terus Terang berdasarkan informasi yang kami dapat pada saat pelatihan PMKP dan Manris, mereka itu tidak didampingi oleh manajemen pada saat menentukan mana prioritas yang akan diambil. Level Kabid malah justru tidak ikut. jadi hanya staf dari unit nya. kadang-kadang kepala ada yang hadir, Kalau dari komite mutu atau komite manajemen risikonya kadang-kadang hadir kadang tidak. Informasi yang kami dapat pada saat pelatihan, mereka sampai bilang, 'Ini sebetulnya rumah sakit, rumah sakitnya siapa karena kami harus menentukan sendiri : keterlibatan manajemennya belum ada. (YE)</i> <i>Sebetulnya sudah masuk dalam strategi, hanya saja pada pelaksanaannya tidak seperti yang di tentukan, hanya secara administrasi tertulis saja, tapi pelaksanaannya belum secara benar (YE)</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Ada. itu nanti dilaporkan ke Subkom Manris. Nah, pendekatannya sesuai dengan template (NS)</i> <i>Kita awalnya ikut Kemkes yang akreditasi, sudah berjalan, kemudian berkenaan dengan pergub, waktu itu direktur kami memutuskan untuk ikut pergub. (YD,FN)</i> <i>Kalau manris kita menggunakan pergub DKI nomor 122 tahun 2020 : sejak tahun 2022-2023. (NE)</i> <i>Kalau seingat saya waktu akreditasi itu kita pakai yang KEMKES (NE)</i> <i>Akhirnya, Ketika komite mutu dan SPI punya area kerja yang sudah ada tetapi harus mempunyai forum-forum komunikasi yang terintegrasi..(NK)</i> <i>Pertama mungkin pelatihan-pelatihan secara rutin, pembinaan dari Inspektorat, ORD, dari supra system kami dari BPKP juga dari nara sumber sumber, Kemudian sense of belonging, rasa memiliki RS belum merata, komitmen level middle ke bawah di operasional harus terus menerus diingatkan bahwa budaya keselamatan, budaya risiko-risiko yang harus dipetakan dan ditangani agar potensial kejadian harus terus disampaikan. kemudian komunikasi antar profesi, antar unit kerja, pelayanan professional, masih ada ego-ego dari unit menguatkan dengan SPO-SPO, tapi masih belum sepenuhnya dilaksanakan, perlu refresh untuk pelaksanaanya. (WP)</i> Tantangan <i>menjadi tantangan saat ini terkait system informasi, kita perlu adanya integrasi antar unit, dan penyajian data lebih akurat untuk penyajian data, salah satunya system terintegrasi (WP)</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Hanya tidak tahu kenapa mentoknya di mana, sehingga di pelaporan-pelaporan itu tidak sampai ke Dewas. (YE)</i> <i>yang pertama tantangan itu adalah kebijakan. Ya, kebijakan kita itu banyak yang ibaratnya sudah out of date. Contohnya, peraturan non PNS : Pergub 72 tahun 2007 sampai sekarang 2025, sudah enggak up to date lagi. Pergub 72 itu menjelaskan bahwa pegawai itu non PNS. Kemudian juga ada berbunyi profesional Tapi yang non PNS itu enggak dijelaskan.. Profesional itu siapa? Itu kita enggak tahu. Apakah itu dokter? Apakah itu nakes? Jadi non PNS gelondongan aja. dan Pergub 72 20027 mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja 13. Nah disitu, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya adalah untuk korporasi. Satu sisi, kita adalah BLUD, Badan Layanan Umum, di mana kita tidak mengharapkan profit, beda dengan korporasi ada profit. Sehingga kesulitan kami, di saat ada pegawai non PNS minta pesangon, dia nuntut harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (FK)</i> <i>tantangannya ya itu kan SPI turunan dari atas,. Kalau kita kan ngumpulin dari bawah. Nah, pas di tengahnya itu kadang-kadang, menurut atas, ini terlalu receh gitu ya, terlalu kecil resikonya. Sedangkan dari bawah ini sebenarnya penting. Jadi akhirnya yang manajemen tengahnya,. (YD,FN)</i> <i>Tantangannya memang dari IT kita belum ada aplikasi manris, karena aplikasi yang kita tahu yang sekarang ada itu dari Inspektorat, SIPERISAI namanya. Dan itu miliknya milik Pemprop DKI milik inspektorat (NE)</i>	
Observasi	Pemahaman ERM Pemahaman aktor masih tidak merata dan cenderung terbatas pada risiko klinis atau insiden, belum pada ERM sebagai kerangka terintegrasi pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan Penerapan ERM	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	ERM diterapkan secara sektoral dan reaktif, didominasi level operasional, dengan keterlibatan pimpinan yang terbatas dan dipicu oleh tuntutan audit atau akreditasi. Tantangan Penerapan ERM Tantangan utama meliputi keterbatasan literasi risiko SDM, lemahnya peran pimpinan, ego sektoral, komunikasi lintas unit yang belum optimal, serta sistem informasi yang belum terintegrasi.	
Dokumentasi	Pergub DKI Jakarta No. 122 Tahun 2020 dan dokumen RSUD Tarakan telah mengadopsi konsep ERM dan membentuk struktur formal melalui peta dan profil risiko. Tahapan ERM telah ditetapkan dan disosialisasikan lintas unit, namun kebijakan dan SOP belum sepenuhnya mutakhir serta belum didukung insentif, integrasi sistem informasi, dan pelaporan risiko hingga Dewan Pengawas.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi data menunjukkan bahwa ERM di RSUD Tarakan telah didukung kebijakan dan perangkat formal, namun belum berfungsi sebagai instrumen tata kelola risiko yang terintegrasi dan strategis. Pemahaman aktor masih dominan operasional, sehingga ERM dipersepsikan sebagai kewajiban administratif dan pengelolaan risiko unit, bukan kerangka *enterprise-wide* yang terkait dengan tujuan pelayanan publik. Implementasi yang ada bersifat *compliance-driven* dan kurang terhubung dengan pengambilan keputusan strategis pimpinan. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas dan literasi risiko SDM, lemahnya kepemimpinan strategis, fragmentasi lintas unit, serta sistem informasi yang belum terintegrasi, yang menegaskan adanya kesenjangan antara desain normatif ERM dan praktik tata kelola pelayanan publik.

b. Faktor Pendukung

Tabel 4.7
Triangulasi data Faktor Pendukung

Teknik Pengumpulan Dara	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Faktor pendukung nomor satu saya rasakan hanya puncak pimpinan yang jadi role model, (NK)</i> <i>bagaimana setiap Lini, setiap level, setiap lini itu punya Budaya risiko, itu tidak bisa muncul begitu saja, memang harus turun. (NK)</i> <i>dukungan komitmen pimpinan itu ketika membagi leadernya (NK)</i> <i>butuh support dan komitmennya untuk dibantu menangani manajemen resiko. (TH, LH, RO, GR, SS, FW)</i> <i>Komite Medik juga disupport, kami disupport dengan pendukungannya dan juga dari komitemannya, (LH)</i> <i>komitmen, untuk manajerial sangat komitmen terhadap penerapan manris ini, komitmen kami berbudaya dan mindset-nya budaya sadar risiko, pada waktu pengambilan keputusan, perbaikan-perbaikan, merencanakan anggaran, renstra berpikirnya dari konsep manris. (WP)</i> <i>Sebetulnya faktor pendukungnya ada, dan pada saat itu kami sudah menginformasikan kepada Komite Mutu untuk segera mengirimkan laporan tersebut. Tapi sampai sekarang, belum ada (YE)</i> <i>Pimpinan sangat mendukung, ya. (NS)</i> <i>Pendukungnya, SDM kita, ada ASN, dan non-ASN. Semua itu adalah kekuatan kita, itu bisa memotret tentang identifikasi risiko, atau dari segala macam sudut pandang mereka (FK)</i> <i>pendukung berikutnya bahwa tingkat dari pendidikan dan juga profesinya. juga</i>	Komitmen manajemen puncak dan dukungan regulasi menjadi fondasi utama penerapan ERM, mendorong penerimaan organisasi dan keberlanjutan kebijakan. Budaya risiko dan integrasi ERM dalam proses manajerial mulai terbentuk, namun masih bergantung pada arahan pimpinan dan forum formal, dengan konsistensi implementasi dan pelaporan risiko sebagai tantangan utama. SDM multidisiplin dan SPO mendukung pengendalian risiko, tetapi penguatan kapasitas tetap diperlukan untuk meningkatkan

Teknik Pengumpulan Dara	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>macam-macam sehingga identifikasinya juga akan macam-macam, ada dari keperawatan, ada dari umum, ada segala macam. Itu mungkin faktor sebagai kekuatan. Selain itu, kualifikasi pendidikan, itu kan sangat menentukan juga pola pikirnya. Kalau, kualitas kita secara umum itu sebagian besar masih kualifikasi pendidikan perawat, Nakes lain banyakkkan D3. Karena kita kelas A gitu ya. (FK)</i> <i>menurut saya sih pimpinan itu sangat mendukung waktu itu. Karena kalau kita mau dibawah kan kita bingung yang mana. Apalagi detail teknisnya kan yang dibuat kotak-kotak itu. Pemilihan cakranya itu kan beda-beda. Setelah dijelaskan, ya waktu itu pemimpin, ya udah kita ikut ini. Jadi pendukungnya dari pimpinan, ya. (YD)</i> <i>khususnya pada risiko hukum, sebetulnya satu adalah regulasi jadi regulasi yang dipatuhi oleh para tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Jadi saling terkait, ketika ada regulasi dan itu dipatuhi, otomatis risiko yang tadinya mungkin ada atau berpotensi, otomatis bisa diminimalisir atau mungkin bisa juga hilang (IB)</i> <i>komitmen pimpinan itu mendukung sekali, dengan adanya manajemen risiko ini. Jadi dalam bentuk membuat regulasi. membuat regulasi di WBK. (NE)</i> <i>kita sudah memilih apa saja posisi risiko yang bisa terjadi terhadap masyarakat pengguna rumah sakit dengan SOP SOP ini. (DD)</i> <i>Untuk pendukung dari manajemen risiko, sama seperti yang terkait untuk kalau kita komunikasinya baik dan personel-personelnya baik, itu akan mendukung dengan terus, sehingga tidak ada risiko di lab. (BR)</i>	maturitas ERM.
Observasi	Komitmen & Role Model Pimpinan	

Teknik Pengumpulan Dara	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Terlihat kehadiran Direktur/Wadir dalam rapat sosialisasi, pemantauan risiko, dan evaluasi mutu. Dukungan & Komitmen Pimpinan Koordinasi pimpinan dengan komite dan unit terlihat dalam forum rapat. Komitmen Manajemen (Lintas Level) Manajer unit terlibat dalam identifikasi dan pemetaan risiko Komunikasi Rapat rutin dan koordinasi lintas unit berlangsung Laporan ke Pimpinan dan Dewas Tidak semua siklus pelaporan terlihat berkelanjutan Regulasi Kepatuhan prosedural terlihat pada aktivitas pelayanan SPO SPO dijadikan rujukan operasional di uni SDM Keterlibatan multidisiplin dalam forum risiko Kualifikasi Pendidikan Pemahaman risiko tidak seragam antar staf	
Dokumen	SK Direktur tentang Struktur Manajemen Risiko Tahun 2023; notulen rapat penerapan manajemen risiko Materi sosialisasi manajemen risiko dan laporan PMKP. SK, Renstra, dan dokumen program kerja Program Kerja Manajemen Risiko 2020; Renstra 2023–2026. Undangan, notulen rapat, dan materi sosialisasi manajemen risiko. Laporan PMKP dan format pelaporan risiko SK Direktur, regulasi WBK, dan kebijakan internal. Dokumen SPO pelayanan dan manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko. Data SDM dan dokumen perencanaan pengembangan SDM.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi menunjukkan konsistensi antara persepsi informan, praktik lapangan, dan dokumen terkait faktor pendukung ERM di RSUD Tarakan. Komitmen pimpinan, didukung regulasi dan struktur formal, menjadi faktor dominan yang memberi legitimasi kelembagaan. Instrumen teknis, forum komunikasi, dan SDM multidisiplin telah tersedia, meski konsistensi implementasi dan kapasitas SDM masih bervariasi. Secara keseluruhan, fondasi ERM telah kuat, namun kematangan penerapannya bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan internalisasi praktik risiko dalam kerja sehari-hari.

c. Faktor Penghambat

Tabel 4.8
Triangulasi data Faktor Penghambat

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Belum adanya sistem yang terbentuk dalam melakukan atau jadi kebiasaan di dalam pekerjaan sehari-hari sehingga belum menjadi sebuah budaya. (TH)</i> <i>Belum adanya pemahaman tentang manajemen risiko (TH)</i> pemahaman dari teman teman di operasional, mungkin dari manajerial yang memegang kebijakan sudah sering terpapar dengan manris. Kemudian masalah budaya keselamatan pasien, budaya memetakan segala sesuatu baik yang sudah dan sebelum kejadian terutama sudah memetakan risiko tersebut harus, itu di lapangan harus lebih ditingkatkan. Harus nya no blaming culture, apabila ada beberapa yang masih bila melakukan pengaduan atau keterbukaan, respons masih belum sesuai yang diinginkan dalam konsep manris ini. (WP) <i>pemahaman kita sebagai staf di rumah sakit ini terkait manris. Apalagi manris ini mungkin bagi teman-teman juga hal yang baru yang sebelumnya tidak terpapar, tidak terinformasi (NE)</i> <i>awalnya mungkin penghambat dulu karena untuk, memahami apalagi tadi di tahun</i>	ERM belum terinternalisasi sebagai budaya organisasi dan masih bersifat compliance-driven. Kesenjangan kapasitas SDM, lemahnya fungsi pengendalian, dan koordinasi lintas unit menyebabkan ERM berjalan silo, data risiko berkualitas rendah, serta siklus ERM tidak berkelanjutan. Selain itu, ERM belum terintegrasi dengan alur klinis, perspektif pengguna layanan, dan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	2000, mungkin sebelumnya juga terkait Permenkes, apalagi kita mau akreditasi. Tahun 2023-2024, penilaian dari BPKP, kemudian dari Biro ORB. Kita harus menuju ke WBK WBBM. ada SPIP dari borang-borang. Jadi, semua memang terkait mulai dari akreditasi, kemudian dinilai WBK WBBM. Kemudian, harus merencanakan, Renstra itu juga harus berbasis risiko. (NE) dalam melaksanakan penanganan kemudian pemantauan itu yang menjadi sedikit penghambat, karena kita harus tetap konsisten terus karena siklusnya berlanjut terus. (NE) Bagian pengawasan pengendalian, Ketika peran-peran pengawasan pengendalian masih kendor yang menjadi faktor penghambatnya (NK) hambatan ketika SPI belum all out. Karena SPI bekerjanya versi PERGUB, Administratif, Kemudian pendekatan bagaimana menilai nilai level, prioritas, ini tentunya akan berbeda dengan komite mutu yang biasa klinis. (NK) K3 itu sering menghadapi hambatan. Misalnya untuk risiko kepatuhan yang paling sering dan susah untuk kita terapkan. karena terkait dengan unit-unit. (FS) pada saat kasus medis, misalnya pemberian obat terlambat, terus diagnosa terlambat, bisa terjadi dokternya telat visit, telat terinfo (RM) teman-teman disini belum mau untuk melaporkan, kadang2 masih takut melaporkan.. walaupun sudah ada sosialisasi . Masih ada beberapa yang kurang paham, masih agak sulit.(SS) tidak semuanya bisa kita adopt tapi kita berjalan. (DD)	pengelolaan risiko eksternal, sehingga pendekatan manajemen risiko belum holistik.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>masyarakat ini bukan hanya dari kalangan yang terdidik. Jadi, mulai dari tingkat pendidikannya yang cukup baik sampai terendah, itu bervariasi cara kita menyikapinya. (DD)</i> <i>kolaborasi dengan unit yang lain... kami bingung kalau kita mau sama-sama perbaiki, kalau kita mau audit dimulai dari mitigasi dulu, kita agak kesulitan karena berbeda lintas unitnya. Itu memang hambatan yang kami hadapi. (FS)</i> <i>manajemen risiko itu lintas sektoral, beda unit, bukan hanya RSUD saja, tapi harus ke unit yang lain, bisa Dukcapil atau dinas sosial, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama. (LH)</i> <i>Yang belum terintegratif adalah dengan lintas sektoral misalnya Dukcapil dan Dinas sosial. Jadi kami manajemen risiko di mobilisasi dana adalah orang terlantar, itu kan belum punya jaminan sedangkan kami sudah memberikan pelayanan. Prosesnya harus bisa digandengkan dengan BPS, tapi kan belum punya NIK belum punya seperti itu. Jadi kami minta tolong ke Dukcapil atau dinas sosial, (LH)</i> <i>mungkin adanya kelalaian dari individu tenaga medis atau tenaga kesehatan, jadi dia tidak patuh terhadap regulasi ataupun terhadap standar layanan yang ada, sehingga mengakibatkan adanya risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. (IB)</i> <i>Kalau dari saya, kan kita mengumpulkan dari unit, pengumpulannya itu yang agak-agak, risk register gitu. (YD)</i> <i>rotasi pergantian pimpinan yang dulu pernah diajarin, ini diajarin lagi. (YD)</i> <i>kesulitannya adalah ketika, kita mintakan kepala unit itu punya kerjaan lain juga. Jadi,</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>emang rata2 kayak gini kan kerjaan tambahan . lupa begitu cara pengisiannya. ada yang belum memahami, ditambah lagi ada beberapa yang sempat rotasi. Staff-nya berubah, nanti berubah lagi. Jadi sering sih kendalanya itu. (FN)</i> <i>pasien-pasien yang komplain dengan pelayanan keperawatan kami (NS)</i> <i>pemahaman manris klinis dan non klinis ini tidak terintegrasi. (NK)</i>	
Observasi	Budaya manajemen risiko belum terbentuk; ERM dipersepsikan sebagai beban administratif dan dilakukan tidak rutin. Pemahaman risiko tidak merata, kualitas skoring bervariasi, serta pemisahan risiko klinis–nonklinis masih kuat. Pengawasan dan pemantauan mitigasi lemah, pelaporan insiden dan RCA sering terlambat, serta budaya takut melapor masih ada. Koordinasi lintas unit dan integrasi sistem risiko belum berjalan; data risiko terfragmentasi, komplain pasien tidak masuk sistem ERM, dan risiko kepatuhan sulit ditegakkan lintas unit. Dokumen dan pedoman bersifat umum tanpa mekanisme enforcement, verifikasi kualitas data, knowledge transfer, atau integrasi peran ERM dalam uraian tugas, sehingga keberlanjutan dan konsistensi implementasi rendah.	
Dokumentasi	Program Kerja Manajemen Risiko 2020 mensyaratkan siklus PDCA berkelanjutan, namun tidak ditemukan bukti pelaksanaan konsisten lintas unit. Dokumen program dan SOP ada, namun pelatihan berkelanjutan dan modul pembelajaran tidak dilaksanakan rutin. Program MR menetapkan audit dan evaluasi berkala, tetapi laporan monev tidak rutin terdokumentasi.	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	SOP etik & hukum ada, monitoring tidak konsisten. Audit & PDCA diwajibkan, bukti pelaksanaan tidak rutin	

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa hambatan implementasi ERM di RSUD Tarakan bersifat sistemik dan multidimensional, ditandai kesenjangan antara kerangka kebijakan formal dan praktik di lapangan. Budaya manajemen risiko belum terbentuk, ERM masih dipersepsikan sebagai beban administratif dan dijalankan secara *compliance-driven*, dengan integrasi terbatas ke alur kerja klinis dan non-klinis. Kelemahan koordinasi lintas unit, fungsi pengawasan yang belum optimal, serta siklus ERM yang tidak berjalan utuh menyebabkan risiko berulang tanpa pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, perbaikan ERM menuntut penguatan budaya, kapasitas SDM, tata kelola, dan integrasi pelayanan publik, bukan sekadar penyempurnaan dokumen.

2. Tata Kelola dan Budaya (*Governance and Culture*)

a. Kesesuaian visi, misi, nilai dan sasaran rumah sakit

Tabel 4.9

Triangulasi data Kesesuaian visi, misi, nilai dan sasaran rumah sakit

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Dalam visi kami “menjadi RS rujukan berstandar internasional” Misi : menjadi RS yang memberikan pelayanan Kesehatan nasional yang modern dan terpercaya. Disitu saja dari statemen tersebut bagaimana kami memetakan pelayanan kepada masyarakat potensial risikonya, membentuk standar pelayanan dan membuat SPO kalau kita ingin menjadi RS standar Internasional sesuai keinginan owner kurang dari 2-3 tahun kami harus JCI. Kemudian amademen RS di segala bidang, salah satu dari BLUD</i>	Transformasi layanan RSUD Tarakan berorientasi pada outcome dan nilai publik melalui inovasi klinis sebagai sumber value creation. Program Jak-Stroke menjadi bukti peningkatan mutu, akses, dan reputasi, sementara

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>dari sisi keuangan, manris pun kami jagain juga dari keuangan supaya kesesuaiin belanja, tidak terjadi kebocoron dan efisien. Potensial risiko keuangan kami kendalikan juga, misi nya memiliki SDM berkualitas berahlan, bagaimana SDM kita baik secara kometensi, hospitality nya bagus, potensial risiko sudah dipaparkan jangan sampai terjadi, apabila terjadi menjadi risiko prioritas menjadi risiko strategis yang ada di direktur. Agar kita bisa bersaing dengan kompetitor kita RS lain antara lain komunikasi efektif, dan 70% masalahnya adalah SDM. (WP)</i> <i>Kalau saya lihat visi visi 2023-2026 ini, saya begitu masuk sini melihat, memang tidak ada kata manajemen risiko muncul di sana. Yang saya lihat adalah portaker setiap rumah sakit yang di sah kan Pak Gubernur, diberikan ke semua rumah sakit, itu sudah memasukan risiko. Peran risiko yang di-intergrasi risiko, tapi kalau di visi misi belum ada. Tapi begitu melihat prosesnya, saya coba lihat ke bawah, Kalau dari misi saya melihatnya dari akreditasi ternyata di akreditasi ada tersebut di sana. Menurut saya, tools di dalam menyelenggarakan akreditasi di sana ada salah satunya, Kemudian saya masuk lagi ke sasaran, didalam sasaran RS itu juga sudah dijelaskan. Ketika ada sasaran terkait pelayanan, di sana menyebutkan program-program atau kegiatan, atau indikator klinis yang digunakan. Misalnya, waktu tunggu rawat jalan. Kemudian, bagaimana pengelolaan, ketersediaan sarana dan prasarana terstandarisasi. (NK)</i> <i>Kalau visi misi sudah jelas ya bu terlihat bahwa memang untuk keselamatan pasiennya sudah nomor satu ada, untuk nilai yang dianut sudah ada tentang bagaimana pengelolaan risiko,</i>	penguatan standar dan tata kelola berperan sebagai value protection. Integrasi manajemen risiko dalam strategi dan operasional menunjukkan alignment strategis yang memperkuat penciptaan dan perlindungan nilai publik.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	walaupun mungkin tidak disebutkan secara eksplisit. (YE) kita kan visinya. menuju pelayanan terbaik. berstandar internasional, berarti dalam menggapai visi itu kita meningkatkan pelayanan. (NS) Ya, pasti. Kalau untuk secara leteleleg sih mungkin kita gak persis gitu ya. Cuma di dalam setiap poin itu manris memang dikaitkan.. sudah tersirat gitu ya. (YD&FN) Ya, saya rasa sudah mencerminkan . Karena di sana ada misalnya terkait sarana prasarana kalau kita kaitkan dengan manris, misalnya kerusakan alat kesehatan juga menjadi manris. Walaupun tidak tersirat, tapi dalamnya itu sudah ada. (NE) Dari system Value Protection : penguatan dalam hal Cyber Security, system sudah terintegrasi baik data keuangan, data pasien satu, semua satu kesatuan dalam system yang terintegrasi. Yang penting kita lakukan adalah cyber security. Komitmen dari SDM karena semua orang meng-akses, membuat Pakta Integritas dalam rangka untuk value protection. (SH)	
Observasi	Transformasi layanan RSUD Tarakan berbasis kompetensi dan nilai publik tercermin dari indikator klinis, audit, dan layanan unggulan. Inovasi Jak-Stroke berfungsi sebagai value creation melalui alur cepat dan kolaborasi lintas unit, sementara integrasi mutu, keselamatan pasien, dan risiko menjadi mekanisme value protection. Keselarasan visi, strategi, dan operasional terlihat pada integrasi risiko dalam sasaran pelayanan, SDM, IT, dan program prioritas..	
Dokumentasi	Dokumen inovasi dan Renstra menekankan inovasi layanan prioritas,	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	mutu, dan kinerja terukur sebagai sasaran strategis Profil RS dan penghargaan (WSO Angel Award) menguatkan capaian mutu dan pengakuan eksternal layanan Stroke. Dokumen tata kelola, struktur organisasi, dan akreditasi paripurna menunjukkan sistem pengendalian mutu–risiko terinstitusionalisasi Renstra & Profil RS memuat sasaran mutu, keselamatan, SDM, sarpras, dan inovasi sebagai strategi pencapaian visi. Renstra 2023–2026 memformalkan sasaran strategis: inovasi layanan, mutu, SIMRS, dan kompetensi SDM.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data bahwa visi, misi, nilai, dan sasaran RSUD Tarakan secara substantif telah selaras dengan prinsip penciptaan dan perlindungan nilai publik, meskipun manajemen risiko belum dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan visi dan misi formal. Temuan wawancara menunjukkan bahwa aktor organisasi memaknai manajemen risiko sebagai bagian integral dari pencapaian mutu, keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan, sementara observasi lapangan mengonfirmasi bahwa orientasi visi–misi dioperasionalkan melalui praktik layanan berbasis outcome, inovasi pelayanan, serta mekanisme tata kelola klinis dan mutu yang berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Dokumentasi strategis, termasuk Renstra, dokumen inovasi, serta capaian akreditasi dan penghargaan eksternal, memperkuat bukti adanya penyelarasan strategis antara arah organisasi, sasaran kinerja, dan praktik pengendalian risiko. Dengan demikian, hasil triangulasi ini menegaskan bahwa manajemen risiko di RSUD Tarakan bersifat terlembaga (*embedded*) dalam strategi dan operasional organisasi, berfungsi bukan hanya sebagai instrumen kepatuhan administratif, tetapi sebagai mekanisme tata kelola pelayanan publik yang memungkinkan rumah sakit secara simultan menciptakan dan melindungi

nilai publik.

b. Kepemimpinan dan Pengawasan berupa Komitmen terhadap Core Value dan ERM

Tabel 4.10

Triangulasi data Kepemimpinan dan Pengawasan Berupa Komitmen terhadap Core Value dan ERM

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Komitmen pimpinan dalam konteks penerapan manajemen risiko itu masih kurang . (YE) kehadiran pimpinan rapat manajemen risiko <i>Kalau yang manris kemarin, yang datang wadirnya. Wadir, kalau tidak salah kabit yang waktu itu ya. (YE)</i> Dukungan pimpinan untuk pelatihan manajemen risiko, <i>Kalau untuk pelatihan utamanya, mungkin karena kurun waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tahun 2024 mungkin untuk pelatihan pelatihannya, kayaknya susah juga ya. Tergantung dari mana pelatihan itu datang, siapa yang mengadakan mungkin masih seperti itu. Padahal, harapannya maunya semua RSUD itu harusnya berkiblatnya ke ARSADA. Dimana ARSADA punya PPA DHP. (YE)</i> <i>Dewas laporan disampaikan, setiap rabu ada rapat dewas, ada pembahasan di pertemuan formal dan informal dan salah satunya terkait manris. (WP)</i> <i>Waktu kemarin 2025, tapi ini Bu yang salah ya, karena saya yang mengadainya. dari 2025. Terus, antara kan waktu jamannya Bu Arjaty itu ikut nggak ya? Iya, dulu pernah in-house training, tapi hanya membuka saja, menurut Bu Dian, menurut informasi yang saya dapat dari Bu Dian sendiri, rumah sakit Tarakan itu sebetulnya perhatian banget sama pelatihan. (YE)</i>	Pimpinan menunjukkan komitmen perilaku terhadap ERM melalui praktik kepemimpinan dan pengendalian berbasis risiko. Namun, komitmen tersebut masih bersifat implisit dan terfragmentasi dalam dokumen, belum terinstitusionalisasi sebagai core value ERM dalam kebijakan strategis terpadu, sehingga terdapat kesenjangan antara praktik operasional dan penguatan normatif ERM.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	mengambil keputusan mempertimbangkan risiko atau tidak untuk keputusan strategis. Saya rasa harusnya ya bu, tapi sebesar apa pertimbangannya itu yang belum jelas. (YE) penagmbilan keputusan mempertimbangkan risiko Selama ini sih belum, karena kami terus terang saja untuk kinerja yang dilaksanakan oleh Dewas itu penilaian kinerja keuangan dan penilaian kinerja layanan. Terus terang, tadi di dalam Pergub penunjukan dan tugas dari dewas itu tidak secara tertulis ada manris di sana, walaupun diakreditasinya ada, tapi Dewas menjalankan hanya yang sesuai Pergub. Kami untuk yang ini bertiga, ya Pak A, Pak H, saya. Untuk saya karena sudah terpapar dengan akreditasi, saya tentunya memakai yang Starkes. Tapi beliau-beliau karena belum terpapar, sehingga sesuai apa yang ada di Pergub. Sehingga pelaporan-pelaporan itu saya minta melalui sekretaris untuk diberikan ke Dewas. Karena pada saat diakreditasi pasti ada ditanyakan, apakah Anda membuat laporan yang 3 bulanan, J6 bulanan kepada Dewas. (YE) Kami ada SPI merupakan salah satu Back Bone dalam menerapkan manris, kami mempunyai mekanisme kita lakukan 3 bulan sekali (setahun 4 kali) kita lakukan monitoring dan evaluasi, misal triwulan1, dari mulai pemilik risiko direktur, dengan Ketua SPI, dengan coordinator kita memetakan kembali apakah level risiko sudah sesuai dan penanganannya seperti apa, saya sebagai pemilik risiko sangat peduli dengan teman teman yang sudah katakana apakah bisnis proses nya sudah cukup ? Di triwulan ke2 antara komite mutu dan keselamatan pasien juga para coordinator instalasi dengan kasatpel sebagai operator dilihat bagaimana	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>penatalaksanaan risiko berjalan atau tidak, bulan ke-3 antara SPI dengan para manajer (kabag kabid) melakukan evaluasi.</i> <i>Pengambilan keputusan setelah melakukan evaluasi dari risiko tersebut kita akan lihat ternyata apakah grading menurun atau tetap apakah ada residual risiko, keputusan-keputusan manajer dan direktur termasuk memperhatikan darimana manris yang belum kita tangani dengan baik. Program kerja kita dalam Renstra, rencana aksi mencapai perkin dan kinerja berdasarkan manris.</i> <i>Di SPI ada tree line depend, ada internal audit di tingkat unit, tingkat operator, audit SPI, ada audit silang. (WP)</i> <i>pengambilan keputusan, di rumah sakit ini mempertimbangkan risiko :pasti, sih iya ya kan kita pasti diajak, kalau mau mengambil keputusan ada hal yang perlu pakai bahas, ada hal yang button up, ada yang top down. (NS)</i> <i>Pengambilan keputusan oleh Pimpinan, memikirkan risiko : karena yang membuat kebijakan itu pimpinan ya. Kami kan hanya melaporkan dan mungkin komunikasi pada saat laporan. Berdasarkan laporan itu, Keputusannya, ya, kita menampilkan data. Jadi, nanti terserah. (YD)</i> <i>Support sumber daya untuk melaksanakan program.</i> <i>Terlaksana sih. Misalnya ini kalau berkenaan dengan anggaran risiko, itu kan disesuaikan. (YD)</i> <i>Pimpinan itu mengambil keputusan berbasis pada risiko</i> <i>memang pimpinan sudah melaksanakan pengambilan keputusan berbasis risiko. Contohnya misalnya kita punya PERKIN ada Sasaran Strategis ada Renstra. Jadi, berdasarkan Renstra itu, disusunlah mana yang masuk ke dalam risiko. Nanti ini</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>disandingkan dengan yang kegiatannya. (NE)</i> <i>Kalau piagam manajemen risiko tidak ada, adanya nilai zona, artinya integritas belum sampai ke manajemen risiko. (NK)</i> <i>Pengawasan pimpinan untuk yang tahun Kalau yang 2025, 2024, 2023 itu saya tanya tim, dan kita mau jalankan ini proses untuk 2026 juga. Jadi di akhir tahun bulan Desember, kita sudah mau mulai untuk yang 2026. Risiko tahun depan sudah harus siap, sudah mulai untuk manajemen risiko di Desember, dan ibu juga menyampaikan, setiap Desember itu adalah kesempatan Dinas Kesehatan memberikan bagaimana gambaran pengembangan tahun depan. Di setiap akhir Desember, ibu direktur itu punya forum yang disitulah saatnya Dia memberikan gambaran hasil rapim ibu dengan kadis untuk diberitahukan grand design tahun depan, disitulah peran-peran untuk memberikan gambaran top-bottomnya, temen-temen juga diminta laporan pemantauan TW terakhir, mana yang belum, mana yang sudah, Sekaligus melihat sampai hitung-hitungan perkinnya. (NK)</i> <i>Iya, Perkin bisa terancam tidak dapat apabila pemantauan mutunya tidak bagus, Jadi, beliau disitulah beliau melihat, menggrading dan menempatkan selera risiko itu sehingga dicocokkan dengan kebutuhan beliau juga untuk Perkin, jadi monitoringnya seperti itu.</i> <i>Proses perkinnya itu disepakati oleh Dinas Kesehatan dengan Pak Gubernur., dan itu dijadikan Tools Direktur, berarti pemilik risiko itu sudah menghubungkan tidak hanya mutu dan keselamatan pasien tetapi bagaimana bisnis kita berjalan dengan aman, baik untuk pasien, tapi juga untuk kinerja rumah sakit dan organisasi.</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Jadi, dalam pertemuan setiap Triwulan untuk pemantauannya</i> <i>Itu ada forumnya, Misalnya, bulan pertama pemilik risiko harus hadir untuk melihat ini sudah mulai, bagaimana rencananya bagaimana. Nanti TW kedua, beliau juga masuknya di bulan pertama. Tiap TW, dia gilirannya di bulan pertama. Misalnya, di TW 1 di Januari, Nanti TW 2 di bulan April. Karena saya tahu, kenapa ibu pilih itu, karena disitulah pelaporan RENKIN. Itulah input kita ke kinerja. Jadi, setiap 3 bulan itu, kita yang ASN, terutama, itu juga harus meng-input dengan batas waktu Tanggal 8 Januari, pukul 23:59. Itu mengerikan. waktu-waktu itu sampai, itu nggak masuk, tidak divalidasi, tidak dapat dibuktikan. Kenapa Ibu Dir, pemilik risiko, minta di waktu bulan pertama? Karena itulah beliau akan masuk ke PERKIN. (NK)</i> <i>Pengawasan pimpinan terkait dengan manajemen resikonya. Ikut sih ibu, Karena ada pelaporan, setiap Triwulan, ke direktur ya. (YD)</i> <i>Ini, kalau ke dewasa. memang ini tidak ada khusus ya Jadi sifatnya pengawasan nanti untuk feedbacknya kan langsung direktur ada pertemuan</i> <i>Laporan rutin kalau tadi kan direktur tiga bulan, kalau dewasa, semester, oke sesuai akreditasi ya. dewasa. itu dalam akreditasi, harus memberikan feedback sejauh mana maksudnya dokumen feedbacknya itu sudah ada atau belum</i> <i>Kalau yang terbaru sepertinya belum ada, beberapa hari yang lalu,. Dewasnya kan enggak lama. (YD)</i> <i>Pengawasan untuk manajemen risiko, pimpinan menunjuk kami di SPI. Jadi kalau SPI itu di manajemen risiko sebagai unit kepatuhannya. Jadi mulai dari penyusunan sampai ke nanti monitoring</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>evaluasi penanganan risiko itu kami dilibatkan terus. Mulai dari memonitor perumusan profil risiko sampai rencana penanganan risiko. Kemudian nanti kita juga monitor pelaksanaan penanganan risikonya. Bahkan sampai tindak lanjut review, kalau ada hasil-hasil yang kurang, ini kita dimintakan oleh pimpinan. (NE)</i> <i>Direksi atau Dewas, memang turut mengawasi. Karena beliau sebagai pemegang kebijakan dan arahan, jadi mengarahkan kami juga. Kemudian juga, kalau ada tindak lanjut selalu menanyakan ke kami apakah TL-nya sudah. (NE)</i> <i>Kalau saya merasanya itu sudah berjalan. Bahkan, saya merasa pimpinan itu justru sekarang bukan lagi supaya tidak terjadi risiko yang sudah ditetapkan bahkan sekarang, sudah bisa mengelola risiko dengan bijak. Maksudnya, jadi kalau pun terjadi, ya udah kita ngapain? Jadi bukan lagi untuk awas yah, gini-gini tidak begitu Bu, tetapi itu pembinaan dengan Komite Mutu dan cara-cara pelaporannya. walaupun tidak terjadi, menjadikan ajang belajar untuk berikutnya, tapi masuk teman-teman tidak tercapai, ya, cuma gitu aja Bu. Jadi, pengambilan keputusan itu menjadi bentuk penguatan ketika teman-teman semangat. Ayo, capai ini dengan melaksanakan ini, supaya kejadian ini tidak terjadi dan mengurangi kinerja kita. Jadi tidak banyak ngomong ya, teman-teman turun mengurangi kinerja kita. (NK)</i>	
Observasi	Teramati bahwa pimpinan rumah sakit secara rutin memimpin forum rapat kinerja triwulanan dan rapat evaluasi Renstra/Perkin, di mana pembahasan kinerja, mutu, dan risiko organisasi dilakukan secara simultan. Pimpinan meminta laporan pemantauan risiko terintegrasi dengan capaian indikator	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	kinerja dan mutu, serta menempatkan risiko sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Namun, tidak seluruh proses tersebut terdokumentasi secara eksplisit sebagai praktik “risk-based decision making” dalam format ERM formal.	
Dokumentasi	Renstra RSUD Tarakan 2023–2026 menegaskan visi, misi, dan sasaran strategis yang disusun berdasarkan analisis risiko lingkungan internal dan eksternal, serta menetapkan indikator kinerja sebagai alat pengendalian strategis. Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2024 menunjukkan akuntabilitas pimpinan dalam pencapaian kinerja, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi hambatan organisasi sebagai dasar tindak lanjut manajerial. Selain itu, Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan memuat struktur, sasaran, dan tahapan manajemen risiko yang disahkan oleh pimpinan sebagai pedoman operasional. Namun, belum ditemukan dokumen Piagam Manajemen Risiko (Risk Management Charter) yang secara eksplisit menyatakan nilai, peran, dan komitmen pimpinan terhadap core value ERM.	

Sumber: Hasil penelitian 2025

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa komitmen pimpinan RSUD Tarakan terhadap ERM telah tampak dalam praktik kepemimpinan dan pengendalian kinerja berbasis risiko, namun belum terinstitusionalisasi sebagai core value organisasi. Variasi persepsi informan dan bukti observasi menegaskan bahwa internalisasi ERM masih tidak merata dan bergantung pada praktik operasional, sementara dokumentasi belum secara eksplisit menempatkan ERM sebagai nilai strategis formal. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara praktik kepemimpinan berbasis risiko dan pelebagaan ERM sebagai core value

organisasi.

c. *Value for Money*

Tabel 4.11
Triangulasi Hasil Penelitian *Value for Money*

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Belum ada. Kalau misalnya untuk SDM itu dilihat dari laporan Triwulanan. Pada saat kami hadir di rumah sakit, ada laporan tentang kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis Sehingga kita bilang, ya sudah, kalau seperti itu harusnya kita minta kepada dinas kesehatan. Tapi harusnya teman-teman itu kan UUBK sudah bisa mengusulkan untuk dokter spesialis atau subspesialis sendiri, tanpa usaha dinas Kesehatan (YE) Laporan keuangan biasa saja, Prof A biasanya yang untuk keuangan. Efektivitas dan efisiensinya dari laporan keuangan (YE) Selama ini ada E-preqorement (YE) Disampaikan Pak H sebagai Dewas juga, bahwa pasien yang paling banyak itu ada di RS Tarakan, Tetapi kenapa anggaran/uang yang masuk itu sedikit, Sementara di RS K itu pasiennya tidak banyak, tapi dana itu banyak, apa ada yang salah? (YE) value for money belum pernah dengar (NE) Ya, kami pernah melakukan ini, jadi kita ikuti prosesnya di PPBJ. Kita mengetahui apa yang akan diadakan sesuai ketentuan tidak keekonomisan, keefektifannya (NE) mungkin belum ada, tapi kami dalam mengaudit kinerja juga 3E itu kita gunakan. (NE) Dalam value for money, buat struktur tetapi seperti fungsi, untuk membuat	Prinsip economy dan value for money telah diterapkan secara administratif, namun masih bersifat compliance-driven dan belum berbasis strategic cost management. Efisiensi operasional belum terkonversi menjadi efisiensi fiskal, dan efektivitas masih dipahami sebagai output, bukan outcome atau nilai publik. Pengendalian value for money cenderung reaktif melalui audit, belum terintegrasi dalam ERM dan perencanaan strategis.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	perencanaan kita sesuai kebutuhan dari bawah Bottom Up, kalau Top Down nya apabila ada kebijakan baru bisa diturunkan dan bisa ketemu di tengah. Betul betul menghitung secara detail missal pengadaan barang jasa. Untuk SDM misal 1 orang bisa mengerjakan 2 pekerjaan ada multitask, kecuali tenaga professional dokter atau perawat terlatih, beberapa tenaga adminitrasi sudah di hemat. RS karena sudah pemetaan risiko, dalam proses-proses, dalam pembiayaan memilih upaya pencegahan dan pengendalian risiko yang paling efektif. Apabila sudah semua sudah berjalan maka akan lebih efektif efisien. (WP) <i>Value for Money</i>, tentunya kita melakukan karena adanya tantangan bagi kami dengan adanya beberapa regulasi kebijakan dalam rangka efisiensi, akan melakukan skala prioritas, kemudian penguatan pemahaman dari teman teman dari SDM sehingga pelaksanaannya keterbatasan SDM tapi tugas tetap terlaksana dengan baik dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Salah satunya bisa juga penguatan dalam system, dengan adanya terintegrasi dapat lebih efektif baik secara biaya maupun secara waktu, bahkan system dapatmempresentasikan ke akuratan data. (SH)	
Observasi	<i>Economy (Keekonomisan penggunaan sumber daya)</i> Teramati penggunaan sistem e-procurement dan mekanisme PPBJ dalam pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan mengikuti regulasi formal, namun belum seluruh unit menggunakan analisis keekonomisan berbasis perbandingan biaya-manfaat. <i>Efficiency (Efisiensi antara input dan output)</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Ditemukan ketidakseimbangan beban layanan dan penerimaan, dimana volume pasien tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima rumah sakit Effectiveness (Pencapaian tujuan dan hasil) Teramati fokus organisasi pada pemenuhan target layanan dan SPM, bukan pada outcome keuangan atau nilai publik. Pengendalian & Akuntabilitas VfM Tindak lanjut rekomendasi audit dilakukan, namun bersifat korektif dan sektoral.	
Dokumentasi	Dokumen Laporan Tahunan menunjukkan belanja BLUD dan APBD direalisasikan sesuai pagu, namun BPK masih menemukan potensi pendapatan yang belum optimal serta ketidaktepatan pengelolaan pemanfaatan aset dan remunerasi pada LKPD 2023. Laporan Tahunan 2021–2024 menunjukkan peningkatan signifikan kunjungan IGD, rawat jalan, dan rawat inap, namun rasio pendapatan terhadap beban layanan belum dianalisis eksplisit sebagai indikator efisiensi. Dokumen menunjukkan capaian SPM dan KPI layanan tinggi ($\geq 80\text{--}90\%$ pada beberapa tahun), serta realisasi pendapatan BLUD melebihi target pada 2024 (108%). Namun indikator <i>value for money</i> tidak dinyatakan eksplisit sebagai sasaran kinerja. Dokumen TL BPK RI LKPD 2023–2024 menunjukkan perbaikan tata kelola pendapatan, piutang, dan remunerasi sebagai respons atas temuan audit.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data, penerapan *value for money* di RSUD Tarakan telah berjalan pada tataran administratif dan kepatuhan regulasi, khususnya melalui mekanisme penganggaran, pelaporan keuangan, serta pemenuhan indikator layanan. Namun, prinsip 3E (*economy, efficiency, effectiveness*) belum terintegrasi secara eksplisit sebagai kerangka manajerial dan pengambilan keputusan strategis. Temuan audit BPK justru menjadi pemicu utama evaluasi *value for money*, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung reaktif.

Dengan demikian, *value for money* di RSUD Tarakan masih berorientasi pada output pelayanan dan kepatuhan fiskal, belum berkembang menjadi alat penciptaan nilai publik (*public value*). Temuan ini memperkuat argumentasi disertai bahwa *Enterprise Risk Management* (ERM) diperlukan sebagai mekanisme integratif untuk menghubungkan kinerja keuangan, kinerja layanan, dan nilai publik secara berkelanjutan.

d. Pengorganisasian ERM dengan *Three Line Model*

Tabel 4.12

Triangulasi data Pengorganisasian ERM dengan *Three Line Model*

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Setiap unit, koordinator instalasi, satpel pelaksana merupakan pemilik risiko, risiko yang ditingkat organisasi antara lain fiskal, legal, reputasi yang diangkat, untuk operasional semua punya dan langsung menangani bertanggung jawab atas risiko unit. (WP) SPI itu kan harusnya dia ada di lehernya manajemen ya SPI ini di teman-teman kita ini adanya tidak tahu dimana itu, sembunyi, saya minta untuk diberikan ruangan yang baik, kelengkapannya yang baik, jangan cuman kayak mereka merasa yang jadi SPI itu merasa jadi anak buangan, orang yang tidak kepahe, untuk menjadi penting mereka harus belajar, iya harus diberikan pemahaman. (YE) uraian tugas terkait dengan manajemen risiko pada semua pemilik risiko belum terbaca. Tidak terlihat. (YE)	Pengorganisasian ERM telah mengadopsi Three Lines Model, namun fungsi first line masih bersifat administratif, second line cenderung compliance-driven, dan third line berperan ex-post control. Integrasi antar lini belum optimal, sehingga ERM belum berfungsi sebagai sistem pembelajaran risiko yang mendorong kinerja strategis.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kita manajer risiko tidak punya hal seperti itu, pemiliknya itu direktur. Manajer risikonya siapa? Kabid-kabid. Kalau di Unit itu menjalankan kepatuhan mereka ya. Jadi pemilik risiko di sini cuma satu, cuma direktur saja. (FK)</i> <i>Untuk strukturnya, kita ada manajer resiko, ada pemilik risiko, ada koordinator resiko. Kalau yang terakhir ada SK manajer resiko. Itu SK sendiri, penunjukan. kalau dari mutu tetap. Jadi sebenarnya menguntungkan karena koordinatornya wadir pelayanan, manajer risiko adalah kabag kabid. karena dari pergub memang harus ada manajer risiko. mereka membantu mengawasi menganalisis risiko. (YD&FN)</i> <i>Yang saya tahu sih kalau SPI itu dia memantau. (YD&FN)</i> <i>Di bawah langsung direktur, di leher direktur. (NE)</i> <i>Satu unit SPI 4 orang. (NE)</i>	
Observasi	• Pengelolaan risiko dilakukan oleh unit kerja sebagai first line, namun pemahaman risk ownership belum sepenuhnya melekat. • Second line telah berfungsi melalui manajer risiko lintas bidang dalam koordinasi dan pemantauan. • SPI sebagai third line berperan dalam pengawasan pasca kejadian, sementara koordinasi antar three lines masih terbatas dan belum terintegrasi dengan perbaikan kinerja strategis.	
Dokumentasi	SK Struktur Manajemen Risiko menetapkan Direktur sebagai pemilik risiko, unit kerja sebagai pelaksana, serta Koordinator/Manajer Risiko dan Komite Mutu sebagai penggerak koordinasi. SPI	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	berperan sebagai pengawasan independen melalui evaluasi pengendalian dan pelaporan. Namun, mekanisme integrasi lintas three lines belum diatur secara eksplisit dalam dokumen.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa ERM di RSUD Tarakan telah mengadopsi *Three Lines Model* secara struktural, namun integrasi fungsional antar lini masih terbatas. *First line* menjalankan pengelolaan risiko secara administratif, *second line* cenderung *compliance-driven*, dan *third line* berperan *ex post control*. Akibatnya, ERM belum berfungsi sebagai mekanisme tata kelola kinerja dan penciptaan nilai publik, melainkan masih sebagai sistem pengendalian administratif.

e. Penetapan Regulasi manajemen risiko rumah sakit

Tabel 4.13

Triangulasi data Penetapan Regulasi manajemen risiko

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Kita Cuma pakai pergub. Belum ada panduan, misalnya SK direktur. (TH, LH, GR, SS, FW)</i> <i>peraturan internal sudah ada terkait manajemen risiko. Jadi kebijakan pengelolaan manajemen risiko di rumah sakit itu, Terus juga ada dua ketentuan sebetulnya. Satu lagi ada di komite mutu, karena komite mutu ada terkait manajemen risiko. (IB)</i> <i>Sudah, Regulasi-regulasinya ada dukungan dari Pergub, Pergub 122. Kemudian, struktur manajemen juga ada di Pergub, di kami sudah ada SK struktur manajemen risiko. Kemudian, ada kebijakan manajemen risiko. (NE)</i> <i>Pedomannya Pergub saja, (NE)</i> <i>berarti tidak dibikin lagi, belum. (NE)</i>	Regulasi ERM di RSUD Tarakan memiliki legitimasi eksternal yang kuat, namun belum teroperasionalisasi dalam kebijakan internal terpadu, sehingga implementasinya masih <i>compliance-based</i>. Secara struktural ERM telah terbentuk, tetapi belum terintegrasi dalam perencanaan strategis dan budaya organisasi, sehingga ERM lebih berfungsi sebagai pengendalian administratif daripada

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Observasi	Penerapan ERM di RSUD Tarakan masih bertumpu pada regulasi provinsi tanpa panduan teknis internal yang seragam. Struktur ERM telah terbentuk, namun belum dipahami sebagai bagian dari tata kelola strategis, belum terintegrasi dengan perencanaan, dan belum disinergikan dengan budaya risiko organisasi.	instrumen <i>governance</i> strategis.
Dokumentasi	Penerapan ERM di RSUD Tarakan merujuk pada Pergub DKI Jakarta No. 122/2020 Kepgub No. 153/2021, serta didukung SK Direktur tentang Struktur Manajemen Risiko. Dokumen manajemen risiko dan peta risiko telah tersedia, namun belum terintegrasi sebagai kebijakan direktur lintas fungsi. ERM belum ditampilkan eksplisit dalam Renstra, dan budaya organisasi yang ada belum secara langsung menginternalisasikan budaya risiko.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi data menunjukkan bahwa regulasi *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan telah memiliki basis normatif yang kuat dan jelas, terutama melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Regulasi tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas SPIP serta menjamin ketercapaian tujuan organisasi publik melalui pengelolaan risiko yang sistematis. Namun demikian, temuan empiris memperlihatkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan rumah sakit, regulasi ERM masih lebih banyak dimaknai sebagai kewajiban struktural-administratif yang dijalankan oleh unit tertentu, dan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai kerangka rasionalitas pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan organisasi.

f. Regulasi manajemen Risiko Eksternal

Tabel 4.14

Triangulasi data Regulasi manajemen Risiko Eksternal

Teknik pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Harmonisasi dan sinkronisasi Regulasi Koordinasi dengan kemkes, kemendagri dan Pemda untuk penguatan manris: Dengan BPKP, dari sisi manris yang sesuai SPIP, untuk layanan (NR) BPKP dengan Inspektorat. : Sama, Karena kita punya Pergub jadi BPKP itu mengikuti Pergub, kalau Biro ORB itu kaitannya dengan WBK WBBM. Jadi sebetulnya WBK WBBM itu kita diusulkan oleh Biro ORB untuk mendapat predikat tipe dua tadi. Yang satu WBK, kemudian nanti setelah ini lulus menjadi WBBM kaitannya itu SPIP nya, Jadi, kalau SPIP itu kan banyak dari lingkungan pengendalian. Itu wajib, tidak? SPIP. Wajib! Tiga tiganya ini wajib. Sebetulnya, kalau manajemen risiko itu ada di dalam SPIP, Salah satu dari Dinas Kesehatan. SPIP nya unit besarnya. Itu banyak lingkungan pengendalian internal control. CCE nya kita harus kerjakan. (NE) Penilaian dari BPKP Maturitasnya ada, kemarin kita mendapat level 3, Optimal. (NE) nah, itu yang ga ada di pemda. Ada pendanaan disitu., Di Mindseat pemda, Kalau sudah BLUD, tuh tidak dapat lagi APBD. Jadi udah cukup, gak cukuppun, harus cukup. Dan pendapatan hanya dari BPJS hanya itu. Karena dinilai BLUD itu mandiri, mampu cari uang, nggak akan mungkin. Ini layanan dasar urusan mandiri. Itu yang saya pengen buat. Kemkes bikin SEB lah, misalkan, dengan kemendagri. Penegasan bahwa terkait dengan penerapan BLUD kewajiban APBD khusus di bidang BLUD. Ini jadi yang penting. Boro-boro kita melihat undang-undang 17, PP28, ya kan Fasyankes harus terpenuhi 3, ya kan? Sarpras, Alkes, sama SDM. (WS)	Regulasi ERM tersedia secara normatif, namun harmonisasi lintas sektor dan operasionalisasi di RS masih parsial. Peran Dewan Pengawas dan mekanisme pembelajaran risiko belum diperkuat, pendanaan ERM belum jelas, serta beban translasi regulasi di tingkat RS menyebabkan implementasi ERM tidak seragam antar unit.

Teknik pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Harus supaya tidak berbeda secara penerapannya. (IL) Selama ini, memang kita sudah punya undang-undang atau regulasi terkait dengan kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana di sana itu sudah termasuk bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu harus melaksanakan upaya peningkatan mutu, dan salah satunya adalah terkait dengan manajemen risiko. Sehingga, untuk mengakomodir itu, maka kita harus membuat turunan dari Undang-Undang 17 tersebut agar bisa diimplementasikan nantinya di Pelayanan Kesehatan. Selain itu, juga di dalam PP. 28 2024 sebagai turunan dari Undang Undang 17, di mana sudah terkait juga dengan manajemen risiko, itu harus dibuat sehingga untuk itu kita sedang dalam proses penyusunan pedoman manajemen risiko di Fasyankes. (IL) manajemen resiko dalam regulasi eksternal kalau terkait dengan manajemen resiko memang di BLUD tidak mengatur secara detail, karena bagaimanapun pelayanan pasti ada nanti resikonya yang dihadapi. Makanya ada manajemen resikonya bidang kesehatan Itu silakanlah dituangkan dalam peraturan kepala daerah. (WS) regulasi kebijakan pemerintah, dari pergub, akreditasi, ketika mau diadopsi, mempermudah. (YD) Untuk kebijakan saat ini, apalagi untuk rumah sakit dengan berlakunya Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sebetulnya tidak banyak berubah terkait dengan Undang-Undang rumah sakit dan lain-lain. Korelasinya dengan peraturan daerah saat ini salah satunya adalah dari Dinas Kesehatan sudah membuat satu regulasi untuk bantuan hukum terhadap tenaga tenaga kesehatan, di mana ini	

Teknik pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	merupakan amanah dari Undang-Undang 17 bahwa salah satu kewajiban rumah sakit untuk menyediakan bantuan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berada di rumah sakit. (IB) sebagian besarnya sudah mendukung untuk regulasi eksternal yang ada di rumah sakit. Jadi, prinsip hukum ini sebetulnya mandatori ketika mandat dari Undang-Undang yang lebih tinggi sudah otomatis dibawahnya ini hanya melaksanakan . imam Kalau untuk rumah sakit atau kesehatan sendiri sebetulnya sebagian besar sudah saling terkait, saling mengamanatkan jadi contohnya di Undang-Undang Kesehatan itu diamanatkan untuk menyusun hospital by law, misalnya yang diatur oleh Kepala Daerah otomatis Kepala Daerah sudah mengeluarkan juga melalui Dinas Kesehatan hospital by law di rumah sakit, jadi sebetulnya sudah saling terkait ya Bu . (IB) regulasi eksternal yang mendukung penerapan manajemen risiko ini : yang pertama, pengetahuan, sehingga mereka harus paham, setiap bagian itu pasti ada, karena di pelaporan yang saya lihat masing-masing bagian itu juga memiliki risiko. (YE) Regulasi Dewas 79, dan bentrok dengan PMK 10. Yang akreditasi kan, semua rumah sakit. Itu yang jadi bingung di rumah sakit. Makanya memang sebenarnya gini, Permen ke-10 2014 itu sebenarnya jangan dibenturkan dengan 79 2014., makanya ini Permen ke-79 kan lagi proses revisi juga. Lagi proses. Amanatnya aturan Dewas kesehatan itu tidak melihat besaran pendapatan atau asset. Saya pikirkan kalau kecil mau besar itu rumah sakit harus ada perngawasnya, oke sepakat, jadi tidak ada batasan. (WS) Monitoring dan evaluasi	

Teknik pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Selama ini, kalau monitoring dan evaluasi secara langsung pada Fasilitas Kesehatan terkait, kita biasanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat seperti Dinas Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan itu tidak bisa serta-merta memantau seluruh rumah sakit yang berada di seluruh Indonesia, karena memang keterbatasan sumber daya kita. Sehingga kita harus melakukan pemantauan baik itu dengan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan, tapi kita juga mencoba untuk membuat semacam sistem aplikasi yang tentu saja nanti rumah sakit dapat melakukan secara rutin terkait dengan manajemen risiko yang mereka sudah lakukan di Fasilitas Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jadi, monitoring kita akan lebih mudah dengan adanya sistem atau aplikasi yang kita create di Kementerian Kesehatan. (IL)	
Observasi	Manajemen risiko di RS publik lebih bertumpu pada regulasi daerah, dengan harmonisasi lintas sektor yang belum optimal. Peran Dewan Pengawas dalam risiko strategis masih terbatas, monitoring ERM bersifat kepatuhan, dan dukungan pendanaan belum memadai. Akibatnya, rumah sakit harus menerjemahkan sendiri regulasi eksternal ke dalam kebijakan internal.	
Dokumentasi	UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan peningkatan mutu dan keselamatan, termasuk pengelolaan risiko. UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, dan Pergub No. 122 Tahun 2020 bersifat normatif dan memerlukan regulasi turunan internal RS. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD menekankan fleksibilitas dan akuntabilitas keuangan tanpa pengaturan eksplisit ERM, sementara Pergub 122/2020 menegaskan kewajiban manajemen risiko dalam SPIP.	

Teknik pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Permendagri No. 79 Tahun 2018 tidak mengatur pembiayaan ERM secara spesifik, sementara regulasi kesehatan menuntut pemenuhan sarpras, SDM, dan mutu layanan. Pergub DKI Jakarta No. 122 Tahun 2020 mewajibkan manajemen risiko secara sistematis dalam kerangka SPIP. UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 memandatkan manajemen risiko sebagai bagian peningkatan mutu dan keselamatan fasyankes. Pergub No. 226 Tahun 2016 dan Pergub No. 252 Tahun 2015 mengatur tugas dan pelaporan Dewas, serta Kepgub No. 593 Tahun 2022 menetapkan struktur Dewas RSUD, tanpa mandat eksplisit oversight ERM. Pergub No. 122 Tahun 2020 mengatur pemantauan dan reviu manajemen risiko sebagai bagian siklus SPIP, tetapi tidak mengaitkan langsung dengan sasaran strategis RS.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi data menunjukkan bahwa regulasi ERM eksternal di rumah sakit publik telah tersedia secara komprehensif, namun implementasinya lebih ditopang regulasi daerah yang teknis dibanding regulasi nasional yang bersifat normatif. Harmonisasi lintas sektor belum optimal, peran Dewan Pengawas dalam risiko strategis masih terbatas, dan monitoring ERM berorientasi pada kepatuhan administratif. Akibatnya, ERM belum berfungsi sebagai tata kelola strategis yang mengaitkan risiko dengan kinerja, mutu, dan keselamatan, sehingga diperlukan pengembangan model ERM kontekstual rumah sakit publik.

g. Kesesuaian Regulasi internal dan eksternal

Tabel 4.15

Triangulasi data Kesesuaian Regulasi internal dan eksternal

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Kalau saya ketika di awal, misalnya menanyakan sesuatu yang dilaporkan oleh pelaksana, Bingung formatnya, tapi ketika buka, ternyata disini Pergub, disini PMK. Kalau yang Pergub general, berlaku untuk semua. Dia juga sudah ISO dasarnya dan dia tidak membedakan klinis non klinis secara garis besar. Kalau PMK, ternyata pendekatannya karena kita akreditasi. harus dipahami. Kalau itu lebih banyak ke klinis, strukturnya harus begini. dilihat di PMK, ternyata PMK tidak sedalam itu untuk strukturnya. Dia cuman komite, gitu kan? Abis itu mungkin kalau diakreditasi pake pokja-pokja yang membantu. Oh, ternyata disini memfasilitasi soal struktur. Jadi bisa begitu, saya dampilkan. pake struktur yang ini, berarti memudahkan bagaimana memastikan yang klinis dan non-klinis versi PMKP ini berjalan dengan baik, gitu. Akhirnya, kalau saya, yang paling bagus regulasi itu, ya. Tidak ada makna ganda. Kita sebenarnya menunggu kalau mau dijalankan Manris di RS mau yang notabene layanannya, kami juga punya orang keuangan. Kami punya hukum, kami punya tempat tangga kita bikinakan sebuah tools yang benar-benar bisa kita gunakan resmi. Jangan sampai cara kita untuk mengatasi tantangan bisa menggunakan cara kita sendiri. Kita terjemahkan, komite mutu Berperan, SPI berperan dan kita bisa ketemu. (NK) Untuk berkaitan dengan kesehatan, sebetulnya sudah saling sesuai, saling mengamanatkan. Kita masih belum pernah menemukan adanya tumpang tindih, peraturan ketentuan, mungkin	Regulasi internal dan eksternal ERM selaras secara hierarkis dan teleologis, dengan regulasi internal berfungsi mengoperasionalkan mandat publik dan menjembatani berbagai rezim regulasi. Kesesuaian ini memperkuat akuntabilitas vertikal dan keselarasan dengan SPIP, namun penerapan ERM masih dominan administratif dan belum berkembang sebagai tata kelola strategis

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	kalau di luar kesehatan mungkin masih ada beberapa yang masih belum diamanatkan. Masih belum dilaksanakan oleh daerah, misalkan, karena amanat dari undang-undangnya sudah ada. Sudah hampir seluruhnya sudah ada. (IB) Kalau untuk menyesuaikan, antara regulasi tadi dari Pemda dan Kemkes sebetulnya ketika sepanjang tidak bertentangan, kita bisa ambil yang di atasnya, Bu. Misalnya, contoh tadi di peraturan daerah ini hanya general, tapi ketika kita mau menjelaskan secara eksplisit, kita bisa mengakomodir atau mengakomodasi dari peraturan yang lebih tinggi, (IB) Kalau menurut saya, memang itu menjadi sinergitas, Jadi, kalau BPKP sebelumnya memang menjadi inisiasi untuk, baik itu untuk pelatihannya, jadi. BPKP itu juga bagi PEMDA sebagai pembimbing juga membimbing kami di SPIP-nya, di manrisnya. Dan beberapa kali juga kami mengikuti pelatihan di BPKP itu diselenggarakan di Dinas Kesehatan. (NE) pengaruh regulasi, kebijakan pemerintah, atau tuntutan eksternal untuk menyeimbangkan pelayanan cepat dengan prinsip kehati-hatian berbasis risiko Sebetulnya tergantung dari niatan ya, niatan dari teman-teman. Artinya dari pimpinan manajemen memberikan kepercayaan ataupun semangat kepada teman-teman staf di rumah sakit itu bahwa yang utamanya adalah mereka harus memberikan pelayanan yang paripurna, yang terbaik. Disamping kalau misalnya mau apakah itu salah atau tidak, itu sesuai dengan Pergub. Hal ini harus diingatkan kembali, didampingi oleh manajemen yang	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	mengingatkan. Tapi nomor satu adalah pelayanan masyarakat itu tidak boleh mengecewakan. Dan harus ada yang mantau, harus ada yang ditunjuk seperti MPP-nya. MPP-nya itu harus berperan supaya mengantisipasi permasalahan. (YE) kebijakan di internal rumah sakit sudah sesuai tidak dengan tadi yang ibu sebut ada dari BPKP : Belum, di Dewas sendiri sama dinas juga masih belum sinkron. (YE) Kalau untuk menyesuaikan, sebetulnya ketika sepanjang tidak bertentangan, kita bisa ambil yang di atasnya, Bu. Misalnya, contoh tadi di peraturan daerah ini hanya general, tapi ketika kita mau menjelaskan secara eksplisit, kita bisa mengakomodir atau mengakomodasi dari peraturan yang lebih tinggi, (IB)	
Observasi	Praktik ERM di RSUD Tarakan selaras dengan regulasi nasional dan daerah serta dipahami sebagai bagian dari SPIP untuk menjamin mutu, keselamatan, dan kepatuhan pelayanan publik. Struktur dan pengawasan ERM telah berjalan melalui komite mutu, SPI, dan Dewan Pengawas, namun koordinasi dan panduan operasional masih berorientasi kepatuhan dan belum sepenuhnya strategis.	
Dokumentasi	Pergub DKI No. 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko menjadi rujukan utama; Permendagri 79/2018 dan UU 17/2023 memberikan legitimasi normatif tata kelola dan pelayanan Kesehatan UU 17/2023 dan PP 28/2024 menegaskan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkeadilan; dokumen program kerja ERM RSUD memuat fokus risiko klinis dan non-klinis.	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Pergub 122/2020 mengatur Unit Pemilik Risiko (UPR); regulasi Dewan Pengawas mengatur fungsi oversight; dokumen internal RS menetapkan struktur manajemen risiko. Pergub 122/2020 secara eksplisit mengaitkan manajemen risiko dengan SPIP; penguatan peran BPKP dan Inspektorat tercermin dalam kebijakan daerah. UU 17/2023, PP 28/2024, dan regulasi daerah menunjukkan pembagian peran pusat–daerah yang komplementer. Pergub 122/2020 bersifat kerangka umum; dokumen internal RS dan standar akreditasi menyediakan panduan teknis implementasi. Regulasi Dewas BLUD dan Pergub pengawasan menegaskan fungsi kontrol dan pelaporan akuntabel.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan kesesuaian tinggi antara regulasi eksternal dan internal ERM di RSUD Tarakan tanpa konflik normatif, dengan regulasi internal berfungsi mengoperasionalkan mandat publik. Namun, penerapan ERM masih dominan sebagai mekanisme kepatuhan administratif, belum dimanfaatkan sebagai instrumen tata kelola strategis. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan ERM terletak pada keselarasan regulatif, sementara tantangannya adalah reposisi ERM sebagai pengungkit kinerja dan penciptaan nilai publik.

h. Ketersediaan anggaran

Tabel 4.16
Triangulasi data Ketersediaan Anggaran

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>untuk Manris kita masuk di pembiayaan di Pendidikan pelatihan di SDM dan Diklit, untuk honor honor narsum, BPKP, MenparRB, dari kemkes, honor narsum sangat fleksibel digunakan, untuk sarana prasarana, forum diskusi, lokakarya untuk masukan masukan dari stake holder dari pihak ekterbal dengan sangat mudah di fasilitasi anggaran, tidak ada kamar khusus manris, untuk anggaran tadi tertulis untuk manris, untuk pelatihan manris, peningkatan kompetensi. (WP)</i> <i>Terkait litigasi, apabila ada klaim tuntutan apakah post di anggaran : Ada, kita punya lawyer di RS ada post nya di kesekretariat dan legal, semua dibawah wadir adminkeu (WP)</i> <i>Terkait anggaran, Kalau nomenklatur. Kita BLUD, punya dua yaitu yang bersumber APBD sama BLUD. Selama ini belum pernah ditulis anggaran untuk manajemen risiko, tidak ada, tapi semua masuk dan pengusulan atau kebutuhan semua yang berhubungan dengan manris tidak ada. (NK)</i> <i>sepertinya tidak, tidak ada anggaran khusus, sepintas ya bu saya tidak melihat itu. (YE)</i> <i>Secara khusus ga ada. Harusnya ada ya, Bu. karena kan kalau kita bikin program, terus program itu kalau nggak ada dananya ya, gimana bisa dijalankan? Karena program banyak, (FK)</i>	ERM belum diposisikan sebagai investasi strategis dalam penganggaran, melainkan terfragmentasi dalam kegiatan operasional tanpa budget tagging yang jelas. Ketiadaan anggaran khusus ERM merupakan praktik yang disadari secara organisasi, sehingga ERM penting secara normatif namun belum terinstitusionalisasi dalam kebijakan fiskal rumah sakit

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>nggak ada khusus manajemen risiko, tapi kalau misalnya dilihat dari matriks yang kita punya, misalnya pelatihan hospitality gitu ya saat itu terjadi dan lain-lain gitu kan. (YD&FN)</i>	
Observasi	Tidak ditemukan pos anggaran khusus ERM dalam struktur RBA/RKA. Kegiatan terkait manajemen risiko (pelatihan, audit, K3RS, patient safety) teramati berjalan melalui pembiayaan unit lain dan program umum rumah sakit.	
Dokumentasi	Dokumen Renstra Bisnis RSUD Tarakan 2023–2026, Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2024, Program Kerja Manajemen Risiko 2020, serta Peta dan Profil Risiko 2024 tidak mencantumkan nomenklatur anggaran ERM secara eksplisit. Anggaran tercatat pada belanja umum, mutu, K3RS, dan pengembangan SDM.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi data menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran ERM di RSUD Tarakan belum diinstitusionalisasikan secara eksplisit dalam sistem penganggaran organisasi. Secara empiris, observasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak menemukan adanya nomenklatur khusus ERM dalam RBA maupun RKA. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi resmi rumah sakit termasuk Rencana Strategis Bisnis 2023–2026, Laporan Tahunan 2024, Program Kerja Manajemen Risiko, serta Peta dan Profil Risiko yang menunjukkan bahwa aktivitas ERM dilaksanakan melalui pembiayaan tidak langsung, tersebar dalam program mutu, keselamatan pasien, K3RS, dan pengembangan SDM. Konsistensi temuan tersebut dipertegas oleh wawancara informan kunci yang secara eksplisit menyatakan bahwa “tidak ada anggaran khusus manajemen risiko” dan bahwa kegiatan ERM dijalankan dengan memanfaatkan anggaran program lain. Dengan demikian, secara administratif

dan praktis, ERM masih diperlakukan sebagai aktivitas pendukung (*supporting function*), bukan sebagai investasi strategis organisasi.

i. Akuntabilitas

Tabel 4.17
Triangulasi data Akuntabilitas

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Kami setiap tahun mempunyai untuk keterbukaan, informasi publik sarana PPID sangat jalan, organisasi yang informasi publiknya baik sudah mendapat anugerah, kami memiliki mekanisme komunikasi, kita mengundang untuk temu pelanggan, stake holder, LSM, perwakilan masyarakat walikota, camat, pasien, salah satu untuk mendapatkan masukan, kami sampaikan terkait anggaran, program, peningkatan pelayanan. Akuntabilitas politik itu juga kami merespons terhadap kebijakan kebijakan baru dari gubernur, Kemendagri, PERSI dan Kemkes, ada juga di medsos beberapa informasi yang harus disampaikan.</i> <i>Anggaran kami di posting, masyarakat bisa melihat anggaran setiap apabila ada pengadaan barang jasa, masyarakat bisa melihat kita punya anggaran berapa dan akan beli alkes apa, secara aspek legal LHKPN, SPO SPO standar pelayanan di publish ke masyarakat bisa kritisi kita juga. dilihat di PPID, laporan keuangan, laporan tahunan, juga ada di website kita terkait zona integritas WBK juga ada. Untuk manajerial kinerja RS, bed management, system rujukan, JAK - conncted, JAK-Stroke, untuk layanan layanan yang di publish ke masyarakat.(WP)</i> <i>Keterbukaan publik di website dan adanya PPID, Instagram, juga dalam proses pengawasan dari public terkait keterbukaan public (SH)</i>	Akuntabilitas moral telah hadir sebagai nilai dan komitmen simbolik, namun belum dilembagakan menjadi mekanisme pengendalian organisasi berbasis risiko. Nilai moral belum sepenuhnya dikonversi menjadi sistem evaluasi dan insentif. Akuntabilitas politik sangat kuat dan dominan, namun berorientasi pada kepatuhan vertikal. Ruang diskresi manajerial berbasis risiko dan kebutuhan warga masih terbatas. Akuntabilitas legal terpenuhi secara formal dan prosedural. Kepatuhan regulasi tinggi, namun pendekatan masih compliance-driven dan belum

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>kalau yang ini, yang pasti preventifnya kita sampaikan, bagaimana aspek medical legal itu melekat kepada semua pemberi layanan kesehatan? (NK)</i> <i>Kalau managerial accountability, seperti pelaporan kinerja : Jadi kita udah di kunci tadi, Perkin itu yang secara sistemik diatur sama Pemprov Dinas Kesehatan dan disepakati oleh Pak Gubernur. Itu di level eselon 2-3 yaitu Pejabat pejabat struktural sampai kabag kabid dan tugas rumah sakit adalah meng-cascadingkan sampai habis, jadi kalau kita lagi cascading itu seru banget. Ini tanggung renteng, (NK)</i> <i>yang pasti, proses proses untuk kredensialing, pelatihan dokter punya pemantauan. Kebutuhan ditugaskan kesini, butuh kompetensinya apa, dilihat lagi RKK-nya. RKK yang terakhir dia ternyata ditempatkan. di ruang ini. Oh, sekarang dipindah di ruang ini. Berarti skill-nya beda. Dia harus dapat ini. salurannya bisa pakai dikirim all offline. Bisa webinar. Sekarang pemprop DKI punya banyak. Punya Si Jule, Sistem Informasi Jakarta U Learning. Jadi, dengan itu terbuka lebar. Di dalamnya isinya modul banyak banget. Dan itu bisa diambil kapan saja dan ada sertifikat. Punya pemprop DKI, dua-duanya yang punya pemprop DKI.dari klinis juga ada. Hospitality bakal udah masuk ke sana. Layanan Kesehatan Hospitality. Tapi itu kan yang khusus bisa diakses ASN DKI Jakarta. Dikasih akses, dikasih ini. Kalau Untuk yang itu kan LMS. (NK)</i>	sepenuhnya risk-informed. Akuntabilitas manajerial kuat secara administratif, namun belum sepenuhnya berbasis Enterprise Risk Management (ERM). Kinerja dinilai lebih sebagai output pelaporan dibanding instrumen manajemen risiko. Akuntabilitas profesional berjalan aktif, namun belum terintegrasi secara sistemik dengan ERM. Pengembangan kompetensi masih berorientasi individu, bukan risk-based professional governance.
Observasi	Akuntabilitas Moral Pimpinan dan tenaga kesehatan menunjukkan komitmen normatif terhadap keselamatan pasien, mutu layanan, dan nilai etika pelayanan publik. Praktik preventif medical-legal ditekankan dalam diskursus pimpinan,	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	namun masih bersifat normatif dan individual. Akuntabilitas Politik Implementasi kinerja rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Target kinerja bersifat top-down melalui perjanjian kinerja dan cascading sasaran. Akuntabilitas Legal Praktik preventif aspek medico-legal disosialisasikan kepada tenaga kesehatan. Kredensial, pelatihan, dan pemantauan kompetensi berjalan, namun lebih bersifat administrative Akuntabilitas Manajerial Sistem pelaporan kinerja, perjanjian kinerja, dan cascading sasaran berjalan sistematis. Namun pemanfaatan data risiko untuk pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Akuntabilitas Profesional Kredensial tenaga medis, pelatihan berkelanjutan, dan LMS (Si Jule, webinar) tersedia luas. Namun kebutuhan kompetensi berbasis risiko belum sepenuhnya terpetakan	
Dokumentasi	Nilai etika, keselamatan pasien, dan budaya mutu dinyatakan eksplisit dalam Renstra/RSB dan Laporan PMKP 2024, namun belum teroperasionalisasi sebagai indikator kinerja moral yang terukur Laporan Tahunan dan Renstra menunjukkan keselarasan kuat dengan visi–misi Gubernur dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta kepatuhan pada mandat politik daerah Dasar hukum SPIP, manajemen risiko, dan regulasi kepegawaian terdokumentasi lengkap dalam Peta & Profil Risiko 2024 serta Renstra.	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Laporan Tahunan 2021–2024 menunjukkan capaian KPI, SPM, dan BLUD yang terukur, tetapi belum terintegrasi dengan profil risiko sebagai dasar Keputusan Dokumen PMKP dan laporan tahunan mencatat pelatihan, mutu klinis, dan clinical pathway, tetapi keterkaitannya dengan profil risiko masih parsial.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa akuntabilitas di rumah sakit publik telah berjalan secara multidimensional, namun masih dominan normatif, compliance-driven, dan sektoral. Akuntabilitas moral belum terlembaga dalam sistem kinerja berbasis risiko, sementara akuntabilitas politik, legal, manajerial, dan profesional berfungsi administratif dan terfragmentasi. Akibatnya, akuntabilitas belum terorkestrasi dalam satu kerangka ERM yang *risk-informed* dan berorientasi pada nilai publik.

j. Keterlibatan Pemangku kepentingan

Tabel 4.18

Triangulasi data Keterlibatan Pemangku kepentingan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Eksternal kita banyak yang pertama dinas kesehatan, habis itu Dewan Pengawas, habis itu Pem Prop DSKI, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, asuransi. Terus jejaring kita, (NK)</i> <i>hubungannya ada yang sifatnya murni sebagai jejaring pelayanan Biasanya sama rumah sakit, sama fasyankes sama klinik. Kemudian yang kedua stakeholder penelitian, pendidikan latihan juga punya kami sebagai rumah sakit yang sudah pendidikan tipe B dan kami juga sudah mendapatkan sertifikasi di DIKLAT Paripurna baru kemarin. Jadi kami boleh jadi latihan yang bersertifikasi. Yang ketiga, kami</i>	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam ERM masih ad hoc, berfokus pada pelaporan dan umpan balik, belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>juga sudah proses ditunjuk jadi RSPPU. RSPPU web based pendidikan spesialis berbasis rumah sakit untuk Bedah ditunjuknya sudah berproses. Itu yang pendidikan pelatihan penelitian. Kemudian, kalau untuk pelayanan yang tadi BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, asuransi, sama kantor-kantor administrasi jaminan. (NK)</i> <i>Belum terlibat, Dinkes juga masih belajar juga. (YE)</i> <i>kalau manajemen risiko ini kan stakeholdernya. kayak dinas kesehatan ataupun DPRD. dilibatkan DPRD itu pada saat pimpinan yang keluar ya, Ibu misalnya terkait dengan anggaran misalnya, harus di efisiensi atau butuh, (FK)</i> <i>kita ada forum komunikasi lurah, camat sampai walikota. Tidak. Tidak secara eksklusif. Itu sebagai bahan Forum komunikasi. Ya, dari situ misalnya ada kemungkinan-kemungkinan yang sering kita alami gitu-gitu. (YD&FN)</i> <i>Pemangku kepentingan sebetulnya sudah terlibat, Karena pucuk dari manajemen risiko sendiri ada dari direktur. Strukturnya saya lupa, tapi setahu saya paling tinggi itu ada di direktur. Terus, di bawahnya ada di wakil direktur pelayanan sampai di anggota anggotanya. (IB)</i> <i>kalau dinas kesehatan sebetulnya sudah terlibat.</i> <i>: Mungkin setelah penyusunan, setelah penyusunan dilaporkan ke dinas kesehatan dan manajemen risiko ini juga menjadi Perkinnya Direktur bahkan di tahun yang lalu kita sudah BIMTEK dengan BPKP ada 4 kali. Karena semua rumah sakit, semua puskesmas harus memiliki manris Jadi, berhubungan dengan ini, menjadi Perkinnya pimpinan masing-masing juga. (NE)</i>	risiko. ERM masih bersifat internal-centric dan belum berkembang sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif.
Observasi	Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam manajemen risiko belum bersifat sistematis dan berkelanjutan, lebih dominan	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	melalui forum komunikasi umum dan agenda tertentu pimpinan. Teramati adanya forum komunikasi dengan lurah, camat, hingga wali kota, namun tidak secara khusus difokuskan pada manajemen risiko. Pelibatan DPRD dan Dinas Kesehatan terjadi terutama saat pembahasan anggaran atau pelaporan pimpinan, bukan dalam siklus risiko secara utuh. Partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan pengguna layanan diakomodasi melalui mekanisme evaluatif, bukan struktural. Keterlibatan pemangku kepentingan internal lebih dominan dibandingkan eksternal, dengan pusat kendali berada pada direktur dan jajaran manajemen.	
Dokumentasi	Terdapat bukti formal komunikasi dan pelaporan kepada pemangku kepentingan eksternal, namun belum menunjukkan mekanisme kolaboratif dalam pengambilan keputusan risiko. Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2024 menunjukkan akuntabilitas kinerja kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keterbukaan terhadap umpan balik eksternal Laporan Tahunan 2024 Dokumen rapat sosialisasi penerapan manajemen risiko dan pemantauan risiko menunjukkan kehadiran unsur internal rumah sakit, tanpa keterlibatan aktif pemangku kepentingan eksternal dalam proses mitigasi risiko Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan pelibatan masyarakat dalam penilaian mutu layanan dan umpan balik kinerja pelayanan public	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan telah berlangsung, namun

masih didominasi oleh pola administratif dan hierarkis, bukan kolaboratif. Secara empiris, pemangku kepentingan eksternal seperti Dinas Kesehatan, DPRD, BPJS, dan jejaring layanan lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaporan, sosialisasi kebijakan, serta pembahasan anggaran tertentu, sementara keterlibatan langsung dalam siklus manajemen risiko (identifikasi, analisis, dan perlakuan risiko) masih terbatas. Temuan ini konsisten dengan bukti dokumentasi berupa laporan tahunan dan notulen kegiatan sosialisasi manajemen risiko yang menegaskan bahwa proses pengelolaan risiko dikendalikan terutama oleh struktur internal rumah sakit, dengan direktur sebagai aktor kunci akuntabilitas organisasi. Pola tersebut merefleksikan praktik akuntabilitas administratif yang kuat, namun belum sepenuhnya mengarah pada tata kelola risiko yang bersifat *multi-stakeholder*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola risiko di RSUD Tarakan masih memerlukan penguatan pendekatan partisipatif dan kolaboratif agar pengelolaan risiko tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu membangun keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan risiko secara lebih integratif dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik modern, pendekatan *collaborative governance* menjadi penting untuk menjembatani kompleksitas hubungan antaraktor dalam tata kelola rumah sakit.

Dalam penerapan ERM di rumah sakit, *collaborative governance* memungkinkan keterlibatan manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, regulator, BPJS, organisasi profesi, serta masyarakat dalam proses identifikasi risiko, penetapan prioritas risiko, penyusunan strategi mitigasi, dan evaluasi tata kelola risiko. Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan risiko karena keputusan yang dihasilkan merupakan hasil konsensus dan *shared understanding* antar aktor organisasi. Selain itu, mekanisme kolaboratif mendukung terbentuknya *just culture*, meningkatkan transparansi, mengurangi konflik kebijakan, serta memperkuat integrasi antara tata kelola, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, pendekatan *deliberative policy* dan *collaborative governance* dapat dipahami sebagai mekanisme integratif dalam pengembangan model ERM di rumah sakit. Integrasi antara COSO ERM dengan paradigma OPA, NPM, dan NPS tidak dilakukan secara linear maupun teknokratis, tetapi melalui proses sosial dan kelembagaan yang bersifat deliberatif dan kolaboratif. Pendekatan ini menghasilkan model ERM yang lebih kontekstual, adaptif,

partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik, khususnya rumah sakit publik yang memiliki kompleksitas tata kelola dan tanggung jawab pelayanan kepada Masyarakat.

k. Budaya sadar risiko

Tabel 4.19
Triangulasi data Budaya sadar risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>budaya sadar risiko, belum ada. (YD)</i> <i>kepatuhan penggunaan APD yang tadi dokter sampaikan, itu memang untuk petugasnya sendiri. Kalau kita lihat, memang selalu memakai APD lengkap, artinya memang sudah diterapkan. Hanya, kadang-kadang ada yang petugas tidak menyadari, jadi misalnya dia pakai sarung tangan satu untuk memegang semuanya, harusnya diganti terus, setiap pasien lain harus diganti (DD)</i> <i>budaya itu sesuatu yang membutuhkan kontinuitas dari manajemen, yang terkait dengan saya, tentunya yang bisa mencegah infeksi itu bisa terjadi dan itu harus selalu diulang. Salah satu hal yang paling penting tentunya ada komitmen dan SOP yang kita buat itu menjadi acuan bagi masyarakat khususnya para staf. (DD)</i> Komplain <i>Kayak tentunya terkait juga dengan complain, kita sih melakukan identifikasi, lah kalau ada sesuatu yang sesuai atau komplain dari pasien atau customer dan setelah itu kita harus menginformasikan. (TH)</i> Pemahaman budaya Sadar risiko <i>Ya, budaya sadar risiko kalau saya melihatnya, belum sepenuhnya. Tetap harus pakai reminder, Makanya kita upayanya segala macam cara untuk mengingatkan teman-teman</i> <i>Terkait dengan pekerjaan di instalasi gizi , secara tidak langsung sih, walaupun</i>	Budaya sadar risiko telah hadir secara teknis dan normatif, namun belum terinternalisasi sebagai mindset kolektif dan masih bersifat prosedural. Pembelajaran risiko belum berkelanjutan , sehingga budaya risiko berada pada fase transisional dari reaktif menuju preventif, belum menjadi embedded culture.

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i> mungkin istilah sadar risiko itu belum begitu membudaya di dalam instalasi gizi, tapi setidaknya mereka sudah tahu, mungkin berawal dari standar pelayanan umum. (TH)</i> <i> Mungkin belum maksimal, ya, dalam arti kata belum semua dokter. (LH)</i> <i> di Komite Medik Ibu, khusus Komite Medik yang sadar risiko, jadi kami pada saat audit medis itu kami memberikan, kan ada hasil saranan rekomendasi untuk aware lah, apalagi ada kasus tertentu, misalnya memang sampai ada kompleks pasien-pasien yang misalnya seperti itu.</i> <i> Biasanya nanti kami akan bilang, oh iya, dokter wajib ya, visit gitu.</i> <i> Kan kemarin-kemarin ada kasus, nah otomatis karena ada satu kejadian mungkin yang dulu visitnya tidak bagus, jadi sekarang jadi lebih baik lah ya semua. (LH)</i> <i> Budaya sadar risiko , belum (FK)</i> <i> Kalau dibilang sudah ada sebagian, dibilang belum juga ada.</i> <i> Mungkin dari Man-nya ada perubahan budaya kerja, budaya keselamatan, harus pentingnya. Terus sadar risiko, jadi sebelum ada sesuatu yang terjadi, kita mencegah risiko itu mencegah terjadi. Jadi kalau saya maunya seperti itu. Tapi namanya budaya itu kadang-kadang sudah lama, dan itu merubah Itu mungkin perlahan, agak susah. (RM)</i> <i> Kalau perilakunya misalnya identifikasi pasien, apabila salah identifikasi, harus double check. Kemudian juga untuk masalah penggunaan alat APD seperti itu. (BR)</i> <i> Untuk budaya sadar risiko itu, itu memang sebaiknya harus bisa dilaksanakan, berjalan dengan spontan, tanpa ada paksaan , dan petugas itu sendiri harus menyadari bahwa ada risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. yang tadi saya berika contoh untuk yang lift, untuk risikonya ada risiko hukum. Misalnya,</i>	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>rumah sakit bisa dituntut kalau ada kejadian. Lift-nya anjlok sehingga harus benar-benar dilaksanakan betul. Jadi, tidak meremehkan dengan bilang “begini doang”. tetapi harus bisa diterapkan. (FS)</i> Risiko kesalahan obat <i>Pertama, di farmasi budaya sadar risiko itu harus melekat, karena kaitannya dengan obat, risiko kesalahan obat harusnya nol, medication error terutama di indikator mutu juga harus nol. Itulah makanya saat dari mulai proses, dari kita mulai menerima adanya pengkajian, itu merupakan upaya menurunkan risiko. Jadi resep masuk, dikaji dulu oleh apoteker kemudian saat pengerjaan dihitung ulang, terus adanya TBAK , siapa yang mengerjakan itu harus ada sign di situ, jadi setiap proses berbeda, yang mengerjakan maksudnya supaya ada cross-check, itu upaya kami untuk menurunkan adanya risiko. (IS)</i> <i>untuk budaya risiko, kalau di laboratorium kita berhadapan dengan sampel-sampel infeksi yang cukup banyak. Hal yang kita tahu risiko-risiko yang akan mereka dapatkan kalau mereka tidak ada budaya risiko untuk kami juga memitigasi risiko-risiko yang akan bisa terjadi. Jadi, setiap bulan itu kami melakukan mitigasi risiko-risiko yang terjadi, Jadi budaya risiko itu sudah diterapkan. (BR)</i> Tidak didampingi Manajemen <i>sebetulnya, kalau dilihat dari pelatihan yang kemarin dihadiri oleh staf-staf di bagian komite mutu, mereka itu rajin-rajin, artinya, mau dan semangat. Mereka merasa agak kecewa karena tidak didampingi oleh manajemen. Sehingga mereka juga bertanya, apakah benar nih yang kita hitung ini? Apa sudah sesuai belum dengan risiko yang ada di lapangan? Buktinya tadi, yang ada kesalahan-kesalahan, seharusnya bisa diantisipasi. (YE)</i>	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Observasi	Kesadaran risiko tampak dalam praktik harian, namun masih situasional dan memerlukan pengawasan. Kepemimpinan berperan melalui sosialisasi dan Klinik Budaya, meski pendekatan no blame belum konsisten. Pembelajaran risiko belum merata dan pemahaman dampak risiko masih terbatas, sehingga budaya sadar risiko menguat pascakejadian dan belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan.	
Dokumentasi	Program Manajemen Risiko RSUD Tarakan dan Peta Risiko 2024 menunjukkan identifikasi risiko klinis, infeksi, fasilitas, dan etik-hukum telah terdokumentasi sistematis. SK Direktur tentang Penyelenggaraan Klinik Budaya Kerja menetapkan struktur, tim, dan mandat formal pembinaan budaya kerja berbasis nilai dan keselamatan. Undangan, daftar hadir, materi, dan dokumentasi foto Klinik Budaya serta IHT Keperawatan Maret 2025 menunjukkan pelaksanaan pembelajaran budaya kerja dan risiko secara formal Materi Klinik Budaya mengintegrasikan BerAKHLAK, hospitality, keselamatan pasien, komunikasi efektif, dan penanganan komplain. Program Manajemen Risiko RS dan profil risiko tahunan menunjukkan keberlanjutan secara dokumen, namun belum secara eksplisit menilai maturitas budaya risiko.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil triangulasi, bahwa budaya sadar risiko di RSUD Tarakan telah hadir pada level praktik teknis dan kepatuhan prosedural, namun belum terinternalisasi sebagai mindset kolektif organisasi. Kesadaran risiko umumnya muncul secara situasional, dipicu oleh pengawasan, insiden, atau komplain, serta masih memerlukan reminder berulang, sehingga belum berjalan spontan dan konsisten lintas unit dan profesi. Meskipun telah didukung oleh kerangka tata

kelola formal melalui program manajemen risiko, klinik budaya, dan pelatihan, proses internalisasi nilai sadar risiko masih bersifat episodik dan selektif, serta belum berkembang menjadi mekanisme pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, budaya sadar risiko berada pada fase transisional dari pendekatan reaktif menuju preventif, namun belum mencapai tahap *embedded risk culture* yang berfungsi sebagai instrumen strategis perlindungan nilai publik dan keselamatan pelayanan.

1. Kompetensi SDM terhadap risiko

Tabel 4.20
Triangulasi data Kompetensi SDM terhadap risiko

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Kalau saya, sudah pernah. Tahun 2022, setelah itu belum ada lagi. Jadi mungkin terbatas ke kita yang Kordinator atau instalasi. Tapi ke bawahnya belum. jadi masih tataran level ini ya. Tety (TH)</i> <i>belum ada pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti friska (FS)</i> <i>sudah pernah mengikuti pelatihan Santi (SS)</i> <i>kalau saya kan baru, jadi Belum (LH)</i> <i>Belum Gracia (GR)</i> <i>Belum. Tapi kalau Medico legal, iya,. Jadi para, dokter harus gini supaya menghindari segala resiko penuntutan, (LH)</i> <i>Ada. Maksudnya program diklatnya. kan peningkatan kompetensi 20 jam pelatihan. yang bertopik ke manajemen risiko : klinik budaya. Jadi di klinik budaya tadi, kita memberikan pelatihan. berupa pelatihan hospitality. tentang bagaimana penerapan budaya kerja. Untuk yang masuk ke klinik budaya ini, sasaran adalah pembinaan pegawai. Jadi itu adalah orang-orang yang mungkin di lapangan mendapatkan</i>	Kompetensi risiko SDM masih parsial dan tidak terstandar, bergantung pada individu, sehingga belum menjadi kapabilitas organisasi. Pengembangan kompetensi risiko masih bersifat umum dan belum diposisikan sebagai kapabilitas strategis, menunjukkan gap antara kebijakan dan implementasi..

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>komplain. Maksudnya komplain itu adalah terkait perilakunya di klinik. (FK)</i> <i>Kalau nggak salah ya 2022 sama Maksudnya setelah itu ada sih yang Pak Diki. Pak Diki pelatihan Manajemen risiko Tahun berapa? 2025 Dari BPSDM. BPSDM itu dari BPSDM Pemprov DKI (FK) 2001. . (YD&FN)</i> <i>Pelatihan manajemen risiko saya belum (RM)</i> <i>Kami bentuknya in house, Kita setiap kali ada petugas yang akan masuk ke wilayah kita atau petugas yang sudah lama bekerja dalam pelatihan itu dapat mengikuti kembali, kita menyelenggarakan suatu kegiatan di ruang pertemuan termasuk memaparkan apa saja yang bisa menjadi kegiatan yang berisiko terkait pencegahan kondisi infeksi. (DD, BR, FS)</i> <i>Saya sudah mengikuti di rumah sakit sebelumnya, Tapi kalau di RS Tarakan belum. (BR)</i> <i>pernah dilaksanakan 2 hari dengan dr.Arjaty (FS)</i> <i>kalau pelatihan kebetulan belum pernah saya ikut karena 2022 saya belum menjabat sebagai kepala instalasi dan bukan timnya untuk manajemen risiko. (IS)</i>	
Observasi	Observasi lapangan menunjukkan bahwa kompetensi SDM terkait manajemen risiko belum merata di seluruh level organisasi. Pemahaman risiko lebih dominan pada level pimpinan, koordinator, dan unit tertentu yang pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan. Di tingkat pelaksana, implementasi masih bersifat prosedural dan reaktif, terutama pada area klinis dan pengendalian infeksi, tanpa pemahaman konseptual ERM yang utuh. Kegiatan in-house training dan	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	pembekalan risiko dilakukan secara sporadis, belum terstruktur sebagai kurikulum berkelanjutan lintas unit.	
Dokumentasi	Dokumen Undangan dan Notulen Rapat Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko dan Pemantauan Risiko (2022) menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi formal yang melibatkan pimpinan, kepala unit, dan tim mutu. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum pelatihan berjenjang atau sertifikasi kompetensi risiko untuk seluruh SDM. Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan Tahun 2020 memuat aktivitas manajemen risiko, tetapi belum secara eksplisit menempatkan pengembangan kompetensi SDM risiko sebagai program strategis utama. Renstra Bisnis RSUD Tarakan 2023–2026 menegaskan peningkatan kompetensi SDM sebagai sasaran strategis, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan kompetensi manajemen risiko organisasi.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa kompetensi SDM dalam pengelolaan risiko di RSUD Tarakan belum merata, terstandardisasi, dan berkelanjutan. Pelatihan masih terbatas pada sebagian aktor, bersifat insidental dan prosedural, sehingga praktik ERM bergantung pada individu, bukan menjadi kapabilitas organisasi yang terinstitusionalisasi.

m. Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi

Tabel 4.21

Triangulasi data Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>SDM selama ini punya perannya, SDM punya klinik budaya saja keren banget menurut saya begitu masuk sini saya heran gitu iya Bu. Daripada kita harus</i>	Klinik Budaya di RSUD Tarakan diimplementasikan melalui komitmen

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>ngurusin ini sampai hukdis sampai ke sana kemari, kita bina dulu, ternyata SDM mempunyai kepedulian untuk mengawal bagaimana moral dan etika itu berjalan. (NK)</i> <i>Kalau dari SDM-nya, saya kurang paham hanya kalau saya lihat belum Kalau SDM memberikan pembinaan atau bagaimana, saya tidak begitu mengetahui, mungkin di SDM juga katanya ada seperti itu. Hanya saya tidak mengetahui lebih mendalam terkait SDM. (RM)</i> <i>Kalau terjadinya risiko, sebetulnya ada beberapa hal, biasanya di bagian SDM itu salah satunya diambil pakta integritas. Misalkan contoh terhadap risiko pelepasan informasi medis, di bagian SDM mengarahkan pakta integritas bagi setiap pegawai. Bahwa setiap pegawai yang bekerja memiliki user ID untuk akses, yang memiliki akses untuk rekam medis, untuk wajib menjaga kerahasiaannya. (Imam)</i> <i>Ada pakta integritasnya (IB)</i> <i>Di awal mungkin iya, karena di awal belum terpapar, belum terinformasi. Kalau sekarang, misalnya kita menanyakan tentang manajemen risiko, mereka welcome. (NE)</i>	pimpinan yang dilembagakan secara formal, dengan tata kelola, mekanisme pembelajaran berbasis kompetensi, serta sistem evaluasi dan monitoring yang menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem organisasi, bukan sekadar pendekatan normatif. Dengan mengintegrasikan nilai BerAKHLAK ke dalam praktik pelayanan, keselamatan pasien, dan mutu layanan, Klinik Budaya berfungsi sebagai instrumen strategis perubahan budaya organisasi jangka panjang dalam kerangka pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi nilai publik.
Observasi	Klinik Budaya Kerja didukung kuat oleh komitmen pimpinan dan dilaksanakan secara terstruktur, interaktif, dan berkelanjutan. Sosialisasi nilai BerAKHLAK, pelatihan keperawatan, dan simulasi hospitality berjalan aktif dengan evaluasi pascakegiatan, menunjukkan upaya sistematis dalam internalisasi nilai dan perbaikan berkelanjutan.	
Dokumentasi	SK Direktur RSUD Tarakan tentang Penyelenggaraan Klinik Budaya Kerja dan pembentukan Tim Penyelenggara;	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	surat tugas pimpinan dan daftar hadir pimpinan pada kegiatan sosialisasi dan IHT. SK Tim Penyelenggara Klinik Budaya Kerja; lampiran struktur tim, tugas, dan fungsi; surat tugas fasilitator dan narasumber IHT Klinik Budaya Keperawatan. Undangan resmi, surat tugas, daftar hadir peserta dan narasumber, serta dokumentasi foto kegiatan Sosialisasi BerAKHLAK ASN. Dokumen IHT Klinik Budaya Keperawatan (jadwal, daftar peserta, daftar fasilitator), surat tugas, dan bukti foto pelaksanaan Format penilaian Klinik Budaya (hospitality, komunikasi efektif, PPI, handling complaint) dengan kriteria dan standar kelulusan. Ketentuan evaluasi dan monitoring dalam SK Direktur; format penilaian Klinik Budaya dan mekanisme tindak lanjut. SK Direktur menyebutkan Klinik Budaya dilaksanakan secara berkala (minimal tahunan); dukungan anggaran BLUD	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi data menunjukkan bahwa komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi di RSUD Tarakan telah terbangun secara institusional dan operasional, meskipun tingkat pemahaman dan persepsi antar informan belum sepenuhnya seragam. Secara normatif dan struktural, komitmen tersebut dilembagakan melalui kebijakan formal seperti Klinik Budaya, pakta integritas, SOP, serta mekanisme pembinaan dan evaluasi yang terdokumentasi secara

resmi. Secara empiris, observasi memperlihatkan keterlibatan aktif pimpinan dan SDM dalam sosialisasi nilai BerAKHLAK, pelatihan berbasis kompetensi, serta praktik pelayanan yang menekankan etika, keselamatan pasien, dan mutu layanan. Perbedaan tingkat pengetahuan sebagian informan justru menegaskan bahwa budaya dan etika organisasi merupakan proses yang membutuhkan kontinuitas manajerial, bukan kondisi yang terbentuk secara instan. Dengan demikian, Klinik Budaya berfungsi sebagai instrumen strategis penguatan komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi yang dijalankan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola organisasi publik.

n. Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko

Tabel 4.22

Triangulasi data Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>unit sudah menjalankan, kita sudah ada SPO untuk reward & Funishment sesuai peraturan gubernur terkait peraturan kepegawaian, reward tidak selamanya uang tetapi kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan, lomba ke luar kota gugus kendali mutu, ada inovasi yang dilakukan teman teman, dalam system remunerasi ada yang namanya insentif juga. Point-point dapat ditambahkan dalam koefisien tunjangan kinerja, ada SK Direktur nya. (WP)</i> <i>belum ada sistem penghargaan apresiasi kepada staf (TH)</i> <i>sudah ada dukungan. Tapi apresiasi belum ada. (LH&RO)</i> <i>Belum ada sistem penghargaan apresiasi kepada staf. (FS)</i> <i>Belum, belum ya. Terlalu reward sih. Ucapan terima kasih. (NS)</i> <i>belum ya. reward sih. Ucapan terima kasih. (FK)</i>	Sistem penghargaan budaya sadar risiko belum terlembaga secara formal dan masih bersifat simbolik, sehingga belum terintegrasi dengan kinerja dan perilaku sadar risiko. Akibatnya, penghargaan belum dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>bentuk penghargaan, apresiasi mungkin, bagi unit atau staff karena sudah aktif manajemen resiko</i> <i>Belum. (YD&FN)</i> <i>staf yang kalau dia aktif menerapkan manajemen resiko</i> <i>Belum (dr Renny)</i> <i>penghargaan atau apresiasi ketika ada staf yang melakukan manajemen resiko secara aktif</i> <i>Belum (DD,BR,FS)</i>	penerapan ERM.
Observasi	Tidak ditemukan sistem penghargaan formal berbasis manajemen risiko; penguatan budaya sadar risiko lebih dilakukan melalui pembinaan dan edukasi. Pengakuan bersifat informal dan belum terintegrasi dengan sistem kinerja, sehingga insentif risiko belum menjadi bagian dari strategi SDM organisasi.	
Dokumentasi	Tidak terdapat kebijakan, SOP, atau pedoman khusus yang mengatur sistem penghargaan dan pengakuan bagi individu/unit yang aktif dalam manajemen risiko. Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan lebih menekankan pada identifikasi, analisis, pengendalian, dan evaluasi risiko tanpa skema reward formal. Bukti Klinik Budaya menunjukkan adanya kegiatan pembinaan, pelatihan, dan evaluasi perilaku kerja (hospitality, komunikasi, PPI, handling komplain), namun tanpa konsekuensi reward structural. Laporan PMKP 2024 hanya mencantumkan <i>rekomendasi pemberian reward</i> (misalnya pada kepatuhan APD), namun belum terdokumentasi sebagai kebijakan yang diimplementasikan secara sistematis.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil triangulasi data, bahwa sistem penghargaan dan pengakuan dalam penguatan budaya sadar risiko di rumah sakit belum terlembagakan secara formal. Temuan wawancara mengonfirmasi ketiadaan reward atau apresiasi terstruktur

bagi staf maupun unit yang aktif menerapkan manajemen risiko, sementara observasi memperlihatkan bahwa pengakuan yang muncul masih bersifat informal, simbolik, dan edukatif, seperti ucapan terima kasih atau pelibatan dalam kegiatan pembinaan. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi yang tidak menunjukkan adanya kebijakan, SOP, maupun mekanisme penghargaan yang terintegrasi dengan sistem kinerja mutu dan keselamatan pasien, meskipun terdapat rekomendasi pemberian *reward* dalam laporan PMKP yang belum diimplementasikan secara sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghargaan belum diposisikan sebagai instrumen strategis tata kelola dan budaya organisasi dalam mendukung penguatan manajemen risiko, melainkan masih terbatas sebagai praktik normatif dan pembelajaran internal.

o. *Standard decision by Government* dengan SPM

Tabel 4.23

Triangulasi data *Standard decision by Government* dengan SPM

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Angkanya juga ada yang berbeda. Menurut PEMDA begini, menurut Kemkes begitu. Kita juga bingung (FK)</i> <i>Overlap. ada yang di Pergub nggak ada, di Permenkes ada, tapi akhirnya kita merekap semuanya, jadi semua kita ukur. Karena yang meminta laporan sesuai dengan induknya, Jadi kalau dari dinas kita pakai pergub, kalau dari BPKP kita pakai pergub. Jadi menyiasatinya digabung dulu semua gitu, baru laporannya dibagi. untuk formulirnya kita sudah bagi ke masing. masing unit. Jadi nanti masing-masing unit mengisi sesuai dengan yang ada di unitnya. Nanti kami yang tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan kita. (YD&FN)</i> <i>Itu sih tidak sulit rumah sakit biasanya terlibat; hanya langsung melaksanakan perintah dari peraturan perundangan. Misalkan, contoh ada standar pelayanan minimal yang sudah otomatis dari komite mutu, membuat standarisasi mutunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh peraturan</i>	Implementasi SPM masih compliance-driven dan administratif, berfungsi sebagai instrumen pelaporan, bukan dasar pengambilan keputusan strategis berbasis risiko. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara tujuan normatif SPM dan praktik manajerial di rumah sakit.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>daerah. Jadi kita hanya mengakomodir itu saja dalam panduan standar pelayanan mutunya. (IB)</i>	
Observasi	• Implementasi SPM dijalankan melalui berbagai regulasi (Pergub, Permenkes, Instruksi Dinkes). • Terlihat praktik “rekap dan penyesuaian” indikator akibat perbedaan standar antar regulator. • Unit kerja mengisi indikator sesuai kewenangan masing-masing tanpa satu rujukan terpadu.	
Dokumentasi	• Dokumen SPM, Pergub, Permenkes, dan instruksi teknis tersedia dan digunakan bersamaan. • Laporan SKM Triwulan 2023–2025 menunjukkan capaian IKM konsisten kategori Baik–Sangat Baik, namun unsur waktu pelayanan relatif lebih rendah dan berulang. • Dokumen SKM digunakan sebagai bukti kepatuhan terhadap standar pelayanan publik nasional dan daerah.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data, bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di rumah sakit berlangsung dalam kerangka kepatuhan administratif terhadap beragam regulasi yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan dan tumpang tindih standar antar regulator mendorong praktik adaptif berupa penggabungan dan penyesuaian indikator oleh rumah sakit, sehingga SPM dijalankan secara fragmentaris tanpa satu rujukan keputusan terpadu. Dokumentasi menunjukkan tingkat kepatuhan formal yang tinggi—tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang konsisten berada pada kategori baik hingga sangat baik namun SPM masih lebih difungsikan sebagai instrumen pelaporan dan akuntabilitas eksternal dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif SPM dan praktik pengambilan keputusan manajerial di rumah

sakit.

p. *Performance Index by citizen*

Tabel 4.24

Triangulasi data *Performance Index by citizen*

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>kami punya 9 kanal aduan, baik dari walk-in, google review 4.6, tetapi masih banyak comment “complain is a gift” yang penting berapapun complain yang penting tindak lanjut yang ditekankan bahwa manris, saya melihat dari sisi kemampuan RS kelas A, 45 dokter sub spesialis dan 40 dokter spesialis, mereka all-out dalam melayani pasien. Yang positif juga ada. Ada kanal aduan CRM, Complain ini 1x24 jam harus ditindaklanjuti, itu bahan kami untuk melakukan perbaikan. SPM masih dilaporkan dan rutin. (WP)</i> <i>Kita sangat terbuka kritik dan masukan terutama complain masyarakat, kita tidak mungkin zero complain. Kanal terbuka untuk masyarakat menyampaikan aspirasi terkait layanan kita, layanan pengaduan, layanan banyak sekali, ada membuat forum konsultasi publik mengadakan FGD, menyerap aspirasi dalam rangka perbaikan dan menindaklanjuti terhadap masukan tahun sebelumnya, ada juga CRM, kita harus respons cepat karena langsung ke gubernur, akan dilakukan grading melihat potensi-potensi dan mitigasi, apakah ada potensi yang akan terjadi, misal merah terkait hukum, hijau bisa diselesaikan cepat. CRM – Cepat Respons Masyarakat. (SH)</i> <i>Iya, kami pakai google review yang dapat dilihat dari google, masukan dari pasien kami rekap atau HUMAS punya 9 kanal Untuk menerima keluhan pelanggan. Ada yang berhubungan sama perilaku dokter, yang dokter telat, yang dokternya Judes dan lain-lain, kita sampaikan di audit medik. Walaupun tidak melihat siapa yang salah siapa yang benar kita belum tahu, tetapi itu</i>	Performance Index by Citizen di RSUD Tarakan telah terlembaga melalui SKM dan kanal umpan balik dengan tingkat kepuasan baik, namun pemanfaatannya masih berorientasi pelaporan dan reputasi. Integrasi persepsi warga ke dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berbasis risiko belum optimal

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>yang diterima oleh klien, merupakan experiences nya mereka, pengalaman menjadi kontrak kinerja dokter. (NK)</i> <i>Sama itu, admin saya memberikan pesan sama SDM, kita perkaya jangan hanya ngajarin mereka, Tapi menurut saya. Sikap dan perilaku itu kan yang membuat mereka berperilaku seperti itu ya bu. Saya bilang wellness-nya kesehatannya harus dipikirin. Adminstr mental mungkin ada kondisi-kondisi khusus. Makanya saya hubungkan sama K3 RS Kesehatan Kerja Pegawai sama psikososialnya. Jadi tidak hanya diajarin tidak hanya diajarin bagaimana bersikap yang baik, dandan yang baik, omong yang cantik gitu, Gestur yang bagus gitu, tapi juga digali dan mempertimbangkan Gez mana, pendekatan berbeda. (NK)</i> <i>Sembilan kanal : Citizen Relation Management ada milik Pemprov DKI, aplikasi Citizen Relation Management. Jadi respond cepat, buat penerimaan langsung itu Twitter, X, FB, Tik Tok, Google Review, review, kemudian WA, telepon langsung, Barcode. Habis itu, mana lagi? Banyak. Jadi kita menjadikan itu sebagai kendali moral. (NK)</i> <i>Kami belum bisa lihat admini, admin pengukuran adminis mortalitas, re-admission itu ada. (YE)</i> <i>admini kinerja yang dilihat oleh administrasi Dari Google Review. (RM)</i> <i>Biasanya bagian humas, Nanti apabila misalnya ada review, ada bintangnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini nanti ke kami dilaporkan. Pertama ke Wadir terus disampaikan ke kami bahwa ada Google Review. (RM)</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Fifty-fifty. Bintang lima juga ada maksudnya, pelayanannya, servisnya, perawatnya, dokternya. (RM)</i> <i>Humas, misalnya ada hal perlu kronologis, kami buat kronologisnya, nanti diberikan ke humas, jadi mereka yang akan berhubungan. Kalau memang ada rencana pertemuan, ada hubungan dengan dokter atau saya bisa dipertemukan. Apabila ada permintaan keluarga untuk pertemuan dibuat perjanjian oleh humas. (RM)</i>	
Observasi	RSUD Tarakan memantau kinerja berbasis warga melalui berbagai kanal umpan balik dengan persepsi kepuasan umumnya baik namun bervariasi antar unit. Keluhan ditangani responsif melalui Humas dan pembinaan budaya pelayanan, namun data persepsi warga lebih banyak digunakan untuk klarifikasi kasus daripada sebagai input pengambilan keputusan strategis lintas fungsi.	
Dokumentasi	Laporan SKM menunjukkan mekanisme pengukuran formal kepuasan administrasi melalui administrasi SKM berbasis PermenPANRB No. 14/2017 dengan 9 unsur pelayanan dan pengolahan data administrasi per triwulan. Nilai IKM RSUD Tarakan secara konsisten berada pada kategori Baik–Sangat Baik (± 88–92) pada periode 2023–2024, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Unsur dengan nilai tertinggi umumnya biaya dan persyaratan; terendah waktu pelayanan dan sarana prasarana. Dalam laporan SKM, unsur “Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan” secara konsisten memperoleh nilai tinggi (>90) pada administrasi besar triwulan, serta dilengkapi rencana tindak lanjut formal. Unsur “Perilaku Pelaksana” dalam SKM berada pada kategori baik–sangat baik, namun pada beberapa periode masih termasuk unsur dengan nilai administrasi lebih	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	rendah administra unsur biaya atau persyaratan. Dokumen SKM menempatkan hasil admini sebagai bahan evaluasi dan laporan kinerja administ, dengan tindak lanjut yang bersifat unit-level dan administrative.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di rumah sakit publik berlangsung dalam kerangka kepatuhan administratif (compliance-driven) terhadap beragam regulasi pusat dan daerah yang bersifat tumpang tindih. Praktik adaptif berupa penggabungan dan penyesuaian indikator antar regulasi menunjukkan tidak adanya single integrated decision standard dalam tata kelola kinerja pelayanan publik. Meskipun dokumentasi memperlihatkan tingkat kepatuhan formal yang tinggi tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang konsisten berada pada kategori baik hingga sangat baik SPM masih diposisikan terutama sebagai instrumen pelaporan dan akuntabilitas eksternal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan struktural antara tujuan normatif SPM sebagai alat peningkatan kinerja dan praktik pengambilan keputusan manajerial di rumah sakit yang belum berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan.

3. Strategi dan Sasaran

a. Analisa Konteks internal dan eksternal

Tabel 4.25
Triangulasi data Analisa Konteks internal dan eksternal

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>ketika menyusun program, mempertimbangkan dari DINKES atau dari PEMDA?</i> <i>Ada (YD&FN)</i> <i>Setiap penyusunan peraturan perundangan, kita memang tetap memper-hatikan sektor sektor yang memang saling terkait.</i>	Triangulasi menunjukkan bahwa analisis konteks internal–eksternal di RSUD Tarakan telah

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Misalkan pelayanan kesehatan itu ada hubungannya dengan JKN, otomatis tarif, misalkan SK Tarif itu otomatis harus bersinggungan dengan tarif JKN. Dengan layanan JKN, standarisasi tarif JKN. Begitupun, juga ada beberapa hal yang memang harus menyinggung. Misalkan keuangan kita ada dua keuangan pemerintah, ada keuangan BLUD, sangat bersinggungan. (IB)</i>	terintegrasi secara formal dan patuh regulasi, namun masih bersifat compliance-driven dan belum dimanfaatkan optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis ERM.
Observasi	Terlihat bahwa dokumen perencanaan, pelaksanaan manajemen risiko, dan program mutu disusun mengikuti struktur formal dan regulasi yang berlaku. Aktivitas manajemen risiko, PMKP, dan keselamatan pasien berjalan rutin, tetapi lebih menekankan kepatuhan prosedural dan pelaporan.	
Dokumentasi	Dokumen Program Kerja Manajemen Risiko 2020, Laporan PMKP 2024, dan Renstra 2023–2026 menunjukkan bahwa visi, misi, sasaran strategis, indikator mutu, dan manajemen risiko telah diselaraskan dengan RPJMD, kebijakan Dinkes, serta standar nasional SPM, JKN).	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa analisis konteks internal eksternal di RSUD Tarakan telah terintegrasi dan selaras dengan regulasi, namun pemanfaatannya masih dominan *compliance-driven*. Analisis konteks belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis ERM dan pembelajaran organisasi berkelanjutan.

b. Penetapan selera risiko (*risk appetite*)

Tabel 4.26
Triangulasi data Penetapan selera risiko (*risk appetite*)

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Selera risiko tidak punya keputusan khusus karena sangat dinamis, kami mengikuti dari pergub. Ada grade 11 itu baru ditindaklanjuti dilakukan penanganan. Setiap operasional	Selera risiko di RSUD Tarakan masih bersifat implisit dan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	membuat manris, kami sbg pemilik risiko melakukan evaluasi kembali, apakah grading yang sudah ditetapkan teman teman sesuai atau tidak. Karena di Pergub tidak ada klinis dan non klinis ami juga melakukan mix juga dengan permenkes. Pada saat grading kami punya mekanisme triwulan Januari-April-Juli kami melakukan evaluasi kembali apakah grading yang sudah ditetapkan sudah ssesuai atau belum. Saya tidak mengunci teman teman dengan grading Direktur dan wadir melakukan penilaian lagi, kalau itu dibawah 11 bilamana kami rasa sangat strategis harus dilakukan penanganan kami lakukan. Jadi mekanisme grading itu yang kami perkuat, ada braistroming, FGD antar manajemen (WP) Kalau selera risiko ini saya fahamkan, bagaimana batas toleransi, Kalau saya mau memahami selera risiko, itu mitigasi atau tidak? akan dilanjutkan Memang selama ini forum itu membahas itu, menggunakan forum yang besar, yaitu setiap akhir tahun dan awal bulan setiap TW. Tapi rasanya di situ kesempatan ibu dir sebagai pemilik risiko melihat, selera risiko saya di sini. Di sini ini perlu diteruskan. Jadi, baru diputuskan di forum pertama. Belum, dalam bentuk satu kebijakan karena itu masih berdasarkan yang pergub, jadi kita pakai yang itu, meneruskan itu. Maksudnya cara beliau melakukan itu lewat itu, tetapi di rumah sakit sendiri tidak menetapkan. yang ini selera risiko enggak, tapi langsung dieksekusi aja, langsung dipilih Pak Nanang. yang ini, ini saya ambil, ini tidak usah, ini hijau, ini kuning, ini merah.(NK) Belum.(TH) Belum, .(LH) Tapi selera risiko belum. . (RO) Belum. .(GR)	operasional, bergantung pada keputusan pimpinan, serta belum terinstitusionalisasi sebagai kebijakan formal. Akibatnya, selera risiko belum berfungsi optimal sebagai instrumen governance dan pengarah keputusan strategis.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Pernah. Biasanya yang menentukan pimpinan. Sebenarnya, menurut saya itu risiko, itu adalah dari berbagai macam risiko yang berada di dalam RS Tarakan, Pimpinan yang menentukan mana yang akan ditindaklanjuti yang menjadi selera risiko. sudah ditentukan di rumah sakit ini.(SS) ini kita sudah diterapkan seperti ini. Semua, Iya, untuk pakai selera risiko ini. (NS) Iya, dia cuma naik prioritas aja gitu. Ya, prioritas kan yang harus dikerjakan. Terus dari sini nanti yang batas masuk ke situ. (FK) saya mau ralat di pergub 122. Yang tadi selera risiko itu ada., itu kan untuk memenuhi risiko yang sudah kita buat tadi ya.. Jadi, selera risikonya itu kan untuk menentukan sampai sebatas mana sih toleransi yang kita buat gitu ya. Nah, itu ada, Ibu, cuma kami harus mengacu kepada selera risiko yang dari pergub, maksudnya, Oh, kalau dia merah berarti tinggi. Tapi bukannya misalnya tiga kali tiga sembilan, itu masuk tinggi. Jadi dia sudah tetap yang merah. Mana itu di sini selera risiko (FK) Ada Satu kali aja.. Sejak tahun 2023. Apakah itu disosialisasi ke semua unit dong, tentang selera risiko? Ada pengisiannya. (YD,FN) Tahu tentang selera risiko, ya. Iya, mendampingi pengisiannya ya (YD,FN) Pernah, selera risiko itu mungkin punya pimpinan yang mendukung suatu organisasi menjadi lebih baik. Dukungan/kebijakan pimpinan. (RM) Selera risiko nanti coba saya lihat dulu ya Bu. (IB) Selera risiko itu artinya risiko yang ditoleransi oleh pimpinan, Pimpinan boleh menentukan, kalau memang selera risiko	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	menurut pimpinan itu sesuai toleransi, masuk ke dalam mitigasi atau tidak, nanti pimpinan yang menentukan. (NE) Selera risiko kan ada warna, misalnya warna hijau, warna kuning, merah berarti kalau yang warna hijau itu rendah, ya itu tidak dimitigasi lagi. (NE) Kebijakanannya masih pergub. Jadi, semua ada di pergub saja.(NE) belum diturunkan dalam regulasi internal. Kalau Pergub kan regulasi eksternal, jadi masih langsung mengacu ke Pergub. (DD,BR,FS)	
Observasi	Dalam praktik manajemen risiko tahunan dan triwulanan, terlihat bahwa penentuan risiko prioritas dilakukan melalui matriks risiko dan forum pimpinan. Namun tidak ditemukan dokumen internal RS yang secara eksplisit mendefinisikan batas toleransi risiko organisasi. Diskusi selera risiko muncul dalam forum, tetapi tidak terdokumentasi sebagai keputusan strategis tersendiri.	
Dokumentasi	Dokumen Peta dan Profil Risiko RSUD Tarakan 2024 secara eksplisit mencantumkan bahwa penetapan konteks risiko mencakup penetapan selera risiko, namun implementasinya mengacu langsung pada Pergub 122 Tahun 2020. Tidak ditemukan risk appetite statement internal RS, baik dalam bentuk SK Direktur maupun pedoman teknis. Dokumen sosialisasi manajemen risiko juga lebih menekankan proses identifikasi–analisis–mitigasi daripada penegasan selera risiko organisasi.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data bahwa selera risiko di RSUD Tarakan belum terlembagakan secara formal sebagai kebijakan internal organisasi, meskipun secara konseptual telah dipahami dan secara praktis digunakan dalam proses prioritisasi risiko. Selera risiko beroperasi secara implisit, terutama melalui instrumen pimpinan dan forum manajemen risiko, dengan rujukan utama pada

Pergub 122 Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya *institutional gap* antara kerangka instrument eksternal dan internalisasi tata kelola risiko rumah sakit, sehingga selera risiko belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrument strategis *governance* dalam kerangka *Enterprise Risk Management*.

c. **Evaluasi strategi alternatif**

Tabel 4.27
Triangulasi data Evaluasi Alternatif Kinerja

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Penetapan kontek dari awal, yang strategis bisa turunannya dari eselon-2, sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus. Jadi dari RPJNB-Rentra Dinkes-Renja-Renstra RS. Dari sasaran tsb ada Renkin, perjanjian kinerja eselon-2 dengan gubernuh, untuk saat ini ada 22 rencana perjanjian kinerja, pohon kinerja cascading sampai kebawah ke staf, mekanisme evaluasi setiap bulan ketat, sasaran kinerja unit dan kinerja individu jadi apabila 3 bulan tidak tercapai akan turun tunjangan kinerjanya. Reward punishment berjalan (WP)	Evaluasi strategi masih bersifat administratif dan reaktif, berfokus pada capaian dan kepatuhan tanpa analisis komparatif opsi berbasis risiko. Akibatnya, evaluasi belum berkembang menjadi strategic risk-based evaluation dalam kerangka ERM.
Observasi	Evaluasi strategi di RSUD Tarakan dilakukan melalui forum kinerja bulanan–triwulanan sebagai mekanisme koreksi operasional terhadap deviasi dan risiko baru. Penyesuaian strategi bersifat reaktif melalui instruksi pimpinan, tanpa analisis komparatif opsi atau skenario berbasis risiko, sehingga evaluasi berfungsi sebagai adaptive correction, bukan strategic choice process.	
Dokumentasi	Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2021–2024 menunjukkan evaluasi strategi berfokus pada kesesuaian realisasi dengan Renstra/RSB, dengan penyesuaian berupa koreksi target, anggaran, dan tindak lanjut audit. Strategi diperlakukan sebagai satu kerangka tetap, tanpa dokumentasi eksplorasi alternatif berbasis risiko, sehingga perubahan strategi bersifat administratif dan regulatif.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa evaluasi strategi di RSUD Tarakan belum dilembagakan sebagai proses pemilihan alternatif berbasis risiko, melainkan berfungsi sebagai koreksi administratif terhadap capaian dan kepatuhan

perencanaan. Penyesuaian strategi bersifat reaktif melalui revisi target dan program, tanpa analisis komparatif risiko–manfaat, sehingga evaluasi belum berkembang menjadi *strategic risk-based evaluation*.

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran strategis mempertimbangkan risiko

Tabel 4.28

Triangulasi data Perumusan Tujuan dan Sasaran strategis mempertimbangkan risiko

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Tadi sudah, jadi menyusun renstra juga sama top bottom, sama bottom up ketemu di tengah gitu cara kita menyusun rentsra. (NK)</i> <i>ada, di Perkin Pembinaan. Renstra : belum tahu (TH, LH,RO,GR,SS,FW) turun. Ya, turun nanti dari Ibu turun lagi ke bawah gitu ya, iya betul. Oke, itu terdapat di program Ibu ya, program misalnya di kapid keperawatan atau di SDM ya Ibu. Cascading, (FK)</i> <i>Kalau mereka tidak bisa dia naik ke atas boleh naik, ada regulasinya enggak Ibu?(FK)</i> <i>Kalau mekanisme ini nya yang bottom-up itu ada regulasinya gini, maksudnya gini , kami kan di RS Tarakan pertama. diturunkan MPPH Matrix kepala dinas. Dari situ kan turun menjadi perkin para direktur Tadi turun lagi ke Wadir. cascading dari Wadir, misalnya saya di SDM, cascadingnya ini nanti ke empat kabag, di bawah pelayanan. (FK)Cascadingnya, nanti lagi kepada perawat yang di bawah. Jadi, nanti ketika ada yang tidak tercapai, contoh nih, misalnya kayak di saya, misalnya tadi implementasi hospitality harus tercapai 100%, penilaian itu nanti si KSP akan telepon ke saya. Ibu, ini belum tercapai, sementara kita tinggal seminggu lagi. Emang gak mau. saya harus berupaya kerja keras, ayo Ibu Napsiah. Pak Bakar, ini belum dinilai, kenapa? Ketika nanti mereka belum menilai, ini akan naik ke cascading ke atas.</i>	Perumusan tujuan dan sasaran strategis di RSUD Tarakan bersifat hierarkis–integratif, selaras secara vertikal dan horizontal, serta dioperasionalkan hingga level individu. Sasaran strategis berfungsi sebagai instrumen aktif perencanaan, pengendalian kinerja, dan aktivasi manajemen risiko, bukan sekadar pemenuhan administratif..

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Akibatnya, perkin direktur akan turun ketika 100 tadi tidak tercapai. Jadi intervensi kita sampai gitu, seperti saya ini yang saya angkat, masalah hospitality. Implementasi hospitality, kadang Ibu hospitality dari dinas cuma dilihat penampilan luar, bajunya udah pake ini, belum? Rambutnya udah gimana? Itu secara fisik kan, tapi yang paling sering di komplain, perilaku diadap dari dinkes.(FK)</i> <i>Sehingga kami mau mau dengan sistem yang tadi, masih adanya komplain masyarakat terhadap perilaku. Lalu kita membuat klinik budaya. Itu intervensinya sampai gitu. Jadi salah satu manajemen risiko yang dari SDM adalah pembuatan klinik budaya. (FK)</i> <i>Sasaran strategis sudah otomatis masuk dalam renstra, Karena memang rumah sakit ini menjalankan roda organisasinya atau roda bisnisnya, juga tetap harus tercantum dalam renstra. (IB)</i> <i>Memang renstra itu harus turunan dari atas jadi kita harus ambil dulu dari Gubernur renstra nya apa. Sekarang renstra jangka pendek jangka panjangnya. Terus, mungkin diterbitkan renstra nya dinas. Dari renstra nya dinas, turun nanti ke rumah sakit bisa menetapkan renstra nya. (IB)</i> <i>Jadi biasanya contoh ada program nasional, Gubernur itu kan bisa ngambil juga dari prognasnya Presiden. Prognas otomatis kita turunkan di rumah sakit. Misalnya, apa yang sastra-sastra owner yang turun ke renstra Tarakan. Nanti mungkin bisa di renstra-nya langsung.(IB)</i> <i>Ada macam-macam, ada yang kalau memang langsung dilaksanakan bisa langsung dibuatkan kebijakan Misalkan ada program prognas, langsung misalnya prognas angka kematian ibu dan anak, otomatis kita bikin. Tim untuk mengendalikan , untuk membuat</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>pelaporan, untuk menjaga mutu di rumah sakit.(IB)</i> <i>Jadi, unit langsung bikin program yang kemudian menjadi programnya rumah sakit. (IB)</i> <i>Sama seperti Renstra, Masuk itu kan termasuk dalam sasaran organisasi. Jadi, kita pilih misalnya, sasarannya ini, kemudian nanti manris nya kita buat. Itu dalam penentuan konteks juga sebetulnya. (NE)</i>	
Observasi	Proses perencanaan strategis teramati berlangsung formal dan terstruktur melalui forum perencanaan, penyusunan Renstra, dan mekanisme penurunan target kinerja ke unit kerja. Sasaran strategis dijadikan rujukan dalam rapat evaluasi, pemantauan capaian indikator, serta penyesuaian program unit. Keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan tindak lanjut manajerial terlihat konsisten dalam praktik	
Dokumentasi	Dokumen Renstra Bisnis RSUD Tarakan 2022–2026 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang diturunkan dari RPJMD, visi–misi Gubernur, dan Renstra Dinas Kesehatan. Sasaran strategis mencakup peningkatan mutu layanan, pengembangan SDM, inovasi layanan, penguatan SIMRS, dan operasional excellence. Buku Profil RSUD Tarakan memperkuat konsistensi antara tujuan strategis dan arah pengembangan layanan unggulan rumah sakit.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran strategis di RSUD Tarakan telah terstruktur, hierarkis, dan terinstitusionalisasi melalui cascading dari kebijakan daerah hingga individu. Sasaran strategis berfungsi aktif sebagai instrumen perencanaan, pengendalian kinerja, dan dasar pengambilan keputusan, sehingga menjadi landasan pengelolaan kinerja dan risiko organisasi.

4. Kerangka kerja ERM

a. Rancang Program Kerja ERM

Tabel 4.29
Triangulasi data Rancang Program Kerja ERM

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
wawancara	<i>rencana kerja seperti rencana kerja ERM per 5 tahun. Belum (YD,FN)</i>	Program kerja ERM di RSUD Tarakan masih bersifat tahunan dan operasional, belum dikembangkan sebagai perencanaan strategis risiko jangka menengah yang terintegrasi, sehingga fungsi ERM sebagai instrumen strategic governance belum optimal..
Observasi	Tidak ditemukan dokumen rencana kerja ERM jangka menengah (3–5 tahun) yang terstruktur dan terintegrasi dengan perencanaan strategis rumah sakit. Pelaksanaan kegiatan manajemen risiko lebih bersifat operasional tahunan dan berbasis unit kerja.	
Dokumentasi	Dokumen <i>Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan Tahun 2020</i> memuat tujuan, ruang lingkup, sasaran, instrumen, serta rincian kegiatan manajemen risiko klinis dan non-klinis. Namun, dokumen ini bersifat tahunan , tidak menunjukkan peta jalan (roadmap) ERM multi-tahun, dan belum secara eksplisit mengaitkan program kerja dengan strategi organisasi jangka menengah/240nstrum.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data, rancang program kerja manajemen risiko di RSUD Tarakan telah tersedia secara formal dan rinci dalam bentuk program kerja tahunan, namun belum dikembangkan sebagai rencana strategis ERM jangka menengah yang terintegrasi dengan arah kebijakan dan tujuan strategis organisasi. Program kerja ERM masih berorientasi pada pelaksanaan teknis-operasional dan kepatuhan internal, sehingga fungsi ERM sebagai 240nstrument pengelolaan risiko strategis organisasi belum terlembagakan secara optimal.

Konsistensi antara observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa keberadaan program kerja ERM lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan implementasi operasional dan kepatuhan internal, bukan sebagai alat pengendalian strategis risiko organisasi jangka menengah.

b. Roadmap dan Penerapan ERM

Tabel 4.30
Triangulasi data *Roadmap* dan Penerapan ERM

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Pernah dengar roadmap nggak: belum (YD,FN)</i>	Road map ERM di RSUD Tarakan belum terinternalisasi sebagai instrumen strategis dan masih dipahami sebagai siklus operasional tahunan. Akibatnya, ERM berfungsi sebagai compliance tool, bukan instrumen strategic governance.
Observasi	Tidak ditemukan <i>road map</i> ERM yang dipahami secara eksplisit oleh sebagian informan operasional. Istilah <i>road map</i> belum menjadi referensi kerja sehari-hari dalam pengelolaan risiko. Implementasi manajemen risiko berlangsung parsial dan berfokus pada kegiatan rutin (identifikasi risiko, penilaian, pengendalian), tanpa visualisasi tahapan jangka menengah–panjang.	
Dokumentasi	Dokumen Renstra memuat visi, misi, sasaran strategis, dan program kerja multi-tahun, namun tidak ditemukan dokumen khusus yang secara eksplisit memetakan tahapan pengembangan ERM sebagai <i>road map</i> . ERM tidak diposisikan sebagai arsitektur strategis lintas sasaran. Program kerja memuat tahapan manajemen risiko (identifikasi, analisis, pengendalian, audit, PDCA, RCA, FMEA) yang bersifat operasional dan tahunan. Tidak terdapat peta evolusi kematangan ERM dari tahap awal menuju integrasi strategis.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data bahwa, *Road Map* ERM di RSUD Tarakan belum hadir sebagai kerangka strategis eksplisit. Implementasi ERM berlangsung melalui aktivitas operasional yang terfragmentasi dan berbasis kepatuhan, tanpa peta tahapan pengembangan yang terintegrasi dengan Renstra organisasi. Absennya *road map* ERM bukan disebabkan oleh ketiadaan praktik manajemen risiko, melainkan oleh belum adanya institusionalisasi ERM sebagai instrumen perencanaan strategis jangka menengah–panjang dalam tata kelola rumah sakit

publik .

c. **Evaluasi hasil kegiatan ERM**

Tabel 4.31
Triangulasi data Evaluasi Kegiatan ERM

Teknik Pengambilan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>indikator keberhasilan manajemen risiko, pernah ada antara evaluasi biaya dengan risiko Belum ada. (YE)</i> <i>evaluasi manajemen risiko. Lapornya tiap 3 bulan. Ada yang laporan setahun ke 3. Jadi kita evaluasinya setiap 3 bulan. Emang programnya juga sekalian ini ada forum besar gitu. Dibilang setiap 3 bulan, jadi sekalian dengan laporan. Dan di evaluasi ini sudah berjalan atau belum. evaluasi biasanya di akhir tahun aja sih. laporan aja. (YD)</i>	Evaluasi ERM di RSUD Tarakan berjalan operasional namun belum strategis, masih terfragmentasi dan compliance-based. Akibatnya, evaluasi belum mengaitkan risiko dengan kinerja, nilai publik, dan kepercayaan warga secara terintegrasi..
Observasi	Evaluasi ERM di RSUD Tarakan dilakukan periodik namun belum terstruktur sebagai siklus formal, berfokus pada mutu dan keselamatan pasien. Hasil evaluasi lebih digunakan untuk perbaikan teknis unit daripada keputusan strategis, dan belum mencakup penilaian risiko strategis, reputasi, dan nilai publik.	
Dokumentasi	Dokumen PMKP, Laporan Tahunan 2024, dan tindak lanjut BPK memuat evaluasi mutu, kinerja, dan tata kelola, namun belum terintegrasi sebagai evaluasi ERM end-to-end. Hasil evaluasi juga belum dikaitkan secara eksplisit dengan indikator nilai publik.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan triangulasi data, bahwa evaluasi kegiatan *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan telah berjalan secara operasional dan periodik, namun belum berfungsi sebagai mekanisme evaluatif strategis yang terintegrasi. Evaluasi risiko dilaksanakan melalui berbagai forum dan laporan

(PMKP, mutu, IKP, audit, dan laporan tahunan), tetapi masih terfragmentasi, belum terdokumentasi sebagai satu laporan evaluasi ERM terpadu yang mengaitkan risiko dengan pencapaian tujuan organisasi dan nilai publik. Praktik evaluasi cenderung *compliance-based* dan *performance-oriented*, dengan fokus dominan pada mutu dan keselamatan pasien, sementara evaluasi risiko strategis, reputasi, keuangan, dan nilai publik belum terformalisasi secara konsisten. Hasil evaluasi lebih banyak dimanfaatkan untuk perbaikan teknis unit (*corrective action*) dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan *risk re-assessment* tingkat rumah sakit. Dengan demikian, terdapat gap implementasi antara desain konseptual evaluasi ERM (end-to-end: identifikasi–analisis–perlakuan–evaluasi) dan praktik aktual, serta menunjukkan bahwa orientasi evaluasi ERM masih berada pada spektrum OPA–NPM, dan belum sepenuhnya bertransformasi menuju NPS yang menempatkan evaluasi ERM sebagai instrumen eksplisit penciptaan dan pengukuran nilai publik dan kepercayaan masyarakat.

d. Perbaikan berkelanjutan

Tabel 4.32
Triangulasi data Perbaikan berkelanjutan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Tidak ada pelaporan dan jawaban dari teman-temannya menyampaikan google review itu sudah kami kelola dengan baik, seperti apa baiknya? maksudnya jawabannya jawaban dari rumah sakit itu sudah seperti mesin saja, jadi jawabannya begitu. mohon maaf, tapi tindak lanjutnya apa? saya penasaran, tindak lanjutnya seperti apa ? secara pelaksanaannya, secara tata bahasa sudah disampaikan, tapi belum dalam pelaksanaannya, jadi ini berarti salah satu yang perlu diperbaiki, ketika melakukan evaluasi resiko, berarti tata kelolanya, kemudian sistem informasinya juga masih, saat ini mungkin belum optimal, (YE) Iya, memantau hasilnya. (NE)	Perbaikan berkelanjutan masih bersifat administratif, belum menjadi pembelajaran organisasi berbasis risiko; tindak lanjut insiden dan audit belum terinstitusionalisasi, data digunakan untuk monitoring, dan kepemimpinan belum mendorong

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	kalau Manris, sepemahaman saya, ini mendampingi bagaimana para kabid sampai di ujung menjalankan Manris dengan mulai mengidentifikasi, itu dikawal, didampingi, membuat penilaian sampai grading, sampai itu dikumpulkan dan dikasih ke pemilik risiko untuk dikasih selera risikonya, itu Subkomite Manris yang terutama mendampingi mereka setiap pertemuan minggu, bulan kedua. Tapi ketika kabag-kabid ini berperan sebagai manajer risiko, dia punya forum sendiri dengan SPI, jadi sebenarnya Pak Nanang tadi sudah sering ketemu sama manajer risiko, tetapi mungkin dia belum bisa mengaudit, hanya kepatuhan. bisa saya buktikan kalau menilai kepatuhan mengerjakan Manris, iya, saya rasa sudah. Tapi kalau melakukan audit internal terjadwal untuk kabag kabid rasanya belum. Nah, itu belum untuk audit internal, bukan menilai kepatuhan Manris, tapi melakukan audit, ini yang kita dorong,(NK)	perbaikan adaptif berbasis nilai.
Observasi	Evaluasi dan tindak lanjut risiko dilakukan rutin namun masih berorientasi kepatuhan dan pelaporan. Pembelajaran dari insiden dan audit belum terinstitusionalisasi menjadi perubahan sistem, data mutu lebih digunakan untuk memastikan target, dan kepemimpinan menekankan pengendalian dibanding pembelajaran lintas unit.	
Dokumentasi	Dokumen PMKP dan Laporan Tahunan 2024 menunjukkan siklus monitoring dan tindak lanjut telah tersedia, namun sebagian rencana perbaikan belum terlaksana dan belum terintegrasi dengan perbaikan sistem ERM.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa perbaikan berkelanjutan ERM di RSUD Tarakan telah tersedia secara struktural, namun masih berorientasi kepatuhan administratif dan belum berfungsi sebagai pembelajaran organisasi berbasis risiko. Temuan risiko dan audit belum konsisten ditransformasikan menjadi perubahan sistem, dengan kepemimpinan lebih menekankan kontrol daripada pembelajaran. Akibatnya, ERM masih berada pada tahap formal–prosedural, belum menjadi mekanisme penciptaan nilai publik.

e. **Pelaporan Program ERM dan budaya sadar risiko**

Tabel 4.33

Triangulasi Data Pelaporan Program ERM dan budaya sadar risiko

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
wawancara	Yang non medis Nakes, Saya masuk ke sini, sangat bagus ada klinik budaya kerja. Jadi, bagaimana unit-unit itu mendapatkan hal-hal yang terkait keluhan hospitality, keluhan komunikasi efektif yang tidak bagus, Komunikasi, risikonya. Itu kemudian diusulkan masuk ke klinik budaya kerja SDM.(NK) Tapi mungkin yang selama ini apa yang saya rasakan karena ada pendekatan, satu-satu kasus-kasus yang memang berkaitan dengan kinerjanya direkturnya ini yang butuh khusus, jadi antara <i>no blame</i> antara ada sebuah kejadian, Memang, kalau teori mutu itu yang kita paham Kemungkinan itu terjadi ada kemungkinan gitu, tapi kalau dihubungkan dengan bagaimana itu dampaknya : reputasi, dampak fiskal, yang level pimpinan tertinggi, yang biasanya kita harus diangkat sampai ke ibu direktur (NK) Di organisasi yang pertama diterapkan Budaya sadar risiko, setiap individu setiap manajer di tingkat bawah ka satpel semua menyadari risiko kita harus evaluasi bisa menjaga tenaga Kesehatan dari hal hal berbau legal litigasi. Menciptakan standar yang jelas turunannya SPO untuk mencegah litigasi kepada tenaga Kesehatan, kemudian ada budaya Namanya <i>Risk Culture Wellness</i> : organisasi dengan budaya risiko berjalan dengan sehat, komunikasi terbuka, tidak takut lapor no blame culture, tidak mudah menghakimi tidak mudah marah, organisasi yang terbuka menjadi role model menciptakan budaya. (WP) Ya, budaya sadar risiko itu, kita dalam kegiatan itu harus merencanakan dan memitigasi risikonya. Jadi kalau kita mau	Pemanfaatan teknologi informasi dalam ERM masih bersifat administratif dan belum menjadi enabler kinerja, pembelajaran, dan nilai publik. ERM belum terdigitalisasi secara sistemik dan belum terintegrasi dalam agenda transformasi digital rumah sakit, sehingga praktiknya tetap compliance-oriented

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	bertindak, ini apa risikonya apa kejadiannya apa efeknya yang akan kita lakukan (NE) Kalau untuk pelayanan kami membuat Klinik budaya untuk mencegah. Jadi kami kan di keperawatan itu selalu monev bekerjasama dengan komite asesor dan kepala ruangan timnya. Jadi kami monev, hasil dari monev itu nanti kami usulkan ke SDM ke DIKLAT untuk dibuatkan klinik budaya. Jadi dari pelayanannya bahkan sampai ke BB, ya berat badan, (FK) Bentuk klinik budaya klinik budaya itu, jadi kami yang kurang, misalnya hospitalitynya kurang terkait dengan SDM, hospitality kurang, kita bina, kita ajarkan, perlu kita. memanggil pelatih atau pelatihan itu kita usulkan ke pimpinan untuk dilatih. Kalau untuk monevnya itu kita rutin. (FK)	
Observasi	Observasi terhadap praktik pengelolaan risiko menunjukkan bahwa pencatatan <i>risk register</i> masih dilakukan secara manual dan tersebar pada media berbasis <i>cloud</i> sederhana (misalnya folder bersama), belum terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Tidak ditemukan <i>dashboard</i>, <i>storyboard</i>, atau <i>real-time risk monitoring</i> yang mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis risiko. Proses pelaporan risiko cenderung bersifat periodik dan administratif, bukan analitik dan prediktif.	
Dokumentasi	Dokumen ERM RSUD Tarakan menunjukkan tahapan ERM telah lengkap, namun belum didukung sistem informasi khusus dan belum terintegrasi dengan SIMRS/EMR atau dashboard kinerja. Meski terdapat komitmen transformasi digital, belum ada bukti integrasi teknologi tersebut dengan fungsi manajemen risiko.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Pelaporan risiko di RSUD Tarakan telah berjalan formal dan periodik serta mulai dikaitkan dengan budaya sadar risiko, namun masih administratif dan

belum terintegrasi dengan kinerja dan sistem informasi. Risk register dikelola manual dan terpisah dari SIMRS/EMR, sehingga pelaporan bersifat retrospektif dan kurang mendukung analisis strategis. Akibatnya, pelaporan risiko belum berfungsi sebagai mekanisme tata kelola kinerja dan nilai publik yang *performance-driven*.

5. Informasi dan Komunikasi ERM

a. Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas dan tepat waktu

Tabel 4.34

Triangulasi data Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas dan tepat waktu

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
wawancara	Kalau ke Dewas itu semesteran Mekanisme itu sudah jalan Kalau ke Dewas 6 bulanan. (NK) Saya tidak bisa melihat karena pelaporan tahun 2023 juga tidak ada. Jadi kami selalu buat absensi terkait dengan pelaporan Manris maupun PMKP, di mana pada Tahun 2023 dan 2024 tidak mengumpulkan laporan, untuk tahun 2025, ini baru diserahkan. Ini yang baru kemarin kami terima dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3, kemudian peta dan profil risikonya yang baru kami terima. (YE) Pada saat itu memang kita kumpulkan, ya jadi setahun sekali, malah setiap semester itu ada pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit terkait dengan evaluasi dari pelaporan dari PMKP maupun Manris. Tetapi tetap saja belum.(YE) Jadi laporan kami pertama Ke Gubernur, per semester, tembusan ke Dinas Kesehatan. (YE) Ya, kalau yang seperti ini, setiap kita Rapat, ada diskusi, itu selalu keluar ke masalah-masalah. laporan ke Gubernur, ada setiap semester. (YE)	Pemanfaatan teknologi informasi dalam ERM masih administratif dan berbasis dokumen, belum menjadi enabler kinerja dan pembelajaran. ERM belum terintegrasi dalam agenda transformasi digital rumah sakit, sehingga praktiknya tetap compliance-oriented.

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Observasi	Observasi terhadap praktik pengelolaan risiko menunjukkan bahwa pencatatan <i>risk register</i> masih dilakukan secara manual dan tersebar pada media berbasis <i>cloud</i> sederhana (misalnya folder bersama), belum terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Tidak ditemukan <i>dashboard</i> , <i>storyboard</i> , atau <i>real-time risk monitoring</i> yang mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis risiko. Proses pelaporan risiko cenderung bersifat periodik dan administratif, bukan analitik dan prediktif.	
Dokumentasi	Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2024 menegaskan komitmen rumah sakit terhadap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan manajemen, termasuk pengembangan sistem informasi dan EMR. Namun, tidak terdapat bukti eksplisit bahwa pengembangan teknologi tersebut telah mencakup modul atau <i>dashboard</i> khusus manajemen risiko dan keterkaitannya dengan kinerja, mutu, dan pengambilan keputusan strategis	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Komunikasi dan pelaporan risiko di RSUD Tarakan telah berjalan formal dan hierarkis, namun belum efektif, tepat waktu, dan terintegrasi. Pelaporan masih manual, tidak konsisten, dan berorientasi kepatuhan, sehingga belum mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis risiko dan transformasi digital ERM.

b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko

Tabel 4.35

Triangulasi Data Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
wawancara	Saat ini belum, ya masih tadi Google Drive aja, belum online lah seperti ya, data-data belum terintegrasi secara sim RS ya. storyboard atau dashboard belum ya.(FW) Kalau SIMRS untuk manajemen risiko bagaimana, dashboard storyboard tentang man risk ya : Belum (NS) Kalau IT support sistimnya masih kurang. Karena SIMRS kami juga beberapa belum bisa memprovide dari pelayanan. Maksudnya yang pelayanan setiap hari, mungkin masih ada beberapa yang belum bisa diprovide, sedangkan harus ditambah dengan pengendalian manajemen resiko, gitu kan. (YD) Manajemen resiko di rumah sakit ini sudah integrative, karena saya dari keuangan di mobilisasi dana, bahwa dari pasien, dana harus sudah komunikasi dengan unit lain misalnya pelayanan, keuangan, atau dengan yang lain. ketika membuat risk register itu berarti keuangan sama yang lain-lain itu sudah jadi satu, gak berdiri sendiri gitu. (LH) Kayaknya untuk semua rumah sakit ya, para pejabat atau para pimpinan yang duduk di manajemen itu sepertinya kurang memahami tupoksinya dia sebetulnya mereka hanya terima laporan. Tanpa menganalisa dengan baik, harusnya apa dan solusinya seperti apa. (YE) koordinasi lintas unit atau lintas profesi? Kami belum bisa melihat seperti itu, hanya melihat dari hasil laporan-laporan yang dipaparkan itu bahwa ini berjalan baik, tapi kami tidak langsung ke pelayanannya itu seperti apa belum tahu. terutama saya melihatnya dari Google Review. Justru dari Google Review di situ baru terlihat, kalau misalnya jeleknya dimana, Bintang satunya yang diberikan oleh masyarakat, baru bisa ditanyakan kenapa begini ? (YE)	Pemanfaatan TI dalam ERM masih administratif dan berbasis dokumen, belum menjadi enabler kinerja dan pembelajaran. ERM belum terintegrasi dalam agenda transformasi digital rumah sakit, sehingga praktiknya tetap compliance-oriented

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	resiko mereka itu terkait juga dengan unit yang lain, integrasinya yang masih belum untuk mengintegrasikan menjadi satu file. (YD) Tadi juga ceritakan kalau di tingkat manajer resiko tadi membuat risk register. Saya bertanya kalau ke cascading top down tapi boleh nggak bottom up. Artinya gini, kalau unit sudah tidak sanggup menangani risiko? J : ada peran konsultasi, Jadi, komunikasi dan konsultasi, jadi bukan cuman bantuin mendampingi manajer itu berjalan, tapi manajer risiko harus bertanggung jawab juga memberikan bantuan ketika unitnya dibawahnya itu punya masalah. (NK) Kita sudah buat permintaan, sudah masuk ke roadmap-nya IT, tapi karena fokusnya IT tadi adalah EMR jadi belum, masih manual, risk register ke subkom masuknya ke Google drive,. Jadi, kita tidak update. ; Di aplikasi yang ada juga ada. Apakah sudah masuk dalam rencana program? Di tahun berapa rencana? Diizinkan. Kalau di IT sendiri sebenarnya ada roadmap-nya berdasarkan kebutuhan. Kalau untuk tahun mereka, belum mampu. Belum tahu, oke. Belum bisa seberapa, ya? (YD) dashboard, manajemen risiko ? Story board? belum (YD)	
Observasi	Observasi terhadap praktik pengelolaan risiko menunjukkan bahwa pencatatan <i>risk register</i> masih dilakukan secara manual dan tersebar pada media berbasis <i>cloud</i> sederhana (misalnya folder bersama), belum terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Tidak ditemukan <i>dashboard</i>, <i>storyboard</i>, atau <i>real-time risk monitoring</i> yang mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis risiko. Proses pelaporan risiko cenderung bersifat periodik dan administratif, bukan analitik dan prediktif.	
Dokumentasi	Dokumen Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan Tahun 2020 dan Peta & Profil Risiko Tahun 2024 menunjukkan	

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	bahwa tahapan ERM telah disusun lengkap (identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan), namun tidak didukung oleh sistem informasi khusus ERM. Tidak ditemukan kebijakan, arsitektur sistem, maupun aplikasi yang mengintegrasikan data risiko dengan SIMRS, EMR, atau dashboard kinerja rumah sakit .	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TI dalam ERM di RSUD Tarakan masih administratif, manual, dan tidak terintegrasi dengan SIMRS/EMR, sehingga ERM bersifat *compliance-oriented*. Terdapat digital dan *policy implementation gap* karena ERM belum diposisikan sebagai bagian inti transformasi digital dan tata kelola kinerja.

6. *Performance*

a. Identifikasi risiko

Tabel 4.36
Triangulasi data Identifikasi risiko

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>belum membuat tentang manajemen risiko (GR)</i> <i>Jadi, kita lihat risiko-risiko yang terjadi di unit saya itu apa saja. Jadi dari situ melihat apakah risikonya yang sering terjadi atau yang perlu diantisipasi (SS)</i> <i>sama. semuanya dapat semacam Google Sheet gitu ya. Terus nanti diisi, terus nanti dikumpulkan ke Google Drive. Setiap 3 bulan, setiap tahun. (FW)</i> <i>Bikin risk register, nanti dikumpulnya ke subkom menris, Di komite mutu :</i>	Identifikasi risiko di RSUD Tarakan telah berjalan sistematis dan luas, namun masih berorientasi operasional dan reaktif, belum diturunkan dari strategi serta belum mengaitkan

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kalau untuk monitor visit dokter untuk manris nya saya minta tiap-tiap ruangan untuk membuat sheet harian atau kita mengambilnya mingguan, dilaporkan ke saya hari ini yang tidak visit siapa. Reinne (RM)</i> <i>form yang harus diisi oleh komite atau instalasi kan setiap tahun ?</i> <i>Iya, ada yang yang triwulan monitoring komite mutu atau instalasi. Kita buat dulu selanjutnya diberikan per tiga bulan ke komite mutu Dedy (DD)</i> <i>Kalau dari akreditasi, berarti kayak form pengawasan, profil, untuk risiko klinis, gimana diintegrasikan ?</i> <i>Bentuk formatnya tetap bisa. kebetulan. surveyor yang terakhir ini bisa. Berarti sudah ada kategori klinis non klinis di dalam list register-nya ya Sudah. (YD)</i> <i>Kalau yang sudah berjalan tentunya kita bisa melihat adanya potensi-potensi kejadian yang tidak kita inginkan itu risiko yang harus kita kelola agar kita mampu tetap laksana dan tidaklah menjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi kita. Tentunya hal-hal semacam itu dimulai dengan ditilik identifikasi dengan kemungkinan-kemungkinan apa saja risiko yang bisa terjadi dari hal yang tidak diinginkan, biasanya ada sesuatu risiko yang kita diskusikan. Jadi, di dalam komite kita diskusikan karena wilayah masing-masing kita itu berbeda. Saya dokter, sementara komite saya ada perawat. itu kita harus komunikasikan bagaimana jembatannya supaya yang terbaik. (DD)</i> <i>Contohnya terkait misalnya APAR api ringan, misalnya dia tidak berfungsi baik ketika mau dipakai terus kemudian lewat expired, yang paling sering ditemukannya karena monitoringnya kurang, misalnya seperti itu. (FS)</i>	risiko dengan kinerja strategis. Akibatnya, prinsip Performance COSO ERM sebagai penghubung risiko–kinerja belum berfungsi optimal dan identifikasi risiko belum menjadi performance enabler.

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kategori risiko : Semua : Risiko operasional, fiskal, fraud, reputasi, kebijakan, risiko legal FGD (TH,LH,RO,GR,SS,FW)</i> <i>Berarti ketika mengidentifikasinya dimulai dari proses bisnis, proses, atau langsung menuliskan risiko nya. J : Pasti, kalau misalnya dia ditemukan, bisnis proses apa yang menjadi risikonya. (DD)</i> <i>risiko non klinis enggak ada, cuma klinis. Tetty (TH)</i> <i>IGD : klinis aja, , waktu tunggu pasien. (TH)</i> <i>dianalisa, resikonya itu ada risiko klinis dan non klinis, atau hanya khusus klinis? Enggak, dua-duanya. Sudah ada dua-duanya. Iya, jadi contohnya pasien misalnya kan akan, mungkin kita bukan audit dulu ya, pasien yang misalnya. los nya sudah panjang, tapi pasien ini adalah dengan komplikasi. Jadi, dengan diagnosanya bukan hanya satu, tapi ada komplikasi yang lain. Misalnya, dia ada CAD, terus CABD, terus ternyata dari saat perjalanan dia operasi, terjadilah dia gagal nafas atau apa sebagainya. Nah, itu kan LOSnya panjang. (LH)</i> <i>kalau risk register lebih ke klinis. Karena pelayanan tidak berbanding lurus dengan keuangan. LH)</i> <i>istilah risiko klinis dan risiko non klinis Pernah dengar (RM)</i> <i>Mungkin kalau yang klinis, perbedaannya kalau klinis lebih cenderung ke manusianya misalnya keselamatan pasien untuk pelayanan keselamatan SDM-nya juga. Kalau yang non klinis itu kayak anggaran keuangan seperti itu. (RM)</i> <i>Pada waktu pembuatan risk register, apakah mengidentifikasi risiko klinis dan non klinis atau hanya klinis? Dokter pernah dengar istilah itu risiko klinis dan risiko non klinis ?</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>J : Sepertinya kami mengkaji yang klinis saja. (DD)</i> <i>Contohnya kalau di lab itu misalnya risk fraud, biasanya ada kerjasama dengan vendor, kita buat mekanisme supaya tidak ada kerjaan-kerjaan setelah itu. (BR)</i> <i>Kalau kita di K3 sih masih yang non klinis. Non klinis saja, karena bukan pelayanan. (FS)</i> <i>Farmasi juga masih non klinis. Karena yang masih risiko itu kekosongan obat, pelayanan pasien tidak diidentifikasi hanya medication error saja. Kalau medication error berarti sudah masuk ke klinis, ya. Karena kan pelayanan pasien itu masuk ke risiko klinis. Kalau pelayanan pasien berarti ke non klinis. (IS)</i> <i>risiko legal yang ada di rumah sakit cukup tinggi?</i> <i>: kalau hasil peta risikonya, kalau peta risiko sebetulnya namanya risiko kesehatan, otomatis bisa tinggi, Karena risikonya terhadap kesehatan, misalkan risiko hukum rumah sakit itu mungkin ada beberapa jenis, kita petakan dulu risiko kesehatan, risiko terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan maupun yang non kesehatan. Kalau yang tenaga medis tenaga kesehatan ini otomatis risikonya terhadap nyawa seseorang atau kesehatan seseorang. Otomatis, skoringnya juga angka kepatuhannya dibuat harus lebih tinggi Imam (IB)</i> <i>risk register yang dibuat oleh instalasi atau unit, nanti dikumpulkan ke subkom manris Itu ada tidak direkap khusus kategori yang risiko legal</i> <i>J : Kalau risiko legal ini tidak semua unit ada, otomatis yang unit-unit terkait yang mempunyai risiko itu ada. Misalnya contohnya datangnya itu yang pelaporan, soalnya dari unit langsung ke komite mutu. Imam (IB)</i>	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kalau risiko hukum, masih dalam kategori aman untuk RSUD Tarakan. Imam. (IB)</i> <i>Risiko medication error pada saat prosesnya, saat proses penerimaan kita ada namanya pengkajian. Pengkajian awal, disitu salah satu upaya awal, upaya pertama kita untuk menjaga. (IS)</i> <i>Kalau di kita, itu mungkin kalau di bawah saya ada pemeliharaan alkes, alat medisnya sering rusak gitu. Jadi, menghambat pelayanan, pelayanan tidak optimal karena pemeliharaan alat medisnya tidak secara rutin. Itu sering banget terjadi dan risiko yang cukup sering yang saya lihat di rumah sakit Tarakan. (FS)</i> <i>Setahun sekali, ICRA terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Sementara risk register sendiri itu potensi yang akan terjadi dari suatu kegiatan yang dilakukan walaupun punya form masing-masing tersendiri. (DD)</i> <i>Bikin ICRA-nya dulu atau risk register-nya dulu? Apakah ICRA nanti masuk ke risk register, atau risk register masuk ke ICRA? Seperti apa?</i> <i>Misalnya contoh ada sesuatu kegiatan Pembangunan dibuatkan ICRA Renovasi, kalau ICRA program tentu risikonya baru ICRA program Kemudian dilaporkan ke komite (DD)</i>	
Observasi	Identifikasi risiko di RSUD Tarakan dilakukan berbasis aktivitas unit dan mencakup risiko klinis–nonklinis, namun masih dominan operasional dan reaktif. Risiko belum dipetakan secara eksplisit ke strategi, sasaran mutu, dan kinerja strategis, sehingga hasil identifikasi lebih berfungsi untuk pengendalian unit daripada pengambilan keputusan strategis.	
Dokumentasi	• Dokumen <i>Peta dan Profil Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024</i> menunjukkan identifikasi risiko dimulai dari sasaran unit (UKP/UKM), bukan dari strategi	

Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	organisasi secara menyeluruh. Risiko disusun per unit dan proses. • Profil risiko memuat kejadian, penyebab, dan dampak risiko terhadap gangguan layanan operasional (jam layanan terganggu, pelayanan tidak optimal, keluhan pasien). Dampak terhadap indikator kinerja strategis belum dinyatakan eksplisit. • Dokumen peta risiko memuat kategori risiko operasional, reputasi, dan fasilitas-lingkungan di berbagai unit (IGD, rawat inap, penunjang, administrasi). • Dokumen menunjukkan dampak risiko dinyatakan dalam bentuk gangguan operasional atau reputasi, bukan dalam pencapaian target mutu atau kinerja strategis. • Profil risiko disusun berdasarkan pengalaman unit, kejadian aktual, dan evaluasi operasional tahunan. Pendekatan skenario strategis belum tampak dominan. • Notulen dan materi sosialisasi manajemen risiko menunjukkan fokus pada pengisian risk register dan pemantauan risiko, bukan integrasi dengan evaluasi kinerja organisasi.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa identifikasi risiko di RSUD Tarakan telah berjalan sistematis di level operasional dan mencakup risiko klinis–nonklinis, namun masih reaktif dan belum diturunkan dari strategi organisasi. Keterkaitan risiko dengan kinerja strategis belum eksplisit, sehingga prinsip *risk–performance linkage COSO ERM* belum optimal dan identifikasi risiko masih berfungsi sebagai pengendalian operasional, bukan manajemen risiko strategis.

b. Analisis risiko

Tabel 4.37
Triangulasi data Analisa risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>pertama kita melihat dari keluhan ataupun pelayanan tidak sesuai yang seharusnya dilakukan pada pasien. pasien itu harus mendapatkan makanan sesuai dietnya</i> <i>Kalau menghitung-hitung gitu tadi, ya satu tahun sekali dibuat, ya dok. Kemudian, dikirim ke Ke bagian mutu. (TH)</i> <i>analisnya masih sama berarti kan kemungkinan tapi rumusnya pakai yang BPKP. Iya . (YD)</i> <i>Rumah sakit membuat template, semua mengikuti template yang diberikan oleh rumah sakit yang dari komite mutu. Komite mutu yang membuat, tanggal mengisi dan dikumpulkan di drive. DD</i> <i>Istilahnya apa, Kalau dia menurun, apa perbedaan dari risiko awal? J : belum tahu perbedaannya. DD</i>	Analisis risiko di RSUD Tarakan telah baku dan sistematis, namun masih berorientasi operasional dan kepatuhan. Risiko belum terintegrasi dengan sasaran strategis dan kinerja, sehingga prioritas dan tindak lanjut belum berfungsi sebagai pengungkit peningkatan kinerja strategis.
Observasi	Analisis risiko di RSUD Tarakan berfokus pada pencegahan insiden dan gangguan pelayanan, menggunakan matriks dampak–probabilitas untuk prioritas. Namun, risiko masih dikaitkan dengan proses operasional harian, bukan sasaran strategis, sehingga tindak lanjut dan pemantauan lebih bersifat teknis–administratif.	
Dokumentasi	• Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan menetapkan sasaran seperti efektivitas pengendalian risiko, zero fatal accident, dan kepatuhan regulasi. • Peta dan Profil Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024 memuat risiko berdasarkan area (keselamatan pasien, fasilitas, BLUD, etik-hukum), namun belum secara eksplisit memetakan risiko terhadap indikator kinerja strategis RS • Matriks grading risiko dan ketentuan tindak lanjut tercantum dalam	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Program Manajemen Risiko dan Profil Risiko RS. • Dokumen Profil Risiko 2024 menunjukkan daftar prioritas risiko dan warna band risiko sebagai dasar pengendalian • Program Kerja Manajemen Risiko dan dokumen pemantauan menunjukkan rencana aksi dan evaluasi pengendalian risiko. • Notulen rapat sosialisasi dan pemantauan risiko menunjukkan adanya proses review dan komunikasi risiko lintas unit	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa analisis risiko di RSUD Tarakan telah baku dan sistematis di level operasional, namun belum terintegrasi dengan sasaran strategis dan kinerja organisasi. Risiko masih diposisikan sebagai risiko operasional, sehingga hasil analisis lebih berfungsi untuk kepatuhan dan pengendalian teknis daripada sebagai instrumen peningkatan kinerja dan nilai publik.

c. Penentuan prioritas risiko

Tabel 4.38
Triangulasi data Penentuan Prioritas risiko

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>lihat dari level kemungkinan dan level dampaknya sih, kita melihat dari kategori resikonya juga ya, (LH,RO)</i> <i>:level dampak. aturannya batasan di angka 13, biasanya diprioritaskan dan dievaluasi. Itu sesuai dengan ketentuan yang merah itu. 13 itu kan memang harus dimitigasi. Dibawah 13 tidak dimitigasi. (LH, RO)</i>	Prioritas risiko di RSUD Tarakan ditetapkan formal berdasarkan skor risiko, namun masih berfokus pada risiko operasional dan bersifat

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Itu ketentuan dari Pergub (LH,RO)</i> <i>memprioritaskan gimana caranya Membuat profil menggunakan apa dari risk register terus diprioritaskan biasanya di ranking dari yang paling besar. (YD)</i> <i>Ada ya Ada di mana Ada garisnya Di atas atau di bawah dari selera risiko ya kan. (YD)</i> <i>pertimbangan ukuran atau apa yang masuk menjadi prioritas risiko. Dilihat dari apanya?</i> <i>Mungkin dilihat dari kategori risiko, menjadi risiko itu lebih menarik untuk ditampilkan karena pencitraan RS. (NE)</i> <i>selera risiko atau CBA (cost-benefit analysis) misalnya,digunakan tidak Pak, untuk ketika mau memprioritaskan risiko? Tidak (NE)</i> <i>sudah pernah membuat risk register atau profil risiko di tingkat unit. (ED,</i> <i>oh ya risiko operasional, dikumpulkan ke semua ke MUTU ya sama dengan risiko keuangan juga semua jadi satu ya, iya ke MUTU setiap tahun. Dokumennya daftar risiko, profile dan peta risiko. (LH,RO)</i> <i>daftar risiko yang ada, risiko yang paling besar, paling ini tinggi skornya di mana Ibu?</i> <i>Yang paling tinggi,. di Mutu ya bukanlah Mutu Pelayanan, kemudian keduanya adalah etik dan ketiga kredensial. Contoh risiko Untuk Mutu Pelayanan Pasien, Ibu pasien safety. (LH)</i> <i>Profil harusnya ada. (DD)</i> <i>perbedaan daftar risiko dengan profil?</i>	compliance-driven. Kesenjangan pemahaman unit dan keterbatasan orientasi strategis membuat prioritisasi belum optimal sebagai pengungkit kinerja dan nilai publik..

Teknik Pengumpulan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>Secara detail mungkin kita juga masih belum tahu (DD)</i>	
Observasi	Unit kerja memprioritaskan risiko berdasarkan skor kemungkinan–dampak melalui peta risiko, dengan risiko operasional dominan sebagai prioritas. Namun, pemahaman unit belum merata dan prioritisasi belum mempertimbangkan analisis biaya–manfaat atau keterkaitan dengan nilai publik.	
Dokumentasi	Dokumen <i>Profil dan Peta Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024</i> menunjukkan bahwa besaran risiko ≥ 13 dikategorikan sebagai prioritas risiko dan wajib ditindaklanjuti dengan rencana penanganan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No. 122 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Dokumen profil risiko memperlihatkan bahwa sebagian besar risiko prioritas berada pada kategori Risiko Operasional dan Risiko Reputasi, dengan level risiko Tinggi (4) dan Sedang (3), seperti risiko keselamatan pasien, keterlambatan layanan, gangguan fasilitas, dan reputasi rumah sakit Dalam dokumen profil risiko, prioritas risiko telah ditetapkan secara kuantitatif melalui matriks analisis risiko, namun tidak selalu disertai penjelasan naratif mengenai rasionalisasi prioritas di tingkat unit. Dokumen manajemen risiko belum menunjukkan penggunaan formal CBA atau integrasi eksplisit dengan indikator kinerja nilai publik, meskipun selera risiko telah ditetapkan secara regulatif. Dokumen menyatakan bahwa risiko prioritas akan dilakukan penanganan dan pemantauan berkala untuk menurunkan level risiko residual di lingkungan RSUD Tarakan.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa prioritas risiko di RSUD Tarakan telah ditetapkan secara formal dan konsisten sesuai regulasi, namun masih berorientasi kepatuhan dan stabilitas operasional. Pertimbangan strategis seperti biaya–manfaat dan nilai publik belum terintegrasi, serta pemahaman unit masih terbatas, sehingga prioritas risiko lebih dipersepsikan administratif daripada instrumen strategis..

d. Perlakuan risiko

Tabel 4.39
Triangulasi data Perlakuan risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Penanganan terhadap resiko itu masing-masing unit yang buat. (TH, LH,GR,FW,SS,RO)</i> <i>memitigasi, untuk meningkatkan mutu tapi tetap efisien:</i> <i>Kemarin itu yang saya dengar, mereka mengumpulkan teman-teman spesialis dan subspesialis terkait remunerasi yang mungkin belum sesuai. Dan kita sedang berusaha untuk minta ke gubernur untuk perbaikan tarif. Kemarin juga minta BPJS, sebetulnya arahan dari Prof Amal supaya pembayaran BPJS ke rumah sakit itu bagaimana caranya untuk lebih cepat supaya tidak terlalu lama. (YE)</i> <i>Ya, kalau itu kita mungkin harus menyampaikan ke pimpinan dulu, nanti kalau menurut pimpinannya Oke ini dimitigasi lanjut untuk penanganan dan sebagainya. (NE)</i>	Perlakuan risiko di RSUD Tarakan berjalan desentralistik namun masih administratif dan prosedural, berorientasi efisiensi dan kepatuhan. Integrasi dengan strategi penciptaan nilai publik dan pendekatan partisipatif belum optimal.
Observasi	Ditemukan praktik bahwa setiap unit secara mandiri menyusun rencana penanganan risiko dan melaporkannya kepada pimpinan sebelum diimplementasikan Teramati bahwa penanganan risiko lebih berfokus pada menjaga kelancaran operasional harian dibandingkan pengendalian risiko strategis jangka Panjang	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Ditemukan kepatuhan formal terhadap regulasi, namun variasi kualitas implementasi antar unit masih terlihat Teramati bahwa penanganan risiko reputasi bersifat reaktif terhadap komplain dan temuan eksternal Terlihat adanya pola hierarkis: unit → pimpinan → keputusan mitigasi	
Dokumentasi	Dokumen Peta & Profil Risiko memuat kolom <i>Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan</i> dan <i>Keputusan Penegasan</i> yang menunjukkan risiko ditangani (status “Ya”) Program Manajemen Risiko RSUD Tarakan 2024 menekankan pengendalian risiko operasional untuk menjamin efektivitas layanan Dokumen dasar hukum dan formulir penanganan risiko menunjukkan kesesuaian dengan kerangka regulative Profil Risiko memuat risiko reputasi dengan tindakan mitigasi berupa pelatihan dan monitoring Matriks prioritas risiko dan kolom <i>Keputusan Penegasan</i> pada Peta Risiko RSUD Tarakan	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa perlakuan risiko di RSUD Tarakan telah berjalan konsisten dan terdokumentasi di tingkat unit, namun masih parsial, sektoral, dan berorientasi operasional. Perlakuan risiko belum terintegrasi dengan tujuan strategis, kinerja organisasi, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan mutu dan kinerja rumah sakit belum optimal.

e. Pembiayaan risiko

Tabel 4.40

Triangulasi data Pembiayaan risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Belum ada. (TH,LH,GR,FW,SS,RO)</i> <i>nggak ada , karena kan di Pergub nggak ada ya. Mungkin gini, tadi pembiayaan. itu tidak ada khusus manajemen risiko. Ini udah dibagi-bagi, misalnya untuk kegiatan klinik budaya. Berarti misalnya pelatihan-pelatihan itu ada sih. Tapi misalnya nanti kaitannya, dalam pelayanan, misalnya sarana perasaannya nggak mendukung, misalnya perlu pengadaan lift. nanti itu ada di bagian umum ya. Tapi tidak khusus untuk manajemen. risiko nggak ada. Nah, misalnya saya maaf ada tamu besar datang. Ketika saya butuh konsumsi-konsumsi atau jasa narasumber, jasanya itu mungkin di saya SDM, konsumsi-konsumsi yang umum gitu. Ya, pelatihan-pelatihan kan seperti itu. (NS)</i> <i>Opsi pembiayaan, di risk register terkait sumber, masih mengikuti 122 Pergub apakah dari asuransi atau operasional : karena kami BLUD untuk pembiayaan sangat fleksible, sumber biaya dari BLUD, APBD hanya untuk belanja alat Kesehatan belanja modal. Barang jasa belanja pegawai dari BLUD. (WP)</i> <i>pergub ada opsi untuk pembiayaannya Nggak ada (YD,FN)</i>	Pembiayaan risiko di RSUD Tarakan belum diposisikan sebagai fungsi strategis dan belum dilembagakan dalam sistem keuangan BLUD. ERM masih dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, bukan instrumen yang memerlukan dukungan anggaran khusus.
Observasi	Dari pengamatan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Tarakan, tidak ditemukan alokasi anggaran khusus yang secara eksplisit ditetapkan untuk kegiatan manajemen risiko. Aktivitas terkait risiko (pelatihan, budaya keselamatan, perbaikan sarana, pengendalian insiden) dibiayai secara tersebar melalui unit kerja lain seperti SDM, umum, atau program pelayanan.	
Dokumentasi	Telaah terhadap Renstra Bisnis RSUD Tarakan 2023–2026 menunjukkan fokus anggaran pada peningkatan layanan, SDM, sarana prasarana, dan kinerja keuangan, tanpa pos atau program khusus pembiayaan ERM. Laporan Tahunan RSUD Tarakan Tahun 2024 juga hanya menampilkan belanja operasional dan investasi layanan, tanpa pengungkapan biaya risiko secara terpisah. Dalam Peta dan	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Profil Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024 serta Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan, aspek pembiayaan tidak dijabarkan sebagai komponen pengendalian risiko yang terstruktur.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa pembiayaan risiko di RSUD Tarakan belum dilembagakan dan tidak memiliki alokasi anggaran khusus, sehingga ERM dijalankan secara parsial melalui anggaran unit lain. Kondisi ini menegaskan bahwa ERM masih dipahami sebagai kewajiban kepatuhan, bukan investasi strategis untuk peningkatan kinerja dan nilai publik.

f. Portofolio risiko

Tabel 4.41
Triangulasi data Portofolio risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Portofolio manajemen risiko belum (TH,LH,GR,FW,SS,RO)</i> <i>Di Mutu semua (NS)</i> <i>Di Mutu semua (FK)</i> <i>Belum (YD,FN)</i> <i>Dari komite mutu (NE)</i>	Portofolio risiko di RSUD Tarakan masih parsial dan sektoral, belum terintegrasi sebagai instrumen ERM strategis. Risiko dikelola secara compliance-driven dan belum berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja, pengambilan
Observasi	Keberadaan portofolio risiko terintegrasi Tidak ditemukan dokumen portofolio risiko terintegrasi lintas unit yang merangkum risiko strategis, operasional, keuangan, dan pelayanan publik secara komprehensif. Tidak ditemukan mekanisme rutin pembaruan portofolio risiko lintas tahun dan lintas unit.	
Dokumentasi	Laporan Tahunan 2024 dan Laporan PMKP 2024 belum menampilkan <i>enterprise risk register</i> atau peta portofolio risiko rumah sakit secara menyeluruh.	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Laporan Tahunan 2024 menyajikan kinerja layanan dan keuangan, namun tidak mengaitkan capaian tersebut dengan risiko prioritas organisasi. Dokumen TL Rekomendasi BPK RI LKPD 2023 menunjukkan fokus pada risiko piutang BLUD dan klaim, namun tidak tergabung dalam portofolio risiko ERM. Laporan SKM TW IV 2024 menghasilkan indeks kepuasan dan rencana tindak lanjut, namun tidak diposisikan sebagai bagian dari portofolio risiko publik. Laporan-laporan bersifat sektoral (tahunan, mutu, SKM, audit) tanpa satu dokumen induk portofolio risiko.	keputusan strategis, dan sistem dinamis yang diperbarui berkala.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa portofolio risiko di RSUD Tarakan masih parsial dan sektoral, belum terintegrasi sebagai instrumen ERM strategis. Risiko dikelola secara compliance-driven dan administratif, sehingga belum berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja, pengambilan keputusan strategis, dan penciptaan nilai publik.

7. *Review dan revisi*

a. **Penilaian perubahan substansial pada perubahan internal / eksternal signifikan direspons dengan penyesuaian risiko**

Tabel 4.42

Triangulasi data Penilaian perubahan substansial pada perubahan internal / eksternal signifikan direspons dengan penyesuaian risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	Kami setiap triwulan kami melakukan rapat besar, itu seperti siklus kami lihat lagi, apakah sudah sesuai, kami melakukan penanganan tidak diterima begitu saja risikonya, di bulan ke-2 komite mutu dan ka satpel melakukan rapat evaluasi lagi, di mekanisme itu tiba-tiba ada kebijakan, aspek legak, kita bisa langsung merubah,	Pemantauan risiko di RSUD Tarakan telah rutin dan terstruktur, namun masih berorientasi kepatuhan

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	perubahan dan bisa di adjust langsung. Kemudian SPI ada pertemuan dengan kepala bidang/bagian disitu dapat kita ad-just langsung. (WP) Di Google Sheet, Nanti juga di Drive itu juga kita evaluasi, monitoring kita lakukan. Template nya sama. (LH, RO) Kayak evaluasinya itu ya monev, evaluasinya per tiga bulan oleh Tim mutu (LH, RO) Ini kan kita mengeliminasi resiko. Ada perubahan, bagaimana dampaknya: Berkurang : Dan di awal, di bulan Januari,. Diketahui bahwa resiko itu berkurang dilihat dari complain. dalam bentuk scoringnya, dihitung bagian mutu. (FW) Tadi saya ada lihat juga form pemantauan yang dibuat dari unit. Itu berarti yang diisi dari komite mutu, apa yang dipantau? Kalau mengisi form pemantauan itu, kira-kira apa saja yang dipantau? dan hal apa? J : Untuk gradingnya, risiko-risiko kita, apakah ada perbaikan atau ada penurunan? DD	administratif. Pemantauan belum terintegrasi dengan sistem kinerja dan indikator nilai publik, sehingga belum berfungsi sebagai pengendali kinerja strategis dan pencipta nilai publik.
Observasi	Pemantauan risiko di RSUD Tarakan dilakukan rutin oleh unit dan Komite Mutu menggunakan instrumen standar, termasuk penilaian perubahan level risiko. Namun, hasil pemantauan belum terintegrasi dengan indikator kinerja dan belum dimanfaatkan secara konsisten untuk pengambilan keputusan strategis.	
Dokumentasi	• Dokumen <i>Peta dan Profil Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024</i> menunjukkan adanya siklus pemantauan dan review risiko sebagai bagian dari tahapan manajemen risiko, termasuk pemantauan berkelanjutan dan berkala. • Peta risiko tahun 2024 memuat perubahan level risiko (tinggi-sedang) berdasarkan hasil pemantauan dampak dan kemungkinan, termasuk penetapan keputusan penegasan risiko.	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	• Dokumen Program Kerja Manajemen Risiko RSUD Tarakan menegaskan peran Tim PMKP/Mutu dan unit kerja dalam pemantauan, evaluasi, serta pelaporan risiko. • Dokumen peta risiko dan program kerja menunjukkan penggunaan matriks risiko, skor dampak–kemungkinan, serta formulir pemantauan sebagai alat utama monitoring. • Dokumen menunjukkan bahwa hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi risiko, namun tidak selalu terdokumentasi sebagai dasar perbaikan kebijakan atau alokasi sumber daya • Dokumen peta risiko dan program kerja belum menunjukkan integrasi langsung antara hasil monitoring risiko dengan indikator kinerja atau outcome pelayanan publik.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa pemantauan risiko di RSUD Tarakan telah rutin, terstandar, dan mampu mendeteksi perubahan risiko, namun masih berorientasi administratif. Pemantauan belum terintegrasi dengan kinerja, outcome pelayanan, dan keputusan strategis, sehingga berfungsi sebagai kontrol kepatuhan, bukan instrumen governance berbasis ERM dan nilai publik.

b. Review Kinerja dan Risiko

Tabel 4.43
Triangulasi Data Review kinerja dan Revisi

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	kalau ada risiko yang ternyata tidak bisa selesai di tingkat unit, upayakan perbaikannya, tapi masih sama risikonya gimana: Masih tetap menjadi tanggung jawab unit atau naik ke atasan: Naik ke atasan. Biasanya sih dari data yang ada ke atasan saya, misalnya saya kepala bagian umum. Belum ada sampai mekanisme Eskalasi. Tapi kalau resiko cascading dari atas ke bawah, ada misalnya,	Review dan revisi risiko di RSUD Tarakan masih ad hoc dan administratif, belum terlembaga sebagai siklus evaluatif yang terintegrasi

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Perkin Ibu Direktur, turun sampai ke tingkat pelaksana. (SS) risk register kemudian di tengah bulan, ada risiko yang signifikan. boleh revisi risk registernya : Boleh tapi belum ada aturannya nggak, tertulis.. Kemudian, efektivitas tadi setiap tiga bulan direview ya. (TH,LH,GR,FW,SS,RO) Mereview, monev manajemen risiko : Tidak dalam bentuk laporan, dalam, bentuk Koordinasi (ED) Dalam bentuk personal. Ini harus begini, harusnya ada ininya ya. (TH,LH,GR,FW,SS,RO) Kalau perubahan signifikan yang ada risiko baru gimana bagaimana boleh nggak dirubah lagi Sejauh ini sih jarang yang disikutin jarang. (YD) Kalau perubahan signifikan yang ada risiko baru gimana bagaimana boleh nggak dirubah lagi. Sejauh ini sih jarang yang disikutin jarang. (YD) sub komite manajemen risiko, pernah tidak berdiskusi atau komunikasi dengan Ka instalasi rawat inap dalam hal memberikan pemantauan atau evaluasi manajemen risiko, ada tidak secara periodik : Ya ada tapi tidak kontinyu (RM)	dengan keputusan manajerial, peningkatan mutu, dan kinerja organisasi.
Observasi	Review dan revisi risiko di unit kerja masih insidental dan informal, belum terjadwal dan terdokumentasi. Pemantauan berfokus pada risiko klinis dan mutu, sementara risiko non-klinis dan strategis belum direview secara konsisten atau dieskalasi berbasis hasil review.	
Dokumentasi	Dokumen <i>Peta dan Profil Risiko RSUD Tarakan Tahun 2024</i> menunjukkan bahwa identifikasi, analisis, dan penetapan rencana pengendalian risiko telah dilakukan.	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	Namun, tidak ditemukan dokumen formal yang secara eksplisit mencatat mekanisme revisi risk register di tengah periode berjalan akibat perubahan konteks risiko. Notulen rapat penerapan manajemen risiko tahun 2022–2023 menegaskan bahwa unit diminta mereview risiko yang telah disusun, namun mekanisme, frekuensi, dan standar revisi tidak diatur secara rinci dalam kebijakan tertulis. Review lebih diarahkan untuk melengkapi data awal sebelum monitoring. Laporan PMKP Tahun 2024 menunjukkan evaluasi kinerja mutu dan keselamatan pasien dilakukan secara rutin, tetapi bagian manajemen risiko belum secara eksplisit menampilkan hasil review dan revisi risiko sebagai dasar perbaikan sistemik lintas unit. Laporan Tahunan RSUD Tarakan 2024 menampilkan evaluasi kinerja, hambatan, dan rencana tindak lanjut organisasi, namun tidak secara khusus menguraikan bagaimana hasil review risiko digunakan untuk menyesuaikan kebijakan, struktur, atau alokasi sumber daya.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil triangulasi data, bahwa praktik *review* dan *revisi risiko* di RSUD Tarakan telah diakui secara normatif sebagai bagian dari manajemen risiko, namun belum terlembagakan secara sistematis sebagai siklus tata kelola yang baku, terjadwal, dan strategis. Wawancara menunjukkan bahwa review dan revisi risiko dipahami sebagai aktivitas yang dimungkinkan (boleh dilakukan), tetapi tanpa pedoman tertulis, mekanisme eskalasi yang jelas, maupun standar operasional yang mengikat, sehingga pelaksanaannya bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada inisiatif individu atau unit kerja. Observasi mengonfirmasi bahwa review risiko lebih banyak berlangsung dalam bentuk koordinasi informal atau pembahasan insidental, bukan sebagai forum evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian dan risiko residual lintas jenis risiko (klinis, non-klinis, dan strategis).

Secara dokumentatif, temuan ini diperkuat oleh ketiadaan dokumen formal yang secara eksplisit mengatur mekanisme revisi *risk register* di tengah periode berjalan, serta tidak terintegrasinya hasil review risiko dengan siklus evaluasi kinerja, pengambilan keputusan manajerial, dan penyesuaian strategi organisasi. Review risiko masih diposisikan sebagai kelanjutan administratif dan pelengkap pelaporan, bukan sebagai instrumen pembelajaran organisasi dan tata kelola strategis. Akibatnya, perubahan konteks risiko aktual di lapangan berpotensi tidak tercermin secara memadai dalam *risk register* organisasi, dan fungsi review revisi risiko belum berperan optimal dalam memperkuat integrasi ERM dengan sistem peningkatan mutu (PMKP) maupun perencanaan kinerja tahunan rumah sakit.

c. Perbaikan ERM dengan Tindakan peningkatan sistem ERM secara berkelanjutan

Tabel 4.44

Triangulasi Data Perbaikan ERM dengan Tindakan peningkatan sistem ERM secara berkelanjutan

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	laporannya ada. Itu juga ada pertemuan setiap, jadi mana yang selesai, mana yang tidak. Jadi, maksudnya risikonya itu, scoringnya turun atau tidak. Ada pemantauan dan kami juga setiap ini ada pertemuan, laporan ke subkomunitas manajemen risiko, (NS) Kalau menurut saya, memang turut mengawasi. Karena beliau sebagai pemegang kebijakan dan arahan, jadi mengarahkan kami juga. Kemudian juga, kalau ada tindak lanjut selalu menanyakan ke kami apakah TL-nya sudah. (NE) Direktur nanti disposisi untuk lakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi. (NE)	Review dan revisi risiko di RSUD Tarakan masih ad hoc dan administratif, belum terlembaga sebagai siklus evaluatif yang terintegrasi dengan pengambilan keputusan, peningkatan mutu, dan evaluasi kinerja strategis.
Observasi	Review dan revisi risiko di unit kerja masih insidental dan informal, belum sistematis serta terdokumentasi. Pemantauan berfokus pada risiko klinis dan mutu, sementara risiko non-klinis dan strategis belum direview atau dieskalasi secara terstruktur.	
Dokumentasi	Dokumen risiko RSUD Tarakan 2024 menunjukkan identifikasi dan pengendalian telah dilakukan, namun mekanisme revisi risk	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	register belum diformalkan. Review risiko bersifat awal dan insidental, belum terintegrasi dalam evaluasi kinerja, PMKP, atau penyesuaian kebijakan dan sumber daya.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa perbaikan ERM di RSUD Tarakan diakui secara normatif, namun belum terlembaga sebagai siklus review–revisi yang sistematis dan strategis. Review risiko masih ad hoc, administratif, dan tidak terintegrasi dengan kinerja, strategi, maupun PMKP, sehingga perubahan risiko aktual belum sepenuhnya tercermin dalam risk register.

8. Audit Internal ERM

a. Audit internal berbasis risiko

Tabel 4.45
Triangulasi Data Audit internal berbasis risiko

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Wawancara	<i>Mengaudit menggunakan risk based thinking atau berbasis risiko? kertas kerja audit berdasarkan apa create sendiri, kertas kerja, (NE)</i> Laporan SPI <i>Laporan SPI, kalau audit ada. Kemudian, untuk kepatuhan ada per semester. Jadi, bapak laporan audit laporan komplit. Laporan yang untuk kepatuhan manajemen risiko ke direktur langsung.</i> <i>Kalau ke dewas kami melalui direktur dulu, jadi kami tidak langsung ke dewas. (NE)</i> Proses Audit <i>Yang diaudit biasanya instalasi-instalasi, Unit-unit misalnya, Tahun lalu kami, mengaudit farmasi.</i> <i>Itu dijadwalkan pilihannya?</i> <i>Misalnya tahun ini unit ini, atau kalau saya punya grading kecil-kecilan, Jadi yang saya grading itu yang memiliki anggaran besar,</i>	Audit internal di RSUD Tarakan masih bersifat compliance-driven dan reaktif, belum berfungsi optimal sebagai third line of defense berbasis risiko. Peran SPI dalam governance dan penciptaan nilai publik masih lemah dan lebih sebagai unit pendukung

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	<i>kemudian pelayanannya juga, misalnya, kompleks. (NE)</i> <i>tidak mengaudit yang kabit-kabit : Iya.(NE)</i> <i>Belum pernah mengaudit komite mutu. Belum (NE)</i> <i>Memeriksa risk register di unit tapi kumpulkannya semua ke subkom manrisk, merekap juga menentukan ranking. (NE)</i> <i>di SPI ada SOP-SOP melakukan audit (NE)</i> <i>Selain itu, biasanya, kesibukan kita kalau dari awal tahun pendampingan, Karena LKPD itu pasti setiap Februari sampai Mei itu BPK di kami, jadi pendampingan untuk audit eksternal. BPK perwakilan DKI. (NE)</i> <i>Bapak auditnya dua-duanya klinis dan non-klinis atau hanya lebih ke area keuangan ? Ke area keuangan. Lebih banyak ke keuangan, persediaan. (NE)</i> <i>Kalau pelayanan waktu tahun 2024, pernah audit layanan akupunktur, karena akupunktur kami auditnya kinerja. Yang tadi 3N, (NE)</i> <i>Maksud saya, yang ketika Bapak per tahun, itu tiap 3 bulan, itu melakukan audit ? Selain keuangan, semua pelayanan yang ada di rumah sakit ini, Bapak audit tidak? ada IGD, ada. ICU itu juga masuk ranah Bapak, masuk hanya pada saat grading-nya tidak masuk ke grading kami. (NE)</i> <i>yang melakukan audit pelayanan, background dari 4 orang di SPI dari bagian Farmasi, Kemudian dua orang lagi dari keperawatan, 1 orang dari sarjana ekonomi. (NE)</i>	dibanding strategic assurance provider.
Observasi	Fungsi audit internal (SPI) di RSUD Tarakan masih berfokus pada keuangan dan kepatuhan, belum menerapkan risk-based audit yang terintegrasi dengan risk register. Pelaporan SPI terbatas ke Direktur, independensi dan peran pengawasan strategis masih lemah, serta	

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	pemantauan tindak lanjut belum didukung sistem audit terintegrasi.	
Dokumentasi	Dokumen <i>Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LKPD Tahun 2023</i> menunjukkan bahwa sebagian besar temuan BPK (pendapatan, belanja, piutang BLUD) ditindaklanjuti melalui koordinasi administratif, penyusunan perjanjian, klarifikasi, dan penagihan. Tidak ditemukan dokumen yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan langsung antara hasil audit internal SPI dengan pencegahan temuan BPK secara proaktif. Dokumen tindak lanjut BPK menunjukkan adanya batas waktu pelaksanaan (Juni–November 2024) dan bukti administratif berupa surat, perjanjian kerja sama, klarifikasi ke Kemenkes/BPKP, serta dokumen penagihan piutang. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pengendalian lebih kuat pada audit eksternal dibandingkan audit internal rumah sakit.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa audit internal (SPI) di RSUD Tarakan telah berjalan formal, namun masih compliance-driven dan belum berfungsi optimal sebagai *third line of defense* berbasis ERM. Posisi strategis SPI lemah karena keterbatasan independensi, minimnya integrasi dengan manajemen risiko dan kinerja, serta peran yang lebih mendukung audit eksternal daripada sebagai strategic assurance dalam tata kelola publik.

b. Tindak lanjut audit internal

Tabel 4.46
Triangulasi Data Tindak lanjut audit internal

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	ada monitoring hasil, lapor ke Direktur, kemudian mekanismenya: Direktur nanti disposisi untuk lakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi. (NE)	Tindak lanjut audit di RSUD Tarakan

Teknik Pengambilan data	Hasil Penelitian	Kesimpulan
	memantau lagi tidak setelah ini: Iya, memantau hasilnya (NE) Kemudian tindak lanjut dari hasil audit tadi kalau 3 line model, ada lini 1, lini 2, lini 3. Berarti Bapak ada di lini berapa: Lini 1. (NE)	masih bersifat administratif dan compliance-driven, belum terintegrasi sebagai mekanisme pembelajaran dan pengendalian risiko dalam siklus ERM.
Observasi	Tindak lanjut audit dilakukan melalui disposisi Direktur dan pelaksanaan unit, namun pemantauan masih informal dan tidak berbasis indikator risiko. Peran three lines belum terintegrasi, fokus tindak lanjut lebih pada pemenuhan rekomendasi pemeriksa daripada mitigasi risiko berulang, serta belum dimanfaatkan sebagai input pembaruan risk register.	
Dokumentasi	Matriks tindak lanjut rekomendasi BPK tersedia dengan penugasan dan tenggat, namun berfokus administratif. Tidak terdapat mekanisme eskalasi, evaluasi efektivitas, keterlibatan three lines, maupun keterkaitan dengan risiko residual dan portofolio risiko organisasi.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Triangulasi menunjukkan bahwa tindak lanjut audit di RSUD Tarakan telah berjalan formal dan patuh regulasi, namun masih bersifat administratif dan belum berbasis risiko. Peran three lines belum terintegrasi, sehingga hasil audit belum dimanfaatkan sebagai pembelajaran organisasi atau input strategis dalam pembaruan risk register dan portofolio risiko.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, pembahasan ini menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu: (1) Bagaimana kondisi aktual penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta; (2) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta; dan (3) Bagaimana Model *Enterprise Risk Management* (ERM) pada pelayanan publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan triangulasi data dari wawancara,

observasi, dan dokumen, yang menghasilkan temuan empiris tentang implementasi ERM di rumah sakit publik

Pembahasan ini difokuskan pada dimensi dan indikator sesuai operasional konsep ERM, yaitu: (1) Dimensi Tata Kelola dan Budaya, yang mengkaji struktur pengawasan dan budaya risiko; (2) Dimensi Strategi dan Sasaran, yang mengevaluasi penetapan tujuan strategis dengan mempertimbangkan risiko; (3) Dimensi Kerangka Kerja, yang membahas Program kerja dan Perbaikan berkelanjutan; (4) Dimensi Informasi dan Komunikasi, yang menganalisis sistem informasi dan komunikasi risiko; (5) Dimensi Performance, yang pengkajian dan perlakuan risiko; (6) Dimensi Review dan Revisi, yang mengeksplorasi pengkajian dan pemantauan risiko; serta (7) Dimensi Audit Internal, yang memeriksa risiko secara independen. Setiap dimensi akan dianalisis berdasarkan indikator-indikator spesifik, dikaitkan dengan teori administrasi publik, COSO ERM 2017 ASHRM, dan Undang Undang Pelayanan Publik, serta dibandingkan dengan penelitian terbaru untuk memberikan wawasan yang komprehensif. Dengan struktur ini, pembahasan bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik ERM di RSUD Tarakan dan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan publik kesehatan.

Sebagai langkah awal untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kondisi aktual penerapan manajemen risiko, pembahasan ini dimulai dengan gambaran umum penerapan ERM di RSUD Tarakan, yang mencakup analisis keseluruhan implementasi berdasarkan data triangulasi dari berbagai sumber.

1. Gambaran Umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan

a. Pemahaman ERM di RSUD Tarakan

Dalam konteks manajemen risiko di rumah sakit, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan tradisional dan ERM yang lebih modern, yang tercermin dalam temuan penelitian di RSUD Tarakan. Manajemen risiko tradisional cenderung bersifat reaktif dan terfragmentasi, di mana risiko diperlakukan sebagai insiden individu yang harus dimitigasi secara terpisah tanpa mempertimbangkan interdependensi atau dampak holistik terhadap nilai organisasi.

Sebaliknya, ERM dipahami sebagai proses terintegrasi yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko secara menyeluruh di seluruh tingkatan organisasi, sejalan dengan definisi COSO ERM 2017 yang menekankan peran Dewan Direksi, Manajemen, dan Staf dalam mengelola risiko sesuai

dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi (Moeller, 2011).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan ERM di RSUD Tarakan belum sepenuhnya mampu mengelola paradoks pelayanan kesehatan sebagai risiko strategis. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketegangan antara tuntutan peningkatan akses pelayanan, kualitas layanan, dan keterbatasan sumber daya belum diposisikan sebagai bagian dari risiko strategis organisasi. Akibatnya, pengelolaan risiko yang dilakukan masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, ERM yang diterapkan belum berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjembatani dualisme peran rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik dan organisasi yang harus menjaga keberlanjutan operasionalnya, melainkan masih berada pada tataran administratif dan operasional. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek implementasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman konseptual terhadap ERM di dalam organisasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman ERM di RSUD Tarakan belum merata dan masih didominasi oleh pendekatan tradisional, di mana risiko dianggap sebagai ancaman reaktif yang terbatas pada mitigasi individu, tanpa integrasi ke dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini menghambat transisi menuju ERM yang proaktif, yang menurut COSO (2017) dan Kaplan & Mikes (2012), mampu menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan risiko sebagai peluang dan ancaman saling terkait, terutama dalam lingkungan VUCA yang dinamis.

Transisi dari manajemen risiko tradisional ke ERM menjadi krusial dalam konteks kesehatan, karena memungkinkan pengelolaan sinergis antara risiko klinis dan non-klinis, yang pada akhirnya meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, risiko di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: risiko klinis, yang mencakup peristiwa negatif terkait pelayanan kesehatan; dan risiko non-klinis, yang meliputi peristiwa di luar pelayanan kesehatan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan manajemen risiko yang komprehensif, di mana ERM berperan dalam identifikasi, penilaian, dan

pengelolaan proaktif guna meningkatkan mutu layanan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman risiko di RSUD Tarakan masih terfokus pada aspek klinis, dengan staf dan manajemen sering menganggap risiko sebagai insiden reaktif seperti kesalahan medis, tanpa memperhatikan interaksi dengan risiko non-klinis.

Lebih lanjut, kategori risiko dalam organisasi pelayanan kesehatan umumnya terdiri atas risiko strategis, operasional, kepatuhan, reputasi, dan keuangan. Setiap kategori tersebut tidak bersifat eksklusif terhadap satu domain risiko tertentu, melainkan dapat mencakup baik risiko klinis maupun nonklinis secara simultan. Sebagai contoh, risiko operasional klinis dapat berupa potensi kesalahan prosedur klinis yang berdampak pada keselamatan pasien maupun risiko operasional non klinis berupa gangguan sistem informasi yang menghambat pelayanan. Demikian pula, risiko reputasi, dapat berupa potensi insiden keselamatan pasien sebagai domain klinis maupun kegagalan tata kelola organisasi sebagai domain non klinis. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi menjadi krusial agar organisasi mampu mengidentifikasi keterkaitan antar kategori risiko serta memastikan bahwa seluruh potensi dampak baik klinis maupun non-klinis dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ERM, risiko organisasi dapat dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu risiko sistematis dan risiko unsistematis. Risiko sistematis (*systematic risk*) merupakan risiko yang bersifat makro dan berdampak luas terhadap organisasi, sektor, maupun sistem secara keseluruhan. Risiko ini umumnya berasal dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, krisis ekonomi, fluktuasi anggaran pemerintah, maupun kondisi epidemiologis, sehingga tidak dapat dieliminasi melalui pengendalian internal semata. Dalam perspektif COSO ERM 2017, risiko sistematis dikategorikan sebagai risiko strategis karena berkaitan langsung dengan *external environment* dan pencapaian tujuan strategis organisasi, sehingga pengelolaannya memerlukan *environment scanning*, formulasi strategi adaptif, penetapan *risk appetite* yang realistis, serta penguatan tata kelola organisasi (Moeller, 2011; Frigo & Anderson, 2011).

Sebaliknya, risiko unsistematis (*unsystematic risk*) merupakan risiko yang bersifat mikro, spesifik pada organisasi, unit kerja, atau aktivitas tertentu, dan pada umumnya dapat dikurangi melalui pengendalian internal yang efektif. Dalam konteks rumah sakit pemerintah, risiko ini dapat berupa *human error* pada

prosedur klinis, kegagalan alat kesehatan di unit tertentu, fraud internal, maupun keterlambatan distribusi logistik farmasi yang berdampak pada kelancaran pelayanan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua jenis risiko terletak pada tingkat kendali organisasi: risiko sistematis menuntut respons strategis dan adaptif, sedangkan risiko unsistematis lebih menekankan pada penguatan sistem pengendalian operasional.

Temuan empiris menunjukkan bahwa manajemen risiko di RSUD Tarakan masih didominasi oleh pengelolaan risiko unsistematis. Identifikasi risiko telah berjalan sistematis di tingkat unit dan mencakup risiko klinis maupun non-klinis, namun prosesnya masih bersifat operasional, reaktif, dan berbasis pengalaman unit, serta belum diturunkan dari strategi organisasi maupun dikaitkan secara eksplisit dengan kinerja strategis. Analisis risiko juga berfokus pada pencegahan insiden dan gangguan pelayanan menggunakan matriks probabilitas–dampak, tetapi tindak lanjutnya lebih bersifat teknis-administratif daripada strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko belum sepenuhnya berfungsi sebagai *performance enabler* sebagaimana prinsip *risk–performance linkage* dalam COSO ERM.

Di sisi lain, perhatian terhadap risiko sistematis masih relatif terbatas. Penelitian menegaskan bahwa rumah sakit perlu memperluas identifikasi menuju risiko strategis untuk menghadapi tantangan VUCA di sektor kesehatan Indonesia, karena fokus yang terlalu kuat pada risiko operasional dapat menghambat kesiapan organisasi dalam merespons ketidakpastian eksternal. Selain itu disharmonisasi regulasi sebagai risiko sistematis yang mempengaruhi penerapan ERM di RSUD Tarakan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka ERM yang menekankan integrasi risiko dengan strategi dan praktik lapangan yang masih berorientasi kepatuhan.

Keterbatasan penerapan ERM yang masih berorientasi pada risiko klinis menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya mengadopsi perspektif *systems thinking* dalam memahami kompleksitas risiko. Dalam organisasi yang bersifat kompleks, hubungan sebab-akibat sering kali tidak linear serta menuntut pemahaman terhadap interdependensi strategis antar unit dan fungsi organisasi. Tanpa perspektif sistem, risiko cenderung dipahami sebagai peristiwa operasional yang berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari dinamika organisasi yang saling terhubung. Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak organisasi merasa telah

mengelola risiko, namun tetap rentan terhadap kegagalan strategis (Kim & Senge, 1994).

Kegagalan dalam mengimplementasikan ERM secara *enterprise-wide* pada dasarnya bukan semata persoalan metodologis, melainkan berakar pada keterbatasan cara berpikir organisasi dalam membaca kompleksitas sistem. Ketika hubungan sebab-akibat tidak terlihat secara langsung, organisasi cenderung mereduksi risiko pada level operasional dan mengabaikan dinamika strategis yang justru menentukan keberlanjutan kinerja. Akibatnya, perhatian manajemen lebih terfokus pada risiko yang paling terlihat seperti risiko klinis sementara risiko strategis yang berkaitan dengan reputasi, keberlanjutan fiskal, dan legitimasi publik berpotensi terabaikan. Dengan demikian, persoalan utama dalam implementasi ERM bukan terletak pada ketiadaan instrumen teknis, tetapi pada keterbatasan pola pikir organisasi dalam memahami interdependensi sistemik (Kim & Senge, 1994).

Transformasi menuju ERM enterprise-wide oleh karena itu harus dipahami sebagai proses *organizational learning*. Konsep *mental models*, yang merujuk pada peta internal berupa keyakinan, asumsi, dan rutinitas yang membentuk persepsi serta tindakan individu, memainkan peran sentral dalam proses tersebut. Apabila pimpinan dan pengelola organisasi masih memaknai risiko sebatas bahaya klinis atau insiden operasional, maka ERM tidak akan berkembang menjadi instrumen tata kelola strategis. Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar prosedural, melainkan bersifat *epistemic* yaitu perubahan mendasar pada cara organisasi memahami realitas risiko (Kim & Senge, 1994).

Dalam konteks pembelajaran organisasi, perubahan mental model individu hanya akan berdampak sistemik apabila berkembang menjadi *shared mental models* yang kemudian mengarahkan tindakan kolektif organisasi. Tanpa proses tersebut, organisasi berisiko mengalami *fragmented learning*, yaitu situasi ketika pembelajaran terjadi pada individu atau unit tertentu tetapi tidak terintegrasi ke dalam memori organisasi. Fenomena ini sering terlihat dalam praktik manajemen risiko sektor publik, dimana keberadaan komite atau unit risiko tidak otomatis menghasilkan perubahan strategis karena pemahaman risiko tidak tersebar secara merata (Kim & Senge, 1994).

Dari perspektif *systems thinking*, kegagalan mengintegrasikan pembelajaran organisasi sering kali diperparah oleh apa yang disebut sebagai

dynamic complexity, yakni kondisi ketika hubungan sebab-akibat sulit diidentifikasi karena melibatkan berbagai keterlambatan, umpan balik, serta pola perubahan jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, organisasi dapat terjebak dalam *superficial learning*, yaitu perubahan perilaku tanpa diikuti perubahan asumsi dasar. Akibatnya, setiap krisis ditangani secara reaktif tanpa menghasilkan kapasitas organisasi untuk mengantisipasi risiko serupa di masa depan. Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan ERM pada posisi simbolik sebagai alat kepatuhan (*symbolic compliance*), bukan sebagai mekanisme navigasi strategi (Kim & Senge, 1994).

Oleh karena itu, implementasi ERM enterprise-wide mensyaratkan transformasi organisasi menjadi *learning organization* yang mampu mengembangkan kapabilitas adaptif secara berkelanjutan. Pengembangan kapabilitas tersebut tidak dapat dicapai melalui pelatihan sesaat atau peningkatan anggaran semata, tetapi membutuhkan komitmen terhadap perubahan budaya, infrastruktur, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, *enterprise risk* bukan sekadar proyek manajerial, melainkan agenda transformasi organisasi (Kim & Senge, 1994).

Peran kepemimpinan menjadi krusial dalam proses transformasi tersebut. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya menyediakan visi dan arah strategis, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya serta mendorong koordinasi lintas batas organisasi. Tanpa dukungan manajemen puncak, ERM berisiko terjebak pada level administratif dan gagal memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Oleh sebab itu, pimpinan organisasi tidak cukup berfungsi sebagai regulator internal, tetapi harus bertindak sebagai *risk leader* yang mengarahkan organisasi menuju kesadaran risiko kolektif (Yang & Maxwell, 2011).

Penerapan ERM membutuhkan kepemimpinan transformasional yang mampu membangun budaya risiko, mengintegrasikan visi strategis, serta mendorong pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Pemimpin transformasional berfungsi sebagai integrator sistem dan agen perubahan yang memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari tata kelola rumah sakit publik secara menyeluruh.

Selain kepemimpinan, integrasi risiko juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam berbagi informasi lintas unit maupun lintas

organisasi. Struktur birokrasi yang kaku, perbedaan prosedur, serta resistensi terhadap perubahan sering menjadi hambatan utama dalam proses tersebut. Fragmentasi informasi menyebabkan risiko strategis sulit terdeteksi karena data tersebar dalam *silo* organisasi. Dalam konteks ini, *enterprise-wide* ERM mensyaratkan adanya sistem berbagi informasi risiko yang memungkinkan organisasi membaca pola interdependensi secara lebih komprehensif (Yang & Maxwell, 2011).

Lebih fundamental lagi, organisasi perlu menyadari bahwa tindakan tidak selalu menghasilkan pembelajaran. Pengalaman menunjukkan bahwa organisasi dapat mengambil tindakan, mengamati respons, dan menarik kesimpulan tanpa benar-benar memahami hubungan antara keputusan dan dampaknya. Ketika kesalahan atribusi ini terjadi, organisasi berpotensi mengembangkan kebijakan yang tidak efektif sekalipun tampak berhasil dalam jangka pendek. Hal ini menegaskan pentingnya *systems thinking* sebagai kerangka analitis untuk memahami umpan balik serta konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan strategis (Kim & Senge, 1994).

Dengan mengintegrasikan perspektif *systems thinking* dan *organizational learning*, ERM *enterprise-wide* dapat dipahami sebagai kapasitas organisasi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap risiko melalui perubahan mental model, penguatan pembelajaran bersama, serta pengembangan kapabilitas adaptif. Transformasi ini menandai pergeseran mendasar dari pendekatan *risk management* tradisional menuju *risk governance* yang bersifat strategis.

Sintesis tersebut mengarah pada pemahaman bahwa organisasi berperforma tinggi bukanlah organisasi yang sekadar mampu mengidentifikasi risiko, tetapi organisasi yang mampu memahami bagaimana risiko muncul dari interaksi sistemik serta bagaimana respons terhadap risiko akan membentuk masa depan organisasi. Dalam perspektif ini, ERM berfungsi tidak hanya sebagai alat proteksi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan *organizational resilience* sekaligus memperkuat penciptaan nilai publik.

Dengan demikian, kritik terhadap keterbatasan penerapan ERM sesungguhnya membuka ruang untuk menegaskan bahwa *enterprise-wide risk management* merupakan manifestasi dari kematangan organisasi dalam berpikir sistemik. Tanpa *systems thinking*, risiko akan selalu terlihat parsial; namun

dengan perspektif sistem, risiko berubah menjadi sumber *strategic insight* yang memungkinkan organisasi mengantisipasi ketidakpastian secara lebih cerdas.

Hal ini sejalan dengan panduan ASHRM (2020), yang mengklasifikasikan domain risiko kesehatan menjadi klinis, operasional, strategis, keuangan, hukum, teknologi, dan *hazard*, tetapi temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman ERM belum merata, dengan fokus utama pada risiko klinis dan operasional, sementara risiko strategis dan teknologi belum dipahami oleh staf non-klinis. Ketidakmerataan ini berpotensi mengurangi efektivitas peningkatan mutu pelayanan kesehatan, karena risiko klinis yang tidak terkelola dapat menyebabkan insiden keselamatan pasien, sedangkan risiko non-klinis seperti kebocoran data kesehatan dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan data dalam UU No. 17 Tahun 2023.

Selain klasifikasi jenis risiko, pemahaman ERM di RSUD Tarakan juga dipengaruhi oleh level organisasi, yaitu strategis, taktis, dan operasional, yang menuntut pendekatan terintegrasi namun belum sepenuhnya terwujud. Pada level strategis, ERM seharusnya mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti perubahan regulasi kesehatan atau krisis keuangan akibat pandemi, yang memerlukan pengelolaan proaktif untuk mendukung ketahanan organisasi. Level taktis melibatkan koordinasi antar departemen untuk mengelola risiko operasional, sedangkan level operasional fokus pada mitigasi risiko harian seperti kesalahan prosedural.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum ada pembagian pemahaman risiko yang jelas di level ini, di mana banyak staf dan manajemen tingkat menengah masih menganggap risiko sebagai insiden klinis reaktif, tanpa melihatnya sebagai elemen strategis. Hanya 3 informan yang memahami ERM sebagai proses lintas-fungsi, dari 18 informan, sementara sisanya 15 informan terjebak pada pemahaman tradisional risiko sebagai masalah operasional semata.

Ketidakmerataan ini tercermin dalam evolusi paradigma administrasi publik, dari *Old Public Administration* (OPA) yang hierarkis dan birokratis, menuju *New Public Management* (NPM) yang berorientasi efisiensi, serta *New Public Service* (NPS) yang menekankan nilai publik dan partisipasi. Dalam konteks OPA, ERM dipahami sebagai kewajiban administratif untuk mematuhi regulasi seperti KMK No. 1128/2022, terutama di kalangan staf administrasi. Pendekatan NPM terlihat dalam fokus pada pengukuran kinerja dan efisiensi,

seperti pengurangan biaya risiko melalui *Value for Money* (VfM), namun pemahaman ini belum merata, dengan manajemen operasional lebih paham daripada staf klinis. Sementara itu, NPS tercermin dalam pemahaman ERM sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan partisipasi pemangku kepentingan, sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan *Standard Decision by Government dan Performance Index by Citizen*, meskipun temuan penelitian menyoroti bahwa pemahaman partisipatif ini masih terbatas pada kelompok elit, sehingga partisipasi pemangku eksternal seperti pasien belum optimal.

Secara keseluruhan, ketidakmerataan pemahaman risiko di RSUD Tarakan, baik dalam jenis risiko klinis dan non-klinis maupun domain serta level organisasi, diperburuk oleh kurangnya pelatihan ERM yang komprehensif, menyebabkan risiko dianggap sebagai ancaman terpisah dari ERM sebagai solusi terintegrasi. Hal ini membuat implementasi dimensi *Performance* dalam ERM tidak konsisten dan kurang adaptif terhadap VUCA, sehingga berpotensi mengurangi nilai publik seperti keselamatan pasien dan mutu layanan.

Dalam konteks penelitian ini, temuan bahwa implementasi ERM di RSUD Tarakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan komponen strategis menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko masih cenderung berorientasi pada mitigasi risiko klinis dibandingkan penciptaan nilai organisasi secara menyeluruh.

Padahal, sebagai organisasi pelayanan publik yang dibiayai oleh sumber daya negara, RSUD Tarakan secara inheren merupakan *public enterprise* institusi yang harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial, efisiensi operasional, mutu layanan dan keselamatan pasien.

Kegagalan mengintegrasikan nilai *enterprise* ke dalam ERM berpotensi menimbulkan bias pelayanan, misalnya peningkatan kualitas layanan tanpa kontrol biaya, atau sebaliknya efisiensi fiskal yang mengorbankan *outcomes* kesehatan. Dalam kerangka *Public Service Value*, kondisi tersebut mencerminkan trade-off yang dapat mengurangi nilai publik apabila tidak dikelola secara strategis. (Cole, M., & Parston, G. 2006).

Oleh karena itu, transformasi ERM menuju pendekatan *public enterprise-wide* menjadi krusial agar risiko tidak hanya dipahami sebagai ancaman operasional, tetapi juga sebagai variabel strategis dalam penciptaan nilai publik. Dalam konteks pelayanan kesehatan, pendekatan ini menuntut integrasi antara

manajemen risiko, kinerja sistem pelayanan kesehatan, serta hasil pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan tersebut adalah *Hospital Public Service Value Outcome Model* yang dikembangkan dalam sistem kesehatan Ontario (Cole & Parston, 2006).

Model ini menjelaskan bahwa Nilai layanan publik rumah sakit ditentukan oleh dua Dimensi yaitu *Outcome* dan *Cost Effectiveness* untuk menjelaskan proses penciptaan nilai publik dalam organisasi pelayanan kesehatan.

Konsep nilai publik (*public value*) pertama kali diperkenalkan oleh Moore yang menekankan bahwa organisasi sektor publik harus mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Moore, 1995). Dalam konteks pelayanan kesehatan, nilai publik tercermin dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan (WHO, 2007). Oleh karena itu, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan publik dituntut tidak hanya menghasilkan outcome klinis yang baik, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem pelayanan serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dimensi *Outcome* klinis menggambarkan keberhasilan pelayanan medis dalam meningkatkan status kesehatan pasien serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Dimensi *cost-effectiveness* menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan dalam menghasilkan manfaat kesehatan yang optimal.

1) Dimensi Outcome Klinis: Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan

Keselamatan pasien dan Mutu pelayanan merupakan komponen penting dalam evaluasi kinerja pelayanan klinis rumah sakit. Donabedian menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dapat dinilai melalui outcome klinis yang dihasilkan oleh sistem pelayanan kesehatan (Donabedian, 1988). Dalam konteks ini, Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini antara lain seperti kepatuhan terhadap *clinical pathway*, tingkat *hospital-acquired infection (HAIs)*, *medication error rate*, *30-day readmission rate*, *mortality rate*, jumlah kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan (*adverse events*), serta *pressure injury rate*. Indikator-

indikator tersebut telah digunakan secara luas dalam sistem pemantauan keselamatan pasien di berbagai negara (WHO, 2017).

2) *Dimensi Cost effectiveness*

Optimalisasi sumber daya merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi sistem pelayanan rumah sakit. Efisiensi ini tercermin melalui pemanfaatan tempat tidur yang optimal, pengurangan pemborosan dalam proses klinis dan administratif, serta pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Beberapa indikator operasional yang umum digunakan untuk mengukur efisiensi rumah sakit antara lain *Bed Occupancy Rate (BOR)*, *Average Length of Stay (ALOS)*, *Turn Over Interval (TOI)*, serta *Bed Turn Over (BTO)*. Indikator-indikator tersebut banyak digunakan dalam analisis kinerja rumah sakit untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya pelayanan kesehatan (WHO, 2003).

Selain itu, efisiensi biaya pelayanan kesehatan juga dapat diukur melalui *cost per case* berbasis sistem pembayaran INA-CBG, rasio klaim pending BPJS, persentase unit layanan yang mengalami *overbudget*, serta persentase pasien rawat inap tanpa indikasi klinis (*alternate level of care*). Indikator-indikator ini mencerminkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola sumber daya secara optimal sekaligus menjaga keberlanjutan finansial organisasi.

3) *Governance and Enterprise Risk Management*

Tata kelola organisasi yang efektif merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ERM semakin banyak diterapkan dalam organisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan ketahanan organisasi terhadap berbagai risiko strategis, operasional, dan finansial (COSO, 2017).

Risk management maturity ini mencakup integrasi ERM dalam proses pengambilan keputusan strategis, penerapan *risk-based budgeting*, serta penetapan *risk appetite* organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kematangan manajemen risiko meliputi skor maturitas ERM rumah sakit, persentase unit yang memiliki *risk register* aktif, persentase risiko strategis yang memiliki rencana mitigasi, penggunaan *risk dashboard*

dalam rapat manajemen, frekuensi kejadian kerugian (*loss events*), serta besaran kerugian finansial akibat kejadian risiko.

4) **Value Creation**

Model ini juga menjelaskan alur penciptaan nilai publik melalui suatu mekanisme yang sistematis. Implementasi pelayanan berbasis bukti (*evidence-based care*) akan meningkatkan kualitas pelayanan klinis. Peningkatan kualitas tersebut pada akhirnya akan menurunkan kejadian tidak diharapkan (*adverse events*), sehingga biaya akibat mutu yang buruk (*cost of poor quality*) dapat ditekan. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit sekaligus memperkuat keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, proses tersebut akan menghasilkan nilai layanan publik yang optimal bagi masyarakat.

5) **Keunggulan Model ERM**

Dibandingkan dengan model *Public Service Value* dalam sistem kesehatan Ontario, Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, model ini secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan *enterprise risk management* dalam kerangka evaluasi kinerja rumah sakit. *Kedua*, model ini menambahkan dimensi tata kelola berbasis risiko (*risk-based governance*) sebagai faktor penting dalam menciptakan nilai layanan publik. *Ketiga*, model ini relevan untuk diterapkan pada rumah sakit publik dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Keempat*, indikator dalam model ini dapat diintegrasikan dengan sistem dashboard digital untuk pemantauan kinerja organisasi secara real-time.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa ERM dalam organisasi kesehatan publik harus bergerak melampaui paradigma compliance menuju paradigma *value creation*. Integrasi antara nilai enterprise dan nilai pelayanan bukanlah dikotomi, melainkan prasyarat bagi organisasi publik untuk mempertahankan legitimasi, meningkatkan kinerja, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program edukasi ERM yang intensif untuk menyelaraskan pemahaman di seluruh organisasi,

meminimalkan risiko klinis melalui pelatihan staf medis, dan mengoptimalkan risiko non-klinis melalui kolaborasi lintas departemen. Dengan pendekatan ini, RSUD Tarakan dapat memenuhi mandat UU No. 17 Tahun 2023 untuk mengintegrasikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, sehingga berkontribusi maksimal pada pencapaian tujuan ERM yang adaptif dan berbasis nilai publik.

b. Penerapan ERM di RSUD Tarakan

Penerapan ERM di RSUD Tarakan diatur oleh dua regulasi utama yaitu Peraturan Gubernur (Pergub no 122 tahun 2020) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan, KMK No. 1128/2022. Pergub no 122/2020, mewajibkan rumah sakit daerah untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah, sementara Standar akreditasi Kementerian Kesehatan menuntut penerapan manajemen risiko sebagai syarat mutlak untuk memperoleh Akreditasi Rumah Sakit. Dengan demikian, RSUD Tarakan harus mengadopsi kedua regulasi ini secara simultan, yang sering kali menimbulkan tantangan dalam harmonisasi praktik. Kedua regulasi ini merujuk pada ISO 31000:2018 sebagai kerangka kerja utama untuk manajemen risiko, yang menekankan proses sistematis identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko, namun belum sepenuhnya mengadopsi COSO ERM 2017 yang lebih fokus pada integrasi risiko dengan strategi bisnis. Hal ini membuat RSUD Tarakan mengintegrasikan elemen-elemen ISO 31000 ke dalam praktik sehari-hari, sambil menyesuaikan dengan konteks regulasi lokal dan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ERM di RSUD Tarakan belum melibatkan lima komponen COSO ERM 2017, yaitu *Governance and Culture* (budaya sadar risiko dan komitmen pimpinan), *Strategy and Objective-Setting* (penetapan tujuan strategis dengan mempertimbangkan risiko), *Performance* (identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko), *Review and Revision* (evaluasi berkelanjutan), serta *Information, Communication, and Reporting* (pelaporan risiko yang transparan). Penerapan ini mencakup risiko klinis (seperti keselamatan pasien) dan non-klinis (seperti keuangan dan reputasi), dengan integrasi di tingkat strategis (perencanaan rumah sakit), taktis (pengorganisasian unit), dan operasional (aktivitas sehari-hari). Meskipun regulasi utama merujuk

pada ISO 31000:2018, komponen COSO ini digunakan sebagai alat pendukung untuk memastikan bahwa praktik ERM di RSUD Tarakan tidak hanya memenuhi standar akreditasi tetapi juga selaras dengan Pergub 122, yang menekankan pengelolaan risiko sebagai bagian dari tata kelola publik.

Penerapan ERM di RSUD Tarakan menunjukkan transisi yang kompleks dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang birokratis menuju *New Public Management* (NPM) yang efisien, serta *New Public Service* (NPS) yang partisipatif, namun dengan pengakuan bahwa institusi rumah sakit tidak dapat sepenuhnya menghilangkan elemen OPA. Dalam konteks OPA, sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003), ERM diterapkan melalui struktur hierarkis dengan fokus kuat pada kepatuhan prosedural, di mana risiko dikelola melalui aturan birokratis yang ketat untuk memastikan stabilitas dan akuntabilitas organisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Tarakan masih sangat bergantung pada pendekatan hierarkis ini dalam identifikasi dan analisis risiko, seperti penggunaan prosedur formal untuk mendokumentasikan risiko klinis guna mencegah kesalahan medis, yang mencerminkan nilai OPA dalam menjaga kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Transisi menuju NPM, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), terlihat dalam upaya RSUD Tarakan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui pengukuran hasil risiko dan optimasi sumber daya, misalnya dalam prioritas risiko klinis yang mengurangi biaya insiden keselamatan pasien. Sementara itu, elemen NPS, sesuai dengan Denhardt dan Denhardt (2015), muncul dalam partisipasi pemangku kepentingan seperti staf medis dan pasien dalam proses perlakuan risiko, yang menekankan nilai publik seperti keadilan dan keselamatan. Namun, rumah sakit sebagai institusi kesehatan tidak dapat menghilangkan paradigma OPA sepenuhnya karena kepatuhan pada prosedur menjadi kewajiban mutlak dalam memberikan pelayanan kepada pasien untuk memastikan keselamatan pasien. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa risiko klinis, seperti *Hospital acquired infection* (HAIs) atau kesalahan pemberian obat, dapat berakibat fatal jika tidak dikelola melalui protokol birokratis yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 21-23 yang mewajibkan SPM untuk mutu layanan kesehatan. Temuan penelitian menegaskan bahwa meskipun transisi ke NPM dan NPS meningkatkan inovasi dan partisipasi, elemen OPA tetap esensial sebagai fondasi

untuk mencegah risiko yang mengancam nyawa, sehingga ERM di RSUD Tarakan menjadi hibrida yang mengintegrasikan ketiga paradigma ini untuk adaptasi terhadap tantangan VUCA di sektor kesehatan publik Indonesia.

Berdasarkan ASHRM (2020), penerapan ERM di RSUD Tarakan mencakup domain risiko kesehatan yang komprehensif, dengan fokus pada mitigasi risiko klinis melalui Standard keselamatan pasien. UU No. 25 Tahun 2009 mendukung penerapan ini melalui standar pelayanan minimal (SPM) dan survei kepuasan masyarakat, yang terintegrasi dalam proses ERM untuk memastikan akuntabilitas dan mutu layanan publik. Integrasi ini juga selaras dengan Pergub no122 dan Standar akreditasi Kementerian Kesehatan, yang mendorong rumah sakit untuk mengadopsi ISO 31000:2018 sebagai dasar, sehingga ERM tidak hanya menjadi alat kepatuhan tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di era VUCA. Dengan demikian, diharapkan model ERM ini adaptif, memadukan regulasi daerah dan nasional dengan paradigma administrasi publik untuk menghadapi kompleksitas risiko di sektor kesehatan.

c. Tantangan dalam Penerapan ERM di RSUD Tarakan

Hasil penelitian mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kompeten, budaya organisasi yang belum sepenuhnya sadar risiko, keterbatasan anggaran, serta disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan ini menghambat integrasi ERM secara menyeluruh, sehingga penerapan masih bersifat parsial (*silo-based*) dan reaktif terhadap risiko. Dalam konteks ini, penerapan ERM di RSUD Tarakan mencerminkan hibrida paradigma administrasi publik yang menggabungkan elemen *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)*, di mana masing-masing paradigma berkontribusi pada pengelolaan risiko namun juga menimbulkan tantangan yang saling terkait. OPA, sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003) dan Wilson (1887), menekankan struktur hierarkis dan kepatuhan prosedural yang kaku, yang tercermin dalam temuan penelitian bahwa RSUD Tarakan masih bergantung pada aturan birokratis untuk mengelola risiko klinis, seperti Standar akreditasi rumah sakit berdasarkan KMK No. 1128/2022, namun hal ini menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan lambatnya adaptasi terhadap risiko strategis seperti disharmonisasi regulasi.

NPM, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017) serta Osborne dan Gaebler (1992), mendorong efisiensi melalui pengukuran kinerja dan optimasi sumber daya, yang terlihat dalam upaya RSUD Tarakan untuk mengurangi biaya risiko melalui *Value for Money* (VfM), namun temuan menunjukkan bahwa orientasi efisiensi ini sering mengabaikan aspek keadilan sosial, seperti keterbatasan anggaran yang menghambat partisipasi staf non-klinis dalam ERM. NPS, sesuai dengan Denhardt dan Denhardt (2015), menekankan nilai publik, partisipasi, dan akuntabilitas, yang mendukung temuan bahwa RSUD Tarakan melibatkan pemangku kepentingan dalam perlakuan risiko untuk meningkatkan keselamatan pasien, namun tantangan terletak pada partisipasi publik yang terbatas, di mana kurangnya keterlibatan masyarakat dan pasien memperlemah legitimasi ERM dan membuatnya kurang responsif terhadap kebutuhan publik.

Hibrida paradigma ini, mengintegrasikan kekuatan OPA dalam kepatuhan, NPM dalam efisiensi, dan NPS dalam partisipasi, menjadi solusi adaptif untuk RSUD Tarakan, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan seperti budaya organisasi yang belum sadar risiko di mana staf masih melihat risiko sebagai ancaman reaktif daripada peluang strategis memperparah ketidakseimbangan hibrida ini.

ASHRM (2020) menyoroti tantangan serupa, seperti kurangnya budaya keselamatan dan keterbatasan SDM, yang menghambat penerapan ERM di rumah sakit, dan ini selaras dengan temuan bahwa RSUD Tarakan perlu lebih banyak pelatihan untuk membangun kesadaran risiko yang merata. Pendapat dari Denhardt dan Denhardt (2015) menekankan NPS sebagai paradigma yang relevan untuk ERM di sektor kesehatan, di mana partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas risiko, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ini masih terbatas, sehingga ERM di RSUD Tarakan belum sepenuhnya mencapai nilai publik seperti keadilan dalam akses layanan. Osborne (2018) mengembangkan konsep *Public Service-Dominant Logic*, yang menyarankan ERM sebagai alat ko-produksi nilai publik antara penyedia dan pengguna layanan, sejalan dengan penerapan di RSUD Tarakan yang melibatkan pasien dalam evaluasi risiko, meskipun keterbatasan anggaran membatasi skala partisipasi ini.

COSO (2017) menekankan integrasi risiko dengan strategi organisasi, yang didukung oleh Frigo dan Anderson (2011) yang menyatakan ERM sebagai pendorong nilai publik, dan temuan penelitian menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah mulai mengintegrasikan risiko ke dalam strategi, namun *silo-based approach* masih dominan karena keterbatasan SDM.

UU No. 25 Tahun 2009 menekankan perlunya harmonisasi regulasi untuk mengatasi disharmonisasi, guna memastikan ERM mendukung pelayanan publik yang efektif, yang tercermin dalam temuan bahwa konflik antara regulasi pusat dan daerah menghambat integrasi risiko strategis. Diperkuat oleh KemenPAN-RB (2021) yang menekankan survei kepuasan sebagai alat evaluasi risiko, sejalan dengan pendapat terbaru dari OECD (2020) tentang ketahanan pelayanan publik di era VUCA, di mana temuan penelitian menyoroti bahwa RSUD Tarakan perlu lebih banyak survei untuk mengukur risiko VUCA seperti ketidakpastian pandemi.

Penelitian ini sejalan dengan studi terbaru seperti Ferdosi et al. (2020) yang menekankan kerangka ERM berbasis ISO 31000 untuk eksekutif rumah sakit, serta Pascarella et al. (2021) yang mengidentifikasi tantangan subjektivitas dalam penilaian risiko, mirip dengan tantangan di RSUD Tarakan yang sering bergantung pada penilaian subjektif akibat keterbatasan data kuantitatif. Pratama (2024) menunjukkan kontribusi ERM terhadap kinerja rumah sakit, yang konsisten dengan temuan penerapan ERM di RSUD Tarakan yang meningkatkan efisiensi operasional meskipun masih parsial.

Berbeda dengan Hanggraeni dan Maris (2016) yang fokus pada risiko operasional, penelitian ini mengintegrasikan risiko strategis dan non-klinis secara menyeluruh melalui hibrida paradigma OPA-NPM-NPS. Dibandingkan dengan Dihartawan et al. (2024) yang menggunakan SEM-PLS untuk faktor risiko, penelitian ini lebih kontekstual dengan teori administrasi publik, menekankan hibrida sebagai mekanisme untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan SDM dan anggaran. Penelitian ini unik karena mengkaji ERM di RSUD Tarakan dalam konteks VUCA, berbeda dari studi internasional seperti Zaitseva et al. (2022) yang fokus pada metodologi risiko kesehatan di Rusia, sehingga memberikan kontribusi praktis berupa model hibrida yang dapat direplikasi di rumah sakit daerah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko kompleks. Secara keseluruhan, hibrida paradigma ini tidak hanya mengatasi tantangan

melalui integrasi kekuatan masing-masing, tetapi juga memastikan ERM di RSUD Tarakan tetap adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada nilai publik, meskipun tantangan seperti budaya risiko yang belum matang memerlukan intervensi lebih lanjut untuk mencapai implementasi yang holistik.

Tabel 4.47
Pembahasan Gambaran penerapan ERM di RSUD Tarakan

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Pemahaman ERM di RSUD Tarakan	Pemahaman ERM di RSUD Tarakan belum merata dan cenderung terbatas pada risiko klinis atau insiden. Sebagian informan memahami manajemen risiko sebatas kewajiban administratif, belum sebagai kerangka strategis terintegrasi. Istilah kunci ERM seperti <i>risk appetite</i> , <i>inherent risk</i> , dan <i>residual risk</i> belum dipahami oleh sebagian besar pelaksana.	Pemahaman ERM masih bersifat operasional–parsial dan belum terinternalisasi sebagai instrumen tata kelola strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya <i>gap</i> antara kerangka normatif regulasi dan kapasitas kognitif pelaksana, sehingga ERM belum berfungsi sebagai <i>value-creating governance tool</i> . Temuan ini sejalan dengan COSO ERM (2017) dan Kaplan & Mikes (2012) yang menekankan ERM sebagai integrasi risiko dengan pencapaian tujuan strategis organisasi.	Penguatan literasi ERM lintas level organisasi melalui pelatihan berjenjang (strategis–taktis–operasional), dengan penekanan pada perbedaan manajemen risiko tradisional dan ERM strategis serta integrasi risiko klinis dan non-klinis.
Penerapan ERM di RSUD Tarakan	ERM telah diadopsi secara formal melalui Pergub DKI Jakarta No. 122 Tahun 2020 dan standar akreditasi Kemenkes (KMK No. 1128/2022). Peta risiko, profil risiko, dan forum formal telah tersedia, namun penerapannya cenderung reaktif, sektoral, dan <i>compliance-driven</i> . Keterlibatan pimpinan dalam penetapan	Penerapan ERM di RSUD Tarakan bersifat prosedural dan belum terintegrasi dengan perencanaan strategis, penganggaran, serta pengambilan keputusan pimpinan. ERM lebih berfungsi sebagai alat pemenuhan regulasi (OPA–compliance)	Integrasi ERM ke dalam siklus perencanaan strategis RS, penganggaran berbasis risiko, dan manajemen kinerja pimpinan. Diperlukan penegasan peran direksi dan dewan pengawas dalam penetapan <i>risk appetite</i> dan

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
	prioritas risiko masih terbatas.	daripada instrumen manajemen kinerja dan nilai publik (NPM–NPS). Temuan ini menguatkan kerangka COSO ERM (2017), ISO 31000:2018, serta analisis paradigma Hughes (2003), Pollitt & Bouckaert (2017), dan Denhardt & Denhardt (2015).	prioritas risiko strategis.
Tantangan dalam Penerapan ERM di RSUD Tarakan	Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM yang kompeten, budaya risiko yang belum matang, ego sektoral antar unit, lemahnya komunikasi lintas unit, disharmonisasi regulasi pusat–daerah, serta sistem informasi risiko yang belum terintegrasi dan belum menjangkau pelaporan hingga Dewan Pengawas.	Tantangan ERM bersifat struktural, kultural, dan sistemik, yang menunjukkan bahwa RSUD Tarakan masih berada pada fase transisi menuju ERM matur. Dominasi pendekatan silo dan reaktif menghambat fungsi ERM sebagai instrumen tata kelola publik yang adaptif terhadap VUCA. Temuan ini konsisten dengan ASHRM (2020), OECD (2020), serta Frigo & Anderson (2011) yang menekankan pentingnya budaya risiko, integrasi sistem, dan kepemimpinan dalam keberhasilan ERM.	Penguatan kepemimpinan risiko, pengembangan sistem informasi ERM terintegrasi, harmonisasi regulasi internal, serta pembangunan budaya risiko melalui insentif, komunikasi lintas unit, dan pelaporan risiko yang transparan hingga level Dewan Pengawas.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

2. Faktor Pendukung

Temuan penelitian mengenai faktor pendukung penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan menunjukkan bahwa keberhasilan awal ERM

tidak berdiri pada satu dimensi tunggal, melainkan terbentuk melalui kombinasi struktur birokrasi formal, kepemimpinan, budaya organisasi, dan kapasitas aktor publik. Konfigurasi ini menegaskan bahwa ERM dalam konteks rumah sakit publik harus dipahami sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanism*), bukan sekadar instrumen teknokratis pengendalian risiko. Faktor-faktor pendukung spesifik meliputi regulasi, SK struktur manajemen risiko, SPO, program kerja formal, mekanisme pelaporan ke pimpinan dan Dewan Pengawas, komitmen manajemen menengah, penggunaan instrumen teknis (matriks risiko, format laporan, SIPERISAI), integrasi awal risiko dalam perencanaan dan SIMRS, pimpinan sebagai role model, dukungan dan komitmen pimpinan, budaya risiko, komunikasi lintas unit, serta keterlibatan SDM multidisiplin. Faktor-faktor ini saling terkait dan membentuk fondasi kuat untuk implementasi ERM yang efektif, memungkinkan rumah sakit mengelola risiko secara proaktif dan terintegrasi.

Melanjutkan dari fondasi tersebut, faktor pendukung ERM di RSUD Tarakan dapat dikaitkan dengan tiga paradigma utama administrasi publik: *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)*. Dalam konteks OPA, yang menekankan hierarki, kepatuhan aturan, dan netralitas birokrasi (Hughes, 2003), faktor-faktor seperti regulasi, SK struktur manajemen risiko, SPO, program kerja formal, serta mekanisme pelaporan ke pimpinan dan Dewan Pengawas mencerminkan dominasi nilai legalitas, hierarki, dan kepatuhan prosedural. OPA memandang organisasi publik sebagai sistem yang dikendalikan melalui aturan formal dan otoritas struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa ERM di RSUD Tarakan memperoleh legitimasi awal melalui instrumen birokrasi formal, yang berfungsi sebagai *enabling structure* bagi pengelolaan risiko. Namun, secara teoritik, OPA memiliki keterbatasan karena cenderung menghasilkan ERM yang bersifat *compliance-driven* dan administratif. Risiko diposisikan sebagai kewajiban pelaporan, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, meskipun fondasi OPA penting sebagai prasyarat kelembagaan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa OPA tidak cukup untuk menjelaskan dinamika ERM secara utuh dalam organisasi pelayanan publik yang kompleks (Denhardt & Denhardt, 2015).

Beralih ke paradigma berikutnya, faktor pendukung seperti komitmen manajemen menengah, penggunaan instrumen teknis (matriks risiko, format laporan, SIPERISAI), serta integrasi awal risiko dalam perencanaan dan SIMRS

mencerminkan pengaruh *New Public Management* (NPM). Dalam paradigma NPM, ERM dipahami sebagai alat manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengendalian kinerja organisasi publik (Raczkowski, 2016). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan NPM memungkinkan ERM berfungsi sebagai performance tool, sejalan dengan prinsip COSO ERM 2017 yang menekankan integrasi risiko dengan strategi dan kinerja. Namun demikian, pendekatan NPM juga memiliki keterbatasan karena berpotensi mereduksi ERM menjadi alat teknis-manajerial yang berorientasi pada output dan indikator, tanpa cukup memperhatikan dimensi nilai, etika, dan partisipasi aktor publik (Hill, 2016).

Selanjutnya, faktor seperti pimpinan sebagai *role model*, dukungan dan komitmen pimpinan, komunikasi lintas unit, serta keterlibatan SDM multidisiplin menunjukkan bahwa ERM di RSUD Tarakan tidak semata-mata berjalan melalui struktur dan instrumen, tetapi juga melalui nilai, relasi, dan perilaku aktor publik. Dalam kerangka NPS, ERM dipahami sebagai proses kolektif untuk melindungi dan menciptakan nilai publik (*protect and create public value*) termasuk keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, tetapi sebagai *moral and strategic steward* yang menanamkan kesadaran risiko ke seluruh organisasi (Denhardt & Denhardt, 2015). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ERM sangat bergantung pada *governance* berbasis nilai, bukan hanya pada kepatuhan atau efisiensi.

Ketika dikaitkan dengan COSO ERM 2017, khususnya komponen *Governance & Culture*, temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan kerangka konseptual ASHRM yang menekankan bahwa ERM di sektor kesehatan harus dimulai dari *tone at the top*, struktur tata kelola yang jelas, serta budaya sadar risiko yang terinternalisasi dalam perilaku klinis dan manajerial (ASHRM, 2020). Faktor pimpinan sebagai *role model*, komitmen manajemen puncak, dan budaya risiko secara langsung merepresentasikan elemen *governance oversight* dan *risk culture* dalam COSO ERM. Sementara itu, keberadaan regulasi, SPO, dan struktur formal memperkuat *governance structures*, dan komunikasi lintas unit memperkuat *organizational values and behaviors*. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ERM di RSUD Tarakan telah memenuhi elemen dasar *Governance & Culture*, meskipun tingkat kematangannya masih berproses. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendukung faktor pendukung melalui *standard decision by government* (SPM) dan *performance index by citizen*, yang memastikan ERM

terintegrasi dengan standar pelayanan minimal dan evaluasi kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.

Pendapat dari Osborne (2018) dalam *Public Service-Dominant Logic* menekankan bahwa faktor pendukung seperti keterlibatan pemangku kepentingan dan budaya sadar risiko memfasilitasi ko-produksi nilai publik dalam ERM, yang relevan dengan konteks rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan. OECD (2020) menyoroti pentingnya ketahanan organisasi publik di era VUCA, di mana faktor seperti analisa konteks internal/eksternal dan perbaikan berkelanjutan mendukung adaptasi risiko. Frigo dan Anderson (2011) memperbarui COSO ERM dengan menekankan integrasi risiko strategis, yang didukung oleh faktor pendukung seperti rancang program ERM dan roadmap penerapan. Pendapat terbaru dari ASHRM (2020) menambahkan fokus pada risiko digital dan pandemi, yang selaras dengan faktor pembiayaan risiko dan portofolio risiko di RSUD Tarakan.

Penelitian ini menunjukkan persamaan dengan studi terbaru seperti Ferdosi et al. (2020), yang mengidentifikasi faktor pendukung ERM seperti kepemimpinan dan budaya risiko di organisasi kesehatan, serta Pascarella et al. (2021), yang menekankan analisis risiko dan komunikasi sebagai elemen kunci, mirip dengan faktor identifikasi risiko dan pelaporan di RSUD Tarakan. Pratama (2024) menyoroti kontribusi ERM terhadap kinerja rumah sakit melalui faktor seperti pengorganisasian dan evaluasi, yang konsisten dengan temuan ini. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kontekstual Indonesia; misalnya, berbeda dengan Zaitseva et al. (2022) yang menekankan metodologi risiko kesehatan di Rusia, penelitian ini lebih menekankan integrasi dengan UU Pelayanan Publik dan paradigma administrasi publik. Dibandingkan dengan Dihartawan et al. (2024), yang menggunakan SEM-PLS untuk faktor risiko, penelitian ini lebih holistik dengan mengkaji faktor pendukung secara kualitatif dalam konteks rumah sakit publik DKI Jakarta.

Tabel 4.48
Pembahasan Faktor Pendukung

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Komitmen & Role Model Pimpinan	Pimpinan puncak (Direktur/Wadir) menunjukkan dukungan aktif terhadap ERM melalui kehadiran dalam rapat, penerbitan regulasi	Komitmen pimpinan merupakan faktor pendukung utama yang memberi legitimasi kelembagaan dan memperkuat <i>tone at the top</i> . Temuan ini	Memperkuat peran pimpinan sebagai <i>risk owner</i> strategis melalui penetapan <i>risk appetite</i> , keterlibatan aktif dalam evaluasi risiko,

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
	internal, dan arahan langsung kepada unit dan komite. Pimpinan dipersepsikan sebagai role model budaya sadar risiko.	konsisten dengan komponen Governance & Culture dalam COSO ERM (2017) serta pandangan ASHRM (2020) yang menekankan kepemimpinan sebagai prasyarat keberhasilan ERM di sektor kesehatan.	dan penguatan fungsi pengawasan Dewan Pengawas.
Dukungan Regulasi & Struktur Formal	RSUD Tarakan telah memiliki SK struktur manajemen risiko, Program kerja, serta SPO yang menjadi rujukan penerapan ERM. Struktur formal memberikan dasar legal dan administratif pelaksanaan ERM.	Regulasi dan struktur formal berfungsi sebagai <i>enabling structure</i> yang memperkuat legitimasi ERM dalam kerangka Old Public Administration (OPA). Namun, sebagaimana dikemukakan Hughes (2003) dan Denhardt & Denhardt (2015), pendekatan ini cenderung menghasilkan ERM yang <i>compliance-driven</i> jika tidak dilengkapi integrasi strategis.	Melakukan penyelarasan regulasi internal dengan praktik ERM strategis (COSO ERM) agar struktur formal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis.
Komunikasi & Forum Lintas Unit	Terdapat rapat rutin, forum mutu, dan koordinasi lintas unit yang menjadi sarana identifikasi dan diskusi risiko. Namun, tidak semua siklus pelaporan risiko berjalan konsisten hingga level Dewan Pengawas.	Komunikasi lintas unit mendukung kolaborasi multidisiplin dan mengurangi pendekatan silo, sebagaimana ditegaskan oleh OECD (2020) tentang pentingnya koordinasi dalam ketahanan organisasi publik di era VUCA.	Memperkuat mekanisme komunikasi dan pelaporan risiko terintegrasi hingga Dewan Pengawas, termasuk pemanfaatan sistem informasi risiko yang konsisten dan berkelanjutan.
Keterlibatan SDM Multidisiplin	SDM dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang beragam terlibat dalam identifikasi dan pemetaan risiko, memperkaya perspektif risiko klinis dan non-klinis. Namun, kapasitas dan pemahaman ERM belum seragam.	Keterlibatan SDM multidisiplin memperkuat ERM sebagai proses partisipatif dan ko-produksi nilai publik, selaras dengan NPS (Osborne, 2018) dan kerangka ASHRM (2020) yang menekankan peran tim lintas profesi dalam	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan ERM berbasis peran dan domain risiko, serta memperluas partisipasi staf non-klinis dalam proses ERM strategis.

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		manajemen risiko Kesehatan	
Instrumen Teknis & Sistem Pendukung	Tersedia instrumen teknis seperti matriks risiko, format pelaporan, serta aplikasi SIPERISAI dari Inspektorat. Integrasi awal risiko dalam perencanaan dan SIMRS mulai dilakukan.	Instrumen teknis mendukung fungsi ERM sebagai <i>performance tool</i> dalam paradigma New Public Management (NPM), sejalan dengan COSO ERM (2017) dan Frigo & Anderson (2011). Namun, tanpa penguatan nilai dan kepemimpinan, instrumen berisiko menjadi sekadar alat teknokratis.	Mengembangkan sistem ERM terintegrasi dengan SIMRS dan perencanaan strategis, serta memastikan instrumen digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya pelaporan administratif.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

3. Faktor Penghambat

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan *Enterprise Risk Managtaement* (ERM) di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang signifikan, yang mencakup keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai, regulasi yang tidak harmonis, keterbatasan anggaran, budaya risiko yang belum kuat, teknologi informasi yang belum optimal, serta tantangan implementasi praktis seperti konsistensi pelaporan dan koordinasi lintas unit. Dengan hambatan yang cukup substansial yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas ERM secara keseluruhan. Faktor-faktor ini tidak hanya memengaruhi proses identifikasi dan mitigasi risiko, tetapi juga berdampak pada kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan berkualitas.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, yang terlihat dari data wawancara yang menunjukkan bahwa tenaga kesehatan belum sepenuhnya memahami konsep ERM secara mendalam, sehingga implementasi menjadi tidak optimal. Observasi lapangan mengkonfirmasi bahwa pemahaman risiko tidak seragam antar staf, sementara dokumen seperti data sumber daya manusia dan dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia memperkuat temuan ini. Kaitan dengan teori Administrasi Publik menunjukkan bahwa *Paradigma Old Public Administration* (OPA) menekankan kompetensi

birokrasi sebagai dasar efisiensi, sebagaimana dijelaskan oleh Hughes (2003), sementara *New Public Management* (NPM) mendorong pengembangan kompetensi untuk mencapai efisiensi, seperti yang dikemukakan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), dan *New Public Service* (NPS) menekankan kompetensi untuk mendukung partisipasi, sesuai pandangan Denhardt dan Denhardt (2015). Kerangka COSO ERM 2017 juga menuntut kompetensi sumber daya manusia untuk integrasi risiko, sebagaimana diuraikan oleh Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa kompetensi ini mendukung pengelolaan risiko klinis. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut kompetensi untuk *Standard Decision by Government* dan *Performance Index by Citizen*. Pendapat terbaru dari Budiani et al. (2025) menyoroti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia sebagai hambatan utama di rumah sakit Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru oleh Nugraheni (2019), yang menemukan kompetensi sumber daya manusia rendah di unit filing rumah sakit, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada unit spesifik, sedangkan penelitian ini mencakup ERM secara keseluruhan.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai juga menjadi penghambat signifikan, sebagaimana diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan beban kerja tinggi dan kekurangan tenaga, observasi yang mengungkap keterlibatan multidisiplin namun terbatas, serta dokumen seperti struktur organisasi. Dalam konteks teori Administrasi Publik, NPM menekankan efisiensi sumber daya manusia untuk mencapai hasil, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), sementara COSO ERM 2017 mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sesuai dengan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa jumlah sumber daya manusia penting untuk mengelola risiko operasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut sumber daya manusia yang memadai untuk pelayanan publik. Pendapat terbaru dari Kemenkes RI (2021) menyoroti *burnout* sumber daya manusia selama pandemi sebagai hambatan. Temuan ini mirip dengan penelitian oleh Firmansyah (2022), yang menemukan jumlah sumber daya manusia rendah di rumah sakit, meskipun penelitian tersebut lebih spesifik pada keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan penelitian ini mencakup risiko multidimensi.

Lebih lanjut, regulasi yang tidak harmonis muncul sebagai hambatan signifikan, dengan data wawancara menunjukkan disharmoni antara regulasi pusat dan daerah, observasi yang mengkonfirmasi kepatuhan prosedural namun tidak konsisten, serta

dokumen seperti Surat Keputusan Direktur dan regulasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dari perspektif teori Administrasi Publik, OPA menekankan regulasi hierarkis, sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003), sementara NPS mendorong harmonisasi regulasi untuk mendukung partisipasi, sesuai dengan Denhardt dan Denhardt (2015). Kerangka COSO ERM 2017 mendukung kerangka kerja regulasi yang kuat, seperti yang diuraikan oleh Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa regulasi penting untuk mengelola risiko hukum. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut harmonisasi regulasi untuk pelayanan publik. Pendapat terbaru dari Dimitrov (2019) menyoroti disharmoni regulasi sebagai hambatan global. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Prasanti et al. (2019), yang menemukan regulasi tidak harmonis di rumah sakit milik negara, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada rumah sakit umum, sedangkan penelitian ini lebih kontekstual pada DKI Jakarta.

Selanjutnya, keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat utama, sebagaimana diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan alokasi anggaran terbatas untuk ERM, observasi yang menunjukkan koordinasi pimpinan namun terbatas, serta dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra). Dalam teori Administrasi Publik, NPM menekankan efisiensi anggaran, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), sementara COSO ERM 2017 mendukung sumber daya anggaran yang memadai, sesuai dengan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa anggaran penting untuk mengelola risiko keuangan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut anggaran yang memadai untuk pelayanan publik. Pendapat terbaru dari BPKP (2020) menyoroti keterbatasan anggaran sebagai hambatan di rumah sakit daerah. Temuan ini mirip dengan studi oleh Hardino et al. (2025), yang menemukan anggaran rendah untuk ERM, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada perencanaan, sedangkan penelitian ini mencakup implementasi secara lebih luas.

Di samping itu, budaya risiko yang belum kuat juga menghambat penerapan ERM, dengan data wawancara menunjukkan resistensi perubahan, observasi yang mengungkap diskusi risiko namun tidak konsisten, serta dokumen seperti materi sosialisasi. Dari sudut pandang teori Administrasi Publik, NPS menekankan budaya partisipatif, sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2015), sementara COSO ERM 2017 menuntut *governance and culture* yang kuat, sesuai dengan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa budaya risiko penting untuk keselamatan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut budaya

risiko untuk akuntabilitas. Pendapat terbaru dari Putra dan Hendrawan (2024) menyoroti budaya risiko rendah di rumah sakit. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Bucké et al. (2022), yang menemukan budaya risiko sebagai hambatan, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada total *quality management*, sedangkan penelitian ini lebih kontekstual pada rumah sakit publik.

Selain itu, teknologi informasi yang belum optimal juga menjadi penghambat, sebagaimana diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan pemanfaatan teknologi rendah, observasi yang mengungkap koordinasi namun masih manual, serta dokumen seperti laporan Program Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Dalam teori Administrasi Publik, NPM mendorong teknologi untuk efisiensi, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), sementara COSO ERM 2017 mendukung *information, communication, and reporting*, sesuai dengan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa teknologi penting untuk risiko klinis. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut teknologi untuk pelayanan publik. Pendapat terbaru dari Darwiesh et al. (2022) menyoroti teknologi sebagai hambatan di rumah sakit. Temuan ini mirip dengan studi oleh Setiawan et al. (2021), yang menemukan teknologi rendah, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada metode OCTAVE-S, sedangkan penelitian ini mencakup teknologi umum.

Akhirnya, tantangan implementasi praktis seperti konsistensi pelaporan dan koordinasi lintas unit juga menghambat ERM, dengan data wawancara menunjukkan tantangan pelaporan, observasi yang mengungkap rapat rutin namun tidak berkelanjutan, serta dokumen seperti notulen rapat. Dari perspektif teori Administrasi Publik, OPA menekankan koordinasi hierarkis, sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003), sementara COSO ERM 2017 mendukung *review and revision*, sesuai dengan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa koordinasi penting untuk risiko operasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut koordinasi untuk pelayanan publik. Pendapat terbaru dari Monteduro et al. (2021) menyoroti konsistensi sebagai hambatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Saud et al. (2021), yang menemukan konsistensi rendah, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada rekam medis, sedangkan penelitian ini mencakup ERM secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, faktor penghambat ERM di RSUD Tarakan menunjukkan hambatan struktural seperti regulasi dan anggaran, serta hambatan kultural seperti kompetensi sumber daya manusia dan budaya risiko, yang sejalan dengan tantangan rumah sakit publik di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan

yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas ERM, sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan publik yang lebih aman, efisien, dan akuntabel. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, RSUD Tarakan dapat memperkuat ketangguhan organisasi dalam menghadapi risiko multidimensi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

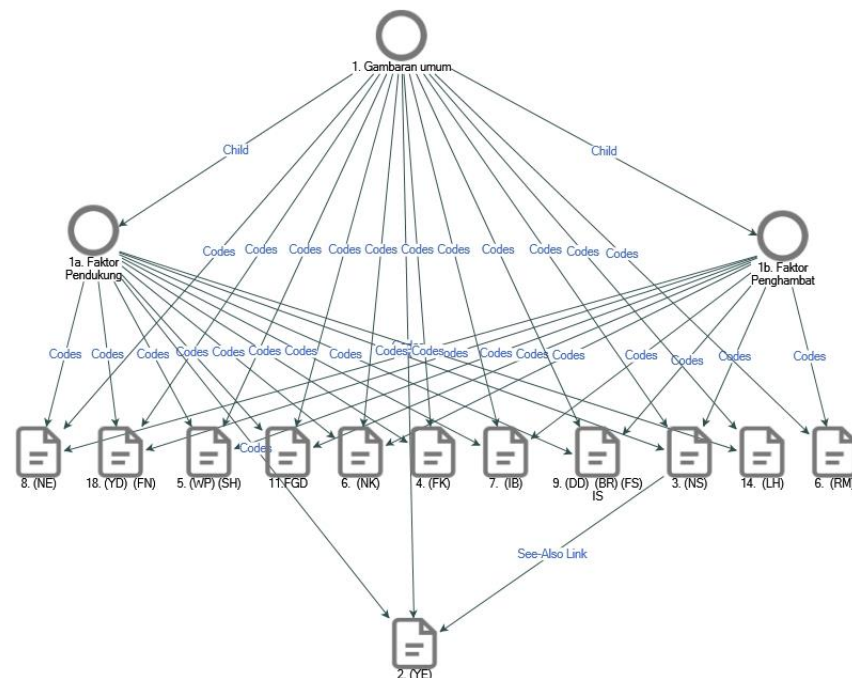
Tabel 4.49
Pembahasan Faktor Penghambat

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Integrasi Risiko Klinis dan Non-Klinis yang Lemah	Risiko klinis dan non-klinis dikelola terpisah; risiko non-klinis (hukum, reputasi, sosial) belum sepenuhnya masuk dalam sistem ERM.	Pemisahan ini menghambat pendekatan holistik ERM dan bertentangan dengan kerangka ASHRM (2020) dan COSO ERM (2017) yang menekankan integrasi portofolio risiko.	Mengintegrasikan seluruh domain risiko dalam satu <i>risk register</i> terpadu dan memastikan keterlibatan lintas profesi dalam penilaian risiko.
Budaya Risiko yang belum terinternalisasi	ERM dipersepsikan sebagai beban administratif dan belum menjadi kebiasaan kerja. Budaya <i>no blaming</i> dan pelaporan insiden belum berjalan optimal; masih ada rasa takut melapor.	Budaya risiko yang lemah menunjukkan bahwa komponen Governance & Culture dalam COSO ERM (2017) belum matang. Hal ini konsisten dengan temuan ASHRM (2020) dan pendekatan NPS yang menekankan nilai, etika, dan partisipasi sebagai fondasi pengelolaan risiko. Pendapat terbaru Putra & Hendrawan (2024) menyoroti budaya rendah. Persamaan dengan Buckè et al. (2022) (budaya risiko hambatan); perbedaan: fokus total quality management vs. rumah sakit publik.	Membangun budaya risiko melalui kampanye internal, penguatan <i>just culture</i> , insentif pelaporan, dan integrasi nilai keselamatan pasien dalam evaluasi kinerja.
Fungsi Pengendalian & Pengawasan yang Lemah	Peran pengawasan, audit, dan pemantauan mitigasi risiko belum berjalan konsisten. Siklus ERM (PDCA) tidak terdokumentasi dan tidak berkelanjutan.	Lemahnya fungsi pengendalian menyebabkan ERM berjalan <i>silo</i> dan reaktif. Temuan ini bertentangan dengan prinsip <i>review and revision</i> dalam COSO ERM (2017) dan praktik evaluasi berkelanjutan yang	Memperkuat fungsi SPI dan komite terkait, menetapkan audit ERM berkala, serta memastikan siklus PDCA terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

		direkomendasikan OECD (2020).	
Keterbatasan Pemahaman dan Kompetensi SDM	Pemahaman ERM belum merata, khususnya di level operasional; istilah dan konsep ERM belum dipahami mendalam. Rotasi SDM dan beban kerja tinggi menyebabkan konsistensi pengelolaan risiko rendah.	Keterbatasan kompetensi SDM menjadi penghambat utama integrasi ERM lintas level organisasi. Temuan ini sejalan dengan tuntutan kompetensi dalam COSO ERM (2017) dan ASHRM (2020), serta paradigma OPA–NPM–NPS yang menekankan kapasitas aktor publik (Hughes, 2003; Pollitt & Bouckaert, 2017; Denhardt & Denhardt, 2015). Kaitan dengan OPA (birokrasi), NPM (efisiensi), NPS (partisipasi), COSO ERM 2017 (integrasi risiko), ASHRM (risiko klinis), UU No. 25/2009 (Standard Decision by Government). Pendapat terbaru Budiani et al. (2025) menyoroti hambatan ini di rumah sakit Indonesia. Persamaan dengan Nugraheni (2019) (kompetensi rendah di unit spesifik); perbedaan: fokus ERM keseluruhan vs. unit spesifik	Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan ERM berjenjang, sertifikasi kompetensi risiko, dan mekanisme <i>knowledge transfer</i> untuk mengatasi dampak rotasi SDM.
Regulasi yang Tidak Harmonis dan beban Kepatuhan	Disharmonisasi regulasi pusat–daerah dan banyaknya tuntutan kepatuhan (akreditasi, WBK, SPIP) membebani implementasi ERM.	Regulasi yang tidak harmonis memperkuat pendekatan <i>compliance-driven</i> ala OPA, sehingga ERM sulit berkembang menjadi instrumen strategis. Temuan ini sejalan dengan Denhardt & Denhardt (2015) dan OECD (2020). Dimitrov (2019) menyoroti hambatan global. Persamaan dengan Prasanti et al. (2019) (disharmoni di rumah sakit); perbedaan:	Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan kebijakan ERM agar lebih fokus pada penciptaan nilai publik, bukan sekadar kepatuhan administratif.

		fokus rumah sakit umum vs. DKI Jakarta.	
Keterbatasan Anggaran	Alokasi anggaran terbatas; koordinasi pimpinan terbatas; dokumen Renstra memperkuat.	Kaitan dengan NPM (efisiensi anggaran), COSO ERM 2017 (sumber daya anggaran), ASHRM (risiko keuangan), UU No. 25/2009 (anggaran memadai). Pendapat terbaru BPKP (2020) menyoroti hambatan di rumah sakit daerah. Persamaan dengan Hardino et al. (2025) (anggaran rendah); perbedaan: fokus perencanaan vs. implementasi.	Alokasikan anggaran khusus ERM melalui penganggaran berbasis risiko, penggalangan dana alternatif, dan efisiensi biaya untuk mendukung program mitigasi risiko
Teknologi Informasi dan Sistm ERM yang Belum Optimal	Pengelolaan risiko masih banyak dilakukan manual; sistem informasi ERM belum terintegrasi dengan SIMRS dan pelaporan belum real-time.	Keterbatasan teknologi menghambat komponen Information, Communication, and Reporting dalam COSO ERM (2017) dan efisiensi ala NPM (Pollitt & Bouckaert, 2017).	Mengembangkan sistem ERM digital terintegrasi dengan SIMRS, termasuk dashboard risiko dan pelaporan real-time

Sumber: Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.4

Project Map Gambaran umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan
Sumber: Hasil Penelitian 2025

Word Query Gambaran umum Penerapan ERM di RSUD Tarakan
Sumber: Hasil Penelitian 2025

Tata Kelola dan Budaya dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan komponen fundamental yang menentukan fondasi pengelolaan risiko secara efektif di organisasi pelayanan publik seperti rumah sakit. Berdasarkan kerangka COSO ERM 2017, komponen ini mencakup *Governance and Culture*, yang menekankan struktur tata kelola yang kuat, komitmen kepemimpinan, dan budaya organisasi yang mendukung kesadaran risiko, sebagaimana dijelaskan oleh Moeller (2011). Dalam konteks administrasi publik, dimensi ini selaras dengan paradigma *New Public Service* (NPS) yang menekankan nilai-nilai demokratis, partisipasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan pandangan Denhardt dan Denhardt (2015). ASHRM (2020) menambahkan bahwa budaya risiko yang kuat diperlukan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam operasional harian rumah sakit, sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut standar kepatuhan dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan kesehatan.

Selanjutnya, dimensi ini juga melibatkan *value for money (VfM)*, yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil pelayanan kesehatan yang optimal, serta pengorganisasian ERM dengan *three lines model*, yang membagi tanggung jawab risiko antara manajemen operasional, pengawas internal, dan auditor eksternal. Penetapan regulasi manajemen risiko di rumah sakit menjadi aspek krusial, yang mengacu pada regulasi manajemen risiko eksternal yang mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kesesuaian antara

regulasi internal dan eksternal untuk menghindari konflik atau disharmoni. Ketersediaan anggaran juga merupakan elemen penting dalam dimensi ini, karena mendukung implementasi program ERM secara berkelanjutan. Akuntabilitas, sebagai prinsip utama, memastikan bahwa setiap keputusan risiko dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, sementara keterlibatan pemangku kepentingan mendorong partisipasi aktif dari pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam proses pengelolaan risiko.

Di samping itu, budaya sadar risiko menjadi inti dari dimensi ini, yang mendorong seluruh anggota organisasi untuk mengenali dan merespons risiko secara proaktif, didukung oleh kompetensi sumber daya manusia terhadap risiko yang memadai. Komitmen sumber daya manusia terhadap nilai dan etika organisasi memperkuat integritas dalam pengelolaan risiko, sedangkan sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko memberikan insentif untuk perilaku yang mendukung ERM. *Standard decision by government* dengan standar pelayanan minimal (SPM) memastikan kepatuhan terhadap kebijakan nasional, dan *performance index by citizen* mengukur kepuasan masyarakat sebagai indikator efektivitas pengelolaan risiko.

Secara keseluruhan, dimensi Tata Kelola dan Budaya ini tidak hanya membentuk kerangka kerja ERM di rumah sakit, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan risiko berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan publik, akuntabilitas, dan keberlanjutan organisasi, yang sejalan dengan temuan penelitian tentang faktor penghambat dan kebaruan dalam penerapan ERM di RSUD Tarakan. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, rumah sakit dapat mencapai *value protection* dan *value creation* yang lebih optimal, sehingga risiko tidak hanya diminimalkan tetapi juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk inovasi dalam pelayanan kesehatan.

a. Kesesuaian Visi, Misi, Nilai, dan Sasaran Rumah Sakit

Indikator ini menilai sejauh mana visi, misi, nilai, dan sasaran rumah sakit terintegrasi dengan *Enterprise Risk Management* (ERM), yang merupakan fondasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil layanan kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

Dalam teori Administrasi Publik, paradigma *Old Public Administration* (OPA) menekankan hierarki dalam penyusunan sasaran, di mana struktur birokrasi yang terpusat memainkan peran utama dalam menentukan arah organisasi (Hughes, 2003). Sementara itu, *New Public Management* (NPM)

mendorong penyusunan sasaran yang berbasis hasil, dengan penekanan pada efisiensi dan pengukuran kinerja yang terukur (Pollitt & Bouckaert, 2017), sedangkan *New Public Service* (NPS) menekankan nilai publik sebagai inti dari setiap sasaran, memastikan bahwa keputusan organisasi selalu mengutamakan kepentingan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Kerangka kerja COSO ERM 2017 menuntut adanya *governance and culture* yang kuat untuk mendukung integrasi risiko ke dalam visi, misi, nilai, dan sasaran rumah sakit, sehingga risiko tidak dianggap sebagai ancaman terpisah, melainkan bagian integral dari perencanaan strategis (Moeller, 2011).

ASHRM (2020) menambahkan bahwa sasaran rumah sakit harus mencakup risiko klinis dan non-klinis secara menyeluruh, seperti risiko keselamatan pasien dan operasional, untuk memastikan keberlanjutan layanan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut sasaran rumah sakit yang mendukung *Standard Decision by Government*, di mana keputusan standar pelayanan harus selaras dengan pengelolaan risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.

Pendapat terbaru dari Ferdosi et al. (2020) menyoroti bahwa integrasi sasaran dengan ERM dapat meningkatkan efektivitas organisasi kesehatan dalam menghadapi tantangan kompleks, termasuk risiko strategis dan operasional. Persamaan dengan penelitian lain terlihat dalam penelitian oleh Jule (2020), yang menemukan bahwa sasaran terintegrasi dengan risiko dapat memperkuat budaya keselamatan di rumah sakit, mirip dengan temuan di RSUD Tarakan yang menunjukkan kesesuaian antara sasaran dan pengelolaan risiko. Namun, perbedaan muncul karena penelitian Jule (2020) lebih fokus pada aspek keselamatan kerja secara spesifik, sedangkan penelitian ini mencakup nilai publik yang lebih luas, seperti akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

b. Kepemimpinan dan Pengawasan berupa Komitmen terhadap *Core Value* dan ERM

Dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), tujuan utama adalah mencapai *value protection* dan *value creation*, yang secara teoritis dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi nilai organisasi dari risiko yang dapat merusak aset, reputasi, dan operasional, sekaligus menciptakan nilai baru melalui pengelolaan risiko yang proaktif untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi (Moeller, 2011). *Value protection* berfokus pada mitigasi risiko yang dapat

mengurangi kerugian finansial, operasional, atau reputasional, melalui identifikasi dini bahaya dan pengendalian internal yang kuat, sementara *value creation* menekankan pemanfaatan risiko sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif, misalnya dengan mengintegrasikan risiko ke dalam strategi bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik (Frigo & Anderson, 2011). Dalam konteks rumah sakit publik seperti RSUD Tarakan, tujuan ini sejalan dengan prinsip administrasi publik yang menuntut pelayanan kesehatan yang aman, efisien, dan berkelanjutan, di mana ERM tidak hanya melindungi pasien dan organisasi dari insiden keselamatan, tetapi juga menciptakan nilai melalui peningkatan mutu layanan dan kepercayaan masyarakat.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ERM di RSUD Tarakan belum sepenuhnya mencapai tujuan *value protection* dan *value creation* secara optimal, karena faktor penghambat seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, regulasi yang tidak harmonis, dan budaya risiko yang lemah sering kali menghambat mitigasi risiko secara efektif, sehingga risiko seperti potensi kesalahan medis atau keterlambatan layanan tetap muncul dan mengurangi nilai organisasi. Di sisi lain, hasil penelitian mengungkap potensi *value creation* melalui penguatan koordinasi lintas unit dan teknologi informasi, yang dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan risiko klinis dan operasional, meskipun hambatan anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai membatasi realisasi penuhnya.

Perbandingan dengan COSO ERM 2017 yang menekankan integrasi risiko untuk mencapai kedua tujuan tersebut, praktik di RSUD Tarakan masih lebih berorientasi pada *value protection* reaktif daripada *value creation* proaktif, yang memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas ERM secara keseluruhan.

Lebih lanjut, salah satu indikator kunci adalah komitmen pimpinan terhadap nilai inti dan ERM, yang mengukur sejauh mana kepemimpinan organisasi mendukung pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari tata kelola. Dalam Administrasi Publik, Paradigma *Old Public Administration* (OPA) menekankan pengawasan hierarkis sebagai dasar komitmen, sebagaimana dijelaskan oleh Hughes (2003), sementara *New Public Management* (NPM) mendorong komitmen untuk efisiensi hasil, sesuai dengan Pollitt dan Bouckaert (2017), dan

New Public Service (NPS) menekankan komitmen etis untuk kepentingan publik, seperti yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2015). Kerangka COSO ERM 2017 menuntut *tone at the top* yang kuat untuk mendukung integrasi risiko, sebagaimana diuraikan oleh Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan bahwa komitmen ini penting untuk mengelola risiko kesehatan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut komitmen untuk akuntabilitas dalam pelayanan. Pendapat terbaru dari Ferdosi et al. (2020) menyoroti komitmen pimpinan sebagai kunci keberhasilan ERM di tingkat eksekutif organisasi kesehatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru oleh Afifa dan Adisasmito (2021), yang menemukan komitmen rendah selama pandemi COVID-19, mirip dengan kondisi di RSUD Tarakan, meskipun penelitian tersebut lebih spesifik pada risiko COVID-19, sedangkan penelitian ini mencakup komitmen umum terhadap ERM. Data menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan namun pengawasan masih perlu diperkuat di level operasional, yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan *value protection* melalui penguatan *tone at the top*. Hal ini berkontribusi pada *value creation* dengan membangun budaya risiko yang lebih tangguh, sehingga RSUD Tarakan dapat lebih efektif dalam mengelola risiko multidimensi untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

c. ***Value for Money***

Dalam konteks *value for money*, penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya rumah sakit, merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Jika efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan (outcome), efisiensi fokus pada penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output maksimal, maka ekonomis menyoroti penggunaan sumber daya dengan hemat dan tepat guna, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan nilai yang diperoleh tanpa pemborosan. Hal ini sejalan dengan kerangka 3E (*Economy, Efficiency, Effectiveness*) yang diperkenalkan oleh *National Audit Office* (NAO) Inggris pada tahun 2001, yang menjadi landasan sistematis untuk menilai *value for money* di sektor publik. Dalam teori ini, *economy* didefinisikan sebagai pengadaan dan penggunaan sumber daya dengan biaya terendah yang memungkinkan, tanpa

mengorbankan kualitas, sementara *efficiency* melibatkan rasio output terhadap input, dan *effectiveness* mengukur sejauh mana tujuan tercapai.

Untuk mengukur ketiga aspek ini secara sistematis, NAO (2001) merekomendasikan pendekatan berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diintegrasikan dengan *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS). Adapun cara pengukuran *Economy*, *Efficiency*, *Effectiveness* sebagai berikut :

- 1) **Ekonomis (*Economy*):** Diukur melalui analisis biaya per unit input, seperti perbandingan harga pembelian sumber daya (misalnya obat-obatan atau peralatan medis) dengan standar pasar, atau rasio biaya operasional terhadap anggaran yang dialokasikan. Dalam NPM (Hood, 1991), *economy* dievaluasi melalui benchmarking terhadap praktik terbaik untuk meminimalkan biaya tanpa mengurangi nilai tambah. NPS (Denhardt & Denhardt, 2015) menambahkan dimensi sosial, seperti memastikan *economy* tidak mengorbankan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Indikator praktis meliputi *cost-saving ratio* (penghematan biaya dibagi total biaya) atau audit pengadaan yang membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. COSO ERM 2017 (Moeller, 2011) mengintegrasikan risiko ke dalam pengukuran ini, seperti mengukur risiko pemborosan sumber daya akibat fluktuasi harga bahan medis. ASHRM (2020) menekankan pengelolaan risiko non-klinis, seperti risiko keuangan dari pembelian yang tidak efisien, untuk mendukung *economy*. OECD (2015) merekomendasikan *cost-benefit analysis* untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan memberikan nilai ekonomi yang optimal, misalnya melalui indikator seperti *return on investment* (ROI) untuk investasi kesehatan.
- 2) **Efisien (*Efficiency*):** Diukur melalui rasio output terhadap input, seperti jumlah pasien yang dilayani per unit biaya atau waktu. NPM menekankan efisiensi sebagai prioritas untuk mencapai hasil terukur dan kompetitif (Pollitt & Bouckaert, 2017), dengan indikator seperti *productivity ratio* (output per jam kerja staf). NPS memperluas ini dengan mempertimbangkan dampak sosial, seperti efisiensi dalam distribusi layanan yang adil. COSO ERM 2017 mengukur efisiensi melalui integrasi risiko operasional, seperti mengurangi waktu tunggu pasien untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. ASHRM (2020) menambahkan risiko klinis, seperti efisiensi dalam

pencegahan infeksi yang mengurangi biaya perawatan. OECD (2015) menggunakan *cost-effectiveness ratio* untuk membandingkan biaya intervensi dengan outcome kesehatan, sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut efisiensi sebagai standar, diukur melalui indikator seperti utilisasi sumber daya (misalnya tingkat hunian tempat tidur rumah sakit/ (Bed Occupation Rate / BOR).

- 3) **Efektif (*Effectiveness*)**: Diukur melalui tingkat pencapaian tujuan, seperti persentase pasien yang sembuh atau tingkat kepuasan pasien. NPM fokus pada outcome terukur (Pollitt & Bouckaert, 2017), dengan indikator seperti *outcome rate* (hasil kesehatan per intervensi). NPS menekankan dampak sosial yang luas, seperti peningkatan aksesibilitas dan keadilan (Denhardt & Denhardt, 2015). COSO ERM 2017 mengukur efektivitas melalui pengelolaan risiko strategis, seperti mengantisipasi risiko yang mengganggu outcome. ASHRM (2020) menambahkan risiko klinis, seperti pengurangan kesalahan medis yang meningkatkan efektivitas. OECD (2015) merekomendasikan indikator seperti *health outcome indicators* (misalnya tingkat mortalitas atau morbiditas) seperti PROMs (*Patient-Reported Outcome Measures*) dan PREMs (*Patient-Reported Experience Measures*) adalah alat ukur dalam dunia kesehatan untuk menilai kualitas layanan dari perspektif pasien, di mana PROMs fokus pada hasil kesehatan (bagaimana fungsi pasien setelah pengobatan) dan PREMs fokus pada pengalaman pasien selama perawatan. sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menuntut outcome kesehatan yang optimal.

Pendekatan sistematis ini memungkinkan integrasi risiko (seperti dalam COSO ERM) untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan *value for money*, yang relevan untuk rumah sakit seperti RSUD Tarakan yang menghadapi keterbatasan anggaran.

Dalam teori Administrasi Publik, paradigma *New Public Management* (NPM) menekankan efisiensi sebagai prioritas utama, di mana organisasi publik diharapkan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang terukur dan kompetitif (Pollitt & Bouckaert, 2017). Sementara itu, *New Public Service* (NPS) mendorong penciptaan nilai publik yang lebih luas, bukan sekadar efisiensi semata, dengan fokus pada keadilan, partisipasi, dan dampak sosial yang berkelanjutan (Denhardt & Denhardt, 2015). Kerangka kerja COSO ERM 2017

mendukung komponen *performance* sebagai bagian dari integrasi risiko, di mana *value for money* dapat dicapai melalui pengelolaan risiko yang meminimalkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan hasil layanan (Moeller, 2011). ASHRM (2020) menambahkan bahwa *value for money* di sektor kesehatan harus mencakup pengelolaan risiko klinis dan non-klinis, seperti mengurangi biaya akibat kesalahan medis atau inefisiensi operasional, untuk memastikan keberlanjutan layanan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut efisiensi pelayanan sebagai standar, di mana rumah sakit harus menunjukkan penggunaan sumber daya yang hemat namun tetap menghasilkan *outcome* kesehatan yang optimal. Pendapat terbaru dari OECD (2015) menyoroti *value for money* sebagai ukuran kinerja utama di sektor publik, dengan penekanan pada keseimbangan antara biaya, kualitas, dan keberlanjutan, yang relevan untuk mengatasi tantangan anggaran kesehatan yang terbatas.

Dalam pembahasan lebih lanjut, teori NPM yang dikembangkan oleh Hood (1991) menjelaskan bahwa efisiensi bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah melalui inovasi manajerial, yang dapat diterapkan dalam rumah sakit untuk mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan. Sementara itu, NPS menekankan bahwa *value for money* harus diukur tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial, seperti aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan (Denhardt & Denhardt, 2015).

COSO ERM 2017 memperluas konsep ini dengan mengintegrasikan risiko ke dalam pengukuran kinerja, sehingga rumah sakit dapat mengantisipasi risiko keuangan yang dapat mengganggu *value for money* (Moeller, 2011), seperti keterlambatan pembayaran klaim BPJS. ASHRM (2020) menambahkan dimensi risiko kesehatan spesifik, seperti pengelolaan risiko infeksi nosokomial yang dapat meningkatkan biaya perawatan, sehingga *value for money* tercapai melalui pencegahan proaktif. OECD (2015) memberikan panduan praktis bahwa *value for money* di sektor kesehatan dapat diukur melalui indikator seperti *cost-effectiveness ratio*, yang membandingkan biaya intervensi kesehatan dengan *outcome* kesehatan yang dihasilkan.

Penelitian yang sama dengan temuan ini, seperti penelitian oleh Jackson (2012), menemukan bahwa *value for money* sering kali rendah di organisasi publik karena inefisiensi dalam alokasi sumber daya, yang mirip dengan kondisi di RSUD Tarakan di mana efisiensi tercapai namun efektivitas masih rendah.

Namun, perbedaan muncul karena penelitian Jackson (2012) lebih bersifat umum dan tidak spesifik pada sektor kesehatan, sedangkan penelitian ini fokus pada rumah sakit publik dengan tantangan unik seperti risiko klinis dan regulasi kesehatan.

Penelitian lainnya yang berbeda, seperti WHO (2007), menekankan *value for money* di sektor kesehatan melalui pendekatan *cost-benefit analysis* untuk intervensi kesehatan, yang berbeda dari temuan RSUD Tarakan yang lebih menyoroti aspek efektivitas outcome pasien. Sementara itu, NAO (2001) memperkenalkan konsep 3Es (*economy, efficiency, effectiveness*) sebagai kerangka untuk menilai *value for money*, yang sejalan dengan temuan penelitian ini tetapi lebih luas cakupannya, tidak terbatas pada rumah sakit.

Penelitian oleh Dihartawan et al. (2024) tentang faktor yang mempengaruhi manajemen risiko di rumah sakit Indonesia menemukan bahwa SOP berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *value for money*, yang berbeda dari temuan RSUD Tarakan yang menunjukkan efisiensi baik tetapi efektivitas rendah, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengukuran outcome. Pratama (2024) dalam studinya tentang pengaruh manajemen risiko pada kinerja RSUD menemukan kontribusi positif manajemen risiko terhadap efisiensi, yang mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, tetapi berbeda dalam aspek efektivitas yang masih perlu ditingkatkan melalui integrasi risiko strategis.

Berdasarkan temuan penelitian di RSUD Tarakan, *value for money* menunjukkan pencapaian yang bervariasi di antara ketiga aspek 3E. Secara spesifik, aspek ekonomis (*economy*) tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh penghematan biaya dalam pengadaan sumber daya dan alokasi anggaran yang hemat, yang sejalan dengan rekomendasi NPM untuk optimasi sumber daya melalui inovasi manajerial. Misalnya, rumah sakit berhasil menekan biaya operasional melalui *benchmarking* harga obat-obatan dan peralatan medis, dengan *cost-saving ratio* yang positif, serta mengintegrasikan risiko keuangan seperti keterlambatan pembayaran klaim BPJS melalui COSO ERM, sehingga meminimalkan pemborosan. Hal ini konsisten dengan panduan OECD (2015) tentang *cost-benefit analysis*, di mana biaya yang dikeluarkan memberikan nilai ekonomi yang optimal tanpa mengorbankan kualitas dasar.

Disisi lain, efisiensi juga tercapai, seperti yang ditunjukkan oleh rasio output terhadap input yang tinggi, misalnya utilisasi tempat tidur rumah sakit

yang optimal dan pengurangan waktu tunggu pasien melalui manajemen risiko operasional (ASHRM, 2020). Ini mendukung temuan Pratama (2024) yang menemukan kontribusi positif manajemen risiko terhadap efisiensi, meskipun berbeda dalam aspek efektivitas yang masih rendah.

Sementara itu, efektivitas tetap rendah, dengan outcome kesehatan pasien seperti tingkat kesembuhan atau kepuasan yang belum optimal, yang mungkin disebabkan oleh fokus berlebihan pada input daripada outcome holistik, sebagaimana disoroti oleh Dihartawan et al. (2024). Temuan ini berbeda dari penelitian Jackson (2012) yang lebih umum, tetapi mirip dengan tantangan rumah sakit Indonesia lainnya, seperti keterbatasan anggaran yang memprioritaskan economy dan efficiency atas effectiveness.

Sehingga temuan penelitian di RSUD Tarakan, di mana *value for money* tercapai pada aspek efisiensi (seperti penghematan biaya operasional) namun rendah pada efektivitas (seperti outcome kesehatan pasien), penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan tantangan umum di rumah sakit Indonesia, seperti keterbatasan anggaran dan fokus pada input daripada outcome (Dihartawan et al., 2024). Namun, berbeda dengan studi internasional seperti WHO (2007) yang menekankan *cost-effectiveness*, temuan RSUD Tarakan lebih menyoroti perlunya integrasi ERM untuk meningkatkan efektivitas, yang sejalan dengan rekomendasi OECD (2015) tentang pengukuran kinerja yang holistik. Data menunjukkan *value for money* tercapai pada efisiensi namun rendah pada efektivitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *value for money* masih berorientasi pada kepatuhan fiskal dan output layanan. Namun, apabila ditinjau melalui perspektif *public value*, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai pelayanan publik yang komprehensif. Efisiensi anggaran tidak selalu identik dengan penciptaan nilai apabila belum diikuti oleh pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan (Moore, 2013).

Dalam sektor kesehatan, *equity* menjadi dimensi kritis karena keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola biaya, tetapi juga dari sejauh mana layanan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa integrasi dimensi equity, *value for money* berisiko tereduksi menjadi instrumen akuntabilitas finansial semata, bukan sebagai mekanisme penciptaan nilai publik (Braveman, 2006; WHO, 2010).

Oleh karena itu, integrasi Enterprise Risk Management menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis rumah sakit tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap mutu layanan dan keadilan distribusi pelayanan kesehatan. Pendekatan ini selaras dengan paradigma *New Public Service* yang menempatkan kepentingan publik dan nilai sosial sebagai orientasi utama penyelenggaraan layanan pemerintah (Denhardt & Denhardt, 2015).

1) Integrasi Temuan Empiris dengan *Balanced Scorecard* dan *Cost-Effectiveness*

Temuan empiris penelitian menunjukkan bahwa kinerja RSUD Tarakan secara umum telah memperlihatkan capaian operasional yang positif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka *cost-effectiveness*. Dokumen laporan tahunan memperlihatkan peningkatan signifikan pada kunjungan layanan, sementara capaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja utama berada pada kategori tinggi. Meskipun demikian, rasio antara pendapatan dan beban layanan belum dianalisis secara eksplisit sebagai indikator efisiensi, sehingga hubungan antara biaya dan hasil belum menjadi bagian dari evaluasi strategis organisasi.

Selain itu, realisasi pendapatan BLUD bahkan melampaui target, dan berbagai indikator layanan menunjukkan kinerja $\geq 80\text{--}90\%$. Namun demikian, indikator *value for money* belum dinyatakan secara eksplisit sebagai sasaran kinerja organisasi, sehingga pengukuran kinerja masih cenderung berorientasi pada kepatuhan fiskal dan output pelayanan.

Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa pencapaian *value for money* di RSUD Tarakan menunjukkan variasi antar dimensi 3E. Aspek efisiensi telah tercapai melalui penghematan biaya operasional dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, tetapi efektivitas masih relatif rendah karena outcome kesehatan pasien—seperti tingkat kesembuhan dan kepuasan—belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan organisasi untuk berfokus pada pengendalian input dan output, sementara pengukuran outcome belum ditempatkan sebagai pusat evaluasi kinerja.

Akibatnya, relasi antara biaya dan hasil belum terstruktur dalam kerangka *cost-effectiveness* yang komprehensif.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa organisasi publik sering kali berhasil mencapai efisiensi tanpa diikuti oleh peningkatan efektivitas, sehingga nilai publik yang dihasilkan belum maksimal (Cole & Parston, 2006). Oleh karena itu, integrasi Balanced Scorecard menjadi krusial untuk memastikan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari pencapaian operasional, tetapi juga dari kemampuan organisasi mengonversi sumber daya menjadi outcome bernilai tinggi (Madsen, 2025).

2) Rekonstruksi KPI: Menghubungkan Outcome dan Biaya

Untuk memperkuat integrasi outcome dan *cost-effectiveness*, indikator kinerja utama perlu direkonstruksi menjadi indikator berpasangan (*paired KPI*), yaitu indikator yang secara simultan mengukur hasil strategis dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengevaluasi apakah peningkatan outcome terjadi secara efisien atau justru menghasilkan pemborosan.

Sebagai ilustrasi, peningkatan profitabilitas dan *cost recovery rate* dapat dikaitkan dengan rasio pendapatan bersih per unit biaya layanan; kepuasan pasien dapat dianalisis bersama biaya per kunjungan; efisiensi proses dapat diukur melalui biaya per penurunan *length of stay* atau peningkatan *bed occupancy rate*; sedangkan investasi sumber daya manusia dapat dievaluasi melalui hubungan antara biaya pelatihan dan peningkatan outcome pasien. Pendekatan ini menempatkan outcome kesehatan dan pengalaman pasien sebagai pusat evaluasi *value for money*, sekaligus memperkuat disiplin investasi organisasi (Sundari, 2024).

Secara konseptual, langkah ini mencerminkan pergeseran dari orientasi pengeluaran menuju orientasi nilai, di mana organisasi dinilai bukan berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi berdasarkan nilai sosial yang dihasilkan dari setiap unit sumber daya (Cole & Parston, 2006).

3) Peran ERM dalam menyelaraskan Outcome dan *Cost-Effectiveness*

Keseimbangan antara *service value* dan *financial sustainability* tidak dapat dicapai hanya melalui sistem pengukuran kinerja, tetapi memerlukan

mekanisme integratif yang mampu mengelola risiko strategis organisasi. Dalam konteks ini, ERM berperan sebagai instrumen penyelarasan antara visi dan misi organisasi, strategi, kinerja, serta penciptaan nilai publik.

ERM memungkinkan organisasi menurunkan biaya melalui pengendalian risiko (*cost containment*) sekaligus meningkatkan pendapatan melalui mitigasi risiko finansial (*income enhancement*), tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dengan menggunakan prinsip 3E (*economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*) organisasi dapat memastikan bahwa setiap keputusan strategis menghasilkan *outcome* optimal sekaligus menjaga keberlanjutan layanan. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka manajemen kinerja modern yang menempatkan risiko sebagai bagian integral dari penciptaan nilai (Moeller, 2011).

Dengan demikian, ERM tidak semata-mata merupakan alat penghematan, melainkan mesin strategis yang mengintegrasikan visi, kinerja, dan nilai publik. Dalam arsitektur organisasi, ERM berfungsi sebagai *risk integrator* yang menghubungkan visi–misi rumah sakit dengan strategi, empat perspektif *Balanced Scorecard*, serta *outcome* pelayanan.

4) Implikasi Strategis bagi Kinerja Rumah Sakit Publik

Outcome dalam *Balanced Scorecard* tidak hanya merepresentasikan hasil operasional, tetapi juga dampak strategis jangka panjang yang mencerminkan penciptaan nilai organisasi (Madsen, 2025). Oleh karena itu, *cost-effectiveness* harus menjadi bagian integral dalam interpretasi kinerja, baik finansial maupun non-finansial, melalui evaluasi sistematis terhadap hubungan antara biaya dan hasil.

Sinergi antara perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta *learning and growth* memungkinkan organisasi memetakan *outcome* dan *cost-effectiveness* secara komprehensif. Dalam konteks RSUD Tarakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah relatif kuat pada aspek *economy* dan *efficiency*, namun masih menghadapi tantangan pada dimensi *effectiveness* berbasis *outcome* pasien. Hal ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari orientasi pada capaian layanan dan serapan

anggaran menuju pengukuran biaya per *outcome* kesehatan dan kepuasan pasien.

Pemahaman ini mengarah bahwa organisasi publik berperforma tinggi bukanlah organisasi yang paling hemat ataupun paling ekspansif dalam pelayanan, melainkan organisasi yang mampu mengoptimalkan *social return* dari setiap unit sumber daya yang digunakan (Cole & Parston, 2006). Outcome menciptakan legitimasi publik, *cost-effectiveness* memastikan keberlanjutan fiskal, produktivitas menjaga ketahanan kinerja jangka panjang, dan institusi menentukan apakah nilai tersebut dapat dihasilkan secara efisien.

Dalam konteks rumah sakit publik, integrasi *Balanced Scorecard* dengan ERM memungkinkan organisasi membangun sistem kinerja yang tidak hanya efisien secara finansial tetapi juga mampu menghasilkan nilai publik yang berkelanjutan. ERM menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan strategi melalui pengelolaan risiko yang sistematis, sehingga keseimbangan antara kualitas layanan dan efisiensi biaya dapat terjaga.

Dengan demikian, keterkaitan antara *outcome* dan *cost-effectiveness* bukan sekadar isu teknis dalam pengukuran kinerja, melainkan merepresentasikan pergeseran paradigma administrasi publik dari orientasi pengeluaran menuju orientasi nilai. Organisasi publik yang mampu mengelola keseimbangan ini secara strategis akan berada pada posisi yang lebih kuat untuk menghasilkan *public value* sekaligus mencapai status sebagai *high-performance public organization*. Pada akhirnya, kinerja organisasi publik ditentukan bukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan institusional dan manajerial dalam mengonversi sumber daya tersebut menjadi outcome bernilai tinggi secara produktif dan berkelanjutan.

d. Pengorganisasian ERM dengan *Three Lines Model*

Indikator pengorganisasian ERM dengan *Three Lines Model* menilai pengorganisasian manajemen risiko di RSUD Tarakan berdasarkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), yang membagi tanggung jawab risiko menjadi tiga lini utama: lini pertama untuk manajer

operasional yang mengelola risiko sehari-hari, Lini kedua untuk fungsi pengawasan seperti komite risiko, dan lini ketiga untuk audit independen.

Dalam konteks Regulasi yang menjadi acuan dalam pengorganisasian ERM di rumah sakit adalah Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 menetapkan struktur manajemen risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Regulasi ini membentuk Tim Manajemen Risiko, dengan fokus pada risiko operasional, keuangan, hukum, dan strategis yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintah. Integrasi dengan sistem pengendalian internal membantu meminimalkan risiko kegagalan dalam pelayanan publik, dan struktur ini sangat relevan untuk diterapkan pada rumah sakit milik pemerintah di DKI Jakarta, seperti RSUD, untuk mengelola risiko umum seperti bencana, keamanan data, atau ketidakpatuhan regulasi.

Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 mengatur pembentukan dan fungsi Komite Mutu Rumah Sakit bertanggung jawab atas peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan keselamatan pasien, dengan tugas utama melakukan pengembangan standar, dan penanganan insiden yang wajib diimplementasikan di semua rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional. Di dalam Komite Mutu, terdapat sub komite manajemen risiko yang secara khusus berperan mengelola risiko di lingkungan rumah sakit.

Harmonisasi antara kedua regulasi ini, dengan mempertimbangkan peran sub komite manajemen risiko, dapat dilakukan melalui integrasi struktur organisasi untuk menghindari duplikasi peran dan memastikan koordinasi yang sinergis, terutama di rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Tim Manajemen Risiko di tingkat provinsi dapat berkoordinasi dengan Komite Mutu, di mana sub komite manajemen risiko berfungsi sebagai unit operasional yang menghubungkan risiko umum seperti kebijakan anggaran atau bencana dengan risiko spesifik kesehatan seperti keselamatan pasien. Misalnya, sub komite dapat melaporkan temuan risiko klinis ke Tim Manajemen Risiko untuk mitigasi holistik, memastikan alur informasi yang lancar. Pembagian peran juga jelas: Keputusan Gubernur menangani risiko strategis dan operasional di seluruh pemerintah, sementara Peraturan Menteri Kesehatan fokus pada mutu klinis melalui Komite Mutu, dengan sub komite sebagai ekstensi yang fokus pada risiko klinis harian tanpa tumpang tindih. Integrasi proses dapat menggunakan kerangka

kerja bersama seperti ISO 31000, di mana sub komite menerapkan standar mutu sebagai bagian dari mitigasi risiko yang lebih luas.

Untuk mengimplementasikan harmonisasi ini, langkah-langkah praktis dapat dimulai dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan anggota Tim Manajemen Risiko, Komite Mutu, dan sub komite manajemen risiko untuk pengembangan kebijakan, dan pelaporan risiko terintegrasi. Pelatihan bersama juga penting untuk memastikan pemahaman tentang kedua regulasi, sehingga staf rumah sakit dapat mengidentifikasi risiko secara komprehensif, dengan sub komite mendapat pelatihan khusus dalam teknik mitigasi risiko klinis yang selaras dengan standar pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui indikator bersama, seperti tingkat kepatuhan akreditasi rumah sakit, pengurangan insiden keselamatan pasien. Sub komite dapat bertanggung jawab atas pelaporan berkala ke Komite Mutu dan Tim Manajemen Risiko.

Manfaat dari harmonisasi ini sangat signifikan, karena meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi redundansi tugas, karena sub komite dapat menangani risiko spesifik tanpa duplikasi dengan Tim Manajemen Risiko. Selain itu, harmonisasi memperkuat tata kelola risiko di sektor kesehatan, yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap standar nasional serta daerah. Pendekatan ini juga memfasilitasi respons proaktif terhadap risiko, di mana sub komite dapat mengantisipasi ancaman kesehatan yang terkait dengan isu pemerintah daerah, seperti perubahan kebijakan lingkungan atau transportasi yang mempengaruhi akses kesehatan.

Dalam konteks administrasi publik, model ini selaras dengan prinsip *Old Public Administration* (OPA) yang menekankan struktur hierarkis dan pembagian tanggung jawab (Hughes, 2003), serta COSO ERM 2017 yang mendukung *governance* melalui komponen *Governance and Culture* (Moeller, 2011). ASHRM (2020) menambahkan bahwa untuk risiko kesehatan, *Three Lines Model* memastikan integrasi antara lini operasional klinis dan non-klinis, lini pengawasan mutu, serta lini audit, sehingga mendukung akuntabilitas dan keselamatan pasien.

Selain itu, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut struktur organisasi yang jelas untuk memastikan tanggung jawab risiko dalam pelayanan publik. Pendapat terbaru dari Khassouani et al. (2021) menyoroti

efektivitas *Three Lines Model* di rumah sakit publik Maroko, di mana model ini membantu mengatasi tumpang tindih tanggung jawab dan meningkatkan respons terhadap risiko kesehatan.

Sejalan dengan temuan ini, studi oleh Hutagalung (2022) menemukan bahwa pengorganisasian ERM di rumah sakit Indonesia, khususnya terkait Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), menunjukkan tingkat implementasi yang rendah karena kurangnya integrasi antara lini operasional, pengawasan, dan audit, yang mirip dengan kondisi awal di RSUD Tarakan sebelum intervensi. Berbeda dengan penelitian Hutagalung (2022) yang spesifik fokus pada risiko SIMRS seperti keamanan data dan gangguan sistem, penelitian ini mencakup ERM yang melibatkan risiko klinis, non-klinis, strategis, operasional, dan reputasi secara menyeluruh, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas.

Berdasarkan temuan penelitian, yang mengindikasikan bahwa lini pertama (manajer unit) telah aktif dalam mengidentifikasi risiko operasional, lini kedua (komite mutu dan sub komite manajemen risiko) memberikan pengawasan, dan lini ketiga (audit internal) menjalankan fungsi *assurance*, meskipun masih ada kesenjangan dalam integrasi vertikal. Hal ini sejalan dengan teori OPA yang menekankan hierarki (Hughes, 2003) dan COSO ERM 2017 (Moeller, 2011), namun memerlukan penguatan sesuai ASHRM (2020) dan Khassouani et al. (2021) untuk risiko kesehatan spesifik. Dibandingkan dengan Hutagalung (2022), temuan ini lebih positif karena mencakup ERM holistik, bukan hanya SIMRS, menunjukkan potensi RSUD Tarakan untuk menjadi model implementasi *Three Lines Model* di rumah sakit publik Indonesia. Triangulasi data mengonfirmasi bahwa struktur ini mendukung akuntabilitas sesuai UU No. 25 Tahun 2009, meskipun perlu perbaikan untuk mengatasi *silo approach* yang masih terlihat. Dengan demikian, pengorganisasian ERM berdasarkan *Three Lines Model* tidak hanya memperkuat governance tetapi juga meningkatkan ketangguhan rumah sakit dalam menghadapi multirisiko di era VUCA.

Harmonisasi pengorganisasian dengan *three line model* memungkinkan pengintegrasian manajemen risiko umum dengan fokus pada risiko klinis dan mutu pelayanan secara spesifik, sehingga rumah sakit di DKI Jakarta dapat beroperasi lebih efektif dan responsif. Implementasi harmonisasi ini memerlukan

komitmen dari pimpinan rumah sakit dan pemerintah daerah untuk menciptakan struktur yang terkoordinasi.

e. Penetapan Regulasi Manajemen Risiko

Dalam konteks standar akreditasi rumah sakit, khususnya Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 14), rumah sakit diwajibkan untuk menetapkan Program manajemen risiko yang terintegrasi sebagai bagian dari tata kelola internal, guna mencegah cedera dan kerugian melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko. Namun, dalam temuan penelitian, rumah sakit membuat Program Manajemen Risiko tanpa membuat regulasi berupa kebijakan manajemen risiko internal, hanya mengacu langsung pada regulasi eksternal seperti Peraturan Gubernur (Pergub no 122 Tahun 2020) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat menimbulkan masalah integrasi, di mana risiko internal rumah sakit seperti risiko klinis, operasional, keuangan, reputasi, dan kepatuhan, tidak sepenuhnya terintegrasi dengan risiko eksternal yang diatur oleh Pergub tersebut. Akibatnya, rumah sakit mungkin kurang fleksibel dalam menyesuaikan regulasi dengan konteks spesifiknya, seperti jenis pelayanan, dan sumber daya yang tersedia, sehingga efektivitas pencegahan insiden keselamatan pasien berkurang.

Untuk mengatasi hal ini, RSUD Tarakan perlu menetapkan regulasi internal yang harmonis dengan regulasi eksternal, dengan melibatkan pimpinan rumah sakit dalam proses penyusunan program manajemen risiko tahunan. Dengan demikian, regulasi internal menjadi landasan untuk memastikan bahwa rumah sakit tidak hanya mematuhi aturan eksternal tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan internal, seperti peningkatan insiden keselamatan pasien atau perubahan regulasi kesehatan nasional.

Kaitan dengan teori administrasi publik memberikan perspektif yang lebih untuk memahami pengaturan regulasi ini. *Old Public Administration* (OPA) menekankan birokrasi ketat, hierarki, dan kepatuhan terhadap regulasi formal, seperti yang dijelaskan oleh Hughes (2003), di mana rumah sakit sebagai entitas pemerintah daerah harus mengikuti Pergub secara kaku untuk memastikan akuntabilitas. Namun, pendekatan ini dapat menghambat fleksibilitas, karena risiko internal rumah sakit yang spesifik tidak selalu sesuai dengan regulasi

daerah yang lebih umum. Di sisi lain, *New Public Management* (NPM) mendorong efisiensi dan inovasi melalui manajemen risiko sebagai alat performa, sebagaimana dikemukakan oleh Hood (1991), sehingga rumah sakit perlu membuat regulasi internal dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal dan mengintegrasikan risiko ke dalam proses operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan mutu, bukan hanya mengacu pada Pergub. Sementara itu, *New Public Service* (NPS) menekankan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel kepada masyarakat, seperti dalam Denhardt dan Denhardt (2000), di mana regulasi manajemen risiko internal harus memprioritaskan keselamatan pasien sebagai hak publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, rumah sakit yang hanya mengacu pada Pergub tanpa kebijakan internal mungkin melanggar prinsip NPS, karena risiko seperti insiden keselamatan pasien dapat merusak kepercayaan publik.

Framework seperti COSO ERM 2017, yang menekankan *governance* terintegrasi dan respons risiko strategis sebagaimana dijelaskan oleh Moeller (2011), mendukung rumah sakit untuk menetapkan regulasi internal yang mencakup komponen seperti identifikasi risiko dan pengendalian, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada regulasi eksternal. ASHRM (2020) menambahkan dimensi regulasi untuk risiko hukum dan klinis di rumah sakit, yang dapat melengkapi Pergub dengan kebijakan internal spesifik. Dari sisi regulasi, Permenkes No. 11 Tahun 2017 dan standar akreditasi mewajibkan rumah sakit untuk memiliki program manajemen risiko internal yang harmonis. Jika rumah sakit hanya mengacu pada Pergub 122 tanpa regulasi internal, ini dapat melanggar standar akreditasi dan regulasi Kemenkes, karena tidak ada integrasi risiko internal.

Pendapat dari Dimitrov (2019) menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara internal dan eksternal untuk mencegah konflik dan meningkatkan efektivitas, yang sangat relevan dengan konteks rumah sakit di Indonesia. Dalam evolusi administrasi publik, rumah sakit perlu fleksibilitas internal sambil mematuhi regulasi eksternal, sehingga risiko seperti insiden keselamatan pasien dapat dikelola secara proaktif. Ini selaras dengan tren global menuju integrasi risiko, di mana rumah sakit tidak hanya reaktif terhadap pergub tetapi juga inovatif dalam mengembangkan kebijakan internal.

Dibandingkan dengan penelitian Prasanti et al. (2019) tentang implementasi manajemen risiko di rumah sakit milik pemerintah, terdapat persamaan dalam temuan bahwa regulasi rendah atau tidak terintegrasi, di mana rumah sakit cenderung bergantung pada regulasi eksternal tanpa kebijakan internal yang kuat, mirip dengan masalah di RSUD Tarakan. Kedua studi juga menunjukkan bahwa regulasi ada namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan risiko eksternal, terutama dalam konteks rumah sakit pemerintah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus: penelitian Prasanti et al. lebih umum pada rumah sakit milik pemerintah secara nasional, sedangkan penelitian ini kontekstual pada DKI Jakarta dengan penekanan spesifik pada Pergub 122 sebagai regulasi daerah. Selain itu, penelitian ini lebih mendalam mengkaji kaitan dengan teori administrasi publik dan framework seperti COSO ERM 2017, sementara Prasanti et al. lebih fokus pada implementasi risiko tanpa analisis teoritis mendalam, menunjukkan variasi regional di Indonesia yang memengaruhi efektivitas regulasi. Dengan demikian, rumah sakit di DKI Jakarta perlu lebih proaktif dalam menetapkan regulasi internal untuk mengatasi kesenjangan ini.

f. Regulasi Manajemen Risiko Eksternal

Dalam konteks penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di RSUD Tarakan, yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, regulasi eksternal memainkan peran krusial sebagai fondasi hukum dan operasional. Regulasi ini tidak hanya memberikan pedoman teknis, tetapi juga memastikan bahwa manajemen risiko diintegrasikan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi keuangan, dan kepatuhan terhadap standar nasional.

RSUD Tarakan, sebagai fasilitas kesehatan publik di ibu kota, harus menavigasi berbagai risiko seperti risiko operasional, keuangan, reputasi, dan kesehatan masyarakat, yang sering kali dipicu oleh faktor eksternal seperti pandemi, kepadatan penduduk, atau perubahan kebijakan daerah. Regulasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri terkait BLUD, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta menjadi acuan utama, dan memberikan landasan etis dan hukum yang berfungsi sebagai pilar utama yang membentuk kerangka kerja ERM di RSUD Tarakan dan

memastikan bahwa risiko tidak hanya diidentifikasi tetapi juga dikelola secara proaktif untuk mendukung misi pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Kementerian Kesehatan, melalui Peraturan Menteri Kesehatan seperti Permenkes No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menetapkan standar nasional untuk manajemen risiko di fasilitas kesehatan. Ini mencakup pengelolaan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit menular, keselamatan pasien, dan mutu layanan, yang harus diintegrasikan ke dalam rencana strategis RSUD Tarakan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, memberikan fleksibilitas keuangan kepada RSUD Tarakan sebagai BLUD, namun dengan kewajiban menerapkan manajemen risiko untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Regulasi ini memaksa RSUD Tarakan untuk mengintegrasikan ERM dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mengelola risiko seperti defisit keuangan atau ketidakpatuhan regulasi, sehingga memastikan transparansi dan efisiensi di tengah tantangan keuangan daerah Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, berperan dalam mengawasi dan memfasilitasi ERM melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, termasuk pengawasan risiko kesehatan daerah dan integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. RSUD Tarakan harus melaporkan risiko seperti penyebaran penyakit menular atau risiko lingkungan perkotaan ke Dinas Kesehatan, yang kemudian menjadi dasar untuk intervensi berbasis data di wilayah Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, seperti Pergub No. 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memberikan pedoman lokal yang spesifik untuk ERM di BLUD termasuk membentuk tim ERM, menetapkan kategori risiko seperti risiko fiskal, kebijakan, dan kepatuhan, serta melaporkan hasil evaluasi risiko ke Gubernur DKI Jakarta. Regulasi ini memastikan bahwa ERM disesuaikan dengan konteks daerah Jakarta, seperti risiko kepadatan penduduk, polusi udara, atau bencana alam, sehingga RSUD Tarakan dapat merespons tantangan lokal dengan lebih efektif.

Disisi lain, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 593 Tahun 2022

tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, tugas Dewan Pengawas telah diatur secara rinci dalam regulasi daerah. Namun, terdapat aspek penting yang belum tercakup secara eksplisit, yaitu manajemen risiko, yang justru menjadi persyaratan utama dalam Standar Akreditasi rumah sakit. Hal ini menciptakan disharmonisasi antara tugas Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pergub dengan ekspektasi dari Standar Akreditasi, sehingga perlu penyelarasan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan kepatuhan operasional rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Pergub Nomor 252 Tahun 2015 secara spesifik mengatur tugas Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD, termasuk pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas diwajibkan menyampaikan laporan pengawasan minimal per semester kepada Gubernur, dengan format yang mencakup penilaian terhadap berbagai aspek seperti kinerja pelayanan, keuangan, ketaatan regulasi, dan permasalahan pengelolaan beserta solusinya. Selain itu, Dewan Pengawas dapat menyampaikan laporan tambahan sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan, seperti penurunan kinerja atau pergantian pejabat. Meskipun pengawasan ini cukup komprehensif, regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan manajemen risiko sebagai bagian dari tugas Dewan Pengawas, meskipun evaluasi kinerja dan ketaatan regulasi bisa terkait secara tidak langsung dengan aspek risiko.

Di sisi lain, standar akreditasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan rumah sakit, menempatkan manajemen risiko sebagai komponen kunci untuk memastikan keselamatan pasien dan kelancaran operasional. Manajemen risiko mencakup risiko klinis dan risiko non klinis yang harus dilaporkan secara berkala. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas diharapkan terlibat aktif, termasuk memberikan umpan balik atas laporan manajemen risiko dan memastikan tindak lanjut yang efektif, dengan frekuensi pelaporan setiap semester atau lebih sering untuk menjaga transparansi dan pengendalian risiko.

Oleh karena itu, meskipun tidak diatur dalam Pergub, Standar Akreditasi mempersyaratkan Dewan Pengawas untuk terlibat dalam manajemen risiko melalui mekanisme pelaporan dan umpan balik berkala sebagai fungsi pengawasan manajemen risiko (*risk oversight*). Secara spesifik, Dewan Pengawas

harus menerima laporan manajemen risiko dari Direktur Rumah Sakit, setiap semester, yang mencakup Profil risiko prioritas, peristiwa risiko yang terjadi, dan langkah-langkah mitigasinya. Selanjutnya, Dewan Pengawas wajib memberikan umpan balik konstruktif, termasuk saran untuk perbaikan, rekomendasi kebijakan, dan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Umpan balik ini dapat diintegrasikan ke dalam laporan pengawasan semesteran sesuai Pergub, namun perlu diperluas untuk mencakup aspek risiko yang saat ini belum tercakup dalam format laporan tersebut.

Disharmonisasi ini muncul karena Pergub Nomor 252 Tahun 2015 lebih fokus pada pengawasan umum tanpa menekankan manajemen risiko sebagai tugas eksplisit, sementara standar akreditasi menjadikannya prioritas untuk memastikan rumah sakit dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Akibatnya, rumah sakit BLUD berpotensi kesulitan memenuhi standar akreditasi tanpa penyesuaian, yang dapat berdampak pada mutu pelayanan dan reputasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi Pergub agar memasukkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tugas Dewan Pengawas, dengan format laporan yang diperluas. Dewan Pengawas juga perlu dilatih untuk memahami standar akreditasi, dan laporan risiko setiap semester. Harmonisasi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga meminimalkan risiko, memastikan rumah sakit BLUD tetap terakreditasi, dan pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Regulasi eksternal ini mendorong evolusi dari model administrasi tradisional ke modern dimana ERM menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Dalam perspektif *Old Public Administration* (OPA), yang menekankan hierarki, birokrasi, dan kepatuhan aturan seperti yang dikemukakan Woodrow Wilson pada 1887, regulasi eksternal seperti UU Pelayanan Publik dan Permendagri BLUD memaksa RSUD Tarakan untuk mematuhi aturan ketat, meminimalkan risiko melalui kontrol birokratis. Namun, OPA sering kali dianggap kaku, sehingga regulasi ini mendorong transisi ke *New Public Management* (NPM), yang diperkenalkan oleh Osborne dan Gaebler pada 1992, dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas hasil.

Di RSUD Tarakan, ERM diterapkan untuk mengoptimalkan sumber daya, seperti mengurangi risiko keuangan melalui penganggaran fleksibel BLUD,

sehingga pelayanan kesehatan lebih efisien dan berorientasi pada hasil di tengah kompleksitas Jakarta.

Lebih lanjut, *New Public Service* (NPS) oleh Denhardt dan Denhardt (2000) menekankan pelayanan publik sebagai misi bersama, di mana regulasi eksternal mendorong RSUD Tarakan untuk melihat risiko sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. NPS memandang birokrasi sebagai mitra masyarakat, sehingga ERM di RSUD Tarakan tidak hanya mengelola risiko internal tetapi juga melibatkan masyarakat Jakarta dalam mitigasi, seperti edukasi risiko kesehatan di komunitas padat penduduk. Regulasi ini menciptakan sinergi antara OPA (kepatuhan), NPM (efisiensi), dan NPS (partisipasi), memungkinkan RSUD Tarakan bertransformasi dari birokrasi statis menjadi organisasi responsif yang mengintegrasikan risiko dalam setiap aspek operasional.

Kerangka COSO ERM 2017, menekankan integrasi risiko ke dalam strategi organisasi melalui komponen seperti tata kelola, budaya risiko, dan pemantauan. Regulasi eksternal seperti Permenkes dan Pergub DKI Jakarta memberikan landasan untuk menerapkan COSO di RSUD Tarakan, di mana Dewan Pengawas memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dianalisa, dan dimitigasi secara sistematis. ASHRM, yang fokus pada risiko kesehatan, melengkapi COSO dengan pedoman spesifik untuk fasilitas kesehatan, seperti manajemen risiko keselamatan pasien.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan etis, mengharuskan RSUD Tarakan sebagai penyedia layanan publik untuk menerapkan ERM guna memastikan pelayanan yang bermutu, adil, dan akuntabel. Regulasi ini mengintegrasikan ERM dengan prinsip pelayanan publik, di mana risiko seperti ketidakpuasan pasien atau kesalahan medis harus dikelola untuk menjaga kepercayaan masyarakat Jakarta. Dengan demikian, regulasi eksternal menciptakan harmoni antara COSO, ASHRM, dan UU Pelayanan Publik, memungkinkan RSUD Tarakan menerapkan ERM yang holistik dan berbasis bukti.

Pendapat Bevir dan Rhodes (2003) yang menekankan ERM sebagai alat transformasi birokrasi, tentang *governance* yang melihat risiko sebagai bagian dari jaringan aktor. Di RSUD Tarakan, regulasi eksternal mendukung pendekatan ini dengan melibatkan multi-stakeholder seperti Kemenkes, Kemendagri, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam pengelolaan risiko. Pendapat terbaru dari

OECD (2020) tentang risiko publik menyoroti pentingnya ERM di sektor kesehatan untuk ketahanan, yang sejalan dengan regulasi PP No. 28 Tahun 2024 yang mendorong integrasi risiko dalam kesehatan nasional. Teori risiko modern, seperti yang dikembangkan oleh Power (2007) tentang "*risk society*", melihat risiko sebagai konstruksi sosial, sehingga regulasi di RSUD Tarakan tidak hanya teknis tetapi juga sosial, melibatkan edukasi masyarakat Jakarta untuk mitigasi risiko bersama.

Penelitian oleh Aven (2016) tentang risiko sebagai ketidakpastian, menunjukkan persamaan dengan penerapan ERM di RSUD Tarakan, di mana regulasi eksternal mendorong pendekatan probabilistik untuk mengukur risiko kesehatan di lingkungan perkotaan seperti di Jakarta. Penelitian oleh McKinsey (2022) tentang ERM di rumah sakit menemukan bahwa regulasi seperti BLUD meningkatkan efisiensi risiko, mirip dengan RSUD Tarakan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks local bahwa penelitian internasional sering fokus pada risiko finansial, sedangkan di Indonesia, regulasi menekankan risiko kesehatan publik seperti wabah di Jakarta, yang lebih spesifik. Penelitian oleh WHO (2023) tentang manajemen risiko kesehatan global menunjukkan kesamaan dalam integrasi lintas-sektor, tetapi berbeda karena regulasi Indonesia lebih birokratis dibandingkan pendekatan fleksibel di negara maju. Secara keseluruhan, regulasi eksternal di RSUD Tarakan sejalan dengan tren global ERM sebagai alat pencegahan, namun perlu adaptasi lokal untuk efektivitas maksimal di DKI Jakarta.

g. Kesesuaian Regulasi Internal dan Eksternal

Indikator harmonisasi regulasi menilai sejauh mana regulasi internal rumah sakit selaras dengan regulasi eksternal pemerintah, yang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan risiko kesehatan. Dalam konteks Administrasi Publik, paradigma *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2015) menekankan harmonisasi regulasi sebagai fondasi untuk mencapai nilai publik, di mana regulasi internal rumah sakit harus diselaraskan dengan regulasi eksternal untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan kesehatan. Selain itu, kerangka Enterprise Risk Management (ERM) COSO 2017, sebagaimana dijelaskan oleh Moeller (2011), mendukung harmonisasi ini melalui komponen *Governance and Culture*, yang memastikan

regulasi internal rumah sakit selaras dengan standar eksternal untuk mengelola risiko kesehatan secara terintegrasi.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) menambahkan bahwa kesesuaian regulasi sangat penting untuk mengelola risiko kesehatan, termasuk harmonisasi antara regulasi teknis Kementerian Kesehatan dan regulasi daerah, guna mencegah disharmoni yang dapat meningkatkan risiko operasional di rumah sakit. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut kesesuaian regulasi sebagai bagian dari standar pelayanan publik, di mana rumah sakit harus menyelaraskan regulasi internal dengan regulasi eksternal untuk memastikan kualitas dan keselamatan layanan kesehatan. Namun, pendapat terbaru dari OECD (2020) menyoroti disharmonisasi regulasi sebagai tantangan utama dalam administrasi publik, terutama di sektor kesehatan, yang dapat menghambat implementasi ERM dan meningkatkan risiko ketidakefisienan di rumah sakit.

Penelitian sebelumnya oleh Lindelow (2006) menemukan kesesuaian regulasi yang rendah di negara berkembang, mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, di mana regulasi internal belum sepenuhnya selaras dengan regulasi eksternal, menyebabkan hambatan dalam pengelolaan risiko. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian Lindelow (2006), yang bersifat umum untuk negara berkembang secara keseluruhan, dengan penelitian ini yang spesifik pada konteks Indonesia, khususnya RSUD Tarakan di DKI Jakarta, dengan fokus pada harmonisasi regulasi kesehatan nasional dan daerah. Data menunjukkan bahwa kesesuaian regulasi secara umum baik, namun masih ada disharmoni pada regulasi teknis, seperti antara KMK No. 1128/2022 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memerlukan perbaikan untuk mendukung ERM yang efektif.

h. Ketersediaan Anggaran

Dalam konteks pengelolaan risiko di rumah sakit, *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan pendekatan strategis yang penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi operasional, keamanan pasien, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Namun, berdasarkan data, RSUD Tarakan, belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk implementasi ERM secara menyeluruh.

RSUD Tarakan, sebagai rumah sakit daerah kelas A di DKI Jakarta, telah beroperasi dengan anggaran terbatas yang sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti gaji tenaga medis, pembelian obat-obatan, dan pemeliharaan fasilitas. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya ERM terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengekspos kerentanan sistem Kesehatan, belum ada langkah konkret untuk menambahkan pos anggaran khusus. Ini tercermin dari laporan keuangan tahun 2022-2023, di mana tidak ada item terpisah untuk pelatihan ERM, audit risiko, atau pengadaan perangkat lunak manajemen risiko. Akibatnya, inisiatif ERM saat ini bergantung pada sumber daya internal yang terbatas, seperti tim yang menangani risiko tanpa dukungan finansial yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini, RSUD Tarakan perlu mempertimbangkan penambahan anggaran khusus ERM dalam rencana anggaran tahun depan. Estimasi awal menunjukkan bahwa alokasi sekitar 5-10% dari anggaran operasional tahunan dapat digunakan untuk:

- 1) Pelatihan staf tentang ERM.
- 2) Pengadaan alat bantu seperti software risiko (misalnya, dari vendor lokal atau internasional).
- 3) Audit risiko berkala oleh konsultan eksternal.

Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan rumah sakit tetapi juga mendukung tujuan pembangunan kesehatan nasional. Dengan demikian, pembahasan ini menekankan urgensi bagi pemerintah daerah dan manajemen RSUD Tarakan untuk segera mengintegrasikan ERM ke dalam prioritas anggaran, guna memastikan layanan kesehatan yang lebih aman dan efisien di masa depan.

Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) di rumah sakit, yang merupakan elemen krusial untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan risiko kesehatan. Dalam konteks Administrasi Publik, paradigma *New Public Management* (NPM) yang dikemukakan oleh Pollitt & Bouckaert (2017) menekankan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama, di mana sumber daya keuangan harus dialokasikan secara optimal untuk mencapai hasil yang terukur dan efisien dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan kerangka ERM COSO 2017, sebagaimana dijelaskan oleh Moeller (2011), yang mendukung penyediaan

sumber daya yang memadai untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam operasional organisasi, termasuk alokasi anggaran khusus untuk mitigasi risiko.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) menambahkan bahwa anggaran yang memadai sangat penting untuk mengelola risiko keuangan di sektor kesehatan, seperti risiko pembengkakan biaya operasional atau keterlambatan pembayaran klaim BPJS, yang dapat mengganggu stabilitas rumah sakit. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menuntut ketersediaan anggaran yang memadai sebagai bagian dari standar pelayanan, di mana rumah sakit harus mengalokasikan dana untuk memastikan kualitas dan keselamatan layanan kesehatan. Namun, pendapat terbaru dari BPKP (2020) menyoroti keterbatasan anggaran sebagai tantangan utama dalam implementasi ERM di rumah sakit pemerintah, yang sering kali menghambat pengembangan sistem risiko yang komprehensif.

i. Akuntabilitas

Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989) terdapat lima dimensi akuntabilitas yang saling terkait dalam konteks administrasi publik, khususnya organisasi pelayanan publik. Kelima dimensi ini mencakup aspek moral, politik, manajerial, profesional, dan hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara multidimensi kepada pemangku kepentingan. Teori ini relevan dalam konteks *Enterprise Risk Management* (ERM) karena akuntabilitas menjadi fondasi untuk mengintegrasikan risiko dengan tata kelola, strategi, dan kinerja organisasi. *Moral accountability*, sebagai bentuk akuntabilitas yang berlandaskan nilai-nilai etika universal seperti integritas dan kejujuran, tercermin dalam perilaku tenaga medis yang memprioritaskan keselamatan pasien tanpa diskriminasi. Selanjutnya, *political accountability* berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada aktor politik dan masyarakat melalui mekanisme seperti pemilihan umum atau forum publik, di mana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada gubernur atau DPRD terkait pencapaian target kesehatan daerah. *Managerial accountability*, di sisi lain, fokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil terukur, seperti melalui KPI atau audit internal, yang dalam rumah sakit mencakup pertanggungjawaban kepala instalasi atas indikator seperti *Bed*

Occupancy Rate. Professional accountability terkait dengan standar profesi dan kode etik organisasi seperti IDI atau MKEK, di mana dokter spesialis bertanggung jawab atas pelanggaran etik praktik medis. Terakhir, legal accountability berbasis pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi hukum jika dilanggar, seperti tuntutan malpraktik atau pelanggaran pengadaan. Teori Jabbra ini menekankan bahwa akuntabilitas bukanlah konsep statis, melainkan dinamis dan saling melengkapi, sehingga mendukung tata kelola risiko yang holistik dalam organisasi publik

Dalam hubungannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, teori Jabbra menemukan evolusi melalui studi empiris yang mengintegrasikan akuntabilitas ke dalam ERM dan governance di sektor kesehatan. Misalnya, penelitian Ferdosi et al. (2020) mengembangkan kerangka ERM untuk eksekutif organisasi kesehatan berdasarkan ISO 31000, yang menekankan akuntabilitas profesional dan manajerial dalam mitigasi risiko, mirip dengan dimensi Jabbra, namun lebih menyoroti komunikasi risiko sebagai elemen baru. Pascarella et al. (2021), dalam analisis metodologi penilaian risiko menggunakan matriks risiko, berkaitan dengan akuntabilitas manajerial dan profesional, sambil menyoroti subjektivitas yang dapat mengurangi akuntabilitas moral dan politik jika tidak dikontrol. Darwiesh et al. (2022) menggunakan AI untuk manajemen risiko, memperluas akuntabilitas legal dan profesional melalui pemantauan *real-time*, meskipun kurang menekankan dimensi moral dan politik. Buckè et al. (2022) menyoroti integrasi manajemen mutu dan risiko, yang berkaitan dengan akuntabilitas manajerial dan profesional, dengan temuan bahwa sertifikasi ISO 9001 meningkatkan akuntabilitas, mirip dengan Jabbra, namun lebih menekankan pencegahan risiko daripada pertanggungjawaban etis. Terakhir, Dihartawan et al. (2024) menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis faktor risiko di rumah sakit Indonesia, menemukan bahwa SOP berkontribusi signifikan terhadap manajemen risiko, selaras dengan akuntabilitas manajerial Jabbra, namun menambahkan aspek teknis seperti identifikasi bahaya.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dengan teori Jabbra dalam mengakui akuntabilitas multidimensi sebagai dasar mitigasi risiko, terutama melalui integrasi dengan *governance* dan fokus pada pencegahan risiko etis. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan teknis dan teknologi, seperti AI atau analisis statistik, yang tidak secara eksplisit dibahas

Jabbra, serta evolusi menuju pendekatan empiris yang lebih spesifik pada risiko kesehatan, sementara Jabbra lebih normatif dan klasik. Dengan demikian, penelitian modern memperluas Jabbra dengan alat praktis, namun tetap mempertahankan inti multidimensi sebagai fondasi governance risiko.

Berdasarkan temuan penelitian di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, teori Jabbra dapat diintegrasikan praktik ERM dan akuntabilitas, di mana RS Tarakan telah menerapkan ERM dengan komponen ISO 31000 dan beberapa komponen COSO ERM 2017, namun masih ada kesenjangan dalam akuntabilitas multidimensi. *Moral accountability*, misalnya, tercermin dalam komitmen terhadap *core values* dan budaya sadar risiko, namun masih lemah dalam etika organisasi, sehingga Jabbra menyarankan penguatan melalui pelatihan etika untuk mencegah risiko reputasi dan keselamatan pasien. *Political accountability* terlihat dalam keterlibatan pemangku kepentingan dan kesesuaian visi-misi dengan sasaran rumah sakit, yang mencerminkan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, meskipun Jabbra menekankan mekanisme politik seperti forum DPRD yang belum optimal, sehingga risiko strategis seperti perubahan kebijakan belum sepenuhnya diantisipasi. *Managerial accountability* menonjol dalam pengorganisasian ERM dengan Three Lines Model dan evaluasi kinerja, yang menunjukkan fokus pada efisiensi sumber daya, namun Jabbra mengonfirmasi ini sebagai inti, dengan temuan keterbatasan anggaran yang menghambat pencapaian KPI, sehingga perlu perbaikan dalam alokasi sumber daya. *Professional accountability* teridentifikasi melalui kompetensi SDM terhadap risiko dan standar keputusan berdasarkan SPM, yang selaras dengan Jabbra, meskipun risiko klinis seperti malpraktik menunjukkan perlunya penguatan kode etik profesi untuk mencegah litigasi. Terakhir, *legal accountability* tercermin dalam regulasi internal dan eksternal serta audit internal, yang mencerminkan kepatuhan hukum, namun Jabbra menekankan ini sebagai bentuk formal, dengan temuan disharmonisasi regulasi seperti KMK versus Pergub yang berpotensi risiko hukum jika tidak diselaraskan. Secara keseluruhan, teori Jabbra membantu menjelaskan bahwa akuntabilitas multidimensi di RS Tarakan masih parsial, dengan kekuatan di managerial dan legal, namun lemah di moral dan political, sehingga integrasi Jabbra dengan ERM COSO dapat meningkatkan ketangguhan RS Tarakan dalam menghadapi risiko VUCA,

melalui penguatan budaya etis dan partisipasi politik untuk mendukung pelayanan publik yang akuntabel.

j. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Indikator keterlibatan pemangku kepentingan menilai sejauh mana partisipasi *stakeholder* dalam proses manajemen risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Keterlibatan ini diukur melalui mekanisme seperti forum diskusi, survei kepuasan, rapat koordinasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan risiko.

Dalam konteks teori administrasi publik, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen inti paradigma *New Public Service* (NPS) oleh Denhardt & Denhardt (2015), yang menekankan partisipasi warga negara sebagai ko-produser layanan untuk mencapai tujuan publik yang demokratis dan kolaboratif. Kerangka COSO ERM 2017 (Moeller, 2011) mendukung ini melalui komponen "*Governance and Culture*", yang menuntut budaya kolaboratif dan partisipasi stakeholder untuk mengidentifikasi risiko secara holistik. ASHRM (2020) menambahkan bahwa di sektor kesehatan, keterlibatan pemangku kepentingan penting untuk mengelola risiko multidimensi, seperti risiko klinis dan reputasi, melalui dialog terbuka.

Penelitian oleh Nabatchi (2010) dalam studi deliberasi publik menemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sering rendah di organisasi publik, mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, di mana partisipasi masyarakat terbatas pada survei kepuasan saja tanpa dialog mendalam. Persamaan terletak pada hambatan seperti kurangnya kapasitas partisipasi dan resistensi birokrasi, yang menyebabkan risiko tidak teridentifikasi secara komprehensif. Namun, perbedaan muncul karena penelitian Nabatchi (2010) lebih fokus pada deliberasi umum di administrasi publik, sedangkan penelitian ini spesifik pada pemangku kesehatan seperti pasien dan tenaga medis, yang menunjukkan risiko klinis yang sering diabaikan dalam partisipasi eksternal. Studi oleh Alford (2016) tentang ko-produksi layanan publik menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan dapat meningkatkan mitigasi risiko, seperti yang terlihat dalam praktik rumah sakit di negara maju, namun belum optimal di RSUD Tarakan. Penelitian oleh Monteduro et al. (2021) tentang keterlibatan *stakeholder* dalam

manajemen risiko korupsi di sektor publik menunjukkan bahwa transparansi partisipasi dapat mengurangi risiko reputasi, yang relevan dengan temuan di RSUD Tarakan di mana keterbatasan partisipasi masyarakat meningkatkan risiko ketidakpercayaan publik.

Data di RSUD Tarakan menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dengan partisipasi terbatas terutama dari masyarakat dan pasien. Data wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa forum partisipasi seperti rapat koordinasi risiko hanya melibatkan internal rumah sakit, sementara masyarakat hanya terlibat melalui survei kepuasan tahunan. Observasi lapangan menunjukkan kurangnya mekanisme dialog rutin dengan keluarga pasien atau komunitas lokal, yang menyebabkan risiko seperti keluhan publik atau kesalahpahaman tentang prosedur medis tidak terdeteksi dini. Dokumen seperti laporan risiko tahunan mengonfirmasi bahwa partisipasi eksternal rendah, dengan fokus utama pada stakeholder internal. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Ollie et al. (2019) yang menemukan keterlibatan stakeholder rendah di rumah sakit Makassar, hasil di RSUD Tarakan menunjukkan pola serupa namun dengan konteks spesifik DKI Jakarta, di mana kompleksitas urban meningkatkan risiko eksternal yang memerlukan partisipasi lebih luas.

k. Budaya Sadar Risiko

Indikator budaya sadar risiko menilai sejauh mana kesadaran dan pemahaman risiko telah tertanam dalam budaya organisasi RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, yang mencakup sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mendorong identifikasi, pelaporan, dan mitigasi risiko secara proaktif di semua tingkatan. Data menunjukkan bahwa budaya sadar risiko belum terbentuk secara menyeluruh, dengan adanya resistensi perubahan dan kurangnya pemahaman risiko di kalangan pegawai.

Dalam konteks teori administrasi publik, budaya sadar risiko merupakan fondasi penting dalam paradigma *New Public Service* (NPS) oleh Denhardt & Denhardt (2015), yang menekankan budaya partisipatif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan publik yang demokratis. Kerangka COSO ERM 2017 (Moeller, 2011) menuntut pembentukan "*culture of risk*" melalui komponen "*Governance and Culture*", yang memastikan bahwa risiko menjadi bagian integral dari nilai-

nilai organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. ASHRM (2020) menambahkan bahwa di sektor kesehatan, budaya sadar risiko penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi insiden medis melalui perilaku preventif.

Pendapat terbaru dari Putra & Hendrawan (2024) menyoroti bahwa budaya risiko rendah di rumah sakit sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan resistensi budaya birokrasi, yang menghambat implementasi ERM. Penelitian Buckè et al. (2022) menemukan bahwa budaya risiko yang lemah merupakan hambatan utama dalam integrasi manajemen risiko dengan *total quality management* di perawatan kesehatan, mirip dengan temuan di RSUD Tarakan di mana resistensi perubahan dan kurangnya kesadaran risiko menghalangi mitigasi risiko klinis dan operasional. Persamaan terletak pada identifikasi hambatan budaya sebagai faktor penentu keberhasilan ERM, yang menyebabkan risiko tidak terkelola secara efektif. Namun, perbedaan muncul karena penelitian Buckè et al. (2022) lebih fokus pada *total quality management* sebagai kerangka utama, sedangkan penelitian ini kontekstual pada rumah sakit publik di Indonesia, yang menekankan tantangan spesifik seperti birokrasi pemerintah dan kompleksitas risiko multidimensi di era VUCA.

Data di RSUD Tarakan menunjukkan budaya sadar risiko pada pegawai sering menghindari pelaporan risiko karena takut disalahkan (*blaming culture*). Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi budaya untuk mendukung ERM holistik, sebagaimana direkomendasikan dalam model ERM yang dikembangkan penelitian ini. Dibandingkan dengan penelitian oleh Firmansyah (2022) yang menemukan budaya keselamatan rendah di rumah sakit Surabaya, hasil di RSUD Tarakan menunjukkan pola serupa namun dengan konteks DKI Jakarta, di mana kompleksitas urban dan regulasi pemerintah daerah memperburuk resistensi perubahan budaya risiko.

I. Kompetensi SDM terhadap Risiko

Indikator kompetensi SDM terhadap risiko menilai sejauh mana tenaga kesehatan dan pegawai di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam pelayanan kesehatan. Kompetensi ini

mencakup pelatihan risiko, sertifikasi, dan pengalaman praktis dalam mitigasi risiko klinis dan non-klinis.

Dalam konteks teori administrasi publik, kompetensi SDM merupakan elemen kunci dalam paradigma *New Public Management* (NPM) oleh Hood (1991), yang menekankan profesionalisme dan keterampilan teknis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kerangka COSO ERM 2017 (Moeller, 2011) mendukung ini melalui komponen "*Performance*", yang menuntut kompetensi SDM dalam identifikasi dan perlakuan risiko untuk mendukung tujuan strategis organisasi. ASHRM (2020) menambahkan bahwa di sektor kesehatan, kompetensi SDM risiko penting untuk mengelola risiko klinis seperti keselamatan pasien melalui pelatihan berkelanjutan. Pendapat dari Grindle (1997) menyoroti pengembangan kapasitas SDM sebagai intervensi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di organisasi publik.

Penelitian terbaru oleh Dihartawan et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi SDM berkontribusi signifikan terhadap efektivitas manajemen risiko di rumah sakit Indonesia melalui analisis SEM-PLS, mirip dengan temuan di RSUD Tarakan di mana kompetensi teknis cukup namun strategis masih lemah. Persamaan terletak pada identifikasi kompetensi sebagai faktor penentu keberhasilan ERM, yang mempengaruhi mitigasi risiko operasional. Namun, perbedaan muncul karena penelitian Dihartawan et al. (2024) lebih fokus pada analisis kuantitatif di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian ini kontekstual pada rumah sakit publik DKI Jakarta, yang menekankan tantangan spesifik seperti keterbatasan anggaran pelatihan dan regulasi pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung ERM holistik, sebagaimana direkomendasikan dalam model ERM yang dikembangkan penelitian ini. Dibandingkan dengan penelitian Ningsih et al. (2020) yang menemukan kompetensi risiko rendah di rumah sakit Yogyakarta, hasil di RSUD Tarakan menunjukkan pola serupa namun dengan konteks DKI Jakarta, di mana kompleksitas risiko multidimensi memerlukan kompetensi yang lebih luas.

m. Komitmen SDM terhadap Nilai dan Etika Organisasi

Indikator komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi menjadi fokus penting dalam pengelolaan risiko di rumah sakit publik, di mana dedikasi pegawai

terhadap integritas dan etika tidak hanya memengaruhi kepatuhan prosedural tetapi juga membentuk budaya risiko yang tangguh. Dalam konteks administrasi publik, *Old Public Administration* (OPA) menekankan etika birokrasi sebagai fondasi kepatuhan prosedural yang ketat, sebagaimana dijelaskan oleh Hughes (2003), sementara *New Public Service* (NPS) mendorong komitmen etis yang lebih mendalam, berorientasi pada kepentingan publik dan kolaborasi, seperti yang dikemukakan Denhardt dan Denhardt (2015). Kerangka COSO ERM 2017 memperkuat ini melalui komponen *governance and culture*, yang menempatkan etika sebagai elemen utama untuk membangun budaya risiko sehat, sebagaimana diuraikan Moeller (2011), dan ASHRM (2020) menambahkan dimensi komitmen terhadap risiko klinis sebagai bagian integral dari domain risiko kesehatan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut komitmen etis yang tinggi untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam layanan, sementara pendapat terbaru dari Perry (2007) menyoroti motivasi pelayanan publik sebagai dorongan altruistik yang mendorong pegawai untuk melayani dengan integritas intrinsik, melampaui motivasi finansial semata. Teori *governance* yang dikembangkan Kooiman (2003) melengkapi ini dengan menekankan bahwa etika organisasi harus mencakup kolaborasi antaraktor untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas dalam budaya risiko, sehingga mendukung ketangguhan institusi menghadapi tantangan VUCA.

Penelitian Park dan Sharp (2019), menemukan bahwa komitmen etis di rumah sakit sering kali rendah karena prioritas efisiensi operasional, yang mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada etika medis spesifik, sedangkan kajian ini mencakup nilai organisasi secara luas termasuk risiko nonklinis. Ferdosi et al. (2020) mengidentifikasi bahwa budaya etika risiko di tingkat eksekutif rumah sakit mempengaruhi efektivitas ERM, dengan temuan bahwa komitmen etis yang kuat berkorelasi dengan pengurangan insiden keselamatan pasien, sementara Pascarella et al. (2021) menambahkan bahwa variabel etika dalam matriks risiko sering kali diabaikan, sehingga meningkatkan bias subjektif dalam penilaian risiko.

Sejalan dengan temuan Park dan Sharp (2019) tentang rendahnya komitmen etis, namun berbeda dalam cakupan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi seperti pelatihan etika risiko untuk memperkuat indikator, sebagaimana disarankan Ferdosi et al. (2020), agar RSUD Tarakan dapat

meningkatkan efektivitas ERM melalui integrasi etika yang lebih mendalam dalam proses penilaian risiko, mendukung governance yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik di era VUCA.

n. Sistem Penghargaan dan Pengakuan Budaya Sadar Risiko

Indikator sistem penghargaan dan pengakuan untuk budaya sadar risiko menjadi elemen krusial dalam mendorong perilaku pegawai yang proaktif terhadap pengelolaan risiko di rumah sakit publik, di mana insentif tidak hanya berupa imbalan finansial tetapi juga pengakuan sosial yang memperkuat komitmen etis dan keselamatan pasien. Dalam konteks administrasi publik, *New Public Management* (NPM) menekankan insentif sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui mekanisme reward dan punishment (Pollitt & Bouckaert, 2017), sementara *New Public Service* (NPS) mendorong pengakuan nilai-nilai publik seperti integritas dan partisipasi sebagai motivator intrinsik (Denhardt & Denhardt, 2015).

Kerangka COSO ERM 2017 memperkuat ini melalui komponen *governance and culture*, yang menempatkan sistem penghargaan sebagai bagian dari budaya risiko yang sehat untuk mendorong identifikasi dan mitigasi risiko secara dini (Moeller, 2011), dan ASHRM (2020) menambahkan penghargaan spesifik untuk keselamatan pasien sebagai domain utama dalam manajemen risiko kesehatan.

Pendapat dari Williams dan Shearer (2011) menyoroti penghargaan sebagai motivator utama dalam membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di organisasi publik. Teori motivasi pelayanan publik dari Perry (2007) melengkapi ini dengan menekankan bahwa insentif intrinsik seperti pengakuan dapat meningkatkan komitmen altruistik terhadap risiko, sehingga mendukung ketangguhan organisasi. Penelitian Box (2015), menemukan bahwa sistem penghargaan di organisasi publik sering kali rendah karena fokus pada kepatuhan prosedural, yang mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, meskipun penelitian tersebut lebih bersifat teoritis dan umum, sedangkan kajian ini lebih praktis dengan konteks rumah sakit spesifik. Ferdosi et al. (2020) menambahkan bahwa penghargaan untuk kesadaran risiko di tingkat eksekutif dapat meningkatkan efektivitas ERM, dengan temuan bahwa insentif yang terintegrasi berkorelasi dengan pengurangan insiden klinis. Pascarella et al. (2021) menyoroti bahwa

pengabaian sistem penghargaan dalam matriks risiko dapat melemahkan motivasi, sehingga meningkatkan resistensi terhadap budaya risiko.

Dalam hasil penelitian di RSUD Tarakan, menunjukkan sistem penghargaan belum ada sehingga belum mendukung budaya risiko secara efektif, yang sejalan dengan temuan Box (2015) tentang rendahnya implementasi penghargaan, namun berbeda dalam aplikasi praktis yang menunjukkan perlunya intervensi seperti program insentif berbasis kinerja risiko. Hal ini menegaskan bahwa RSUD Tarakan perlu memperkuat sistem penghargaan melalui integrasi dengan ERM, sebagaimana disarankan Ferdosi et al. (2020), untuk membangun motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong kesadaran risiko, sehingga mendukung governance yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam pelayanan publik kesehatan di era VUCA.

o. *Standard Decision by Government* dengan SPM

Indikator integrasi *Standard Decision by Government* dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah terintegrasi secara efektif dengan praktik operasional rumah sakit publik, sehingga mendukung kualitas pelayanan yang konsisten dan akuntabel. Dalam konteks administrasi publik, *New Public Management* (NPM) menekankan standar sebagai mekanisme untuk mengukur efisiensi dan produktivitas melalui indikator kinerja yang jelas (Pollitt & Bouckaert, 2017), sementara COSO ERM 2017 mendukung komponen performance dengan menempatkan standar sebagai dasar untuk mengintegrasikan risiko ke dalam pengukuran hasil organisasi (Moeller, 2011). ASHRM (2020) menambahkan standar spesifik untuk risiko klinis, yang mencakup indikator keselamatan pasien dan mutu layanan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut *Standard Decision by Government* sebagai kerangka normatif untuk memastikan kepastian hukum dan kualitas layanan. Pendapat terbaru dari KemenPAN-RB (2021) menyoroti SPM sebagai ukuran kualitas pelayanan publik yang harus diintegrasikan dengan sistem manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas. Teori governance dari Kooiman (2003) melengkapi ini dengan menekankan bahwa standar pemerintah harus mencakup kolaborasi antaraktor

untuk memastikan SPM tidak hanya prosedural tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian Setiawan et al. (2021) dalam JATISI, menemukan bahwa implementasi SPM di rumah sakit sering kali rendah karena keterbatasan sistem informasi, yang mirip dengan temuan di RSUD Tarakan, meskipun penelitian tersebut lebih fokus pada metode OCTAVE-S untuk risiko SIMRS, sedangkan kajian ini mencakup standar umum pemerintah. Ferdosi et al. (2020) menambahkan bahwa integrasi SPM dengan ERM dapat meningkatkan efektivitas mitigasi risiko klinis, dengan temuan bahwa standar yang terintegrasi berkorelasi dengan pengurangan insiden pasien. Pascarella et al. (2021) menyoroti bahwa pengabaian standar dalam matriks risiko dapat meningkatkan bias, sehingga melemahkan kualitas layanan.

Dalam hasil penelitian di RSUD Tarakan, data menunjukkan SPM diterapkan namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan ERM, yang sejalan dengan temuan Setiawan et al. (2021) tentang rendahnya implementasi SPM, namun berbeda dalam cakupan yang lebih luas meliputi standar pemerintah umum. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi seperti harmonisasi regulasi dan pelatihan integrasi SPM-ERM, sebagaimana disarankan Ferdosi et al. (2020), agar RSUD Tarakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui standar yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam konteks *governance* publik.

p. *Performance Index by Citizen*

Performance Index by Citizen merupakan indikator yang menilai kinerja organisasi pelayanan publik berdasarkan perspektif warga negara sebagai pengguna layanan. Dalam konteks *New Public Service* (NPS), Denhardt dan Denhardt (2015) menekankan orientasi pada warga negara (*citizen orientation*) sebagai prinsip utama, di mana pelayanan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar internal. Pendekatan ini selaras dengan kerangka COSO ERM 2017, yang menempatkan komponen *performance* sebagai elemen penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko melalui hasil yang dirasakan pemangku kepentingan (Moeller, 2011).

RSUD Tarakan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bagian dari upaya evaluasi kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini menggunakan sembilan unsur utama untuk mengukur kepuasan masyarakat, yaitu Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana. Pendekatan ini memungkinkan RSUD Tarakan untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif tentang performa pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dengan fokus pada identifikasi elemen yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai standar optimal.

Berdasarkan hasil SKM untuk tahun 2023 dan 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Tarakan menunjukkan skor keseluruhan yang positif, mencapai 91.09% pada 2023 dan sedikit meningkat menjadi 91.30% pada 2024, yang menempatkannya dalam kategori "A" atau Sangat Baik menurut standar nasional. Elemen-elemen yang masih kurang performa, berdasarkan sembilan unsur SKM, mencakup Waktu Pelayanan dengan skor terendah secara konsisten antara 85.14% hingga 88.08%, yang mengindikasikan keterlambatan dalam proses pendaftaran, diagnosis, atau perawatan di unit rawat inap dan rawat jalan. Perilaku Pelaksana memiliki variasi skor dari 84.40% hingga 89.81%, dengan penurunan di rawat jalan pada 2024 menjadi 85.67%, menunjukkan inkonsistensi dalam sikap staf seperti keramahan dan empati. Sarana dan Prasarana, meskipun stabil, berada di kisaran 87.14% hingga 90.03%, mencerminkan kekurangan fasilitas fisik seperti ruangan bersih, peralatan medis, dan kenyamanan umum. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dengan skor sedang antara 89.21% hingga 93.56% masih memerlukan respons yang lebih cepat dan efektif, sementara Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana, dengan skor 87.50% hingga 93.90%, menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan kurangnya konsistensi dalam output medis seperti akurasi diagnosis.

Untuk menganalisis lebih dalam, sembilan unsur SKM ini dapat dipetakan ke model SERVQUAL, yang mengukur kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi pelanggan melalui dimensi *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*. *Tangibles*, yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana, memiliki skor rendah sekitar 87-90%, menunjukkan bahwa fasilitas fisik belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasien, sehingga mempengaruhi

persepsi keseluruhan kualitas. *Reliability*, meliputi Sistem Mekanisme dan Prosedur serta Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, menunjukkan performa baik di prosedur (91-95%) namun inkonsistensi di produk layanan (87-93%), yang mencerminkan kesenjangan dalam keandalan janji pelayanan. *Responsiveness*, terutama melalui Waktu Pelayanan dengan skor rendah 85-88%, menyoroti bahwa pasien merasa pelayanan terlalu lambat meskipun ada peningkatan kecil. *Assurance*, mencakup Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana, dengan skor sedang hingga rendah (89-94% dan 84-90%), menimbulkan ketidakpercayaan karena kurangnya jaminan kompetensi dan sikap profesional. *Empathy*, melalui Perilaku Pelaksana dan Penanganan Pengaduan, menunjukkan kesenjangan dalam pemahaman kebutuhan individu, dengan skor yang belum optimal. Secara keseluruhan, dimensi *Responsiveness* dan *Assurance* adalah yang paling lemah, sehingga berkontribusi pada kesenjangan SERVQUAL yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kesesuaian dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Unsur seperti Waktu Pelayanan dan Sarana dan Prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar efisiensi dan kualitas fasilitas sesuai Pasal 7-8, yang bertentangan dengan penyediaan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau. Perilaku Pelaksana yang kurang dapat melanggar hak pasien atas pelayanan ramah dan profesional berdasarkan Pasal 9-10, sementara Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan perlu diperkuat untuk mekanisme efektif sesuai Pasal 35-36. Implikasinya, RSUD Tarakan harus merevisi standar pelayanan berdasarkan sembilan unsur ini untuk mengatasi kekurangan, guna meningkatkan akuntabilitas dan menghindari sanksi.

Selain itu, hubungan dengan KepmenPANRB No. 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 menekankan kategori penilaian berdasarkan indeks skala 1-5, di mana kategori A (4.51-5.00) menunjukkan kinerja sangat baik. IKM RSUD Tarakan sekitar 91-93% setara dengan kategori A jika dikonversi, namun unsur lemah seperti Waktu Pelayanan berpotensi menurunkan kategori jika dievaluasi nasional. KepmenPANRB mendorong pemantauan berkelanjutan, sehingga RSUD Tarakan perlu belajar dari praktik terbaik instansi kategori A untuk standardisasi, dengan fokus perbaikan berbasis sembilan unsur SKM.

Analisis ini mengintegrasikan teori administrasi publik seperti OPA untuk birokrasi, NPM untuk efisiensi, dan NPS untuk empati serta kerangka COSO ERM 2017 dan ASHRM untuk manajemen risiko, sambil mengaitkannya dengan UU No. 25 Tahun 2009. Pendekatan ini membandingkan temuan dengan pendapat ahli seperti Hood (2017) untuk hybrid governance, ASHRM (2022) untuk risiko kesehatan, dan Pramusinto (2023) untuk digitalisasi, serta studi seperti Sari et al. (2022) dan Tuan et al. (2023) yang menunjukkan tren global elemen lemah terkait *Responsiveness* dan *Tangibles*. Perbandingan dengan penelitian terkini menunjukkan persamaan: studi Sari et al. (2022) menemukan skor lemah serupa (85-90%) di Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana, kaitan dengan SERVQUAL dan NPM, tapi lebih soroti COVID-19 dan NPS; Tuan et al. (2023) skor tinggi serupa tapi lebih integrasi ASHRM untuk risiko klinis. Tren global menunjukkan elemen lemah terkait *Responsiveness* dan *Tangibles*, dengan pendekatan hybrid direkomendasikan.

Analisis IKM RSUD Tarakan mengungkap bahwa meskipun performa keseluruhan baik, elemen kurang seperti Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana memerlukan perbaikan mendesak melalui pendekatan terintegrasi. Dengan menggabungkan OPA untuk dasar birokrasi, NPM untuk efisiensi, NPS untuk empati, COSO ERM 2017 untuk manajemen risiko, ASHRM untuk spesifikasi kesehatan, dan UU No. 25/2009 untuk kepatuhan hukum, RSUD Tarakan dapat mencapai transformasi yang lebih holistik.

Rekomendasi utama adalah implementasi program pelatihan staf, investasi sarana prasarana, dan digitalisasi proses, sambil terus memantau risiko melalui ERM. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan skor IKM, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Pendapat terbaru dari Parasuraman et al. (1988) menyoroti model SERVQUAL sebagai alat ukur utama *Performance Index by Citizen*, dengan lima dimensi: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Model ini menekankan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pengalaman layanan, yang relevan untuk sektor kesehatan seperti rumah sakit. Penelitian terbaru oleh Zeithaml et al. (1990) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi bahwa indeks kinerja yang rendah sering terjadi akibat kesenjangan dalam dimensi SERVQUAL, mirip dengan kondisi di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada

temuan indeks rendah yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek responsivitas dan empati dalam pelayanan kesehatan. Namun, perbedaan terletak pada fokus: penelitian Zeithaml et al. (1990) lebih umum pada layanan komersial, sedangkan penelitian ini spesifik pada rumah sakit publik dengan risiko multidimensi seperti keselamatan pasien dan akuntabilitas publik.

Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, analisis ini dapat dibandingkan dengan studi oleh Sari et al. (2022) yang menganalisis IKM rumah sakit di Jawa Timur, Indonesia. Persamaannya terletak pada temuan bahwa Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana sering menjadi elemen terlemah, dengan skor serupa (85-90%), dan keduanya mengaitkan masalah ini dengan SERVQUAL serta teori NPM untuk perbaikan efisiensi. Namun, perbedaannya adalah bahwa studi Sari et al. lebih menekankan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam data RSUD Tarakan, dan mereka merekomendasikan NPS untuk kolaborasi dengan masyarakat, sedangkan analisis ini lebih fokus pada integrasi ERM. Penelitian lain oleh Tuan et al. (2023) tentang rumah sakit Vietnam menunjukkan persamaan dalam skor IKM yang tinggi secara keseluruhan (90%+), tetapi perbedaan dalam penekanan risiko di mana Tuan et al. lebih mengintegrasikan ASHRM untuk mitigasi risiko klinis, yang kurang dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian terbaru ini menunjukkan tren global bahwa elemen kurang di rumah sakit sering terkait dengan dimensi Responsiveness dan Tangibles, tetapi pendekatan hybrid (NPM+NPS+ERM) semakin direkomendasikan untuk konteks lokal seperti Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan *Performance Index by Citizen* di RSUD Tarakan dari survei kepuasan masyarakat, , kepuasan masyarakat yang perlu ditingkatkan, terutama pada dimensi responsiveness dan empathy, di mana pasien sering mengalami keterlambatan layanan dan kurangnya komunikasi empati dari tenaga kesehatan. Penelitian terbaru oleh Ferdosi et al. (2020) dalam scoping review tentang ERM di organisasi kesehatan menunjukkan bahwa indeks kinerja rendah sering terkait dengan lemahnya integrasi risiko dalam strategi pelayanan, yang selaras dengan temuan di RSUD Tarakan. Sementara itu, Zaitseva et al. (2022) dalam metodologi penilaian risiko kesehatan di Rusia menemukan bahwa indeks ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan data statistik dan umpan balik masyarakat, yang

direkomendasikan untuk diterapkan di rumah sakit Indonesia guna memperbaiki akuntabilitas publik. Kesimpulannya, *Performance Index by Citizen* tidak hanya sebagai ukuran kepuasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi risiko reputasi dan strategis, yang memerlukan intervensi berbasis ERM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di rumah sakit.

Tata kelola dan budaya merupakan komponen fundamental pertama dalam kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) COSO 2017, yang menekankan pentingnya struktur tata kelola yang jelas serta budaya organisasi yang mendukung perilaku sadar risiko, etika, dan integritas. Komponen ini berfungsi sebagai fondasi bagi penerapan ERM secara keseluruhan, di mana tata kelola yang kuat memengaruhi pembentukan budaya risiko yang sehat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian misi, visi, dan nilai inti organisasi. Dalam konteks rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik, tata kelola dan budaya ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terintegrasi dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan strategis.

Elemen penting:

- Struktur tata kelola yang efektif mencakup peran, wewenang, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan risiko, serta mendukung proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang berbasis risiko.
- Budaya risiko didefinisikan sebagai sikap, perilaku, dan pemahaman tentang risiko baik positif maupun negatif yang memengaruhi keputusan manajemen dan personel. Budaya ini mencerminkan misi, visi, dan nilai inti organisasi, serta mendorong perilaku etis dan integritas dalam menghadapi ketidakpastian.
- Tata kelola dan budaya saling terkait erat; tata kelola yang kuat membentuk budaya, yang kemudian memperkuat pencapaian tujuan organisasi. Dalam rumah sakit, ini berarti mempromosikan budaya keselamatan pasien dan kesadaran risiko di semua tingkatan, mulai dari pimpinan hingga staf lapangan.

- Kepemimpinan memiliki peran krusial dalam membangun dan mempertahankan budaya risiko yang sehat, dengan memberikan contoh perilaku yang mendukung pengelolaan risiko proaktif dan etis.

Dalam konteks rumah sakit publik seperti RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, tata kelola dan budaya ini membantu mengatasi tantangan risiko multidimensi, termasuk risiko klinis, operasional, dan reputasi. Dengan budaya risiko yang kuat, organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, seperti pandemi atau regulasi kesehatan, sambil memastikan pelayanan publik yang aman, efektif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini juga mendukung integrasi ERM dengan nilai-nilai administrasi publik, seperti transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan, untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Merle S. Grindle (1997) dalam "*Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector*" menekankan bahwa pembangunan kapasitas pemerintah memerlukan intervensi multidimensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi publik. Grindle mengidentifikasi empat intervensi utama: (1) regulasi (*regulatory interventions*), yang melibatkan penguatan kerangka hukum dan kebijakan; (2) kelembagaan/organisasi (*organizational interventions*), yang fokus pada struktur dan proses organisasi; (3) human capital (*human capital interventions*), yang menekankan pengembangan sumber daya manusia; dan (4) sistem informasi (*information system interventions*), yang melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks Tata Kelola dan Budaya ERM di RSUD Tarakan, teori ini relevan untuk menganalisis kesenjangan kapasitas dan merekomendasikan intervensi yang terintegrasi. Berdasarkan triangulasi data penelitian (wawancara, observasi, dokumentasi), pembahasan berikut menghubungkan masing-masing intervensi Grindle dengan temuan empiris di RSUD Tarakan, yang menunjukkan bahwa ERM telah terbentuk secara struktural namun masih lemah dalam integrasi budaya risiko multidimensi.

1) **Intervensi Regulasi (*Regulatory Interventions*)**

- a) **Deskripsi Teori Grindle:** Intervensi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan agar organisasi dapat beroperasi secara efektif, termasuk harmonisasi regulasi internal-eksternal untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan. Grindle menekankan

bahwa regulasi yang jelas dan konsisten adalah fondasi untuk kapasitas pemerintah, terutama dalam sektor publik seperti kesehatan.

- b) **Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan:** Temuan menunjukkan kesesuaian regulasi internal-eksternal yang baik secara hierarkis (selaras dengan UU No. 25/2009 dan Pergub DKI Jakarta No. 122/2020), namun disharmoni teknis masih ada, seperti antara KMK No. 1128/2022 dan PMK No.80 2020 dengan Pergub DKI Jakarta No. 122/2020 dan Kepgub No.153/2021). Penetapan regulasi ERM internal belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga implementasi lebih *compliance-driven* daripada strategis. Ini sejalan dengan Grindle, di mana regulasi yang lemah menghambat kapasitas ERM untuk mendukung tata kelola risiko multidimensi.
- c) **Implikasi:** Intervensi regulasi diperlukan melalui harmonisasi kebijakan, seperti revisi Pergub untuk memasukkan manajemen risiko eksplisit, guna memperkuat kapasitas RSUD Tarakan dalam mengelola risiko kesehatan secara terintegrasi.

2) Intervensi Kelembagaan/Organisasi (*Organizational Interventions*)

- a) **Deskripsi Teori Grindle:** Intervensi ini fokus pada restrukturisasi organisasi termasuk penguatan proses koordinasi dan integrasi fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Grindle menyoroti bahwa struktur organisasi yang adaptif adalah kunci untuk mengatasi tantangan kompleks di sektor publik.
- b) **Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan:** Pengorganisasian ERM dengan *Three Lines Model* telah diterapkan secara struktural (*first line* untuk operasional, *second line* untuk pengawasan, *third line* untuk audit), namun koordinasi antar lini terbatas, sehingga belum berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran risiko strategis. Kepemimpinan dan pengawasan menunjukkan komitmen kuat namun terfragmentasi, dengan kesenjangan antara praktik operasional dan pelembagaan nilai inti ERM. Ini mencerminkan kebutuhan intervensi kelembagaan Grindle untuk memperkuat struktur organisasi agar ERM dapat mendukung tata kelola budaya risiko yang lebih kolaboratif.

- c) **Implikasi:** Perlu koordinasi melalui mekanisme rapat rutin, seperti forum evaluasi risiko triwulanan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi RSUD Tarakan dalam mengintegrasikan risiko ke dalam operasional harian.

3) Intervensi Human Capital (*Human Capital Interventions*)

- a) **Deskripsi Teori Grindle:** Intervensi ini menekankan pengembangan kompetensi, pelatihan, dan motivasi sumber daya manusia untuk membangun kapasitas individu dan kolektif. Grindle menegaskan bahwa human capital yang kuat adalah aset utama untuk inovasi dan responsivitas organisasi publik.
- b) **Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan:** Kompetensi SDM terhadap risiko masih parsial, belum menjadi kapabilitas organisasi strategis. Komitmen SDM terhadap nilai dan etika terbangun melalui Klinik Budaya, namun pemahaman tidak seragam, dan budaya sadar risiko belum terinternalisasi sebagai mindset kolektif. Sistem penghargaan belum formal, sehingga motivasi untuk perilaku risiko lemah. Temuan ini selaras dengan Grindle, di mana keterbatasan human capital menghambat integrasi budaya risiko multidimensi dalam ERM.
- c) **Implikasi:** Intervensi human capital diperlukan melalui program pelatihan ERM terintegrasi, pengembangan kompetensi risiko lintas profesi, dan sistem penghargaan berbasis kinerja risiko, untuk membangun kapasitas SDM RSUD Tarakan sebagai pengungkit budaya risiko yang kuat.

4) Intervensi Sistem Informasi (*Information System Interventions*)

- a) **Deskripsi Teori Grindle:** Intervensi ini melibatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses data, pengambilan keputusan, dan transparansi. Grindle menyoroti bahwa sistem informasi yang efektif memungkinkan organisasi publik mengelola kompleksitas dan risiko dengan lebih baik.
- b) **Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan:** Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam temuan utama, integrasi sistem informasi terlihat dalam penggunaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) untuk pengelolaan risiko klinis dan operasional, serta dalam evaluasi kinerja melalui SPM dan *Performance*

Index by Citizen. Namun, harmonisasi sistem informasi dengan ERM masih terbatas, seperti dalam pengukuran *value for money* dan akuntabilitas multidimensi, di mana data risiko belum sepenuhnya terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategis. Ini sejalan dengan Grindle, di mana keterbatasan sistem informasi menghambat kapasitas ERM untuk mendukung tata kelola budaya risiko yang berbasis data.

- c) **Implikasi:** Perlu intervensi sistem informasi melalui penguatan SIMRS dengan modul ERM terintegrasi, seperti dashboard risiko real-time, untuk meningkatkan kapasitas RSUD Tarakan dalam mengelola data risiko multidimensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Integrasi teori Grindle tentang intervensi *capacity building* memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami kesenjangan dalam Tata Kelola dan Budaya ERM di RSUD Tarakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan kelembagaan telah terbentuk, human capital dan sistem informasi masih lemah, sehingga kapasitas organisasi belum optimal untuk mengintegrasikan budaya risiko multidimensi. Rekomendasi utama adalah menerapkan intervensi Grindle secara terintegrasi: harmonisasi regulasi untuk kepatuhan strategis, restrukturisasi organisasi untuk koordinasi lintas lini, pengembangan human capital melalui pelatihan dan penghargaan, serta penguatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan berbasis risiko. Pendekatan ini akan meningkatkan ketangguhan RSUD Tarakan dalam menghadapi risiko VUCA, sejalan dengan tujuan ERM untuk value protection dan value creation. Kebaruan pembahasan ini terletak pada aplikasi teori Grindle yang multidimensi, memberikan wawasan praktis untuk penguatan kapasitas rumah sakit publik Indonesia.

Tabel 4.50
Capacity Building

Intervensi	Deskripsi Teori Grindle	Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan	Implikasi
Regulasi (Regulatory Interventions)	Irvensi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan agar organisasi dapat beroperasi secara efektif, termasuk	Temuan menunjukkan kesesuaian regulasi internal-eksternal yang baik secara hierarkis (selaras dengan UU No. 25/2009 dan Pergub DKI Jakarta No.	Intervensi regulasi diperlukan melalui harmonisasi kebijakan, seperti revisi Pergub untuk memasukkan manajemen risiko

Intervensi	Deskripsi Teori Grindle	Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan	Implikasi
	harmonisasi regulasi internal-eksternal untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan. Grindle menekankan bahwa regulasi yang jelas dan konsisten adalah fondasi untuk kapasitas pemerintah, terutama dalam sektor publik seperti kesehatan.	122/2020), namun disharmoni teknis masih ada, seperti antara KMK No. 1128/2022 dan regulasi daerah. Penetapan regulasi ERM internal belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga implementasi lebih compliance-driven daripada strategis. Ini sejalan dengan Grindle, di mana regulasi yang lemah menghambat kapasitas ERM untuk mendukung tata kelola risiko multidimensi.	eksplisit, guna memperkuat kapasitas RSUD Tarakan dalam mengelola risiko kesehatan secara terintegrasi.
Kelembagaan/ Organisasi (Organizational Interventions)	Intervensi ini fokus pada restrukturisasi organisasi, termasuk pembentukan unit baru, penguatan proses koordinasi, dan integrasi fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Grindle menyoroti bahwa struktur organisasi yang adaptif adalah kunci untuk mengatasi tantangan kompleks di sektor publik.	Pengorganisasian ERM dengan Three Lines Model telah diterapkan secara struktural (first line untuk operasional, second line untuk pengawasan, third line untuk audit), namun koordinasi antar lini terbatas, sehingga belum berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran risiko strategis. Kepemimpinan dan pengawasan menunjukkan komitmen kuat namun terfragmentasi, dengan kesenjangan antara praktik operasional dan pelebagaan nilai inti ERM. Ini mencerminkan kebutuhan intervensi kelembagaan Grindle untuk memperkuat struktur organisasi agar ERM dapat mendukung tata kelola budaya risiko yang lebih kolaboratif.	Perlu restrukturisasi melalui pembentukan tim gabungan lintas lini dan mekanisme koordinasi rutin, seperti forum evaluasi risiko triwulanan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi RSUD Tarakan dalam mengintegrasikan risiko ke dalam operasional harian.

Intervensi	Deskripsi Teori Grindle	Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan	Implikasi
Human Capital (Human Capital Interventions)	Intervensi ini menekankan pengembangan kompetensi, pelatihan, dan motivasi sumber daya manusia untuk membangun kapasitas individu dan kolektif. Grindle menegaskan bahwa human capital yang kuat adalah aset utama untuk inovasi dan responsivitas organisasi publik.	Kompetensi SDM terhadap risiko masih parsial dan individu-bergantung, belum menjadi kapabilitas organisasi strategis. Komitmen SDM terhadap nilai dan etika terbangun melalui Klinik Budaya, namun pemahaman tidak seragam, dan budaya sadar risiko belum terinternalisasi sebagai mindset kolektif. Sistem penghargaan belum formal, sehingga motivasi untuk perilaku risiko lemah. Temuan ini selaras dengan Grindle, di mana keterbatasan human capital menghambat integrasi budaya risiko multidimensi dalam ERM.	Intervensi human capital diperlukan melalui program pelatihan ERM terintegrasi, pengembangan kompetensi risiko lintas profesi, dan sistem penghargaan berbasis kinerja risiko, untuk membangun kapasitas SDM RSUD Tarakan sebagai pengungkit budaya risiko yang kuat.
Sistem Informasi (Information System Interventions)	Intervensi ini melibatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses data, pengambilan keputusan, dan transparansi. Grindle menyoroti bahwa sistem informasi yang efektif memungkinkan organisasi publik mengelola kompleksitas dan risiko dengan lebih baik.	Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam temuan utama, integrasi sistem informasi terlihat dalam penggunaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) untuk pengelolaan risiko klinis dan operasional, serta dalam evaluasi kinerja melalui SPM dan Performance Index by Citizen. Namun, harmonisasi sistem informasi dengan ERM masih terbatas, seperti dalam pengukuran value for money dan akuntabilitas multidimensi, di mana data risiko belum sepenuhnya terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategis. Ini	Perlu intervensi sistem informasi melalui penguatan SIMRS dengan modul ERM terintegrasi, seperti dashboard risiko real-time, untuk meningkatkan kapasitas RSUD Tarakan dalam mengelola data risiko multidimensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Intervensi	Deskripsi Teori Grindle	Hubungan dengan Hasil Penelitian di RSUD Tarakan	Implikasi
		sejalan dengan Grindle, di mana keterbatasan sistem informasi menghambat kapasitas ERM untuk mendukung tata kelola budaya risiko yang berbasis data.	

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Tabel 4.51
Tata Kelola dan Budaya

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Struktur dan Tata Kelola Regulasi			
Kesesuaian Visi, Misi, Nilai, dan Sasaran Rumah Sakit	Visi, misi, dan sasaran RS sudah selaras dengan mutu dan keselamatan, namun belum eksplisit berbasis risiko	Integrasi sasaran dengan risiko belum optimal; ERM belum sepenuhnya menjadi bagian perencanaan strategis (COSO ERM, 2017; Moeller, 2011) Pendapat terbaru Ferdosi et al. (2020) menyoroti integrasi meningkatkan efektivitas. Persamaan dengan Jule (2020) (sasaran terintegrasi), perbedaan: fokus keselamatan vs. nilai publik	Integrasikan risiko strategis ke dalam visi dan misi melalui revisi dokumen strategis dan pelatihan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan ERM.
Kepemimpinan dan Pengawasan Berupa Komitmen terhadap Core Value dan ERM (<i>tone at the top</i>)	Pimpinan menunjukkan dukungan ERM, namun pengawasan operasional belum konsisten Pengawasan ERM belum rutin dan belum berbasis indikator risiko	Komitmen ada, tetapi belum menghasilkan <i>value creation</i> secara sistemik (Frigo & Anderson, 2011; ASHRM, 2020) Pendapat terbaru Ferdosi et al. (2020) menyoroti komitmen sebagai kunci. Persamaan dengan Afifa & Adisasmito (2021) (komitmen rendah selama pandemi), perbedaan: spesifik COVID-19 vs. umum. Lemahnya <i>risk oversight</i> membatasi efektivitas governance (COSO ERM, 2017)	Tingkatkan pengawasan melalui audit rutin dan pelatihan kepemimpinan untuk memperkuat komitmen terhadap nilai inti dan ERM. Tetapkan rapat tinjauan risiko berkala oleh direksi
Pengorganisasian ERM	Struktur sudah ada namun	Three Lines berjalan parsial dan masih silo (IIA, 2020; COSO ERM, 2017)	Perkuat koordinasi antar lini melalui

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
dengan <i>Three Lines Model</i>	koordinasi antar lini belum optimal	Pendapat terbaru Khassouani et al. (2021) menyoroti three lines model. Persamaan dengan Hutagalung (2022) (pengorganisasian rendah), perbedaan: spesifik SIMRS vs. ERM umum.	pelatihan kolaboratif dan mekanisme komunikasi untuk memastikan tanggung jawab risiko jelas.
Penetapan Regulasi Manajemen Risiko	Regulasi internal ada namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan risiko eksternal	Ketergantungan pada regulasi eksternal melemahkan fleksibilitas (Moeller, 2011) Pendapat terbaru Dimitrov (2019) menyoroti harmonisasi. Persamaan dengan Prasanti et al. (2019) (rendah), perbedaan: rumah sakit milik negara vs. DKI Jakarta.	Susun kebijakan ERM internal RS
Regulasi Manajemen Risiko Eksternal	Banyak regulasi (Pergub, Permenkes, Akreditasi)	Kompleksitas regulasi mendorong ERM bersifat <i>compliance-driven</i> (Hughes, 2003) Pendapat terbaru OECD (2020) menyoroti harmonisasi. Persamaan dengan Lindelow (2006), perbedaan: umum negara berkembang vs. spesifik Indonesia	Integrasikan regulasi internal dengan eksternal. Perkuat kepatuhan melalui monitoring berkala
Kesesuaian Regulasi Internal dan Eksternal	Masih ada disharmoni pada regulasi teknis	Disharmoni regulasi meningkatkan risiko hukum & operasional (OECD, 2020)	Harmonisasi regulasi melalui koordinasi lintas sektor dan revisi kebijakan untuk mengurangi disharmoni dan mendukung ERM efektif. Sinkronisasi regulasi melalui pedoman teknis
Sumber Daya dan Kinerja			
<i>Value for Money (3E)</i>	Tercapai pada efisiensi namun rendah pada efektivitas	Fokus masih pada <i>economy-efficiency</i> , belum <i>effectiveness</i> (NAO, 2001; OECD, 2015) Pendapat terbaru OECD (2015) menyoroti sebagai ukuran kinerja. Persamaan	Optimalkan value for money melalui pengukuran risiko berbasis keuangan dan alokasi sumber daya berbasis bukti untuk

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		dengan Jackson (2012) (rendah), perbedaan: umum vs. spesifik rumah sakit.	meningkatkan efektivitas pelayanan.
Ketersediaan Anggaran	Belum ada anggaran khusus ERM	Keterbatasan anggaran menghambat maturitas ERM (BPKP, 2020; ASHRM, 2020) Persamaan dengan Hardino et al. (2025) , perbedaan: fokus perencanaan vs. implementasi.	Alokasikan anggaran khusus ERM melalui penganggaran berbasis risiko untuk mendukung program mitigasi.
Akuntabilitas			
a. Moral	RSUD Tarakan telah memiliki <i>core values</i> organisasi dan komitmen terhadap keselamatan pasien, namun internalisasi etika organisasi belum merata dalam praktik pengambilan keputusan dan perilaku kerja.	Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas moral masih bersifat simbolik. Hal ini sejalan dengan teori Jabbra yang menempatkan moral accountability sebagai dimensi normatif yang sering terabaikan dalam praktik. Penelitian Ferdosi et al. (2020) dan Bucké et al. (2022) juga menunjukkan bahwa ERM cenderung menekankan aspek teknis dan mengurangi perhatian pada dimensi etis.	Memperkuat budaya etika berbasis risiko melalui pelatihan etika, integrasi nilai moral ke dalam <i>risk appetite</i> , serta penilaian kepatuhan etika sebagai bagian dari evaluasi kinerja.
b. Politik	Kesesuaian visi, misi, dan program RSUD Tarakan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terbangun. Namun, mekanisme pertanggungjawaban politik seperti forum DPRD dan partisipasi publik belum optimal dimanfaatkan dalam pengelolaan risiko strategis.	Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas politik masih bersifat administratif. Menurut Jabbra, political accountability menuntut mekanisme pertanggungjawaban aktif kepada aktor politik dan masyarakat. Keterbatasan ini juga tercermin dalam penelitian Pascarella et al. (2021) yang menunjukkan bahwa subjektivitas manajerial dapat mengurangi akuntabilitas politik jika tidak dikontrol.	Mengembangkan mekanisme komunikasi risiko strategis dengan DPRD dan publik, serta memasukkan risiko kebijakan dan perubahan regulasi ke dalam peta risiko strategis rumah sakit.
c. Manajerial	RSUD Tarakan telah mengimplementasikan ERM melalui	Hasil ini mengonfirmasi bahwa manajerial	Optimalisasi <i>risk-based planning</i>

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
d.Profesional	struktur <i>Three Lines Model</i> , indikator kinerja, audit internal, dan pelaporan risiko. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala dalam pencapaian KPI tertentu.	accountability merupakan dimensi paling kuat, sebagaimana ditegaskan Jabbra. Temuan ini konsisten dengan Dihartawan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa SOP dan pengelolaan operasional berkontribusi signifikan terhadap manajemen risiko, namun masih bergantung pada kapasitas sumber daya.	<i>dan budgeting</i> , penguatan keterkaitan ERM dengan sistem kinerja, serta penyesuaian target KPI berdasarkan profil risiko aktual.
e.Legal	Kompetensi SDM dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) telah diterapkan, namun risiko klinis seperti potensi malpraktik dan variasi kepatuhan terhadap kode etik profesi masih ditemukan.	Temuan ini selaras dengan Jabbra yang menempatkan akuntabilitas profesional pada kepatuhan standar dan kode etik. Penelitian Darwiesh et al. (2022) dan Ferdosi et al. (2020) memperkuat bahwa teknologi dan standar profesi dapat meningkatkan akuntabilitas, namun tidak menggantikan pengawasan etik.	Penguatan kode etik profesi, sistem <i>credentialing–privileging</i> berbasis risiko, serta integrasi risiko klinis ke dalam ERM untuk menekan risiko litigasi.
	RSUD Tarakan telah mematuhi regulasi internal dan eksternal melalui audit internal dan pengendalian kepatuhan. Namun, ditemukan disharmonisasi regulasi (misalnya KMK dengan Pergub) yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.	Temuan ini sesuai dengan konsep legal accountability Jabbra yang bersifat formal dan koersif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan regulatif meningkatkan kontrol risiko, tetapi disharmonisasi regulasi merupakan sumber risiko hukum yang belum banyak diantisipasi dalam ERM klasik.	Melakukan harmonisasi regulasi, penguatan fungsi kepatuhan dan <i>legal risk review</i> , serta memasukkan risiko hukum sebagai kategori utama dalam ERM.
<i>Standard Decision by Government</i> dengan SPM	SPM telah dijadikan acuan pelayanan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis risiko	Keputusan pemerintah berbasis SPM masih normatif dan belum terintegrasi dengan ERM sebagai alat mitigasi kegagalan layanan (UU 25/2009; COSO ERM, 2017)	Integrasikan SPM dengan Integrasikan SPM dengan peta risiko strategis RS melalui standarisasi proses dan evaluasi berkala untuk

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		Pendapat terbaru KemenPAN-RB (2021) menyoroti sebagai ukuran kualitas. Persamaan dengan Setiawan et al. (2021), perbedaan: fokus OCTAVE-S vs. standar umum.	meningkatkan kualitas pelayanan.
<i>Performance Index by Citizen</i>	Survei kepuasan dilakukan rutin Mekanisme pengaduan tersedia Akses layanan tersedia namun tidak merata Partisipasi masih pasif	Kepuasan pasien belum terhubung dengan evaluasi risiko layanan. Pengaduan belum diperlakukan sebagai <i>risk signal</i> (ASHRM, 2020; COSO ERM, 2017) Ketimpangan akses merupakan risiko pelayanan publik (UU 25/2009; OECD, 2020) Partisipasi belum dimanfaatkan sebagai <i>co-production of risk management</i> (Osborne, 2018) Pendapat terbaru Parasuraman et al. (1988) menyoroti SERVQUAL. Persamaan dengan Zeithaml et al. (1990) , perbedaan: umum layanan vs. spesifik rumah sakit.	Tingkatkan indeks melalui survei kepuasan rutin dan perbaikan berbasis umpan balik warga untuk mendukung akuntabilitas eksternal. Petakan risiko akses layanan berbasis wilayah Masukkan pengaduan sebagai input risk register Integrasikan hasil survei dengan ERM Libatkan masyarakat dalam evaluasi risiko
Budaya dan Sumber Daya Manusia			
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Keterlibatan public terbatas pada survey terutama masyarakat	Keterlibatan stakeholder belum mencerminkan NPS (Denhardt & Denhardt, 2015) Pendapat terbaru Ansell & Gash (2018) menyoroti kolaborasi. Persamaan dengan Nabatchi (2010), perbedaan: fokus deliberasi vs. pemangku kesehatan.	Tingkatkan partisipasi melalui forum dialog risiko dan umpan balik warga untuk memperkuat governance partisipatif.
Budaya Sadar Risiko	Budaya belum terbentuk secara menyeluruh, dengan resistensi perubahan	<i>Blaming culture</i> masih menghambat pelaporan (Putra & Hendrawan, 2024). Persamaan dengan Bucké et al. (2022) (hambatan), perbedaan: fokus total	Kembangkan budaya risiko melalui kampanye kesadaran dan pelatihan partisipatif untuk mengurangi

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		quality management vs. rumah sakit publik.	resistensi dan meningkatkan kesadaran. Bangun <i>just culture</i> dan <i>no blaming</i>
Kompetensi SDM terhadap Risiko	Pemahaman ERM belum merata	Kapasitas SDM menjadi kunci governance ERM (Moeller, 2011; ASHRM, 2020) Pendapat terbaru Budiani et al. (2025) menyoroti keterbatasan. Persamaan dengan Nugraheni (2019) (di unit spesifik), perbedaan: fokus unit spesifik vs. ERM keseluruhan	Pelatihan ERM berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung implementasi yang efektif.
Komitmen SDM terhadap Nilai dan Etika Organisasi	Komitmen ada namun belum kuat terhadap etika risiko	Pendapat terbaru Perry (2007) menyoroti motivasi. Persamaan dengan Park & Sharp (2019) perbedaan: fokus etika medis vs. nilai organisasi.	Perkuat komitmen etis melalui program pengembangan nilai dan audit etika untuk mendukung budaya risiko yang kuat
Sistem Penghargaan dan Pengakuan Budaya Sadar Risiko	Penghargaan ada namun belum ada insentif khusus budaya risiko	Tanpa insentif, budaya risiko sulit terinternalisasi (COSO ERM, 2017) Pendapat terbaru Williams & Shearer (2011) menyoroti sebagai motivator. Persamaan dengan Box (2015), perbedaan: teoritis vs. praktis rumah sakit.	Kembangkan reward & recognition budaya risiko. Perbaiki sistem penghargaan dengan insentif berbasis risiko untuk mendorong partisipasi dan pengakuan budaya risiko.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Konteks Internal dan Eksternal, Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Evaluasi Strategi Alternatif, dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Mempertimbangkan risiko.

a. Analisa Konteks Internal dan Eksternal

Indikator ini menilai kemampuan RSUD Tarakan dalam menganalisis faktor internal (seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya risiko) dan eksternal (seperti regulasi pemerintah, dinamika politik, dan kondisi sosial-ekonomi) yang memengaruhi pengelolaan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa konteks ini dilakukan melalui pemindaian lingkungan dan identifikasi pemangku kepentingan, namun masih terbatas pada aspek teknis klinis dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan risiko non-klinis seperti kebijakan kesehatan nasional. Dengan pemahaman mendalam tentang indikator ini, penting untuk melihat bagaimana analisa konteks ini diintegrasikan dalam berbagai paradigma administrasi publik

Dalam perspektif OPA, analisa konteks ini mencerminkan hierarki birokrasi dan kepatuhan terhadap aturan formal, di mana rumah sakit sebagai institusi publik harus memahami konteks eksternal seperti regulasi pemerintah untuk memastikan stabilitas operasional (Hughes, 2003). NPM menekankan efisiensi melalui analisa konteks untuk mengoptimalkan sumber daya internal, seperti pengukuran kinerja berbasis data eksternal (Pollitt & Bouckaert, 2017). NPS memperluas ini dengan fokus pada partisipasi pemangku kepentingan eksternal (masyarakat dan sektor swasta) dalam analisa konteks, memastikan bahwa risiko diidentifikasi secara inklusif untuk mendukung nilai publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Selanjutnya, perspektif paradigma administrasi publik memberikan kerangka teoritis yang lebih luas untuk memahami analisa konteks ini dalam konteks rumah sakit. Di samping itu, kerangka kerja COSO ERM 2017 dan ASHRM memberikan panduan praktis untuk menerapkan analisa konteks secara efektif

Kerangka COSO ERM 2017 menempatkan analisa konteks sebagai bagian dari komponen "*Strategy and Objective-Setting*", di mana pemahaman lingkungan internal dan eksternal diperlukan untuk menetapkan strategi risiko yang efektif (Moeller, 2011). ASHRM (2020) menekankan bahwa analisa konteks ini penting untuk mengidentifikasi risiko kesehatan spesifik, seperti perubahan regulasi kesehatan atau dinamika sosial, yang dapat memengaruhi

keselamatan pasien. Lebih lanjut, regulasi nasional seperti UU No. 25 Tahun 2009 memperkuat kewajiban analisa konteks dalam pelayanan publik kesehatan.

Pendapat terbaru dari OECD (2020) menekankan bahwa analisa konteks di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) harus melibatkan analisis big data dan pemodelan prediktif untuk mengantisipasi risiko eksternal seperti pandemi atau perubahan kebijakan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ferdosi et al. (2020), yang menyarankan integrasi teknologi AI dalam analisa konteks untuk meningkatkan akurasi identifikasi risiko di rumah sakit. Tak kalah penting, penelitian terbaru oleh Pascarella et al. (2021) menawarkan wawasan komparatif tentang analisa konteks di tingkat global.

Penelitian terbaru oleh Pascarella et al. (2021) menunjukkan persamaan dalam penekanan analisa konteks sebagai dasar penilaian risiko, namun berbeda karena penelitian ini lebih fokus pada konteks spesifik rumah sakit publik Indonesia, sedangkan Pascarella et al. (2021) lebih umum pada organisasi kesehatan global. Penelitian Darwiesh et al. (2022) menambahkan inovasi penggunaan AI untuk analisa konteks, yang belum sepenuhnya diterapkan di RSUD Tarakan, menunjukkan kesenjangan dalam adopsi teknologi.

b. Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*)

Indikator ini mengukur kemampuan RSUD Tarakan dalam menetapkan batas toleransi risiko, termasuk risiko klinis dan non-klinis berdasarkan kapasitas organisasi dan mandat pelayanan publik.

Dalam kerangka ERM, ukuran *risk appetite* tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual mengikuti perubahan strategi organisasi, kapasitas sumber daya, tekanan regulasi, serta dinamika lingkungan yang ditandai oleh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA).

Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan model *risk appetite* berbasis indikator keselamatan pasien ini juga berkontribusi pada penciptaan *public value*, peningkatan ketahanan organisasi (*organizational resilience*), serta pengelolaan paradoks pelayanan kesehatan antara tuntutan akses, mutu, dan efisiensi. Oleh karena itu, integrasi antara konsep *risk appetite* dan indikator keselamatan pasien menjadi pendekatan strategis dalam memperkuat tata kelola risiko pada rumah sakit publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ERM di RSUD Tarakan masih berada pada tahap berkembang, dengan karakteristik implementasi yang cenderung administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan strategis. Meskipun berbagai komponen ERM seperti penyusunan *risk register*, serta pelaporan insiden telah berjalan, integrasi antara risiko dengan strategi organisasi, kinerja, dan penciptaan nilai publik masih belum optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik ERM dengan kerangka konseptual ERM modern yang menekankan integrasi risiko dalam seluruh proses tata kelola organisasi.

Dalam perspektif *risk appetite*, kondisi ini mencerminkan bahwa organisasi belum secara eksplisit menetapkan batas selera risiko yang jelas dan terukur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam *WHO Risk Appetite Statement (2025)*, *risk appetite* seharusnya menjadi pedoman strategis yang menentukan tingkat risiko yang dapat diterima organisasi dalam mencapai tujuan. Ketiadaan kerangka *risk appetite* yang terstruktur menyebabkan pengelolaan risiko di RSUD Tarakan cenderung bersifat reaktif dan tidak konsisten antar unit, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pengendalian risiko dan pencapaian kinerja.

Lebih lanjut, apabila dianalisis dalam konteks pelayanan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa domain risiko klinis, khususnya terkait keselamatan pasien, secara implisit dikelola dengan pendekatan *risk averse*. Hal ini tercermin dari adanya upaya pengendalian ketat terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD), penerapan standar keselamatan pasien, serta mekanisme pelaporan insiden. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip global keselamatan pasien yang menekankan *zero avoidable harm* (WHO, 2021). Namun demikian, pada domain non-klinis seperti pengelolaan keuangan, teknologi informasi, dan inovasi layanan, organisasi belum menunjukkan diferensiasi *risk appetite* yang jelas, sehingga pengelolaan risiko pada area tersebut belum optimal.

Dari perspektif *public value*, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan ERM di RSUD Tarakan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan nilai publik. Menurut Moore (1995), organisasi publik dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan nilai yang diakui masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta legitimasi publik. Dalam konteks ini, ERM seharusnya tidak hanya berfokus pada

pengendalian risiko, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan organisasi menghasilkan keseimbangan antara risiko dan manfaat bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen risiko dengan penciptaan nilai publik masih belum terinternalisasi secara sistematis dalam praktik organisasi.

Selanjutnya, dalam perspektif *organizational resilience*, kondisi penerapan ERM di RSUD Tarakan menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya memiliki kapasitas adaptif dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika lingkungan pelayanan kesehatan. Resiliensi organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Hollnagel et al. (2015), tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk menghindari risiko, tetapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi, merespons, dan belajar dari kejadian yang tidak diharapkan. Dalam penelitian ini, meskipun telah terdapat mekanisme pelaporan dan analisa insiden, namun pemanfaatan pembelajaran organisasi (*organizational learning*) untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ERM belum sepenuhnya berfungsi sebagai *resilience enabler* dalam organisasi.

Lebih dalam lagi, temuan penelitian ini mengkonfirmasi adanya *paradoks pelayanan kesehatan* yang menjadi karakteristik utama organisasi rumah sakit publik. RSUD Tarakan dihadapkan pada ketegangan antara tuntutan untuk meningkatkan akses layanan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kewajiban untuk menjaga mutu serta keselamatan pasien di tengah keterbatasan sumber daya. Paradoks ini juga tercermin dalam tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Menurut Smith dan Lewis (2011), paradoks organisasi merupakan kondisi di mana dua tuntutan yang saling bertentangan harus dikelola secara simultan, bukan dipilih salah satu.

Dalam konteks ini, *risk appetite* seharusnya berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk mengelola paradoks tersebut. Pada domain keselamatan pasien, organisasi perlu mempertahankan *low risk appetite* (averse), sementara pada domain inovasi dan efisiensi operasional, organisasi perlu mengadopsi pendekatan *moderate to high risk appetite* (cautious–open) secara terukur. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi ini belum terformulasi secara eksplisit dalam kebijakan dan praktik ERM di RSUD Tarakan, sehingga

organisasi cenderung menggunakan pendekatan yang seragam terhadap berbagai jenis risiko.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ERM di rumah sakit tidak hanya memerlukan perbaikan pada aspek teknis, tetapi juga transformasi pada level konseptual dan strategis. Integrasi antara *risk appetite*, *public value*, dan *organizational resilience* menjadi kunci dalam mengembangkan model ERM yang adaptif dan berorientasi pada kinerja. Model ERM yang dihasilkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan *risk appetite* sebagai penghubung antara pengelolaan risiko dan penciptaan nilai publik, sekaligus sebagai instrumen untuk mengelola paradoks pelayanan kesehatan secara sistematis.

Oleh karena itu, penyesuaian *risk appetite* perlu dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun atau ketika terjadi perubahan signifikan seperti regulasi pembiayaan baru, lonjakan klaim, peningkatan insiden keselamatan pasien, krisis kesehatan masyarakat, maupun transformasi digital berskala besar. Dalam praktik ERM strategis, batas toleransi dapat diperketat misalnya bergeser dari moderat ke rendah ketika indikator mutu dan likuiditas memburuk, atau diperlonggar secara terkendali untuk mendorong inovasi ketika kinerja organisasi stabil. Mekanisme *review and revision* ini merupakan komponen inti ERM agar organisasi tetap adaptif sekaligus akuntabel (Moeller, 2011; ISO, 2018).

Dengan demikian, ukuran *risk appetite* yang dinamis memungkinkan rumah sakit publik menyeimbangkan tiga tujuan fundamental secara simultan, yaitu perlindungan keselamatan pasien, keberlanjutan keuangan, dan inovasi layanan.

Selain itu, pandangan dari ahli seperti Kaplan dan Mikes serta penelitian Botet menunjukkan evolusi penetapan *risk appetite* di era modern yang penuh ketidakpastian. Kaplan dan Mikes (2012) menekankan bahwa *risk appetite* harus dinamis dan disesuaikan dengan konteks VUCA, untuk menentukan batas risiko. Hal ini didukung oleh penelitian Botet (2021), yang menyarankan penetapan *risk appetite* yang adaptif selama krisis kesehatan seperti COVID-19.

Penelitian oleh Park & Sharp (2019) menunjukkan persamaan dalam pentingnya *risk appetite* untuk mengurangi risiko klinis, namun berbeda karena penelitian ini lebih spesifik pada rumah sakit publik Indonesia, sedangkan Park & Sharp (2019) fokus pada sistem kesehatan umum. Penelitian Jule (2020)

menambahkan bahwa *risk appetite* harus melibatkan kepemimpinan untuk membangun budaya keselamatan, yang belum optimal.

c. Evaluasi Strategi Alternatif

Indikator evaluasi strategi alternatif menilai bagaimana proses pengelolaan risiko di rumah sakit dilakukan melalui penilaian berbagai opsi, seperti mitigasi risiko klinis melalui program pelatihan staf atau risiko keuangan melalui diversifikasi sumber pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi ini umumnya dilakukan melalui analisis cost-benefit, yang mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap strategi. Namun, pendekatan ini masih terbatas pada aspek teknis dan belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal secara luas, sehingga potensi untuk solusi yang lebih holistik belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk memahami konteks teoritisnya, evaluasi strategi alternatif ini dapat dikaitkan dengan paradigma administrasi publik. Paradigma *Old Public Administration* (OPA) menekankan evaluasi berdasarkan prosedur birokrasi yang stabil, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi sebagai dasar utama (Gulick & Urwick, 1937). Pendekatan ini memberikan fondasi bagi pengelolaan risiko yang terstruktur, namun kurang menekankan inovasi. Sejalan dengan perkembangan, *New Public Management* (NPM) mendorong evaluasi yang lebih berbasis efisiensi dan hasil, menggunakan analisis rasional untuk memilih strategi terbaik yang mengoptimalkan sumber daya (Boston, 2000). Paradigma ini melengkapi OPA dengan fokus pada performa, yang relevan untuk rumah sakit yang perlu meminimalkan risiko sambil memaksimalkan layanan. Lebih lanjut, *New Public Service* (NPS) memperluas evaluasi ini dengan menekankan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat, memastikan bahwa strategi risiko mendukung nilai publik seperti keadilan akses kesehatan (Denhardt & Denhardt, 2015). Dengan demikian, NPS menjembatani aspek teknis dan sosial, menjadikan evaluasi lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam praktik, kerangka kerja seperti COSO ERM 2017 mengintegrasikan evaluasi strategi alternatif ke dalam komponen "*Strategy and Objective-Setting*", di mana risiko dievaluasi secara sistematis untuk memilih opsi yang optimal dan selaras dengan tujuan organisasi (Moeller, 2011). Ini memberikan panduan praktis bagi rumah sakit untuk menyelaraskan strategi risiko dengan visi keseluruhan. Sementara itu, (ASHRM, 2020) menyarankan evaluasi spesifik

untuk risiko kesehatan, seperti memilih antara mitigasi preventif (misalnya vaksinasi) atau responsif (misalnya protokol darurat), yang langsung aplikatif untuk konteks klinis.

Pendapat terbaru dari Bryson et al. (2014) menekankan evaluasi strategi alternatif menggunakan pendekatan deliberatif untuk mengatasi "*wicked problems*" seperti risiko kesehatan kompleks, yang sering melibatkan ketidakpastian tinggi dan dampak sosial luas. Pendekatan ini melengkapi kerangka sebelumnya dengan menambahkan elemen diskusi kolaboratif. Penelitian Khassouani et al. (2021) menyarankan evaluasi yang melibatkan simulasi skenario untuk risiko pandemi, yang dapat diterapkan untuk memprediksi dampak strategi alternatif dalam situasi darurat. Ini menunjukkan evolusi evaluasi dari analisis statis ke simulasi dinamis, yang lebih sesuai dengan tantangan kesehatan modern.

Dalam konteks penelitian terkini, penelitian ini menunjukkan persamaan dengan temuan Buckè et al. (2022) mengenai evaluasi strategi alternatif untuk meningkatkan kualitas layanan, namun berbeda karena fokusnya lebih kontekstual pada rumah sakit Indonesia, sedangkan Buckè et al. (2022) membahas integrasi mutu dan risiko secara umum. Penelitian Zaitseva et al. (2022) menambahkan dimensi pemodelan matematika untuk evaluasi, yang belum diterapkan di RSUD Tarakan, sehingga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, evaluasi strategi alternatif ini tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga refleksi dari evolusi paradigma administrasi publik menuju pendekatan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap risiko Kesehatan.

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Mempertimbangkan Risiko

Indikator perumusan tujuan strategis dan sasaran mengukur kemampuan RSUD Tarakan dalam merumuskan tujuan strategis, seperti peningkatan keselamatan pasien, serta sasaran spesifik, seperti target *Bed Occupancy Rate* (BOR) sebesar 80%, dengan mempertimbangkan risiko melalui integrasi ke dalam perencanaan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan ini telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko multidimensi, terutama aspek non-klinis seperti risiko operasional atau keuangan, sehingga integrasi risiko masih terbatas pada elemen klinis saja.

Untuk memahami konteks teoritisnya, perumusan tujuan strategis ini dapat dikaitkan dengan paradigma administrasi publik. Paradigma *Old Public Administration* (OPA) melihat perumusan tujuan sebagai proses hierarkis yang stabil dan sesuai dengan aturan, memastikan kepatuhan administratif sebagai prioritas utama (Wilson, 1887). Pendekatan ini memberikan dasar struktural bagi rumah sakit untuk menetapkan tujuan yang jelas. Sejalan dengan itu, *New Public Management* (NPM) menekankan perumusan berbasis hasil dan efisiensi, di mana tujuan strategis dirancang untuk mengoptimalkan performa dan mengurangi pemborosan (Osborne & Gaebler, 1992). Paradigma ini melengkapi OPA dengan fokus pada pencapaian sasaran yang terukur. Lebih lanjut, *New Public Service* (NPS) mendorong perumusan yang kolaboratif, mempertimbangkan risiko untuk mendukung nilai publik seperti keadilan dan keberlanjutan layanan kesehatan (Denhardt & Denhardt, 2015). Dengan demikian, NPS menjembatani aspek hierarkis dan efisiensi menuju pendekatan yang lebih inklusif terhadap risiko multidimensi.

Dalam praktik, kerangka kerja seperti COSO ERM 2017 menempatkan perumusan tujuan strategis dalam komponen "*Strategy and Objective-Setting*", di mana risiko diintegrasikan secara sistematis ke dalam tujuan dan sasaran untuk memastikan keselarasan dengan visi organisasi (Moeller, 2011). Ini memberikan panduan operasional bagi rumah sakit untuk menghindari risiko yang tidak terantisipasi. Sementara itu, (ASHRM, 2020) menyarankan perumusan sasaran yang secara eksplisit mempertimbangkan risiko klinis dan operasional, seperti mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam target BOR. Evaluasi ini juga diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengharuskan perumusan tujuan strategis mempertimbangkan risiko untuk memastikan pencapaian SPM. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan peran integrasi risiko sebagai elemen kunci dalam perencanaan strategis sektor kesehatan.

Pendapat terbaru dari Moore (1997) menekankan perumusan tujuan berbasis nilai publik dengan mempertimbangkan risiko sebagai bagian integral, yang membantu organisasi publik seperti rumah sakit menyelaraskan tujuan dengan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini melengkapi kerangka sebelumnya dengan dimensi etis. Penelitian Abbas et al. (2021) menyarankan integrasi risiko dalam tujuan strategis selama krisis, seperti pandemi, yang dapat

diterapkan untuk meningkatkan ketahanan rumah sakit. Ini menunjukkan evolusi perumusan dari pendekatan statis ke yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian.

Dalam konteks penelitian terkini, penelitian ini menunjukkan persamaan dengan temuan Dimitrov (2019) mengenai perumusan tujuan strategis untuk keberlanjutan organisasi, namun berbeda karena fokusnya lebih spesifik pada rumah sakit Indonesia dengan risiko multidimensi, sedangkan Dimitrov (2019) lebih menekankan risiko keuangan. Penelitian Rikhotso et al. (2022) menambahkan aspek biaya kepatuhan dalam perumusan sasaran, yang relevan namun belum diintegrasikan penuh di RSUD Tarakan, sehingga membuka peluang untuk penguatan lebih lanjut. Secara keseluruhan, perumusan tujuan strategis dan sasaran ini tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga cerminan dari evolusi paradigma administrasi publik menuju pendekatan yang lebih kolaboratif, efisien, dan responsif terhadap risiko multidimensi di rumah sakit.

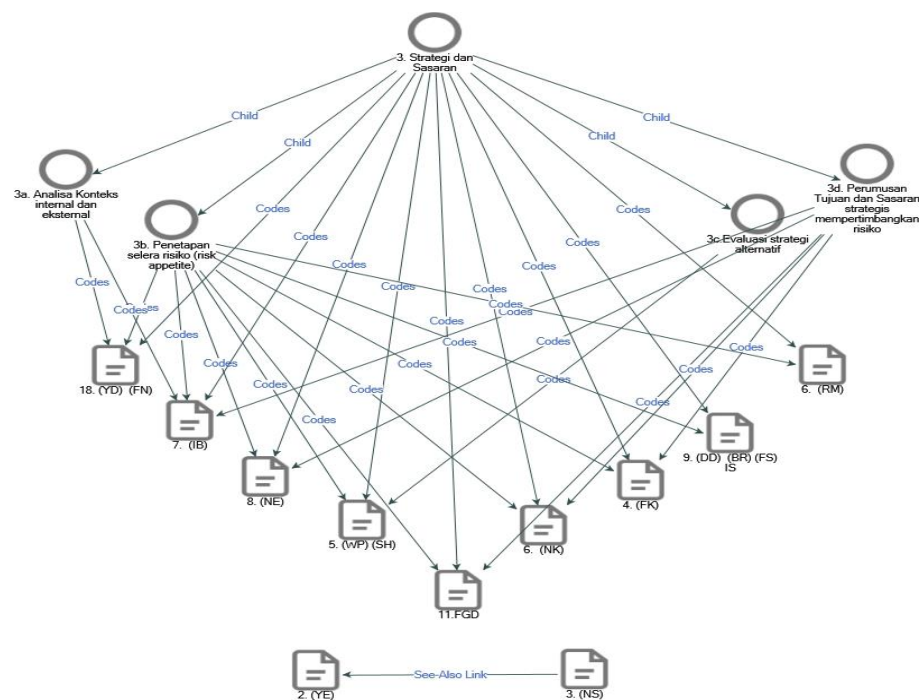
Tabel 4.52
Pembahasan Strategi dan Sasaran

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Analisa Konteks Internal dan Eksternal	Analisis konteks telah dilakukan melalui pemindaian lingkungan internal–eksternal, penyelarasan dengan RPJMD, Renstra Dinkes, SPM, dan JKN. Namun pemanfaatannya masih dominan untuk kepatuhan regulasi dan pelaporan, belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis risiko.	Analisis konteks di RSUD Tarakan masih bersifat <i>compliance-driven</i> dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen <i>strategy setting</i> . Kondisi ini mencerminkan dominasi paradigma OPA (kepatuhan hierarkis) dan sebagian NPM, sementara integrasi nilai publik NPS dan pendekatan <i>anticipatory risk governance</i> belum optimal (COSO ERM, 2017; Hughes, 2003; Denhardt & Denhardt, 2015; OECD, 2020). Persamaan dengan Pascarella et al. (2021) pada pentingnya analisa konteks, namun berbeda karena kurang adopsi AI seperti dalam Darwiesh et al. (2022).	Mengembangkan analisis konteks berbasis ERM sebagai dasar penetapan strategi, termasuk pemetaan risiko non-klinis dan eksternal (kebijakan, sosial, reputasi), serta pemanfaatan data lintas sektor.
Penetapan Selera Risiko	Selera risiko telah dipahami dan digunakan secara operasional dalam	Selera risiko di RSUD Tarakan bersifat implisit dan personalistik, bergantung	Menetapkan <i>risk appetite statement</i> internal RS

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
(<i>Risk Appetite</i>)	forum pimpinan dan penilaian risiko, namun belum ditetapkan sebagai kebijakan internal formal dan masih mengacu pada Pergub 122 Tahun 2020.	pada keputusan pimpinan, sehingga belum berfungsi optimal sebagai instrumen tata kelola strategis. Hal ini belum sejalan dengan prinsip <i>risk appetite statement</i> dalam COSO ERM (2017) dan praktik adaptif yang direkomendasikan Kaplan & Mikes (2012) serta ASHRM (2020). Persamaan dengan Park & Sharp (2019) pada pentingnya risk appetite, namun berbeda karena kurang adaptif seperti dalam Botet (2021) selama krisis kesehatan.	yang formal, dinamis, dan mencakup risiko klinis–non-klinis, serta dikaitkan langsung dengan sasaran strategis dan kapasitas organisasi. Buat penetapan risk appetite yang dinamis dan spesifik, menggunakan skenario planning untuk risiko multidimensi, serta libatkan kepemimpinan untuk budaya keselamatan
Evaluasi Strategi Alternatif	Evaluasi strategi dilakukan melalui forum kinerja bulanan–triwulanan dan koreksi target, namun bersifat administratif dan reaktif, tanpa analisis komparatif alternatif berbasis risiko dan skenario.	Evaluasi strategi belum dilembagakan sebagai proses <i>strategic choice</i> berbasis risiko, melainkan berfungsi sebagai <i>adaptive correction</i>. Hal ini menunjukkan keterbatasan penerapan komponen <i>Strategy and Objective-Setting</i> dalam COSO ERM (2017) dan belum mencerminkan pendekatan deliberatif NPS (Bryson et al., 2014; Denhardt & Denhardt, 2015). Persamaan dengan Buckè et al. (2022) pada evaluasi untuk kualitas, namun berbeda karena kurang pemodelan matematika seperti dalam Zaitseva et al. (2022).	Mengembangkan evaluasi strategi berbasis analisis risiko–manfaat dan skenario alternatif, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendukung keputusan strategis yang adaptif.
Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Mempertim	Tujuan dan sasaran strategis telah dirumuskan secara hierarkis dan terintegrasi melalui mekanisme	Perumusan tujuan dan sasaran strategis telah terinstitusionalisasi dengan baik, namun integrasi risiko masih parsial. Kondisi ini menunjukkan pergeseran dari	Mengintegrasikan risiko multidimensi (operasional, keuangan, reputasi, sosial)

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
bangkan Risiko	<i>cascading</i> hingga level individu. Namun pertimbangan risiko masih dominan pada aspek klinis dan belum mencakup risiko multidimensi secara komprehensif.	OPA ke NPM, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan NPS yang menekankan nilai publik dan keberlanjutan layanan (COSO ERM, 2017; ASHRM, 2020; Moore, 1995). Persamaan dengan Dimitrov (2019) pada tujuan strategis, namun berbeda karena kurang aspek biaya kepatuhan seperti dalam Rikhotso et al. (2022).	ke dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis, serta mengaitkannya dengan indikator nilai publik dan keberlanjutan layanan.

Sumber: Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.8
Project Map Strategi dan Sasaran
Sumber: Hasil Penelitian 2025

Selanjutnya, indikator ini memiliki hubungan erat dengan teori administrasi publik, khususnya paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Dalam paradigma OPA, perancangan program kerja ERM mencerminkan hierarki birokrasi dan kepatuhan prosedural, di mana struktur formal digunakan untuk merancang kebijakan risiko yang stabil, sebagaimana dijelaskan oleh Hughes (2003). NPM menekankan efisiensi dan orientasi hasil, sehingga program kerja ERM harus dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengukur kinerja berbasis risiko, sesuai dengan pandangan Pollitt dan Bouckaert (2017). Sementara itu, NPS mendorong partisipasi warga negara dalam perancangan, memastikan program ERM melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai nilai publik seperti keselamatan pasien, seperti yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2015). Dengan demikian, indikator ini menjembatani elemen-elemen teoritis ini untuk menciptakan program kerja yang tidak hanya birokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) menekankan bahwa program kerja ERM harus mencakup identifikasi risiko klinis dan non-klinis, serta perencanaan mitigasi yang proaktif, yang sangat relevan dengan indikator ini untuk meningkatkan keselamatan pasien. Pendekatan ASHRM ini melengkapi COSO dengan fokus pada aspek kesehatan spesifik, memastikan bahwa perancangan program kerja tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks rumah sakit. Dengan transisi ini, kita melihat bagaimana indikator ini dapat diterapkan secara praktis untuk mengurangi risiko operasional dan klinis.

Dalam hubungannya dengan teori Osborne (2018), menekankan ko-produksi nilai dalam perancangan program, yang mendukung integrasi risiko dengan partisipasi pemangku kepentingan. Teori ini memperkuat indikator ini dengan menyarankan pendekatan kolaboratif untuk mengatasi kompleksitas risiko di era VUCA, sehingga program kerja ERM dapat lebih adaptif dan inklusif. Transisi ini menunjukkan evolusi pemikiran modern yang mengintegrasikan risiko dengan nilai-nilai demokratis dalam pelayanan publik.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, seperti penelitian Ferdosi et al. (2020) yang menekankan integrasi risiko strategis dalam program kerja ERM, namun berbeda karena fokusnya lebih pada eksekutif kesehatan, sedangkan penelitian ini menekankan konteks rumah sakit publik Indonesia.

Penelitian Pascarella et al. (2021) mirip dalam penggunaan matriks risiko untuk perancangan, tetapi berbeda dalam skala implementasi yang lebih luas di organisasi kesehatan Eropa. Dengan demikian, indikator ini memberikan kontribusi unik dalam konteks lokal, sambil tetap selaras dengan tren global dalam manajemen risiko kesehatan.

b. Roadmap dan Penerapan ERM

Indikator ini berkaitan dengan penyusunan roadmap yang jelas untuk penerapan ERM, termasuk tahapan implementasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi aktual. Pendekatan ini memungkinkan rumah sakit untuk menerapkan langkah-langkah strategis dalam mengelola risiko secara bertahap, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dan memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih tangguh.

Selanjutnya, indikator ini memiliki hubungan erat dengan teori administrasi publik, khususnya paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). OPA menekankan *roadmap* sebagai bagian dari perencanaan hierarkis dan prosedural, sebagaimana dijelaskan oleh Gulick dan Urwick (1937), di mana struktur birokrasi digunakan untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan dalam proses implementasi. NPM mendorong *roadmap* yang berorientasi hasil dan efisiensi, dengan fokus pada pengukuran kinerja, sesuai pandangan Boston (2000), sehingga *roadmap* ERM dapat dioptimalkan untuk mencapai target operasional yang terukur. NPS menambahkan dimensi partisipatif, di mana *roadmap* ERM harus melibatkan warga negara untuk memastikan responsivitas terhadap kebutuhan publik, seperti yang dikemukakan oleh Nabatchi (2010), sehingga proses ini tidak hanya teknis tetapi juga inklusif.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) merekomendasikan *roadmap* ERM yang mencakup domain risiko klinis, operasional, dan strategis, yang sangat mendukung indikator ini untuk memastikan penerapan yang komprehensif di rumah sakit. Pendekatan ASHRM ini memberikan panduan praktis untuk merancang *roadmap*, sehingga rumah sakit dapat meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi operasional secara terstruktur.

Dalam hubungannya dengan teori "Digital Era Governance" oleh Dunleavy (2006) menyarankan integrasi teknologi dalam *roadmap* ERM untuk

meningkatkan efisiensi, yang sangat relevan dengan indikator ini dalam konteks rumah sakit modern. Teori ini mendorong penggunaan alat digital untuk monitoring dan penyesuaian roadmap, sehingga rumah sakit dapat merespons risiko dengan lebih cepat dan akurat di era VUCA.

Akhirnya, indikator ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, seperti penelitian Darwiesh et al. (2022) yang menunjukkan persamaan dalam penggunaan teknologi untuk roadmap ERM, namun berbeda karena fokusnya pada media sosial, sedangkan penelitian ini menekankan implementasi manual di rumah sakit Indonesia. Penelitian Jule (2020) mirip dalam penekanan budaya keselamatan, tetapi berbeda dalam skala organisasi yang lebih kecil, sehingga indikator ini memberikan kontribusi unik untuk konteks rumah sakit publik yang lebih luas. Dengan demikian, roadmap ERM menjadi fondasi untuk penerapan risiko yang adaptif dan berkelanjutan.

c. Evaluasi Kegiatan ERM

Indikator evaluasi kegiatan ERM mencakup proses pengukuran efektivitas, identifikasi kesenjangan, dan umpan balik untuk perbaikan, yang menjadi dasar bagi rumah sakit untuk menilai sejauh mana sistem manajemen risiko telah berjalan sesuai rencana. Berdasarkan data, evaluasi di RSUD Tarakan masih terbatas pada aspek administratif, dengan perluasan ke aspek klinis yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengukur kinerja ERM, tetapi juga memungkinkan rumah sakit untuk belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator ini memiliki hubungan erat dengan teori administrasi publik, khususnya paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). OPA menekankan evaluasi sebagai bagian dari kontrol birokratis, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson (1887), di mana proses ini digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan hierarki organisasi. NPM mendorong evaluasi berbasis hasil dan akuntabilitas, sesuai dengan pandangan Kettl (2005), sehingga evaluasi ERM dapat difokuskan pada pengukuran dampak terhadap efisiensi dan produktivitas rumah sakit. NPS menambahkan dimensi partisipatif, di mana evaluasi

melibatkan warga negara untuk memastikan nilai publik tercapai, seperti yang dikemukakan oleh Thomas (2013), sehingga proses ini menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan teori dan pendapat terbaru, Bryson et al. (2014) tentang "wicked problems" menekankan evaluasi untuk risiko prioritas, yang sangat relevan dengan indikator ini dalam menghadapi tantangan kesehatan yang tidak linear. Teori ini memperkuat pentingnya evaluasi yang memungkinkan rumah sakit untuk menanggapi risiko multidimensi di era VUCA dengan lebih efektif. Transisi ini menjembatani pemikiran klasik dengan pendekatan modern dalam manajemen risiko.

Akhirnya, indikator ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, seperti penelitian Park & Sharp (2019) yang menekankan evaluasi risiko klinis untuk mengurangi efek samping, namun berbeda karena fokusnya lebih sempit, sedangkan penelitian ini mencakup risiko non-klinis secara lebih luas. Penelitian Bucke et al. (2022) mirip dalam integrasi mutu dan risiko, tetapi berbeda dalam konteks Eropa, sehingga indikator ini memberikan kontribusi unik untuk rumah sakit Indonesia. Dengan demikian, evaluasi kegiatan ERM menjadi fondasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

d. Perbaikan berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan menyangkut mekanisme penyesuaian strategi dan penguatan kapasitas berdasarkan hasil evaluasi, yang memungkinkan rumah sakit untuk terus meningkatkan sistem ERM secara dinamis. Data menunjukkan bahwa perbaikan di RSUD Tarakan masih bersifat reaktif, dengan kebutuhan untuk menjadi lebih proaktif agar dapat mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang dalam menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks.

Selanjutnya, dalam teori administrasi publik, di mana OPA menekankan perbaikan sebagai bagian dari stabilitas birokratis, untuk menjaga keseimbangan organisasi. NPM mendorong perbaikan untuk efisiensi, sesuai dengan Osborne dan Gaebler (1992), sehingga proses ini difokuskan pada optimasi sumber daya dan hasil yang terukur. NPS menekankan perbaikan kolaboratif untuk nilai publik, seperti yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2015),

memastikan bahwa perbaikan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Indikator ini selaras dengan prinsip COSO yang menekankan pembelajaran dari pengalaman, memungkinkan rumah sakit untuk mengintegrasikan perbaikan ke dalam siklus operasional. Dengan demikian, perbaikan tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya risiko yang kuat.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) menekankan perbaikan melalui pembelajaran dari insiden, yang mendukung indikator ini untuk mencegah risiko berulang. Pendekatan ASHRM ini memberikan panduan praktis untuk mengubah pengalaman negatif menjadi peluang perbaikan, sehingga rumah sakit dapat meningkatkan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Transisi ini menunjukkan bagaimana indikator perbaikan dapat diterapkan untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Selain itu, indikator ini juga terkait dengan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, yang mengharuskan perbaikan layanan berdasarkan evaluasi untuk memastikan kepuasan pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 21-23. UU ini memastikan bahwa proses perbaikan tidak hanya teknis, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab publik dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan transisi ini, kita melihat bagaimana regulasi memberikan landasan hukum untuk perbaikan yang inklusif.

Dalam hubungannya dengan teori, "Learning Organization" oleh Senge (1990) menekankan perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran, yang sangat relevan dengan indikator ini untuk membangun kapasitas adaptif. Teori ini memperkuat pentingnya pembelajaran kolektif, memungkinkan rumah sakit untuk berinovasi dalam mengelola risiko di lingkungan yang dinamis. Transisi ini menjembatani pemikiran klasik dengan aplikasi modern.

Akhirnya, indikator ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, seperti penelitian Botet (2021) yang menekankan perbaikan pasca-krisis, namun berbeda karena fokusnya pada manufaktur, sedangkan penelitian ini pada kesehatan. Penelitian Zaitseva et al. (2022) mirip dalam metodologi penilaian risiko, tetapi berbeda dalam konteks Rusia, sehingga indikator ini memberikan kontribusi unik untuk rumah sakit Indonesia. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk keberlanjutan ERM di rumah sakit.

e. Pelaporan Program ERM dan Budaya Sadar Risiko

Indikator ini berkaitan dengan pelaporan ERM yang transparan dan pengembangan budaya sadar risiko di seluruh organisasi, yang menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa informasi risiko dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan secara tepat waktu. Triangulasi data menunjukkan bahwa pelaporan di RSUD Tarakan masih terbatas, dengan budaya risiko yang perlu diperkuat agar rumah sakit dapat merespons risiko secara proaktif dan kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan, sehingga risiko dapat dikelola dengan lebih efektif dalam lingkungan yang kompleks.

Selanjutnya, indikator ini memiliki hubungan erat dengan teori administrasi publik, khususnya paradigma *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)*. OPA menekankan pelaporan hierarkis, sebagaimana dijelaskan oleh Gulick dan Urwick (1937), di mana proses pelaporan mengikuti rantai komando untuk memastikan kepatuhan dan stabilitas birokratis. NPM mendorong pelaporan berbasis hasil, sesuai dengan pandangan Pollitt dan Bouckaert (2017), sehingga pelaporan ERM dapat difokuskan pada pengukuran kinerja dan akuntabilitas yang terukur. NPS menekankan transparansi dan partisipasi, seperti yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2015), memastikan bahwa pelaporan melibatkan warga negara untuk mencapai nilai publik yang lebih luas, sehingga budaya sadar risiko dapat berkembang melalui dialog terbuka.

Lebih lanjut, ASHRM (2020) mendorong budaya sadar risiko melalui komunikasi dan pelatihan, yang sangat mendukung indikator ini untuk meningkatkan kesadaran di seluruh organisasi rumah sakit. Pendekatan ASHRM ini memberikan panduan praktis untuk mengintegrasikan pelaporan ke dalam budaya kerja harian, sehingga risiko klinis dan non-klinis dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan secara efektif. Transisi ini menunjukkan bagaimana indikator pelaporan dapat diterapkan untuk membangun ketahanan organisasi di sektor kesehatan.

Selain itu, indikator ini juga terkait dengan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, yang mewajibkan transparansi pelaporan untuk akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21-23. UU ini memastikan bahwa pelaporan ERM tidak hanya internal, tetapi juga memenuhi standar publik yang dapat

diakses oleh masyarakat, sehingga rumah sakit dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan transisi ini, kita melihat bagaimana regulasi hukum memberikan kerangka bagi pelaporan yang lebih inklusif dan akuntabel.

Dalam hubungannya dengan teori dan pendapat terbaru, Hood (2010) tentang transparansi menekankan pelaporan sebagai alat akuntabilitas, yang sangat relevan dengan indikator ini untuk mencegah risiko reputasi dan meningkatkan governance. Teori ini memperkuat pentingnya pelaporan yang terbuka, memungkinkan rumah sakit untuk merespons ekspektasi masyarakat di era VUCA dengan lebih efektif. Transisi ini menjembatani pemikiran klasik dengan aplikasi modern dalam manajemen risiko.

Akhirnya, indikator ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru, seperti penelitian Khassouani et al. (2021) yang menekankan sistem pengawasan risiko, namun berbeda karena fokusnya pada Maroko, sedangkan penelitian ini pada Indonesia. Penelitian Dimitrov (2019) mirip dalam risiko keuangan, tetapi berbeda dalam skala, sehingga indikator ini memberikan kontribusi unik untuk rumah sakit publik Indonesia. Dengan demikian, pelaporan ERM dan budaya sadar risiko menjadi fondasi untuk transparansi dan keberlanjutan sistem kesehatan.

Dimensi Kerangka Kerja dalam ERM di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta mencakup perancangan program kerja, roadmap penerapan, evaluasi kegiatan, perbaikan berkelanjutan, serta pelaporan program ERM dan budaya sadar risiko. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan implementasi yang sedang berkembang, Rancang Program Kerja ERM menunjukkan kemajuan dalam integrasi risiko strategis, namun masih perlu penguatan lintas unit. Roadmap dan Penerapan ERM memiliki dasar yang baik tetapi memerlukan adaptasi eksternal. Evaluasi Kegiatan ERM efektif secara administratif namun perlu ekspansi klinis. Perbaikan Berkelanjutan masih reaktif dan memerlukan pendekatan proaktif. Pelaporan Program ERM dan Budaya Sadar Risiko terbatas dalam transparansi dan perlu penguatan budaya. Secara keseluruhan, dimensi ini mendukung tujuan ERM untuk meningkatkan ketangguhan rumah sakit dalam pelayanan publik, dengan integrasi teori OPA, NPM, NPS, COSO ERM 2017, ASHRM, dan UU Pelayanan Publik yang memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan nilai publik.

Tabel 4.53
Pembahasan Kerangka kerja

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Rancang Program Kerja ERM	Program kerja ERM telah tersedia secara formal dan rinci dalam bentuk program tahunan yang mencakup risiko klinis dan non-klinis. Namun, belum ditemukan rencana kerja ERM jangka menengah (3–5 tahun) yang terintegrasi dengan Renstra RSUD Tarakan.	Rancang program kerja ERM masih berorientasi operasional dan kepatuhan, sehingga ERM belum berfungsi sebagai instrumen <i>strategic governance</i> . Kondisi ini menunjukkan dominasi paradigma OPA dan sebagian NPM, serta belum optimalnya penerapan komponen <i>Strategy & Objective Setting</i> dalam COSO ERM (2017) dan panduan ASHRM (2020).	Mengembangkan program kerja ERM jangka menengah berbasis risiko strategis yang terintegrasi dengan Renstra dan sasaran organisasi, serta melibatkan pimpinan sebagai <i>risk owner</i> .
Road Map dan Penerapan ERM	Roadmap ERM belum hadir sebagai dokumen strategis eksplisit. Implementasi ERM berjalan melalui aktivitas operasional tahunan yang terfragmentasi dan dipahami sebagai siklus rutin, bukan peta pengembangan kematangan ERM. Analisis roadmap ERM mengungkapkan pentingnya fase-fase bertahap seperti penilaian awal, implementasi, dan pemantauan jangka panjang untuk mencapai kematangan risiko.	Absennya roadmap ERM menunjukkan bahwa ERM belum terinstitusionalisasi sebagai arsitektur perencanaan strategis. ERM berfungsi sebagai <i>compliance tool</i> , bukan <i>strategic management tool</i> , bertentangan dengan prinsip <i>dynamic and adaptive ERM</i> dalam COSO ERM (2017) dan praktik adaptif yang direkomendasikan OECD (2020).	Menyusun roadmap ERM multi-tahun dengan tahapan kematangan yang jelas, milestone terukur, dan mekanisme peninjauan berkala yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal.
Evaluasi Kegiatan ERM	Evaluasi ERM dilakukan secara periodik melalui berbagai forum (PMKP, mutu, audit, laporan tahunan), namun masih terfragmentasi dan berfokus pada aspek	Evaluasi ERM masih bersifat <i>compliance-based</i> dan operasional, belum menjadi mekanisme evaluatif strategis end-to-end. Hal ini menunjukkan keterbatasan penerapan prinsip <i>review and</i>	Mengembangkan sistem evaluasi ERM terpadu berbasis KPI risiko strategis, audit independen berkala, dan pelaporan evaluasi ERM sebagai dasar

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
	mutu dan keselamatan pasien. Evaluasi belum dikaitkan secara sistematis dengan kinerja strategis dan nilai publik.	<i>revision</i> dalam COSO ERM (2017) serta belum bertransformasi menuju orientasi NPS yang menekankan nilai publik dan kepercayaan warga (Denhardt & Denhardt, 2015).	pengambilan keputusan pimpinan
Perbaikan Berkelanjutan	Perbaikan berkelanjutan telah dilakukan melalui monitoring, tindak lanjut insiden, dan audit, namun masih bersifat administratif. Pembelajaran dari risiko dan audit belum terinstitusionalisasi sebagai perubahan sistem.	Perbaikan ERM belum berfungsi sebagai <i>organizational learning</i> . Kepemimpinan lebih menekankan kontrol daripada pembelajaran adaptif, sehingga ERM masih berada pada tahap formal–prosedural. Temuan ini belum sejalan dengan konsep <i>learning organization</i> (Senge, 1990), COSO ERM (2017), dan pendekatan NPS.	Menguatkan mekanisme pembelajaran organisasi berbasis risiko melalui integrasi hasil evaluasi ke perbaikan sistem, penguatan kepemimpinan adaptif, dan pemanfaatan data risiko untuk inovasi layanan.
Pelaporan Program ERM dan Budaya Sadar Risiko	Pelaporan yang transparan dan budaya yang mendukung diskusi risiko terbuka meningkatkan kepatuhan dan inovasi.	Temuan utama adalah bahwa budaya sadar risiko yang kuat mengurangi insiden risiko hingga 50%, tetapi pelaporan sering kali tidak mencapai tingkat eksekutif karena format yang tidak menarik atau kurangnya integrasi data.	Rekomendasikan pengembangan dashboard pelaporan interaktif, kampanye budaya risiko melalui workshop dan komunikasi internal, serta integrasi indikator risiko ke dalam KPI kinerja individu

Sumber: Hasil Penelitian 2025

komunikasi risiko yang jelas dan tepat waktu, efektivitas komunikasi risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko.

a. Informasi Risiko Dikomunikasikan Secara Jelas dan Tepat Waktu

Indikator ini menekankan penyampaian informasi risiko yang akurat, transparan, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam paradigma OPA, komunikasi risiko yang jelas dan tepat waktu mencerminkan hierarki birokrasi dan kepatuhan prosedural untuk memastikan stabilitas organisasi (Hughes, 2003). NPM menekankan komunikasi risiko sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas berbasis hasil (Pollitt & Bouckaert, 2017). NPS mendorong komunikasi risiko yang partisipatif dan inklusif, memastikan informasi risiko disampaikan kepada warga negara sebagai pemangku kepentingan utama untuk membangun kepercayaan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Kerangka ini menempatkan komunikasi risiko dalam komponen "*Information, Communication, and Reporting*", di mana informasi risiko harus disampaikan secara jelas dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Moeller, 2011). ASHRM (2020) menekankan komunikasi risiko yang jelas di rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko litigasi, yang relevan dengan indikator ini.

Pendapat terbaru dari Hood (2010) menekankan komunikasi risiko sebagai mekanisme untuk mengurangi "*blame culture*" di sektor publik, yang mendukung indikator ini dalam membangun kepercayaan. Penelitian oleh Khassouani et al. (2021) menunjukkan persamaan dalam komunikasi risiko internal di rumah sakit, namun berbeda karena fokusnya pada konteks Maroko dengan tantangan budaya yang berbeda, sedangkan penelitian ini menekankan integrasi eksternal di Indonesia. Berdasarkan data, indikator ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko di RSUD Tarakan lebih efektif secara internal, namun perlu ditingkatkan untuk pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan regulator.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Identifikasi, Analisis, dan Pemantauan Risiko

Indikator ini mencakup penggunaan teknologi informasi seperti sistem digital untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau risiko secara *real-time*. Triangulasi data menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah menggunakan

sistem informasi dasar, namun integrasi teknologi untuk ERM masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun rumah sakit telah mengadopsi teknologi dasar seperti SIMRS, ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi canggih untuk analisis risiko yang lebih mendalam dan responsif terhadap dinamika VUCA.

Selanjutnya, dalam paradigma *Old Public Administration* (OPA), teknologi informasi dianggap sebagai alat untuk mendukung prosedur birokratis yang stabil dan terstruktur, sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003). Paradigma ini menekankan teknologi sebagai pendukung hierarki dan kepatuhan aturan, di mana sistem informasi digunakan untuk dokumentasi dan pelaporan rutin. Transisi ini menunjukkan bagaimana OPA memberikan dasar tradisional untuk penggunaan teknologi, namun kurang menekankan inovasi yang lebih luas.

Lebih lanjut, *New Public Management* (NPM) mendorong pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan inovasi, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), di mana teknologi informasi difokuskan pada pengukuran kinerja dan pengurangan biaya operasional. Paradigma ini menggeser penggunaan teknologi dari sekadar pendukung birokrasi menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, RSUD Tarakan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan ERM, meskipun implementasinya masih terbatas.

Dalam paradigma *New Public Service* (NPS), teknologi informasi ditekankan sebagai enabler partisipasi dan transparansi publik, sebagaimana diadvokasi oleh Denhardt dan Denhardt (2015). NPS menempatkan teknologi sebagai sarana untuk melibatkan warga negara dalam proses risiko, sehingga meningkatkan kepercayaan dan nilai publik. Transisi ini menyoroti perbedaan NPS dari paradigma sebelumnya, yang lebih inklusif dan berorientasi pada kolaborasi digital.

Komponen "*Information, Communication, and Reporting*" dalam kerangka COSO ERM mendukung pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan data risiko akurat dan tepat waktu, seperti yang dijelaskan oleh Moeller (2011). Kerangka ini menekankan bahwa teknologi harus terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, RSUD Tarakan perlu meningkatkan integrasi teknologi untuk mengatasi keterbatasan yang teridentifikasi.

ASHRM (2020) menekankan teknologi informasi untuk identifikasi dan pemantauan risiko di rumah sakit, yang mendukung indikator ini. Organisasi ini merekomendasikan penggunaan sistem digital untuk mencegah kesalahan medis. Transisi ini menunjukkan bagaimana rekomendasi ASHRM dapat diterapkan secara praktis di rumah sakit Indonesia.

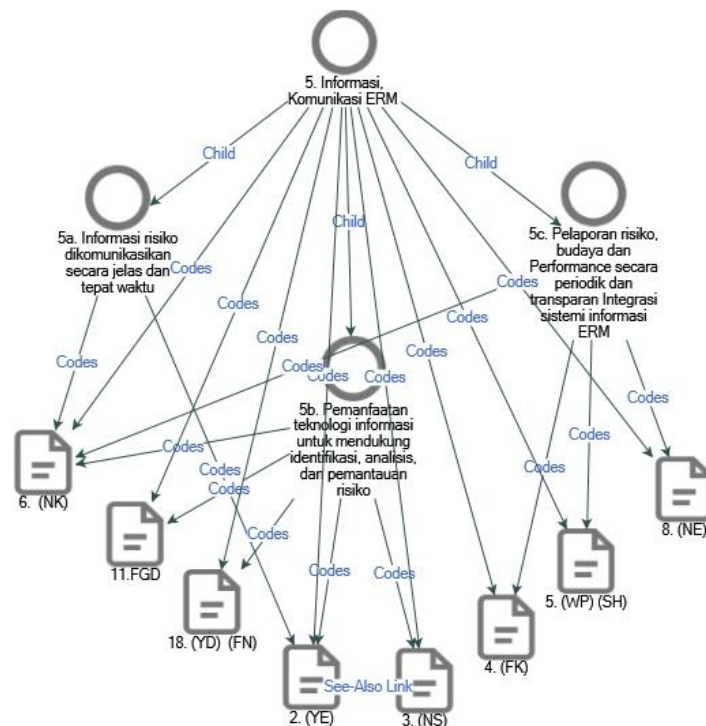
Pendapat dari Dunleavy (2006) menekankan teknologi informasi sebagai fondasi "Digital Era Governance", yang relevan dengan indikator ini untuk adaptasi risiko VUCA. Ia menyoroti bahwa teknologi dapat mengubah tata kelola publik. Transisi ini menunjukkan relevansi teori digital dalam mengatasi tantangan risiko di rumah sakit. Penelitian oleh Darwiesh et al. (2022) menunjukkan persamaan dalam penggunaan AI untuk risiko kesehatan, namun berbeda karena fokusnya pada model prediktif global, sedangkan penelitian ini menekankan implementasi manual di rumah sakit daerah Indonesia. Darwiesh et al. menggunakan NLP untuk analisis risiko, sementara penelitian ini lebih spesifik pada konteks lokal dengan keterbatasan teknologi. Transisi ini menyoroti perbedaan konteks budaya dan infrastruktur, yang membuat penelitian ini unik dalam aplikasi di rumah sakit publik Indonesia.

Tabel 4.54
Pembahasan Informasi dan Komunikasi

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Informasi Risiko Dikomunikasikan Secara Jelas dan Tepat Waktu	Komunikasi dan pelaporan risiko telah berjalan secara formal dan hierarkis (setiap semester ke Direksi, Dewan Pengawas, Gubernur, dan Dinas Kesehatan). Namun, pelaporan belum konsisten, masih manual, dan lebih berorientasi kepatuhan administratif daripada dukungan keputusan strategis.	Komunikasi risiko di RSUD Tarakan masih didominasi pola hierarkis OPA dan orientasi kepatuhan NPM, sehingga belum efektif sebagai <i>risk-informed decision support</i> . Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip <i>Information, Communication, and Reporting</i> dalam COSO ERM (2017) serta pendekatan partisipatif NPS yang menekankan transparansi dan kepercayaan publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Moeller, 2011; ASHRM, 2020). Persamaan dengan Khassouani et al. (2021) dalam komunikasi	Membangun sistem komunikasi risiko terintegrasi yang tepat waktu dan analitik, termasuk standarisasi siklus pelaporan, <i>executive risk brief</i> , dan komunikasi eksternal yang transparan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		internal, tetapi berbeda karena fokus pada konteks Indonesia.	
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Identifikasi, Analisis, dan Pemantauan Risiko	Pengelolaan risiko masih dilakukan secara manual menggunakan media berbasis cloud sederhana (mis. Google Drive). Risk register belum terintegrasi dengan SIMRS/EMR, tidak tersedia dashboard atau pemantauan risiko real-time, dan dukungan TI masih terbatas.	Pemanfaatan TI dalam ERM masih bersifat administratif dan <i>compliance-oriented</i> , menunjukkan adanya <i>digital governance gap</i> . Hal ini belum sejalan dengan tuntutan COSO ERM (2017) dan ASHRM (2020) yang menekankan integrasi data risiko untuk pengambilan keputusan strategis, serta konsep Digital Era Governance (Dunleavy, 2006) dan NPM–NPS yang memposisikan TI sebagai <i>enabler</i> kinerja, transparansi, dan nilai publik.	Mengembangkan sistem informasi ERM terintegrasi dengan SIMRS/EMR, dilengkapi dashboard risiko real-time, analitik prediktif, dan mekanisme komunikasi dua arah lintas unit serta dengan pemangku kepentingan eksternal.

Sumber: Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.12

Project Map Informasi dan Komunikasi

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Dimensi Performance dalam kerangka Enterprise Risk Management (ERM) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan komponen inti yang mengintegrasikan proses operasional pengelolaan risiko dengan paradigma administrasi publik kontemporer. Dimensi ini mencakup enam indikator utama identifikasi risiko, analisis risiko, penentuan prioritas risiko, perlakuan risiko, pembiayaan risiko, dan portofolio risiko yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko yang sistematis.

a. Identifikasi risiko

Indikator identifikasi risiko, yang menekankan proses mengenali dan mendokumentasikan risiko potensial terhadap tujuan organisasi, menunjukkan temuan bahwa RSUD Tarakan telah berhasil mengidentifikasi risiko klinis dan non-klinis (namun cakupannya masih terbatas pada risiko strategis seperti perubahan kebijakan kesehatan nasional. Dari perspektif teori administrasi publik, OPA sebagaimana dikemukakan oleh Hughes (2003) dalam konteks pendekatan hierarkis dan prosedural menekankan identifikasi risiko sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan birokratis, yang selaras dengan temuan bahwa RSUD Tarakan menggunakan prosedur formal untuk

mendokumentasikan risiko, meskipun belum sepenuhnya mencakup aspek strategis yang lebih luas. NPM, seperti yang dijelaskan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), mendorong identifikasi risiko untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengukuran hasil, di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah mengukur risiko klinis untuk mengoptimalkan layanan pasien, namun perluasan ke risiko strategis dapat lebih meningkatkan efisiensi jangka panjang. NPS, sesuai dengan Denhardt dan Denhardt (2015), menekankan identifikasi risiko yang inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti staf medis, pasien, dan komunitas untuk menjaga nilai publik seperti keselamatan pasien, yang mendukung temuan bahwa RSUD Tarakan melibatkan tim multidisiplin dalam proses ini, meskipun partisipasi pemangku eksternal masih terbatas.

Kerangka COSO ERM 2017, melalui komponen Performance yang diuraikan oleh Moeller (2011), menempatkan identifikasi risiko sebagai langkah sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan, yang tercermin dalam temuan bahwa RSUD Tarakan menggunakan pendekatan sistematis ini untuk mengidentifikasi risiko, namun perlu integrasi data yang lebih komprehensif. ASHRM (2020) secara spesifik menekankan identifikasi risiko klinis dan non-klinis sebagai fondasi mitigasi di rumah sakit, yang relevan dengan temuan bahwa fokus RSUD Tarakan pada risiko klinis telah membentuk dasar mitigasi yang kuat.

Pendapat dari Kaplan dan Mikes (2012) menegaskan identifikasi risiko sebagai proses dinamis yang mempertimbangkan ketidakpastian VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), yang mendukung temuan bahwa RSUD Tarakan perlu memperluas identifikasi ke risiko strategis untuk menghadapi tantangan VUCA di sektor kesehatan Indonesia. Dibandingkan dengan penelitian Ferdosi et al. (2020), yang fokus pada eksekutif kesehatan global, temuan ini menunjukkan persamaan dalam pentingnya risiko strategis, namun berbeda karena konteks spesifik rumah sakit daerah Indonesia yang menghadapi keterbatasan sumber daya.

b. Analisis risiko

Indikator analisis risiko, yang berkaitan dengan penilaian probabilitas dan dampak risiko untuk risiko klinis dan risiko non klinis, menunjukkan temuan bahwa RSUD Tarakan menggunakan matriks risiko untuk menilai risiko sesuai

Pergub no 122 tahun 2020. Teori OPA, sebagaimana dikemukakan oleh Wilson (1887), menekankan analisis risiko sebagai bagian dari kontrol birokratis untuk mencegah penyimpangan, yang tercermin dalam temuan bahwa RSUD Tarakan menerapkan kontrol prosedural dalam analisis, meskipun kurangnya data kuantitatif membatasi efektivitasnya. NPM, seperti yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1992), mendorong analisis risiko untuk optimasi sumber daya, di mana temuan menunjukkan bahwa RSUD Tarakan menganalisis risiko untuk mengalokasikan sumber daya medis secara efisien, namun perluasan ke data kuantitatif dapat meningkatkan optimasi ini. NPS, sesuai dengan Denhardt dan Denhardt (2015), menambahkan dimensi partisipatif dalam analisis untuk memastikan keadilan, yang mendukung temuan bahwa RSUD Tarakan melibatkan staf dalam proses ini, meskipun partisipasi pasien masih minim.

Kerangka COSO ERM 2017, melalui komponen Performance yang diuraikan oleh Moeller (2011), mendukung analisis risiko sebagai langkah evaluatif terhadap tujuan, yang selaras dengan temuan bahwa analisis di RSUD Tarakan membantu menilai risiko terhadap tujuan layanan kesehatan. ASHRM (2020) merekomendasikan analisis risiko menggunakan domain kesehatan spesifik, yang relevan dengan temuan bahwa RSUD Tarakan fokus pada domain ini.

Pendapat terbaru dari Bryson et al. (2014) menekankan analisis risiko untuk mengatasi "wicked problems" di sektor publik, seperti pandemi kesehatan, yang mendukung temuan bahwa RSUD Tarakan perlu analisis yang lebih kuat untuk menghadapi masalah kompleks ini. Penelitian Pascarella et al. (2021), yang fokus pada konteks Eropa, menunjukkan persamaan dalam penggunaan matriks risiko, namun berbeda karena temuan ini menekankan kebutuhan data kuantitatif di Indonesia.

c. **Penentuan prioritas risiko**

Prioritas risiko sering kali ditentukan berdasarkan selera risiko organisasi, yang mencerminkan Tingkat risiko sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan kapasitas sumber daya yang dimiliki (COSO, 2017). Pendekatan ini tidak berdiri sendiri; teori lain, seperti analisis biaya-manfaat (*Cost-Benefit Analysis/CBA*), turut berperan dalam menilai prioritas risiko secara kuantitatif, di mana biaya penanganan risiko dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh untuk memastikan keputusan yang efisien (Boardman et al., 2018). Hasil dari penentuan

prioritas ini kemudian digunakan ke tahap perlakuan risiko, seperti mitigasi atau transfer risiko, sementara risiko yang tidak diprioritaskan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut sehingga disebut sebagai risiko yang dapat diterima (*risk acceptance*) (ISO 31000, 2018; Hopkin, 2018).

Untuk menentukan prioritas risiko, melibatkan penilaian dan pemeringkatan berdasarkan dampak serta probabilitas terjadinya risiko, yang membantu organisasi mengidentifikasi ancaman paling mendesak (Aven, 2016). Dalam konteks RSUD Tarakan, temuan menunjukkan bahwa rumah sakit ini memprioritaskan risiko klinis, seperti yang terkait dengan keselamatan pasien dan prosedur medis,

Dari sudut pandang teoritis, beberapa pendekatan klasik memberikan landasan kuat untuk praktik ini. Misalnya, OPA, menekankan bahwa prioritas risiko harus didasarkan pada hierarki organisasi, di mana keputusan diambil oleh tingkat manajemen tertinggi. Hal ini tercermin dalam temuan di RSUD Tarakan, di mana prioritas risiko ditentukan oleh manajemen puncak, meskipun pendekatan ini perlu lebih inklusif dengan melibatkan stakeholder lain seperti staf medis dan pasien untuk meningkatkan akuntabilitas (Gulick & Urwick, 1937). Selanjutnya, NPM (*New Public Management*), seperti yang diuraikan oleh Pollitt dan Bouckaert pada 2017, mendorong prioritas risiko yang berorientasi pada efisiensi operasional, dan temuan studi menunjukkan bahwa fokus pada risiko klinis telah berhasil meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di RSUD Tarakan, meskipun perluasan prioritas ke risiko nonklinis dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya secara lebih luas (Pollitt & Bouckaert, 2017). Tidak kalah pentingnya, NPS (*New Public Service*), sesuai dengan pandangan Denhardt dan Denhardt pada 2015, menekankan prioritas risiko yang selaras dengan nilai-nilai publik, seperti keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan berkualitas, yang secara langsung mendukung praktik RSUD Tarakan dalam memprioritaskan risiko yang berdampak langsung pada pasien, sehingga memperkuat komitmen terhadap kepentingan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015).

Kerangka COSO ERM 2017, khususnya melalui komponen *Performance* yang dijelaskan oleh Moeller pada 2011, turut mendukung penentuan prioritas untuk perlakuan risiko berdasarkan alokasi sumber daya yang efisien, yang sangat selaras dengan praktik di RSUD Tarakan (Moeller, 2011). Demikian pula, ASHRM pada 2020 menekankan prioritas risiko berdasarkan domain risiko

kesehatan, yang relevan dengan fokus klinis dalam temuan studi ini, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi panduan untuk pengembangan manajemen risiko di masa depan (ASHRM, 2020)

Terkait risiko material, hasil triangulasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko prioritas di RSUD Tarakan berada pada kategori risiko operasional klinis dan risiko reputasi dengan level sedang hingga tinggi, yaitu insiden keselamatan pasien, keterlambatan layanan, gangguan fasilitas, serta potensi dampak terhadap citra rumah sakit. Bahkan dalam wawancara disebutkan bahwa risiko dengan skor tertinggi berada pada aspek mutu pelayanan khususnya *patient safety*. Temuan ini menegaskan bahwa risiko material terbesar di RSUD Tarakan berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan mutu pelayanan yang memiliki konsekuensi berlapis: tidak hanya berdampak klinis, tetapi juga berpotensi memicu risiko reputasi, hukum, dan kepercayaan publik.

Dominasi risiko operasional sebagai prioritas juga terlihat dari mekanisme pemetaan risiko yang menggunakan skor kemungkinan dampak, di mana risiko dengan nilai ≥ 13 dikategorikan sebagai prioritas dan wajib dimitigasi. Namun, prioritisasi tersebut masih berorientasi pada stabilitas operasional dan kepatuhan regulasi, sementara pertimbangan strategis seperti analisis biaya dan manfaat (*Cost benefit analysis / CBA*) dan nilai publik belum terintegrasi secara memadai. Akibatnya, risiko lebih dipersepsikan sebagai kewajiban administratif daripada sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan bahwa RSUD Tarakan berada pada fase transisi menuju ERM yang lebih matang. Risiko telah diidentifikasi dan dianalisis secara formal, tetapi portofolio risiko masih parsial dan sektoral serta belum terintegrasi sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, risiko material terbesar yakni risiko mutu pelayanan dan keselamatan pasien harus diposisikan bukan hanya sebagai isu operasional, tetapi sebagai risiko strategis organisasi. Ketika risiko klinis berdampak tinggi beririsan dengan reputasi dan kepercayaan publik, maka kegagalan pengelolaannya berpotensi mengancam legitimasi institusi sebagai penyedia layanan kesehatan. Oleh karena itu, integrasi antara pengelolaan risiko sistematis dan unsistematis menjadi krusial agar ERM tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi sebagai instrumen tata kelola strategis yang mampu menjaga

keberlanjutan pelayanan publik rumah sakit di tengah lingkungan yang semakin kompleks dan tidak pasti.

d. Perlakuan risiko

Indikator perlakuan risiko, yang berkaitan dengan strategi mitigasi, menunjukkan temuan bahwa perlakuan di RSUD Tarakan lebih reaktif, seperti menangani insiden setelah terjadi. OPA menekankan perlakuan sebagai kepatuhan prosedur (Hughes, 2003), yang tercermin dalam prosedur formal temuan. NPM mendorong perlakuan untuk efisiensi (Osborne & Gaebler, 1992), yang mendukung temuan bahwa perlakuan reaktif telah mengurangi biaya insiden. NPS menekankan kolaborasi (Denhardt & Denhardt, 2015), yang perlu ditingkatkan berdasarkan temuan. COSO ERM 2017 mendukung perlakuan sebagai respons (Moeller, 2011),

Penelitian oleh Pascarella et al. (2021) menekankan bahwa perlakuan risiko di organisasi kesehatan harus melibatkan matriks risiko untuk prioritas mitigasi, sementara Ferdosi et al. (2020) merekomendasikan kerangka ISO 31000 untuk respons risiko yang lebih proaktif di tingkat eksekutif. Dalam konteks kesehatan, Darwiesh et al. (2022) menggunakan AI untuk mitigasi risiko strategis, yang dapat diterapkan untuk mengubah pendekatan reaktif menjadi prediktif di rumah sakit. Botet (2021) menyoroti perlakuan risiko pasca-krisis seperti COVID-19, yang mirip dengan temuan RSUD Tarakan namun berbeda konteks karena fokus pada pemulihan operasional pabrik, bukan kesehatan publik.

Namun, temuan di RSUD Tarakan mengungkapkan bahwa belum ada opsi penanganan risiko yang komprehensif untuk mitigasi, seperti loss prevention (pencegahan kerugian), loss reduction (pengurangan kerugian), segregasi (pemisahan tugas), atau transfer risiko, sesuai dengan rekomendasi ASHRM 2020. Perlakuan risiko, yang berkaitan dengan strategi mitigasi, menunjukkan bahwa perlakuan di RSUD Tarakan lebih bersifat reaktif, seperti menangani insiden setelah terjadi, daripada proaktif. OPA menekankan perlakuan sebagai kepatuhan prosedur (Hughes, 2003), yang tercermin dalam prosedur formal yang ditemukan di rumah sakit tersebut. NPM mendorong perlakuan untuk efisiensi (Osborne & Gaebler, 1992), yang mendukung temuan bahwa pendekatan reaktif telah mengurangi biaya insiden, meskipun tidak optimal. NPS menekankan kolaborasi (Denhardt & Denhardt, 2015), yang perlu ditingkatkan berdasarkan

temuan, untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses mitigasi. COSO ERM 2017 mendukung perlakuan sebagai respons strategis (Moeller, 2011), yang dapat membantu RSUD Tarakan beralih ke pendekatan yang lebih antisipatif.

e. Pembiayaan risiko

Indikator pembiayaan risiko menunjukkan temuan bahwa pembiayaan terbatas, memengaruhi mitigasi. NPM menekankan efisiensi (Pollitt & Bouckaert, 2017), NPS keadilan (Denhardt & Denhardt, 2015), COSO (Moeller, 2011), ASHRM (2020), UU Pasal 21-23, OECD (2015) untuk VfM, dan Dimitrov (2019) mirip dalam kesehatan. Penelitian terbaru oleh Dihartawan et al. (2024) menyoroti bahwa pembiayaan risiko yang terbatas di rumah sakit Indonesia menghambat implementasi mitigasi, sejalan dengan temuan bahwa anggaran terbatas mempengaruhi efektivitas pengendalian risiko operasional dan klinis. Pratama (2024) menemukan bahwa SIMRS berkontribusi pada efisiensi pembiayaan risiko, namun keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama, yang mendukung temuan bahwa pembiayaan terbatas mengurangi kemampuan mitigasi risiko strategis dan operasional. Dimitrov (2019) mengidentifikasi risiko keberlanjutan sistem kesehatan akibat biaya swasta yang tinggi, mirip dengan temuan bahwa pembiayaan risiko yang tidak memadai meningkatkan beban finansial rumah sakit dan mengancam akses layanan publik. Secara keseluruhan, teori NPM dan OECD (2015) menekankan efisiensi pembiayaan untuk VfM, sementara NPS mendorong keadilan dan standar pelayanan, namun temuan empiris menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan risiko di RSUD Tarakan menghambat transisi dari pendekatan reaktif ke proaktif, sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih strategis untuk meningkatkan ketahanan organisasi kesehatan.

f. Portofolio risiko

Portofolio risiko dalam konteks ERM merujuk pada pendekatan holistik untuk mengelola seluruh spektrum risiko organisasi secara terintegrasi, mirip dengan pengelolaan portofolio investasi di mana risiko individu dievaluasi dalam konteks keseluruhan untuk mencapai keseimbangan optimal antara risiko dan imbal hasil, sebagaimana dijelaskan oleh Moeller (2011) melalui kerangka COSO ERM 2017 yang menekankan integrasi risiko strategis, operasional, dan

kepatuhan dalam satu sistem pengelolaan, sementara ASHRM (2020) memperluas konsep ini dengan mengintegrasikan risiko klinis dan non-klinis dalam portofolio kesehatan, dan Frigo serta Anderson (2011) menyoroti pentingnya portofolio risiko untuk menciptakan nilai melalui mitigasi risiko yang terkoordinasi; dalam paradigma administrasi publik, *New Public Management* (NPM) menekankan optimasi portofolio risiko untuk efisiensi operasional (Pollitt & Bouckaert, 2017), sedangkan *New Public Service* (NPS) mendorong pendekatan partisipatif dalam pengelolaan portofolio risiko untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Denhardt & Denhardt, 2015),

Buckè et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi portofolio risiko dengan manajemen mutu dapat meningkatkan kinerja organisasi kesehatan secara keseluruhan, meskipun skala implementasinya bervariasi tergantung konteks organisasi. Penelitian tentang portofolio risiko di sektor kesehatan menunjukkan evolusi dari pendekatan *silo-based* menuju integrasi holistik, dengan fokus pada pengembangan model yang menggabungkan data empiris dan simulasi risiko, seperti studi Ferdosi et al. (2020) yang mengembangkan kerangka kerja ERM berbasis ISO 31000 untuk eksekutif organisasi kesehatan, Darwiesh et al. (2022) yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola portofolio risiko melalui analisis data media sosial, Pascarella et al. (2021) yang mengembangkan metodologi penilaian risiko menggunakan matriks risiko, Park dan Sharp (2019) yang menyoroti pendekatan proaktif melalui stratifikasi risiko, serta Buckè et al. (2022) yang menemukan integrasi portofolio risiko dengan manajemen mutu total meningkatkan pengambilan keputusan dan keselamatan pasien.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator portofolio risiko di rumah sakit masih belum dilaksanakan karena kurangnya integrasi antara risiko klinis dan non-klinis, serta keterbatasan dalam pemantauan risiko agregat, di mana NPM untuk optimasi (Pollitt & Bouckaert, 2017) efektif dalam mengoptimalkan portofolio risiko untuk efisiensi namun sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial, NPS partisipatif (Denhardt & Denhardt, 2015) meningkatkan akuntabilitas melalui keterlibatan pemangku kepentingan, COSO (Moeller, 2011) dan ASHRM (2020) menekankan bahwa portofolio risiko terintegrasi meningkatkan ketahanan organisasi Kesehatan. Frigo & Anderson (2011) menemukan bahwa portofolio risiko efektif menciptakan nilai melalui mitigasi terkoordinasi, dan Buckè et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi

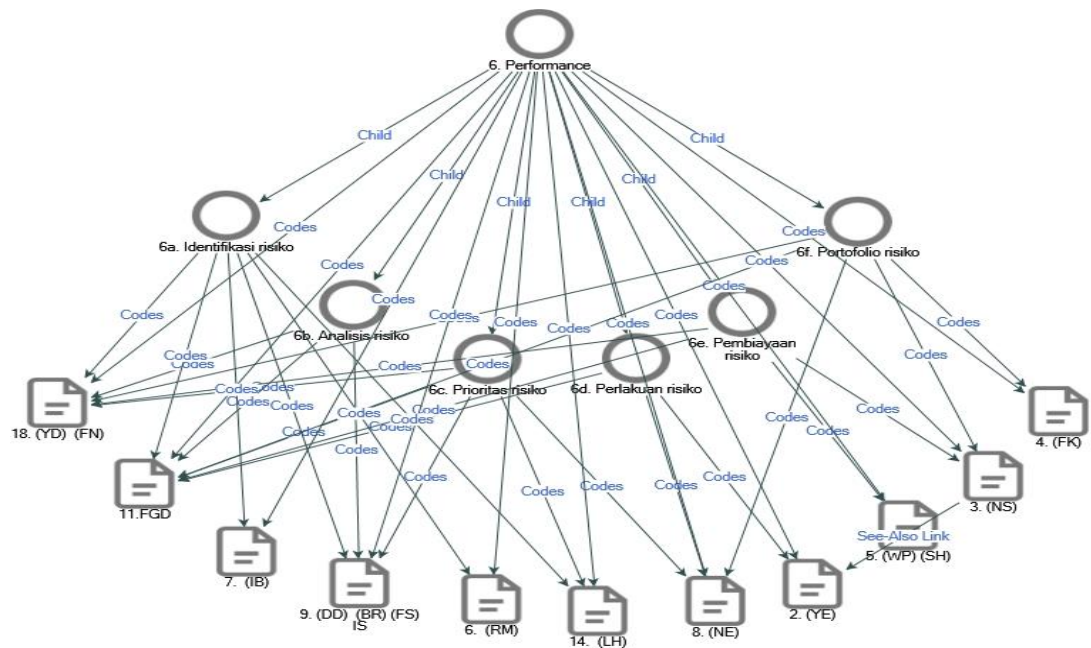
portofolio risiko dengan manajemen mutu mirip dengan pendekatan lain namun berbeda dalam skala implementasi, dengan hasil bahwa rumah sakit dengan portofolio risiko yang matang memiliki kinerja keselamatan pasien yang lebih baik, secara keseluruhan menegaskan perlunya pengembangan portofolio risiko yang lebih komprehensif untuk menghadapi kompleksitas risiko di era VUCA.

Tabel 4.55
Pembahasan Performance

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Identifikasi Risiko	Identifikasi risiko telah berjalan sistematis di tingkat unit dan mencakup risiko klinis serta non-klinis. Namun, prosesnya masih dominan operasional, reaktif, dan berbasis pengalaman unit; risiko belum diturunkan dari strategi dan belum dikaitkan dengan kinerja strategis organisasi.	Identifikasi risiko di RSUD Tarakan belum berfungsi sebagai <i>performance enabler</i> karena keterkaitan risiko–kinerja strategis belum eksplisit. Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip <i>risk–performance linkage</i> dalam COSO ERM (2017) dan masih mencerminkan dominasi pendekatan OPA–NPM dibandingkan orientasi nilai publik NPS (Moeller, 2011; Denhardt & Denhardt, 2015).	Mengintegrasikan identifikasi risiko dengan sasaran strategis dan indikator kinerja RS, termasuk risiko strategis dan eksternal (kebijakan, reputasi, sosial).
Analisis Risiko	Analisis risiko dilakukan menggunakan matriks dampak–probabilitas sesuai Pergub No. 122 Tahun 2020. Analisis bersifat baku dan konsisten, tetapi berfokus pada pengendalian operasional dan kepatuhan, belum pada peningkatan kinerja strategis.	Analisis risiko masih bersifat reaktif dan tidak terintegrasi; probabilitas risiko tinggi (misalnya risiko keuangan akibat keterlambatan klaim BPJS) tidak selalu dikuantifikasi dengan data akurat, sehingga prioritas mitigasi kurang tepat.	Mengembangkan analisis risiko berbasis data dan skenario strategis, serta mengaitkannya dengan capaian kinerja dan nilai publik.
Penentuan Prioritas Risiko	Prioritas risiko ditetapkan secara formal berdasarkan skor risiko (≥ 13) sesuai regulasi. Risiko operasional dan klinis mendominasi prioritas, sementara pertimbangan strategis dan nilai publik belum terintegrasi.	Penentuan prioritas risiko masih <i>compliance-driven</i> dan belum menggunakan pendekatan strategis seperti <i>cost–benefit analysis</i> atau nilai publik. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan COSO ERM (2017) dan pendekatan NPM–NPS (Pollitt &	Memasukkan pertimbangan strategi, nilai publik, dan analisis biaya–manfaat dalam penentuan prioritas risiko..

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
		Bouckaert, 2017; Denhardt & Denhardt, 2015).	
Perlakuan Risiko	Perlakuan risiko dilakukan secara desentralistik oleh unit kerja dan terdokumentasi, namun cenderung reaktif, sektoral, dan berorientasi efisiensi operasional. Integrasi dengan strategi jangka panjang dan evaluasi kinerja belum optimal.	Perlakuan risiko di RSUD Tarakan belum berfungsi sebagai instrumen penciptaan nilai publik dan peningkatan kinerja strategis. Hal ini menunjukkan dominasi pendekatan prosedural OPA dan efisiensi NPM , sementara pendekatan kolaboratif NPS belum berkembang (COSO ERM, 2017; ASHRM, 2020; Denhardt & Denhardt, 2015).	Mengembangkan perlakuan risiko yang proaktif dan strategis, termasuk mitigasi jangka panjang, kolaborasi lintas unit, dan keterkaitan dengan kinerja organisasi.
Pembiayaan Risiko	Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pembiayaan risiko. Aktivitas terkait risiko dibiayai secara tersebar melalui anggaran unit lain (SDM, umum, pelayanan), sehingga tidak terkelola sebagai fungsi strategis	Pembiayaan risiko belum dilembagakan dan memperkuat persepsi ERM sebagai kewajiban kepatuhan, bukan investasi strategis. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip <i>value for money</i> dan <i>risk investment</i> dalam COSO ERM (2017) dan OECD (2015, 2020).	Menetapkan kebijakan pembiayaan risiko khusus dalam kerangka BLUD dan mengaitkannya dengan risiko prioritas strategis..
Portofolio Risiko	Portofolio risiko terintegrasi belum tersedia. Risiko dikelola secara sektoral oleh unit dan komite mutu, tanpa satu dokumen induk yang merangkum risiko strategis, operasional, dan publik.	Absennya portofolio risiko menunjukkan bahwa ERM belum berfungsi sebagai sistem pengendalian kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Hal ini belum sejalan dengan konsep <i>enterprise risk portfolio</i> dalam COSO ERM (2017), ASHRM (2020), dan temuan Frigo & Anderson (2011) tentang penciptaan nilai melalui pengelolaan risiko terintegrasi.	Menyusun portofolio risiko RSUD Tarakan yang terintegrasi lintas unit, diperbarui berkala, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Sumber: Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.14
Project Map Performance
 Sumber : Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.15
Word Query Performance
 Sumber : Hasil Penelitian 2025

9. Review dan Revisi

Dimensi Review dan Revisi dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan komponen yang memastikan sistem manajemen risiko tetap adaptif, responsif, dan berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan kerangka COSO ERM 2017, dimensi ini mencakup proses

evaluasi berkala terhadap efektivitas ERM, penyesuaian risiko berdasarkan perubahan signifikan, serta tindakan perbaikan sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi (COSO, 2017). Dalam konteks rumah sakit publik seperti RSUD Tarakan, dimensi ini sangat relevan untuk menjaga ketahanan pelayanan kesehatan di tengah dinamika VUCA.

a. Penilaian Perubahan Substansial pada Perubahan Internal/Eksternal signifikan Direspons dengan Penyesuaian Risiko

Indikator ini menilai kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan merespons perubahan signifikan, seperti perubahan regulasi kesehatan, pandemi, atau perubahan internal seperti restrukturisasi organisasi, dengan penyesuaian risiko yang tepat waktu. Dalam teori Administrasi Publik, pendekatan OPA menekankan hierarki birokrasi yang kaku, sehingga respons terhadap perubahan sering lambat dan reaktif (Hughes, 2003). Sebaliknya, NPM mendorong responsivitas berbasis hasil melalui desentralisasi dan efisiensi, sementara NPS menekankan partisipasi warga dan dialog deliberatif untuk adaptasi yang inklusif (Denhardt & Denhardt, 2015).

COSO ERM 2017 mengintegrasikan ini dalam komponen Review and Revision, dimana penilaian perubahan signifikan menjadi dasar penyesuaian risiko untuk menjaga pencapaian tujuan strategis (COSO, 2017). ASHRM (2020) menekankan bahwa respons terhadap perubahan eksternal seperti pandemi COVID-19 harus proaktif, melibatkan penyesuaian protokol risiko klinis dan non-klinis.

Teori dari Osborne (2018) menekankan ko-produksi layanan kesehatan, dimana perubahan eksternal seperti regulasi BPJS harus direspons melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk penyesuaian risiko yang efektif. Persamaan dengan penelitian terbaru: Studi Ferdosi et al. (2020) menunjukkan bahwa kerangka ERM berbasis ISO 31000 memungkinkan penilaian perubahan eksternal secara sistematis, mirip dengan COSO ERM 2017. Penelitian Pascarella et al. (2021) lebih menekankan matriks risiko subjektif, sedangkan indikator ini mengintegrasikan evaluasi objektif berdasarkan data triangulasi. Penelitian Park & Sharp (2019) menyoroti pendekatan proaktif melalui pemodelan prediktif, yang sejalan dengan respons penyesuaian risiko di rumah sakit.

b. Review Kinerja dan Revisi

Indikator ini fokus pada evaluasi berkala terhadap kinerja ERM, termasuk revisi strategi risiko berdasarkan hasil review untuk meningkatkan efektivitas. Dalam teori Administrasi Publik, OPA menekankan review birokratis formal namun seringkali tidak adaptif (Weber, 1947). NPM mendorong review berbasis kinerja dan akuntabilitas hasil, sementara NPS menekankan review inklusif dengan partisipasi stakeholder untuk legitimasi demokratis (Denhardt & Denhardt, 2015). COSO ERM 2017 menempatkan review sebagai komponen untuk memastikan ERM mendukung pencapaian tujuan, dengan revisi yang berkelanjutan (COSO, 2017). ASHRM (2020) menyarankan review kinerja ERM melalui audit internal dan benchmarking untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Pendapat terbaru dari OECD (2020) menyoroti bahwa review kinerja ERM di sektor publik harus inklusif, melibatkan data digital untuk revisi yang tepat waktu. Persamaan dengan penelitian terbaru: Studi Jule (2020) menunjukkan bahwa review kinerja ERM di rumah sakit mengurangi klaim cedera hingga 59%, mirip dengan indikator ini. Penelitian Botet (2021) lebih fokus pada rencana kontinjensi darurat, sedangkan indikator ini mencakup revisi strategis yang lebih luas. Penelitian Darwiesh et al. (2022) menggunakan AI untuk review risiko, yang berbeda dari pendekatan manual di indikator ini namun dapat diintegrasikan untuk inovasi.

c. Perbaikan ERM dengan Tindakan Peningkatan Sistem ERM Secara Berkelanjutan

Indikator ini menilai upaya perbaikan sistem ERM melalui tindakan berkelanjutan seperti pelatihan, teknologi, dan integrasi proses untuk meningkatkan ketahanan organisasi. Dalam teori Administrasi Publik, OPA menekankan perbaikan birokratis standar namun lambat (Hughes, 2003). NPM mendorong perbaikan efisien berbasis inovasi, sementara NPS menekankan perbaikan kolaboratif dan etis (Denhardt & Denhardt, 2015). COSO ERM 2017 menyarankan perbaikan berkelanjutan melalui komponen *Review and Revision* untuk mendukung budaya risiko yang adaptif (COSO, 2017). ASHRM (2020) menekankan perbaikan melalui pendidikan keselamatan dan sistem informasi terintegrasi.

Teori dari Alford (2016) dalam *Public Value Theory* menekankan perbaikan ko-produksi layanan kesehatan, dimana tindakan peningkatan ERM harus melibatkan pasien dan komunitas. Pendapat terbaru dari WHO (2021) menyoroti perbaikan sistem ERM melalui digitalisasi untuk respons cepat terhadap risiko kesehatan global. Persamaan dengan penelitian Buckè et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi manajemen mutu dan risiko meningkatkan kinerja rumah sakit, mirip dengan indikator ini. Penelitian Zaitseva et al. (2022) menggunakan logika perbaikan risiko jangka panjang, yang lebih kompleks daripada pendekatan berkelanjutan di indikator ini. Penelitian Khassouani et al. (2021) menekankan sistem kewaspadaan kesehatan, yang sejalan namun lebih spesifik pada adaptasi pandemi.

Dimensi Review dan Revisi merupakan elemen krusial dalam ERM rumah sakit publik, yang memastikan sistem manajemen risiko tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan. Dimensi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik secara keseluruhan. Perubahan dan perbaikan berkelanjutan karena respons terhadap perubahan eksternal seperti pandemi dan upaya peningkatan sistem melalui pelatihan, yang sejalan dengan COSO ERM 2017 dan ASHRM. Namun, review kinerja masih terbatas pada aspek internal, menunjukkan perlunya integrasi NPS untuk partisipasi stakeholder yang lebih luas. Secara teoritis, dimensi ini menggabungkan elemen OPA (hierarki review), NPM (efisiensi revisi), dan NPS (inklusi perbaikan), serta mendukung UU Pelayanan Publik melalui akuntabilitas dan kualitas layanan. Persamaan dengan penelitian terbaru seperti Ferdosi et al. (2020) dan Jule (2020) menunjukkan efektivitas review dalam mengurangi risiko, sementara perbedaan dengan studi seperti Darwiesh et al. (2022) menekankan potensi inovasi digital untuk peningkatan di masa depan.

Tabel 4.56

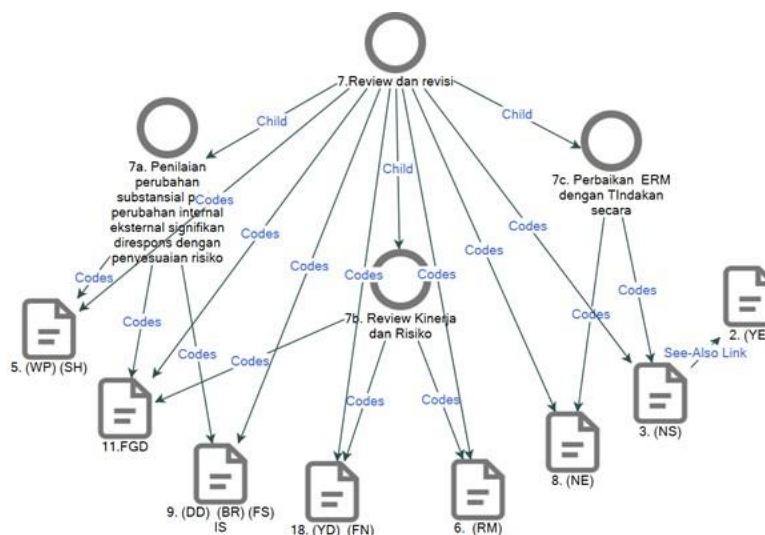
Pembahasan Review dan revisi

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Penilaian Perubahan Substansial pada Perubahan Internal/Eksternal Signifikan Direspons	RSUD Tarakan melakukan penilaian perubahan signifikan (mis. pandemi COVID-19, perubahan regulasi, fluktuasi anggaran) melalui rapat triwulanan, monitoring oleh Komite Mutu dan	Penilaian perubahan substansial telah berjalan pada level strategis dan taktis, tetapi pada level operasional masih terbatas dan belum sistematis. Respons penyesuaian risiko	Memperkuat mekanisme deteksi perubahan internal-eksternal secara real-time melalui sistem informasi terintegrasi, memperjelas

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
dengan Penyesuaian Risiko	SPI, serta pembaruan peta risiko. Penyesuaian risiko dapat dilakukan, namun belum konsisten di semua unit dan masih berorientasi administratif.	sering tertunda karena keterbatasan koordinasi dan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan penerapan komponen Review and Revision dalam COSO ERM (2017) serta belum optimalnya <i>anticipatory governance</i> sebagaimana direkomendasikan OECD (2020) dan ASHRM (2020).	tanggung jawab unit dalam penyesuaian risiko, serta melakukan audit berkala atas respons perubahan signifikan.
Review Kinerja dan Revisi	Review kinerja dan risiko dilakukan melalui rapat manajemen risiko, koordinasi unit, dan laporan mutu. Namun, revisi risk register dan kebijakan risiko belum memiliki pedoman tertulis, mekanisme eskalasi, dan dokumentasi baku; review sering bersifat informal dan ad hoc.	Review kinerja ERM diakui secara normatif tetapi belum terlembagakan sebagai siklus evaluatif yang terjadwal, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan pengambilan keputusan manajerial serta kinerja organisasi. Hal ini belum sejalan dengan prinsip evaluasi berkelanjutan dalam COSO ERM (2017), praktik review berbasis kinerja NPM, dan pendekatan partisipatif NPS (Denhardt & Denhardt, 2015; ASHRM, 2020).	Menetapkan kebijakan dan SOP review–revisi risiko yang jelas, termasuk frekuensi, mekanisme eskalasi, dan keterkaitan dengan evaluasi kinerja, serta melibatkan auditor internal/eksternal untuk memperkuat kualitas review.
Perbaikan ERM dengan Tindakan Peningkatan Sistem ERM Secara Berkelanjutan	Perbaikan ERM dilakukan melalui pelatihan, monitoring tindak lanjut, pembaruan risk register, dan disposisi pimpinan atas rekomendasi. Namun, perbaikan masih parsial, belum terintegrasi dengan PMKP dan	Tindakan perbaikan ERM masih bersifat teknis dan administratif, belum membentuk <i>organizational learning</i> dan peningkatan sistemik jangka panjang. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan konsep	Mengembangkan roadmap perbaikan ERM jangka panjang dengan indikator kinerja terukur, mengintegrasikan perbaikan ERM dengan PMKP dan perencanaan strategis, serta melakukan

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
	perencanaan kinerja, serta belum dievaluasi dampaknya secara sistematis	<i>continuous improvement</i> dalam COSO ERM (2017), ASHRM (2020), dan pendekatan nilai publik NPS (Denhardt & Denhardt, 2015; WHO, 2021).	benchmarking dan evaluasi tahunan untuk memastikan keberlanjutan.

Sumber: Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.16

Project Map Review dan Revisi

Sumber : Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.17

Word Query Review dan Revisi

Sumber : Hasil Penelitian 2025

10. Audit Internal

Dimensi Audit Internal dalam ERM berperan sebagai mekanisme pengawasan independen yang memastikan efektivitas sistem manajemen risiko melalui evaluasi berbasis risiko, pelaporan temuan, dan tindak lanjut yang sistematis. Berdasarkan kerangka COSO ERM 2017, audit internal berbasis risiko merupakan bagian integral dari komponen *Review and Revision*, yang mendukung akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan (COSO, 2017). Dalam konteks rumah sakit publik seperti RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, dimensi ini penting untuk menjamin risiko klinis, dan risiko nonklinis telah dikelola dengan baik serta memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan akuntabel.

a. Audit Internal Berbasis Risiko

Indikator ini menilai pelaksanaan audit internal yang berfokus pada area risiko tinggi, seperti risiko klinis (keselamatan pasien) dan risiko operasional (pengelolaan sumber daya), untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas ERM. Dalam teori Administrasi Publik, OPA menekankan audit birokratis hierarkis dan formal untuk memastikan kepatuhan prosedural (Hughes, 2003). NPM mendorong audit berbasis risiko untuk efisiensi dan akuntabilitas hasil, sementara NPS menekankan audit inklusif yang melibatkan stakeholder untuk legitimasi dan transparansi (Denhardt & Denhardt, 2015). COSO ERM 2017 mengintegrasikan audit internal sebagai alat untuk menilai efektivitas ERM dan mendukung pengambilan keputusan strategis (COSO, 2017). ASHRM (2020) menyarankan audit berbasis risiko di rumah sakit untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien dan operasional.

Pendapat dari IIA (Institute of Internal Auditors, 2023) menyoroti bahwa audit berbasis risiko harus menggunakan data analitik untuk mendeteksi risiko seperti *cyber threats* di sistem kesehatan. Persamaan dengan penelitian Ferdosi et al. (2020) menunjukkan bahwa audit berbasis risiko di tingkat eksekutif rumah sakit meningkatkan identifikasi risiko strategis, mirip dengan COSO ERM 2017. Perbedaan dengan Penelitian Pascarella et al. (2021) lebih fokus pada matriks risiko subjektif, sedangkan indikator ini mengintegrasikan audit objektif. Penelitian Park & Sharp (2019) menekankan audit proaktif melalui pemodelan prediktif, yang sejalan namun lebih spesifik pada risiko klinis.

b. Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Indikator ini menilai efektivitas tindak lanjut terhadap temuan audit, seperti perbaikan prosedur risiko dan pelaporan kepada manajemen, untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Dalam teori Administrasi Publik, OPA menekankan tindak lanjut birokratis formal namun seringkali lambat (Hughes, 2003). NPM mendorong tindak lanjut efisien berbasis hasil, sementara NPS menekankan tindak lanjut kolaboratif dengan partisipasi stakeholder (Denhardt & Denhardt, 2015).

COSO ERM 2017 menempatkan tindak lanjut sebagai bagian dari *Review and Revision* untuk memastikan ERM mendukung pencapaian tujuan (COSO, 2017). ASHRM (2020) menyarankan tindak lanjut audit untuk mitigasi risiko keselamatan dan operasional. Teori terbaru dari Bryson et al. (2014) menekankan tindak lanjut audit sebagai respons terhadap wicked problems, dimana perbaikan risiko di rumah sakit harus inklusif. Pendapat dari OECD (2020) menyoroti bahwa tindak lanjut audit di sektor publik harus transparan dan melibatkan teknologi untuk tracking perbaikan. Persamaan dengan penelitian Jule (2020) menunjukkan bahwa tindak lanjut audit mengurangi klaim cedera hingga 59%, mirip dengan indikator ini. Perbedaan: Penelitian Botet (2021) lebih fokus pada rencana kontinjensi, sedangkan indikator ini mencakup tindak lanjut sistematis yang lebih luas. Penelitian Darwiesh et al. (2022) menggunakan AI untuk tindak lanjut risiko, yang berbeda dari pendekatan manual namun dapat diintegrasikan.

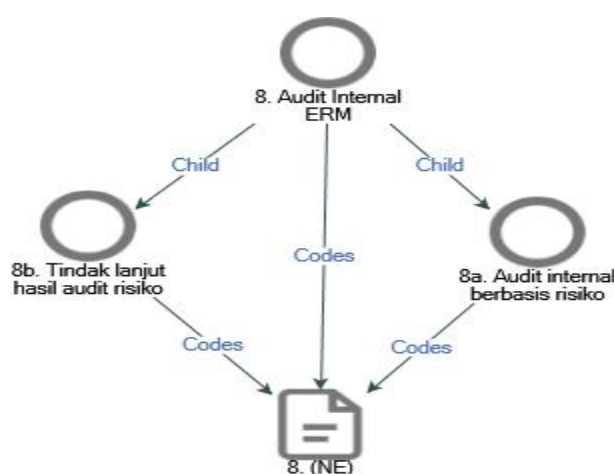
Dimensi Audit Internal merupakan pilar pengawasan dalam ERM rumah sakit publik, yang memastikan evaluasi risiko dan perbaikan yang efektif. Indikator audit berbasis risiko fokus pada risiko kritis seperti keselamatan pasien, yang sejalan dengan COSO ERM 2017 dan ASHRM. Namun, tindak lanjut masih terbatas dalam kecepatan dan inklusivitas, menunjukkan perlunya integrasi NPS untuk partisipasi stakeholder yang lebih luas. Secara teoritis, dimensi ini menggabungkan elemen OPA (hierarki audit), NPM (efisiensi tindak lanjut), dan NPS (inklusi pengawasan), serta mendukung UU Pelayanan Publik melalui akuntabilitas dan kualitas layanan. Persamaan dengan penelitian terbaru seperti Ferdosi et al. (2020) dan Jule (2020) menunjukkan efektivitas audit dalam mengurangi risiko, sementara perbedaan dengan studi seperti Darwiesh et al. (2022) menekankan potensi inovasi digital untuk peningkatan di masa depan.

Tabel 4.57
Pembahasan Audit Internal

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
Audit Internal Berbasis Risiko	Audit internal dilaksanakan oleh SPI dengan fokus utama pada keuangan, persediaan, dan kepatuhan. Pemilihan objek audit mempertimbangkan besaran anggaran dan kompleksitas layanan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan <i>risk register</i> organisasi. Pelaporan SPI disampaikan ke Direktur dan tidak langsung ke Dewan Pengawas; audit ke komite dan risiko strategis belum dilakukan secara konsisten.	Audit internal di RSUD Tarakan masih compliance-driven dan reaktif, sehingga belum berfungsi optimal sebagai <i>third line of defense</i> berbasis ERM. Independensi dan peran strategis SPI masih terbatas, serta integrasi audit dengan manajemen risiko dan kinerja belum kuat. Temuan ini belum sepenuhnya sejalan dengan komponen <i>Review and Revision</i> dalam COSO ERM (2017) dan praktik <i>risk-based internal audit</i> yang direkomendasikan IIA (2023) dan ASHRM (2020); juga mencerminkan dominasi OPA dibanding NPM–NPS (Denhardt & Denhardt, 2015). .Persamaan dengan penelitian Ferdosi et al. (2020) dalam identifikasi risiko strategis; perbedaan dengan Pascarella et al. (2021) yang lebih subjektif. Teori OPA menekankan hierarki, NPM efisiensi, NPS inklusivitas.	Memperkuat audit internal berbasis risiko dengan mengaitkan rencana audit pada <i>risk register</i> dan portofolio risiko RS, memperluas cakupan audit ke risiko non-klinis dan strategis, serta meningkatkan independensi pelaporan SPI kepada Dewan Pengawas.
Tindak Lanjut Hasil Audit Internal	Tindak lanjut audit dilakukan melalui disposisi Direktur kepada unit terkait dan dimonitor oleh SPI. Mekanisme tindak lanjut masih bersifat administratif, tidak berbasis indikator risiko, belum terintegrasi dengan <i>three lines model</i> , serta belum dimanfaatkan	Tindak lanjut audit internal belum terlembagakan sebagai mekanisme pembelajaran organisasi dan pengendalian risiko berkelanjutan. Peran <i>three lines</i> belum terintegrasi, sehingga hasil audit lebih berfungsi memenuhi rekomendasi pemeriksa daripada memperkuat ERM. Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan	Mengembangkan sistem <i>tracking</i> tindak lanjut audit berbasis digital, mengaitkan tindak lanjut dengan risiko residual dan portofolio risiko, serta melibatkan <i>three lines</i> secara terintegrasi agar hasil audit menjadi dasar pembelajaran dan penguatan ERM.

Aspek	Hasil Penelitian	Temuan Penelitian	Rekomendasi
	sebagai input pembaruan <i>risk register</i> dan pencegahan risiko berulang.triangulasi data.	dalam COSO ERM (2017), praktik tindak lanjut audit NPM, dan pendekatan partisipatif NPS (OECD, 2020; Denhardt & Denhardt, 2015) . Persamaan dengan Jule (2020) dalam pengurangan risiko; perbedaan dengan Botet (2021) yang lebih fokus pada kontinjensi. Teori NPM menekankan hasil, NPS kolaborasi.	

Sumber: Hasil Penelitian



Gambar 4.18

Project Map Audit internal

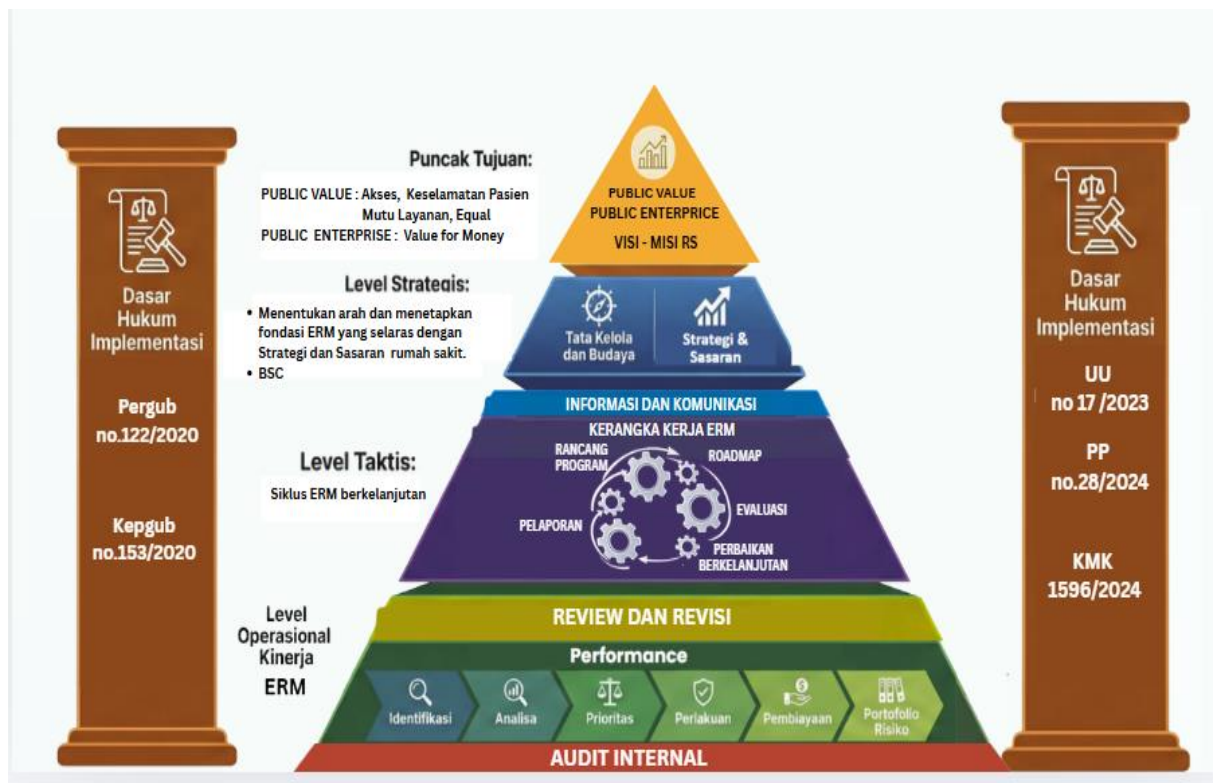
Sumber : Hasil Penelitian 2025



Gambar 4.19

Word Query Audit internal

Sumber : Hasil Penelitian 2025.



Gambar 4.20
Model Enterprise Risk Management di Rumah Sakit

11. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kelebihan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Penelitian

- 1) Penelitian dilakukan pada satu rumah sakit publik, yaitu RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, sehingga generalisasi temuan secara langsung ke seluruh rumah sakit publik di Indonesia perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan konteks kelembagaan masing-masing daerah.
- 2) Pendekatan kualitatif yang digunakan sangat bergantung pada kedalaman data wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga temuan lebih menekankan pada pemahaman proses dan konteks dibandingkan pengukuran kuantitatif tingkat kematangan ERM.
- 3) Penelitian ini belum mengukur dampak implementasi model ERM secara longitudinal, sehingga efektivitas model dalam jangka panjang terhadap

kinerja, keselamatan pasien, dan kepercayaan publik masih memerlukan penelitian lanjutan.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan yang terus berkembang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan konsistensi penerapan model ERM yang dikembangkan.

b. Kelebihan Penelitian

Kelebihan utama penelitian ini terletak pada kontribusi konseptual dan paradigmatis, yaitu pengembangan Model *Enterprise Risk Management* rumah sakit publik berbasis administrasi publik yang mengintegrasikan COSO ERM 2017 dengan paradigma OPA, NPM, dan NPS. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan empiris, tetapi juga menawarkan model implementatif yang menjembatani kesenjangan empiris, teoretis, dan normatif dalam pengelolaan risiko rumah sakit publik. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik dengan mencakup seluruh tingkatan organisasi (strategis, taktis, dan operasional), mengintegrasikan risiko klinis dan non-klinis, serta menempatkan komunikasi risiko dan teknologi digital sebagai mekanisme inti tata kelola dan pembelajaran organisasi. Kelebihan lainnya adalah relevansi praktis dan kebijakan yang tinggi, sehingga model yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan penguatan tata kelola risiko rumah sakit publik di Indonesia.

12. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis penting bagi pengembangan kajian administrasi publik dan manajemen risiko sektor Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Temuan penelitian memperkuat argumen bahwa COSO ERM 2017 tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adaptasi konteks sektor publik. Dalam rumah sakit publik, ERM tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengendalian internal, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola, akuntabilitas publik, dan penciptaan nilai sosial.
- 2) Penelitian ini menunjukkan bahwa hibridisasi paradigma OPA, NPM, dan NPS merupakan prasyarat bagi efektivitas ERM di organisasi pelayanan publik. OPA menyediakan legitimasi struktural, NPM menyediakan efisiensi dan instrumen manajerial, sementara NPS memberikan orientasi nilai publik

dan legitimasi sosial. Tanpa integrasi ketiganya, ERM cenderung terfragmentasi.

- 3) Penelitian ini memperluas literatur ERM dengan menempatkan komunikasi risiko dan teknologi informasi sebagai dimensi kunci pembentuk kinerja ERM, bukan sekadar faktor pendukung teknis. Hal ini memperkaya diskursus ERM dari perspektif *governance* dan *public value*.

b. Implikasi Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan temuan penelitian, implikasi kebijakan dirumuskan pada tiga level utama:

1) Implikasi Kebijakan Tata Kelola

Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu menggeser kebijakan ERM dari pendekatan kepatuhan menuju ERM berbasis nilai publik, dengan:

- a) Menetapkan selera risiko institusional secara formal,
- b) Mengintegrasikan ERM dalam siklus perencanaan strategis dan penganggaran,
- c) Memperkuat peran pimpinan sebagai *risk steward* strategis

2) Implikasi Kebijakan Organisasi

RSUD Tarakan dan rumah sakit publik sejenis perlu:

- a) Mengembangkan ERM sebagai portofolio risiko enterprise-wide, bukan sekadar agregasi risiko unit,
- b) Memperkuat pembelajaran organisasi berbasis risiko,
- c) Membangun budaya sadar risiko yang aman untuk pelaporan dan pembelajaran, bukan menyalahkan.

3) Implikasi Kebijakan Sistem Informasi

Penguatan ERM memerlukan:

- a) Integrasi risk register dengan SIMRS,
- b) Pengembangan dashboard risiko real-time,
- c) Pemanfaatan analitik risiko untuk mendukung pengambilan keputusan prediktif di lingkungan VUCA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola risiko secara strategis untuk menciptakan nilai publik, memastikan keberlanjutan, dan membangun ketahanan organisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa:

1. Kondisi aktual Penerapan Manajemen Risiko di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

Penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Enterprise Risk Management (ERM)* yang terintegrasi dan strategis. Praktik yang ada masih bersifat silo, administratif, dan berorientasi pada kepatuhan, sehingga belum mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis maupun dalam merespon dinamika lingkungan yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di RSUD Tarakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Enterprise Risk Management (ERM)* yang terintegrasi dan strategis. Praktik yang ada masih bersifat silo, administratif, dan berorientasi pada kepatuhan, sehingga belum mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis maupun dalam merespon dinamika lingkungan yang kompleks.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor pendukung meliputi komitmen kepemimpinan sebagai *role model*, dukungan Regulasi dan Struktur internal, komunikasi lintas unit, serta keterlibatan SDM multidisiplin dan instrument teknis dan sistim digital yang selaras dengan paradigma dan komponen *Governance & Culture* COSO ERM 2017.
- b. Faktor penghambat bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya integrasi kepemimpinan strategis dan kapasitas institusional meliputi integrasi risiko klinis dan non klinis yang masih lemah, budaya risiko yang belum terinternalisasi, Fungsi Pengendalian dan pengawasan yang lemah, keterbatasan kompetensi SDM, Regulasi yang tidak harmonis, keterbatasan anggaran dan teknologi informasi yang belum optimal. Hambatan utama bukan terletak pada

ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya integrasi kepemimpinan strategis dan kapasitas institusional.

3. Model Enterprise Risk Management (ERM) pada Pelayanan Publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menghasilkan Model *Enterprise Risk Management* pada Pelayanan Publik di Rumah Sakit yang mengintegrasikan COSO ERM 2017 dengan hibridisasi paradigma *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)* dan *New Public Service (NPS)* serta memasukkan paradoks pelayanan kesehatan sebagai sumber risiko strategis. Model ini menempatkan ERM sebagai instrumen strategis yang menghubungkan antara tata kelola, strategi, dan kinerja organisasi, serta mengintegrasikan pengelolaan risiko pada seluruh level organisasi, yaitu strategis, taktis, dan operasional (STO).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi ERM dari sekadar alat manajerial menjadi instrumen strategis dalam tata kelola pelayanan publik, serta mengkonstruksi paradoks pelayanan kesehatan sebagai risiko strategis yang harus dikelola secara sistematis untuk memperkuat ketahanan organisasi, serta memastikan keberlanjutan dan penciptaan nilai publik di tengah tekanan *value squeeze* dan dinamika VUCA.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kesenjangan empiris dan teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi normatif dalam pengembangan kebijakan manajemen risiko di sektor kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran diberikan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan penerapan ERM di RSUD Tarakan dan rumah sakit publik lainnya, dengan fokus pada penguatan integrasi risiko, harmonisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas. Saran ini disusun dalam point-point untuk setiap pihak:

1. Saran bagi RSUD Tarakan

- a. Tingkatkan integrasi ERM secara holistik dengan mengadopsi model hibridisasi OPA-NPM-NPS, termasuk penguatan budaya risiko melalui pelatihan partisipatif dan insentif untuk kesadaran risiko.
- b. Optimalkan alokasi anggaran untuk ERM, seperti pengadaan teknologi informasi real-time dan rekrutmen SDM kompeten, guna mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan mitigasi risiko klinis dan non-klinis.

- c. Perkuat komunikasi lintas unit dan partisipasi stakeholder eksternal (pasien, masyarakat) melalui forum dialog rutin, untuk mendukung dimensi Information, Communication, and Reporting dalam COSO ERM 2017.
- d. Lakukan audit internal berkala berbasis risiko dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan review and revision yang efektif, serta harmonisasi regulasi internal dengan eksternal.

2. Saran bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- a. Koordinasikan harmonisasi regulasi kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti integrasi KMK No. 1128/2022 dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, untuk mengurangi disharmonisasi yang menghambat ERM di rumah sakit.
- b. Berikan dukungan teknis dan pelatihan ERM kepada rumah sakit daerah, termasuk pengembangan kompetensi SDM melalui program sertifikasi risiko kesehatan.
- c. Fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan benchmarking ERM antar rumah sakit, untuk meningkatkan Performance Index by Citizen sesuai UU No. 25 Tahun 2009.
- d. Alokasikan anggaran khusus untuk teknologi informasi ERM di rumah sakit, guna mendukung identifikasi risiko real-time dan mitigasi VUCA.

3. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

- a. Tingkatkan alokasi anggaran kesehatan untuk ERM, termasuk pembiayaan risiko strategis seperti pandemi dan perubahan regulasi, untuk mengatasi keterbatasan anggaran di rumah sakit.
- b. Harmonisasi kebijakan daerah dengan nasional melalui koordinasi lintas sektor, memastikan regulasi internal rumah sakit selaras dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan SPM.
- c. Dorong partisipasi masyarakat dalam governance risiko melalui forum deliberatif, untuk memperkuat dimensi NPS dalam ERM.
- d. Implementasikan sistem monitoring risiko daerah yang terintegrasi, menggunakan data digital untuk evaluasi berkelanjutan dan respons cepat terhadap risiko kesehatan.

4. Saran bagi Kementerian Kesehatan

- a. Revisi regulasi kesehatan nasional untuk harmonisasi dengan daerah, seperti memperkuat KMK No. 1128/2022 dengan pedoman ERM spesifik rumah sakit publik.
- b. Berikan panduan nasional untuk implementasi ERM berbasis COSO 2017 dan ASHRM, termasuk roadmap untuk rumah sakit tipe A di daerah.
- c. Alokasikan dana nasional untuk pengembangan kapasitas SDM kesehatan dalam ERM, melalui program pelatihan dan sertifikasi risiko.
- d. Integrasikan ERM dengan survei kepuasan masyarakat nasional, untuk meningkatkan akuntabilitas dan nilai publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009.

5. Saran bagi Kementerian Dalam Negeri

- a. Koordinasikan harmonisasi regulasi antar daerah untuk ERM kesehatan, memastikan konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
- b. Berikan dukungan teknis untuk implementasi ERM di pemerintah daerah, termasuk pengembangan model governance risiko yang inklusif.
- c. Fasilitasi benchmarking ERM antar provinsi, untuk belajar dari praktik terbaik dalam mengatasi tantangan VUCA di sektor kesehatan.
- d. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi ERM di rumah sakit daerah melalui audit nasional, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

6. Saran bagi Akademisi dan Peneliti

Melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait manajemen risiko di sektor publik, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan. Akademisi diharapkan dapat mengembangkan model-model ERM yang lebih komprehensif, serta melakukan penelitian komparatif di berbagai konteks organisasi untuk memperkuat generalisasi teoritis. Selain itu, integrasi antara teori administrasi publik dan manajemen risiko perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan kerangka konseptual yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abah, R. C., & ESQ, E. C. O. (2019). The Importance of Enterprise Risk Management to Public Sector Organisations in Nigeria. *Public Policy and Administration Research*, 9(3), 132
- Abbas, A., et al. (2021). Stakeholder engagement in risk management: A systematic review. *Journal of Risk Research*, 24(5), 567-589. <https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1891234>
- Abbas, J., Wang, D., Su, Z., & Ziapour, A. (2021). The Role of Social Media in the Advent of COVID-19 Pandemic: Crisis Management, Mental Health Challenges and Implications. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 1917–1932. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S284313>
- Ackoff, RL (1999). *Re-Creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century*. Oxford University Press.
- Acs, Z. J., & Stough, R. R. (Eds.). (2008). *Public policy in an entrepreneurial economy: Creating the conditions for business growth*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-72663-2>
- Afifa, T. D., & Adisasmito, W. B. B. (2021). Analisis Manajemen Risiko Penularan Virus COVID-19 Pada Dokter Dan Perawat Di Rumah Sakit X. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARS)*, 5(2). <https://doi.org/10.52643/marsi.v5i2.1487>
- Agarwal, R., & Ansell, J. (2016). Strategic change in enterprise risk management. *Strategic Change*, 25(4), 427–439.
- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., Thabrany, H., Susiloretni, K. A., Soewondo, P., Ahmad, S. A., Kurniawan, M., Hidayat, B., Pardede, D., Mundiharno, ... Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Agustina, Z., & Hariri, A. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *Iblam Law Review*, 2(2), 108–128. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>
- Airmic, A., & Irm, A. (2010). structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000. *The Public Risk Management Association, London, UK*.
- Alford, J. (2016). Co-production, interdependence and publicness: Extending public service-dominant logic. *Public Management Review*, 18(5), 673–691.
- Alijoyo, A. (2022). Enterprise Risk Management, Value Chain, And Life Cycle Cost: How The Three Concepts Are Adopted To Increase Competitiveness. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(2), 388–396. <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i2.228>
- Anindya, S. R. (2023). Potential risk management design based on ISO 31000:2018 a case study of RSUD BLUD X. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 1(60), 1–9. <https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art1>

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Ari, Y. (2020). Implementasi Manajemen Risiko di Sektor Publik: Urgensi dan Tantangan.
- Aripin, S., & Samboteng, L. (2021). Agile bureaucracy for public policy accountability: implementation of the street vendor policy in Indonesia. In *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* (pp. 108-116). Atlantis Press.
- Arrow, K. J. (1964). Control in large organizations. *Management Science*, 10(3), 397–408.
- American Society for Health Care Risk Management. (2014). *Enterprise risk management playbook for healthcare leaders*. ASHRM.
- ASHRM. (2020). *Enterprise Risk Management for Health Care Boards : Leveraging the Value The Board ' s Role in ERM Traditional Risk Management Versus Enterprise Risk Management*. 1–9.
- ASHRM (2020), Healthcare Enterprise Risk management Playbook, Sec ed.
- ASHRM. (2014). *Enterprise Risk Management: A Framework for Healthcare Organizations*. American Society for Health Care Risk Management, American Hospital Association. Retrieved from <https://www.ashrm.org/resources/erm-framework>
- Australian National Audit Office (ANAO). (2020). *Risk Management in the Australian Public Service*. ANAO Report No. 6 2020–21.
- Aven, T., & Ylönen, M. (2019). The strong power of standards in the safety and risk fields: A threat to proper developments of these fields?. *Reliability Engineering & System Safety*, 189, 279-286.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Laporan Pemantauan SPIP dan Manajemen Risiko Nasional 2023*. Jakarta: BPKP.
- Baker, J. D. (2017). Implementing Enterprise Risk Management in Healthcare: The Cleveland Clinic Experience. *Journal of Healthcare Risk Management*, 36(3), 27–34. <https://doi.org/10.1002/jhrm.21258>
- Bass, B M. Bass & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Bazaluk, O., Tsopa, V., Cheberiachko, S., Deryugin, O., Radchuk, D., Borovytskyi, O., & Lozynskyi, V. (2023). Ergonomic risk management process for safety and health at work. *Frontiers in Public Health*, 11, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1253141>
- Beasley, M. S., Hermanson, D. R., Carcello, J. V, & Neal, T. L. (2010). *Fraudulent financial reporting: 1998-2007: An analysis of US public companies*.
- Benninga, S. (2010). *Principles of finance with Excel* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-benefit analysis: Concepts and practice*(5th ed.). Cambridge University Press.
- Boldea, L. (2021). Integrating COSO ERM and ASHRM in Healthcare Settings. *Journal of Risk Management in Healthcare*, 8(4), 112-128

- Boston, J. (2000). The challenge of evaluating systemic change: the case of public management reform. *International Public Management Journal*, 3(1), 23–46.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- ISO. (2018). *ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines*. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/65694.html>
- Botet, J. (2021). Dealing with Unforeseen Circumstances. Implication of Risk Management in the COVID-19 Public Health Emergency. In *Risk Management*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.97408>
- Botet, J. (2021). Risk management in healthcare during the COVID-19 pandemic. *Journal of Healthcare Risk Management*, 41(2), 7–15. <https://doi.org/10.1002/jhrm.21456>
- Bottorff, J. L. (2015). Knowledge Translation. *Qualitative Health Research*, 25(11), 1461–1462. <https://doi.org/10.1177/1049732315611266>
- Bovaird, T., Löffler, E., & Parrado-Díez, S. (2002). Finding a bowling partner: The role of stakeholders in activating civil society in Germany, Spain and the United Kingdom. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14616670210151621>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). A comment on Marsh and McConnell: Towards a framework for establishing policy success. *Public Administration*, 88(2), 584–585.
- Box, R. C. (2015). *Public service values*. Routledge.
- Boyne, G. A., & Chen, A. A. (2006). Performance Targets and Public Service Improvement. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(3), 455–477. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul007>
- BPJS Kesehatan. (2020). *Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2019*. <https://bpjs-kesehatan.go.id>
- BPKP. (2020). *Laporan Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Tahun 2020*.
- Bracci, E., Bruno, A., D’Amore, G., & Ievoli, R. (2024). The integration of performance management and risk management in the public sector: an empirical case. *Journal of Management Control*, 35(1), 137–163. <https://doi.org/10.1007/s00187-024-00369-2>
- Bracci, E., et al. (2024). Ethics and coordination in public sector risk management. *Public Management Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2300000>
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2024). Public sector accounting, accountability and austerity: More than balancing the books? *Public Money & Management*, 44(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2280885>
- Braveman, P. (2006). Health disparities and health equity: Concepts and measurement. *Annual Review of Public Health*, 27, 167–194. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102103>
- Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Defining equity in health. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 57(4), 254–258. <https://doi.org/10.1136/jech.57.4.254>

- Bromiley, P., McShane, M., Nair, A., & Rustambekov, E. (2015). Enterprise risk management: Review, critique, and research directions. *Long Range Planning*, 48(4), 265–276.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2014). *Financial management: Theory & practice* (14th ed.). Cengage Learning.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Buckè, V., Ruželè, D., Ruževičius, J., & Buckus, R. (2022). The Link Between the Application of Quality Management Principles and Risk Management in Healthcare. *12th International Scientific Conference "Business and Management 2022."* <https://doi.org/10.3846/bm.2022.746>
- Buckè, R., et al. (2022). Three lines of defense model in healthcare risk management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6123. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106123>
- Budiani, N. P. S., & Zakiyah, A. (2025). Literature Review Penerapan Management Resiko pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan*, 23(1), 25-33.
- Canadian Patient Safety Institute. (2015). *Patient Safety and Risk Management Framework*. Retrieved from <https://www.patientsafetyinstitute.ca>
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary* (2nd ed.). ABC-Clío.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2015). Performance and accountability—A theoretical discussion and an empirical assessment. *Public Organization Review*, 15(2), 207–225.
- Cichoń, S. (2018). Managing human capital in the context of risk management in public administration. *Studia i Prace WNEiZ*, 52(52), 9–18. <https://doi.org/10.18276/sip.2018.52/3-01>
- Cole, M., & Parston, G. (2006). *Unlocking public value: A new model for achieving high performance in public service organizations*. John Wiley & Sons.
- Comcover. (2008). Risk management guide for Australian government. Comcover. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance. COSO.
- COSO. (2017). *Enterprise Risk Management. Integrating with strategy and performance*. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. <https://www.coso.org>
- COSO. (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance – Executive summary*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

- Commission. <https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Crozier, M. (1964). Pouvoir et organisation. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, 5(1), 52–64.
- Dahl, A., & Soss, J. (2014). Neoliberalism for the common good? Public value governance and the downsizing of democracy. *Public Administration Review*, 74(4), 496–504.
- Daneshjo, N., Malega, P., Kóna, J., & Barilová, B. (2021). Integrated Management System and Corporate Risk Management. *TEM Journal*, 10(4). <https://doi.org/10.18421/TEM104-26>
- Daraba, D. (2019). *Reformasi birokrasi & pelayanan publik*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Darwiesh, A., El-Baz, A. H., Abualkishik, A. Z., & Elhoseny, M. (2022). Artificial Intelligence Model for Risk Management in Healthcare Institutions: Towards Sustainable Development. *Sustainability*, 15(1), 420. <https://doi.org/10.3390/su15010420>
- Daud, A. (2007). Pengetahuan, Persepsi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Klinis di Lima Rumah Sakit di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten Tahun 2005. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(1), 11–19.
- Daud, A., Aripin, S., Daraba D, Ginting G, (2025), The Edge Of Risk Management In Health Sector Public Organizations: Bibliometric Analysis, ICOBEST
- Deonisia, A. (2025), Klaim tertunda BPJS Kesehatan capai Rp 5 Triliun, Layanan publik jangan terdampak, https://www.kompas.id/artikel/klaim-tertunda-bpjs-kesehatan-capai-rp-5-triliun-layanan-ke-masyarakat-bisa-terdampak?utm_source=chatgpt.com
- De Savigny, D., & Adam, T. (2009). *Systems thinking for health systems strengthening*. World Health Organization.
- de Souza, F. S. R. N., Braga, M. V. de A., da Cunha, A. S. M., & de Sales, P. D. B. (2020). Incorporation of international risk management standards into federal regulations. *Revista de Administração Pública*, 54(1), 59–78. <https://doi.org/10.1590/0034-761220180117x>
- DeLeon, L., & Denhardt, R. B. (2000). The political theory of reinvention. *Public Administration Review*, 60(2), 89–97.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Denhardt, R. B., Denhardt, J. V., & Blanc, T. A. (2013). *Public administration: An action orientation*. Cengage Learning.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. In *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.12347>
- De Waal, L., & Lodewijkx, H. (2015). Defining hybridity and hybrid contingencies in public organizations: An alternative conceptual model. In A. Alford & O. Palonen (Eds.),

- Public Service and Administration* (pp. 115–132). Routledge. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/284738001_Defining_Hybridity_and_Hybrid_Contingencies_in_Public_Organizations_An_Alternative_Conceptual_Model
- Dewi, N. K. Y. W., & Darma, G. S. (2019). Strategi Investasi & Manajemen Resiko Rumah Sakit Swasta di Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(2), 110. <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2044>
- Dihartawan, A., Prasetyo, D., & Rahmawati, S. (2023). Analisis faktor-faktor risiko di 90 rumah sakit Indonesia: Pengaruh SOP dan identifikasi bahaya terhadap kualitas manajemen risiko. *ScholarHub Universitas Indonesia*. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id>
- Dihartawan, D., Lestari, F., Widanarko, B., & Besral. (2024). Analysis of Factors Affecting Hospital Risk Management in Indonesia: The SEM-PLS Approach. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 19(2), 135–143. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v19i2.1106>
- Dimitrov, G. (2019). Risks to the sustainability of the healthcare system stemming from the increase in private healthcare costs. *VUZF Review*, 3, 75.
- Dimitrov, V. (2019). Value for money in risk management. *Risk Management*, 21(3), 145–167. <https://doi.org/10.1057/s41283-019-00045-6>
- Dimitrov, V. (2019). Regulatory harmonization in healthcare: Challenges and opportunities. *International Journal of Health Policy and Management*, 8(12), 717–720. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2019.67>
- Dobrowolski, Z., Drozdowski, G., & Panait, M. (2022). Understanding the Impact of Generation Z on Risk Management—A Preliminary Views on Values, Competencies, and Ethics of the Generation Z in Public Administration. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), 3868.
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033>
- Donaldson, L., al. (2022). Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management. In *Dental Nursing* (Vol. 18, Issue 12). <https://doi.org/10.12968/denn.2022.18.12.596>
- Donaldson, M. S., Corrigan, J. M., & Kohn, L. T. (Eds.). (2000). To err is human: building a safer health system.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

- Durán, E. A. V., Suárez, J. P. R., Abril, M. S. O., & Botia, G. C. P. (2019). Comparison between electric vehicle technology and gasoline in regular operation. Pilot experience in public service. *Journal of Physics: Conference Series*, 1414(1), 12014.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Ebi, K. L., Vanos, J., Baldwin, J. W., Bell, J. E., Hondula, D. M., Errett, N. A., Hayes, K., Reid, C. E., Saha, S., Spector, J., & Berry, P. (2021). Extreme Weather and Climate Change: Population Health and Health System Implications. *Annual Review of Public Health*, 42(1), 293–315. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-012420-105026>
- Fanny, N., & Soviani, A. (2020). Analisis Manajemen Risiko Di Ruang Filing RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2020. *Infokes*, 10(2), 12–19.
- Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. Sir Isaac Pitman & Sons.
- Ferdosi, M., Rezayatmand, R., & Molavi Taleghani, Y. (2020). Risk Management in Executive Levels of Healthcare Organizations: Insights from a Scoping Review (2018). *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 215–243. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S231712>
- Ferdosi, M., et al. (2020). Strategic alignment of vision and risk in hospitals. *Journal of Health Organization and Management*, 34(7), 789-804. <https://doi.org/10.1108/JHOM-03-2020-0089>
- Ferlie, E. (1996). *The new public management in action*. Oxford university press.
- Figueras, J., Robinson, R., & Jakubowski, E. (2005). *Purchasing to improve health systems performance: drawing the lessons*. Purchasing to improve health systems performance. Maidenhead,
- Firmansyah, M. H. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Islam Surabaya A. Yani. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.31550>
- Fitriana, L., Nugroho, H. S. W., & Astuti, R. D. (2022). Implementasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 25–34. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.25-34>
- Fletcher, K. C., & Stanton, T. H. (2019). Public Sector Enterprise Risk Management. In *Public Sector Enterprise Risk Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429446115>
- Frączkiewicz-Wronka, A., Ingram, T., Szymaniec-Mlicka, K., & Tworek, P. (2021). Risk Management and Financial Stability in the Polish Public Hospitals: The Moderating Effect of the Stakeholders' Engagement in the Decision-Making. *Risks*, 9(5), 87. <https://doi.org/10.3390/risks9050087>
- Fransisca L, (2025), Dugaan Malpraktek di RSUD Tarakan, Pemprov DKI temukan ketidaksesuaian SOP, <https://beritanasional.com/detail/106432/dugaan-malapraktik-di-rsud-tarakan-pemprov-dki-temukan-ketidaksesuaian-sop>
- Frederickson, G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2012). *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.

- Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2011). Strategic risk management: A foundation for improving enterprise risk management and governance. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 22(3), 81–88. <https://doi.org/10.1002/jcaf.20677>
- Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2011). Embracing enterprise risk management: Practical approaches for getting started. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 22(3), 29–
- Frisby, C., & Read, K. (2022). The patient journey. *Dental Nursing*, 18(12), 596–597. <https://doi.org/10.12968/denn.2022.18.12.596>
- Gilson, L. (2006). Trust in health care: theoretical perspectives and research needs. *Journal of Health Organization and Management*, 20(5), 359–375.
- Ginting, G. (2016). Entrepreneurial University Menjadi Alternatif Pilihan Institusi Pendidikan Tinggi Menghadapi Persaingan Di Era Digital: Permodelan Penciptaan Public Value. *Institusi Pendidikan Tinggi di Era Digital: Pemikiran, Permodelan dan Praktek Baik*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- Gray, J. A. M. (2017). *Evidence-based healthcare and public health: How to make decisions about health services and public health* (4th ed.). Elsevier.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Notes on the Theory of Organization* (Vol. 3). Columbia University. Institute of Public Administration.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hanggraeni, D., & Maris, A. W. I. (2016). *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO 31000: Teori dan Hasil Penelitian*. Universitas Indonesia.
- Hardino, Indasah, & Katmini. (2025). Implementation of integrated risk management in planning and budget governance. *Journal of Nursing Practice*, 8(3), 688–698. <https://thejnp.org/index.php/jnp/article/view/475>
- Hardino, A., Syahrizal, A., & Winata, H. (2025). Keterkaitan Sistem Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis di Rumah Sakit Daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 18(2), 101–117.
- Hill, S., & Dinsdale, G. (2001). *A foundation for developing risk management learning strategies in the public service*. Canadian Centre for Management Development.
- Hillson, D., & Murray-Webster, R. (2017). *Understanding and managing risk attitude* (2nd ed.). Routledge.
- HM Treasury. (2020). *The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts*. London: HM Government. <https://www.gov.uk/government/publications/orange-book>
- Hollnagel, E., Wears, R. L., & Braithwaite, J. (2015). *From Safety-I to Safety-II: A white paper*. The Resilient Health Care Net.

- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public Administration*.
- Hood, Christopher. (2010). Can we? Administrative limits revisited. *Public Administration Review*, 70(4), 527–534.
- Hsia, R. Y., Mbembati, N. A., Macfarlane, S., & Kruk, M. E. (2012). Access to emergency and surgical care in sub-Saharan Africa: the infrastructure gap. *Health Policy and Planning*, 27(3), 234–244.
- Hughes, O. E. (2012). *Public management and administration: An introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration: An Introduction* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Hussein, M., Pavlova, M., Ghalwash, M., & Groot, W. (2021). The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: a systematic literature review. *BMC health services research*, 21, 1-12.
- Hutagalung, L. E. (2022). Aanalisa Manajemen Risiko Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit XYZ Menggunakan ISO 31000. *TeIKa*, 12(01). <https://doi.org/10.36342/teika.v12i01.2820>
- Hutagalung, F. (2022). Implementasi enterprise risk management di rumah sakit menggunakan OCTAVE-S. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jti.v15i2.456>
- Hutchins, G. (2018). *ISO 31000: 2018 Enterprise risk management*. Greg Hutchins.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academy Press.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines*. ISO.
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2023). The IIA's three lines model: An update. <https://www.theiia.org/en/content/standards-and-guidance/standards-and-guidance-ippf/three-lines-model/>
- ISO. (2009). *Risk management principles and guidelines*. BSI Group. <https://doi.org/10.1080/08982112.2013.814508>
- Izza, N., Jati, S. P., & Pramukarso, D. T. (2022). Analisis Implentasi Manajemen Resiko Pada Masa Pandemi COVID-19 di Instalasi Bedah Sentral. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 278–292.
- JabbER, J. G., & Dwivedi, O. P. (1989). *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Jackson, P. M. (2012). Value for Money and Public Management Reform. *Public Money & Management*, 12(4), 9-16.
- Johns, N., Hartwell, H., & Morgan, M. (2010). Improving the provision of meals in hospital. The patients' viewpoint. *Appetite*, 54(1), 181–185.
- Jordan, S. R. (2014). Public service quality improvements: A case for exemption from IRB review of public administration research. *Accountability in Research*, 21(2), 85–108.

- Jule, J. G. (2020). Workplace Safety: A Strategy for Enterprise Risk Management. *Workplace Health and Safety*, 68(8), 360–365. <https://doi.org/10.1177/2165079920916654>
- Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). Managing Risks: A New Framework. *Harvard Business Review*, 90(6), 48–60.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.
- KARS. (2022). *Standar Akreditasi Rumah Sakit* (1st ed.).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2021a). *Laporan Survei Kesehatan Jiwa dan Burnout Tenaga Kesehatan di Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2021b). *Vaksin Dashboard*. <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Keputusan Menteri Kesehatan No. 1128 Tahun 2022 tentang STARKES*.
- Kemenkes RI. (2023). *Pedoman Implementasi Rekam Medis Elektronik Terintegrasi*. Satusehat Kemenkes.
- Kemenkeu RI. (2019). *Press Release PMK No.187/PMK.05/2019 tentang PMN BPJS Kesehatan*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan No. 1354 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan*
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Laporan Insiden Keselamatan Pasien tahun 2024 Rumah Sakit Seluruh Indonesia*
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Insiden Keselamatan Pasien tahun 2024 Rumah Sakit Seluruh Indonesia*
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Insiden Keselamatan Pasien tahun 2024 Rumah Sakit Seluruh Indonesia*
- Kemkominfo RI. (2023). *Laporan Tahunan Keamanan Siber 2023*. <https://www.kominfo.go.id>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Petunjuk Teknis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021*. KemenPAN-RB.
- Kettl, D. F. (2005). Reforming the executive branch of the US Government. *Institutions of American Democracy: The Executive Branch*, 344–378.

- Khassouani, C.-E., Asri, A., & Soulaymani, A. (2021). Risk management and surveillance systems: A Model proposed for the provincial public hospital (CHP). *E3S Web of Conferences*. Vol. 319.
- Kim, D. H., & Senge, P. M. (1994). Putting systems thinking into practice. *System Dynamics Review*, 10(2–3), 277–290. John Wiley & Sons.
- King, C. S., & Stivers, C. (1998). Citizens and administrators: Roles and relationships. *Public Administration and Society*, 267.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage Publications.
- Kristanto, P. F., & Lisdiono, P. (2025). Evaluasi penerapan Enterprise Risk Management pada RSUD BLUD berdasarkan Permenkes No. 25/2019 dan ISO 31000. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(2), Article eja.2025.v35.i02.p08. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02.p08>
- Kristanto, A., & Lisdiono, H. (2025). Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko di RSUD dengan Status BLUD. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 22–35.
- Kumar, S. (2021). Risk Management and Enterprise Risk Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3891339>
- Kusnadi Jaya. (2023). *Implementasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit: Antara Regulasi dan Praktik*. CRMS Indonesia. Retrieved from <https://crmsindonesia.org/publications/menyusun-puzzle-manajemen-risiko-di-rsud/>
- Lapsley, I. (2009). New public management: The cruellest invention of the human spirit? 1.
- Lee, J., McCullough, J. S., & Town, R. J. (2013). The impact of health information technology on hospital productivity. *The RAND Journal of Economics*, 44(3), 545–568.
- Legido-Quigley, H., Asgari, N., Teo, Y. Y., Leung, G. M., Oshitani, H., Fukuda, K., Cook, A. R., Hsu, L. Y., Shibuya, K., & Heymann, D. (2020). Are high-performing health systems resilient against the COVID-19 epidemic *Lancet (London, England)*, 395(10227), 848.
- Lindelow, M. (2006). Sometimes more equal than others: how health inequalities depend on the choice of welfare indicator. *Health Economics*, 15(3), 263–279.
- Linu, N. B., Serena, Y. M., & Waha, C. J. J. (2025). Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam Penanganan Sengketa Medis Dokter dan Pasien. *Lex PrivatumLEX PRIVATUM*, 15(2).
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell Sage Foundation.
- Lodge, M., & Gill, D. (2011). Toward a new era of administrative reform? The myth of post-NPM in New Zealand. *Governance*, 24(1), 141–166.
- Lubis, A. Y. (2020). Disparitas putusan malpraktek kedokteran studi putusan mahkamah agung no. 365k/pid/2012. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(4), 87–96.
- Madsen, D. Ø. (2025). Balanced Scorecard: History, implementation, and impact. *Administrative Sciences*, 15(1), Article 39. <https://doi.org/10.3390/admsci15010039>

- Manning, N. (2001). The legacy of the New Public Management in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 67(2), 297–312.
- McCourt, W. (2008). Public management in developing countries: From downsizing to governance. *Public Management Review*, 10(4), 467–479.
- McDermott, F. D., Heeney, A., Kelly, M. E., Steele, R. J., Carlson, G. L., & Winter, D. C. (2015). Systematic review of preoperative, intraoperative and postoperative risk factors for colorectal anastomotic leaks. *Journal of British Surgery*, 102(5), 462–479.
- McKee, M., & Healy, J. (2002). *Hospitals in a changing Europe* (Vol. 3). Citeseer.
- McPake, B. I. (1996). Public autonomous hospitals in sub-Saharan Africa: trends and issues. *Health Policy*, 35(2), 155–177.
- McPhee, I. (2005). Risk and risk management in the public sector. *Canberra: Australian National Audit Office*.
- Merton, R. K. (1962). Bureaucratic structure and personality. *Josephson, E. and M.(Eds.): Man Alone: Alienation in Modern Society, New York (A Laurel Edition) 1962, Pp. 123-131*.
- Meyer, R. E., & Waldorff, S. B. (2022). Organization theory and public management. In *Elgar Encyclopedia of Public Management*.
<https://doi.org/10.4337/9781800375499.organization.theory>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Salada, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In *Sage* (Vol. 3, Issue 1).
- Mills, A. (1994). Decentralization and accountability in the health sector from an international perspective: what are the choices? *Public Administration and Development*, 14(3), 281–292.
- Moeller, R. R. (2011). *COSO Enterprise Risk Management*. Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118269145>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y., & Allegrini, V. (2021). Does stakeholder engagement affect corruption risk management? *Journal of Management and Governance*, 25(3), 759–785. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09527-9>
- Moore, M. H. (2013). *Recognizing public value*. Harvard University Press.
- Moore, M. H. (1997). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard university press.
- Moynihan, D. P., Fernandez, S., Kim, S., LeRoux, K. M., Piotrowski, S. J., Wright, B. E., & Yang, K. (2011). Performance regimes amidst governance complexity. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(suppl_1), i141–i155.
- Muktiyanto, A., Hadiwidjaja, R. D., Perdana, H. D., Firman, A., Trisnowati, Y., & Yulianto, K. S. (2025). Pendampingan dan reuiu penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas di Kota Tangerang Selatan. *Journal Human Resources* 24/7. *Abdimas: Abdimas*, 3(2), 35-46.

- Nabatchi, T. (2010). Addressing the citizenship and democratic deficits: The potential of deliberative democracy for public administration. *The American Review of Public Administration*, 40(4), 376–399.
- National Audit Office. (2001). *Getting Value for Money in Public Services*. NAO
- Newman, J. E., & Clarke, J. H. (2009). *Publics, politics and power: Remaking the public in public services*.
- NHS England. (2016). *Risk Management Policy*. NHS England Publications. Retrieved from <https://www.england.nhs.uk/publication/risk-management-policy/>
- Ningsih, K. P., Tunnisa, U., & Erviana, N. (2020). Manajemen Risiko Redesign Sistem Penjajaran Rekam Medis dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). *Indonesian of Health Management Journal*, 8(1), 8–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/inohim.v8i1.204>
- NSW Government. (2020). *NSW Health Enterprise Risk Management Framework*. Retrieved from https://www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2020/PD2020_002.html
- Nugraheni, S. W., Firdaus, E. N., & Agustine, V. D. (2019). Risk Management In Hospital Filing Unit. *International Conference Of Health Science, & Technology*, 1(1), 59–62.
- Nurdin, D. A., & Wibowo, A. (2021). Barriers To Reporting Patient Safety Incident In Health Care Workers: Integrative Literature Review. *Indonesian Journal of Health Administration*, 9(2), 210-217.
- O’Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian Journal of Public Administration*, 66(3), 353–366.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *Recommendation of the Council on Public Procurement*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). Value for money in government: The concept and its measurement. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264215065-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Regulatory policy in the public sector. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/12345678>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). The resilience of public sector organizations in times of crisis. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f3c8d7a-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Digital government in Chile: Strengthening the institutional and governance framework. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a5b5b5b-en>
- Olii, M. W., Rivai, F., & Palutturi, S. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Klinis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada Rumah Sakit di Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 2(1). <https://doi.org/10.30597/jkmm.v2i1.10063>
- Ontario Hospital Association. (2010). *Enterprise Risk Management Toolkit for Healthcare Leaders*. Retrieved from https://www.oha.com/Documents/ERM_Toolkit.pdf

- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming government. In *Reading Mass. Adison Wesley Public Comp.*
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?. *Public Management Review*, 8(3), 377–
- Osborne, S. P. (2010a). *Delivering public services: time for a new theory?* Taylor & Francis.
- Osborne, S. P. (2010b). Introduction: the (new) public governance: a suitable case for treatment. In *The new public governance*. London: Routledge.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?. *Public Management Review*, 8(3), 377–
- Osborne, S. P. (2013). *Voluntary organizations and innovation in public services*. Routledge.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment? *Public Management Review*, 18(5), 639–653. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927>
- Osborne, S. P., Strokosch, K., & Radnor, Z. (2018). Co-production and the co-creation of value in public services: A perspective from service management. In *Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services*. <https://doi.org/10.4324/9781315204956>
- Paape, L., & Speklé, R. F. (2012). The adoption and design of enterprise risk management practices: An empirical study. *European Accounting Review*, 21(3), 533-564.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions. *Journal of Service Quality Retailing, Spring*, 64(1), 12–40.
- Park, S. J., & Sharp, A. L. (2019). Improving health and health care efficiency through risk management. *Journal of Hospital Management and Health Policy*, 3, 9–9. <https://doi.org/10.21037/jhmhp.2019.04.02>
- Park, J., & Sharp, B. (2019). Value for money in healthcare: A review of the literature. *Health Economics*, 28(6), 738–752. <https://doi.org/10.1002/hec.3870>
- Pascarella, G., Rossi, M., Montella, E., Capasso, A., De Feo, G., Botti, G., Nardone, A., Montuori, P., Triassi, M., D'Auria, S., & Morabito, A. (2021). Risk Analysis in Healthcare Organizations: Methodological Framework and Critical Variables. *Risk Management and Healthcare Policy*, Volume 14, 2897–2911. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S309098>
- Pascarella, G., et al. (2021). Clinical risk management in hospitals. *International Journal of Environmental Research and Public*. 18(15), 7890. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157890>
- Pascarella, G., Rossi, M., & Sansone, F. (2021). Enterprise risk management in healthcare: A systematic review. *Journal of Risk Research*, 24(10), 1234–1250. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1858162>
- Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Pemerintah RI (2009). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

- Pemerintah RI. (2023). *Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)*.
- Pemerintah RI. (2023). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Kesehatan*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di RSUD*
- Permadi, E. A., & Hartanti, D. (2025). Evaluasi multidimensional ERM maturity model pada institusi publik: Analisis aspek compliance dan strategy. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(4), Article eja.2025.v35.i04.p12. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i04.p12>
- Perry, J. L. (2007). Democracy and the new public service. *The American Review of Public Administration*, 37(1), 3–16.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). The Problem of Mutual Empowerment. *Administration & Society*.
- Peters, M. A. (2001). *Poststructuralism, Marxism, and neoliberalism: Between theory and politics*. Rowman & Littlefield.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. St. Martin's Press.
- Polidano, C. (1999). *The new public management in developing countries* (Vol. 13). Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford University Press.
- Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). *Redefining health care: creating value-based competition on results*. Harvard business press.
- Postuła, M. (2016). Risk analysis as an instrument of public management. In *Risk Management in Public Administration* (pp. 93–113). Springer.
- Pramusinto, A. (2023). Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 dalam Pelayanan Publik Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45-62.
- Prasanti, I., Chandoko, C. C., & Palupi, A. L. (2019). Implementation of Enterprise Risk Management in a State Owned Managed Hospital: lesson learnt. *Journal of Hospital Management*, 1(1), 16–22. <https://johm.ub.ac.id/index.php/johm/article/view/5>
- Prasanti, D., Sari, D. P., & Wibowo, A. (2019). Regulasi manajemen risiko di rumah sakit milik negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jap.v7i2.456>
- Prasanti, D., et al. (2019). Risk management maturity in Indonesian hospitals. *Journal of Health Management*, 21(2), 145-160. <https://doi.org/10.1177/0972063419845678>
- Pratama, M. R. M. (2024). *Analysis of The Influence of Risk Management And Hospital Management Information System on The Performance of Regional Public Hospitals (Empirical Study at Regional General Hospitals in Lampung Province)*. 2(3), 379–384. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13789915>
- Preker, A. S., & Harding, A. (2003). *Innovations in health service delivery: the corporatization of public hospitals* (Vol. 434). World Bank Publications.

- Priyarsono, D. (2023). *Urgensi dan Titik-titik Kritis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/17/urgensi-dan-titik-titik-kritis-manajemen-risiko-pembangunan-nasional>
- Purnatimu, N. A., & Rifai, M. (2023). Analysis of Occupational Safety and Health Risk in Emergency Installations with Hospital X Yogyakarta Using the Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) Method. *MASHIJO: Medical Science and Hospital Journal Dental and Oral Hospital of Universitas Muhammadiyah Semarang*, 02(1), 34–39.
- Putra, I. P. A. S., & Hendrawan, I. K. R. (2024). Analisis Manajemen Risiko SIMRS pada Rumah Sakit Ganesha Menggunakan ISO 31000. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 14(1), 88–98. <https://doi.org/10.34010/jati.v14i1.12329>
- Raczkowski, K. (2017). *Risk management in public administration*. Springer.
- Raczkowski, K., & Tworek, P. (2017). What Does Risk Management in an Economy Really Mean? *Risk Management in Public Administration*, 1–41.
- Rainey, H. G. (2009). *Understanding and managing public organizations*. John Wiley & Sons.
- Raz, T., & Hillson, D. (2005). A comparative review of risk management standards. *Risk*
- Rechel, B., Mladovsky, P., Ingleby, D., Mackenbach, J. P., & McKee, M. (2013). Migration and health in an increasingly diverse Europe. *The Lancet*, 381(9873), 1235–1245.
- Rhodes, R. A. W. (2016). Recovering the craft of public administration. *Public Administration Review*, 76(4), 638–647.
- Rikhotso, O., Morodi, T. J., & Masekameni, D. M. (2022). Health risk management cost items imposed by Occupational Health and Safety Regulations: A South African perspective. *Safety Science*, 150, 105707. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105707>
- Rothstein, H., Borraz, O., & Huber, M. (2013). Risk and the limits of governance: Exploring varied patterns of risk-based governance across Europe. *Regulation and Governance*, 7(2), 215–235. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2012.01153.x>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2014). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- RSUD Tarakan (2024). Profil RSUD Tarakan, Jakarta
- Rubino, M. (2018). A comparison of the main ERM frameworks: how limitations and weaknesses can be overcome implementing IT governance. *International Journal of Business and Management*, 13(12), 203–214.
- Sari, D. P., et al. (2022). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Daerah: Kajian SERVQUAL dan NPM. *Journal of Public Health*, 14(3), 200–215.
- Sajwani, R. (202). *Enterprise risk management in healthcare organizations*. The British University in Dubai.
- Sarker, A. E. (2006). New public management in developing countries: An analysis of success and failure with particular reference to Singapore and Bangladesh. *International Journal of Public Sector Management*, 19(2), 180–203.

- Sattar, A. (2015). Systematic risk and unsystematic risk in portfolio theory. *International Journal of Research – Granthaalayah*, 3(8), 43-49. https://www.granthaalayahpublication.org/journals/granthaalayah/article/view/IJRG15_A08_134/789
- Saud, N. P. R., Handayani, L., & Lestari, P. A. (2021). Tingkat Kemapanan Implementasi Manajemen Risiko Rekam Medis di Rumah Sakit Kota Gorontalo. *Journal of Health, Education and Literacy (J-Healt)*, 3(2), 90–96.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Peter Senge. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
- Setiawan, I., Sekarini, A. R., Waluyo, R., & Afiana, F. N. (2021). Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan ISO 31000 dan Standar Pengendalian ISO/EIC 27001 di Tripio Purwokerto. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 389–396. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1093>
- Setiyono, B. (2020). *Manajemen Pelayanan Umum* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing Administration Public*. Taylor & Prancis: Abingdon.
- Shughart, W. F., II, & Razzolini, L (2001). *The Elgar companion to public choice*. Edward Elgar Publishing.
- Simatupang, T. M. (1995). *Pemodelan sistem*. Penerbit Kanida.
- Slomski, B. (2022). Darwin and American public administration. *Politics and the Life Sciences*,
- Smith, P. C., Mossialos, E., Papanicolas, I., & Leatherman, S. (2009). *Performance measurement for health system improvement: Experiences, challenges and prospects*. Cambridge University Press
- Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing. *Academy of Management Review*, 36(2), 381–403.
- Soleh, M. (2020). Risk Culture As A Solution To Face Covid-19 Pandemic. *Ilomata International Journal of Management*, 1(4), 203–214. <https://doi.org/10.52728/ijjm.v1i4.163>
- Sorano, E., Giovando, G., Rizzi, A., & Sardi, A. (2022). The provision for risks and charges of public healthcare companies: An analysis of a national context. *Corporate Ownership and Control*, 20(1), 19–30. <https://doi.org/10.22495/cocv20i1art2>
- Standards Australia. (2018). *AS ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines*. Standards Australia. Retrieved from <https://www.standards.org.au/standards-catalogue/sa-snz/publicsafety/ob-007/as--iso-31000-colon-2018>
- Sundari, S. (2024). Analisis penerapan balanced scorecard dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*.
- Supriyono, B. (2001). Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 25-33.

- Taylor, F. W. (1911). Principles and methods of scientific management. *Journal of Accountancy*, 12(3), 3.
- Thomas, J. C. (2013). Citizen, customer, partner: Rethinking the place of the public in public management. *Public Administration Review*, 73(6), 786–796.
- Trisnantoro, L. (2018). Healthcare system reform and governance for sustainable development under Indonesia's health insurance (JKN) policy. In *Sustainable development goals in Southeast Asia and ASEAN* (pp. 143–159). Brill.
- Tuan, N. P., et al. (2023). Risk Management in Vietnamese Hospitals: Integrating ASHRM and SERVQUAL. *International Journal of Healthcare Management*, 16(2), 150-165.
- Tukamuhabwa, B., Mutebi, H., & Isabirye, D. (2023). Supplier performance in the public healthcare: internal social capital, logistics capabilities and supply chain risk management capabilities as antecedents in a developing economy. *Journal of Business and Socio- Economic Development*, 3(1), 50–68. <https://doi.org/10.1108/JBSED-04-2021-0046>
- Tworek, P. (2012). Integrated Risk Management in Construction Enterprises - Theoretical Approach. *Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice*, nr 8, 125–135.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Vanesa, V. G. H., Natassa, J., Amin, M., Raviola, R., & Edigan, F. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Petugas Khusus Laboratorium COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Duri Tahun 2021: Risk Management Analysis For COVID-19 Laboratory Special Officers At Mandau Duri General Hospital in 2021. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 2(1), 347–362. <https://doi.org/10.25311/kesmas.Vol2.Iss1.552>
- Weber, M. (1947a). Legitimate authority and bureaucracy. *The Theory of Social and Economic Organisation*, 328–340.
- Weber, M. (1947b). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.
- Wibowo, A. (2022). *Manajemen Risiko*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Max Weber. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.
- Williams, I., & Shearer, H. (2011). Appraising public value: Past, present and futures. *Public Administration*, 89(4), 1367–1384.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
- World Health Organization, (WHO) (2007). *Cost-effectiveness thresholds and health interventions*. WHO Press.
- World Health Organization. (WHO), (2003). *Health service indicators and hospital performance measurement*.
- World Health Organization (WHO), (2007). *Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes. WHO's framework for action*. WHO Press.
- World Health Organization, (WHO), (2009). *WHO Patient Safety Research: Better Knowledge for Safer Care*. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44277>

- World Health Organization, (WHO), (2010). *Health systems financing: The path to universal coverage*. WHO Press.
- World Health Organization. (WHO), (2017). *Patient safety: Making health care safer*.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Patient Safety Fact File*.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care*.
- World Health Organization, (WHO), (2025). *WHO risk appetite statement*. WHO.
<https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/about-us/accountability/who-risk-appetite-statement.pdf>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. The World Bank. Yin, R. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*.
- Yang, T.-M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*, 28(2), 164–175.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.008>
- Yostin, A. N., Tahjoo, A., & Unggul, U. E. (2023). The development of clinical risk management implementation model in improving quality and patient safety. *Journal of HealthSains*, 4(6), 44–59.
- Zaitseva, N. V., May, I. V., & Zaitsev, A. A. (2022). Developing the methodology for health risk assessment within public management of sanitary-epidemiological welfare of the population. *Health Risk Analysis*, 3, 4-20.
<https://journal.fcrisk.ru/eng/sites/journal.fcrisk.ru.eng/files/upload/article/624/health-risk-analysis-2022-3-1.pdf>
- Zaitseva, N., et al. (2022). Quantitative risk assessment methodologies in healthcare. *Safety Science*, 145, 105512. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105512>
- Zahra, A., Anisah, A., & Putri, N. A. (2021). Manajemen risiko sistem informasi rumah sakit (Studi kasus: Rumah sakit EMC Tangerang) [Hospital information system risk management (Case study: EMC Hospital Tangerang)]. In *Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)* (pp. 456-469). Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Zaitseva, N., Goncharova, N., & Andronova, I. (2022). Methodological approaches to risk management in healthcare. *Healthcare*, 10(5), 890.
<https://doi.org/10.3390/healthcare10050890>
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. Free Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

1. Panduan Wawancara

No	Indikator	Kode	Pertanyaan Wawancara	Informan
1	Kondisi eksisting penerapan ERM	KE01	1. Pendekatan apa yang digunakan pada penerapan manajemen risiko / ERM di saat ini? 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang memengaruhi efektivitas penerapan ERM? 3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan ERM secara menyeluruh dan terintegrasi?	Direktur RS, Manajer Mutu/Risiko
2	Kesesuaian visi, misi, nilai, dan sasaran rumah sakit	GC01	4. Apakah visi, misi, dan nilai saat ini sudah mencerminkan pentingnya pengelolaan risiko?	Direksi, Kepala Bagian Perencanaan
3	Komitmen terhadap <i>Core Value</i> dan ERM	GC02	5. Bagaimana bentuk komitmen pimpinan terhadap nilai inti dan manajemen risiko? 6. Bagaimana sistem pengawasan pimpinan terhadap ERM? 7. Seberapa besar pimpinan mengambil keputusan berbasis risiko? 8. Bagaimana pimpinan mendukung transformasi menuju pelayanan berbasis nilai? 9. Apa dampak pendekatan berbasis nilai terhadap penciptaan nilai (<i>value creation</i>) bagi pasien dan rumah sakit? 5. Bagaimana pendekatan berbasis nilai membantu melindungi nilai (<i>value creation</i>) RS ?	Direktur RS, Komite Mutu
4.	<i>Value for Money (VfM)?</i> (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomi) (sumber)	GC03	10. Bagaimana rumah sakit memastikan bahwa program manajemen risiko memberikan manfaat optimal dengan sumber daya yang efisien? 11. Bagaimana rumah sakit memastikan bahwa tata kelola (<i>governance</i>) mendukung pencapaian <i>Value for Money</i> ? 12. Bagaimana upaya rumah sakit dalam menekan biaya pengadaan (ekonomi) tanpa menurunkan kualitas layanan? 13. Bagaimana strategi rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di unit? 14. Bagaimana rumah sakit memastikan bahwa pelayanan yang diberikan 15. efektif dan mencapai outcome yang	SPI, Direktur Keuangan

No	Indikator	Kode	Pertanyaan Wawancara	Informan
			diharapkan masyarakat/pasien? 16. Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem manajemen risiko untuk meningkatkan <i>Value for Money</i> ?	
5.	Pengorganisasian ERM dengan <i>Three Lines Model</i>	GC04	17. Apakah sudah menerapkan pembagian peran menurut <i>three lines model</i> dalam pengelolaan risiko? Apakah peran dan tanggung jawab manajemen risiko pada semua level telah diatur dan didefinisikan?	Manajer Risiko, SPI
6	Penetapan regulasi manajemen risiko di RS		18. Bagaimana regulasi eksternal mendukung pelaksanaan ERM? 19. Apakah sudah ada regulasi internal terkait manajemen risiko saat ini?	Manajer Risiko, Bagian Hukum
7.	Penetapan regulasi manajemen risiko di tingkat Pusat (Kemenkes dan Kemendagri)		20. Bagaimana penetapan regulasi manajemen risiko RS ? 21. Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan Kemenkes terhadap pelaksanaan ERM di rumah sakit ? 22. Bagaimana koordinasi Kemenkes dengan kementerian/lembaga lain dalam penguatan tata kelola risiko dan mutu rumah sakit publik? 23. Bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan mengatur penerapan manajemen risiko di rumah sakit ? 24. Apakah ada panduan teknis atau kebijakan terkait ERM di BLUD? 25. Terkait fleksibilitas yang diberikan pada BLUD, bagaimana dengan sistem monev atau pengawasannya ? 26. Secara akuntabilitas keuangan di BLUD bagaimana peran Kemendagri? 27. Bagaimana Penilaian kinerja bidang Kesehatan di BLUD ? 28. Terkait pengaturan Dewan Pengawas RS bagaimana pengaturan Regulasinya? 29. Job disc Dewas di SK Gubernur tidak ada pengawasan terhadap manajemen resiko. Bagaimana hal ini terkait dengan Permendagri 79 ? 30. Bagaimana sinkronisasi, harmonisasi regulasi saat ini sehingga mengakomodir semuanya?	Kemkes Kemendagri
8.	Kesesuaian regulasi internal dan eksternal	GC06	31. Bagaimana kesesuaian regulasi manajemen risiko internal dan eksternal?	Manajer Risiko, Bagian Hukum
	Ketersediaan anggaran untuk ERM	GC07	32. Apakah tersedia alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan manajemen risiko di rumah sakit ini?	Direktur Keuangan, Manajer

No	Indikator	Kode	Pertanyaan Wawancara	Informan
			33. Apakah Program manajemen risiko telah diintegrasikan dengan rencana strategis dan anggaran?	Risiko
	Lima jenis akuntabilitas	GC08	34. Bagaimana bentuk <i>moral accountability</i> saat ini?	Direktur
			35. Bagaimana bentuk <i>political accountability</i> saat ini?	Direktur
			36. Bagaimana bentuk <i>managerial accountability</i> saat ini?	Direktur
			37. Bagaimana bentuk <i>professional accountability</i> saat ini?	Direktur
			38. Bagaimana bentuk <i>legal accountability</i> saat ini?	Direktur
	Keterlibatan pemangku kepentingan	GC09	39. Bagaimana keterlibatan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam pengelolaan risiko di rumah sakit? 40. Apakah pasien atau keluarganya pernah dilibatkan / berpartisipasi 41. dalam pengelolaan risiko?	Manajer Risiko
	Budaya sadar risiko	GC10	42. Sejauh mana budaya sadar risiko sudah menjadi bagian dari keseharian tenaga kesehatan?	Manajer Risiko, Kepala Ruangan
	Kompetensi SDM terhadap risiko	GC11	43. Bagaimana rumah sakit membangun budaya sadar risiko di kalangan staf? 44. Apakah ada pelatihan staf terkait peningkatan kapasitas ERM?	SDM, Kepala Ruangan
	Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi	GC12	45. Bagaimana komitmen pegawai terhadap nilai dan etika organisasi dalam konteks manajemen risiko?	SDM, Komite Etik
	Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko	GC13	46. Apakah pimpinan menunjukkan dukungan terhadap pengembangan budaya risiko? 47. Apakah ada sistem penghargaan dan apresiasi /pengakuan terhadap staf yang berkontribusi aktif dalam manajemen risiko?	SDM, Manajer Risiko
9.	Standard decision by RS Government dengan SPM	GC14	48. Bagaimana rumah sakit mengikuti kebijakan standar pengambilan keputusan dari pemerintah terkait manajemen risiko? 49. Bagaimana rumah sakit memenuhi SPM?	Direksi, Hukum, SPI
	Performance Index by Citizen (SERVQUAL)	GC15	50. Apakah ada penilaian performance index yang menilai <i>Reliability, Assurance, Responsiveness, Tangibles, Empathy</i> ?	Humas, Pemasaran, Komite Mutu
18	Analisis konteks internal dan eksternal	SS01	51. Bagaimana rumah sakit menganalisis konteks internal dan eksternal dalam menyusun program manajemen risiko?	Manajer risiko, Perencanaan
19	Penetapan selera risiko (<i>risk appetite</i>)	SS02	52. Apakah Pimpinan rumah sakit sudah menetapkan selera risiko dan sudah di	

No	Indikator	Kode	Pertanyaan Wawancara	Informan
			komunikasikan ke semua level? 53. Apakah selera risiko menjadi acuan dalam memprioritaskan risiko?	Direktur, Manajer risiko
20	Evaluasi strategi alternatif	SS03	54. Apakah dilakukan evaluasi strategi alternatif sebelum memutuskan pendekatan manajemen risiko ?	Direksi, Perencanaan
21	Perumusan tujuan dan sasaran strategis	SS04	55. Apakah mempertimbangkan Sasaran Strategi Pemilik dalam menyusun Renstra? 56. Bagaimana risiko dipertimbangkan dalam menyusun tujuan dan rencana strategis rumah sakit?	Direksi, Komite Mutu, Manajer risiko
22	Program kerja ERM	RP01	57. Bagaimana Rencana kerja ERM lima tahunan? 58. Bagaimana program kerja ERM disusun?	Manajer Risiko
23	Penyusunan roadmap ERM	RM02	59. Apakah telah disusun roadmap implementasi ERM di rumah sakit? 60. Apakah Roadmap sesuai Rencana dan Program kerja ERM?	Manajer Risiko, Direksi
24	Evaluasi hasil kegiatan ERM	ER01	61. Bagaimana proses evaluasi terhadap implementasi ERM dilakukan? 62. Apakah evaluasi risiko dilakukan atas perubahan lingkungan internal/ eksternal?	Manajer risiko, SPI
25	Tindak lanjut hasil evaluasi	TL02	63. Apa langkah perbaikan yang berdasarkan hasil evaluasi ERM sebelumnya?	SPI, Manajer risiko
26	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko	IKP01	64. Bagaimana teknologi informasi digunakan dalam mendukung identifikasi dan analisis risiko? 65. Apakah risiko-risiko utama sudah terdokumentasi dalam sistem elektronik ? 66. Apakah Sistem informasi EMR (SIEMR) terintegrasi di semua level? 67. Apakah terdapat Dashboard dan story board risiko ?	IT RS, Manajer Risiko
27	Mekanisme pelaporan ERM	IKP02	68. Bagaimana mekanisme pelaporan risiko dilakukan? 69. Apakah Laporan risiko disampaikan ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Manajer Risiko,
28	Komunikasi informasi risiko	IKP04	70. Bagaimana informasi risiko disampaikan ke seluruh level organisasi 71. Apakah risiko dikomunikasikan secara efektif dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Manajer Risiko,
29	Pelaporan risiko dan performa secara periodik	IKP05	72. Apakah dilakukan pelaporan rutin tentang risiko, budaya sadar risiko dan performa kepada manajemen?	SPI, Direksi

No	Indikator	Kode	Pertanyaan Wawancara	Informan
30	Identifikasi risiko klinis dan non-klinis	PF01	73. Bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan di Tingkat unit 74. Bagaimana identifikasi risiko dilakukan di semua Tingkat/ Level? 75. Apakah identifikasi risiko dilakukan sesuai kategori mencakup lingkup risiko klinis dan non klinis?	Manajer Risiko, Kepala Unit
31	Analisis risiko terhadap Tingkat keparahan berdasarkan dampak dan kemungkinan	PF02	76. Bagaimana risiko dianalisis berdasarkan dampak dan kemungkinan kejadiannya? 77. Apakah kriteria dampak dan kemungkinan ditetapkan dan digunakan seragam di semua level UPR?	Manajer risiko
32	Penentuan prioritas risiko	PF03	78. Bagaimana risiko dikategorikan dan diprioritaskan?	Manajer Risiko
33	Perlakuan risiko	PF04	79. Apa saja bentuk mitigasi atau respons terhadap risiko? 80. Apakah ada strategi respons atas risiko ekstrim berupa rencana kontinjensi dan rencana tanggap darurat?	Kepala Unit, Manajer Risiko
34	Pembiayaan risiko	PF05	81. Apakah ada prsoses pemilihan opsi pembiayaan?	Direksi, Keuangan
35	Risiko dikaji dalam portofolio terintegrasi	PF06	82. Apakah terdapat dokumen portofolio risiko?	SPI, Manajer Risiko
36	Penilaian perubahan substansial	RR01	83. Bagaimana rumah sakit merespons perubahan signifikan yang berpotensi memunculkan risiko baru?	Direksi, Perencanaan
37	Review kinerja dan risiko	RR02	84. Apakah dilakukan review risiko dalam tahapan proses manajemen risiko? 85. Seberapa rutin evaluasi efektivitas manajemen risiko?	Manajer risiko, SPI
38	Perbaikan ERM	RR03	86. Apa langkah perbaikan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan sistem ERM?	Manajer risiko, SPI
39	Audit internal berbasis risiko	AU01	87. Apakah audit internal sudah berbasis risiko?	SPI
40	Tindak lanjut hasil audit	AU02	88. Bagaimana proses tindak lanjut dari temuan audit risiko dilaksanakan?	SPI

2. Tabel Panduan Dokumentasi

Indikator	Dokumen yang Direview	Aspek yang Direview
Kondisi eksisting penerapan ERM	1. Dokumen kebijakan mutu, dokumen profil risiko RS	1. Ada tidaknya dokumen ERM, 2. Bukti implementasi,
Kesesuaian visi, misi, nilai dan sasaran rumah sakit	2. Dokumen Renstra RS, 3. Dokumen profil RS	Keterpaduan visi-misi dengan prinsip ERM

Kepemimpinan dan Pengawasan	4. SK Direksi, 5. Notulen rapat pimpinan	Bukti keterlibatan pimpinan dalam pengawasan risiko
Pengorganisasian ERM dengan three line Model	6. Struktur organisasi, uraian tugas	Kejelasan pembagian fungsi first, second, third line
Penetapan Regulasi manajemen risiko	7. SK, SOP manajemen risiko	Kelengkapan dan kejelasan regulasi risiko
Kesesuaian Regulasi internal dan eksternal	8. SK, regulasi RS, Permenkes	Kesesuaian isi regulasi dengan standar nasional
Ketersediaan anggaran	9. RKA, laporan realisasi anggaran	Alokasi dan penggunaan anggaran ERM
Lima jenis Akuntabilitas (jabbra)	10. Laporan akuntabilitas kinerja, laporan tahunan	Bukti akuntabilitas legal, profesional, administratif, politis, moral
Keterlibatan Pemangku kepentingan	11. dokumentasi kegiatan	Partisipasi stakeholder dalam ERM
Value for Money (VfM)	12. Laporan SPI, laporan audit	Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pengelolaan risiko
Budaya sadar risiko	13. Hasil survei budaya keselamatan, laporan insiden	Internalisasi budaya risiko dalam keseharian
Kompetensi SDM terhadap risiko	14. Data pelatihan, sertifikat pelatihan	Jumlah pelatihan dan sertifikasi terkait risiko
Komitmen SDM terhadap nilai dan etika organisasi	15. Kode etik, absensi pelatihan etika	Kepatuhan terhadap nilai dan kode etik
Sistem penghargaan dan pengakuan	16. SK penghargaan, dokumentasi penghargaan	Sistem insentif untuk kontribusi dalam ERM
Standard decision by RS Government	17. Pedoman kebijakan RS	Penerapan pengambilan keputusan standar oleh RS
Performance Index by citizen	18. Hasil survei kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat berbasis dimensi SERVQUAL
Analisa Konteks internal dan eksternal	19. Dokumen analisis SWOT, analisis risiko strategis	Kelengkapan dan kedalaman analisa
Penetapan risk appetite	20. Dokumen risk appetite statement	Ada tidaknya pernyataan risk appetite
Evaluasi strategi alternatif	21. Notulen rapat direksi dan Dewas	Pembahasan berbagai alternatif strategi
Perumusan Tujuan strategis	22. Dokumen perencanaan strategis	Tujuan strategis mempertimbangkan risiko
Program kerja ERM	23. Rencana kerja tahunan ERM	Program ERM terstruktur dan berjalan
Roadmap ERM	24. Dokumen roadmap implementasi ERM	Tahapan dan target implementasi ERM
Evaluasi kegiatan ERM	25. Laporan evaluasi mutu & risiko	Capaian indikator dan rekomendasi perbaikan
Tindak lanjut hasil evaluasi	26. Rencana tindak lanjut, notulen	Bukti tindak lanjut dan perbaikan

Pemanfaatan TI untuk ERM	27. Sistem informasi risiko, aplikasi pelaporan	Fungsi dan integrasi sistem IT dengan ERM
Mekanisme pelaporan ERM	28. Form pelaporan risiko, laporan insiden	Adanya sistem pelaporan yang terdokumentasi
Komunikasi informasi risiko	29. Dokumentasi sosialisasi risiko	Frekuensi dan cakupan komunikasi risiko
Pelaporan risiko & performa	30. Laporan manajemen risiko triwulan/tahunan	Isi laporan mencakup budaya, risiko, dan kinerja
Identifikasi risiko	31. Risk register unit, komite	Dokumentasi risiko klinis dan non-klinis
Analisis keparahan risiko	32. Risk Profil unit, komite	Metode dan hasil analisis risiko
Penentuan prioritas risiko	33. Risk register, scoring risiko	Skor risiko dan prioritas pengelolaan
Mitigasi risiko	34. Dokumen rencana mitigasi	Tindakan mitigasi terhadap risiko prioritas
Pembiayaan risiko	35. Rencana anggaran risiko	Alokasi dana mitigasi dan pengendalian risiko
Risiko dalam portofolio	36. Peta risiko strategis	Integrasi risiko lintas unit
Penilaian perbaikan	37. Laporan perbaikan	Tanggapan risiko terhadap perbaikan
Review kinerja dan risiko	38. Laporan audit mutu & risiko	Rutin tidaknya evaluasi kinerja risiko
Perbaikan ERM	39. Rencana pengembangan ERM	Upaya penguatan berkelanjutan ERM
Audit internal berbasis risiko	40. Laporan SPI berbasis risiko	Audit dilakukan dengan pendekatan risiko
Tindak lanjut audit	41. Laporan tindak lanjut audit	Dokumentasi pelaksanaan rekomendasi audit

3. Tabel Panduan Observasi

No	Indikator	Fokus Observasi	Aspek yang diobservasi
1	Kesesuaian visi, misi, nilai, dan sasaran RS	1. Nilai-nilai rumah sakit terlihat dalam poster/banner/internalisasi	Keberadaan, keterbacaan, dan kesesuaian nilai RS di area strategis
		2. Integrasi risiko dalam Renstra rumah sakit	Penjabaran risiko pada tujuan strategis Renstra
		3. Penyesuaian target strategis	Adanya indikator risiko pada target strategis RS
2	Kepemimpinan dan Pengawasan	4. Piagam Manajemen risiko dipajang atau mudah diakses	Letak piagam MR dan kemudahan akses staf
3	Ketersediaan anggaran	5. Ketersediaan Anggaran untuk manajemen risiko (Visual dokumen anggaran MR)	Dokumen visual RKAT menampilkan alokasi MR
4	Budaya sadar risiko	6. Pelaksanaan briefing risiko harian	Bukti pelaksanaan briefing risiko di unit kerja
		7. Sistem penghargaan dan pengakuan budaya sadar risiko Insentif dan pengakuan staf	Sistem reward bagi pelaku pengelolaan risiko
	Kompetensi SDM	8. Pengetahuan dan keterampilan	

No	Indikator	Fokus Observasi	Aspek yang diobservasi
5	terhadap risiko	staf	Sertifikasi, pelatihan, evaluasi kompetensi
6	Pengorganisasian ERM dengan Three Line Model	9. Dokumen visual struktur organisasi menunjukkan peran Three Lines Model	Struktur organisasi menampilkan governance line, management line, dan assurance line
7	Penetapan Regulasi Manajemen Risiko	10. Ketersediaan kebijakan risiko	Kebijakan terpajang atau tersedia di unit kerja
8	Value for Money (VfM)	11. Visual bukti kegiatan sosialisasi ERM	Poster, dokumentasi, atau absen kegiatan ERM
		12. Efisiensi: proses pelayanan	Observasi alur proses pelayanan tanpa pemborosan
		13. Efektifitas: kepatuhan prosedur keselamatan pasien	Penerapan SOP keselamatan pasien saat pelayanan
		14. Ekonomi: praktik penggunaan bahan habis pakai	Pemakaian BHP sesuai kebutuhan tanpa pemborosan
9	Teknologi Informasi	15. Sistem elektronik untuk pelaporan risiko yang dapat diakses staf	Ketersediaan dan kemudahan akses SI-ERM bagi staf
10	Rancang Program	16. 16. Pelaksanaan pelatihan sesuai roadmap	Observasi jadwal pelatihan dan pelaksanaan di unit kerja
11	Pelaporan & Evaluasi	17. Mekanisme feedback risiko (kotak laporan, email)	Tersedianya media pelaporan risiko oleh staf
		18. Forum evaluasi berkala	Pelaksanaan forum evaluasi risiko dan output rekomendasi
12	Performance	19. Pengisian risk register	Ketersediaan risk register di unit dan keterisian item
		20. Prioritas risiko ke profil risiko	Proses pemilahan risiko prioritas menjadi profil risiko RS
		21. Perlakuan risiko	Bukti mitigasi risiko di unit kerja
		22. Pemantauan risiko	Bukti monitoring pelaksanaan perlakuan risiko
		23. Komunikasi antar unit/pemangku kepentingan via forum risiko, Ketersediaan SOP komunikasi risiko	Adanya forum komunikasi risiko dan SOP-nya
13	Audit internal berbasis risiko	24. Audit berbasis ERM	Observasi partisipasi SPI dalam audit risiko/mutu
	Tindak lanjut audit risiko	25. Evidence implementasi rekomendasi audit	Bukti tindak lanjut rekomendasi audit di unit kerja

Lampiran 2. Daftar Rumah Sakit di DKI Jakarta

Data Rumah Sakit di DKI Jakarta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
1	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	Umum	C	Kementerian Kesehatan
2	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Cilincing	Umum	B	Pemprov DKI
3	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Grha Kedoya	Umum	B	Swasta
4	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Koja	Umum	C	Pemprov DKI
5	Kota Adm. Jakarta Barat	RSIA Metro Hospitals Kebon Jeruk	Khusus Jiwa	A	Swasta
6	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Pademangan	Umum	B	Pemprov DKI
7	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Pasar Minggu	Khusus Kanker	A	Pemprov DKI
8	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Kanker Dharmais	Umum	B	Kementerian Kesehatan
9	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Tanjung Priok	Khusus Ibu dan Anak	A	Pemprov DKI
10	Kota Adm. Jakarta Barat	RSUD Tugu Koja	Khusus Jantung	A	Pemprov DKI
11	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Premier Jatinegara	Umum	B	Swasta
12	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Tria Dipa	Umum	C	Swasta
13	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Pusat Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa	Umum	C	TNI/POLRI
14	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Mata Nusantara	Umum	B	Swasta
15	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Pusat Otak Nasional	Umum	C	Kementerian Kesehatan
16	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Restu Kasih	Umum	B	Swasta
17	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Tingkat IV Cijantung Kesdam Jaya	Khusus Ibu dan Anak	C	TNI/POLRI
18	Kota Adm. Jakarta Barat	RS FKG Universitas Prof. DR. Moestopo (B)	Umum	B	Swasta
19	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Universitas Kristen Indonesia	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
20	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Bedah Halimun	Umum	D	Swasta
21	Kota Adm. Jakarta Barat	RSIA Avisena	Khusus Mata	A	Swasta
22	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Yadika Pondok Bambu	Umum	C	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
23	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Jantung dan Pembuluh Darah Heartology	Umum	C	Swasta
24	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Siloam TB Simatupang	Umum	C	Swasta
25	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Siloam Asri	Umum	B	Swasta
26	Kota Adm. Jakarta Timur	RSGM TNI Angkatan Udara	Umum	C	TNI/POLRI
27	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Prikasih	Umum	D	Swasta
28	Kota Adm. Jakarta Barat	RSIA Al-Fauzan	Khusus Gigi dan Mulut	A	Swasta
29	Kota Adm. Jakarta Barat	RS Andhika	Umum	C	Swasta
30	Kota Adm. Jakarta Barat	RSIA Brawijaya Duren Tiga	Umum	D	Swasta
31	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Siloam Mampang	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
32	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Jatipadang	Khusus Ibu dan Anak	C	Pemprov DKI
33	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Agung	Khusus Mata	C	Swasta
34	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Jiwa Dharmawangsa	Khusus Infeksi	A	Swasta
35	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Zahirah	Umum	C	Swasta
36	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Pesanggrahan	Umum	C	Pemprov DKI
37	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Medistra	Umum	B	Swasta
38	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Sammarie Wijaya	Umum	D	Swasta
39	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Alvernia Agusta	Umum	C	Swasta
40	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Tebet	Umum	D	Pemprov DKI
41	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Asta Nugraha	Umum	C	Swasta
42	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Panti Nugraha	Umum	B	Swasta
43	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Gandaria	Umum	C	Swasta
44	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Tebet	Umum	C	Swasta
45	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Petukangan	Umum	C	Swasta
46	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Resti Mulya	Umum	B	Swasta
47	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA SamMarie Basra	Umum	C	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
48	Kota Adm. Jakarta Utara	RSIA Sayyidah	Umum	B	Swasta
49	Kota Adm. Jakarta Utara	RSKD Duren Sawit	Umum	C	Pemprov DKI
50	Kota Adm. Jakarta Utara	RSU Adhyaksa	Umum	B	Pemprov DKI
51	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Budhi Asih	Umum	C	Pemprov DKI
52	Kota Adm. Jakarta Utara	RS MRCCC Siloam Semanggi	Umum	B	Swasta
53	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Cipayung	Umum	D	Pemprov DKI
54	Kota Adm. Jakarta Utara	RS Siaga Raya	Umum	C	Swasta
55	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Ciracas	Umum	B	Pemprov DKI
56	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Kramat Jati	Umum	C	Pemprov DKI
57	Kota Adm. Jakarta Utara	RSUD Matraman	Umum	B	Pemprov DKI
58	Kab. Adm. Kep. Seribu	RS Muhammadiyah Taman Puring	Umum	D	Swasta
59	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Setia Mitra	Umum	A	Swasta
60	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Alia Hospital	Umum	B	Swasta
61	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Jagakarsa	Umum	B	Pemprov DKI
62	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Aneka Tambang Medika (ANTAM)	Umum	C	BUMN/Kementerian Lain
63	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Bedah Rawamangun	Khusus Kanker	A	Swasta
64	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Kebayoran Lama	Khusus Jiwa	C	Pemprov DKI
65	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto	Umum	A	TNI/POLRI
66	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Columbia Asia Pulomas	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
67	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Dharma Nugraha	Khusus Ketergantungan Obat	B	Swasta
68	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD	Umum	C	TNI/POLRI
69	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS DR. Euis	Umum	B	Swasta
70	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS EMC Pulomas	Umum	B	Swasta
71	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Haji Jakarta	Khusus Bedah	B	Swasta
72	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Harapan Bunda	Umum	B	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
73	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Harapan Jayakarta	Khusus THT-KL	C	Swasta
74	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Aulia	Umum	C	Swasta
75	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Harum Sisma Medika	Umum	D	Swasta
76	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Hermina Jatinegara	Umum	C	Swasta
77	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Mayapada Kuningan	Khusus Orthopedi	C	Swasta
78	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Islam Jakarta Pondok Kopi	Umum	B	Swasta
79	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Mampang Prapatan	Umum	C	Pemprov DKI
80	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Islam Klender Jakarta	Khusus Gigi dan Mulut	B	Swasta
81	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Ali Sibroh Malisi	Umum	C	Swasta
82	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Jantung Bina Waluya	Umum	C	Swasta
83	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Jantung Jakarta	Khusus Ibu dan Anak	B	Swasta
84	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSIA Kemang Medical Centre	Umum	C	Swasta
85	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Brawijaya Tebet	Umum	C	Swasta
86	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Kepulauan Seribu	Khusus Ibu dan Anak	C	Pemprov DKI
87	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Kartika Pulomas	Umum	C	Swasta
88	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSIA Budhi Jaya	Umum	C	Swasta
89	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Metropolitan Medical Centre	Umum	C	Swasta
90	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Ketergantungan Obat	Khusus Ibu dan Anak	B	Kementerian Kesehatan
91	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSIA JWCC Asih	Umum	C	Swasta
92	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Mediros	Umum	C	Swasta
93	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Moh. Ridwan Meuraksa	Umum	B	TNI/POLRI
94	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSIA Brawijaya	Umum	B	Swasta
95	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Bhayangkara Sespimma Polri	Umum	C	TNI/POLRI
96	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Olahraga Nasional	Umum	C	BUMN/Kementerian Lain
97	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Yadika Kebayoran Lama	Umum	D	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
98	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Pengayoman Cipinang	Umum	D	BUMN/Kementerian Lain
99	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Atmajaya	Umum	B	Swasta
100	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Duta Indah	Umum	D	Swasta
101	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Kembangan	Umum	C	Pemprov DKI
102	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSUD Kemayoran	Umum	D	Pemprov DKI
103	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Ladokgi TNI-AL R.E. Martadinata	Umum	D	TNI/POLRI
104	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS UKRIDA	Khusus Bedah	C	Swasta
105	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS YPK Mandiri	Umum	D	Swasta
106	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Firdaus	Khusus Mata	C	Swasta
107	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Gading Pluit	Umum	C	Swasta
108	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Anggrek Mas	Umum	D	Swasta
109	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Rumkital Marinir Cilandak	Umum	C	TNI/POLRI
110	Kota Adm. Jakarta Selatan	RSIA Tambak	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
111	Kota Adm. Jakarta Selatan	RS Hermina Podomoro	Khusus Jantung	C	Swasta
112	Kota Adm. Jakarta Timur	RS PGI Cikini	Umum	A	Swasta
113	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan	Umum	B	BUMN/Kementerian Lain
114	Kota Adm. Jakarta Timur	RSUD Cengkareng	Khusus Gigi dan Mulut	B	Pemprov DKI
115	Kota Adm. Jakarta Timur	RS FKG Universitas Indonesia	Umum	B	Swasta
116	Kota Adm. Jakarta Timur	RSUP Fatmawati	Khusus Ibu dan Anak	C	Kementerian Kesehatan
117	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Evasari	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
118	Kota Adm. Jakarta Timur	RSAL DR. Mintohardjo	Khusus Ibu dan Anak	C	TNI/POLRI
119	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Islam Jakarta Sukapura	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
120	Kota Adm. Jakarta Timur	RS JEC Primasana	Khusus Jantung	C	Swasta
121	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Husada	Khusus Jiwa	C	Swasta
122	Kota Adm. Jakarta Timur	RSIA Aries	Khusus Bedah	A	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
123	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Dr. Soeharto Heerdjan	Khusus Bedah	C	Kementerian Kesehatan
124	Kota Adm. Jakarta Timur	RS PK. St. Carolus	Khusus Jiwa	A	Swasta
125	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Mitra Keluarga Kelapa Gading	Umum	B	Swasta
126	Kota Adm. Jakarta Timur	RSPAD Gatot Soebroto	Umum	B	TNI/POLRI
127	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Mulyasari	Khusus Otak	A	Swasta
128	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pantai Indah Kapuk	Umum	C	Swasta
129	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pekerja	Umum	B	BUMN/Kementerian Lain
130	Kota Adm. Jakarta Timur	RSUD Johar Baru	Umum	C	Pemprov DKI
131	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Royal Taruma	Umum	C	Swasta
132	Kota Adm. Jakarta Timur	RSUD Kalideres	Umum	A	Pemprov DKI
133	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pondok Indah - Pondok Indah	Umum	B	Swasta
134	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pelabuhan Jakarta	Umum	D	BUMN/Kementerian Lain
135	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pluit	Umum	D	Swasta
136	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Umum	C	Kementerian Kesehatan
137	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Port Medical Centre	Umum	D	Swasta
138	Kota Adm. Jakarta Timur	RS THT Proklamasi	Umum	B	Swasta
139	Kota Adm. Jakarta Timur	RSGM YARSI	Umum	C	Swasta
140	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Mitra Kemayoran	Umum	C	Swasta
141	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Puri Medika	Umum	B	Swasta
142	Kota Adm. Jakarta Timur	RSAB Harapan Kita	Khusus Jantung	B	Kementerian Kesehatan
143	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Pondok Indah - Puri Indah	Umum	C	Swasta
144	Kota Adm. Jakarta Timur	RSIA Ibnu Sina	Umum	C	Swasta
145	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Royal Progress	Umum	B	Swasta
146	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Bina Estetika	Umum	C	Swasta
147	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Cinta Kasih Tzu Chi	Umum	B	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
148	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Satya Negara	Umum	D	Swasta
149	Kota Adm. Jakarta Timur	RS YARSI	Umum	D	Swasta
150	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Islam Jakarta Cempaka Putih	Umum	B	Swasta
151	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Sukmul Sisma Medika	Umum	C	Swasta
152	Kota Adm. Jakarta Timur	RS Siloam Kebon Jeruk	Umum	C	Swasta
153	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Tzi Chi Hospital	Umum	A	Swasta
154	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Pelni	Umum	A	BUMN/Kementerian Lain
155	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Abdi Waluyo	Umum	B	Swasta
156	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUD Tamansari	Umum	B	Pemprov DKI
157	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Patria IKKT	Umum	B	Swasta
158	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Pusat Pertamina	Umum	B	BUMN/Kementerian Lain
159	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Medika Permata Hijau	Umum	B	Swasta
160	Kota Adm. Jakarta Timur	RSIA Family	Umum	B	Swasta
161	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Hermina Kemayoran	Umum	C	Swasta
162	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSIA Grand Family	Umum	D	Swasta
163	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Budi Kemuliaan	Khusus Ibu dan Anak	B	Swasta
164	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Pertamina Jaya	Umum	C	BUMN/Kementerian Lain
165	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUD Sawah Besar	Umum	C	Pemprov DKI
166	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUD Tanah Abang	Umum	B	Pemprov DKI
167	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSIA Santo Yusuf	Umum	A	Swasta
168	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Kramat 128	Khusus THT-KL	B	Swasta
169	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Bhakti Mulia	Umum	B	Swasta
170	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Salemba Satu Medika	Umum	C	Swasta
171	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Mitra Keluarga Kalideres	Khusus THT-KL	C	Swasta
172	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Menteng Mitra Afia	Khusus Mata	B	Swasta
173	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Ciputra Citra Garden City	Khusus Bedah	C	Swasta

No	Wilayah	Nama_rumah_sakit	Jenis	Kelas	Kepemilikan
174	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS JEC Kedoya	Umum	C	Swasta
175	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Hermina Daan Mogot	Umum	B	Swasta
176	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSIA Bunda Jakarta	Khusus Gigi dan Mulut	A	Swasta
177	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Murni Teguh Sudirman	Khusus Ibu dan Anak	C	Swasta
178	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUD Tarakan	Umum	C	Pemprov DKI
179	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS dr. Abdul Radjak Salemba	Khusus Gigi dan Mulut	B	Swasta
180	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Siloam Agora	Umum	D	Swasta
181	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Jakarta Eye Center Menteng	Umum	D	Swasta
182	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS THT Prof Nizar	Umum	D	Swasta
183	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Sumber Waras	Umum	D	Swasta
184	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS FKG Universitas Trisakti	Khusus THT-KL	C	Swasta
185	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Bunda Jakarta	Umum	D	Swasta
186	Kota Adm. Jakarta Pusat	RS Cendana	Umum	B	Swasta
187	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSUD Cempaka Putih	Khusus Gigi dan Mulut	B	Pemprov DKI
188	Kota Adm. Jakarta Pusat	RSPI Prof. Sulianti Saroso	Umum	B	Kementerian Kesehatan

Sumber : Portal Satu Data Jakarta – Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Lampiran 3. Pelayanan di RSUD Tarakan

No	Unit	Pelayanan
1	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Pelayanan kegawatdaruratan 24 jam, triase prioritas 1–3. Didukung oleh : • SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) • PONEK 24 Jam (Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergency Komprehensif) • Dokter umum terlatih dan perawat gawat darurat
2	Instalasi Rawat Jalan	Lokasi: Gedung A Lantai 2, Gedung C Lantai 2, Gedung Sky Hospital Lantai 6–9. Pendaftaran: • Online melalui aplikasi JakSehat / JKN Mobile / website • Loker tersedia di lobby Gedung A, Sky Hospital lantai 8–9, dan Poli Cendana • Waktu praktik dokter: 08.30–13.00 WIB
3	Klinik Jantung	• Fasilitas Catheterization Laboratory (Cathlab) • Tindakan diagnostik & intervensi jantung invasif
4	Klinik Penyakit Dalam	Dengan subspesialis: • Ginjal & Hipertensi • Gastroenterohepatologi • Hematologi Onkologi • Endokrin-Metabolik-Diabetes
5	Klinik Kebidanan & Kandungan (Obsgyn)	• Uroginekologi • Fetomaternal • ginekologi onkologi, • fertilitas, • dilengkapi USG 4D & layanan bedah mayor/minor
6	Klinik Anak	• Klinik Spesialis Anak • Hemato Onkologi Anak • Tumbuh Kembang • Vaksinasi • Neonatologi (dalam pengembangan)
7	Klinik Bedah	Subspesialis : • Bedah Digestif (laparoskopi advance) • Bedah Onkologi • Bedah Ortopedi • Bedah Urologi • Bedah Plastik & Rekonstruksi (termasuk Burn Center)
8	Klinik Lainnya	• Mata • THT-KL • Kulit & Kelamin • Paru • Neurologi • Kedokteran Jiwa • Pelayanan Psikologis • Gigi & Mulut
9	Instalasi Rawat Inap	• Ruang perawatan dewasa • Ruang perawatan anak • Ruang bersalin

No	Unit	Pelayanan
		• Fasilitas ruang pertemuan untuk edukasi • Sistem CCTV untuk keamanan pasien
10	Instalasi Rawat Intensif	• ICU • ICCU • NICU • PICU • PACU • Intermediate Ward (IW) • Dirancang untuk menangani pasien kritis dengan dukungan peralatan komprehensif.
11	Instalasi Bedah Sentral	Tersedia ruang operasi modern yang menangani seluruh disiplin bedah: • Bedah umum • Bedah digestif • Bedah onkologi • Bedah orthopedi • Bedah saraf • Bedah urologi • Bedah plastik • Fasilitas mencakup ruang operasi bersih, peralatan anestesi, dan pemulihan pascaoperasi (PACU).
12	Instalasi Laboratorium	• Patologi Klinik • Patologi Anatomi • Mikrobiologi Klinik • Mendukung diagnosis terpadu, skrining penyakit, kultur, hingga pemeriksaan biomolekuler.
13	Instalasi Radiologi	Fasilitas meliputi : • CT Scan • MRI • C-Arm (untuk tindakan bedah) • USG, X-ray modern
14	Instalasi Farmasi	Memberikan layanan: • Peracikan & penyerahan obat • Konseling obat • Pengelolaan obat dengan sistem berbasis teknologi
15	Instalasi Rekam Medis	Mengelola rekam medis elektronik dan manual, penyimpanan data, pendokumentasian kasus, serta penerbitan dokumen resmi kesehatan.
16	Instalasi Gizi	Layanan gizi klinis, konsultasi diet, serta penyiapan makanan pasien sesuai kebutuhan terapi.
17	Instalasi Penunjang Terapi	Meliputi: • Rehabilitasi Medik (fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara) • Unit Hemodialisa • Bank/Unit Transfusi Darah
18	Instalasi Penunjang Khusus	Termasuk: • CSSD (Sterilisasi alat) • Sanitasi Rumah Sakit

No	Unit	Pelayanan
		• Pemulasaraan jenazah • Laundry medis
19	Layanan Unggulan	RSUD Tarakan memiliki berbagai layanan unggulan skala provinsi: 1. Jantung Terpadu 2. Stroke Center 3. Onkologi Terpadu 4. Urologi–Nefrologi 5. Integrated Trauma & Crisis Service 6. Burn Center (pusat luka bakar) 7. Layanan Kesehatan Mata 8. Geriatri 9. Kesehatan Ibu & Anak 10. Tumbuh Kembang Anak 11. TB RO/MDR 12. Forensik 13. Klinik Nyeri 14. Gastroentero-Hepatologi 15. Kulit, Kelamin & Estetika 16. Layanan Jiwa Anak & Remaja 17. Gigi & Mulut 18. HIV Dewasa & Anak 19. Medical Check Up

Lampiran 4. Definisi Operasional

A. Enterprise Risk Management (ERM)

Aspek	Definisi Operasional
Risiko Sistematis	Tingkat paparan rumah sakit terhadap faktor makro yang tidak dapat dikendalikan organisasi namun berdampak pada kinerja strategis.
Risiko Tidak Sistematis	Tingkat potensi kerugian akibat kelemahan proses internal, SDM, teknologi, dan tata kelola.
Risiko Klinis	Peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan terutama keselamatan pasien
Risiko Nonklinis	Peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak negatif terkait dengan selain pelayanan kesehatan
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional organisasi, termasuk risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Risiko Strategis	Risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam menghadapi perubahan ² di lingkungan bisnis / eksternal, termasuk dan / atau pengembangan bisnis baru. (terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis RS). Mis. risiko investasi, pemasaran, pengembangan produk dan lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Risiko Keuangan	Risiko yang disebabkan segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan kepercayaan public terhadap organisasi.

B. Keselamatan Pasien dan Dimensi Mutu Pelayanan (WHO)

Aspek	Definisi Operasional
Keselamatan Pasien	Suatu kerangka kerja yang berupa kegiatan terorganisasi untuk membangun budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam Pelayanan Kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menurunkan risiko, mengurangi bahaya yang dapat dihindari, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, serta mengurangi dampak ketika terjadi insiden pada Pasien.
Safety	Derajat layanan yang mampu menekan risiko bahaya selama proses perawatan.
Effectiveness	Tingkat keberhasilan pelayanan dalam menghasilkan outcome optimal sesuai standar ilmiah.
Efficiency	Tingkat kemampuan menghasilkan layanan maksimal dengan pemborosan minimal.
Patient-Centred Care	Tingkat penghormatan terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis.
Timeliness	Tingkat kecepatan pasien memperoleh layanan tanpa keterlambatan berisiko.
Equity	Tingkat konsistensi mutu pelayanan tanpa kesenjangan antar kelompok populasi.

C. Value for Money (Extended Public Sector Framework)

	Definisi Operasional
<i>Economy</i>	Tingkat kemampuan memperoleh sumber daya dengan biaya paling ekonomis tanpa menurunkan kualitas.
<i>Efficiency</i>	Tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan layanan.
<i>Effectiveness</i>	Tingkat pencapaian target layanan dan manfaat kesehatan masyarakat.
<i>Equality</i>	Tingkat ketersediaan layanan bagi seluruh populasi tanpa diskriminasi.
<i>Equity</i>	Tingkat proporsionalitas pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien, terutama kelompok rentan.

Lampiran 5

Surat Permohonan Ijin Penelitian di RSUD Tarakan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
 Jalan Kesehatan Nomor 10 Telepon 3451338 Faksimile 3451341
 website : dinkes.jakarta.go.id E-mail : dinkes@jakarta.go.id
 J A K A R T A

Nomor : 570/HM.10.02 Kode Pos 10160
 Sifat : Penting 29 Agustus 2025
 Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana
 Universitas Terbuka
 di
 Tangerang Selatan

Sehubungan dengan Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data Penelitian Disertasi dengan judul "*Model Enterprise Management (ERM) Pada Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan Provinsi DKI Jakarta*" a.n. Arjaty Wahidah Daud yang diajukan secara online melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (<https://ppid-dinkes.jakarta.go.id>) pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan nomor permohonan 202500898, maka kami sampaikan informasi, sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penelitian, pengambilan data, dan wawancara di RSUD Tarakan harap terlebih dahulu berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai lokasi penelitian dengan Ibu Nunung (0895321739522).
2. Surat Ijin Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/ judul penelitian dimaksud.
4. Tidak dibenarkan melakukan pengambilan informasi dan data pribadi sebelum adanya dokumen Perjanjian Pertukaran Data dan *Inform Consent* penelitian.
5. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, peneliti diwajibkan memaparkan, melaporkan dan menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui link <https://bit.ly/PENGUMPULANHASILPENELITIANDINKESDKI2>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Standarisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan narahubung a.n. Meta Ayu (087811242687).
6. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan oleh instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

7. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pembiayaan Penelitian yang menjadi objek lokasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Dinas Kesehatan
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan,



Tembusan:

1. Direktur RSUD Tarakan
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran 6

Surat Keterangan Selesai Penelitian di RSUD Tarakan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 445 / 2025

TENTANG
PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Weningtyas Purnomorini, MARS
NIP : 197205242006042016
Jabatan : Direktur
Unit : Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi DKI Jakarta

dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut di bawah ini,

Nama : dr. Arjaty W. Daud, MARS FISQua, CERG GRGP QRMA CGRCP
NIM : 501201741
Program Studi : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Judul Tugas Akhir : Model Enterprise Risk Management pada Pelayanan Publik
di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi DKI Jakarta

telah melakukan kegiatan penelitian/pengambilan data dari tanggal 25 September s.d.
30 November 2025 di instansi kami

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 November 2025

Direktur RSUD Tarakan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



[Handwritten Signature]
Weningtyas Purnomorini, MARS
NIP. 197205242006042016